

Dr. Dorin Dragoș

Întrebări cu răspunsuri multiple de

Semiologie medicală

cu elemente de morfopatologie și fiziopatologie

Semiologie generală, cardiovasculară, respiratorie și digestivă



Editura Universitară „Carol Davila”
București, 2014

ISBN: 978 – 973 – 708 – 780 – 5

Editura Universitară „Carol Davila” București a
U.M.F. „Carol Davila” București este acreditată de
Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul superior (CNCSIS),
cu avizul nr. 11/23.06.2004

În conformitate cu prevederile Deciziei Nr. 2/2009 a Consiliului Național al Colegiului Medicilor din
România, privind stabilirea sistemului de credite de educație medicală continuă, pe baza cărora se
evaluează activitatea de perfecționare profesională a medicilor, a criteriilor și normelor de acreditare a
educației medicale continue, precum și a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație
medicală continuă, Colegiul Medicilor din România acreditează (recunoaște)
EDITURA UNIVERSITARĂ „CAROL DAVILA” BUCUREȘTI
ca furnizor de EMC.

Rugăm pe oricare dintre cititori să ne semnaleze eventualele greșeli la adresa:
dordrag@ddorindragos.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României
DRAGOȘ, DORIN

Întrebări cu răspunsuri multiple de semiologie medicală
cu elemente de morfo- și fiziopatologie : semiologia generală,
cardiovasculară, respiratorie și digestivă / dr. Dorin Dragoș. –
București : Editura Universitară „Carol Davila”, 2014

Bibliogr.
ISBN 978-973-708-780-5

616.1-07(075.8)

Coordonator:
dr. Dorin DRAGOȘ (dr.D.D.), Medic primar Medicină internă, Spitalul Universitar de Urgență
București, Medic specialist Nefrologie, Șef de lucrări U.M.F. „Carol Davila” București, Doctor
în Științe medicale, www.ddorindragos.ro
Coordonator:
Cont. dr. Dorin Ionescu (dr.D.I.), Medic primar Medicină internă, Medic primar Nefrologie,
Spitalul Universitar de Urgență București, Conferențiar universitar U.M.F. „Carol Davila”
București, Doctor în Științe medicale
dr. Johann Francisc BACH (dr.J.F.B.), Medic primar Medicină internă, Spitalul Universitar
de Urgență București, Asistent universitar U.M.F. „Carol Davila” București, Doctor în Științe
medicale

dr. Maria Daniela TÂNASESCU (dr.M.D.T.), Medic primar Medicină internă, Spitalul
Universitar de Urgență București, Medic specialist Nefrologie, Asistent universitar U.M.F.
„Carol Davila” București, Doctor în Științe medicale
dr. Oana Maria SCHIOPU (dr.O.M.S.), Medic specialist Medicină internă, Spitalul Universitar
de Urgență București, Asistent universitar U.M.F. „Carol Davila” București, Doctor în Științe
medicale
dr. Maria Mirabela MANEA (dr.M.M.M.), Medic rezident Neurologie, Institutul Național de
Neurologie și Boli Neurovasculare

Cuprins

Cuprins	3	Bolile vasculare Dr.J.F.B.	129
Prescurtări	3	Semiologie digestivă – Dr.D.D., Dr.M.M.M.	131
Semiologie generală	5	Durerea abdominală	131
Semiologia Dr.D.I.	5	Disfagia	146
Durerea Dr.D.I.	5	Greața și vărsăturile	156
Favore Dr.O.M.S.	6	Indigestia	163
Testul adipos Dr.D.D., dr.M.D.T.	7	Tulburările de tranzit	168
Starea de hidratare Dr.D.D., dr.M.D.T.	13	Hemoragia digestivă	193
Febra și hipertermia Dr.D.D., dr.O.M.S.	49	Icterusul	199
Semiologie ORL și oftalmologică – dr.J.F.B.	57	Mătreșea abdominalului	213
Semiologie cardiorespiratorie	60	Ascizia	221
Dispneea Dr.D.D., Dr.M.M.M.	60	Răspunsuri	229
Expectorația Dr.D.D., Dr.M.D.T.	91	Semiologie generală	229
Hemoptizia Dr.D.D., Dr.M.M.M.	93	Semiologie ORL și oftalmologică	232
Cianoza Dr.D.D., dr.O.M.S.	101	Semiologie cardiorespiratorie	232
Durerea toracică Dr.D.D., Dr.M.M.M.	107	Semiologie digestivă	237
Palpitațiile Dr.D.D., Dr.M.M.M.	121	Bibliografie	245
Tuburații de ritm și de conducere Dr.J.F.B.	124		

Prescurtări

AAN = Ac antinucleari;	DE = dispneea funcțională;
AAM = Ac antimiocondrial;	DSA = defect septal atrial;
AD/AS = atrul drept/stâng;	DSV = defect septal ventricular;
ADH = hormon antidiuretic;	DurAbd = durere abdominală;
AINS = antiinflamatoare nesteroidiene;	DurTor = durere toracică;
ALI = alaiin aminotransferază;	DZ = diabet zaharat;
AST = aspartat aminotransferază;	ECG/ECGe = electrocardiogramă;
AMBG = anticorpi anti-MBG;	EcoCG = ecocardiografie;
AMPe = adenozin-5'-monofosfat ciclic;	EDS = endoscopie digestivă superioară;
ANCA = anticorpi anticitoplasma neurofililor;	EPA = edemul pulmonar acut;
angioRMN = angiografie prin RMN;	FALC = fosfatază alcalină;
ART = acidoză renală tubulară;	FC = frecvență cardiacă;
ARTd = ART distală;	FE = fracție de ejeție;
ARTp = ART proximală;	FEF = flux expirator forțat;
ARTz = angiotensina 2;	FNT = factorul de necroză tumorală;
AV = activitate ventriculară/ă;	FSR = fluxul sanguin renal;
AVP = arginin-vasopresină;	GASA = gradientul de albumină ser-ascită;
BAV = bloc atro-ventricular;	GGT = gamma-giutranil-transpeptidază;
BCI = boală cardiacă ischemică;	GI = gastrointestinal/ă;
BFG = barieră de filtrare glomerulară;	GND = glomerulonefrită difuză acută;
BIC = boală inflamatorie colonică;	GPLM = glomerulopatia cu leziuni minime;
BNP = peptide natriuretice cerebrale;	GSFS = glomeruloscleroză focală și segmentară;
BPOC = boală pulmonară obstructivă cronică;	HAD = hemoragia alevclară difuză;
BRA = blocanți receptorilor pentru angiotensină;	HAS = hiperaldosteronismul secundar;
BRD/BRs = bloc de ram drept/ stg;	HD = hemoragie digestivă;
BRGE = boala de reflux gastroesofagian;	HDI = HD inferioară;
CK = creatininază;	HDS = HD superioară;
CMH = cardiomiopatie hipertrofică;	HIV = virusul imunodeficienței umane;
CMHO = CMH obstructivă;	HRGR = hiperreactivitatea căilor respiratorii;
COHgb = carboxi-Hgb;	HTA = hipertensiune arterială;
CPC = cord pulmonar cronic;	HTAP = hipertensiune arterială pulmonară;
CPRE = colangio-pancreatografie retrogradă	HTP = hipertensiune portală;
endoscopică;	HVD/HVS = hipertrofie ventriculară dreaptă/stângă;
CPRM = colangio-pancreatografie prin RMN;	IACRS = infecție acută de căi respiratorii superioare;
CSP = colangită sclerozană primară;	IC = insuficiență cardiacă;
DAO = disecția de aortă;	ICG/ICG = IC congestivă globală;

DI/ICS = IC dreaptă stângă;
CA = inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei;
A = imunoglobulină A;
M = imunoglobulină M;
I = interferină;
IA = infarct miocardic acut;
IAO = inhibitori de monoaminooxidază;
M = indicatori de necroză miocardică;
P = inhibitori ai pompei de protoni;
= insuficiență renală;
AIRC = IR acută cronică;
DI/VS = insuficiență ventriculară dreaptă stângă;
DH = lactat-dehidrogenază;
ES = lupus eritematos sistemic;
3L = Lowry-Ganong-Levine;
AC = membrana alveolo-capilară;
BG = MB glomerulară;
D = macula densă;
SH = hormonul melanocitostimulator;
C = nervul cranian;
T-ProBNP = fragmentul N-terminal al pro-BNP;
TA = necroză tubulară acută;
TG = nitroglicerină;
h. = presiunea hidrostatică;
a.co₂, Pa_{o₂} = presiunea parțială a CO₂ în sângele arterial;
co₂ = presiunea parțială a CO₂;
G = prostaglandină;
GE₂ = prostaglandină E₂;
GI₂ = prostaglandină I₂;
NU = peptidă la natruretice;
NU-A = PNU arterială;
NU-B = PNU cerebrală;
o₂ = presiunea parțială a O₂;
PI = pneumopatii interstițiale;
TDVS = presiunea telediastolică din VS;
VC = presiune venoasă centrală;
VM = prolaps de valvă mitrală;
IGE = reflux gastroesofagian;
HS = retenție hidrosalină;
ZMN = rezonanță magnetică nucleară;

RS = ritm sinusal;
Sa_{o₂} = saturația cu oxigen a Hgb din sângele arterial;
SCA = sindrom coronarian acut;
SdNF = sindrom nefrotic;
SED = spasmi esofagici difuzi;
SEI = sfincțierul esofagian inferior;
SES = sfincțierul esofagian superior;
SHU = sindrom hemolitic-uremic;
SIDA = sindromul de imunodeficiență dobândită;
SII = sindromul de intestin iritabil;
SIV = sept interventricular;
SN = sistemul nervos;
SNC = sistemul nervos central;
SRA = sistemul renin-angiotensină;
SRAA = sistemul renin-angiotensină-aldosteron;
StAo = stenoză aortică;
TA = tensiune arterială;
TAD = TA sistolică;
TAS = TA diastolică;
TBC = tuberculoză;
TC = tomografie computerizată;
TEP = tromboembolism pulmonar;
TEVP = tromboembolism veno-pulmonar;
TFS = tromboflebită superficială;
TimpC = tamponadă cardiacă;
TPSV = tahicardie paroxistică supraventriculară;
TSH = hormonul stimulator al tiroidei;
TVP = tromboză venoasă profundă;
UDLUG = ulcer duodenal gastric;
UDPGT = UDP-glucuroniltransferaza;
VCI = vena cavă inferioară;
VCM = virus citomegalic;
VDI = virus = Ventriculului drept stâng;
VEB = virus Epstein-Barr;
VEM = volumul entrocitar mediu;
VEMS = volumul expirator maxim într-o secundă;
VHA (VHB) VHC (VHD) VHE = virusul hepatitic A/B/C/D/E;
VHS = virus herpes simplex;
VIP = peptidă intestinală vasoactivă;
VSCE = volumul sanguin circulant eficient;
VSH = viteză de sedimentare a hematitelor;
WPW = Wolff-Parkinson-White;

Prescurtări frecvent folosite: c.e. = cu excepția; s.u.c.g. = sunt următoarele, cu excepția; u.a.s.c.g. = următoarele afirmații sunt corecte, cu excepția; s.c.f.g. = sunt corect formulate, cu excepția.

Semiologie generală

Semiologia – dr.D.I.

1. Ce este semiologia?
 - A. o știință a bolilor produse de factorii externi;
 - B. o ramură a științelor medicale ce se ocupă de clasificarea bolilor;
 - C. o disciplină medicală de bază ce integrează informațiile prelucrate pentru a fundamenta majoritatea bolilor medicale și chirurgicale;
 - D. o disciplină medicală ce studiază omul și îl integrează în mediul extern prin trăirile și experiența medicului;
 - E. o disciplină medicală care observă, studiază și interpretează semnele și simptomele omului bolnav;
2. Semnul reprezintă:
 - A. o manifestare clinică observată de medic;
 - B. o caracteristică morfologică specifică unei rase umane;
 - C. un fenomen biologic obișnuit;
 - D. o anomalie morfologică care apare la cel puțin 25% din pacienții respectivi;
 - E. o modificare a percepției pacientului asupra propriilor funcții;
3. Simptomele pot fi descrise cât mai complet prin una din frazele de mai jos:
 - A. o manifestare anormală observată de familie;
 - B. o anomalie clinică descrisă de pacient sub forma unor senzații;
 - C. un fenomen biologic obișnuit pentru majoritatea oamenilor;
 - D. o anomalie funcțională care apare la cel puțin 25% din pacienții respectivi;
 - E. o reprezentare grafică a severității bolii durerii;
4. Sindromul reprezintă:
 - A. o senzație complexă resimțită de bolnav și prezentată prin propria imagine;
 - B. o proiecție în exterior a manifestărilor bolii;
 - C. un complex de semne și simptome care apar de obicei împreună;
 - D. un amalgam de semne și simptome exprimate de pacient;
 - E. toate semnele și simptomele care apar la un moment dat;

Durerea – dr.D.I.

5. Asociați caracteristicile clinice:
 1. localizare și iradiere precise;
 2. localizare modestă și iradiere la distanță;
 3. localizare incertă și/sau la distanță de origine;
 și următoarele tipuri de durere:
 - a. durere viscerală;
 - b. durere referită;
 - c. durere somatică;
 care sunt asocierile corecte:
 - A. a-1, b-3, c-2;
 - B. a-2, b-1, c-3;
 - C. a-2, b-3, c-1;
 - D. a-3, b-1, c-2;
 - E. a-3, b-2, c-1;
6. Asociați manifestările clinice:
 1. hemicranie și vărsătură;
 2. pulsătilă și intensă;
 3. lăcrimare și rinoree;
 și u. tipuri de cefalee/ durere:
 - a. migrena clasică;
 - b. cluster headache;
 - c. durerea vasculară;
 care sunt asocierile corecte:
 - A. a-1, b-3, c-2;
 - B. a-2, b-1, c-3;
 - C. a-2, b-3, c-1;
 - D. a-3, b-1, c-2;
 - E. a-3, b-2, c-1;
7. Asociați sediul leziunilor inflamatorii:
 1. leziuni ale timpanului și urechii medii;
 2. leziuni ale pavilionului urechii;
 3. leziuni ale stâncii mastoide;
 și u. tipuri de cefalee/ durere:
 - a. durere auriculară;
 - b. durere osoasă;
 - c. durere somatică;
 care sunt asocierile corecte:
 - A. a-1, b-2, c-3;
 - B. a-1, b-3, c-2;
 - C. a-2, b-1, c-3;
 - D. a-2, b-3, c-1;
 - E. a-3, b-1, c-2;
8. Asocierea unei cefalee cu vărsături explozive fără greață sugerează:
 - A. migrena comună;
 - B. cefaleea vasculară nemigrenosă;
 - C. hipertensiunea intracraniană;
 - D. cefaleea occipitală;
 - E. nevralgia de trigemen;
9. Caracterile semiologice ale durerii sunt descrise cel mai bine prin:
 - A. localizarea, intensitatea, iradirea, continuitatea, periodicitatea, severitatea, manifestări asociate;
 - B. localizarea, iradierea, durata, severitatea, calitatea, asocierea cu semne cardiovasculare, reacții de apărare;
 - C. topografia, intensitatea, periodicitatea, manifestări asociate, reacțiile de apărare și fugă din fața durerii;
 - D. topografia, intensitatea, cronologia, calitatea, condiții de ameliorare și agravare, manifestările asociate, atitudinea față de durere;
 - E. topografia, durata, calitatea, asocierea de simptome generale, atitudinea și trăirile psihologice;
10. C.d.u. afirmații NU caracterizează durerea de tip nevralgic:
 - A. iradiază pe traiectul unui nerv;
 - B. este accentuată de compresia în puncte de sensibilitate (Valleix);
 - C. este accentuată de mișcare;
 - D. este calmată de aplicații reci;
 - E. este accentuată de imobilizare;
11. C.d.u. afirmații NU caracterizează durerea viscerală?
 - A. este profundă;
 - B. este difuză;
 - C. este bine localizată;
 - D. iradiază spre suprafață;
 - E. este originară în nociceptorii viscerali;
12. C.d.u. asocieri de semne și simptome pot fi întâlnite în migrena clasică:
 - A. greață și vărsături;
 - B. HTA și hipercapnie;
 - C. cianoza și cefalee;
 - D. greață și polurie;
 - E. insomnie și tremor de repaus;
13. Ce tip de cefalee asociază fenomene vegetative de tip lăcrimare și rinoree în timpul crizei:
 - A. cefaleea psihogenă;
 - B. cefaleea din nevralgia de trigemen;
 - C. cefalee din meningită;
 - D. cefaleea „cluster headache”;
 - E. cefaleea din nevrita retrobulbară;
14. Claudicația intermitentă este:
 - A. o durere bine localizată, persistentă, intensă;
 - B. o durere pulsătilă, accentuată sincron cu activitatea cardiacă;
 - C. o durere persistentă, bine localizată, puțin intensă;

- D. o durere localizată într-o masă musculară, apărută în timpul efortului și care cedează în repaus;
- E. o durere imprecis localizată, cu senzație de constricție, cedează la așesare;
15. Definiția durerii:
- A. este o experiență senzitivă sau senzorială nepălăcută produsă de factor externi;
- B. este o experiență senzitivă și emoțională nepălăcută asociată cu leziune tisulară actuală sau potențială;
- C. este o reacție de apărare a organismului la agresivitatea factorilor de mediu externi și interni, manifestată prin modificarea parametrilor vitali;
- D. este o experiență fizică la contactul cu factorii de mediu potențial patogeni;
- E. este o experiență fizică sau emoțională nepălăcută indusă de mecanisme patologice externe sau interne;
16. Durerea somatică superficială:
- A. durere bine localizată, suprafața corporală, intensitate proporțională cu severitatea stimulului, calitatea corelată cu natura stimulului;
- B. durere localizată cutaneo-mucos, pe o suprafață mică, extraordinar de intensă, cu senzație de asur și durată mare;
- C. durere localizată pe un hemitorp, intensitate și calitate proporțională cu stimulul produs, durată relativ scurtă corelată cu natura stimulului;
- D. durere localizată relativ bine, pe o suprafață variabilă, cu intensitate mare sau foarte mare, corelată cu natura stimulului și învariabil asociată cu manifestări vegetative;
- E. durere bine localizată pe un segment al corpului, intensitate mică, medie, calitate proporțională cu severitatea stimulului, asociind variabil manifestări vegetative sau viscerale;
17. Migrena:
- A. nu este pulsantă;
- B. este de intensitate mică, medie și nu afectează activitățile cotidiene;
- C. este bine localizată - hemicranie;
- D. iradiază obișnuit, spre zona gâtului;
- E. este originară în nociceptoni viscerali de la nivelul capului;
18. Migrena:
- A. este o durere pulsantă;
- B. este de intensitate mică și nu afectează activitățile cotidiene;
- C. este localizată exclusiv la nivelul scapului parieto-occipital;
- D. iradiază, obișnuit, spre zona gâtului;
- E. nu are manifestări generale;
- Fantere - dr. O.M.S.
19. Caniția definește:
- A. pierderea părului epicranian dermatal genetic;
- B. pierderea patologică dobândită a părului din hipotiroide;
- C. procesul de albire a părului pornit de la un păr colorat;
- D. pierderea generalizată tranzitorie a părului care apare după tratament citostatic;
- E. o noțiune sinonimă cu leucotrichia;
20. Despre coloniche este falsă:
- A. reprezintă inversul unghiei hipocratice din punct de vedere al modificărilor de formă care apar;
- B. definește deformarea unghiei cu apariția unei concavități transversale;
- C. definește deformarea unghiei cu apariția unei convexități transversale;
- D. se însoțește de subțierea și fragilizarea unghiei;
- E. poate apare în anemiile feriprive;
21. Despre hipericocoră este falsă:
- A. dezvoltarea excesivă a părului respectă arealul normal al pilozității;
- B. dezvoltarea excesivă a părului apare în zone normale nepiloase;
- C. poate fi localizată sau generalizată;
- D. poate apare după fracturi, traumatisme;
- E. poate fi congenitală;
22. Despre hipocratismul digital este falsă:
- A. face parte din osteoartropatia hipertrofică pneumatică;
- B. aspectul este de „deget în băț de toboșar”;
- C. apare hipertrofia osoasă a falangelor distale și a fesului subungual și unghia hipocratice;
- D. poate să apară în tumorile pulmonare;
- E. este caracteristic cirozei hepatice;
23. Despre modificările de culoare ale unghiilor este falsă:
- A. leuconchia apare în insuficiența hepatică;
- B. unghie galbene apar în ocroroză;
- C. unghie negre apar în excesul de acid homogenizant;
- D. unghie brune apar în hemocromoză;
- E. linile Mees apar la nivelul unghiilor în intoxicația cu fluoruri;
24. Despre unghia hipocratice u.a.s.c.g.e.:
- A. apare modificarea curburi unghiei atât în sens transversal, cât și longitudinal;
- B. unghia apare convexă;
- C. este cunoscută și sub denumirea de unghie „în sică de ceas”;
- D. în asocieră cu hipertrofia osoasă a falangelor distale și a fesului subungual realizează hipocratismul digital;
- E. este cunoscută și sub denumirea de coloniche;
25. Despre unghie normale este falsă:
- A. sunt formațiuni cornoase;
- B. sunt transparente;
- C. sunt ușor curbate transversal;
- D. sunt subțiri;
- E. sunt opace, având culoare roz-pai;
26. Linile Mees care pot apare la nivelul unghiilor reprezintă:
- A. dungă albe, longitudinale care pot apare în intoxicația cu arsenic;
- B. hemoragii „în flacăra” apărute în axul longitudinal al unghiei în endocardita bacteriană;
- C. dunga maro care traversează unghia de la un capăt la altul și care pot apare în melanom;
- D. dungă albe, transversale care pot apare în intoxicația cu fluoruri;
- E. dunga de demarcație de la nivelul unghiei jumătate albă, jumătate roșie care poate apare în hipoproteinemie;
27. Modificările din onicogriroză includ:
- A. îngroșarea unghiei;
- B. opacifierea unghiei;
- C. colorația galben-brună a unghiei;
- D. fragilizarea unghiei;
- E. accentuarea curburi unghiei;
28. Onicomadexa definește:
- A. despicarea unghiei de patul unghial;
- B. caderea unghiei;
- C. lipsa unghiei;
- D. îngroșarea unghiei;
- E. subțierea unghiei;
29. Pahionichia definește:
- A. îngroșarea unghiei;
- B. subțierea unghiei;
- C. caderea unghiei;
- D. despicarea unghiei de patul unghial;
- E. lipsa unghiei;
30. Semnele de virilizare includ:
- A. îngroșarea voci;
- B. amenoree;
- C. atrofia glandelor mamare;
- D. dezvoltarea musculară;
- E. hipertrofia;

Testul adipos - dr.D.D.

dr.M.D.T.

- Fiziologia reglării greutății
31. U.d.f.d. fiziologia reglării greutății s.c.f.g.e.:
- A. Individul sănătos își menține greutatea corporală;
- B. la un punct de echilibru toate;
- C. stabiți în condițiile în care, în;
- D. mod normal, aportul de calorii și nivelul de activitate;
- E. nu variază de la o zi la alta.
32. R.I. fiziologia reglării greutății, u.a.s.c.g.e.:
- A. din cauza importanței fiziologice a menținerii depozitelor de energie, scăderea în greutate voluntară este dificil de realizat și de menținut;
- B. centrul hipotalamic al foamei/alimentației și sățietății joacă un rol central în reglarea apetitului și a metabolismului;
- C. hipoglicemia stimulează centrul sățietății;
- D. α-MSH acționează prin receptorul MC4R al melanocortinei pentru a scădea apetitul;
- E. reducerea tesutului adipos se asociază cu creșterea producției de leptină;
33. R.I. fiziologia reglării greutății, u.a.s.c.g.e.:
- A. apetitul și metabolismul sunt reglate de o rețea complexă de factori nervoși și hormoni;
- B. crește înaintea de mese și scade după mese;
- C. stimulează secreția hormonului de creștere din adenohipofiză;
- D. este produsă în principal de celulele P/D, situate în porțiunea funcțională a stomacului și de celulele E din pancreas;
- E. este produsă și în nucleul arcuat din hipotalamus;
- Scăderea în greutate
39. R.I. scăderea în greutate, u.a.s.c.g.e.:
- A. scăderea în greutate semnificativă neînțelegătoare la un individ anterior sănătos prevestește adesea o boală sistemică subiacentă;
- B. odată cu înalțarea în vârstă, cheltuielile de energie în repaus crește;
- C. cheltuielile de energie în repaus este influențată de funcția tirodiană;
- D. modificările greutății pot implica scăderea masei tisulare sau a conținutului de lichide din organism;
- E. scăderea în greutate se produce când cheltuielile de energie depășesc cantitatea de energie disponibilă pentru utilizare;
40. R.I. scăderea în greutate, u.a.s.c.g.e.:
- A. examinarea medicală de rutină trebuie să includă evaluarea modificărilor greutății corporale;
- B. odată cu înalțarea în vârstă, compoziția corpului se schimbă, masa musculară crește, iar tesutul adipos scade;
- C. aproximativ 40% din aportul caloric este cheltuit pentru activitatea fizică;
- D. un deficit de 3800 kcal se corelează în general cu pierderea a 0.5 kg de grăsime corporală;
- E. aportul de alimente poate fi influențat de o mare varietate de stimuli vizuali, olfactivi și gustativi;
41. R.I. scăderea în greutate, u.a.s.c.g.e.:
- A. pierderea a 25% din greutatea corporală în decurs de 5-12 luni ar trebui să determine investigații suplimentare;
- B. la cei mai mulți indivizi, aproximativ jumătate din energia alimentelor este utilizată pentru procese bazale, cum ar fi procesele intelectuale;

C. aștept pot folosi >50% din aportul caloric în timpul efortului. intens:

D. în interpretarea variațiilor în greutate trebuie avută în vedere greutatea apoi (1 kg/l) câștigată sau pierdută;

E. aportul de alimente poate fi influențat de factori genetici, psihologici și sociali;

42. R.I. scăderea în greutate, u.a.s.c.g.e.:
A. odată cu înaintarea în vârstă, greutatea corporală scade (în medie cu 0.5% pe an, începând de pe la vârsta de 60 de ani);
B. la o persoană de 70 kg, activitatea bazală consumă ~1800 kcal/zi;
C. aproximativ 50% din aportul caloric furnizează energia folosită pentru digestia, absorbția și metabolizarea alimentelor;
D. pierderea în greutate care persistă timp de săptămâni sau luni reprezintă pierdere de masă tisulară;
E. procesele patologice care afectează absorbția se pot manifesta prin schimbarea frecvenței și a consistenței scaunelor;

43. C.d.u. NU este o cauză tipică de scădere în greutate:
A. scăderea ingestiei de hrană;
B. malabsorbție;
C. pierderea de calorii;
D. șezutul în fotoliu;
E. creșterea necesarului de energie.

44. C.d.u. NU afectează absorbția:
A. insuficiență pancreatică;
B. colecistită acută;
C. sprue celiac;
D. leziuni de iradiere;
E. infecție;

45. C.d.u. NU afectează absorbția:
A. colestază;
B. tumori intestinale;
C. boală inflamatorie colonică;
D. hipocaciditate gastrică;
E. efecte ale medicamentelor;

46. C.d.u. NU este o cauză de pierdere netă de calorii:
A. vărsăturile;
B. aportul alimentar;
C. diareea;
D. glicozuria din DZ;
E. drenajul prin fistulă;

47. R.I. scăderea în greutate semnificativă neintenționată, u.a.s.c.g.e.:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-2, c-3;
C. a-2, b-1, c-2;
D. a-2, b-1, c-2, d-1;
E. a-2, b-1, c-2, d-1;

54. R.I. cele mai frecvente cauze de scădere în greutate în funcție de vârstă (așadar cele care

A. indică un prognostic nefavorabil la diverse categorii de persoane/pacienți:
B. este asociată cu mortalitate și morbiditate crescute, mai ales la tineri, asocieri care persistă chiar și după luarea în considerare a afecțiunilor comorbide;
C. previne infecțiile;
D. la pacienții neoplasici, se asociază cu o capacitate funcțională scăzută;
E. la pacienții neoplasici, se asociază cu supraviețuire mai mică;

48. R.I. scăderea în greutate semnificativă neintenționată, u.a.s.c.g.e.:
A. este relativ frecventă, în special la vârstnici;
B. este asociată cu o mortalitate scăzută;
C. poate fi însoțită și de deficite de vitamine și de principii nutritive;
D. la pacienții neoplasici, se asociază cu răspuns mai prost la chimioterapie;
E. depășind 4.5 kg (în 6 luni), se asociază cu mortalitate mai mare în urma unei intervenții chirurgicale, chiar dacă aceasta este electivă;

49. R.I. cauzele scăderii în greutate, u.a.s.c.g.e.:
A. DZ nou instalat este adesea însoțit de scădere în greutate;
B. depresia și izolarea pot provoca scădere în greutate marcată, în special la vârstnici;
C. FNT-α mobilizează preferențial grăsimea, dar cruță mușchii scheletici;
D. cancerul care produce cel mai adesea scădere în greutate la vârstnici este cel prostatic;
E. BPOC produce scădere în greutate prin efortul excesiv exercitat de mușchii respiratori;

50. F.d.u. mecanisme ale scăderii în greutate:
1. glicozurie și lipsa acțiunilor anabolice ale insulinei;
2. anorexie și creșterea cheltuielii energetice în repaus;
3. anorexie, lipsa resurselor și a suportului;
și următoarele stări patologice:
a. DZ netratat;
b. izolarea (mai ales la vârstnici);
c. boala pulmonară cronică;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;

B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-1, c-1, d-2;
E. a-2, b-1, c-2, d-1;

51. F.d.u. mecanisme ale scăderii în greutate:
1. creșterea metabolismului energetic în repaus;
2. anorexie și creșterea cheltuielii energetice în repaus;
3. intoleranță digestivă (anorexie, greață, vărsături);
și următoarele stări patologice:
a. hipertridism;
b. insuficiență renală;
c. insuficiență cardiacă congestivă;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;

52. F.d.u. mecanisme ale scăderii în greutate:
1. creșterea metabolismului;
2. anorexie, lipsa resurselor;
3. citokine proinflamatoare, catabolism crescut, anorexie;
și următoarele stări patologice:
a. depresia (mai ales la vârstnici);
b. boli autoimune sistemice;
c. feocromocitom;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;

53. R.I. cele mai frecvente cauze de scădere în greutate în funcție de vârstă (așadar cele care trebuie vizate în mod special în demersul diagnostic), f.d.u. categorii de vârstă:
1. la vârstnici;
2. la persoane mai tinere;
și următoarele stări patologice:
a. depresie;
b. tulburări psihiatrice, inclusiv tulburări de alimentație;
c. DZ;
d. afecțiuni gastrointestinale benigne;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-1, d-2;
E. a-2, b-1, c-2, d-1;

54. R.I. cele mai frecvente cauze de scădere în greutate în funcție de vârstă (așadar cele care

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dăunează următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, r.i. = referitor/relațiile la; u.f.d. = următoarele fragmente dintr-o frază desprse;

59. R.I. cauzele scăderii în demersul diagnostic), f.d.u. categorii de vârstă:
1. la vârstnici;
2. la persoane mai tinere;
și următoarele stări patologice:
a. hipertridism;
b. lipsa suportului familial;
c. infecție, mai ales cu HIV;
d. cancer;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-2, b-1, c-1, d-2;
D. a-2, b-1, c-2, d-1;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;

60. R.I. cauzele scăderii în greutate, f.d.u. categorii:
1. afecțiuni neoplasice;
2. afecțiuni respiratorii;
3. factori legați de vârstă;
și următoarele cauze:
a. cancer hepatobiliar;
b. diminuarea gustului și a mirosului;
c. emfizem;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;

61. R.I. cauzele scăderii în greutate, f.d.u. categorii:
1. afecțiuni neoplasice;
2. afecțiuni respiratorii;
3. factori legați de vârstă;
și următoarele cauze:
a. invalidități funcționale;
b. neoplazii hematologice;
c. boala pulmonară obstructivă cronică;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-1, c-2;

62. R.I. cauzele scăderii în greutate, f.d.u. categorii:
1. afecțiuni neoplasice;
2. infecții sistemice trenante;
3. afecțiuni neurologice;
și următoarele cauze:
a. izolare;
b. cancer de prostată;
c. antibiotice;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-1, c-2;

63. R.I. cauzele scăderii în greutate, f.d.u. categorii:
1. afecțiuni neoplasice;
2. afecțiuni cardiace;
3. factori legați de vârstă;
și următoarele cauze:
a. boala Parkinson;
b. cancer mamar;
c. tuberculoză;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;

64. R.I. cauzele scăderii în greutate, f.d.u. categorii:
1. afecțiuni neoplasice;
2. infecții sistemice trenante;
3. afecțiuni neurologice;
și următoarele cauze:
a. boli neuromusculare;
b. cancer genitourinar;
c. parazitoză;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;

65. R.I. cauzele scăderii în greutate, f.d.u. categorii:
1. afecțiuni neoplasice;
2. infecții sistemice trenante;
3. afecțiuni neurologice;
și următoarele cauze:
a. cancer ovarian;
b. endocardită bacteriană subacută;
c. demență;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-1, c-2;

66. R.I. cauzele scăderii în greutate, f.d.u. categorii:
1. afecțiuni neoplasice;
2. medicamente;
3. factori sociali;
și următoarele cauze:
a. izolare;
b. cancer de prostată;
c. antibiotice;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dăunează următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, r.i. = referitor/relațiile la; u.f.d. = următoarele fragmente dintr-o frază desprse;

nificativă, aceasta este confirmată când este măsurată obiectiv; C. examenul fizic trebuie să înceapă cu măsurarea greutății și determinarea semnelor vitale (temperaturică, respirații); D. investigațiile paraclinice confirmă sau infirmă diagnosticul posibil sugerat de istoric și de examenul fizic;

E. indicatorii tumorali pot sugera o neoplazie oculară, dîrînd eventual investigații imagistice;

78. R.1. evaluarea/ diagnosticarea scăderii în greutate, u.a.s.c.g.e.; A. cancerul pulmonar trebuie avut în vedere doar la pacienții cu istoric de fumat; B. nu rareori, pacienții la care s-a produs o scădere în greutate semnificativă nu sunt conștienți de aceasta;

C. la bărbai trebuie efectuată examinarea rectală, incluzând examinarea prostatei;

D. examinarea neuropsihică trebuie să includă și teste de depistare pentru depresie;

E. la toți pacienții, determinările biochimice din ser trebuie să includă glucoză, electroliți, calciu, analize renale și hepatice;

79. U.f.d.f.d. evaluarea scăderii în greutate s.c.f.g.e.;

A. Dacă nu se găsește cauză, B. scăderii în greutate, se;

C. recomandăm urmărirea clinică;

D. atenția și electuarea unei baterii complete;

E. de investigații suplimentare.

80. U.f.d.f.d. evaluarea scăderii în greutate s.c.f.g.e.;

A. investigațiile imagistice;

B. abdominale prin TC sau RMN;

C. furnizează relativ frecvent diagnosticul;

D. în concordanță cu prevalența scăzută a bolilor digestive;

E. la pacienții cu scădere în greutate.

81. U.f.d.f.d. evaluarea scăderii în greutate s.c.f.g.e.;

A. Pe lângă testele obligatorii la toți pacienții investigații;

B. paraclinice trebuie să includă;

C. testele de depistare pentru cancer recomandate curent;

D. adecvate pentru grupul de sex și de vîrstă;

E. cum ar fi scintigrafia și ecografia abdominală.

82. U.f.d.f.d. evaluarea scăderii în greutate s.c.f.g.e.;

A. în absența unei măsurări obiective a greutății scăderii;

B. în greutate a unui pacient;

C. poate fi confirmată prin faptul că trebuie;

D. să strîngă curea sau mai mult;

E. sau că hainele i-au rămas mici;

83. U.f.d.f.d. diagnosticarea scăderii în greutate s.c.f.g.e.;

A. Scăderea în greutate poate fi;

B. prima manifestare în hipertiroidismul subclinic/ frust;

C. mai ales la pacienții tineri;

D. care se pot prezenta cu scădere în greutate și astenie;

E. și cu puține alte manifestări de tireotoxicoză.

84. R.1. cauza scăderii în greutate, f.d.u. manifestări care sugerează afectarea unui anumit aparat organelor:

1. hiperpigmentație, hiponatremie și hiperkalemie;

2. pneumonie post-obstructivă, dispnee, use, hemoptize;

3. greeță/ vărsături, tîburări de tranziț, anemie feriprivă;

a. cancer pulmonar;

b. insuficiență corticosuprarenaliană;

c. cancer digestiv;

care sunt asocierile corecte:

A. a-1, b-2, c-3;

B. a-2, b-1, c-3;

C. a-2, b-3, c-1;

D. a-3, b-1, c-2;

E. a-3, b-2, c-1;

85. Scăderea în greutate poate fi prima manifestare în:

A. boli infectioase teranale;

B. tumori digestive;

C. cancerul pulmonar;

D. hipertiroidismul subclinic/ frust;

E. boala Cushing;

86. Scăderea în greutate poate fi prima manifestare în boli infectioase teranale, cum s.u.c.g.e.;

A. infecția cu HIV;

B. tuberculoză;

C. amigdalita acută;

D. infecții fungice;

E. infecții parazitare;

87. R.1. evaluarea scăderii în greutate, f.d.u. metode de culegere a informațiilor:

1. istoric – simptome generale;

2. istoric;

3. examenul fizic – elemente care pot direcționa evaluarea;

82. U.f.d.f.d. evaluarea scăderii în greutate s.c.f.g.e.;

A. în absența unei măsurări obiective a greutății scăderii;

B. în greutate a unui pacient;

C. poate fi confirmată prin faptul că trebuie;

D. să strîngă curea sau mai mult;

E. sau că hainele i-au rămas mici;

83. U.f.d.f.d. diagnosticarea scăderii în greutate s.c.f.g.e.;

A. Scăderea în greutate poate fi;

B. prima manifestare în hipertiroidismul subclinic/ frust;

C. mai ales la pacienții tineri;

D. care se pot prezenta cu scădere în greutate și astenie;

E. și cu puține alte manifestări de tireotoxicoză.

84. R.1. cauza scăderii în greutate, f.d.u. manifestări care sugerează afectarea unui anumit aparat organelor:

1. hiperpigmentație, hiponatremie și hiperkalemie;

2. pneumonie post-obstructivă, dispnee, use, hemoptize;

3. greeță/ vărsături, tîburări de tranziț, anemie feriprivă;

a. cancer pulmonar;

b. insuficiență corticosuprarenaliană;

c. cancer digestiv;

care sunt asocierile corecte:

A. a-1, b-2, c-3;

B. a-2, b-1, c-3;

C. a-2, b-3, c-1;

D. a-3, b-1, c-2;

E. a-3, b-2, c-1;

85. Scăderea în greutate poate fi prima manifestare în:

A. boli infectioase teranale;

B. tumori digestive;

C. cancerul pulmonar;

D. hipertiroidismul subclinic/ frust;

E. boala Cushing;

86. Scăderea în greutate poate fi prima manifestare în boli infectioase teranale, cum s.u.c.g.e.;

A. infecția cu HIV;

B. tuberculoză;

C. amigdalita acută;

D. infecții fungice;

E. infecții parazitare;

87. R.1. evaluarea scăderii în greutate, f.d.u. metode de culegere a informațiilor:

1. istoric – simptome generale;

2. istoric;

3. examenul fizic – elemente care pot direcționa evaluarea;

82. U.f.d.f.d. evaluarea scăderii în greutate s.c.f.g.e.;

A. în absența unei măsurări obiective a greutății scăderii;

B. în greutate a unui pacient;

C. poate fi confirmată prin faptul că trebuie;

D. să strîngă curea sau mai mult;

E. sau că hainele i-au rămas mici;

83. U.f.d.f.d. diagnosticarea scăderii în greutate s.c.f.g.e.;

A. Scăderea în greutate poate fi;

B. prima manifestare în hipertiroidismul subclinic/ frust;

C. mai ales la pacienții tineri;

D. care se pot prezenta cu scădere în greutate și astenie;

E. și cu puține alte manifestări de tireotoxicoză.

84. R.1. cauza scăderii în greutate, f.d.u. manifestări care sugerează afectarea unui anumit aparat organelor:

1. hiperpigmentație, hiponatremie și hiperkalemie;

2. pneumonie post-obstructivă, dispnee, use, hemoptize;

3. greeță/ vărsături, tîburări de tranziț, anemie feriprivă;

a. cancer pulmonar;

b. insuficiență corticosuprarenaliană;

c. cancer digestiv;

care sunt asocierile corecte:

A. a-1, b-2, c-3;

B. a-2, b-1, c-3;

C. a-2, b-3, c-1;

D. a-3, b-1, c-2;

E. a-3, b-2, c-1;

85. Scăderea în greutate poate fi prima manifestare în:

A. boli infectioase teranale;

B. tumori digestive;

C. cancerul pulmonar;

D. hipertiroidismul subclinic/ frust;

E. boala Cushing;

86. Scăderea în greutate poate fi prima manifestare în boli infectioase teranale, cum s.u.c.g.e.;

A. infecția cu HIV;

B. tuberculoză;

C. amigdalita acută;

D. infecții fungice;

E. infecții parazitare;

87. R.1. evaluarea scăderii în greutate, f.d.u. metode de culegere a informațiilor:

1. istoric – simptome generale;

2. istoric;

3. examenul fizic – elemente care pot direcționa evaluarea;

82. U.f.d.f.d. evaluarea scăderii în greutate s.c.f.g.e.;

A. în absența unei măsurări obiective a greutății scăderii;

B. în greutate a unui pacient;

C. poate fi confirmată prin faptul că trebuie;

D. să strîngă curea sau mai mult;

E. sau că hainele i-au rămas mici;

83. U.f.d.f.d. diagnosticarea scăderii în greutate s.c.f.g.e.;

A. Scăderea în greutate poate fi;

B. prima manifestare în hipertiroidismul subclinic/ frust;

C. mai ales la pacienții tineri;

D. care se pot prezenta cu scădere în greutate și astenie;

E. și cu puține alte manifestări de tireotoxicoză.

84. R.1. cauza scăderii în greutate, f.d.u. manifestări care sugerează afectarea unui anumit aparat organelor:

1. hiperpigmentație, hiponatremie și hiperkalemie;

2. pneumonie post-obstructivă, dispnee, use, hemoptize;

3. greeță/ vărsături, tîburări de tranziț, anemie feriprivă;

a. cancer pulmonar;

b. insuficiență corticosuprarenaliană;

c. cancer digestiv;

care sunt asocierile corecte:

A. a-1, b-2, c-3;

B. a-2, b-1, c-3;

C. a-2, b-3, c-1;

D. a-3, b-1, c-2;

E. a-3, b-2, c-1;

85. Scăderea în greutate poate fi prima manifestare în:

A. boli infectioase teranale;

B. tumori digestive;

C. cancerul pulmonar;

D. hipertiroidismul subclinic/ frust;

E. boala Cushing;

86. Scăderea în greutate poate fi prima manifestare în boli infectioase teranale, cum s.u.c.g.e.;

A. infecția cu HIV;

B. tuberculoză;

C. amigdalita acută;

D. infecții fungice;

E. infecții parazitare;

87. R.1. evaluarea scăderii în greutate, f.d.u. metode de culegere a informațiilor:

1. istoric – simptome generale;

2. istoric;

3. examenul fizic – elemente care pot direcționa evaluarea;

82. U.f.d.f.d. evaluarea scăderii în greutate s.c.f.g.e.;

A. în absența unei măsurări obiective a greutății scăderii;

B. în greutate a unui pacient;

C. poate fi confirmată prin faptul că trebuie;

D. să strîngă curea sau mai mult;

E. sau că hainele i-au rămas mici;

83. U.f.d.f.d. diagnosticarea scăderii în greutate s.c.f.g.e.;

A. Scăderea în greutate poate fi;

B. prima manifestare în hipertiroidismul subclinic/ frust;

C. mai ales la pacienții tineri;

D. care se pot prezenta cu scădere în greutate și astenie;

E. și cu puține alte manifestări de tireotoxicoză.

84. R.1. cauza scăderii în greutate, f.d.u. manifestări care sugerează afectarea unui anumit aparat organelor:

1. hiperpigmentație, hiponatremie și hiperkalemie;

2. pneumonie post-obstructivă, dispnee, use, hemoptize;

3. greeță/ vărsături, tîburări de tranziț, anemie feriprivă;

a. cancer pulmonar;

b. insuficiență corticosuprarenaliană;

c. cancer digestiv;

care sunt asocierile corecte:

A. a-1, b-2, c-3;

B. a-2, b-1, c-3;

C. a-2, b-3, c-1;

D. a-3, b-1, c-2;

E. a-3, b-2, c-1;

85. Scăderea în greutate poate fi prima manifestare în:

A. boli infectioase teranale;

B. tumori digestive;

C. cancerul pulmonar;

D. hipertiroidismul subclinic/ frust;

E. boala Cushing;

86. Scăderea în greutate poate fi prima manifestare în boli infectioase teranale, cum s.u.c.g.e.;

A. infecția cu HIV;

B. tuberculoză;

C. amigdalita acută;

D. infecții fungice;

E. infecții parazitare;

87. R.1. evaluarea scăderii în greutate, f.d.u. metode de culegere a informațiilor:

1. istoric – simptome generale

3. investigațiile paraclinice care trebuie efectuate la toți pacienții; și u. elemente de diagnostic:
- a. aspecte financiare care pot afecta aportul de alimente;
 - b. hormonul stimulator al tiroidei;
 - c. disfație;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
 - B. a-2, b-1, c-3;
 - C. a-2, b-3, c-1;
 - D. a-2, b-3, c-2;
 - E. a-3, b-2, c-1;
95. R.I. evaluarea scăderii în greutate, f.d.u. metode de culegere a informațiilor:
1. istoric;
 2. examenul fizic – elemente care pot direcționa evaluarea;
 3. investigațiile paraclinice care trebuie efectuate la toți pacienții;
 - și u. elemente de diagnostic:
- a. semne de depresi;
 - b. palpitații;
 - c. examinarea detaliată a abdomenului;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
 - B. a-1, b-3, c-2;
 - C. a-2, b-1, c-3;
 - D. a-2, b-3, c-1;
 - E. a-3, b-2, c-1;
96. R.I. evaluarea scăderii în greutate, f.d.u. metode de culegere a informațiilor:
1. istoric;
 2. istoric – simptome;
 3. investigațiile paraclinice care trebuie efectuate la toți pacienții;
 - și u. elemente de diagnostic:
- a. hemoleucograma cu formulă leucocitară;
 - b. simptome de boală neurologică;
 - c. factori sociali;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
 - B. a-1, b-3, c-2;
 - C. a-2, b-1, c-3;
 - D. a-2, b-3, c-1;
 - E. a-3, b-2, c-1;
93. R.I. evaluarea scăderii în greutate, f.d.u. metode de culegere a informațiilor:
1. istoric;
 2. istoric – simptome digestive;
 3. investigațiile paraclinice care trebuie efectuate la toți pacienții;
 - și u. elemente de diagnostic:
- a. biochimie serică;
 - b. dificultate în alimentație;
 - c. manifestări de demență;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
 - B. a-2, b-1, c-3;
 - C. a-2, b-3, c-1;
 - D. a-3, b-1, c-2;
 - E. a-3, b-2, c-1;
94. R.I. evaluarea scăderii în greutate, f.d.u. metode de culegere a informațiilor:
1. istoric;
 2. istoric – simptome digestive;

100. R.I. evaluarea scăderii în greutate, f.d.u. metode de culegere a informațiilor:
1. istoric;
 2. examenul fizic – elemente care pot direcționa evaluarea;
 3. investigațiile suplimentare;
 - și u. elemente de diagnostic:
- a. candidoză orală;
 - b. TC toracic;
 - c. consum de alcool;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
 - B. a-2, b-1, c-3;
 - C. a-2, b-3, c-1;
 - D. a-3, b-1, c-2;
 - E. a-3, b-2, c-1;
101. R.I. evaluarea scăderii în greutate, f.d.u. metode de culegere a informațiilor:

1. istoric;
2. examenul fizic – elemente care pot direcționa evaluarea;
3. investigațiile suplimentare;
- și u. elemente de diagnostic:
- a. medicamente;
 - b. indicatori tumorali;
 - c. leziuni dentare;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
 - B. a-1, b-3, c-2;
 - C. a-2, b-1, c-3;
 - D. a-3, b-1, c-2;
 - E. a-3, b-2, c-1;
- Starea de hidratare – dr.D.D., dr.M.D.T.**
102. R.I. starea de hidratare, u.a.s.c.g.e.:
- A. proporția de apă din greutatea organismului crește pe măsură ce avansăm în vârstă;
 - B. la nou-născuți apa reprezintă 75-78% din greutatea organismului;
 - C. la femeia adultă, apa reprezintă 55% din greutatea organismului;
 - D. din spațiul extracelular, 75% reprezintă compartimentul extravascular (interstițial);
 - E. substanța fundamentală a țesutului conjunctiv este formată din proteoglicani hidratați;
103. R.I. starea de hidratare, u.a.s.c.g.e.:
- A. pe măsură ce îmbătrânim, ne „uscăm”;
 - B. la vârsta de un an, apa reprezintă 65% din greutatea organismului;
 - C. la femei, proporția de apă din greutatea organismului este mai mică decât la bărbați întrucât proporția de țesut adipos este mai mare;
 - D. din spațiul extracelular, 25% reprezintă compartimentul intravascular (vascular);
 - E. țesut conjunctiv este alcătuit din celule, fibre, substanță fundamentală;
104. R.I. starea de hidratare, u.a.s.c.g.e.:
- A. apa reprezintă ~60% din greutatea organismului;
 - B. proporția de apă din greutatea organismului este cu atât mai mică cu cât proporția de țesut adipos este mai mică;
 - C. din apa totală a organismului, două treimi reprezintă compartimentul spațiului intracelular;

- D. țesutul interstițial conține Țesut conjunctiv;
- E. deshidratarea reprezintă scăderea apei interstițiale sub nivelul necesar pentru hidratarea maximală a proteoglicanilor;
105. R.I. starea de hidratare, u.a.s.c.g.e.:
- A. la tineri proporția de apă este mai mică;
 - B. la bărbatul adult, apa reprezintă 60% din greutatea organismului;
 - C. din apa totală a organismului, o treime reprezintă compartimentul spațiului extracelular;
 - D. țesut conjunctiv este alcătuit din trei componente;
 - E. edemul apare când cantitatea de apă interstițială crește peste nivelul necesar pentru hidratarea maximală a proteoglicanilor;
106. U.f.d.f.d. starea de hidratare s.c.f.g.e.:
- A. în mod normal, cantitatea de apă din Țesutul interstițial;
 - B. este exact cât poate fi legată;
 - C. de proteoglicani atunci când aceștia;
 - E. sunt hidratați minimal.
- Deshidratarea**
107. R.I. deshidratare, u.a.s.c.g.e.:
- A. deshidratarea reprezintă scăderea cantității totale de apă din organism;
 - B. limbă uscată este un semn relevant pentru deshidratare doar în măsura în care pacientul respiră pe gură;
 - C. corectarea rapidă (>2 mEq/L/h) a deshidratării hiponatremice poate produce mielinoliză centrală, mai ales pontină;
 - D. în deshidratarea hiponatremică, rehidratarea trebuie făcută lent (în 248 de ore);
 - E. dintre diuretice, Țiazidele determină hiponatremie mai frecvent furosemidul;
108. R.I. deshidratare, u.a.s.c.g.e.:
- A. deshidratarea presupune scăderea volumului de lichid atât intracelular, cât și extracelular;
 - B. clasificarea deshidratării se face în funcție de osmolaritate și de severitate;
 - C. pentru siguranță, creșterea natremiei în deshidratarea hiponatremică este de dorit să depășească 10-12 mEq/Lzi;
 - D. hipoadosteronismul provoacă deshidratare hiponatremică, asoc.
109. R.I. deshidratare, u.a.s.c.g.e.:
- A. manifestările clinice ale deshidratării sunt mai ales consecința nivelului sodiului;
 - B. sodiul seric poate fi folosit drept indicator al osmolarității (în măsura în care glicemia este normală);
 - C. corectarea natremiei în deshidratarea hiponatremică este preferabil să se realizeze cu cel puțin 8 mEq/Lzi;
 - D. SPSC (sindromul de pierdere de sare cerebrală) este un diagnostic de excludere și poate fi confundat cu sindromul de secreție inadecvată de ADH;
 - E. furosemidul crește hipertonie medulară;
110. F.d.u. afirmații/ evenimente care explică de ce diureticele Țiazidice produc mai frecvent hiponatremie decât furosemidul:
- a. hipertonie medulară nu este influențată (nu este scăzută);
 - b. apa este reabsorbită din tubul colector când acesta traversează medulara hipertonă;
 - c. apa reabsorbită în circulație diluează sodiul plasmatic;
 - d. Țiazidicele acționează în tubul distal, care este situat în corticală;
- care este lanțul cauzal/ logic just:
- A. a→c→d→b;
 - B. b→a→d→c;
 - C. b→d→a→c;
 - D. c→d→b→a;
 - E. d→a→b→c;
111. F.d.u. afirmații/ evenimente care explică de ce furosemidul produce mai rar hiponatremie decât diureticele Țiazidice:
- a. acționează la nivelul ansei Henle, care traversează medulară;
 - b. sodiul plasmatic nu este diluat;
 - c. scade hipertonie medulară;
 - d. scade reabsorbția apei din tubul colector când acesta traversează medulara hipotonă;
 - e. împiedică trecerea sodiului din lumenul ansei Henle în medulară;
- care este lanțul cauzal/ logic just:
- A. a→e→c→d→b;
 - B. b→a→c→d→e;
 - C. c→a→b→d→e;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintr-o următoare; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, r.l. = referitor/referențiale; u.f.d.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază desprins.

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintr-o următoare; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, r.l. = referitor/referențiale; u.f.d.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază desprins.

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintr-o următoare; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, r.l. = referitor/referențiale; u.f.d.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază desprins.

- d. apa intravasculară trece în spațiul extravascular;
care este lanțul causal corect:
A. a → c → d → b;
B. b → a → c → d;
C. b → c → d → a;
D. c → a → b → d;
E. d → b → a → c;
131. F.d.u. evenimentele/ manifestări care pot să apară în deshidratarea hiponatremică:
a. hiperhidratare intracelulară;
b. apa migrează în celule;
c. crampes musculare, apatie, convulsii, hipertensiune intracraniană, hiperemie cerebrală;
care este lanțul causal corect:
A. a → b → c;
B. a → c → b;
C. b → a → c;
D. b → c → a;
E. c → a → b;
132. F.d.u. evenimentele/ manifestări care pot să apară în deshidratarea hipernatremică:
a. hipovolemia este mai puțin importantă;
b. pierdere excesivă de apă (față de sodiu);
c. hipernatremie;
d. apa extravasculară trece în spațiul intravascular;
care este lanțul causal corect:
A. a → c → d → b;
B. a → c → d → a;
C. b → c → d → a;
D. c → d → a → b;
E. d → c → a → b;
133. F.d.u. evenimentele/ manifestări care pot să apară în deshidratarea hipernatremică:
a. deshidratare celulară;
b. pentru a compensa, celulele generează particule active osmotice (osmoli idogeni);
c. apa este trasă din celule osmotice în spațiul extracelular;
d. creșterea osmolarității intracelulare trage apa înapoi în celule pentru a menține volumul de fluid intracelular;
care este lanțul causal corect:
A. a → c → d → b;
B. a → d → b → c;
C. b → c → d → a;
D. c → a → b → d;
E. d → b → a → c;
134. F.d.u. evenimentele/ manifestări care pot să apară în deshidratarea hipernatremică la rehidratare rapidă:
a. umflarea celulei;
b. osmolaritatea intracelulară crescută (prin osmoli idogeni);
c. influx masiv de apă;
d. edem cerebral;
e. ruperea membranei;
care este lanțul causal corect:
A. a → e → b → c → d;
B. a → e → c → b → d;
C. b → c → a → e → d;
D. c → b → a → d → e;
E. d → a → c → e → b;
135. R.I. două cauze ale hiponatremiei, f.d.u. categorii [SPSC = sd. de pierdere de sare cerebrală, SIADH = sd. de secreție inadecvată de ADH]:
1. SPSC și SIADH;
2. SPSC;
3. SIADH;
și următoarele trăsături:
a. hiponatremie asociată cu hipovolemie;
b. cauzat de leziuni cerebrale (hemoragie, traumatisme, tumoră, inflamație);
c. concentrația urinară a sodiului este <100 mEq/L, întrucât odala cu sodiu se pierde și apă;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
136. R.I. două cauze ale hiponatremiei, f.d.u. categorii:
1. SPSC;
2. SIADH;
și următoarele trăsături:
a. concentrația urinară a sodiului este >100 mEq/L;
b. hiponatremie corectabilă prin restricție de lichide;
c. naștere neadevărată în asocieră cu leziuni cerebrale;
d. hiponatremie asociată cu hipovolemie;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-2, b-1, c-1, d-2;
D. a-2, b-1, c-2, d-1;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;
140. F.d.u. cauze renale ale deshidratații hiponatremice:
1. excreția unui solvit activ osmotice și puțin sau deloc reabsorbabil;
2. nefropatii cu pierdere de sare prin funcție tubulară perturbată;
3. scăderea aldosteronului sau a efectelor renale ale acestuia;
și următoarele stări patologice:
a. nefropatii tubulointerstițiale (mai ales producătoare de acidoză renală tubulară de tip 4);
b. cetoacidoză diabetică sau alcoolică;
c. uropatie post-obstructivă;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-2, b-1, c-1, d-2;
D. a-2, b-1, c-2, d-1;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;
143. F.d.u. cauze renale ale deshidratații hiponatremice:
1. excreția unui solvit activ osmotice și puțin sau deloc reabsorbabil;
2. nefropatii cu pierdere de sare prin funcție tubulară perturbată;
3. scăderea aldosteronului sau a efectelor renale ale acestuia;
și următoarele stări patologice:
a. nefropatii tubulointerstițiale (mai ales producătoare de acidoză renală tubulară de tip 4);
b. cetoacidoză diabetică sau alcoolică;
c. uropatie post-obstructivă;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-2, b-1, c-1, d-2;
D. a-2, b-1, c-2, d-1;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;
144. F.d.u. cauze renale ale deshidratații hiponatremice:
1. excreția unui solvit activ osmotice și puțin sau deloc reabsorbabil;
2. nefropatii cu pierdere de sare prin funcție tubulară perturbată;
și următoarele stări patologice:
a. faza de vindecare a NTA;
b. biconditație (ART) sau alcaloză metabolică;
c. cetonurie;
d. nefropatie de reflux;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-1, d-2;
E. a-2, b-1, c-2, d-1;
142. F.d.u. cauze renale ale deshidratații hiponatremice:
1. excreția unui solvit activ osmotice și puțin sau deloc reabsorbabil;
2. nefropatii cu pierdere de sare prin funcție tubulară perturbată;
3. scăderea aldosteronului sau a efectelor renale ale acestuia;
și următoarele stări patologice:
a. insuficiență corticosuprarenală;
b. nefropatii interstițiale;
c. cetoacidoză prin privare de alimente;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
143. F.d.u. cauze renale ale deshidratații hiponatremice:
1. excreția unui solvit activ osmotice și puțin sau deloc reabsorbabil;
2. nefropatii cu pierdere de sare prin funcție tubulară perturbată;
3. scăderea aldosteronului sau a efectelor renale ale acestuia;
și următoarele stări patologice:
a. insuficiență corticosuprarenală;
b. nefropatii interstițiale;
c. cetoacidoză prin privare de alimente;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
144. F.d.u. cauze renale ale deshidratații hiponatremice:
1. excreția unui solvit activ osmotice și puțin sau deloc reabsorbabil;
2. nefropatii cu pierdere de sare prin funcție tubulară perturbată;
3. scăderea aldosteronului sau a efectelor renale ale acestuia;
și următoarele stări patologice:
a. insuficiență corticosuprarenală;
b. nefropatii interstițiale;
c. cetoacidoză prin privare de alimente;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
145. R.I. cauzele deshidratații hipernatremice, f.d.u. categorii:
1. polurie prin pierdere osmotice de apă;
2. polurie prin secreție/acțiune deficitară a ADH;
3. transpirație, și următoarele stări patologice:
a. hiperpirexie/ șoc termic;
b. manitol administrat intravenos;
c. diabet insipid nefrogen;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-3, c-2;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
146. U.I.d.f. edem și la RHS în general s.c.f.g.e.:
- A. Edemul trebuie încadrat;
B. într-o viziune mai largă;
C. întrucât se referă la presiunea osmotice;
147. R.I. edem și la RHS în de proteoglicani din țesutul interstițial (mixedem);
- A. în hipotirodie crește cantitatea de proteoglicani din țesutul interstițial (mixedem);
- B. cantitatea de apă reținută în spațiul interstițial poate depăși 15-20 kg;
- C. unul dintre mecanismele prin care organismul previne acumularea de lichid în spațiul interstițial este scăderea fluxului limfatic;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele; r.I. = referitor/referitoare la; U.I.d.f.d. = Următoarele fragmente dintre-o frază desprins;

- A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
141. F.d.u. cauze renale ale deshidratații hiponatremice:
1. excreția unui solvit activ osmotice și puțin sau deloc reabsorbabil;
2. nefropatii cu pierdere de sare prin funcție tubulară perturbată;
și următoarele stări patologice:
a. faza de vindecare a NTA;
b. biconditație (ART) sau alcaloză metabolică;
c. cetonurie;
d. nefropatie de reflux;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-1, d-2;
E. a-2, b-1, c-2, d-1;
142. F.d.u. cauze renale ale deshidratații hiponatremice:
1. excreția unui solvit activ osmotice și puțin sau deloc reabsorbabil;
2. nefropatii cu pierdere de sare prin funcție tubulară perturbată;
3. scăderea aldosteronului sau a efectelor renale ale acestuia;
și următoarele stări patologice:
a. insuficiență corticosuprarenală;
b. nefropatii interstițiale;
c. cetoacidoză prin privare de alimente;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
143. F.d.u. cauze renale ale deshidratații hiponatremice:
1. excreția unui solvit activ osmotice și puțin sau deloc reabsorbabil;
2. nefropatii cu pierdere de sare prin funcție tubulară perturbată;
3. scăderea aldosteronului sau a efectelor renale ale acestuia;
și următoarele stări patologice:
a. insuficiență corticosuprarenală;
b. nefropatii interstițiale;
c. cetoacidoză prin privare de alimente;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
144. F.d.u. cauze renale ale deshidratații hiponatremice:
1. excreția unui solvit activ osmotice și puțin sau deloc reabsorbabil;
2. nefropatii cu pierdere de sare prin funcție tubulară perturbată;
3. scăderea aldosteronului sau a efectelor renale ale acestuia;
și următoarele stări patologice:
a. insuficiență corticosuprarenală;
b. nefropatii interstițiale;
c. cetoacidoză prin privare de alimente;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
145. R.I. cauzele deshidratații hipernatremice, f.d.u. categorii:
1. polurie prin pierdere osmotice de apă;
2. polurie prin secreție/acțiune deficitară a ADH;
3. transpirație, și următoarele stări patologice:
a. hiperpirexie/ șoc termic;
b. manitol administrat intravenos;
c. diabet insipid nefrogen;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-3, c-2;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
146. U.I.d.f. edem și la RHS în general s.c.f.g.e.:
- A. Edemul trebuie încadrat;
B. într-o viziune mai largă;
C. întrucât se referă la presiunea osmotice;
147. R.I. edem și la RHS în de proteoglicani din țesutul interstițial (mixedem);
- A. în hipotirodie crește cantitatea de proteoglicani din țesutul interstițial (mixedem);
- B. cantitatea de apă reținută în spațiul interstițial poate depăși 15-20 kg;
- C. unul dintre mecanismele prin care organismul previne acumularea de lichid în spațiul interstițial este scăderea fluxului limfatic;
- C. pentru acumularea de lichid în peritoneu se folosește curent termic de ascie;
D. la producerea edemului din a doua jumătate a ciclului menstrual (edem catamenial) contribuie inflamația sistemică;
E. după resorbția rapidă a edemului, tegumentul prezintă pliuri longitudinale fine;
148. R.I. edem și la RHS în general, u.a.s.c.g.e.:
- A. edemul reprezintă creșterea cantității de apă din țesutul interstițial;
B. la instituirea tratamentului diuretic, se poate produce în primele zile o creștere în greutate în ciuda unei reduceri sesizabile edemelor;
C. apa (și solvii difuzibili) revin în compartimentul vascular pe la extremitatea venoasă a capilarului;
D. când nu se cunoaște cauza acumulării de lichid într-o seroasă, se folosește de multe ori termenul revărsat lichidian sau pur și simplu lichid;
E. la producerea edemului din obezitate contribuie excesul de hormoni feminini;
149. R.I. edem și la RHS în general, u.a.s.c.g.e.:
- A. creșterea cantității de proteoglicani din țesutul interstițial nu reprezintă edem;
B. greutatea la care se ajunge după eliminarea întregii cantități de apă reținute în spațiul interstițial se numește greutate uscată;
C. apa (și solvii difuzibili) revin în compartimentul vascular și prin limfatic;
D. când nu se cunoaște cauza acumulării de lichid în pleură, termenul corect este pleurezie;
E. edemul vechi este cartonat, dur prin acumulare de macrofage;
150. R.I. edem și la RHS în general, u.a.s.c.g.e.:
- A. în hipotirodie crește cantitatea de proteoglicani din țesutul interstițial (mixedem);
- B. cantitatea de apă reținută în spațiul interstițial poate depăși 15-20 kg;
- C. unul dintre mecanismele prin care organismul previne acumularea de lichid în spațiul interstițial este scăderea fluxului limfatic;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele; r.I. = referitor/referitoare la; U.I.d.f.d. = Următoarele fragmente dintre-o frază desprins;

- D. când nu se cunoaște cauza acumulării de lichid în pericard, se folosește termenul revărsat lichidian pericardic sau doar lichid pericardic;
- E. după resorbția rapidă a edemului, tegumentul rămâne „încrețit”;
151. R.I. edem și la RHS în general, u.a.s.c.g.e.:
A. mixedemul este localizat în mod tipic periorbital, dar poate să apară și în regiunea preibială;
- B. edemul poate masca o reducere importantă a țesutului adipos (și adesea și a celui muscular);
- C. creșterea fluxului limfatic se produce drept răspuns la creșterea transsudată de lichid în spațiul interstțial;
- D. există două categorii de mecanisme prin care poate să apară exces de apă în interstțiu;
- E. în etapa de preeдем apare oligurie și creșterea în greutate de 4-6 kg, țărta edem vizibil;
152. R.I. edem și la RHS în general, u.a.s.c.g.e.:
A. pielea de deasupra zonei edemate pare îngroșată, deși în realitate este adesea supusă din cauza nutriției deficiente;
- B. cele mai frecvente boli edematoase cronice sunt IC și celiția ulcerată;
- C. creșterea fluxului limfatic se produce în măsură în care nu există un blocaj al canalelor limfatice;
- D. excesul de apă din interstțiu poate fi produs prin modificarea presiunilor care deplasează apa prin bariera dintre compartimentul vascular și cel interstțial;
- E. edemul asimetric produs de decubitul preferențial pe o parte poate induce în eroare cu privire la etiologia edemului;
153. R.I. edem și la RHS în general, u.a.s.c.g.e.:
A. distribuția edemului oferă informații importante cu privire la cauză;
- B. în cele mai frecvente boli edematoase cronice se produce adesea o creștere importantă a țesutului adipos (și frecvent și a celui muscular);
- C. există schimburi ample între compartimentele vascular și extravascular;
- D. excesul de apă din interstțiu poate fi produs prin creșterea permeabilității barierei dintre compartimentul vascular și cel interstțial;
- E. edemul asimetric produs de decubitul preferențial pe o parte poate sugera că edemul nu ar fi generalizat, ci localizat;
154. R.I. edem și la RHS în general, u.a.s.c.g.e.:
A. edemul din insuficiența cardiacă este mai important la membrele inferioare;
- B. edemul înseamnă exces de apă în țesutul interstțial;
- C. acumulările de apă în seroase nu reprezintă edem propriu-zis;
- D. cel mai important criteriu de clasificare a edemului este localizarea;
- E. edemul nefrotic afectează în mod special pleocapele și organele genitale externe dată fiind laxitatea țesutului conjunctiv din aceste teritorii;
155. R.I. edem și la RHS în general, u.a.s.c.g.e.:
A. edemul din IC se observă la membrele inferioare în special dinneală;
- B. edemul înseamnă exces de apă în compartimentul interstțial sau extravascular;
- C. acumulările de apă în seroase pot însoți edemul atunci când acesta este de cauză sistemică;
- D. criteriul de clasificare a edemului cu cea mai mare relevanță practică este mecanismul;
- E. edemul nefrotic se asociază cu hiperaldosteronism;
156. R.I. edem și la RHS în general, u.a.s.c.g.e.:
A. edemul sistemic devine evident la examenul fizic abia după ce s-au acumulat câțiva (4-6) litri de apă în spațiul interstțial;
- B. apa în exces din interstțiu provine din vasele de sânge;
- C. acumulările de apă în seroase pot fi considerate localizări/ forme particulare ale edemului;
- D. criteriul de clasificare a edemului cel mai relevant pentru depistarea cauzei și înstituirea unui tratament este mecanismul;
- E. o cauză tipică de edem nefrotic este GPM, care de obicei determină și insuficiența renală;
157. R.I. edem și la RHS în general, u.a.s.c.g.e.:
A. prima manifestare a RHS poate să fie scăderea în greutate aparent neexplicabilă;
- B. apa în exces din compartimentul extravascular provine din compartimentul vascular;
- C. când apa se acumulează în seroase din cauze sistemice, va fi bogată în proteine;
- D. edemul poate fi clasificat și d.p.d.v. al localizării drept situat la membrele inferioare sau la față;
- E. edemul din GNDA este prototipul de edem nefrotic;
158. R.I. edem și la RHS în general, u.a.s.c.g.e.:
A. primele manifestări ale RHS se află adesea reducerea cantității de urină mergând până la oligurie;
- B. apa în exces din interstțiu provine în cea mai mare parte din capilare;
- C. când apa se acumulează în seroase din cauze sistemice, va fi un exsudat;
- D. paralizia produce edem unilateral prin scăderea drenajului limfatic și venos pe partea afectată;
- E. în edemul nefrotic temperatura cutanată este crescută;
159. R.I. edem și la RHS în general, u.a.s.c.g.e.:
A. pacientul poate sesiza acumularea de apă prin faptul că nu-l mai începe încălțăminte (mai ales către sfârșitul zilei);
- B. trecerea apei din vas în interstțiu se produce mai ales la nivelul capilarelor intracătă acestuia au peretele cel mai subțire;
- C. acumularea de apă în seroase din cauze sistemice se numește hidrotorace, hidropicard și respectiv hidropneumonie;
- D. administrarea de hormon de creștere poate provoca edem;
- E. edemul nefrotic se asociază, în mod caracteristic, cu polurie;
160. R.I. edem și la RHS în general, u.a.s.c.g.e.:
A. pacientul poate sesiza acumularea de apă prin faptul că rămâne urma de la șosete pe glezne;
- B. peretele capilarelor reprezintă bariera care separă spațiul vascular de cel interstțial;
- C. dintre denumirile de hidrotorace, hidropicard și hidropneumonie, prima nu este folosită în mod curent;
- D. la producerea edemului din sarcină contribuie edemul din sânge și contribuie excesul de hormoni feminini;
- E. edemul nefrotic se asociază în mod caracteristic cu proteinurie cu hipocalcemiemie;
161. F.d.u. afirmații r.l. starea normală a țesutului subcutanat:
a. moleculele de proteoglicani din țesutul interstțial sunt strâns lipite una de cealaltă (țesutul subcutanat este compact);
- b. proteoglicanii nu sunt separați între ei prin apă liberă;
- c. țesutul subcutanat este elastic (fievine imediat la forma inițială după ce este deformat);
- d. la comprimarea țesutului subcutanat, prin apăsarea cu degetul, nu rămâne groapă;
- e. care este înălțimea logică justă:
A. a-b → c-d;
B. b-a → c-d;
C. b-d → a-c;
D. c-a → b-d;
E. d-a → c-b;
162. F.d.u. afirmații r.l. țesutul subcutanat edemărit:
a. la comprimarea țesutului subcutanat, prin apăsarea cu degetul, rămâne groapă;
- b. apare apă liberă care separă moleculele de proteoglicani;
- c. țesutul subcutanat își pierde elasticitatea, devine plastic;
- d. care este înălțimea logică justă:
A. a-b → c;
B. a-c → b;
C. b-a → c;
D. b-c → a;
E. c-a → b;
163. R.I. deosebirea dintre edem și starea normală a țesutului subcutanat, f.d. cele două stări:
1. în mod normal:
2. când se instalează edemul, și umătoarele caracteristici:
a. la comprimarea țesutului subcutanat, prin apăsarea cu degetul, rămâne groapă;
- b. moleculele de proteoglicani „plutesc” în apă;
- c. fiind compact, țesutul subcutanat este elastic;
- d. proteoglicanii nu sunt separați între ei prin apă liberă;
- e. care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-2, d-1;
C. a-2, b-1, c-1, d-2;
D. a-2, b-1, c-2, d-1;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;
164. R.I. deosebirea dintre edem și starea normală a țesutului subcutanat, f.d. cele două stări:
1. în mod normal:
2. când se instalează edemul, și umătoarele caracteristici:
a. apare apă liberă care separă moleculele de proteoglicani;
- b. la comprimarea țesutului subcutanat, prin apăsarea cu degetul, nu rămâne groapă;
- c. moleculele de proteoglicani din țesutul interstțial sunt strâns lipite una de cealaltă;
- d. fiind elastic, țesutul subcutanat revine imediat la forma inițială după ce este deformat;
- e. care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-3, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-3;
C. a-2, b-3, c-1, d-1;
D. a-3, b-1, c-2, d-1;
E. a-3, b-2, c-1, d-1;
165. R.I. deosebirea dintre edem și starea normală a țesutului subcutanat, f.d. cele două stări:
1. în mod normal:
2. când se instalează edemul;
3. în cazul edemului inflamator;
- a. umătoarele caracteristici:
a. introduc moleculele de proteoglicani sunt strâns împachetate, țesutul subcutanat este compact (și păstrează forma);
- b. la comprimarea țesutului subcutanat, prin apăsarea cu degetul, nu rămâne groapă;
- c. țesutul subcutanat își pierde elasticitatea, devine plastic;
- d. acumularea de apă în țesutul subcutanat este însoțită de proteine și de celule;
- e. care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-3;
B. a-1, b-2, c-3, d-1;
C. a-1, b-3, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-3, d-1;
E. a-3, b-2, c-1, d-1;
166. F.d.u. evenimente care apar după episoade repetate și prelungite de edem și mai ales în cazul edemului cronic:
a. depunere de colagen;
- b. difuziunea dificilă a oxigenului prin grosimea straturii de edem;
- c. îngroșarea și îndurarea țesutului subcutanat;
- d. hipoxie locală;
- e. pielea de deasupra zonei edemate pare îngroșată;
- f. care este lanțul causal corect:
A. a → c → e → d → b;
B. b → d → a → c → e;
C. c → b → e → a → d;
D. d → c → e → a → b;
E. e → b → d → a → c;
167. F.d.u. evenimente care apar după episoade repetate și prelungite de edem și mai ales în cazul edemului cronic:
a. tulburări trofice și favorizarea infecțiilor cutanate și subcutanate;
- b. difuziunea dificilă a substanțelor nutritive;
- c. dermatită, celiță;
- d. nutriție deficitară;
- e. roșeață și căldură locală;
- f. care este lanțul causal corect:
A. a → c → e → d → b;
B. b → d → a → c → e;
C. c → a → d → b → e;
D. a → b → a → c → b;
E. d → e → c → b → a;
168. F.d.u. evenimente care apar după episoade repetate și prelungite de edem și mai ales în cazul edemului cronic:
a. difuziunea dificilă a substanțelor nutritive;
- b. nutriție deficitară;
- c. disfuncția glande sudoripare și sebacee;
- d. piele uscată;
- e. care este lanțul causal corect:
A. a → b → c → d;
B. a → b → d → c;
C. b → d → a → c;
D. b → d → c → a;
E. c → b → d → a;
169. Tulburări trofice care apar ca urmare a edemului cronic s.u.g.e.:
A. disfuncția anexelor pielii;
- B. psoriazis exsivă;
- C. piele îngroșată;
- D. hiperkeratoză;
- E. ulceratii;
- F. țesut cutanat greu vindecabil;
170. R.I. evidențierea edemului prin examen fizic, u.a.s.c.g.e.:
A. pentru evidențierea godeului, examinatorul trebuie să apese (cu degetul) tegumentul scurt (cel mult o secundă);

Prescurtări frecvent folosite: c.g. = cu excepția, s.u.g.e. = sunt umătoarele, cu excepția, u.a.s.c.g.e. = umătoarele afirmații sunt corecte, cu excepția, s.c.f.g.e. = sunt corect formulate, cu excepția.

- B. peretele capilarelor reprezintă bariera care separă spațiul vascular de cel interstțial;
- C. dintre denumirile de hidrotorace, hidropicard și hidropneumonie, prima nu este folosită în mod curent;
- D. la producerea edemului din sarcină contribuie edemul din sânge și contribuie excesul de hormoni feminini;
- E. edemul nefrotic se asociază în mod caracteristic cu proteinurie cu hipocalcemiemie;
161. F.d.u. afirmații r.l. starea normală a țesutului subcutanat:
a. moleculele de proteoglicani din țesutul interstțial sunt strâns lipite una de cealaltă (țesutul subcutanat este compact);
- b. proteoglicanii nu sunt separați între ei prin apă liberă;
- c. țesutul subcutanat este elastic (fievine imediat la forma inițială după ce este deformat);
- d. la comprimarea țesutului subcutanat, prin apăsarea cu degetul, nu rămâne groapă;
- e. care este înălțimea logică justă:
A. a-b → c-d;
B. b-a → c-d;
C. b-d → a-c;
D. c-a → b-d;
E. d-a → c-b;
162. F.d.u. afirmații r.l. țesutul subcutanat edemărit:
a. la comprimarea țesutului subcutanat, prin apăsarea cu degetul, rămâne groapă;
- b. apare apă liberă care separă moleculele de proteoglicani;
- c. țesutul subcutanat își pierde elasticitatea, devine plastic;
- d. care este înălțimea logică justă:
A. a-b → c;
B. a-c → b;
C. b-a → c;
D. b-c → a;
E. c-a → b;
163. R.I. deosebirea dintre edem și starea normală a țesutului subcutanat, f.d. cele două stări:
1. în mod normal:
2. când se instalează edemul, și umătoarele caracteristici:
a. la comprimarea țesutului subcutanat, prin apăsarea cu degetul, rămâne groapă;
- b. moleculele de proteoglicani „plutesc” în apă;
- c. fiind compact, țesutul subcutanat este elastic;
- d. proteoglicanii nu sunt separați între ei prin apă liberă;
- e. care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-2, d-1;
C. a-2, b-1, c-1, d-2;
D. a-2, b-1, c-2, d-1;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;
164. R.I. deosebirea dintre edem și starea normală a țesutului subcutanat, f.d. cele două stări:
1. în mod normal:
2. când se instalează edemul, și umătoarele caracteristici:
a. apare apă liberă care separă moleculele de proteoglicani;
- b. la comprimarea țesutului subcutanat, prin apăsarea cu degetul, nu rămâne groapă;
- c. moleculele de proteoglicani din țesutul interstțial sunt strâns lipite una de cealaltă;
- d. fiind elastic, țesutul subcutanat revine imediat la forma inițială după ce este deformat;
- e. care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-3, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-3;
C. a-2, b-3, c-1, d-1;
D. a-3, b-1, c-2, d-1;
E. a-3, b-2, c-1, d-1;
165. R.I. deosebirea dintre edem și starea normală a țesutului subcutanat, f.d. cele două stări:
1. în mod normal:
2. când se instalează edemul;
3. în cazul edemului inflamator;
- a. umătoarele caracteristici:
a. introduc moleculele de proteoglicani sunt strâns împachetate, țesutul subcutanat este compact (și păstrează forma);
- b. la comprimarea țesutului subcutanat, prin apăsarea cu degetul, nu rămâne groapă;
- c. țesutul subcutanat își pierde elasticitatea, devine plastic;
- d. acumularea de apă în țesutul subcutanat este însoțită de proteine și de celule;
- e. care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-3;
B. a-1, b-2, c-3, d-1;
C. a-1, b-3, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-3, d-1;
E. a-3, b-2, c-1, d-1;
166. F.d.u. evenimente care apar după episoade repetate și prelungite de edem și mai ales în cazul edemului cronic:
a. depunere de colagen;
- b. difuziunea dificilă a oxigenului prin grosimea straturii de edem;
- c. îngroșarea și îndurarea țesutului subcutanat;
- d. hipoxie locală;
- e. pielea de deasupra zonei edemate pare îngroșată;
- f. care este lanțul causal corect:
A. a → c → e → d → b;
B. b → d → a → c → e;
C. c → b → e → a → d;
D. d → c → e → a → b;
E. e → b → d → a → c;
167. F.d.u. evenimente care apar după episoade repetate și prelungite de edem și mai ales în cazul edemului cronic:
a. tulburări trofice și favorizarea infecțiilor cutanate și subcutanate;
- b. difuziunea dificilă a substanțelor nutritive;
- c. dermatită, celiță;
- d. nutriție deficitară;
- e. roșeață și căldură locală;
- f. care este lanțul causal corect:
A. a → c → e → d → b;
B. b → d → a → c → e;
C. c → a → d → b → e;
D. a → b → a → c → b;
E. d → e → c → b → a;
168. F.d.u. evenimente care apar după episoade repetate și prelungite de edem și mai ales în cazul edemului cronic:
a. difuziunea dificilă a substanțelor nutritive;
- b. nutriție deficitară;
- c. disfuncția glande sudoripare și sebacee;
- d. piele uscată;
- e. care este lanțul causal corect:
A. a → b → c → d;
B. a → b → d → c;
C. b → d → a → c;
D. b → d → c → a;
E. c → b → d → a;
169. Tulburări trofice care apar ca urmare a edemului cronic s.u.g.e.:
A. disfuncția anexelor pielii;
- B. psoriazis exsivă;
- C. piele îngroșată;
- D. hiperkeratoză;
- E. ulceratii;
- F. țesut cutanat greu vindecabil;
170. R.I. evidențierea edemului prin examen fizic, u.a.s.c.g.e.:
A. pentru evidențierea godeului, examinatorul trebuie să apese (cu degetul) tegumentul scurt (cel mult o secundă);

Prescurtări frecvent folosite: u. = umătoarele; c.d.u. = care dintre umătoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date umătoarele, f.l. = referitor/referitoare la; U.d.f.d. = Umătoarele fragmente dintr-o frază despre.

- C. evidențierea edemului se face ușor la nivel sacrat intrucât există un plan dur subiacent;
D. la coapsă, edemul se evidențiază cel mai bine în regiunea supero-externă;
E. la pacientul care se deplasează, edemul se observă inițial premaleolar, ulterior retrolibial;
174. U.f.d.f.d. evidențierea edemului în absența unui plan dur subiacent s.c.f.g.e.:
A. Demonstrarea edemului peritelui abdominal;
B. se face prin apăsarea fermă cu degetele subumbilical;
C. cu evidențierea aspectului de „coajă de portocală”;
D. urmată de desprinderea degetelor și observarea;
E. persistenței aspectului de „coajă de portocală”;
175. U.f.d.f.d. evidențierea edemului în absența unui plan dur subiacent s.c.f.g.e.:
A. Pentru evidențierea godeului;
B. examinatorul strânge între două degete;
C. (de obicei, police și inelar);
D. ferm și persistent piulii cutanat;
E. din regiunea unde vrea să decelaze prezența edemului.
176. Pentru c.d.u. regiuni evidențierea edemului nu se face prin pensarea piului cutanat între două degete:
A. coapsă;
B. regiunea prethibială;
C. peretele abdominal;
D. membrul superior;
E. sânii;
177. U.f.d.f.d. evidențierea edemului cu ocazia efectuării unor alte manevre de examen fizic s.c.f.g.e.:
A. Edemul poate deveni evident:
B. în urma palpării spațiilor intercostale;
C. (pentru evidențierea modului în care acestea expansionează;
D. în inspirație) tegumentele toracelui pacientului;
E. înroșindu-se după presiunea exercitată de degetele examinătorului.
178. U.f.d.f.d. evidențierea edemului cu ocazia efectuării unor alte manevre de examen fizic s.c.f.g.e.:
A. La auscultatia inimii;
B. rămâne urma de la stetoscop;
- B. la pacientul mergător, edemul se evidențiază prin apăsare pe regiunea sacrată;
C. uneori edemul devine evident cu ocazia efectuării unei alte manevre de examen fizic;
D. evidențierea edemului este mai dificilă la peretele abdominal din cauza inexistenței unui plan dur subiacent;
E. la gambă, edemul se evidențiază cel mai bine în regiunea posterioară;
171. R.I. evidențierea edemului prin examen fizic, u.a.s.c.g.e.:
A. pentru evidențierea godeului, examinătorul trebuie să apese pe tegumentul situat deasupra unui plan moale;
B. la pacientul alitat, edemul se evidențiază prin apăsare pe stern;
C. la pacientul cu edem, palparea spațiilor intercostale în cadrul examenului toracelui poate lăsa amprente pe tegumentele toracelui;
- D. la față, demonstrarea edemului se face prin evidențierea godeului;
E. la sânii, edemul se evidențiază cel mai bine în cadrulul supero-extern;
172. R.I. evidențierea edemului prin examen fizic, u.a.s.c.g.e.:
A. evidențierea edemului se face comprimând perseverent și progresiv țesutul subcutanat pe planul dur subiacent;
B. tegumentul strâns între două degete va căpăta aspect de coajă de portocală (pori cutanați devin evidenți);
C. la pacientul cu edem, poate rămâne o amprentă pe torace în urma apăsării ferme și prelungite cu stetoscopul;
D. edemul brațului se evidențiază cel mai bine în regiunea anterioară;
E. la membre, edemul se evidențiază cel mai bine pe fețele de extensie;
173. R.I. evidențierea edemului prin examen fizic, u.a.s.c.g.e.:
A. pentru decelarea unui edem incipient, se apasă anterior și superior de maleola medială;
B. după strângerea între două degete a piului cutanat dintr-o zonă edematiată, tegumentul pacientului rămâne amprentat;
- C. după apăsarea mai fermă și mai îndelungată pe toracele pacientului;
D. mai ales la auscultatia unor focare mai sus situate;
E. în special a celui apexian.
179. F.d.u. aspecte legate de localizarea edemului:
a. asimetrie corporală (un sân/ membru mult mai mare/ gros decât celălalt);
b. pacientul are decubit preferențial pe o parte sau pe alta;
c. acumularea de lichid va fi mult mai evidentă pe partea decubă;
d. risc de confuzie cu alte patologii;
e. care este lanțul cauzal/ logic just:
A. b→a→c→d;
B. b→c→a→d;
C. c→b→a→d;
D. c→d→a→b;
E. d→a→c→b;
180. R.I. confuziile pe care le poate genera decubitul preferențial pe o parte, f.d.u. începuturi de frază:
1. edemajerea excesivă a unui sân;
2. edemajerea excesivă a unui membru inferior;
3. edemajerea excesivă a unui membru superior;
și următoarele sfâșiiuri de frază:
a. poate duce la confuzia cu un edem limitat;
b. poate duce la confuzia cu o tromboză venoasă profundă;
c. poate duce la confuzia cu o tumoră mamară;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
181. R.I. localizarea la față a edemului, f.d.u. începuturi de frază:
1. este mai frecvent întâlnită la pacienți;
2. poate fi observată și la pacienți;
3. din cauza orfopneei, este foarte rar observată la pacienții foarte rar observată la pacienții 4. intrucât adesea laja este emaciată, este foarte rar observată la pacienți;
și următoarele sfâșiiuri de frază:
a. cu patologii renale;
b. cu edem carențial;

Prescurtări frecvent folosite: c.e. = cu excepție; s.u. c.e. = sunt următoarele, cu excepția; a.s. c. c.e. = numai barele alinajii sunt corecte, cu excepția; s.c. (c.e.) = sunt corect formulate, cu excepția.

- C. c→d→b→a;
D. d→b→c→a;
E. d→c→b→a;
190. R.I. fiziologic interstițial și a c.f.c.g. cauza:
1. în interstițiu p.p. și ale p.o.
2. nu se pierd p.
3. există un echilibru cantitativ de apă pătrunse în spațiul interstițial și cel al celulei care îl pătrunde
și următoarele c:
a. pielea stă lipită
b. p.o. tisulară
c. spațiul vasculor extravascular dimensiunile;
care sunt asociate:
- A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;
191. R.I. fiziologic interstițial și a c.f.d. cauza:
1. în cavitățile negative;
2. joncțiunile st. endotelului c. impermeabile
3. seroasele su. și nu conțin țesut și următoarele a:
a. cele două f. stau lipite una de alta
b. nu se pierd p.
c. acumulările nu reprezintă care sunt asociate:
- A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
192. U.f.d.f. lăni de lichid în A. Acumularea (având un unghi B. alți de mare edem general edem general C. cu transsudat D. se numește indeobște rez. 193. U.f.d.f. lăni de lichid în A. Termenul folosit pentru B. de lichid în C. întrucât în a
1. la extremitatea arterială a capilarului;
2. la extremitatea venoasă a capilarului;
3. în interstițiu;
și următoarele valori orientative:
- a. p.o. = 28 mmHg;
b. p.o. = 6 mmHg;
c. p.h. = 10 mmHg;
care sunt asociate corecte:
- A. a-1, b-3, c-2;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
187. R.I. valorile p.h. și ale p.o. considerând sensul pozitiv al presiunii dinspre vas spre interstițiu, f.d.u. compartimente:
1. la capătul arterial al capilarului;
2. în capilar (la ambele capete);
3. la capătul venos al capilarului;
și următoarele valori orientative (în mmHg):
- a. lichidul este împins din vas spre interstițiu cu o presiune de 35-22 = 13;
b. lichidul este atras din vas spre interstițiu cu o presiune de 15-22 = -7;
c. p.h. netă = 10 - (-5) = 15;
d. p.h. netă = 30 - (-5) = 35;
e. p.o. netă = -28+6 = -22;
care sunt asociate corecte:
- A. a-1, b-1, c-2, d-3, e-3;
B. a-1, b-3, c-3, d-1, e-2;
C. a-1, b-3, c-3, d-2, e-1;
D. a-3, b-1, c-2, d-1, e-3;
E. a-3, b-2, c-1, d-1, e-3;
188. C.d.u. substanțe nu poate trece liber prin peretele capilarilor:
- A. apa;
B. albumine;
C. ureea;
D. electroliții;
E. molecule cu $\phi < 30 \text{ \AA}$ (200 Å pentru capilarul hepatic);
189. F.d.u. evenimente r.l. fiziologia (normală a) țesutului interstițial și a cavităților seroase:
- a. nu se acumulează proteine în interstițiu;
b. limfaticile din țesut îndepărtează micile cantități de proteine scurse din vase;
c. p.o. este mare în vas și mică în interstițiu;
d. lichidul rămâne în capilare; care este succesiunea logică:
- B. b→a→c→d;
- c. cirozi;
d. cardiaci;
care sunt asociate corecte:
- A. a-1, b-2, c-4, d-3;
B. a-2, b-1, c-3, d-4;
C. a-2, b-3, c-1, d-4;
D. a-2, b-4, c-1, d-3;
E. a-4, b-1, c-2, d-3;
182. R.I. localizarea la față a edemului, u.a.s.c.f.g.:
- A. se constată față umflată;
B. edemul se observă mai ales în jurul ochilor;
C. apa se acumulează mai ales acolo unde țesutul conjunctiv este cel mai lax, adică mentonier;
D. localizarea facială a edemului este mai evidentă seara;
E. în timpul cîlnostismului nocturn scade afluxul de sânge spre partea superioară a corpului;
183. U.f.d.f. edemul s.c.f.c.g.:
- A. Creșterea în greutate care însoțește formarea edemului;
B. este de regulă sesizată încă de la început întrucât:
C. expansiunea țesutului subcutanat se produce;
D. în zona abdomenului și a coapselor, teritori;
E. ținute de obicei sub observație de cei îngrijorați de greutatea tor.
184. U.f.d.f. edemul s.c.f.c.g.:
- A. la instituirea tratamentului diuretic se poate;
B. produce în primele zile;
C. o scădere în greutate aparent inexplicabilă la pacientul;
D. fără edeme evidente;
E. și fără RHS.
185. R.I. valorile presiunii hidrostatice (p.h.) și ale presiunii oncotice (p.o.), f.d.u. compartimente:
1. la extremitatea arterială a capilarului;
2. la extremitatea venoasă a capilarului;
3. în interstițiu;
și următoarele valori orientative:
- a. p.h. = -5 mmHg;
b. p.o. = 28 mmHg;
c. p.h. = 30 mmHg;
care sunt asociate corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
186. R.I. valorile p.h. și ale p.o., f.d.u. compartimente:

Prăsurcutan frecvent tolosanle: u. = umătoarele; c.d.u. = căre dintre umătoarele; f.d. = lind dale; l.c.u. = referitor/referitoare la; u.f.d.f.d. = Umătoarele fragmente dintr-o frază despre;

dale umătoare, c. l. =

- D. mecanisme separate, și nu unul singur cu acțiune sistemică;
E. care explică prezența asociei, a lichidului pleural și a edemului.
194. R.I. clasificarea edemului pe baza mecanismului și a localizării, f.d.u. începutul de frază:
1. edemul prin scăderea p.o. din vas;
2. edemul inflamator;
3. edemul prin creșterea p.h. din vas;
și următoarele stăpînuri de frază:
a. poate fi doar sistemic;
b. poate fi doar local;
c. poate fi atât sistemic, cât și local;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;
195. R.I. clasificarea edemului pe baza mecanismului și a localizării, f.d.u. începutul de frază:
1. edemul prin creșterea permeabilității barierei indusă hormonal;
2. edemul inflamator din cadrul reacțiilor anafilactice;
3. edemul produs de paralizie;
și următoarele stăpînuri de frază:
a. poate cuprinde mai multe teritorii;
b. poate fi doar sistemic;
c. poate fi unilateral;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-1, c-2;
196. Elemente care favorizează apariția edemului s.u.c.g.:
A. creșterea aldosteronului;
B. scăderea fluxului limfatic;
C. arteriodilatație;
D. creșterea abundenței în vas;
E. creșterea p.h. arteriale;
197. Elemente care favorizează apariția edemului s.u.c.g.:
A. creșterea ADH;
B. scăderea p.o. intravasculară;
C. creșterea fluxului limfatic;
D. creșterea albuminelor în lichidul interstital;
E. permeabilitatea capilarelor pentru apă și electroliți;
198. Hiperaldosteronismul are u. consecințe, c.g.g.:
A. scăderea angiotensinei;
B. creșterea FSR;
C. scăderea natremiei;
D. scăderea kaliemiei;
E. stimularea osmoreceptorilor hipotalamici;
206. R.I. diferențierea stărilor care produc de cele care nu produc edem, f.d.u. circumstanțe:
1. scăderea VSCE produce edem;
2. scăderea volumiei nu produce edem;
și u. situații stări patologice:
A. dieta hiposodată;
B. insuficiența cardiacă stângă;
C. asfiziile, hemoragiile masive, deshidratarea;
D. retenția de lichid în cavitățile peritoneale;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-1, d-2;
E. a-2, b-1, c-2, d-1;
207. R.I. presiunile care deplasează apa între cele două compartimente ale spațiului extracelular, f.d.u. categorii:
1. presiuni care fac apa să se deplaseze către interstițiu;
2. presiuni care fac apa să se deplaseze către vas;
și următoarele presiuni:
a. p.h. interstițială, munită și tensiunea osmotică;
b. p.o. din vas;
c. p.o. interstițială;
d. p.h. din vas;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-1, b-2, c-1, d-2;
D. a-2, b-1, c-1, d-2;
E. a-2, b-1, c-2, d-1;
208. F.d.u. presiuni care deplasează apa între cele două compartimente ale spațiului extracelular:
1. p.o. interstițială;
2. p.h. din vas;
3. p.h. interstițială;
4. p.o. din vas;
și următoarele caracterizări:
a. presiunea care absoarbe apa din vas în interstițiu și o ține în interstițiu;
b. presiunea care împinge apa din vas;
c. presiunea care absoarbe apa din interstițiu în vas și o ține în vas;
d. presiunea care împinge apa în vas;
care sunt asocierile corecte:

Prescurtări frecvent folosite: c.g. = cu excepția, s.u.c.g. = sunt următoarele, cu excepția, u.a.s.c.g. = următoarele afirmatii sunt corecte, cu excepția, i.c.f.c.g. = sunt corect formulate, cu excepția.

- A. a-1, b-2, c-4, d-3;
B. a-1, b-3, c-2, d-4;
C. a-2, b-3, c-1, d-4;
D. a-4, b-2, c-1, d-3;
E. a-4, b-3, c-1, d-2;
209. U.d.f.d. mecanismul edemului s.c.f.c.g.:
A. Când excesul p.h. din vas sau deficitul p.o. din vas acționează sistemic;
B. se produce retenția de apă în întregul organism, invariabil;
C. însoțită de cationi și anioni având concentrația cea;
D. mai mică în mediul extracelular (Na⁺ și Cl⁻), stare numită;
E. retenție hiposalină (RHS);
u.a.s.c.g.:
210. R.I. modificarea presiunilor ca mecanism al edemului, u.a.s.c.g.:
- A. presiunea care deplasează apa între cele două compartimente ale spațiului extracelular sunt numite și forțe Starling;
B. p.o. este presiunea osmotică exercitată de moleculele cu masa moleculară foarte mare, adică de proteine;
C. p.o. este presiunea osmotică exercitată de moleculele care nu pot să treacă liber prin bariere de separare dintre vase și interstițiu;
D. edemul poate să apară prin excesul presiunilor care fac apa să se deplaseze către vas;
E. edemul poate să apară prin excesul p.h. din vas;
F. retenția de Na⁺ este esențială pentru instalarea oricărui edem generalizat;
211. R.I. modificarea presiunilor ca mecanism al edemului, u.a.s.c.g.:
- A. p.o. este numită și presiune coloid-osmotică;
B. p.o. este presiunea osmotică exercitată de moleculele care nu pot să treacă liber prin perelele capilar;
C. edemul poate să apară prin deficitul presiunilor care fac apa să se deplaseze către interstițiu;
D. de obicei, în patogenza edemului este implicată modificarea presiunii este implicată modificarea presiunii comparativ interstițial;
E. edemul poate să apară prin deficitul p.o. din vas;
212. R.I. mecanismele implicate în producerea retenției hiposaline (RHS), u.a.s.c.g.:
- A. inotdeauna este implicat sistemul renina-angiotensină-aldosteron (SRAA);
B. SRAA acționează general, în întregul organism (ca un adevărat sistem hormonal);
C. antagoniști specifici ai receptorilor AT2 de tip 1 sunt blocanții receptorilor de angiotensină (BRA);
D. endotelina este o peptidă vaso-dilatatoare potentă eliberată de celulele endoteliale;
E. creșterea endotelinei contribuie la retenția de Na⁺ din IC;
213. R.I. mecanismele implicate în producerea RHS, u.a.s.c.g.:
- A. SRAA este implicat mai ales prin vasopresină;
B. SRAA acționează și local, intrarenal;
C. pe lângă SRAA, mai sunt și alți factori care contribuie la RHS;
D. concentrația endotelinei crește în IC;
E. creșterea endotelinei contribuie la edemul din IC;
214. R.I. mecanismele implicate în producerea RHS, u.a.s.c.g.:
- A. aldosteronul este hormonul care elimină Na⁺ din organism;
B. AT2 reduce conștința arteriei; eferențe prin activarea receptorilor AT2 de tip 1;
C. principalul factor care mai contribuie la RHS, pe lângă SRAA, este arginin-vasopresina (AVP), numită și hormon antidiuretic (ADH);
D. creșterea endotelinei contribuie la RHS;
E. există și factori care, inhibând natura, tind să contrabalanseze RHS;
215. R.I. felul în care PNU-A contracționează retenția de Na⁺ și creșterea presiunii arteriale din stările hipervolemice, f.d.u. mecanisme generale:
1. excreția de sodiu și apă;
2. dilatație arterială și venoasă;
3. mecanisme particulare:
a. inhibarea reabsorbției sodiului în tubul proximal;
b. creșterea filtrării glomerulare;
c. inhibarea eliberării reninei și aldosteronului;
d. antagonizarea acțiunii factorilor umorali vasoconstrictori (AT2, AVP);
a. vasoconstricție neosmotică;
216. Factori care participă la producerea reacției imediate vasoconstrictoare induse de scăderea VSCE sunt următorii, c.g.:
- A. reacția simpatoadrenergică, B. angiotensină, C. PNU, D. AVP;
E. endotelină;
217. F.d.u. evenimente implicate în producerea edemului:
a. scăderea FSR;
b. RHS;
c. punerea în mișcare a SRAA;
d. diminuarea VSCE;
care este lanțul causal corect:
A. b-c-a-d;
B. c-b-a-d;
C. c-d-b-a-e;
D. d-a-b-a-c;
E. d-a-b-c-b;
218. F.d.u. evenimente implicate în producerea edemului:
a. activarea osmoreceptorilor din hipotalamus;
b. creșterea presiunii osmotice plasmatice;
c. creșterea secreției de AVP, care este lanțul causal corect:
A. a-b-c;
B. a-b-a-b;
C. b-a-b-a;
D. b-a-b-a;
E. c-b-a-a;
219. F.d.u. evenimente implicate în producerea edemului:
a. creșterea secreției de AVP;
b. activarea baroreceptorilor din vene, atri și carotide;
c. scăderea presiunii intravasculare;
care este lanțul causal corect:
A. a-b-a-c;
B. a-b-a-b;
C. b-a-b-a;
D. c-b-a-a;
E. c-b-a-a;
220. F.d.u. evenimente care explică felul în care umplerea arterială deficitară este implicată în producerea edemului:
a. vasoconstricție neosmotică;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele, c.d.u. = care dintre următoarele, f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, f.i. = referitor/referitoare la, U d.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază desparte.

- b. retenție renală de apă și creșterea rezistenței arteriale sistemice și renale;
- c. activarea receptorilor ventriculi și arteriali;
- d. scăderea debitului cardiac; care este lanțul causal corect:
- A. $a \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow c$;
- B. $b \rightarrow d \rightarrow c \rightarrow a$;
- C. $c \rightarrow d \rightarrow a \rightarrow b$;
- D. $d \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a$;
- E. $a \rightarrow c \rightarrow b \rightarrow d$;
224. F.d.u. evenimente care explică felul în care umplerea arterială deficitară este implicată în producerea edemului:
- a. arterioli dilatați sistemică;
- b. creșterea debitului cardiac;
- c. restabilirea și menținerea VSCE;
- care este lanțul causal corect:
- A. $a \rightarrow b \rightarrow c$;
- B. $b \rightarrow a \rightarrow c$;
- C. $c \rightarrow b \rightarrow a$;
- D. $c \rightarrow a \rightarrow b$;
- E. $c \rightarrow b \rightarrow a$;
225. F.d.u. evenimente care explică felul în care umplerea arterială deficitară este implicată în producerea edemului:
- a. arterioli dilatați sistemică;
- b. creșterea debitului cardiac;
- c. restabilirea și menținerea VSCE;
- care este lanțul causal corect:
- A. $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d$;
- B. $b \rightarrow d \rightarrow c \rightarrow a$;
- C. $c \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow b$;
- D. $c \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow a$;
- E. $c \rightarrow d \rightarrow b \rightarrow a$;
222. F.d.u. evenimente care explică felul în care umplerea arterială deficitară este implicată în producerea edemului:
- a. activarea SRAA;
- b. retenție renală de Na⁺;
- c. creșterea rezistenței arteriale sistemice și renale;
- d. scăderea debitului cardiac;
- e. activarea receptorilor ventriculi și arteriali;
- e. restabilirea și menținerea VSCE;
- care este lanțul causal corect:
- A. $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e$;
- B. $b \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow c \rightarrow a$;
- C. $c \rightarrow d \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow e$;
- D. $d \rightarrow a \rightarrow e \rightarrow c \rightarrow b$;
- E. $e \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow b \rightarrow c$;
223. F.d.u. evenimente care explică felul în care umplerea arterială deficitară este implicată în producerea edemului:
- a. activarea receptorilor ventriculi și arteriali;
- b. retenție renală de Na⁺;
- c. creșterea rezistenței arteriale sistemice și renale;
- c. restabilirea și menținerea VSCE;
- d. scăderea debitului cardiac;
- e. activarea SRAA;
- care este lanțul causal corect:
- A. $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e$;
- B. $b \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow c \rightarrow a$;
- C. $c \rightarrow d \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow e$;
- D. $d \rightarrow a \rightarrow e \rightarrow c \rightarrow b$;
- E. $e \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow b \rightarrow c$;
226. F.d.u. evenimente care explică felul în care umplerea arterială deficitară este implicată în producerea edemului:
- a. stimularea neosmotică a AVP;
- b. creșterea rezistenței arteriale sistemice și renale, activarea SRAA;
- c. activarea baroreceptorilor arteriali;
- d. stimularea SN simpatic;
- e. restabilirea și menținerea VSCE;
- care este lanțul causal corect:
- A. $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e$;
- B. $b \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow c \rightarrow a$;
- C. $c \rightarrow d \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow e$;
- D. $d \rightarrow a \rightarrow e \rightarrow c \rightarrow b$;
- E. $e \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow b \rightarrow c$;
227. F.d.u. evenimente care explică felul în care umplerea arterială deficitară este implicată în producerea edemului:
- a. stimularea neosmotică a AVP;
- b. creșterea rezistenței arteriale sistemice și renale, activarea SRAA;
- c. activarea baroreceptorilor arteriali;
- d. stimularea SN simpatic;
- e. restabilirea și menținerea VSCE;
- care este lanțul causal corect:
- A. $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e$;
- B. $b \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow c \rightarrow a$;
- C. $c \rightarrow d \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow e$;
- D. $d \rightarrow a \rightarrow e \rightarrow c \rightarrow b$;
- E. $e \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow b \rightarrow c$;
228. R.I. stările patologice care produc edem prin umplere deficitară (absolută sau relativă) a patului arterial, f.d.u. categorii:
1. scăderea debitului cardiac;
2. arterioli dilatați sistemică;
- și următoarele stări patologice:
- a. deplasarea în alte compartimente a lichidului intravascular;
- b. arterioli dilatați sistemică;
- c. sepsis;
- d. scăderea volumului de lichid extracelular;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-1, c-2, d-2;
- B. a-1, b-2, c-1, d-2;
- C. a-1, b-2, c-2, d-1;
- D. a-2, b-1, c-2, d-1;
- E. a-2, b-2, c-1, d-1;
229. R.I. stările patologice care produc edem prin umplere deficitară (absolută sau relativă) a patului arterial, f.d.u. categorii:
1. scăderea debitului cardiac prin afecțiuni cardiace;
2. scăderea debitului cardiac prin deplasarea în alte compartimente a lichidului intravascular;
3. arterioli dilatați sistemică;
- și următoarele stări patologice:
- a. fistula arteriovenoasă;
- b. sindromul nefrotic;
- c. pericardita restrictivă;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
- B. a-1, b-3, c-2;
- C. a-2, b-1, c-3;
- D. a-2, b-3, c-1;
- E. a-3, b-1, c-2;
232. R.I. diverșii factori implicați în producerea edemului, u.s.c.c.g.:
- A. peptidele natrurice (PNU) tind să contrabalanseze prin favorizarea natruriei;
- B. creșterea PNU în ICC și în ciroza cu ascită este insuficientă pentru a împiedica formarea edemului;
- C. vasoconstricția ca răspuns la scăderea VSCE vizează redistribuirea VSCE către teritoriile vitale;
- D. stimularea adrenergică determină vasoconstricție renală;
- E. AVP crește diureza apasă;
233. R.I. diverșii factori implicați în producerea edemului, u.s.c.c.g.:
- A. PNU este de fapt o polipeptidă;
- B. pe vas, PNU acționează similar endotelinei;
234. R.I. diverșii factori implicați în producerea edemului, u.s.c.c.g.:
- A. distensia arterială determină eliberarea PNU atriale (PNU-A);
- B. PNU este secretat de miocitele atriale și ventriculare;
- C. activarea nervilor simpatici renali ca răspuns la scăderea VSCE contribuie la stimularea SRAA;
- D. umplerea arterială deficitară acționează având ca punct de plecare fie scăderea debitului cardiac, fie arterioli dilatați sistemică;
- E. AT2 este activă în special pe arteriole aferente;
235. R.I. diverșii factori implicați în producerea edemului, u.s.c.c.g.:
- A. retenția de Na⁺ determină eliberarea PNU-A;
- B. acționează deficitar în IC;
- C. acționează deficitar în IC, intuitiv apare rezistența la acțiunea periferică a PNU;
- C. reacția mai lentă la scăderea VSCE constă în RHS;
- D. AT2 care intră în circulația sistemică stimulează producția de aldosteron de către zona glomerulară din corticosuprarrenală;
239. R.I. diverșii factori implicați în producerea edemului, u.s.c.c.g.:
- A. PNU-A scade filtrarea glomerulară;
- B. pe lângă acești factori umorali, la producerea anumitor forme de edem contribuie și scăderea volumului sanguin circulant eficient (VSCE);
- C. SRAA este pus în mișcare de scăderea fluxului de sânge renal ca urmare a diminuării VSCE;
- D. spironolactona este un antagonist al aldosteronului;
- E. în ciroza hepatică apare hiperaldosteronism secundar scăderii VSCE;
240. R.I. diverșii factori implicați în producerea edemului, u.s.c.c.g.:
- A. PNU-A crește reabsorbția sodiului în tubul proximal;
- B. scăderea VSCE contribuie la producerea edemului mai ales în IC și în ciroza hepatică;

Prescurtări frecvent folosite: u.s.c.g. = cu excepția; s.u.c.g. = sunt următoarele, cu excepția; u.s.c.c.g. = următoarele afirmatii sunt corecte, cu excepția; s.c.f.c.g. = sunt corect formulate, cu excepția.

- C. reacția simpatoadrenergică la scăderea VSCE include activarea nervilor simpatici renali;
1. scăderea debitului cardiac prin afecțiuni cardiace;
2. scăderea debitului cardiac prin deplasarea în alte compartimente a lichidului intravascular;
3. arterioli dilatați sistemică;
- și următoarele stări patologice:
- a. tamponadă cardiacă;
- b. IC cu debit crescut;
- c. creșterea permeabilității capilare;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
- B. a-1, b-3, c-2;
- C. a-2, b-1, c-3;
- D. a-3, b-1, c-2;
- E. a-3, b-2, c-1;
231. R.I. stările patologice care produc edem prin umplere deficitară (absolută sau relativă) a patului arterial, f.d.u. categorii:
1. scăderea debitului cardiac prin afecțiuni cardiace;
2. arterioli dilatați sistemică;
3. scăderea debitului cardiac prin deplasarea în alte compartimente a lichidului intravascular;
- și următoarele stări patologice:
- a. fistula arteriovenoasă;
- b. sindromul nefrotic;
- c. pericardita restrictivă;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
- B. a-1, b-3, c-2;
- C. a-2, b-1, c-3;
- D. a-2, b-3, c-1;
- E. a-3, b-1, c-2;
232. R.I. diverșii factori implicați în producerea edemului, u.s.c.c.g.:
- A. peptidele natrurice (PNU) tind să contrabalanseze prin favorizarea natruriei;
- B. creșterea PNU în ICC și în ciroza cu ascită este insuficientă pentru a împiedica formarea edemului;
- C. vasoconstricția ca răspuns la scăderea VSCE vizează redistribuirea VSCE către teritoriile vitale;
- D. stimularea adrenergică determină vasoconstricție renală;
- E. AVP crește diureza apasă;
233. R.I. diverșii factori implicați în producerea edemului, u.s.c.c.g.:
- A. PNU este de fapt o polipeptidă;
- B. pe vas, PNU acționează similar endotelinei;
234. R.I. diverșii factori implicați în producerea edemului, u.s.c.c.g.:
- A. distensia arterială determină eliberarea PNU atriale (PNU-A);
- B. PNU este secretat de miocitele atriale și ventriculare;
- C. activarea nervilor simpatici renali ca răspuns la scăderea VSCE contribuie la stimularea SRAA;
- D. umplerea arterială deficitară acționează având ca punct de plecare fie scăderea debitului cardiac, fie arterioli dilatați sistemică;
- E. AT2 este activă în special pe arteriole aferente;
235. R.I. diverșii factori implicați în producerea edemului, u.s.c.c.g.:
- A. retenția de Na⁺ determină eliberarea PNU-A;
- B. acționează deficitar în IC;
- C. acționează deficitar în IC, intuitiv apare rezistența la acțiunea periferică a PNU;
- C. reacția mai lentă la scăderea VSCE constă în RHS;
- D. AT2 care intră în circulația sistemică stimulează producția de aldosteron de către zona glomerulară din corticosuprarrenală;
239. R.I. diverșii factori implicați în producerea edemului, u.s.c.c.g.:
- A. PNU-A scade filtrarea glomerulară;
- B. pe lângă acești factori umorali, la producerea anumitor forme de edem contribuie și scăderea volumului sanguin circulant eficient (VSCE);
- C. SRAA este pus în mișcare de scăderea fluxului de sânge renal ca urmare a diminuării VSCE;
- D. spironolactona este un antagonist al aldosteronului;
- E. în ciroza hepatică apare hiperaldosteronism secundar scăderii VSCE;
240. R.I. diverșii factori implicați în producerea edemului, u.s.c.c.g.:
- A. PNU-A crește reabsorbția sodiului în tubul proximal;
- B. scăderea VSCE contribuie la producerea edemului mai ales în IC și în ciroza hepatică;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dărm următoarele; f.d.u. = fiind date următoarele, r.i. = referitor la următoarele la u.i.f.d.u. = următoarele fragmente dintr-o frază despic.

- contribuie importantă la producerea edemului;
237. R.I. diverșii factori implicați în producerea edemului, u.s.c.c.g.:
- A. PNU-A contracționează retenția de Na⁺ și creșterea presiunii arteriale din stările hipervolemice;
- B. factorii umorali implicați în producerea RHS au ca acțiuni generice retenția de Na⁺ și de apă și vasodilatația;
- C. RHS ca răspuns la scăderea VSCE contribuie la producerea edemului;
- D. în stările edematoase caracterizate prin hiperaldosteronism secundar, blocarea acțiunii aldosteronului produce o diureză moderată;
- E. în IC apare hiperaldosteronism secundar ca urmare a scăderii VSCE;
238. R.I. diverșii factori implicați în producerea edemului, u.s.c.c.g.:
- A. PNU-A crește excreția de sodiu și apă;
- B. factorii care contrabalansează RHS produc natrurică, diureză apasă și vasoconstricție;
- C. RHS este mediata în primul rând de SRAA;
- D. spironolactona și amiloridul sunt medicamente care blochează acțiunea aldosteronului;
- E. în sindromul nefrotic apare hiperaldosteronism în urma scăderii VSCE;
239. R.I. diverșii factori implicați în producerea edemului, u.s.c.c.g.:
- A. PNU-A scade filtrarea glomerulară;
- B. pe lângă acești factori umorali, la producerea anumitor forme de edem contribuie și scăderea volumului sanguin circulant eficient (VSCE);
- C. SRAA este pus în mișcare de scăderea fluxului de sânge renal ca urmare a diminuării VSCE;
- D. spironolactona este un antagonist al aldosteronului;
- E. în ciroza hepatică apare hiperaldosteronism secundar scăderii VSCE;
240. R.I. diverșii factori implicați în producerea edemului, u.s.c.c.g.:
- A. PNU-A crește reabsorbția sodiului în tubul proximal;
- B. scăderea VSCE contribuie la producerea edemului mai ales în IC și în ciroza hepatică;

- C. RHS este mediată și de AVP.
D. amiloidul implică acțiunea aldosteronului prin blocarea canalelor epiteliale pentru Na⁺.
E. hiperaldosteronismul secundar este un contributor important la RHS produsă de scăderea VSCE.
241. R1. diverși factori implică în producerea edemului, u.a.s.c.g.e.:
A. PNU-A crește eliberarea reninei;
B. VSCE reflectă gradul de umplere a patului arterial;
C. secreția de AVP este stimulată de angiotensină;
D. de obicei, SRAA este pus în mișcare de creșterea VSCE;
E. tratamentul cu hormoni steroizi produce edeme prin scăderea reabsorbției renale de Na⁺.
242. R1. diverși factori implică în producerea edemului, u.a.s.c.g.e.:
A. PNU-A crește eliberarea aldosteronului;
B. scăderea VSCE înseamnă o umplere deficitară a sistemului arterial;
C. secreția de AVP este scăzută de alcool;
D. SRAA poate fi activat și de creșterea peritubulei glomerulare prin vasoconstricție renală;
E. celulele juxtaglomerulare sunt celulele mioepiteliale specializate dispuse în jurul arteriolei aferente.
243. R1. diverși factori implică în producerea edemului, u.a.s.c.g.e.:
A. PNU-A determină dilatație arterioară și venoasă;
B. scăderea VSCE poate surveni prin scăderea cantității de sânge trimise în patul arterial (prin scăderea debitului cardiac);
C. secreția de AVP este scăzută de PNU-A;
D. AINS pot produce vasodilatație renală prin privarea de prostaglandine vasodilatatoare;
E. stimularea celulelor juxtaglomerulare prin cantitatea scăzută de Na⁺ produce buclă de reacție tubuloglomerulară.
244. R1. diverși factori implică în producerea edemului, u.a.s.c.g.e.:
A. PNU-A antagonizează acțiunile vasocostrictoare ale AT2, ale AVP și ale sistemului simpato-adrenergic;
B. scăderea VSCE poate surveni prin creșterea volumului patului arterial (vasodilatație sistemică cu scăderea rezistenței vasculare sistemice);
C. secreția de AVP este stimulată de activarea osmoreceptorilor din hipotalamus prin creșterea presiunii osmotice plasmatică;
D. cidosporina produce vaso-dilatație renală;
E. în citoplasma celulelor juxtaglomerulare pot fi observate granule secretorii care conțin renină.
245. R1. diverși factori implică în producerea edemului, u.a.s.c.g.e.:
A. PNU ceterubal (PNU-B) este strâns înrudit cu PNU-A;
B. umplerea patului arterial este deficitară și în caz de hipovolemie;
C. secreția de AVP este stimulată direct de scăderea presiunii intravasculare;
D. în ciroza hepatică se produce vasodilatație renală simultan cu vasodilatația sistemică;
E. renina este o enzimă cu o masă moleculară de aproximativ 40 kDa.
246. R1. diverși factori implică în producerea edemului, u.a.s.c.g.e.:
A. PNU-B este depozitat în primul rând în miocardul ventricular;
B. în hipovolemie se produce scăderea nu doar a VSCE, ci a volumului de sânge în ansamblu;
C. scăderea presiunii intravasculare activează baroreceptori din vene, atri și carotide;
D. angiotensinogenul este o glicoproteină sintetizată de plasmocite;
E. sistemul simpato-adrenergic include terminațiile nervoase simpatice și catecholaminele circulanțe.
247. R1. diverși factori implică în producerea edemului, u.a.s.c.g.e.:
A. PNU-B este eliberată când crește presiunea distolică ventriculară;
B. în hipovolemie nu doar patul arterial, ci și cel venos și capilar sunt umplute deficitar;
C. la mulți pacienți cu IC, scăderea VSCE reprezintă un stimul neosmotic pentru secreția de AVP;
D. renina taie din substratul ei angiotensinogenul, o decapeptidă, angiotensina 1;
E. edemul de hipovolemie apare în gastera autonomă.
248. R1. diverși factori implică în producerea edemului, u.a.s.c.g.e.:
A. PNU este eliberat dacă sodiul este deficitar;
B. scăderea VSCE tinde să producă hipotensiune;
C. la pacienți cu VSCE scăzut nu se produce o scădere normală a AVP la reducerea osmolarității;
D. din angiotensina 1, prin tăierea a doi aminoacizi, rezultă o octapeptidă, AT2;
E. edemul de permeabilitate este edemul produs de creșterea permeabilității capilare.
249. R1. diverși factori implică în producerea edemului, u.a.s.c.g.e.:
A. PNU este eliberat când atriul este destins;
B. scăderea VSCE tinde să producă hipotensiune;
C. creșterea AVP secundară scăderii umplerii arteriale contribuie la formarea edemului și la hipotensiune;
D. aldosteronul crește reabsorbția Na⁺ de către tubul colector;
E. creșterea p.h. interstițială favorizează formarea edemului;
250. R1. diverși factori implică în producerea edemului, u.a.s.c.g.e.:
A. PNU-B are acțiuni similare cu PNU-A;
B. la scăderea VSCE organismul răspunde prin o reacție imediată și prin o reacție mai lentă;
C. umplerea arterială deficitară determină activarea axei neuro-umurale (și rețenție hidrosalină renală);
D. aldosteronul scade excreția K⁺ de către tubul colector;
E. transsudatul constă în apă și substanțe cu masă moleculară mică și medie, dar nu conține proteine și nici celule.
251. R1. diverși factori implică în producerea edemului, u.a.s.c.g.e.:
A. nivelurile circulante ale PNU-A și PNU-B sunt crescute în ICCG și în ciroza cu ascită;
B. reacția imediată la scăderea VSCE constă în vasoconstricție;
C. umplerea arterială deficitară determină stimularea adrenergică;
D. creșterea osmolarității inhibă secreția de AVP;
E. transsudatul iese din vasul de sânge sub acțiunea p.h. crescute sau a p.o. scăzute.

Prescurtări frecvent folosite: G.E. = cu excepție; s.u.G.E. = sunt umplute, cu excepție; u.a.s.c.g.e. = umplutele afirmate sunt corecte, cu excepție; s.c.i.G.E. = sunt corect formulate, cu excepție.

252. Scăderea fluxului sanguin renal determină u. modificări, G.E.:
A. scăderea angiotensinei;
B. creșterea concentrației sodiului la nivelul maculei dense;
C. dilatația arteriolei eferente;
D. scăderea natriurei;
E. secreție de ADH.
253. Scăderea fluxului sanguin renal determină u. modificări, G.E.:
A. creșterea reninei;
B. scăderea natriurei;
C. scăderea kaliei;
D. scăderea kaliurei;
E. edem doar dacă balanța hidro-salină este pozitivă.
254. R1. cauza care a produs scăderea fluxului sanguin renal (FSR), f.d.u. circumstanțe:
1. scăderea VSCE sau a volumiei;
2. scăderea volumiei cu balanță hidrosalină negativă;
3. scăderea VSCE cu balanță hidrosalină pozitivă;
și următoarele răspunsuri:
a. deshidratare, hemoragie;
b. edeme;
c. retenție de Na (în tubul proximal) și deci de apă;
d. nu apar edeme;
e. perpetuarea retenției de Na (în tubul proximal) și deci de apă, care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-2, d-3, e-3;
B. a-1, b-3, c-2, d-2, e-3;
C. a-2, b-2, c-3, d-1, e-3;
D. a-2, b-3, c-1, d-2, e-3;
E. a-3, b-1, c-2, d-3, e-2.
255. R1. lichidul prezent simultan în cavitatea peritoneală, pleurală și pericardică, u.a.s.c.g.e.:
A. poate reprezenta anasarca sau poliseriozită;
B. poate fi transsudat sau exsudat;
C. prin definiție, în anasarca este întotdeauna un exsudat;
D. se asociază întotdeauna cu edeme în poliseriozită, dar nu și în anasarca;
E. poate să apară prin creșterea p.h. sau printr-un proces inflamator sistemic.
256. R1. anasarca, u.a.s.c.g.e.:
A. edemul este generalizat;
B. de obicei edemul este dur și lasă greu godelu întrucât este vechi;
C. se asociază cu revărsate lichidiene în cavitățile seroase;
- D. de obicei, edemul nu apare pe pereții abdominali, deoarece pacientul este în decubit dorsal;
E. de obicei, edemul nu apare la nivelul sânilor, deoarece pacienta este în ortopne.
257. R1. revărsatele din cavitățile seroase din anasarca, u.a.s.c.g.e.:
A. seroasele sunt dependente din punct de vedere fiziologic de spațiul interstițial;
B. lichidul este serocitrin;
C. lichidul este bogat în proteine;
D. aspectul lichidului indică transsudat;
E. epurările lichidului are o cauză generală.
258. F.d.u. tipuri de edem:
1. edemul renal;
2. edemul venos;
3. edemul vechi;
și următoarele răspunsuri:
a. localizat, pielea se lichenifică în fazele avansate;
b. catonai, dur prin acumularea de fibroblști;
c. temperatură normală, culoare normală sau albă, pufos;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1.
259. F.d.u. tipuri de edem:
1. edemul inflamator;
2. edemul recent;
3. edem vechi, în fazele avansate;
și următoarele răspunsuri:
a. pielea este uscată, pigmentată, pare îngroșată, se descuenează;
b. moale, aspect lucios, uneori se observă picături de lichid transudând prin piele;
c. roșu, dureros, cauză locală, care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1.
260. R1. teritoriul unde se observă edemul, u.a.s.c.g.e.:
A. cel renal se observă inițial retroauricular;
B. cel cardiac se observă inițial la fața;
C. cel inflamator se observă protibial;
D. cel venos se observă sacral;
- E. cel hepatic se observă la membrele inferioare, de obicei după constituirea ascitei;
261. F.d.u. evenimente legate de activarea SRAA:
a. activarea SRAA;
b. vasoconstricție renală;
c. absența prostaglandinelor vasodilatatoare;
d. AINS;
care este lanțul causal corect:
A. a→b→c→d;
B. b→c→d→a;
C. c→d→a→b;
D. d→c→a→b;
E. d→c→b→a.
262. F.d.u. evenimente care explică felul în care SRAA este implicat în producerea edemului în stările cu VSCE scăzut:
a. scade tensiunea (întinderea) la care sunt supuse celule juxtaglomerulare (care acționează ca baroreceptori);
b. scade presiunea din lumen și tensiunea din pereții arteriolelor renale;
c. umplerea deficitară a arteriolelor renale;
d. crește sinteza și eliberarea de renină;
e. peritubulei renale deficitare, care este lanțul causal corect:
A. a→d→e→b→c;
B. b→a→d→e→c;
C. c→a→d→b→e;
D. d→c→b→a→e;
E. e→c→b→a→d.
263. F.d.u. evenimente care explică felul în care SRAA este implicat în producerea edemului în stările cu VSCE scăzut:
a. peritubulei renale deficitare;
b. scade cantitatea de Na⁺ care ajunge în tubul distal la nivelul chemoreceptorilor din macula densă;
c. produce și eliberare de renină;
d. scade filtrarea glomerulară;
e. stimularea celulelor juxtaglomerulare;
f. scade presiunea de peritubule glomerulară;
- A. a→f→d→b→e→c;
B. b→c→e→a→d→f;
C. c→a→f→e→d→b;
D. d→e→a→c→b→f;
E. e→d→b→c→f→a;
264. F.d.u. evenimente care explică felul în care SRAA este

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dăte următoarele; f.d.u. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele; r1. = relevanță/revenire la, u.a.s.c.g.e. = Umplutele afirmate sunt corecte, cu excepție.

- implicată în producerea edemului în stările cu VSCE scăzut:
- AVP crește reabsorbția de apă liberă din tubuli distali și din tubuli colectori;
 - crește apa totală din organism;
 - secreție de AVP;
 - perfuzie renală deficitară;
 - stimularea receptorilor V2;
- care este lanțul causal corect:
- A. a-e-b-c-d;
 - B. b-e-d-a-c;
 - C. c-d-a-b-e;
 - D. d-e-c-a-b;
 - E. e-b-c-d-a.
265. F.d.u. evenimentele care explică faptul în care SRAA este implicată în producerea edemului în stările cu VSCE scăzut:
- eliberarea reninei;
 - activarea receptorilor β -adrenergici din celulele juxtaglomerulare;
 - activarea sistemului simpato-adrenergic;
 - scade inhibiția exercitată prin baroreflex asupra centrului vasomotor;
- care este lanțul causal corect:
- A. a-b-c-d;
 - B. b-c-a-d;
 - C. c-a-b-d;
 - D. c-d-a-b;
 - E. d-c-b-a.
266. F.d.u. evenimentele care explică faptul în care SRAA este implicată în producerea edemului: A72 stimulează producția de aldosteron;
- crește osmolaritatea;
 - retenție de apă;
 - aldosteronul crește reabsorbția Na^+ de către tubul colector;
 - secreție de AVP;
- care este lanțul causal corect:
- A. a-d-b-e-c;
 - B. b-c-d-a-e;
 - C. c-a-b-d-e;
 - D. d-b-a-c-e;
 - E. e-b-c-d-a.
267. F.d.u. evenimentele care explică faptul în care SRAA este implicată în producerea edemului:
- crește p.o. din capilarele peritubulare;
 - constricția arteriolelor eferente indusă de A72;
 - crește reabsorbția de sare și apă din tubul proximal și din ramul ascendent al anselor Henle;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
 - B. a-1, b-3, c-2;
 - C. a-2, b-3, c-1;
 - D. a-3, b-1, c-2;
 - E. a-3, b-2, c-1;
274. Care dintr-un următor nu este un hormon steroid apt să producă edeme prin creșterea reabsorbției renale de Na^+ :
- glucocorticoizi;
 - amilorid;
 - steroidi anabolizanți;
 - estrogeni;
 - progesteronice;
275. R.I. edemul prin creșterea p.h. din vas, f.d.u. categorii:
- RHS primară;
 - RHS secundară creșterii presiunii din capilare prin mecanism retrograd;
 - RHS secundară creșterii presiunii din capilare prin mecanism anterograd;
- și următoarele stări patologice:
- glomerulonefrită difuză acută;
 - bolile limfatice (obstrucție limatică);
 - IC;
 - bolile venoase (obstrucție venoasă sau insuficiență venoasă);
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-1, d-2;
 - B. a-1, b-2, c-2, d-1;
 - C. a-2, b-1, c-1, d-2;
 - D. a-2, b-1, c-2, d-1;
 - E. a-2, b-2, c-1, d-1;
276. R.I. edemul general prin creșterea p.h. din vas, f.d.u. categorii:
- RHS primară;
 - RHS secundară creșterii presiunii din capilare prin mecanism retrograd;
 - RHS secundară creșterii presiunii din capilare prin mecanism anterograd;
- și următoarele stări patologice:
- atecții renale;
 - atecții sisternice;
 - arteriolodilatatie;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
 - B. a-1, b-3, c-2;
 - C. a-2, b-1, c-3;
 - D. a-3, b-1, c-2;
 - E. a-3, b-2, c-1;
277. R.I. edemul general prin creșterea p.h. din vas, f.d.u. categorii:
- RHS primară;
 - RHS secundară creșterii presiunii din capilare prin mecanism retrograd;
 - RHS secundară creșterii presiunii din capilare prin mecanism anterograd;
- și următoarele stări patologice:
- glomerulonefrită difuză acută;
 - tratament cu nifedipină;
 - atecții cardiace;
- care este lanțul causal corect:
- A. a-d-c-b-e;
 - B. b-c-d-a-e;
 - C. c-a-b-d-e;
 - D. d-c-a-b-e;
 - E. e-b-c-d-a.
278. R.I. edemul general prin creșterea p.h. din vas, f.d.u. categorii:
- RHS primară;
 - RHS secundară creșterii presiunii din capilare prin mecanism retrograd;
 - RHS secundară creșterii presiunii din capilare prin mecanism anterograd;
- și următoarele stări patologice:
- glomerulonefrită difuză acută;
 - tratament cu nifedipină;
 - atecții cardiace;
- care este lanțul causal corect:
- A. a-d-c-b-e;
 - B. b-c-d-a-e;
 - C. c-b-d-a-e;
 - D. d-b-c-a-e;
 - E. e-b-c-d-a.
280. F.d.u. evenimentele r.l. edemul prin creșterea p.h. din vas:
- sechestrarea de lichid în interstițiu;
 - scăderea VSCE;
 - creșterea presiunii din capilare prin mecanism retrograd;
 - RHS;
 - creșterea presiunii venoase sisternice prin patologie cardiacă;
- care este lanțul causal corect:
- A. a-d-c-b-e;
 - B. b-c-d-a-e;
 - C. c-b-d-a-e;
 - D. d-b-c-a-e;
 - E. e-b-c-d-a.
281. F.d.u. evenimentele r.l. edemul prin creșterea p.h. din vas:
- RHS;
 - creșterea presiunii din capilare prin mecanism anterograd;
 - scăderea VSCE;
 - sechestrarea de lichid în interstițiu;
 - arteriolodilatatie;
- care este lanțul causal corect:
- A. a-e-b-c-d;
 - B. b-e-d-a-c;
 - C. c-d-a-b-e;
 - D. d-e-c-a-b;
 - E. e-b-c-d-a.
282. F.d.u. evenimentele care explică edemul prin creșterea p.h. din vas la pacienții tratați cu antihipertensive, mai ales cu vasodilatatoare:
- crește transsudarea de apă din capilare;
 - aflux crescut de sânge către capilare;
 - crește presiunea în capilare;
 - edem;
- care este lanțul causal corect:
- A. a-b-c-e-d;
 - B. b-c-e-a-d;
 - C. c-e-a-b-d;
 - D. e-b-a-c-d;
 - E. e-b-c-a-d.
283. C.d.u. NU este un vasodilatator care poate produce edem prin aflix crescut de sânge către capilare:
- triamteren;
 - hidralazină;
 - metildopa;
 - minoxidil;
 - antagoniști α -adrenergici;
 - blocant de canale de calciu dihidropiridinici;
284. Despre edemul cardiac, u.a.s.c.g.e.:
- A. este dureros;
 - B. în patogeneza intervin creșterea presiunii venoase centrale și scăderea debitului cardiac;
 - C. pe măsură ce se agravează, dispneea se accentuează;
 - D. lasă godeu, fiind moale;
 - E. devine dur în fazele avansate, prin proliferarea fibroblastilor;
285. Despre edemul cardiac, u.a.s.c.g.e.:
- A. are cauză locală;
 - B. este cald;
 - C. se asociază cu stază venoasă și capilară;
 - D. d-e-b-c-a.

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = cam dintr-un următor; f.d. = fiind date; f.d.u. = fiind date următoarele; r.l. = relativor/frecvent; s.c.g.e. = sunt următoarele; u.a.s.c.g.e. = următoarele afirmatii sunt corecte, cu excepția; s.u.c.g.e. = sunt corect formulate, cu excepția;

Prescurtări frecvent folosite: s.e. = cu excepția; s.u.c.g.e. = sunt următoarele, cu excepția; u.a.s.c.g.e. = următoarele afirmatii sunt corecte, cu excepția; s.c.g.e. = sunt corect formulate, cu excepția;

- D. este relativ dur față de alte tipuri de edem, mai ales dacă s-a instalat progresiv.
E. se asociază cu o creștere a filtrației glomerulare.
286. Despre edemul cardiac, u.a.s.c.g.e.:
A. apare mai întâi retromaleolar, unde este mai evident dimineața;
B. în mod caracteristic apare circulația venoasă colaterală;
C. în fazele avansate se evidențiază prebătă;
D. când se instalează acut, este moale și deplasabil;
E. se asociază cu hipopertuzie renală, care induce RHS;
287. Despre edemul cardiac, u.a.s.c.g.e.:
A. IC poate fi sistolică sau diastolică;
B. ICD determină creșterea presiunii din capilarele pulmonare;
C. cardiomegalia poate fi constatată clinic, pe radiografie și la ecocardiografie;
D. în IVS, dispneea se agravează în decubit;
E. la pacientul mergător, edemul se dispune în porțiunile inferioare ale membrului inferior;
288. Despre edemul cardiac, u.a.s.c.g.e.:
A. în IC sistolică ventriculul se goleşte insuficient;
B. ICD produce edem prin creșterea transsudării de lichid din capilare în interstițiul sistemic;
C. ecocardiografia este utilă în diagnosticarea IVS și a efectelor care o provoacă;
D. radiografia toracică evidențiază îngroșare peribronșică;
E. la pacientul mergător, edemul se dispune înălțat la gambe, ulterior retromaleolar;
289. Despre edemul cardiac, u.a.s.c.g.e.:
A. în IC sistolică rămâne mult sânge în ventricul la sfârșitul sistolei;
B. la producerea edemului din IVD participă atât RHS prin ambalarea SRAA, cât și scăderea presiunii din capilarele sistemice;
C. în IVS, socul apical este uneori deplasat sau dischinezic;
D. radiografia toracică evidențiază accentuarea desenului vascular în zonele pulmonare superioare;
E. la pacientul așezat, edemul se dispune pe perețile abdominali;
290. Despre edemul cardiac, u.a.s.c.g.e.:
A. în IC sistolică există o cantitate mare de sânge în ventricul în diastolă;
B. în IC ușoară creșterea volumului diastolic ventricular reduce contracția ventriculară;
C. IVD izolat apare cel mai adesea în cadrul unui cord pulmonar cronic decompensat;
D. radiografia toracică evidențiază linii Kerley B;
E. în formele severe, edemul poate ajunge până la perețile toracici;
291. Despre edemul cardiac, u.a.s.c.g.e.:
A. în IC diastolică ventriculul se relaxează insuficient;
B. în IC ușoară creșterea mică a volumului total de sânge poate compensa deficitul de sânge din patul arterial, stabilind o nouă stare de echilibru;
C. în IVD crește presiunea în venele jugulare și suprahepatice;
D. când este sever, edemul pulmonar interstițial poate produce edem alveolar (EPA);
E. înălțat, edemul la membrele inferioare se observă doar dintr-inele;
292. Despre edemul cardiac, u.a.s.c.g.e.:
A. în IC atât sistolică, cât și diastolică crește presiunea diastolică din ventricul;
B. hepatomegalia de stază este dureroasă în cazul că este cronică;
C. în IVD, prin transmitere retrogradă, crește presiunea din venele cave și din tributarele acestora;
D. creșterea presiunii din capilarele pleurale duce la acumularea de lichid în spațiul pleural;
E. în general, edemul de la membrele inferioare se observă mai bine seara întrucât a avut timp peste zi să se acumuleze;
293. Despre edemul cardiac, u.a.s.c.g.e.:
A. activarea SRAA are intensitate maximă în faza timpurie a insuficienței cardiace acute, severe;
B. în IC moderată și severă, perpetuarea retenției hidrosaline duce la acumularea suplimentară de sânge în circulația venoasă;
- C. în mod caracteristic, edemul cardiac se asociază cu cianoză centrală;
D. în formele mai severe, edemul poate cuprinde coapsele și perețile abdominale;
E. hidrotoracele poate deteriora și mai mult funcția respiratorie;
294. Despre edemul cardiac, u.a.s.c.g.e.:
A. activarea SRAA este mai puțin intensă la pacienții cu IC cronică, stabilă, compensată;
B. contracția (elecia/ golirea) deficiată a VS determină acumularea de sânge în teritoriul venos;
C. în IVS sunt caracteristice episoade de dispnee paroxistică nocturnă;
D. creșterea cantității de apă din țesutul interstițial împiedică difuziunea oxigenului și a substanțelor nutritive;
E. adesea singurul element bioumoral care reflectă staza hepatică este bilirubina necorijată crescută;
295. Despre edemul cardiac, u.a.s.c.g.e.:
A. RHS din IC se produce și în IVS, nu doar în ICG;
B. relaxarea (umplerarea) deficiată a VS determină acumularea de sânge în teritoriul venos;
C. în IVS, dispneea este înălțat la efort ușor;
D. împiedicând distensia plămânului, hidrotoracele poate produce sau agrava hipoxemia;
E. edemul cardiac vechi este moale, pufoș, deplasabil;
296. Despre edemul cardiac, u.a.s.c.g.e.:
A. în ICG edemul este mai evident deoarece, pe lângă RHS, interveni- nă și creșterea presiunii venoase sistemice;
B. în IVS acumularea de sânge cu creșterea VSCE;
C. pe măsură ce IVS se agravează, dispneea apare la eforturi din ce în ce mai mici;
D. hidrotoracele poate accentua dispneea;
E. la pacientul așezat, edemul se dispune mai ales în regiunea cea mai joasă a spatelui; sacrat;
297. Despre edemul cardiac, u.a.s.c.g.e.:

Presențuri frecvent toloste: G.E. = cu excepția; S.U.C.G.E. = sunt umflătoare, cu excepția; u.a.s.c.g.e. = umflătoare afirmative sunt corecte, cu excepția; S.C.I.G.E. = sunt corect formulate, cu excepția.

- A. în ICD crește presiunea venoasă sistemică (în venele cave);
B. de obicei, în IVS apare cardiomegalie;
C. în formele grave de IVS, dispneea apare chiar și în repaus;
D. ca orice edem de cauză generală, se dispune decub;
E. creșterea enzimei de colstază este întotdeauna însoțită de creșterea bilirubinei directe;
298. U.I.d.I.d. manifestările stazei pulmonare s.c.i.g.e.:
A. Pe măsură ce edemul pulmonar se agravează;
B. alveolele se umplu cu lichid;
C. iar radiografia toracică evidențiază umplere alveolară;
D. parțială, în mod tipic cu o distribuție periferică;
E. creșterea progresivă până la infiltrate alveolare difuze.
299. U.I.d.I.d. IC s.c.i.g.e.:
A. în IC sistolică, dar nu și diastolică crește presiunea diastolică din ventricul;
C. iar această presiune crescută se transmite direct atrului;
D. deorece în diastolă atrul comunică liber cu ventriculul;
E. valva atrioventriculară fiind deschisă.
300. R.I. VS, f.d.u. cauze:
1. scăderea debitului cardiac stâng;
2. scăderea perfuziei renale;
3. reducerea ritajului periferic; și umflătoare consecințe:
a. scăderea TAS;
b. ambalarea SRAA;
c. răcoala și cianoza extremităților, care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;
301. R.I. VS, f.d.u. cauze:
1. scăderea debitului cardiac stâng;
2. scăderea perfuziei renale;
3. scăderea TAS și creșterea TAD;
și umflătoare consecințe:
a. vasoconstricție periferică;
b. oligurie și/sau retenție azotată;
c. scăderea TA diferențiale; care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
- B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;
302. R.I. VS, f.d.u. cauze:
1. scăderea debitului cardiac stâng;
2. vasoconstricție periferică;
3. scăderea VSCE; și umflătoare consecințe:
a. scăderea amplitudinii pulsului;
b. creșterea TAD;
c. scăderea perfuziei renale; care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
303. F.d.u. evenimente r.I. VS:
a. contracție sau relaxare deficiată a VS;
b. creșterea presiunii în artera pulmonară;
c. creșterea presiunii în capilarele pulmonare;
d. acumularea de sânge în venele pulmonare;
e. creșterea presiunii în ventricul; care este lanțul cauzal corect:
A. a→d→c→b;
B. b→d→a→c;
C. b→d→c→a;
D. c→d→b→a;
E. d→a→b→c;
304. F.d.u. evenimente r.I. VS:
a. creșterea presiunii în artera pulmonară;
b. creșterea presiunii diastolice în VD;
c. edem periferic;
d. împiedicarea golirii VD;
e. creșterea presiunii venoase sistemice; care este lanțul cauzal corect:
A. a→d→b→e→c;
B. b→d→e→c→a;
C. c→e→d→a→b;
D. d→c→b→a→e;
E. e→a→b→c→d;
305. F.d.u. evenimente r.I. VS:
a. galop protodiastolic;
b. cantitate mare de sânge rezistent în VS la sfârșitul sistolei;
c. limitarea umplerii protodiastolice a VS;
d. scăderea debitului cardiac; care este lanțul cauzal corect:
A. a→b→c→d;
B. b→a→d→c;
C. b→a→d→c;
D. c→a→b→d;
E. c→d→b→a;
310. F.d.u. evenimente r.I. IVD izolat:
a. turgescență venelor jugulare;
b. scăderea debitului anterograd al VD;
c. creșterea presiunii din venele cave și din tributarele acestora;

Presențuri frecvent toloste: u. = umflătoare; c.d.u. = care dăre umflătoare; f.d. = fiind date; f.d.u. = fiind date umflătoare; r.I. = referitor/referitoare la; U.I.d.I.d. = Umflătoare fragmente dintr-o frază despre;

- d. creșterea presiunii din venele jugulare;
e. creșterea presiunii din AD;
care este lanțul causal corect:
A. $b \rightarrow e \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow a$;
B. $c \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow b$;
C. $d \rightarrow b \rightarrow a \rightarrow c \rightarrow e$;
D. $e \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a \rightarrow d$;
E. $e \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow b \rightarrow a$;
311. F.d.u. evenimentele r.l. IVD izolat:
a. creșterea presiunii din venele cave și din tributarele acestora;
b. creșterea presiunii din venele suprahepatice;
c. scăderea debitului anterograd al VD;
d. creșterea presiunii din AD;
e. hepatomegalie de stază;
care este lanțul causal corect:
A. $c \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow b \rightarrow e$;
B. $c \rightarrow d \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow e$;
C. $c \rightarrow e \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow d$;
D. $d \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a \rightarrow e$;
E. $d \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow e \rightarrow a$;
312. F.d.u. evenimentele r.l. IVD izolat:
a. creșterea presiunii din capilarele sistemice;
b. creșterea presiunii din venele sistemice;
c. creșterea presiunii din venele cave și din tributarele acestora;
d. creșterea transsudării lichidului din vas în interstițiu;
e. edem periferic;
care este lanțul causal corect:
A. $a \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow b \rightarrow e$;
B. $a \rightarrow e \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow c$;
C. $b \rightarrow e \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow c$;
D. $c \rightarrow b \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow e$;
E. $d \rightarrow b \rightarrow a \rightarrow c \rightarrow e$;
313. F.d.u. evenimentele r.l. IVD izolat:
a. creșterea presiunii din venele cave și din tributarele acestora;
b. creșterea presiunii din venele și din capilarele sistemice;
c. disconfort de stază pe tegumentele gambelor;
d. repetate mici efrații vasculare;
care este lanțul causal corect:
A. $a \rightarrow d \rightarrow b \rightarrow c$;
B. $a \rightarrow d \rightarrow b \rightarrow e$;
C. $c \rightarrow d \rightarrow b \rightarrow a$;
D. $d \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a$;
E. $d \rightarrow c \rightarrow b \rightarrow a$;
314. F.d.u. evenimentele r.l. IVD izolat:
a. scăderea debitului anterograd al VD;
b. implicarea drenării limfei din ductul toracic;
c. stază limfatică;
d. scăderea drenării de proteine din țesuturi;
e. accentuarea edemului;
f. creșterea presiunii venoase sistemice;
care este lanțul causal corect:
A. $a \rightarrow f \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e$;
B. $c \rightarrow d \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow f \rightarrow e$;
C. $c \rightarrow d \rightarrow a \rightarrow f \rightarrow b \rightarrow e$;
D. $d \rightarrow b \rightarrow a \rightarrow c \rightarrow e \rightarrow f$;
E. $f \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow c \rightarrow e$;
315. F.d.u. evenimentele r.l. IVD izolat:
a. activarea SRAA, oligurie, retenție azotată;
b. scădere cantitatea de sânge care ajunge în circulația pulmonară, în AS, în VS și în circulația sistemică;
c. scădere perfuzia renală;
d. scădere debitul anterograd al VD;
care este lanțul causal corect:
A. $b \rightarrow d \rightarrow a \rightarrow c$;
B. $c \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow b$;
C. $c \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow a$;
D. $d \rightarrow a \rightarrow c \rightarrow b$;
E. $d \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a$;
316. F.d.u. evenimentele r.l. IC:
a. cantitate mică de Hgb oxigenată disponibilă pentru a furniza oxigen țesuturilor;
b. cianoză periferică;
c. o cantitate mică de sânge circula lent prin capilarele sistemice;
d. debit cardiac scăzut și circulație încetinită a sângelui;
e. culoare cianotică a sângelui din capilare;
f. desaturare excesivă a Hgb; care este lanțul causal corect:
A. $b \rightarrow d \rightarrow f \rightarrow e \rightarrow a \rightarrow c$;
B. $c \rightarrow b \rightarrow e \rightarrow f \rightarrow a \rightarrow d$;
C. $d \rightarrow c \rightarrow a \rightarrow f \rightarrow e \rightarrow b$;
D. $e \rightarrow d \rightarrow f \rightarrow a \rightarrow c \rightarrow b$;
E. $f \rightarrow b \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow c \rightarrow e$;
317. F.d.u. evenimentele r.l. IVS:
a. respirație dificilă (dispnee);
b. crește p.h. în capilarele pulmonare;
c. crește transsudarea lichidului din capilare;
d. edem pulmonar interstițial;
e. crește presiunea venoasă pulmonară;
f. scădere complianța pulmonară;
care este lanțul causal corect:
A. $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow f \rightarrow e$;
B. $b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow a \rightarrow f$;
C. $c \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow f \rightarrow a \rightarrow b$;
D. $d \rightarrow e \rightarrow f \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow c$;
E. $e \rightarrow f \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d$;
318. F.d.u. evenimentele r.l. IVS:
a. crește presiunea venoasă pulmonară;
b. raluri de stază bazale bilaterale;
c. edem pulmonar interstițial;
d. crește transsudarea lichidului din capilare;
e. crește p.h. în capilarele pulmonare;
care este lanțul causal corect:
A. $a \rightarrow e \rightarrow d \rightarrow c \rightarrow b$;
B. $b \rightarrow c \rightarrow e \rightarrow a \rightarrow d$;
C. $d \rightarrow c \rightarrow e \rightarrow a \rightarrow b$;
D. $e \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow c \rightarrow a$;
E. $e \rightarrow d \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a$;
319. F.d.u. evenimentele r.l. IVS:
a. foarte rar edemul cardiac se observă la față;
b. dispnee agravată în decubit;
c. pacientul are tendința de a sta cu trunchiul ridicat pentru a respira mai bine (ortopnee);
d. lichidul nu va transsuda în interstițiu situat mai sus de nivelul toracelui;
care este lanțul causal corect:
A. $a \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow b$;
B. $b \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow c$;
C. $b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow a$;
D. $c \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow b$;
E. $d \rightarrow c \rightarrow b \rightarrow a$;
320. F.d.u. evenimentele r.l. un cerc vicios care poate agrava IVS:
a. hipoxie cardiacă;
b. hipoxemie;
c. edem pulmonar interstițial sever;
d. perturbarea suplimentară a funcției cardiace;
e. perturbarea schimbului de gaze;
f. agravarea edemului pulmonar interstițial;
care este lanțul causal corect:
A. $a \rightarrow f \rightarrow c \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow e$;
B. $b \rightarrow c \rightarrow f \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow a$;
C. $c \rightarrow e \rightarrow b \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow f$;
D. $d \rightarrow a \rightarrow c \rightarrow e \rightarrow b \rightarrow f$;
E. $e \rightarrow d \rightarrow a \rightarrow c \rightarrow b \rightarrow f$;
321. R.I. manifestările asociate cu edemul cardiac, f.d.u. cauze:
1. transsudarea de lichid în lumenul bronșic;
2. alveolele se umplu cu lichid;
3. presiune crescută în capilarele pleurale;
și următoarele consecințe:
A. $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow f \rightarrow e$;
B. $b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow f \rightarrow a$;
C. $d \rightarrow e \rightarrow f \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow c$;
D. $e \rightarrow f \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d$;
E. $f \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e$;
322. R.I. manifestările asociate cu edemul cardiac, f.d.u. cauze:
1. îngustarea lumenului bronșic prin edemul din perete;
2. complianța pulmonară redusă, hidrotorace;
3. transsudarea de lichid în cavitățile pleurale;
și următoarele consecințe:
a. mătăle cu diminuarea mormurului vezicular;
b. dispnee;
c. raluri bronșice uscate (sifaloare și suierătoare);
care sunt asociate corecte:
A. $a-1, b-2, c-3$;
B. $a-1, b-3, c-2$;
C. $a-2, b-1, c-3$;
D. $a-3, b-1, c-2$;
E. $a-3, b-2, c-1$;
323. F.d.u. evenimentele legate de edemul cardiac vechi:
a. furnizare deficitară de oxigen și substanțe nutritive către teritoriul subcutanat;
b. producție de colagen;
c. debit cardiac scăzut + difuziune deficitară prin stratul de edem;
d. interstițiu va fi populat cu celule care necesită puțin oxigen: fibroblasti;
care este lanțul causal corect:
A. $a \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow c$;
B. $b \rightarrow d \rightarrow a \rightarrow c$;
C. $b \rightarrow d \rightarrow c \rightarrow a$;
D. $c \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow b$;
E. $d \rightarrow c \rightarrow a \rightarrow b$;
324. F.d.u. evenimentele legate de edemul cardiac vechi:
a. edemul nu este foarte mare și lasă godelu greu;
b. producție de colagen;
c. fibrozare interstițială;
d. țesut interstițial devine mai rigid, mai puțin distensibil, dar și mai puțin comprimabil;
e. proliferarea fibroblastilor în țesutul subcutanat;
care este lanțul causal corect:
A. $b \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow c$;
B. $c \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow a \rightarrow b$;
- A. hidrotorace;
b. raluri crepitante;
c. raluri bronșice umede (subcrepitante);
care sunt asociate corecte:
A. $a-1, b-2, c-3$;
B. $a-2, b-1, c-3$;
C. $a-2, b-3, c-1$;
D. $a-3, b-1, c-2$;
E. $a-3, b-2, c-1$;
322. R.I. manifestările asociate cu edemul cardiac, f.d.u. cauze:
1. îngustarea lumenului bronșic prin edemul din perete;
2. complianța pulmonară redusă, hidrotorace;
3. transsudarea de lichid în cavitățile pleurale;
și următoarele consecințe:
a. mătăle cu diminuarea mormurului vezicular;
b. dispnee;
c. raluri bronșice uscate (sifaloare și suierătoare);
care sunt asociate corecte:
A. $a-1, b-2, c-3$;
B. $a-1, b-3, c-2$;
C. $a-2, b-1, c-3$;
D. $a-3, b-1, c-2$;
E. $a-3, b-2, c-1$;
323. F.d.u. evenimentele legate de edemul cardiac vechi:
a. furnizare deficitară de oxigen și substanțe nutritive către teritoriul subcutanat;
b. producție de colagen;
c. debit cardiac scăzut + difuziune deficitară prin stratul de edem;
d. interstițiu va fi populat cu celule care necesită puțin oxigen: fibroblasti;
care este lanțul causal corect:
A. $a \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow c$;
B. $b \rightarrow d \rightarrow a \rightarrow c$;
C. $b \rightarrow d \rightarrow c \rightarrow a$;
D. $c \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow b$;
E. $d \rightarrow c \rightarrow a \rightarrow b$;
324. F.d.u. evenimentele legate de edemul cardiac vechi:
a. edemul nu este foarte mare și lasă godelu greu;
b. producție de colagen;
c. fibrozare interstițială;
d. țesut interstițial devine mai rigid, mai puțin distensibil, dar și mai puțin comprimabil;
e. proliferarea fibroblastilor în țesutul subcutanat;
care este lanțul causal corect:
A. $b \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow c$;
B. $c \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow a \rightarrow b$;
- A. edemul din IRA are un mecanism similar cu cel din GNDA, în măsura în care există oligurie sau anurie;
B. în cazurile mai grave, apare retenție azotată (IRA);
C. pe radiografia toracică, se observă congestie pulmonară, dar nu cardiomegalie;
D. manifestările RHS pot ajunge până la anasară;
E. VSCE este scăzut;
330. F.d.u. evenimentele legate de edemul din GNDA (edemul nefritic):
a. scade fluxul de sânge prin glomerul;
b. scade filtrarea glomerulară;
c. curgerea sângelui prin capilarele glomerulare este împiedicată;
d. RHS;
e. se activează SRAA;
f. capilarele glomerulare sunt blocate de acumularea de celule inflamatoare;
care este lanțul causal corect:
A. $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow e \rightarrow d \rightarrow f$;
B. $b \rightarrow e \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow a \rightarrow f$;
C. $c \rightarrow d \rightarrow a \rightarrow e \rightarrow f \rightarrow b$;
D. $d \rightarrow a \rightarrow f \rightarrow e \rightarrow b \rightarrow c$;
E. $f \rightarrow c \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow e \rightarrow d$;
331. F.d.u. evenimentele legate de edemul din GNDA (edemul nefritic):
a. crește presiunea din capilare;
b. transsudarea de lichid în interstițiu sistemic și pulmonar;
c. edem, edem pulmonar, edem cerebral;
d. RHS;
e. crește volumul;
care este lanțul causal corect:
A. $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e$;
B. $b \rightarrow e \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow c$;
C. $c \rightarrow e \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow a$;
D. $d \rightarrow e \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow c$;
E. $e \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow c$;
332. F.d.u. evenimentele legate de edemul din GNDA (edemul nefritic):
a. crește volumul;
b. crește presiunea din artere;
c. HTA;
d. RHS;
care este lanțul causal corect:
A. $a \rightarrow d \rightarrow b \rightarrow c$;
B. $b \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow c$;
C. $c \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow d$;
D. $c \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow b$;
E. $d \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow c$;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dăre următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, r.l. = referenț/reținere la, u.d.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază despre.

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dăre următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, r.l. = referenț/reținere la, u.d.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază despre.

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dăre următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, r.l. = referenț/reținere la, u.d.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază despre.

333. Manifestări ale RHS asociate edemului nefritic s.u.c.g.e.:
 A. hipotensiune arterială;
 B. edem cerebral;
 C. edem periferic;
 D. edem pulmonar;
 E. lichid în serosă;
334. F.d.u. variante de edem prin creșterea p.h. din capilarele sistemice:
 1. edemul din IC congestivă;
 2. edemul nefritic;
 și următoarele trăsături:
 a. rareori cuprinde fața;
 b. diferența în saturarea cu oxigen dintre sângele arterial și cel venos este normală;
 c. debitul cardiac scăzut;
 d. este alb (nu este cianotic);
 care sunt asocierile corecte:
 A. a-1, b-1, c-2, d-2;
 B. a-1, b-2, c-1, d-2;
 C. a-2, b-1, c-1, d-2;
 D. a-2, b-1, c-2, d-1;
 E. a-2, b-2, c-1, d-1;
335. F.d.u. variante de edem prin creșterea p.h. din capilarele sistemice:
 1. edemul din IC congestivă;
 2. edemul nefritic;
 și următoarele trăsături:
 a. nu se asociază cu hipertensiune periferică;
 b. debitul cardiac este normal sau chiar crescut;
 c. diferența în saturarea cu oxigen dintre sângele arterial și cel venos este crescută;
 d. se asociază cu ortopnee;
 care sunt asocierile corecte:
 A. a-1, b-2, c-1, d-2;
 B. a-1, b-2, c-2, d-1;
 C. a-2, b-1, c-1, d-2;
 D. a-2, b-1, c-2, d-1;
 E. a-2, b-2, c-1, d-1;
336. F.d.u. variante de edem prin creșterea p.h. din capilarele sistemice:
 1. edemul din IC congestivă;
 2. edemul nefritic;
 și următoarele trăsături:
 a. este cianotic;
 b. nu se asociază cu ortopnee;
 c. dimineața este mai accentuat la față;
 d. se asociază cu hipopentuzie periferică;
 care sunt asocierile corecte:
 A. a-1, b-1, c-2, d-2;
 B. a-1, b-2, c-2, d-1;
 C. a-2, b-1, c-1, d-2;
 D. a-2, b-1, c-2, d-1;
337. R.I. edemul din IRC, u.a.s.c.g.e.:
 a. cauza retenției de sare și apă este primar renală;
 B. la pacienți cu IRC secundară HTA, adesea apare retinopatie hipertensivă;
 C. edemul poate fi predominant periorbital;
 D. în cazurile avansate poate să apară frecură pericardică;
 E. în mod caracteristic, anemita este microcitară;
338. R.I. edemul din IRC, u.a.s.c.g.e.:
 A. tensiunea arterială poate fi crescută;
 B. la pacienți cu IRC secundară diabetului, adesea apare retinopatie diabetică;
 C. dispneea poate fi prezentă, dar în general este mai puțin importantă decât în IC;
 D. în mod caracteristic apare alcaloză metabolică;
 E. de obicei apare hipokalemie;
339. R.I. manifestările asociate cu edemul din IRC, f.d.u. categorii:
 1. clinice;
 2. paraclinice;
 și următoarele manifestări:
 a. așchiile sau mușchii ale picioarelor;
 b. scăderea poftei de mâncare;
 c. hiperkalemie;
 d. anemie;
 care sunt asocierile corecte:
 A. a-1, b-1, c-2, d-2;
 B. a-1, b-2, c-1, d-2;
 C. a-1, b-2, c-2, d-1;
 D. a-2, b-1, c-2, d-1;
 E. a-2, b-2, c-1, d-1;
340. R.I. manifestările asociate cu edemul din IRC, f.d.u. categorii:
 1. clinice;
 2. paraclinice;
 și următoarele manifestări:
 a. gust alterat;
 b. acidoză metabolică;
 c. proteinurie;
 d. dispnee;
 care sunt asocierile corecte:
 A. a-1, b-1, c-2, d-2;
 B. a-1, b-2, c-2, d-1;
 C. a-2, b-1, c-1, d-2;
 D. a-2, b-1, c-2, d-1;
 E. a-2, b-2, c-1, d-1;
341. R.I. manifestările asociate cu edemul din IRC, f.d.u. categorii:
 1. clinice;
 2. paraclinice;

Preacurată frecvent folosite: s.g. = cu excepția; s.u.c.g.e. = sunt următoarele; cu excepția; u.a.s.c.g.e. = următoarele afirmații sunt corecte; cu excepția; s.c.i.g.e. = sunt corecte formulate, cu excepția;

346. R.I. edemul din tromboza venoasă profundă (TVP), u.a.s.c.g.e.:
 A. edemul se asociază cu durere;
 B. durerea de inflamație intensă;
 C. edemul este unilateral;
 D. poate fi afectat și unul dintre membrele superioare;
 E. culoarea membrului afectat este modificată;
347. R.I. manifestările asociate cu edemul din IRC, f.d.u. categorii:
 1. clinice;
 2. paraclinice;
 și următoarele manifestări:
 a. gust metalic sau de pește;
 b. retenție azotată;
 c. concentrare dificilă;
 d. hipokalemie;
 care sunt asocierile corecte:
 A. a-1, b-1, c-2, d-2;
 B. a-1, b-2, c-1, d-2;
 C. a-1, b-2, c-2, d-1;
 D. a-2, b-1, c-1, d-2;
 E. a-2, b-2, c-1, d-1;
348. R.I. afecțiunile venoase care pot produce edem local prin creșterea p.h. din capilare, u.a.s.c.g.e.:
 A. edemul poate fi acut, cum este cazul în tromboza venoasă profundă;
 B. în insuficiența venoasă cronică edemul este cronic;
 C. vena poate fi comprimată extern sau invadată tumoral;
 D. compresia extrinsecă a unei vene poate fi exercitată de către o formațiune tumorală;
 E. vena trombozată poate comprima artera adiacentă;
349. U.f.d.f. edemul local prin creșterea p.h. s.c.i.g.e.:
 A. Edemul poate să apară:
 B. prin menținerea unei părți din corp mult timp în poziție ridicată;
 C. cel mai adesea un membru superior;
 D. afectat de ischemie periferică;
 E. la pacienți cu tromboză venoasă profundă;
350. U.f.d.f. edemul local prin creșterea p.h. s.c.i.g.e.:
 A. Pacientul cu artropatie obliterantă;
 B. în general afectat în sus;
 C. în general alături de durere;
 D. pentru ameliora durerea;
 E. prin creșterea gravitațională a fluxului arterial;
351. F.d.u. evenimente legate de edemul din TVP:
 a. crește tensiunea isulară;
 b. durerea locală;
 c. crește presiunea venoasă în amonte de obstacol;
 d. obstacol venos;
 e. crește presiunea în teritoriul capilar drenat de acea venă;
 f. crește transudarea de lichid din vase în interstițiu local;
 care este lanțul causal corect:
 A. a→b→c→d→e→f;
 B. b→d→c→f→a→e;
 C. c→a→d→f→b→e;
 D. d→c→e→f→a→b;
 E. e→b→a→d→c→f;
352. F.d.u. evenimente legate de edemul din TVP:
 a. încrețea transparenței net de lichid din capilar în vas;
 b. p.h. a lichidului interstițial ajunge să contrabalanseze p.h. crescută din capilare;
 c. nu se mai acumulează lichid interstițial (tensiunea isulară);
 d. crește p.h. a lichidului interstițial (tensiunea isulară);
 care este lanțul causal corect:
 A. a→c→d→b;
 B. b→c→a→d;
 C. c→d→a→b;
 D. d→b→a→c;
 E. d→c→b→a;
353. F.d.u. evenimente legate de edemul TVP:
 a. acumularea locală de lichid;
 b. scade volemia;
 c. RHS până la corectarea deficitului volemic;
354. R.I. edemul din insuficiența venoasă cronică, u.a.s.c.g.e.:
 A. în mod caracteristic apare disconfort de stază;
 B. adesea apar tulburări trofice;
 C. pliozitatea devine excesivă;
 D. leziuni aparent ușoare se pot agrava, mergând până la ulcer de gambă (ulcer varicos);
 E. legumului membrului afectat are adesea o tentă palidă;
355. R.I. edemul din insuficiența venoasă cronică, u.a.s.c.g.e.:
 A. edemul este moale, puros;
 B. pielea este subțiată și lucioasă;
 C. leziunile, fle și banane, se vindecă foarte greu;
 D. edemul este una dintre manifestările sindromului posttrombotic;
 E. cianoza se observă mai ales în porțiunile proximale ale membrului afectat;
356. F.d.u. evenimente r.I. edemul din insuficiența venoasă cronică:
 a. reacție fibroasă;
 b. celulita indurativă;
 c. episoade repetate de inflamație/infecție subcutanată;
 care este lanțul temporal corect:
 A. a→b→c;
 B. a→c→b;
 C. b→c→a;
 D. c→a→b;
 E. c→b→a;
357. R.I. edemul calamei:
 u.a.s.c.g.e.:
 A. de obicei este sever;
 B. adesea este însoțit de tulburări psihoneurologice;
 C. se observă mai ales la față;
 D. apare în prime jurnale a ciclului menstrual;
 E. de obicei se asociază cu hiperandrogenism primar;
358. R.I. mecanismul edemului produs de excesul de hormoni feminini, f.d.u. cauze:
 1. progesteron și/sau estrogeni;
 2. artrodiplazie;
 3. relaxarea pereților venos;
 și următoarele consecințe:
 a. creșterea permeabilității capilare;
 b. hiperandrogenism secundar;

Preacurată frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele; r.I. = referitor/referitoare la; U.f.d.f. = următoarele fragmente dintr-o frază despre;

- C. crește presiunea în capilare (prin mecanism retrograd);
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;
359. R.I. mecanismul edemului produs de excesul de hormoni feminini, f.d.u. cauze:
1. crește permeabilitatea capilară;
2. arteriolodilatație;
3. crește presiunea în capilare;
și următoarele consecințe:
a. se scurge lichid și proteine în spațiul interstițial;
b. crește presiunea în capilare (prin mecanism anterograd);
c. crește transsudarea de lichid din vas în interstițiu;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;
360. F.d.u. evenimente legate de edemul produs de excesul de hormoni feminini:
a. crește transsudarea de lichid din vas în interstițiu;
b. afliu crescut de sânge spre capilare;
c. crește presiunea în capilare;
d. arteriolodilatație;
care este lanțul causal corect:
A. a-3-c-b-d;
B. a-4-d-c-b;
C. b-4-c-d-a;
D. d-4-b-c-a;
E. d-c-b-a;
361. F.d.u. evenimente legate de edemul produs de excesul de hormoni feminini:
a. scade întoarcerea venoasă;
b. crește presiunea venoasă;
c. relaxarea peretelui venos;
d. crește transsudarea de lichid din vas în interstițiu;
e. crește presiunea în capilare;
care este lanțul causal corect:
A. a-4-e-c-b-d;
B. b-4-e-c-d-a;
C. c-4-a-b-e-d;
D. d-4-e-a-b-c;
E. e-4-b-d-c-a;
362. R.I. edemul de sarcină (EdSa), u.a.s.c. e:
A. de obicei, EdSa apare din primul trimestru;
B. EdSa este relativ dur;
- C. în patogeneza sunt implicați hormoni feminini;
D. compresia VCI nu este suficientă pentru a explica EdSa;
E. prognosticul EdSa se agravează dacă se asociază cu HTA;
363. R.I. edemul de sarcină (EdSa), u.a.s.c. e:
A. cel mai adesea, EdSa este sever;
B. EdSa se observă mai ales la medii înalți;
C. de obicei este carbonat;
D. de obicei, EdSa este cianotic;
E. prognosticul se agravează dacă se asociază cu proteinurie;
364. R.I. eclampsie u.a.s.c. e:
A. apare în primul trimestru de sarcină;
B. poate fi considerată o formă de encefalopatie hipertensivă, care poate merge până la comă și deces;
C. în patogeneza intervine hipotensiunea placentală prin exces de vasoconstricție, deficit de vasodilatație și formare de microtrombi;
D. se asociază cu hipotensiune; E. în mod caracteristic apar edeme generalizate;
365. R.I. eclampsie u.a.s.c. e:
A. caracteristică este apariția convulsurilor petit mal la o femeie cu preclampsie;
B. prognosticul este benign;
C. în patogeneza intervine activarea trombotică și endotelială, precum și dezechilibrul substanțelor vasoactive;
D. este mai frecventă la multipare;
E. în mod caracteristic apare proteinurie;
366. R.I. preclampsie u.a.s.c. e:
A. definitorie este apariția convulsurilor;
B. este mai frecventă la nulipare;
C. se asociază cu HTA;
D. în mod caracteristic apare proteinurie;
E. în mod caracteristic apar edeme faciale;
367. R.I. manifestările sindromului mediatinal din obstrucția de venă cavă superioară, u.a.s.c. e:
A. apare edem în pelerină;
B. edemul este limitat la față, gât, spatul superior și membrele inferioare;
C. apare circulație venoasă colaterală cavo-cavă;
372. Cauze de hipoproteinemie s.u. e:
A. albuminurie;
B. lipsa aportului;
- D. este caracteristică cianoza localizată în zona edemată;
E. sclerele sunt icterice;
368. R.I. edemul în pelerină, u.a.s.c. e:
A. afectează jumătatea inferioară a toracelui și membrele inferioare;
B. o cauză tipică sunt limfoamele;
C. este provocat de compresia venei cave inferioare;
D. apare în cadrul sindromului mediatinal;
- E. de obicei este carbonat;
369. R.I. edemul din obstrucția limfatică acută, u.a.s.c. e:
A. de obicei, este consecința unei limfangite;
B. adesea apare în cadrul unei infecții sistemice;
C. poate fi provocat de un erizipel;
D. se asociază cu semne de infecție/inflamație;
E. se remite după rezolvarea infecției;
- F. de obicei este simetric;
370. R.I. edemul din obstrucția limfatică cronică, u.a.s.c. e:
A. este provocat de infiltrarea tumorală sau de rezecția nodulilor limfatici regionali, filarioză etc.;
B. inițial edemul este moale, ulterior devine cartonat, cu lichenificări;
C. teritoriul afectat are consistență păstoasă;
D. pielea pare subțiată, punctată de depresiuni lăsată de foliculii piloși („piele de porc”);
E. vasele limfatice superficiale dilatate cu peretele destins (sau chiar dilacerat) pot să apară ca niște trasee proeminente, semitransparente;
371. F.d.u. afirmații r.I. edemul din obstrucția limfatică:
a. blocarea fluxului limfatic;
b. creșterea p.o. a lichidului interstițial;
c. agravarea retenției de lichid;
d. limfedemul nu poate fi tratat;
e. creșterea concentrației proteinelor din lichidul interstițial;
care este înălțimea logică justă:
A. a-4-e-b-c-d;
B. b-4-c-d-e-a;
C. c-4-d-a-b-e;
D. d-4-e-c-b-a;
E. e-4-c-b-a-d;
372. Cauze de hipoproteinemie s.u. e:
A. albuminurie;
B. lipsa aportului;

Prescrutări frecvent folosite: u. = următoarele, c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele; r.I. = referitor/referitoare la; u.a.s.c. e. = Următoarele fragmente dintr-o fază desprind;

- C. gastrită atrofică;
D. enteropatie;
E. hepatopatie;
373. R.I. factorii care determină p.o. din vas, u.a.s.c. e:
A. principalul determinant al p.o. din sânge sunt albuminele;
B. numărul de molecule de albumine este mult mai mic decât numărul de molecule de globuline pentru o cantitate dată de proteine;
- C. o moleculă de albumină este (mult) mai mică decât una de globulină;
D. nivelul presiunii osmotice este dat de greutatea moleculară a moleculelor care o exercită;
E. moleculele mici care trec liber prin peretele vasului nu contribuie la p.o. intravasculară;
374. R.I. factorii care determină p.o. din vas, u.a.s.c. e:
A. albuminele au masa moleculară (mult) mai mică decât a globulinelor;
B. în aceeași cantitate de proteine încap (mult) mai puține molecule de albumine decât de globuline;
C. moleculele de albumine sunt mult mai numeroase decât cele de globuline;
- D. nivelul presiunii osmotice depinde de masa/dimensiunea moleculelor care o exercită;
E. moleculele mici sunt principalul determinant al presiunii osmotice, dar nu influențează p.o. intravasculară;
375. F.d.u. afirmații r.I. p.o. din vas:
a. albuminele sunt principalul determinant al presiunii coloid-osmotice (oncotice) din sânge;
b. albuminele au masa moleculară (mult) mai mică decât a globulinelor;
c. numărul de molecule de albumine este mult mai mare decât numărul de molecule de globuline pentru o cantitate dată de proteine;
care este înălțimea logică justă:
A. a-4-b-c;
B. b-4-a-c;
C. b-4-c-a;
D. c-4-a-b;
E. c-4-b-a;
376. F.d.u. afirmații r.I. p.o. din vas:
a. încap (mult) mai multe molecule de albumine decât de globuline în aceeași cantitate de proteine;
b. o moleculă de albumină este (mult) mai mică decât una de globulină;
c. albuminele sunt principalul determinant al presiunii coloid-osmotice (oncotice) din sânge;
d. moleculele de albumine sunt mult mai numeroase decât cele de globuline;
377. U.f.d.f.d. factorii care determină p.o. din vas s.c.f. e:
A. Un număr mare de molecule;
B. mici exercită o presiune osmotică mai mică;
C. decât un număr mic de molecule mari chiar dacă;
D. masa totală a moleculelor mici este egală;
E. cu cea a moleculelor mari;
378. R.I. edemul prin scăderea p.o. din vas, u.a.s.c. e:
A. este determinat de scăderea cantității de albumină din sânge;
B. este înfulea un edem general;
C. trebuie diferențiat de cauzele mai rare de edem facial;
D. dimineața este mai accentuat la față, din cauza activării suplimentare a SRAA;
E. edemul este generalizat, dar este în special evident la țesuturile foarte moi de la față (mai ales de la pleoape);
379. R.I. edemul prin scăderea p.o. din vas, u.a.s.c. e:
A. hipoproteinemie de obicei nu este suficientă prin ea însăși pentru a determina edem interstițial pulmonar;
B. accentuarea mai multă la față a edemului este valabilă mai ales pentru edemul nefrotic;
C. edemul din mainuri este mai accentuat la față seara;
D. edemul cirotic se observă preponderent la față;
380. R.I. cauzele edemului prin scăderea p.o. din vas, f.d.u. categorii:
1. intră prea puțin;
2. se pierde prea mult;
3. se sintetizează prea puțin;
și u. trăsături manifestări:
a. sinteză hepatică deficitară;
b. statut socioeconomic defavorabil;
c. stare catabolică severă;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-3, c-2;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
381. U.f.d.f.d. edemul prin scăderea p.o. din vas s.c.f. e:
A. Edemul se datorează faptului că apa nu mai este ținută în vas;
B. ci se pierde din vas în interstițiu și în seroase;
C. ceea ce crește presiunea din vase, în măsura în care;
D. aceasta nu este modificată prin alt mecanism, așa cum;
E. este adesea cazul în glomerulopatii care produc sindrom nefrotic.
382. R.I. cauzele edemului prin scăderea p.o. din vas, f.d.u. categorii:
1. intră prea puțin;
2. se pierde prea mult;
3. se sintetizează prea puțin;
și u. trăsături manifestări:
a. aport alimentar insuficient;
b. pierderi renale sau intestinale prea mari;
c. insuficiență hepatică;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;
383. R.I. cauzele edemului prin scăderea p.o. din vas, f.d.u. categorii:
1. intră prea puțin;
2. se pierde prea mult;
3. se sintetizează prea puțin;
și u. trăsături manifestări:
a. sinteză hepatică deficitară;
b. statut socioeconomic defavorabil;
c. stare catabolică severă;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-3, c-2;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
384. R.I. cauzele edemului prin scăderea p.o. din vas, f.d.u. categorii:
1. intră prea puțin;

Prescrutări frecvent folosite: u. = următoarele, c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele; r.I. = referitor/referitoare la; u.f.d.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o fază desprind;

2. se pierde prea mult;
3. se sinetizează prea puțin;
și u. trăsături manifestări:
a. ciroza hepatică;
b. malnutriție proteică;
c. boli inflamatorii intestinale;
d. sindrom nefrotic;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3, d-2;
B. a-1, b-3, c-2, d-2;
C. a-2, b-1, c-2, d-3;
D. a-3, b-2, c-1, d-3;
E. a-3, b-1, c-2, d-2;
385. F.d.u. evenimentele r.l. edemul prin scăderea p.o. din vase:
a. hipotensiune severă;
b. apa nu mai poate fi reținută în compartimentul vascular, fiind pierdută în interstițiu;
c. scade presiunea coloîd-osmotică;
d. scad volumul de sânge arterial total și cel eficient;
e. odată cu apa, în interstițiu scapă și NaCl;
care este lanțul causal corect:
A. a→c→b→e→d;
B. b→d→e→a→c;
C. c→d→e→b→a;
D. d→e→a→b→c;
E. e→b→a→c→d;
386. F.d.u. evenimentele r.l. edemul prin scăderea p.o. din vase:
a. retenție de Na și apă;
b. Na și apă se pierd în continuare în interstițiu;
c. scade perfuzia renală;
d. activarea SRAA;
e. scad volumul de sânge arterial total și cel eficient;
care este lanțul causal corect:
A. a→b→e→c→d;
B. b→e→a→c→d;
C. c→e→b→d→a;
D. d→b→c→e→a;
E. e→c→d→a→b;
387. R.l. edemul hepatic și manifestările asociate acestuia, u.a.s.c.g.e.:
A. scade capacitatea ficatului de a sintetiza albumină;
B. obstrucția biliară determină colestază;
C. deficiul funcțional hepatic responsabil pentru hipotensiune este de obicei prima manifestare a bolii;
D. disprezia apare doar în cazurile cu ascită masivă care împiedică mișcarea diafragmei;
- E. blocajul intrahepatic împiedică elivul alături al sângelui port, cât și al limfei;
388. R.l. edemul hepatic și manifestările asociate acestuia, u.a.s.c.g.e.:
A. ciroza hepatică înseamnă fibrozarea ficatului;
B. edemul este consecința insuficienței hepatice;
C. în mod caracteristic, edemul se asociază și cu alte elemente care semnalează hepatopatie cronică;
D. determinând hiperventilație, dispneea poate provoca acidoză respiratorie;
E. RHS este localizată inițial în sistemul port și teritoriul drenat de acesta;
389. R.l. edemul hepatic și manifestările asociate acestuia, u.a.s.c.g.e.:
A. VSCE scade prin sechestrarea de lichid în amonte de circulația portă și prin vasoconstricția sistemică;
B. în general, în evoluția unei ciroze hepatice, apariția HTP apare după instalarea insuficienței hepatice;
C. vasoconstricția renală contribuie la retenția de Na;
D. cel mai adesea există un istoric de consum excesiv de etanol;
E. RHS este localizată inițial în viscerele abdominale și mai ales în cavitatea peritoneală;
390. R.l. edemul hepatic și manifestările asociate acestuia, u.a.s.c.g.e.:
A. creșterea presiunii tisulare crește formarea de lichid hepatic;
B. consecințele HTP (cum este ascita) preced consecințele insuficienței hepatice (cum este edemul hepatic);
C. scăderea VSCE induce vasodilatația renală;
D. poate să apară contractură Duryvren;
E. RHS este reprezentată inițial mai ales de ascită;
391. R.l. edemul hepatic și manifestările asociate acestuia, u.a.s.c.g.e.:
A. limfaticele hepatice sunt blocate de procesul fibrotic caracteristic pentru ciroză;
- B. de obicei, pacienții care dezvoltă edem hepatic au deja ascită;
C. vasoconstricția renală este contracarată parțial de efectul vasodilatator renal al prostaglandinelor (PGE₂ și PGI₂);
D. presiunea în sistemul vascular este în general mai mare decât în bolile renale sau cardiace formatoare de edem;
E. RHS este localizată ulterior și în interstițiu sistemic;
392. R.l. edemul hepatic și manifestările asociate acestuia, u.a.s.c.g.e.:
A. absența proteinurii deosebite hipotalinemia din insuficiența hepatică de cea din SdMf;
B. pacienții cu edem hepatic au de obicei un abdomen proeminent;
C. prostaglandinele vasodilatoare (PGE₂ și PGI₂) sunt produse în exces în ciroză;
D. tensiunea arterială este scăzută, prin contrast cu tensiunea arterială crescută din bolile renale productoare de edem;
E. în mod caracteristic, jugularele sunt turgescențe;
393. R.l. edemul hepatic și manifestările asociate acestuia, u.a.s.c.g.e.:
A. creșterea transaminazelor depinde de cauza leziunii hepatice;
B. pacienții cu edem hepatic au adesea pieptul emaciă;
C. inhibând sinteza prostaglandinelor, AINS pot decompensa funcția renală;
D. presiunea în venele sistemice este crescută;
E. când survine hipotensiunea, RHS afectează și interstițiul sistemic;
394. R.l. edemul hepatic și manifestările asociate acestuia, u.a.s.c.g.e.:
A. creșterea transaminazelor depinde de cât de severă și de acută este leziunea hepatică;
B. mulți pacienți cu edem hepatic au fața și membrele superioare emaciă;
C. administrarea de AINS la un cirotic poate ameliora retenția de Na;
D. presiunea din artere este scăzută;
E. de obicei nu survine creșterea presiunii în sistemul venos cav.

Prescurtări frecvent folosite: c.d. = cu excepție, s.u.c.g.e. = sunt următoarele, cu excepție, u.a.s.c.g.e. = următoarele afirmații sunt corecte, cu excepție, s.c.l.c.g.e. = sunt corect formulate, cu excepție.

395. R.l. edemul hepatic și manifestările asociate acestuia, u.a.s.c.g.e.:
A. scăderea colesterolului este cel mai sensibil indicator al distoniei hepatice;
B. mulți pacienți cu edem hepatic au amotofie legată de excesul de estrogeni;
C. rareori apare dispnee;
D. RHS este localizată inițial în aval de blocajul intrahepatic;
E. edemul este de obicei alb, moale și pulso;
396. Modificări caracteristice pentru ciroza hepatică s.u.c.g.e.:
A. fibroză în spațiul port și lobulul hepatic;
B. obstrucția intrahepatică a ramificațiilor venei porte;
C. congestia tractului digestiv;
D. inhibarea SRAA;
E. scăderea metabolizării altosteoronilor;
397. Modificări caracteristice pentru ciroza hepatică s.u.c.g.e.:
A. creșterea presiunii în sistemul port;
B. creșterea perfuziei renale;
C. inhibarea SN simpatic renal;
D. hipotensiune;
E. scăderea metabolizării estrogenilor;
398. F.d.u. evenimentele r.l. edemul hepatic:
a. presiune intraabdominală crescută;
b. contribuie la formarea edemului;
c. ascită în cantitate mare;
d. împiedicarea înlocuirii venoase din membre inferioare;
care este lanțul causal corect:
A. a→d→b→c;
B. b→a→d→c;
C. c→a→d→b;
D. c→b→a→d;
E. d→a→c→b;
399. F.d.u. evenimentele r.l. edemul hepatic:
a. jugulare neturgescențe;
b. presiunea tînd să scadă în sistemul vascular;
c. presiunea este scăzută în vene;
d. lichidul extracelular este sechestrat în cavitatea abdominală (ascită);
care este lanțul causal corect:
A. a→b→c→d;
B. a→c→d→b;
- C. b→a→c→d;
D. c→d→b→a;
E. d→b→c→a;
400. F.d.u. evenimentele r.l. edemul hepatic:
a. tendința la hipokalemie;
b. presiunea este scăzută în artere;
c. presiunea tînd să scadă în sistemul vascular;
d. hiperaldosteronism secundar;
e. lichidul extracelular este sechestrat în cavitatea abdominală (ascită);
care este lanțul causal corect:
A. a→c→d→b→e;
B. b→e→a→d→c;
C. c→d→a→b→e;
D. d→e→b→a→c;
E. e→c→b→d→a;
401. R.l. patogenetice RHS și a manifestărilor acestora în hepatopatii cronice, f.d.u. cauze:
1. vasodilatație sistemică;
2. obstrucția sinusoidelor hepatice;
3. activarea SRAA;
și următoarele consecințe:
a. împiedicarea fluxului de sânge venos prin ficat;
b. scade VSCE;
c. retenție de Na în rinichi;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
402. R.l. patogenetice RHS și a manifestărilor acestora în hepatopatii cronice, f.d.u. cauze:
1. scade volumul de sânge care ajunge în patul arterial;
2. scăderea metabolizării hepatice;
3. împiedicarea fluxului de sânge venos prin ficat;
și următoarele consecințe:
a. scade VSCE;
b. acumularea sângelui în sistemul venos port și în viscerele abdominale;
c. acumularea de substanțe vasodilatoare;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
403. R.l. patogenetice RHS și a manifestărilor acestora în hepatopatii cronice, f.d.u. cauze:
1. acumularea sângelui în sistemul venos port;
2. creșterea aldosteronului prin activarea SRAA;
3. fibrozarea ficatului;
și următoarele consecințe:
a. HTP;
b. retenție de Na în rinichi;
c. obstrucția sinusoidelor hepatice;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;
404. R.l. patogenetice RHS și a manifestărilor acestora în hepatopatii cronice, f.d.u. cauze:
1. scade VSCE;
2. acumularea sângelui în amonte de ficat;
3. scăderea metabolizării hepatice;
și următoarele consecințe:
a. scade volumul de sânge care ajunge în patul arterial;
b. activarea SRAA;
c. acumularea aldosteronului;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
405. R.l. manifestările asociate cu edemul hepatic, f.d.u. cauze:
1. scăderea hormonilor steroizi;
2. tromboticoponie, scăderea factorilor de coagulare;
3. hipersecreție de aldosteron și scăderea metabolizării hepatice a aldosteronului;
b. givgoragii;
c. eritroză palmară, buze carminate;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
406. F.d.u. evenimente legate de edemul hepatic:
a. fibrozarea ficatului;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele, c.d.u. = care dînt următoarele, f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, r.l. = referitor/referitoare la, U.I.d.d. = Următoarele fragmente dintr-o fază despre.

- b. sângele se acumulează în amonte de ficat, adică în sistemul venos port și în viscerale abdominale;
c. scade volumul de sânge care ajunge în patul arterial;
d. obstrucție sinusoidală hepatică;
e. împiedicarea fluxului de sânge venos prin ficat;
care este înălțarea logică justă:
A. a → d → e → c → b;
B. b → e → a → c → d;
C. c → d → b → e → a;
D. d → c → b → a → e;
E. e → a → d → b → c;
407. F.d.u. evenimente legate de edemul hepatic:
a. activarea SRAA;
b. scade volumul de sânge care atinge în patul arterial;
c. RHS;
d. retenție de Na⁺ în rinichi;
e. scade VSCE;
care este înălțarea logică justă:
A. a → e → c → b → d;
B. b → e → a → d → c;
C. c → a → d → e → b;
D. d → b → e → a → c;
E. e → d → a → b → c;
408. F.d.u. evenimente legate de edemul hepatic:
a. insuficiență hepatică;
b. RHS;
c. acumularea aldosteronului;
d. retenție de Na⁺ în rinichi;
e. scăderea metabolizării hepatice;
care este înălțarea logică justă:
A. a → e → c → d → b;
B. b → a → c → e → d;
C. c → b → e → a → d;
D. d → b → c → e → a;
E. e → b → a → c → d;
409. F.d.u. evenimente legate de edemul hepatic:
a. vasodilatație sistemică;
b. acumularea substanțelor vasodilatatoare;
c. scăderea metabolizării hepatice;
d. scade VSCE;
e. insuficiență hepatică;
care este înălțarea logică justă:
A. a → c → b → e → d;
B. b → a → d → c → e;
C. c → e → d → b → a;
D. d → a → c → b → e;
E. e → c → b → a → d;
410. F.d.u. afirmații r.l. edemul hepatic:
a. în general, în evoluția unei ciroze hepatice, apariția HTP precede instalarea insuficienței hepatice;
b. de obicei, pacienții care dezvoltă edem hepatic au deja ascită;
c. deficitul funcțional hepatic responsabil pentru hipotalbuminemie apare de obicei în faze mai avansate ale bolii;
d. pacienții cu edem hepatic au de obicei un abdomen proeminent;
e. consecințele HTP (cum este ascita) preced consecințele insuficienței hepatice (cum este edemul hepatic);
care este înălțarea logică justă:
A. a → c → d → b → e;
B. b → e → c → a → d;
C. c → a → e → b → d;
D. d → a → c → e → b;
E. e → d → a → c → b;
411. C.d.u. NU este unul din cele patru sindroame în care pot fi grupate manifestările de hepatopatie cronică:
A. sindromul de HTP;
B. sindromul de retenție hidrosalină;
C. sindromul de citoliză hepatică;
D. sindromul de coleastăz;
E. sindromul de insuficiență hepatică;
412. R.l. manifestările asociate cu edemul hepatic, f.d.u. sindroame:
1. HTP;
2. citoliză hepatică;
3. insuficiență hepatică;
și următoarele manifestări:
a. circulație colaterală de tip porto-cav pe peretele abdominal;
b. transaminaze crescute;
c. scăderea factorilor de coagulare;
care sunt asociile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;
413. R.l. manifestările asociate cu edemul hepatic, f.d.u. sindroame:
1. HTP;
2. insuficiență hepatică – semne ale excesului de estrogeni;
3. insuficiență hepatică;
și următoarele manifestări:
a. hiperbilirubinemie;
b. hiperproteinemie;
c. creșterea γ-globulinelor;
care sunt asociile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;
414. R.l. manifestările asociate cu edemul hepatic, f.d.u. sindroame:
1. HTP;
2. insuficiență hepatică;
3. insuficiență hepatică – faze mai avansate;
și următoarele manifestări:
a. alterarea conștienței;
b. colesterol scăzut;
c. hipofibrinogenemie;
care sunt asociile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;
415. R.l. manifestările asociate cu edemul hepatic, f.d.u. sindroame:
1. HTP;
2. insuficiență hepatică;
3. coleastăz;
și următoarele manifestări:
a. manifestări de encefalopatie hepatică;
b. hiperalbuminemie;
c. icter;
d. excesul de estrogeni și consecințele acestuia;
care sunt asociile corecte:
A. a-1, b-2, c-3, d-2;
B. a-2, b-1, c-3, d-2;
C. a-2, b-3, c-1, d-2;
D. a-2, b-3, c-2, d-1;
E. a-3, b-2, c-1, d-2;
416. R.l. manifestările asociate cu edemul hepatic, f.d.u. sindroame:
1. insuficiență hepatică – semne ale excesului de estrogeni;
2. insuficiență hepatică;
3. coleastăz;
și următoarele manifestări:
a. scăderea transferinei;
b. limbă și buze carminate;
c. gamma-glutamil-transpeptidaza crescută;
care sunt asociile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;
417. R.l. manifestările asociate cu edemul hepatic, f.d.u. sindroame:
a. macrocitolă prim deficit de folat;

Prescurtări frecvent folosite: s.d. = sindrom; s.u.c.g. = sunt următoarele, cu excepția; u.a.s.c.g. = următoarele afirmații sunt corecte, cu excepția; s.c.f.g. = sunt corect formulate, cu excepția.

1. insuficiență hepatică – semne ale excesului de estrogeni;
2. insuficiență hepatică, și coleastăz;
3. următoarele manifestări:
a. fosfataza alcalină crescută;
b. scăderea nivelului plasmatic la α- și β-globulinelor;
c. angioame stelate;
care sunt asociile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
418. R.l. manifestările asociate cu edemul hepatic, f.d.u. sindroame:
1. HTP;
2. coleastăz;
3. insuficiență hepatică;
și următoarele manifestări:
a. scăderea proteinelor sintetizate de ficat;
b. hiperbilirubinemie;
c. creșterea γ-globulinelor;
care sunt asociile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;
419. Glomerulopatii care produc în mod tipic sindrom nefrotic s.u.c.g.:
A. GPM;
B. apar modificări biomorale produse de pierderea anurilor proteice implicate în controlul coagularii;
C. majoritatea glomerulopatiilor producătoare de SdNf provoacă și HTA și/sau hematurie și/sau insuficiență renală (SdNf impur);
D. în mod tipic, GPM determină SdNf pur (mai ales la adulți);
E. în mod tipic, în GPM apare hipovolemie, care tinde să crească TA;
420. F.d.u. evenimente r.l. edemul nefrotic:
a. scăderea p.o. din vas;
b. alterarea BFG;
c. pierderea de proteine prin BFG;
d. transsudarea apei din vas în interstițiu;
e. hipoproteinemie;
care este lanțul cauzal corect:
A. a → b → c → e → d;
B. b → c → e → a → d;
C. c → b → e → a → d;
D. d → b → a → e → c;
E. e → b → d → c → a;
421. R.l. edemul nefrotic, u.a.s.c.g.:
A. este asociat cu glomerulopatii care determină pierdere masivă de proteine;
B. se asociază diversele modificări biomorale produse de pier-

- derea anurilor proteice implicate în diverse procese biologice;
C. pe electrofoza proteinelor plasmatică, se observă scăderea relativă a α₂- și β-globulinelor;
D. glomerulopatia cu cele mai discrete alterări ale barierei de filtrare glomerulară (BFG) este glomerulopatia cu leziuni minime (GPM);
E. în mod tipic, în GPM, fuga apei din vas în interstițiu produce hipovolemie;
422. R.l. edemul nefrotic, u.a.s.c.g.:
A. proteinele se pierd prin BFG alterată;
B. apar modificări biomorale prin pierderea de proteine implicate în metabolismul transportului lipidelor, vitaminelor, hormonilor, oligoelementelor;
C. în mod caracteristic, apare hipalbuminemie (<3,5 g/dl);
D. modificările din GPM sunt vizibile doar prin microscopie electronică;
E. de obicei, GPM determină hematurie;
423. R.l. edemul nefrotic, u.a.s.c.g.:
A. proteinuria masivă determină scăderea p.o. a plasmei;
B. apar modificări biomorale produse de pierderea anurilor proteice implicate în controlul coagularii;
C. majoritatea glomerulopatiilor producătoare de SdNf provoacă și HTA și/sau hematurie și/sau insuficiență renală (SdNf impur);
D. în mod tipic, GPM determină SdNf pur (mai ales la adulți);
E. în mod tipic, în GPM apare hipovolemie, care tinde să crească TA;
424. R.l. edemul nefrotic, u.a.s.c.g.:
A. edemul este dur, cartonat;
B. proteinuria este masivă (>3,5 g pe 24 de ore);
C. depimarea funcției renale duce la scăderea edemului;
D. în SdNf pur nu apar HTA, hematurie sau insuficiență renală;
E. de obicei, în GPM leziunile sunt atât de discrete, încât prin barierea de filtrare scapă proteine, dar nu și hematii;
425. R.l. edemul nefrotic, u.a.s.c.g.:

- A. edemul este mai accentuat dimineața la membrele inferioare, seara la față;
B. proteinuria masivă determină hipotalbuminemie;
C. dacă depimarea funcției renale este suficient de severă apar și manifestări de IR;
D. de obicei, GPM nu determină HTA;
E. de obicei, în GPM nu scapă hematii prin bariera de filtrare întrucât sunt mulți mai mari decât moleculele de albumine;
426. F.d.u. afirmații r.l. manifestări asociate cu edemul nefrotic:
a. hipotalbuminemia stimulează sinteza hepatică de proteine;
b. exces relativ de globuline față de albumină;
c. albumina se pierde renal mai mult decât globulinele;
d. ficatul produce atât albumină cât și α- și β-globuline;
care este lanțul cauzal logic just:
A. a → d → c → b;
B. c → d → b → a;
C. d → b → c → a;
D. d → c → b → a;
E. d → c → b → a;
427. R.l. manifestările asociate edemului nefrotic, f.d.u. cauze:
1. hipoproteinemie;
2. pierderea unor proteine implicate în metabolismul lipoproteinelor;
3. pierderea unor factori anticoagulanți;
și următoarele consecințe:
a. tromboze;
b. dislipidemie (hipercolesterolemie, hipertrigliceridemie);
c. scăderea p.o. a plasmei;
care sunt asociile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
428. R.l. manifestările asociate edemului nefrotic, f.d.u. cauze:
1. scăderea p.o. a plasmei;
2. pierderea transferinei;
3. prin BFG, albumina se pierde mai mult decât globulinele;
și următoarele consecințe:
a. anemie febrilă;
b. edem;
c. aspect în cocoșă al electroforezei proteinelor

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, r.l. = referitor/referitoare la; U.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o fază despre;

plasmatică (prin creșterea relativă a α_2 - și β -globulinelor); care sunt asociate corecte:

- A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;

429. R.I. manifestările asociate edemului nefrotic, f.d.u. cauze:

1. proteinurie masivă;
2. pierdere a globulinelor;
3. fuga apei din vas în interstițiu (în G.P.L.M.);

și următoarele consecințe:

- a. hipovolemie;
b. hipoproteinemie;
c. scăderea nivelului hormonilor tiroidieni;

care sunt asociate corecte:

- A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;

430. R.I. edemul din malnutriția proteică (edemul carențial), u.a.s.c.g.e.:

- A. edemul este alb, moale și puțos;
B. edemul este consecința scăderii p.o. plasmatică prin hipalbuminemie;
C. apare la persoanele care se privează de alimente perioade îndelungate cu scop terapeutic (post);

D. deficitul de vitamine și oligo-elemente (de exemplu zinc) asociază provocă leziuni cutanate;

E. deficitul de vitamină B1 determină hipochinezie miocardică;

431. R.I. edemul din malnutriția proteică (edemul carențial), u.a.s.c.g.e.:

- A. edemul se asociază cu hiposubnutriență, fără proteinurie și fără semne de suferință hepatică sau renală;
B. apare la persoanele dezavantațate material și psihic;
C. la formarea edemului ar putea contribui și hipocalcemia și deficitul caloric (prin perturbarea funcției cardiace);

D. în unele cazuri se poate asocia și deficit de vitamină B1;

E. afectarea cardiacă din berberi este o IC cu debit scăzut din cauza multiplexelor fistule arterio-venozose periferice;

cauza multiplexelor fistule arterio-venozose periferice;

432. R.I. persoanele predispușe la edem carențial, f.d.u. categorii:

1. persoanele dezavantațate material;
2. persoanele dezavantațate psihic;

și următoarele exemple:

- a. prizonieri;
b. bătrâni;
c. anorexici;
d. psihici;

care sunt asociate corecte:

- A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-2, d-1;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;

433. R.I. persoanele predispușe la edem carențial, f.d.u. categorii:
1. persoanele dezavantațate material;
2. persoanele dezavantațate psihic;
- și următoarele exemple:
- a. nevroză;
b. bulimie asociată vărsăturilor provocate repetate;
c. asediți;
d. persoane fără adăpost;
- care sunt asociate corecte:
- A. a-1, b-2, c-1, d-2;
B. a-1, b-2, c-2, d-1;
C. a-2, b-1, c-1, d-2;
D. a-2, b-1, c-2, d-1;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;
434. F.d.u. afirmații r.I. edemul carențial:
- a. scăderea perfuziei sistemice eficiente și VSCE;
b. accentuează formarea edemului;
c. multiple fistule arteriovenozose periferice;
d. în unele cazuri se poate asocia și deficit de vitamină B1;
- e. IC cu debit crescut;
- care este lanțul cauzal corect:
- A. a-2-c-d-e-b;
B. b-e-c-d-a;
C. c-e-a-d-b;
D. d-c-e-a-b;
E. e-b-d-a-c;
435. U.f.d.f.d. edemul carențial s.c.f.g.e.:
- A. Edemul carențial se distribuie gravitațional și, ca urmare, la persoanele imobilizate la pat se dispune pe abdomen;
- C. iar la persoanele care se deplasează se observă;
- D. diminețea mai mult la țigă; E. iar seara mai ales la membrele inferioare;
436. U.f.d.f.d. edemul carențial s.c.f.g.e.:
- A. La rețenția alimentară;
- B. edemul se poate accentua inițial (edem de tratament);
- C. dat fiind aportul de NaCl (și apă) odată cu alimentele și;
- D. eliberarea crescută de insulină;
- E. care scade reabsorbția tubulară de Na⁺;
437. U.f.d.f.d. edemul din boala digestivă cu pierdere de proteine s.c.f.g.e.:
- A. Edemul de hipoproteinemie apare în;
- B. bolile inflamatorii intestinale;
- C. mai ales boala Crohn;
- D. prin pierderea de proteine în;
- E. interstițiu, proteinele exsudând din cauza inflamației;
438. U.f.d.f.d. edemul din boala digestivă cu pierdere de proteine s.c.f.g.e.:
- A. Edemul din bolile inflamatorii intestinale se asociază;
- B. cu alte manifestări caracteristice acestor boli;
- C. constipație;
- D. dureri abdominale;
- E. manifestări sistemice etc.
439. U.f.d.f.d. edemul de permeabilitate s.c.f.g.e.:
- A. Forma tipică este edemul inflamator, dar scurgerea de;
- B. fluid și proteine în interstițiu printr-un perete capilar;
- C. hiperpermeabil este implicată probabil și în patogenia;
- D. edemului asociat cu activarea SRAA și posibilități;
- E. în cea a edemului idiopatic.
440. F.d.u. afirmații r.I. edemul inflamator:
- a. fluidul interstițial este absorbit în vasele limfatice;
- b. exosul de lichid interstițial este absorbit în vasele limfatice;
- c. scade ușor presiunea din capilarele limfatice (față de interstițiu din jur);
- d. crește tensiunea radiației asupra filamenților de ancorare atașate de celulele endoteliale ale capilarelor limfatice;
- e. crește diametrul volumului limfaticelor;
- care este lanțul cauzal corect:
- A. a-2-d-e-b-c;
B. b-e-a-d-c;
C. c-e-a-d-b;
D. d-c-e-a-b;

C. c-2-e-a-d-b;

D. d-1-b-2-c-3-e;

E. e-a-2-d-b-c;

441. F.d.u. afirmații r.I. edemul inflamator:

a. fluidul interstițial expansionează;

b. scade rezistența la fluxul limfatic;

c. fluxul limfatic este facilitat;

d. crește tensiunea radiației asupra filamenților de ancorare atașate de celulele endoteliale ale capilarelor limfatice;

e. crește diametrul volumului limfaticelor;

care este lanțul cauzal corect:

- A. a-2-d-e-b-c;
B. b-c-e-a-d;
C. c-d-e-a-b;
D. d-a-c-b-e;

E. e-a-c-b-d;

442. U.f.d.f.d. edemul inflamator s.c.f.g.e.:

A. Organizarea filamenților de ancorare;

B. cuplul cu joncțiunile supra-pusele intercapitare;

C. dintre celulele endoteliale limfatice adiacente;

D. creează un sistem de valvă unidirecțională;

E. care favorizează fluxul retrograd din capilari limfatici înapoi în spațiul interstițial;

443. U.f.d.f.d. edemul inflamator s.c.f.g.e.:

A. În cazul edemului hidrostatic și oncotic, filamentele;

B. de ancorare atașate de celulele endoteliale ale capilarelor limfatice sunt distuse, ceea ce;

C. favorizează creșterea fluxului limfatic, în măsura în care;

D. acesta nu este stăpânit prin alte mecanisme, de exemplu;

- E. prin scăderea presiunii în vena cavă superioară.
444. U.f.d.f.d. edemul inflamator s.c.f.g.e.:
- A. în edemul inflamator, reacția;
- B. inflamatorie distruge;
- C. filamentele de ancorare atașate de celulele endoteliale;
- D. ale capilarelor limfatice;
- E. motiv pentru care fluxul limfatic crește.
445. R.I. edemul inflamator, u.a.s.c.g.e.:
- A. edemul inflamator este de obicei localizat întrucât apare ca reacție secundară a inflamației;
- B. durerea este generală de acțiunea PGE₂ atât periferică, cât și centrală;
- C. dat fiind prezența proteinelor și a celulelor, edemul este moale;
- D. creșterea permeabilității peretelui capilar poate fi indusă de tratamentul cu Ac monoclonal OKT₃;
- E. unii dintre mediatorii inflamatori atrag leucocitele în țesutul lez;
446. R.I. edemul inflamator, u.a.s.c.g.e.:
- A. degradarea matricei crește presiunea coloid-osmotică efectivă a interstițiului;
- B. acțiunea periferică a PGE₂ asupra neuronilor senzoriali atenuează durerea;
- C. edemul inflamator nu lasă godelu la apăsare;
- D. edemul inflamator se produce în stările inflamatorii caracterizate de pătrunderea leucocitelor în țesuturi;
- E. având acțiune fagocitară, leucocitele eliberează diverse enzime hidrolitice;
447. R.I. edemul inflamator, u.a.s.c.g.e.:
- A. roșeața este consecința scăderii fluxului de sânge în țesutul inflam;
- B. acțiunea centrală a PGE₂ asupra măduvei spinării și a creierului provoacă durere;
- C. edemul se asociază cu semnele clasice de inflamație;
- D. inflamația este o reacție caracteristică la leziunea tisulară;
- E. având acțiune fagocitară, leucocitele eliberează diverse specii reactive de oxigen și de azot;
448. R.I. edemul inflamator, u.a.s.c.g.e.:
- A. anterochilatarea determină edemul inflamator s.c.f.g.e.;
- B. distrugerea filamenților de sânge în țesutul inflam;
- C. diapedeza celulelor inflamatoare se produce de regulă la nivelul arteriolelor;
- D. edemul se asociază cu roșeață, căldură, durere;
- E. inflamația include eliberarea multor mediatori cu diverse acțiuni;
- F. distrugerea de către leucocite a componentelor matricei extracelulare crește complicitatea interstițială;

Prescurtări frecvent folosite: u. = urmărirea; c.d.u. = care dăte urmărirea; f.d. = fiind date; f.d.u. = fiind date urmărirea; r.I. = referitor/referitoare la; U.f.d.f.d. = Urmărirea fragmente dintr-o frază despr.

A. apare în asociere cu o pleurizie purulentă sau cu un abces periteneal;
B. este cald;
C. este dureros;
D. rețeaua venoasă superficială este dilatată;
E. p.o. tisulară este scăzută;
463. R.I. edemul din tromboflebita superficială (TFS), u.a.s.c.g.e.:
A. apare cianoză locală;
B. se pot observa varice (și chiar eczemă varicoasă), care preced însă instalarea TFS;
C. temperatura locală este crescută;
D. frecvent apare la membrul superior;
E. poate să apară în urma celorlalte varice venoase superficiale;
464. R.I. edemul Quincke u.a.s.c.g.e.:
A. este nepruriginos și indolent;
B. poate avea orice localizare cutanată, dar apare mai ales la membrele inferioare;
C. mucoasele și semimucoasele nu sunt afectate;
D. este persistent;
E. o complicație periculoasă este edemul subglotic;
465. R.I. edemul Quincke u.a.s.c.g.e.:
A. este rozat;
B. adeseori are tendința la simetrie;
C. se mai numește edemul catarhal;
D. durează mai multe săptămâni;
E. se asociază cu atopia;
466. R.I. edemul idiosincronic u.a.s.c.g.e.:
A. se produce aproape exclusiv la băbăți;
B. episoadele de edem sunt însoțite adesea de distensie abdominală;
C. variațiile mari ale greutateii sugerează creșterea permeabilității capilare;
D. permeabilitatea capilară excesivă pare să fie ameliorată pe vremea caldă (mai ales vara);
E. în patogeneză ar putea interveni și scăderea activității dopaminergice;
467. R.I. edemul idiosincronic u.a.s.c.g.e.:
A. episoadele de edem apar periodic;
B. este roșu;
C. este moale;
D. lasă godeu;
E. permeabilitatea capilară este crescută;
468. Caracteristici ale edemului inflamator s.u.c.g.e.:
A. este cald;
B. este dureros;
C. tipic, este consecința unei patologii sistemice;
D. lasă ușor godeu;
E. presiune oncotică tisulară scăzută;
469. R.I. edemul parietal asociat inflamațiilor profunde, u.a.s.c.g.e.:
A. este un edem parietal supralacental teritorial profund afectat;
B. este roșu;
C. este moale;
D. lasă godeu;
E. permeabilitatea capilară este crescută;
470. R.I. edemul asociat inflamațiilor profunde, u.a.s.c.g.e.:
A. este cald;
B. este dureros;
C. este consecința unei patologii sistemice;
D. lasă ușor godeu;
E. presiune oncotică tisulară scăzută;
471. F.d.u. afirmații r.l. edemul inflamator:
A. surgerarea proteinelor (și a altor macromolecule) în interstițiu din jur;
B. permeabilizarea sau ruperea barierei endoteliale (se poate produce chiar lezarea endotelului capilar);
C. forțele oncice sunt deplasate din vas în interstițiu;
D. lichidul umează proteinele, trecând în interstițiu;
E. crește lanțul causal corect:
A. a → b → d → c;
B. b → a → c → d;
C. b → d → c → a;
D. c → a → b → d;
E. d → c → a → b;
472. F.d.u. afirmații r.l. edemul inflamator:
A. din vas de sânge ies celule împreună cu plasmă (exsudat);
B. scopul organismului este de a aduce la locul unei agresiuni celule inflamatoare, care provin din sânge;
C. celulele inflamatoare trebuie să traverseze peretele vaselor de sânge;
D. celulele inflamatoare trebuie să treacă din vase în țesuturi;
E. având permeabilitate crescută, peretele capilar poate fi traversat de proteine (care au dimensiuni mult mai mici decât niște celule) și de ser;
F. permeabilitatea peretelui capilar trebuie să crească suficient pentru a permite ieșirea unor celule;
G. care este lanțul causal/ logic just:
A. a → c → f → d → b → e;
B. b → d → c → f → e → a;
C. c → b → d → a → d → e → f;
D. d → a → e → f → b → c;
E. e → a → f → d → b → c;
473. Caracteristici ale edemului inflamator s.u.c.g.e.:
A. este alb;
B. este moale;
C. este localizat;
D. poate să apară în contextul unei afecțiuni generale;
E. permeabilitate capilară crescută;
474. Caracteristici ale edemului inflamator s.u.c.g.e.:
A. este alb;
B. este moale;
C. este localizat;
D. poate să apară în contextul unei afecțiuni generale;
E. permeabilitate capilară crescută;
475. F.d.u. afirmații r.l. edemul inflamator:
A. surgerarea proteinelor (și a altor macromolecule) în interstițiu din jur;
B. permeabilizarea sau ruperea barierei endoteliale (se poate produce chiar lezarea endotelului capilar);
C. forțele oncice sunt deplasate din vas în interstițiu;
D. lichidul umează proteinele, trecând în interstițiu;
E. crește lanțul causal corect:
A. a → b → d → c;
B. b → a → c → d;
C. b → d → c → a;
D. c → a → b → d;
E. d → c → a → b;
476. R.I. cauzele edemului pulmonar necardio-gen, f.d.u. categorii:
1. lezarea directă a peretelui capilarelor pulmonare prin intermediul căilor respiratorii;
2. lezarea indirectă a peretelui capilarelor pulmonare de către mediatori ajunși în plămâni pe cale circulatorie;
și u. stări/situații patologice:
a. aspirație;
b. infarct de fum;
c. administrare intravenoasă de droguri, de exemplu, heroină;
d. pancreatită;
e. stare septică;
care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2, e-2;
B. a-1, b-2, c-2, d-1, e-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-2, e-1;
D. a-2, b-1, c-1, d-2, e-2;
E. a-2, b-1, c-2, d-2, e-1;
477. R.I. cauzele edemului pulmonar necardio-gen, f.d.u. categorii:
1. lezarea directă a peretelui capilarelor pulmonare prin intermediul căilor respiratorii;
2. lezarea indirectă a peretelui capilarelor pulmonare de către mediatori ajunși în plămâni pe cale circulatorie;
3. modificarea acută a presiunilor vasculare pulmonare (unsoari asociată și cu lezarea capilarelor);
și u. stări/situații patologice:
a. derivație cardiopulmonară;
b. pneumonie;
c. descărcări vegetative bruște în edemul pulmonar neurogen și în cel de altitudine;
d. traumatism netoxic;
care sunt asociate corecte:
A. a-2, b-1, c-2, d-3;
B. a-2, b-1, c-3, d-2;
C. a-2, b-2, c-1, d-3;
D. a-2, b-2, c-3, d-1;
E. a-2, b-3, c-1, d-2;
478. R.I. cauzele edemului pulmonar necardio-gen, f.d.u. categorii:
1. lezarea directă a peretelui capilarelor pulmonare prin intermediul căilor respiratorii;
2. lezarea indirectă a peretelui capilarelor pulmonare de către mediatori ajunși în plămâni pe cale circulatorie;
și u. stări/situații patologice:
a. aspirație;
b. infarct de fum;
c. administrare intravenoasă de droguri, de exemplu, heroină;
d. pancreatită;
e. stare septică;
care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2, e-2;
B. a-1, b-2, c-2, d-1, e-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-2, e-1;
D. a-2, b-1, c-1, d-2, e-2;
E. a-2, b-1, c-2, d-2, e-1;
479. R.I. cauzele edemului pulmonar necardio-gen, f.d.u. categorii:
1. lezarea directă a peretelui capilarelor pulmonare prin intermediul căilor respiratorii;
2. lezarea indirectă a peretelui capilarelor pulmonare de către mediatori ajunși în plămâni pe cale circulatorie;
și u. stări/situații patologice:
a. aspirație;
b. infarct de fum;
c. administrare intravenoasă de droguri, de exemplu, heroină;
d. pancreatită;
e. stare septică;
care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2, e-2;
B. a-1, b-2, c-2, d-1, e-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-2, e-1;
D. a-2, b-1, c-1, d-2, e-2;
E. a-2, b-1, c-2, d-2, e-1;
480. R.I. cauzele edemului pulmonar necardio-gen, f.d.u. categorii:
1. lezarea directă a peretelui capilarelor pulmonare prin intermediul căilor respiratorii;
2. lezarea indirectă a peretelui capilarelor pulmonare de către mediatori ajunși în plămâni pe cale circulatorie;
și u. stări/situații patologice:
a. aspirație;
b. infarct de fum;
c. administrare intravenoasă de droguri, de exemplu, heroină;
d. pancreatită;
e. stare septică;
care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2, e-2;
B. a-1, b-2, c-2, d-1, e-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-2, e-1;
D. a-2, b-1, c-1, d-2, e-2;
E. a-2, b-1, c-2, d-2, e-1;
481. R.I. cauzele edemului pulmonar necardio-gen, f.d.u. categorii:
1. lezarea directă a peretelui capilarelor pulmonare prin intermediul căilor respiratorii;
2. lezarea indirectă a peretelui capilarelor pulmonare de către mediatori ajunși în plămâni pe cale circulatorie;
și u. stări/situații patologice:
a. aspirație;
b. infarct de fum;
c. administrare intravenoasă de droguri, de exemplu, heroină;
d. pancreatită;
e. stare septică;
care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2, e-2;
B. a-1, b-2, c-2, d-1, e-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-2, e-1;
D. a-2, b-1, c-1, d-2, e-2;
E. a-2, b-1, c-2, d-2, e-1;
482. R.I. cauzele edemului pulmonar necardio-gen, f.d.u. categorii:
1. lezarea directă a peretelui capilarelor pulmonare prin intermediul căilor respiratorii;
2. lezarea indirectă a peretelui capilarelor pulmonare de către mediatori ajunși în plămâni pe cale circulatorie;
și u. stări/situații patologice:
a. aspirație;
b. infarct de fum;
c. administrare intravenoasă de droguri, de exemplu, heroină;
d. pancreatită;
e. stare septică;
care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2, e-2;
B. a-1, b-2, c-2, d-1, e-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-2, e-1;
D. a-2, b-1, c-1, d-2, e-2;
E. a-2, b-1, c-2, d-2, e-1;
483. R.I. cauzele edemului pulmonar necardio-gen, f.d.u. categorii:
1. lezarea directă a peretelui capilarelor pulmonare prin intermediul căilor respiratorii;
2. lezarea indirectă a peretelui capilarelor pulmonare de către mediatori ajunși în plămâni pe cale circulatorie;
și u. stări/situații patologice:
a. aspirație;
b. infarct de fum;
c. administrare intravenoasă de droguri, de exemplu, heroină;
d. pancreatită;
e. stare septică;
care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2, e-2;
B. a-1, b-2, c-2, d-1, e-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-2, e-1;
D. a-2, b-1, c-1, d-2, e-2;
E. a-2, b-1, c-2, d-2, e-1;
484. R.I. cauzele edemului pulmonar necardio-gen, f.d.u. categorii:
1. lezarea directă a peretelui

Prescurtând frecvent folosiște: *u.* = următoarele; *c.d.u.* = ca dăruite următoare; *f.d.* = fiind date; *f.d.u.* = fiind date următoare; *r.f.* = referitor/referențiale la; *U.f.d.f.d.* = Următoarele fragmente dintr-o frază despre:

Prescurtând frecvent folosiște: *u.* = următoarele; *c.d.u.* = ca dăruite următoare; *f.d.* = fiind date; *f.d.u.* = fiind date următoare; *r.f.* = referitor/referențiale la; *U.f.d.f.d.* = Următoarele fragmente dintr-o frază despre:

- mediații alături în plămâni pe care circulă, în mod normal, cu presiuni normale (uneori asociată și cu lezarea capilarilor);
- și u. stări/situații patologice:
- a. reacții de leucocitizare;
 - b. toxicitatea oxigenului;
 - c. ocluzia bronșelor ale presiunii pleurale asociate cu lezarea trecătoare a capilarilor pulmonari în edemul pulmonar de reexpansune;
 - d. sunt asociate corecte:
- A. a-1, b-3, c-2;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
478. R.I. cauzele edemului pulmonar necardio-gen, f.d.u. categorii:
1. lezarea directă a pereților capilarilor pulmonari drept consecință a unui traumatism toracic nepericardic;
 2. lezarea indirectă a pereților capilarilor pulmonari de către medii alături în plămâni pe cale circulatorie;
 3. modificarea acută a presiunilor vasculare pulmonare (uneori asociată și cu lezarea capilarilor);
- și u. stări/situații patologice:
- a. conținute toracice;
 - b. presiune crescută în arterele pulmonare; embolism pulmonar (poate contribui și leziunea de reflux);
 - c. transfuzii multiple; care sunt asociate corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-1, c-2;
480. R.I. evaluarea pacientului cu edem, u.a.s.c.g.e.:
- A. este foarte utilă evaluarea presiunii venoase centrale (PVC);
- B. urgencea jugularilor indică PVC crescută mai ales dacă dispăre la inspirație;
- C. ascita poate să apară și în IC congestivă veche, severă;
- D. turgescența jugularilor permite diferențierea acestei secundare unei hepatopatii de cea din IC;
- E. pentru a stabili cauza unui edem generalizat, prima întrebare este dacă se asociază sau nu cu lichid pleural;
481. R.I. evaluarea pacientului cu edem, u.a.s.c.g.e.:
- A. creșterea PVC sugerează IC congestivă;
- B. prezența ascitei nu înseamnă neapărat edem de cauză hepatică;
- C. turgescența jugularilor este prezentă în ciroza hepatică și absență în IC congestiv;
- D. primul aspect care trebuie stabilit este dacă edemul este localizat sau generalizat;
- E. de regulă, pacienții cu IC congestivă au proteinurie ușoară sau moderată, ceea ce nu trebuie să ducă la confuzia cu edemul renal;
482. U.I.d.d. estimarea PVC s.c.g.e.:
- A. Pentru estimarea PVC, B. se ridică pacientul la de planul orizontal;
- C. până când, apare distensia jugularilor și se;
- D. măsură distanța pe verticală;
- E. până la nivelul patului.
483. C.d.u. NU este una dintre cauzele mai frecvente cauze de edem generalizat:
- A. afecțiuni renale;
- B. afecțiuni cardiace;
- C. ciroza hepatică;
- D. tromboflebită superficială;
- E. mahnulție proteică;
484. R.I. diagnosticul diferențial al edemului localizat, f.d.u. manifestări:
1. durere, căldură și roșeață locală;
 2. cianoză locală, circulație colaterală venoasă;
 3. edem limitat la un membru inferior sau la unii sau ambele membre superioare;
 4. sindromul de edem; și următoarele variante de edem: a. edem prin obstrucție venoasă; b. edem inflamator;
- c. edem prin obstrucție venoasă limitată;
- care sunt asociate corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-1, c-2;
485. F.d.u. demersuri, constatări și concluzii în evaluarea unui pacient cu edem:
- a. se explorează diverse cauze de edem local;
 - b. pe baza examenului fizic, se orientează diagnosticul etiologic spre inflamație sau obstrucție venoasă ori limitată;
 - c. edemul este localizat;
 - d. se observă tegumentul (culoare, grosime, umiditate, piclozitate), durerea locală, circulația colaterală;
- ce secvență este recomandabilă:
- A. a-1-b-2-c-3;
B. a-2-b-3-c-1;
C. b-1-d-2-c-3;
D. c-1-a-2-b-3;
E. d-1-a-2-b-3;
486. F.d.u. constatări și concluzii în evaluarea unui pacient cu edem generalizat:
- a. edem prin scăderea p.o. intravascular;
 - b. sindrom nefrotic;
 - c. investigații vizând patologia glomerulară specifică;
 - d. proteinurie importantă (>3.5g/24 ore);
 - e. hipoproteinemie importantă (<2.5 g/dl);
- ce secvență este recomandabilă:
- A. a-1-b-2-c-3;
B. a-2-b-3-c-1;
C. b-1-d-2-c-3;
D. d-1-a-2-b-3;
E. a-3-b-1-c-2;
487. F.d.u. demersuri, constatări și concluzii în evaluarea unui pacient cu edem generalizat:
- a. proteinurie mică sau absență;
 - b. hipoproteinemie importantă (<2.5 g/dl);
 - c. edem prin scăderea p.o. intravascular;
 - d. probabilitate ciroză hepatică;
 - e. analize biochimice sugestive pentru hepatopatie;
 - f. confirmare prin elemente de examen fizic și imagistice;
- ce secvență este recomandabilă:
- A. a-1-b-2-c-3;
B. a-2-b-3-c-1;
C. b-1-d-2-c-3;
D. d-1-a-2-b-3;
E. a-3-b-1-c-2;
488. F.d.u. demersuri, constatări și concluzii în evaluarea unui pacient cu edem generalizat:
- a. edem prin scăderea p.o. intravascular;
 - b. proteinurie mică sau absență;
 - c. hipoproteinemie importantă (<2.5 g/dl);

Prescurtări frecvent folosite: U. = urmărirea, C.d.u. = sunt urmărirea, cu excepția, u.a.s.c.g.e. = urmărirea afecțiunilor sunt corecte, cu excepția, s.c.g.e. = sunt corect formulate, cu excepția.

- d. probabilitate mahnulție;
- e. analize biochimice nesugestive pentru hepatopatie;
- f. istoric;
- ce secvență este recomandabilă:
- A. b-1-e-2-a-3-f-4-c-5;
B. c-1-a-2-b-3-e-4-f-5;
C. c-1-b-3-e-2-a-4-f-5;
D. e-1-a-3-c-2-b-4-f-5;
E. e-1-c-2-a-3-b-4-f-5;
489. F.d.u. constatări și concluzii în evaluarea unui pacient cu edem generalizat:
- a. fără hipoproteinemie;
 - b. semne de IC congestivă (hepatomegalie, jugulare turgescențe) prezente;
 - c. IC congestivă;
 - d. secvență este recomandabilă:
- A. a-1-b-2-c-3;
B. a-2-b-3-c-1;
C. b-1-d-2-c-3;
D. d-1-a-2-b-3;
E. c-1-a-2-b-3;
490. F.d.u. demersuri, constatări și concluzii în evaluarea unui pacient cu edem generalizat:
- a. analize de urină (proteinurie, hematurie, cilindri hematociti etc.), coroborate și de analize biochimice caracteristice;
 - b. semne de IC congestivă absente;
 - c. probabilitate ciroză hepatică (mai ales dacă există oligurie importantă sau anurie);
 - d. fără hipoproteinemie;
- ce secvență este recomandabilă:
- A. a-1-b-2-c-3;
B. a-2-b-3-c-1;
C. b-1-d-2-c-3;
D. d-1-a-2-b-3;
E. c-1-a-2-b-3;
491. U.I.d.d. diagnosticul diferențial al edemului pulmonar (EP) s.c.g.e.:
- A. istoricul este esențial în diferențierea EP cardiogen;
- B. de cel necardio-gen intrinsec;
- C. evaluează probabilitatea de boală cardiacă subiacentă;
- D. deși nu permite identificarea stărilor patologice asociate;
- E. cu EP necardio-gen.
492. R.I. utilitatea examenului fizic în diferențierea edemului pulmonar cardiogen de cel necardio-gen, f.d.:
1. edemul pulmonar cardiogen;
 2. edemul pulmonar necardio-gen;
 - și următoarele caracteristici:
 - a. examenul pulmonar poate fi relativ normal în stadiile timpurii;
- b. semne de creștere a presiunii intracardiacă (galop protodiastolic, vene jugulare turgescențe, edem periferic);
- c. raluri crepitante și/sau sibilante/suierătoare la auscultația toracelui;
- d. tablou clinic dominat de semne ale stării patologice declanșatoare;
- care sunt asociate corecte:
- A. a-1, b-2, c-1, d-2;
B. a-1, b-2, c-2, d-1;
C. a-2, b-1, c-1, d-2;
D. a-2, b-1, c-2, d-1;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;
493. R.I. utilitatea radiografiei toracice în diferențierea edemului pulmonar cardiogen de cel necardio-gen, f.d.:
1. edemul pulmonar cardiogen;
 2. edemul pulmonar necardio-gen;
 - și următoarele caracteristici:
 - a. frecvent, revărsatele lichidiene pleurale;
 - b. infiltratele alveolare distribuite relativ uniform pe întreaga arie pulmonară;
 - c. mărirea silurii cardiace;
 - d. îngroșarea desenului interstițial;
 - e. fără cardiomegalie;
- care sunt asociate corecte:
- A. a-1, b-1, c-2, d-1, e-2;
B. a-1, b-1, c-2, d-2, e-1;
C. a-1, b-2, c-1, d-1, e-2;
D. a-1, b-2, c-1, d-2, e-1;
E. a-1, b-2, c-2, d-1, e-1;
494. R.I. utilitatea radiografiei toracice în diferențierea edemului pulmonar cardiogen de cel necardio-gen, f.d.:
1. edemul pulmonar cardiogen;
 2. edemul pulmonar necardio-gen;
 - și următoarele caracteristici:
 - a. infiltrate alveolare perihilare;
 - b. dimensiunea inimii este normală;
 - c. redistribuirea desenului vascular spre campurile superioare;
 - d. doar rareori revărsate lichidiene pleurale;
- care sunt asociate corecte:
- A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-2, b-1, c-1, d-2;
D. a-2, b-1, c-2, d-1;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;
495. R.I. diferențierea edemului pulmonar cardiogen de cel necardio-gen pe baza răspunsului:
1. cardiac;
 2. mai ales hepatic, dar și renal, hepatic;
 3. renal, hepatic;
 - și următoarele trăsături:
 - a. 1. cardiac;
 2. mai ales hepatic, dar și renal, hepatic;
 3. renal, hepatic;
- care sunt asociate corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-1, c-2;
496. R.I. diferențierea celor trei cauze principale de edem generalizat, f.d.:
1. cardiac;
 2. hepatic;
 3. renal;
 - și următoarele trăsături:
 - a. gust alateral (metalic sau de pazele);
 - b. dispnee la efort;
 - c. hipotensiune;
- care sunt asociate corecte:
- A. a-1, b-3, c-2;
B. a-1, b-2, c-1;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-1, c-2;
497. R.I. diferențierea celor trei cauze principale de edem generalizat, f.d.:
1. cardiac;
 2. mai ales hepatic, dar și renal, hepatic;
 3. renal, hepatic;
 - și următoarele trăsături:
 - a. 1. cardiac;
 2. mai ales hepatic, dar și renal, hepatic;
 3. renal, hepatic;
- care sunt asociate corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-1, c-2;

Prescurtări frecvent folosite: U. = urmărirea, C.d.u. = sunt urmărirea, f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date urmărirea, f.l. = referitor/referitoare la; U.I.d.d. = Urmărirea fragmente dintr-o frază despre.

2. hepatic;
3. renal, hepatic;
și următoarele trăsături:
a. concentrare difuză;
b. disnee paroxistică nocturnă;
c. eritem palmar;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
499. R.I. diferențierea celor trei cauze principale de edem generalizat, f.d.:
1. cardiac;
2. hepatic;
3. renal;
și următoarele trăsături:
a. presiune venoasă jugulară crescută;
b. contractură Dupuytren;
c. piciorare agitate sau mioclonii;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
500. R.I. diferențierea celor trei cauze principale de edem generalizat, f.d.:
1. cardiac;
2. hepatic;
3. renal;
și următoarele trăsături:
a. disnee poate fi prezentă, dar în general mai puțin importantă decât în tipul asociat cel mai adesea cu disnee;
b. galop protodiastolic;
c. angioame stelate;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-3, c-2;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
501. R.I. diferențierea celor trei cauze principale de edem generalizat, f.d.:
1. cardiac;
2. hepatic;
3. renal;
și următoarele trăsături:
a. creșterea tensiunii arteriale are același mecanism ca și edemul;
b. ginecomastie la bărbați;
c. uneori șoc apăsător deplasat sau dischinetic;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
- B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
502. R.I. diferențierea celor trei cauze principale de edem generalizat, f.d.:
1. cardiac;
2. hepatic;
3. renal;
și următoarele trăsături:
a. mai ales renal, dar și cardiac; și următoarele trăsături:
b. astenxis;
c. cianoză periferică;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-3, c-2;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
503. R.I. diferențierea celor trei cauze principale de edem generalizat, f.d.:
1. cardiac;
2. hepatic;
3. renal;
și următoarele trăsături:
a. extremități reci;
b. retinopatie diabetică;
c. hipalbuminemie fără proteinurie;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-3, c-2;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
504. R.I. diferențierea celor trei cauze principale de edem generalizat, f.d.:
1. cardiac, renal;
2. hepatic, renal;
3. renal;
și următoarele trăsături:
a. factor uremic;
b. hiperuricemie;
c. semne de encefalopatie;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-3, c-2;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
505. R.I. diferențierea celor trei cauze principale de edem generalizat, f.d.:
1. cardiac;
2. hepatic;
3. renal;
și următoarele trăsături:
a. creșterea tensiunii arteriale are același mecanism ca și edemul;
b. ginecomastie la bărbați;
c. uneori șoc apăsător deplasat sau dischinetic;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
- B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
506. R.I. diferențierea celor trei cauze principale de edem generalizat, f.d.:
1. cardiac;
2. hepatic;
3. renal;
și următoarele trăsături:
a. tensiunea arterială în general mai scăzută decât în celelalte două tipuri;
b. retenție azotată prin scăderea VSCe;
c. acidoză metabolică;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
507. R.I. diferențierea celor trei cauze principale de edem generalizat, f.d.:
1. hepatic;
2. renal;
3. cardiac, hepatic;
și următoarele trăsături:
a. hiponatremie;
b. hipocalcemie prin proteinurie;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-3, c-2;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
508. R.I. diferențierea celor trei cauze principale de edem generalizat, f.d.:
1. hepatic;
2. renal;
3. cardiac, hepatic;
și următoarele trăsături:
a. edemul afectează rareori fața pacientului;
b. retenție azotată prin scăderea VSCe;
c. acidoză metabolică;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-3, c-2;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
509. R.I. diferențierea celor trei cauze principale de edem generalizat, f.d.:
1. cardiac;
2. hepatic;
3. renal;
și următoarele trăsături:
a. unelor enzime hepatice crescute prin congestie hepatică;
b. disnee prin ascită masivă;
c. unelor retenție azotată prin leziune renală infimă;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
510. R.I. diferențierea celor trei cauze principale de edem generalizat, f.d.:
1. hepatic;
2. renal;
3. hepatic, dar și cardiac; și următoarele trăsături:
a. hiperfosfatemie;
b. tendința la hipocalcemie;
c. alcaloză respiratorie;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
511. R.I. diferențierea celor trei cauze principale de edem generalizat, f.d.:
1. cardiac;
2. renal;
3. cardiac, hepatic;
și următoarele trăsături:
a. edemul afectează rareori fața pacientului;
b. retenție azotată prin scăderea VSCe;
c. acidoză metabolică;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-3, c-2;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
512. R.I. diferențierea principalilor cauze de edem generalizat, f.d.:
1. renal;
2. hepatic;
și următoarele trăsături:

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, f.l. = referitor/referitoare la; U.f.d.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază despre;

- D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;
509. R.I. diferențierea celor trei cauze principale de edem generalizat, f.d.:
1. cardiac;
2. hepatic;
3. renal;
și următoarele trăsături:
a. unelor enzime hepatice crescute prin congestie hepatică;
b. disnee prin ascită masivă;
c. unelor retenție azotată prin leziune renală infimă;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
510. R.I. diferențierea celor trei cauze principale de edem generalizat, f.d.:
1. hepatic;
2. renal;
3. hepatic, dar și cardiac; și următoarele trăsături:
a. hiperfosfatemie;
b. tendința la hipocalcemie;
c. alcaloză respiratorie;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
511. R.I. diferențierea celor trei cauze principale de edem generalizat, f.d.:
1. cardiac;
2. renal;
3. cardiac, hepatic;
și următoarele trăsături:
a. edemul afectează rareori fața pacientului;
b. retenție azotată prin scăderea VSCe;
c. acidoză metabolică;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-3, c-2;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
512. R.I. diferențierea principalilor cauze de edem generalizat, f.d.:
1. renal;
2. hepatic;
și următoarele trăsături:
- a. poate predomina edemul periorbital;
b. hiperkalemie;
c. macrocitoză prin deficit de folat;
d. cel mai adesea istoric de consum excesiv de alcool;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-1, d-2;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;
513. R.I. diferențierea celor trei cauze principale de edem generalizat, f.d.:
1. hepatic;
2. renal;
și următoarele trăsături:
a. presiune venoasă jugulară normală sau scăzută;
b. adesea asociat cu ascită;
c. hipocalcemie;
d. semne și simptome uremice;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-2, d-1;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;
514. C.d.u. medicamente nu poate fi incriminat în producerea edemului:
A. hidroclorotiazidă;
B. corticoidi;
C. estrogeni;
D. nifedipină;
E. diclofenac;
515. R.I. mixedem u.a.s.c.g.g.:
A. se produce infiltrare cu mucopolizaharide;
B. edemele sunt false întrucât ceea ce se acumulează primer nu este apă;
C. în hipotiroidia avansată edemul lasă godeuri;
D. tegumentele apar subțilate;
E. edemele sunt moi;
516. R.I. edemul neurotrofic u.a.s.c.g.g.:
A. afectează un membru paralizat;
B. se dispune gravitațional;
C. este accentuat de poziția declivă;
D. ischemia periferică intervine în patogeneza;
E. sunt abolite influențele simpato-adrenergice asupra arteriolelor;
517. R.I. reglarea temperaturii corporale, u.a.s.c.g.g.:
A. temperatura corporală este controlată de hipotalamus;
B. centrul termoreglator este situat în hipotalamusul anterior preoptic și posterior;
C. neuronii hipotalamici termoreglatori primesc semnale de la receptori termici din piele și din mucoase;
D. semnalele de la termoreceptorii din piele sunt transmise prin nervii periferici;
E. pentru a menține temperatura normală, centrul termoreglator al hipotalamusului integrează cele două tipuri de semnale pe care le primește;
518. U.f.d.f.d. reglarea temperaturii corporale s.c.f.g.g.:
A. în mod normal, temperatura corpului este menținută în ciuda variațiilor ambientale;
B. întrucât centrul hipotalamic termoreglator echilibrează;
C. producția excesivă de căldură;
D. (prin activitatea metabolică musculară și hepatică);
E. cu disiparea de căldură prin piele și mișcături.
519. R.I. valorile normale și patologice ale temperaturii orale (t.o.) la persoanele sănătoase de 18-40 de ani, u.a.s.c.g.g.:
A. t.o. medie este $36,8^{\circ} \pm 0,4^{\circ}\text{C}$;
B. t.o. este mai joasă dimineața (6.00);
C. t.o. este mai înaltă după-amiază (16.00-18.00);
D. t.o. maximă normală este $37,2^{\circ}\text{C}$ la ora 6.00 și $37,7^{\circ}\text{C}$ la ora 16.00;
E. t.o. maximă normală este $38,2^{\circ}\text{C}$ la ora 16.00;
520. R.I. variația circadiană a temperaturii, u.a.s.c.g.g.:
A. în mod normal, este de $1,5^{\circ}\text{C}$;
B. la unele persoane în convalescența unei boli febrile, poate atinge până la $1,0^{\circ}\text{C}$;
C. în timpul unei boli febrile, se menține de obicei, dar la niveluri mai înalte, febrile;
D. nivelul ei pare să fie stabilit în copilăria timpurie;
E. poate fi de mai multe grade în anumite tipuri de febră;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, f.l. = referitor/referitoare la; U.f.d.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază despre;

521. R.I. temperatura corporală normală și patologică, u.a.s.c.g.e.;
A. într-o ambianță neutră termică, metabolismul produce mai puțină căldură decât este necesară pentru a menține temperatura centrului între 36,5-37,5°C;
B. persoanele vârstnice pot avea o capacitate redusă de a dezvolta febră;
C. la femeile care au menstruație, temperatura matinală este în general mai mare în cele două săptămâni dinainte de ovulație;
D. după ovulație, temperatura se menține la nivelul crescut până la următoarea ovulație;
E. temperatura corporală este influențată și de sarcină;
522. R.I. temperatura corporală normală și patologică, u.a.s.c.g.e.;
A. febra este definită drept i.o. >37,2°C dimineața și >37,7°C seara;
B. persoanele vârstnice pot face doar o febră modestă chiar și în infecție severă;
C. la ovulație, temperatura scade cu -0,6°C;
D. temperatura corporală scade în perioada postpartorială;
E. temperatura corporală este influențată de disfuncție endocrinologică;
523. F.d.u. evenimente legate de febră:
a. vasoconstricție periferică;
b. deversarea sângelui din periferie către organele interne;
c. activarea neuronilor din centrul vasomotor;
d. scădere pierderea de căldură prin piele, iar individului i se face frig;
e. ridicarea nivelului de referință hipotalamic;
care este lanțul temporal corect:
A. a→c→d→b→e;
B. b→e→d→c→a;
C. c→e→a→d→b;
D. d→b→e→a→c;
E. e→c→a→b→d;
524. F.d.u. evenimente legate de febră:
a. scăderea pierderii de căldură prin piele;
b. individul începe să tremure de frig (frison);
c. vasoconstricție periferică (resfriță inițială la mâini și picioare);
d. crește producția de căldură în mușchi;
e. individul are senzație de frig;
care este lanțul temporal corect:
A. a→d→c→e→b;
B. b→e→c→a→d;
C. c→a→e→d→b;
D. d→e→a→c→b;
E. e→a→c→d→b;
525. F.d.u. mecanisme de creștere a temperaturii centrale implicate în producerea febrei:
1. scăderea pierderii de căldură prin piele;
2. creșterea producției de căldură în mușchi;
3. creșterea producției de căldură metabolică;
4. reducerea pierderii de căldură prin gesturi adaptative;
și următoarele procese/altitudini:
a. vasoconstricție;
b. tremurături;
c. individul se îmbracă mai gros, se acoperă cu o pătură, se ghemește;
d. termogeneza hepatică;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-4, d-3;
B. a-2, b-1, c-3, d-4;
C. a-2, b-3, c-1, d-4;
D. a-2, b-4, c-1, d-3;
E. a-4, b-1, c-2, d-3;
526. R.I. febră și frison, u.a.s.c.g.e.;
A. febra reprezintă creșterea temperaturii corpului peste nivelul de referință hipotalamic;
B. creșterea temperaturii corporale din febră depășește variația zilnică normală;
C. în majoritatea cazurilor de febră, nivelul de referință hipotalamic este urcat cu 1-2°C;
D. creșterea temperaturii se realizează prin procese fiziologice care conservă sau produc căldură;
E. frisonul nu este obligatoriu dacă mecanismele de păstrare a căldurii ridică temperatura sângelui suficient;
527. U.f.d.f.d. febra s.c.f.g.e.;
A. Procesele fiziologice prin care căldura este conservată (vasodilație);
B. sau produsă (termogeneza musculară, hepatică etc.);
C. continuă până când:
D. temperatura sângelui care țîgă neuronii hipotalamici;
E. corespunde noului nivel de referință la termostatu;
528. U.f.d.f.d. febra s.c.f.g.e.;
A. După atingerea echilibrului, febră; termic la noul punct de referință (crescut);
B. hipotalamusul menține temperatura la nivel febril;
E. în starea normală (febrilă);
529. R.I. menținerea echilibrului termic, f.d.u. categorii de procese:
1. reducerea pierderii de căldură;
2. reducerea pierderii de căldură prin gesturi adaptative;
3. dispararea căldurii;
și următoarele procese/altitudini:
a. îmbrăcare, acoperire;
b. vasoconstricție;
c. transpirație;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
530. R.I. menținerea echilibrului termic, f.d.u. categorii de procese:
1. creșterea producției de căldură;
2. reducerea pierderii de căldură prin gesturi adaptative;
3. dispararea căldurii prin gesturi adaptative;
și următoarele procese/altitudini:
a. tremurături;
b. ghemește;
c. dezvelire;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-1, c-2;
531. R.I. menținerea echilibrului termic, f.d.u. categorii de procese:
1. creșterea producției de căldură;
2. dispararea căldurii;
3. dispararea căldurii prin gesturi adaptative;
și următoarele procese/altitudini:
a. vasodilație;
b. dezbrăcare;
c. procese metabolice hepatice;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-1, c-2;

Prescurtări frecvent folosite: c.g. = sunt următoarele, cu excepția, u.a.s.c.g.e. = următoarele afirmatii sunt corecte, cu excepția, s.c.f.g.e. = sunt corect formulate, cu excepția.

532. F.d.u. evenimente asociate cu remiterea febrei:
a. temperatura sângelui de la nivelul hipotalamusului coboară până la noul nivel de referință;
b. dispararea căldurii prin procese fiziologice și gesturi adaptative;
c. scăderea concentrației de pirogeni sau administrare de antipiretice;
d. nivelul de referință hipotalamic revine (coboară) la nivelul normal;
care este înălțuirea temporală/cauzală corectă:
A. a→d→b→c;
B. b→a→d→c;
C. c→a→b→d;
D. c→d→b→a;
E. d→a→c→b;
533. R.I. valorile anormale crescute ale temperaturii, u.a.s.c.g.e.;
A. de obicei, febra infecțioasă nu depășește „platoul termic” natural de 41,1°C;
B. o febră >41,5°C se numește hiperpirexie;
C. hiperpirexia apare cel mai adesea la pacienți cu infecții severe;
D. febra hipotalamică poate avea un substrat organic sau funcțional;
E. cei mai mulți pacienți cu leziuni hipotalamice au temperaturi corporale subnormale, nu supranormale;
534. R.I. valorile anormale crescute ale temperaturii, u.a.s.c.g.e.;
A. menținerea febrei sub „platoul termic” natural ar putea fi mediată prin neuropeptide care funcționează drept antipiretice centrale;
B. hiperpirexia poate să apară la pacienți cu infecții severe;
C. rareori, nivelul de referință hipotalamic crește în urma unei tulburări hipotalamice;
D. urcarea nivelului termostaticului hipotalamic printr-o atecune hipotalamică se numește hipertermie malignă;
E. leziunile hipotalamice care pot provoca febră hipotalamică sunt traumatisme, hemoragii, tumori;
535. U.f.d.f.d. hipertermia s.c.f.g.e.;
A. Exponerea la căldură și producția endogenă de căldură;
B. uneori combinate (de exemplu, efortul într-o ambianță foarte caldă);
C. pot produce căldură mai lent;
D. decât aceasta poate fi disipată;
E. prin mecanismele fiziologice;
536. R.I. hipertermie și la diferențierea acesteia de febră, u.a.s.c.g.e.;
A. hipertermia reprezintă creșterea necontrolată a temperaturii corpului, depășind capacitatea organismului de a pierde căldură;
B. diferențierea febrei de hipertermie este esențială deoarece hipertermia poate provoca rapid moartea deși răspunde la antipiretice;
C. expunerea la căldură precum și creșterea de temperatură este sugestivă pentru diagnosticul de hipertermie;
D. în șocul termic, pielea este caldă dar uscată;
E. antipireticele (aspirină, acetaminofen) nu scad temperatura în hipertermie;
537. R.I. hipertermie și la diferențierea acesteia de febră, u.a.s.c.g.e.;
A. în hipertermie, nivelul de referință al centrului termoreglator hipotalamic este mult ridicat;
B. diferențierea febrei de hipertermie este dificilă în situații de urgență;
C. creșterea temperaturii după administrarea de medicamente care interferează cu termoreglarea este sugestivă pentru diagnosticul de hipertermie;
D. la pacienți care iau medicamente care blochează transpirația, pielea este caldă dar uscată;
E. antipireticele scad temperatura în febră dacă sunt administrate în doze suficiente de mari;
538. R.I. hipertermie și la diferențierea acesteia de febră, u.a.s.c.g.e.;
A. în producerea hipertermiei sunt implicați pirogeni;
B. într-o stare septică sistemică, febra (hiperpirexia) se poate instala rapid, ajungând la temperaturi care depășesc 40,5°C;
C. diagnosticul de hipertermie se pune adesea pe baza evenimentelor imediei de dinaintea creșterii de temperatură;
D. în febră pielea poate fi rece ca urmare a vasoconstricției;
E. în doze suficiente de mari, antipireticele scad temperatura (marcar parțial) chiar și în hiperpirexie;
539. U.f.d.f.d. șocul termic s.c.f.g.e.;
A. într-o ambianță uscată, se pot disipa maxim 600 kcal/h prin;
B. sudorare, necesitând producția a >1 L de transpirație;
C. procese facilitat într-un mediu cu umiditate crescută;
D. ca urmare efortul într-un mediu cu temperatură și umiditate crescute;
E. favorizează șocul termic;
540. C.d.u. NU face parte dintre categoriile de persoane cele mai expuse la șoc termic:
A. vârstnice;
B. imobilizate la pat;
C. care sunt îmbrăcate gros;
D. care iau medicamente anti-coliergice, antiparkinsoniene sau diuretice;
E. care stau în încăperi prost ventilate, fără aer condiționat;
541. F.d.u. cauze ale hipertermiei:
1. șoc termic;
2. hipertermia indusă de medicamente/ droguri;
3. sindromul serotoninergic;
și următoarele trăsături:
a. se deosebește de sindromul malign neuroleptic prin manifestări precum diareea, tremurături și mioclonii;
b. apare cel mai adesea după medicamente psihotrope sau droguri;
c. se produce într-un mediu cald; care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
542. F.d.u. cauze ale hipertermiei:
1. șoc termic;
2. sindromul neuroleptic malign;
3. hipertermia malignă;
și următoarele trăsături:
a. apare la persoanele care au o anumită anomalie moștenită, rară, a rețiculiului sarcoplasmic din mușchii scheletici;
b. este provocată de medicamente neuroleptice;
c. este favorizată de efortul într-un mediu cu temperatură și umiditate crescute;
care sunt asocierile corecte:

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = cauze dintre următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, f.l. = referențiale/intermedie la, U.f.d.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază desu.

- A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-2, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
546. F.d.u. cauze ale hipertermiei:
1. șoc termic;
2. sindromul serotoninergic;
3. hipertermia malignă;
și următoarele trăsături:
a. se poate produce chiar și la persoane sănătoase dacă transpirația este blocată;
b. provocată de inhibitorii selectivi ai receptării serotoninice, IMAO și de alte medicamente serotoninergice (precum antidepresive tricolore);
c. creșterea metabolismului muscular, cu acidoză și instabilitate cardiovasculară; care sunt asociile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-2;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;
547. F.d.u. cauze ale hipertermiei:
1. șoc termic;
2. sindromul serotoninergic;
3. hipertermia malignă;
și următoarele trăsături:
a. se asemănă prin multe trăsături (inclusiv hipertermia) cu sindromul malign serotoninergic; b. acidoză și/sau instabilitate cardiovasculară duc adesea la deces;
c. blocarea transpirației prin deshidratare sau prin medicamente cu efect (advers) anticolinergic (de exemplu, antihistaminice); care sunt asociile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-2;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;
548. F.d.u. tulburări de temperatură induse de medicamente/droguri:
1. șoc termic;
2. hipertermia indusă de medicamente/droguri;
3. sindromul serotoninergic; și următoarele (categoriile de) medicamente/droguri:
a. droguri: fenclolidină, dietilamida acidului liseric (LSD), metilenedioximetamfetamină („ecstasy”), cocaină; care sunt asociile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-2;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;
549. F.d.u. tulburări de temperatură induse de medicamente/droguri:
1. sindromul serotoninergic;
2. hipertermia indusă de medicamente/droguri;
3. sindromul serotoninergic; și următoarele (categoriile de) medicamente/droguri:
a. inhibitori de monoamin-oxidază (IMAO), antidepresive tricolore și amfetamine;
b. medicamente neuroleptice (fenoflazine, butirofenone (haloperidol, bromperidol), proclorperazină, fluoxetină, loxapină, dibenzodiazepine tricolore, prokinetice dopaminergice (metoclopramid, domperidon), tofenen, molidonol);
c. inhibitori selectivi ai receptării serotoninice, IMAO și alte medicamente serotoninergice (precum antidepresive tricolore); care sunt asociile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-2;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;
550. R.I. cauzele hipertermiei, f.d.u. categorii:
1. endocrinopatii care cresc termogeneza;
2. leziuni ale SNC; și următoarele stări patologice:
a. hemoragie cerebrală;
b. leziune hipotalamică;
c. feocromocitom;
d. stare epileptică;
e. tireotoxicoză; care sunt asociile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2, e-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2, e-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-2, e-1;
551. F.d.u. evenimente implicate în patogeniza febrei:
a. pirogenii ajung în circulația sistemică;
b. eliberarea de adenozin-5'-monofosfat ciclic (AMPc);
c. activarea receptorului EP-3 pentru PGE₂ de pe celulele gliale;
d. pirogenii interacționează cu receptori de pe endoteliul capilarelor care înconjoară centrul de reglare hipotalamic;
e. eliberarea de prostaglandină E₂ (PGE₂) de pe versantul cerebral al endoteliului hipotalamic;
care, este înălțarea temporală/cauzală corectă:
A. a-d-e-b-c-a-b;
B. b-e-d-c-a-a;
C. c-b-e-a-d;
D. d-e-a-c-b;
E. e-b-d-a-c;
552. F.d.u. evenimente implicate în patogeniza febrei:
a. AMPc activează terminațiile neuronale din centrul termoreglator;
b. febră;
c. eliberarea de adenozin-5'-monofosfat ciclic (AMPc);
d. conservarea căldurii și producția de căldură;
e. ridicarea nivelului de referință pentru termostatul hipotalamic; care este înălțarea temporală/cauzală corectă:
A. a-b-c-d-e;
B. b-e-c-a-d;
C. c-a-e-b-d-b;
D. d-e-a-c-d-b;
E. e-a-b-c-d-b;
553. R.I. factori implicați în patogeniza febrei, u.a.s.c.g.e.:
A. pirogenii (exogeni și endogeni) nu trec din sânge în creier;
B. la producerea febrei participă rețele de capilare dilatate care fac parte din organul vascular al lamei terminale;
C. în timpul febrei, nivelurile PGE₂ sunt scăzute în hipotalamus și în ventriculul trei;
D. absența genelor celulației trei receptori pentru PGE₂ (decât EP-3) nu alterează mecanismul febrei;
554. R.I. factori implicați în patogeniza febrei, u.a.s.c.g.e.:
A. pirogenii interacționează cu receptori de pe endoteliul capilarelor care înconjoară centrul de reglare hipotalamic;
B. receptori de tip Toll sunt identici cu receptori pe care acționează citokinele;
C. organul vascular al lamei terminale este implicat în producerea febrei, dar și în reglarea osmolarității sângelui;
D. PGE₂ atinge concentrațiile maxime în proximitatea capilarelor care înconjoară centrul termoreglator hipotalamic;
E. dacă gena pentru receptorul EP-3 lipsește, pirogenii declanșează febră necontrolată;
F. AMPc ridică direct sau indirect nivelul de referință pentru termostatul hipotalamic;
555. R.I. factori implicați în patogeniza febrei, u.a.s.c.g.e.:
A. pirogenii exogeni (produsii microbieni) acționează pe receptori de tip Toll;
B. distrugerea organelor vasculare circumventriculare determină creșteri incontolabile ale febrei;
C. dintre cei patru receptori pentru PGE₂, EP-3 este implicat în producerea febrei;
D. AMPc are rol de neurotransmițător;
E. AMPc poate acționa și indirect, determinând eliberarea altor neurotransmițători;
556. R.I. patogeniza febrei, u.a.s.c.g.e.:
A. pirogenii sunt substanțe care produc febră;
B. endotoxina inhibă eliberarea de proteine de fază acută;
C. toxinele streptococilor din grupurile A și B sunt numite și superantigene;
D. factorul de necroză tumorală (FNT) și interferonul (IFN) α sunt citokine pirogene;
E. producția de citokine în SNC este stimulată de diverse evenimente generatoare de inflamație;
557. R.I. patogeniza febrei, u.a.s.c.g.e.:
A. citokinele sunt proteine gigante care reglează procesele imune, inflamatoare și hematopoietice;
B. monocitele/ macrofagele și celulele endoteliale sunt doar

- A. pirogenii exogeni sunt produși bacterieni, toxine bacteriene sau microorganisme întregi;
B. endotoxina provoacă leucotoză;
C. superantigenele sunt toxine bacteriene care inhibă activarea celulelor T;
D. leucotoza cu neutrofilie din infecții este produsă de IL-1 și IL-6;
E. printre citokinele produse în SNC se află IL-1, FNT, IL-6;
558. R.I. patogeniza febrei, u.a.s.c.g.e.:
A. toate bacteriile gram-negative produc endotoxină (lipopolizaharidă);
B. endotoxina provoacă stare generală alterată;
C. Staphylococcus aureus produce toxina responsabilă de sindromul de șoc toxic;
D. citokinele pirogene ajunse în circulația sistemică inhibă sinteza de PGE₂ în țesuturile periferice;
E. infecțiile virale ale SNC pot induce producția de citokine în SNC;
559. R.I. patogeniza febrei, u.a.s.c.g.e.:
A. endotoxina este foarte pirogenă;
B. și bacteriile gram-pozitive produc pirogeni;
C. pirogenii endogeni sunt citokinele pirogene;
D. mioglobina și antralgicele care adesea însoțesc febra sunt provocate de miozita și artrita infecțioasă;
E. hemoragiile cerebrale pot induce producția de citokine în SNC;
560. R.I. patogeniza febrei, u.a.s.c.g.e.:
A. endotoxina provoacă febră;
B. febra poate fi provocată de enterotoxine din Staphylococcus aureus;
C. IL-1 și IL-6 sunt citokine pirogene;
D. traumatismele cerebrale suprimă producția de citokine în SNC;
E. celulele din SNC care produc citokine sunt microglioze și posibili neuroni;
561. R.I. citokine, u.a.s.c.g.e.:
A. citokinele sunt proteine gigante care reglează procesele imune, inflamatoare și hematopoietice;
B. monocitele/ macrofagele și celulele endoteliale sunt doar

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele; r.i. = referitor/referitoare la; U.I.d.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază despre;

- doiă dintre multe tipuri de
celule care produc citokine;
C. sinteza și eliberarea citokinelor
(generatoare de febră) poate fi
stimulată de procese infecțioase
sau neinfecțioase;
D. virusurile și protozoii bacterieni
și fungii sunt factori infecțioși
care stimulează sinteza și eli-
berarea de citokine;
E. diverse procese neinfecțioase
cresc eliberarea de IL-1, FN1, IL-6;
562. C.d.u. NU face parte dintre
procesele neinfecțioase care
cresc producția de citokine:
A. procese inflamatoare (care
eliberează mediatori ai infla-
mației);
B. viruze;
C. traumatisme;
D. necroză tisulară;
E. reacții imune (complexe
antigen-anticorpi ș.a.);
563. U.f.d.f.d. patogeneza febrei
s.c.f.g.e.;
A. O parte din PGE₂ produsă în
peritone (sub);
B. acțiunea citokinelor proin-
geneză ajunse în circulația sistemică;
C. eludează probabil mecanis-
mele de distrugere din plasmă;
D. și ajunge în hipotalamus prin
carotida internă;
E. fiind principalul contributor la
producerea febrei;
564. U.f.d.f.d. patogeneza febrei
s.c.f.g.e.;
A. Citokine produse în SNC;
B. pot ridica nivelul de referință
hipotalamic;
C. doar prin intermediul organelor
circumventuale;
D. explicând hiperplexia;
E. din hemoragiile traumatismele
sau infecțiile SNC;
565. U.f.d.f.d. patogeneza febrei
s.c.f.g.e.;
A. Concentrarea citokinelor
necesită pentru a provoca;
B. febră este cu câteva ordine de
mărimi mai mică;
C. dacă citokinele sunt injectate
direct în creier;
D. sau subcutanat;
E. decât dacă sunt injectate în
circulația sistemică;
566. Categori de pacienți predis-
puși la atenuitate deși au o
infecție s.u.g.e.;
A. non-răscălit;
B. vârstnici;
C. pacienți cu insuficiență renală
hepatică cronică;
D. pacienți cu insuficiență renală
cronică;
E. pacienți care iau neuroleptice;
567. R.I. evaluarea pacientului cu
febră sau hipertermie, u.a.s.c.g.e.;
A. în cadrul istoricului trebuie
stabilită cronologia evenimentele-
lor care au precedat febră;
B. monitorizarea febrei trebuie
făcută folosind de fiecare dată
aceiași modalitate de măsurare
a temperaturii;
C. determinarea citokinelor circ-
lante la pacienți cu febră are o
mare utilitate;
D. nivelurile sanguine ale citoki-
nelor proinogene se corelează
strâns cu febra;
E. indicatorii inflamatori sunt utili
mai ales pentru detectarea unei
boli oculte;
568. R.I. evaluarea pacientului cu
febră sau hipertermie, u.a.s.c.g.e.;
A. pacientul trebuie interogată cu
privire la expunerea la alte
persoane infectate sau la vectori
de boală;
B. neutropenia exclude o infecție
virală;
C. nivelurile sanguine ale citoki-
nelor proinogene sunt adesea sub
limba de detecție;
D. la pacienți subfebrili, valoarea
cea mai mare o are
determinarea proteinei C
reactive și a VSH;
E. granațiile toxice și corpii
Döhle sunt sugestive pentru o
infecție bacteriană;
569. U.f.d.f.d. investigațiile
paraclinice în afebrilitate febrile
s.c.f.g.e.;
A. Formula leucocitară trebuie;
B. efectuată manual sau cu un
instrument capabil să identifice;
C. leucocitele neregulate;
D. toxice și corpii Döhle;
E. care indică o infecție bacte-
riană;
570. R.I. sistematizarea tiparelor
de febră în funcție de
periodicitate, f.d.u. variante;
1. febră zilnică;
2. intervale febrile de una sau mai
multe zile alternând cu intervale
afebrile;
3. următoarele tipare de febră:
a. febra hecică;
b. febra în coccaș;
c. febra ondulantă;
d. febra remitentă;
e. febra intermitentă;
f. febra în coccaș;
g. febra ondulantă;
h. febra remitentă;
i. febra intermitentă;
j. febra în coccaș;
k. febra ondulantă;
l. febra remitentă;
m. febra intermitentă;
n. febra în coccaș;
o. febra ondulantă;
p. febra remitentă;
q. febra intermitentă;
r. febra în coccaș;
s. febra ondulantă;
t. febra remitentă;
u. febra intermitentă;
v. febra în coccaș;
w. febra ondulantă;
x. febra remitentă;
y. febra intermitentă;
z. febra în coccaș;
aa. febra ondulantă;
ab. febra remitentă;
ac. febra intermitentă;
ad. febra în coccaș;
ae. febra ondulantă;
af. febra remitentă;
ag. febra intermitentă;
ah. febra în coccaș;
ai. febra ondulantă;
aj. febra remitentă;
ak. febra intermitentă;
al. febra în coccaș;
am. febra ondulantă;
an. febra remitentă;
ao. febra intermitentă;
ap. febra în coccaș;
aq. febra ondulantă;
ar. febra remitentă;
as. febra intermitentă;
at. febra în coccaș;
au. febra ondulantă;
av. febra remitentă;
aw. febra intermitentă;
ax. febra în coccaș;
ay. febra ondulantă;
az. febra remitentă;
ba. febra intermitentă;
bb. febra în coccaș;
bc. febra ondulantă;
bd. febra remitentă;
be. febra intermitentă;
bf. febra în coccaș;
bg. febra ondulantă;
bh. febra remitentă;
bi. febra intermitentă;
bj. febra în coccaș;
bk. febra ondulantă;
bl. febra remitentă;
bm. febra intermitentă;
bn. febra în coccaș;
bo. febra ondulantă;
bp. febra remitentă;
bq. febra intermitentă;
br. febra în coccaș;
bs. febra ondulantă;
bt. febra remitentă;
bu. febra intermitentă;
bv. febra în coccaș;
bw. febra ondulantă;
bx. febra remitentă;
by. febra intermitentă;
bz. febra în coccaș;
ca. febra ondulantă;
cb. febra remitentă;
cc. febra intermitentă;
cd. febra în coccaș;
ce. febra ondulantă;
cf. febra remitentă;
cg. febra intermitentă;
ch. febra în coccaș;
ci. febra ondulantă;
cj. febra remitentă;
ck. febra intermitentă;
cl. febra în coccaș;
cm. febra ondulantă;
cn. febra remitentă;
co. febra intermitentă;
cp. febra în coccaș;
cq. febra ondulantă;
cr. febra remitentă;
cs. febra intermitentă;
ct. febra în coccaș;
cu. febra ondulantă;
cv. febra remitentă;
cw. febra intermitentă;
cx. febra în coccaș;
cy. febra ondulantă;
cz. febra remitentă;
da. febra intermitentă;
db. febra în coccaș;
dc. febra ondulantă;
dd. febra remitentă;
de. febra intermitentă;
df. febra în coccaș;
dg. febra ondulantă;
dh. febra remitentă;
di. febra intermitentă;
dj. febra în coccaș;
dk. febra ondulantă;
dl. febra remitentă;
dm. febra intermitentă;
dn. febra în coccaș;
do. febra ondulantă;
dp. febra remitentă;
dq. febra intermitentă;
dr. febra în coccaș;
ds. febra ondulantă;
dt. febra remitentă;
du. febra intermitentă;
dv. febra în coccaș;
dw. febra ondulantă;
dx. febra remitentă;
dy. febra intermitentă;
dz. febra în coccaș;
ea. febra ondulantă;
eb. febra remitentă;
ec. febra intermitentă;
ed. febra în coccaș;
ee. febra ondulantă;
ef. febra remitentă;
eg. febra intermitentă;
eh. febra în coccaș;
ei. febra ondulantă;
ej. febra remitentă;
ek. febra intermitentă;
el. febra în coccaș;
em. febra ondulantă;
en. febra remitentă;
eo. febra intermitentă;
ep. febra în coccaș;
eq. febra ondulantă;
er. febra remitentă;
es. febra intermitentă;
et. febra în coccaș;
eu. febra ondulantă;
ev. febra remitentă;
ew. febra intermitentă;
ex. febra în coccaș;
ey. febra ondulantă;
ez. febra remitentă;
fa. febra intermitentă;
fb. febra în coccaș;
fc. febra ondulantă;
fd. febra remitentă;
fe. febra intermitentă;
ff. febra în coccaș;
fg. febra ondulantă;
fh. febra remitentă;
fi. febra intermitentă;
fj. febra în coccaș;
fk. febra ondulantă;
fl. febra remitentă;
fm. febra intermitentă;
fn. febra în coccaș;
fo. febra ondulantă;
fp. febra remitentă;
fq. febra intermitentă;
fr. febra în coccaș;
fs. febra ondulantă;
ft. febra remitentă;
fu. febra intermitentă;
fv. febra în coccaș;
fw. febra ondulantă;
fx. febra remitentă;
fy. febra intermitentă;
fz. febra în coccaș;
ga. febra ondulantă;
gb. febra remitentă;
gc. febra intermitentă;
gd. febra în coccaș;
ge. febra ondulantă;
gf. febra remitentă;
gg. febra intermitentă;
gh. febra în coccaș;
gi. febra ondulantă;
gj. febra remitentă;
gk. febra intermitentă;
gl. febra în coccaș;
gm. febra ondulantă;
gn. febra remitentă;
go. febra intermitentă;
gp. febra în coccaș;
gq. febra ondulantă;
gr. febra remitentă;
gs. febra intermitentă;
gt. febra în coccaș;
gu. febra ondulantă;
gv. febra remitentă;
gw. febra intermitentă;
gx. febra în coccaș;
gy. febra ondulantă;
gz. febra remitentă;
ha. febra intermitentă;
hb. febra în coccaș;
hc. febra ondulantă;
hd. febra remitentă;
he. febra intermitentă;
hf. febra în coccaș;
hg. febra ondulantă;
hh. febra remitentă;
hi. febra intermitentă;
hj. febra în coccaș;
hk. febra ondulantă;
hl. febra remitentă;
hm. febra intermitentă;
hn. febra în coccaș;
ho. febra ondulantă;
hp. febra remitentă;
hq. febra intermitentă;
hr. febra în coccaș;
hs. febra ondulantă;
ht. febra remitentă;
hu. febra intermitentă;
hv. febra în coccaș;
hw. febra ondulantă;
hx. febra remitentă;
hy. febra intermitentă;
hz. febra în coccaș;
ia. febra ondulantă;
ib. febra remitentă;
ic. febra intermitentă;
id. febra în coccaș;
ie. febra ondulantă;
if. febra remitentă;
ig. febra intermitentă;
ih. febra în coccaș;
ii. febra ondulantă;
ij. febra remitentă;
ik. febra intermitentă;
il. febra în coccaș;
im. febra ondulantă;
in. febra remitentă;
io. febra intermitentă;
ip. febra în coccaș;
iq. febra ondulantă;
ir. febra remitentă;
is. febra intermitentă;
it. febra în coccaș;
iu. febra ondulantă;
iv. febra remitentă;
iw. febra intermitentă;
ix. febra în coccaș;
iy. febra ondulantă;
iz. febra remitentă;
ja. febra intermitentă;
jb. febra în coccaș;
jc. febra ondulantă;
jd. febra remitentă;
je. febra intermitentă;
jf. febra în coccaș;
jg. febra ondulantă;
jh. febra remitentă;
ji. febra intermitentă;
jj. febra în coccaș;
jk. febra ondulantă;
jl. febra remitentă;
jm. febra intermitentă;
jn. febra în coccaș;
jo. febra ondulantă;
jp. febra remitentă;
jq. febra intermitentă;
jr. febra în coccaș;
js. febra ondulantă;
jt. febra remitentă;
ju. febra intermitentă;
jv. febra în coccaș;
jw. febra ondulantă;
jx. febra remitentă;
jy. febra intermitentă;
jz. febra în coccaș;
ka. febra ondulantă;
kb. febra remitentă;
kc. febra intermitentă;
kd. febra în coccaș;
ke. febra ondulantă;
kf. febra remitentă;
kg. febra intermitentă;
kh. febra în coccaș;
ki. febra ondulantă;
kj. febra remitentă;
kk. febra intermitentă;
kl. febra în coccaș;
km. febra ondulantă;
kn. febra remitentă;
ko. febra intermitentă;
kp. febra în coccaș;
kq. febra ondulantă;
kr. febra remitentă;
ks. febra intermitentă;
kt. febra în coccaș;
ku. febra ondulantă;
kv. febra remitentă;
kw. febra intermitentă;
kx. febra în coccaș;
ky. febra ondulantă;
kz. febra remitentă;
la. febra intermitentă;
lb. febra în coccaș;
lc. febra ondulantă;
ld. febra remitentă;
le. febra intermitentă;
lf. febra în coccaș;
lg. febra ondulantă;
lh. febra remitentă;
li. febra intermitentă;
lj. febra în coccaș;
lk. febra ondulantă;
ll. febra remitentă;
lm. febra intermitentă;
ln. febra în coccaș;
lo. febra ondulantă;
lp. febra remitentă;
lq. febra intermitentă;
lr. febra în coccaș;
ls. febra ondulantă;
lt. febra remitentă;
lu. febra intermitentă;
lv. febra în coccaș;
lw. febra ondulantă;
lx. febra remitentă;
ly. febra intermitentă;
lz. febra în coccaș;
ma. febra ondulantă;
mb. febra remitentă;
mc. febra intermitentă;
md. febra în coccaș;
me. febra ondulantă;
mf. febra remitentă;
mg. febra intermitentă;
mh. febra în coccaș;
mi. febra ondulantă;
mj. febra remitentă;
mk. febra intermitentă;
ml. febra în coccaș;
mm. febra ondulantă;
mn. febra remitentă;
mo. febra intermitentă;
mp. febra în coccaș;
mq. febra ondulantă;
mr. febra remitentă;
ms. febra intermitentă;
mt. febra în coccaș;
mu. febra ondulantă;
mv. febra remitentă;
mw. febra intermitentă;
mx. febra în coccaș;
my. febra ondulantă;
mz. febra remitentă;
na. febra intermitentă;
nb. febra în coccaș;
nc. febra ondulantă;
nd. febra remitentă;
ne. febra intermitentă;
nf. febra în coccaș;
ng. febra ondulantă;
nh. febra remitentă;
ni. febra intermitentă;
nj. febra în coccaș;
nk. febra ondulantă;
nl. febra remitentă;
nm. febra intermitentă;
nn. febra în coccaș;
no. febra ondulantă;
np. febra remitentă;
nq. febra intermitentă;
nr. febra în coccaș;
ns. febra ondulantă;
nt. febra remitentă;
nu. febra intermitentă;
nv. febra în coccaș;
nw. febra ondulantă;
nx. febra remitentă;
ny. febra intermitentă;
nz. febra în coccaș;
oa. febra ondulantă;
ob. febra remitentă;
oc. febra intermitentă;
od. febra în coccaș;
oe. febra ondulantă;
of. febra remitentă;
og. febra intermitentă;
oh. febra în coccaș;
oi. febra ondulantă;
oj. febra remitentă;
ok. febra intermitentă;
ol. febra în coccaș;
om. febra ondulantă;
on. febra remitentă;
oo. febra intermitentă;
op. febra în coccaș;
oq. febra ondulantă;
or. febra remitentă;
os. febra intermitentă;
ot. febra în coccaș;
ou. febra ondulantă;
ov. febra remitentă;
ow. febra intermitentă;
ox. febra în coccaș;
oy. febra ondulantă;
oz. febra remitentă;
pa. febra intermitentă;
pb. febra în coccaș;
pc. febra ondulantă;
pd. febra remitentă;
pe. febra intermitentă;
pf. febra în coccaș;
pg. febra ondulantă;
ph. febra remitentă;
pi. febra intermitentă;
pj. febra în coccaș;
pk. febra ondulantă;
pl. febra remitentă;
pm. febra intermitentă;
pn. febra în coccaș;
po. febra ondulantă;
pp. febra remitentă;
pq. febra intermitentă;
pr. febra în coccaș;
ps. febra ondulantă;
pt. febra remitentă;
pu. febra intermitentă;
pv. febra în coccaș;
pw. febra ondulantă;
px. febra remitentă;
py. febra intermitentă;
pz. febra în coccaș;
qa. febra ondulantă;
qb. febra remitentă;
qc. febra intermitentă;
qd. febra în coccaș;
qe. febra ondulantă;
qf. febra remitentă;
qg. febra intermitentă;
qh. febra în coccaș;
qi. febra ondulantă;
qj. febra remitentă;
qk. febra intermitentă;
ql. febra în coccaș;
qm. febra ondulantă;
qn. febra remitentă;
qo. febra intermitentă;
qp. febra în coccaș;
qq. febra ondulantă;
qr. febra remitentă;
qs. febra intermitentă;
qt. febra în coccaș;
qu. febra ondulantă;
qv. febra remitentă;
qw. febra intermitentă;
qx. febra în coccaș;
qy. febra ondulantă;
qz. febra remitentă;
ra. febra intermitentă;
rb. febra în coccaș;
rc. febra ondulantă;
rd. febra remitentă;
re. febra intermitentă;
rf. febra în coccaș;
rg. febra ondulantă;
rh. febra remitentă;
ri. febra intermitentă;
rj. febra în coccaș;
rk. febra ondulantă;
rl. febra remitentă;
rm. febra intermitentă;
rn. febra în coccaș;
ro. febra ondulantă;
rp. febra remitentă;
rq. febra intermitentă;
rr. febra în coccaș;
rs. febra ondulantă;
rt. febra remitentă;
ru. febra intermitentă;
rv. febra în coccaș;
rw. febra ondulantă;
rx. febra remitentă;
ry. febra intermitentă;
rz. febra în coccaș;
sa. febra ondulantă;
sb. febra remitentă;
sc. febra intermitentă;
sd. febra în coccaș;
se. febra ondulantă;
sf. febra remitentă;
sg. febra intermitentă;
sh. febra în coccaș;
si. febra ondulantă;
sj. febra remitentă;
sk. febra intermitentă;
sl. febra în coccaș;
sm. febra ondulantă;
sn. febra remitentă;
so. febra intermitentă;
sp. febra în coccaș;
sq. febra ondulantă;
sr. febra remitentă;
ss. febra intermitentă;
st. febra în coccaș;
su. febra ondulantă;
sv. febra remitentă;
sw. febra intermitentă;
sx. febra în coccaș;
sy. febra ondulantă;
sz. febra remitentă;
ta. febra intermitentă;
tb. febra în coccaș;
tc. febra ondulantă;
td. febra remitentă;
te. febra intermitentă;
tf. febra în coccaș;
tg. febra ondulantă;
th. febra remitentă;
ti. febra intermitentă;
tj. febra în coccaș;
tk. febra ondulantă;
tl. febra remitentă;
tm. febra intermitentă;
tn. febra în coccaș;
to. febra ondulantă;
tp. febra remitentă;
tq. febra intermitentă;
tr. febra în coccaș;
ts. febra ondulantă;
tt. febra remitentă;
tu. febra intermitentă;
tv. febra în coccaș;
tw. febra ondulantă;
tx. febra remitentă;
ty. febra intermitentă;
tz. febra în coccaș;
ua. febra ondulantă;
ub. febra remitentă;
uc. febra intermitentă;
ud. febra în coccaș;
ue. febra ondulantă;
uf. febra remitentă;
ug. febra intermitentă;
uh. febra în coccaș;
ui. febra ondulantă;
uj. febra remitentă;
uk. febra intermitentă;
ul. febra în coccaș;
um. febra ondulantă;
un. febra remitentă;
uo. febra intermitentă;
up. febra în coccaș;
uq. febra ondulantă;
ur. febra remitentă;
us. febra intermitentă;
ut. febra în coccaș;
uu. febra ondulantă;
uv. febra remitentă;
uw. febra intermitentă;
ux. febra în coccaș;
uy. febra ondulantă;
uz. febra remitentă;
va. febra intermitentă;
vb. febra în coccaș;
vc. febra ondulantă;
vd. febra remitentă;
ve. febra intermitentă;
vf. febra în coccaș;
vg. febra ondulantă;
vh. febra remitentă;
vi. febra intermitentă;
vj. febra în coccaș;
vk. febra ondulantă;
vl. febra remitentă;
vm. febra intermitentă;
vn. febra în coccaș;
vo. febra ondulantă;
vp. febra remitentă;
vq. febra intermitentă;
vr. febra în coccaș;
vs. febra ondulantă;
vt. febra remitentă;
vu. febra intermitentă;
vv. febra în coccaș;
vw. febra ondulantă;
vx. febra remitentă;
vy. febra intermitentă;
vz. febra în coccaș;
wa. febra ondulantă;
wb. febra remitentă;
wc. febra intermitentă;
wd. febra în coccaș;
we. febra ondulantă;
wf. febra remitentă;
wg. febra intermitentă;
wh. febra în coccaș;
wi. febra ondulantă;
wj. febra remitentă;
wk. febra intermitentă;
wl. febra în coccaș;
wm. febra ondulantă;
wn. febra remitentă;
wo. febra intermitentă;
wp. febra în coccaș;
wq. febra ondulantă;
wr. febra remitentă;
ws. febra intermitentă;
wt. febra în coccaș;
wu. febra ondulantă;
wv. febra remitentă;
ww. febra intermitentă;
wx. febra în coccaș;
wy. febra ondulantă;
wz. febra remitentă;
xa. febra intermitentă;
xb. febra în coccaș;
xc. febra ondulantă;
xd. febra remitentă;
xe. febra intermitentă;
xf. febra în coccaș;
xg. febra ondulantă;
xh. febra remitentă;
xi. febra intermitentă;
xj. febra în coccaș;
xk. febra ondulantă;
xl. febra remitentă;
xm. febra intermitentă;
xn. febra în coccaș;
xo. febra ondulantă;
xp. febra remitentă;
xq. febra intermitentă;
xr. febra în coccaș;
xs. febra ondulantă;
xt. febra remitentă;
xu. febra intermitentă;
xv. febra în coccaș;
xw. febra ondulantă;
xx. febra remitentă;
xy. febra intermitentă;
xz. febra în coccaș;
ya. febra ondulantă;
yb. febra remitentă;
yc. febra intermitentă;
yd. febra în coccaș;
ye. febra ondulantă;
yf. febra remitentă;
yg. febra intermitentă;
yh. febra în coccaș;
yi. febra ondulantă;
yj. febra remitentă;
yk. febra intermitentă;
yl. febra în coccaș;
ym. febra ondulantă;
yn. febra remitentă;
yo. febra intermitentă;
yp. febra în coccaș;
yq. febra ondulantă;
yr. febra remitentă;
ys. febra intermitentă;
yt. febra în coccaș;
yu. febra ondulantă;
yv. febra remitentă;
yw. febra intermitentă;
yx. febra în coccaș;
yy. febra ondulantă;
yz. febra remitentă;
za. febra intermitentă;
zb. febra în coccaș;
zc. febra ondulantă;
zd. febra remitentă;
ze. febra intermitentă;
zf. febra în coccaș;
zg. febra ondulantă;
zh. febra remitentă;
zi. febra intermitentă;
zj. febra în coccaș;
zk. febra ondulantă;
zl. febra remitentă;
zm. febra intermitentă;
zn. febra în coccaș;
zo. febra ondulantă;
zp. febra remitentă;
zq. febra intermitentă;
zr. febra în coccaș;
zs. febra ondulantă;
zt. febra remitentă;
zu. febra intermitentă;
zv. febra în coccaș;
zw. febra ondulantă;
zx. febra remitentă;
zy. febra intermitentă;
zz. febra în coccaș;

Prescurtări frecvent folosite: f.d. = cu excepția; s.u.g.e. = sunt următoarele, cu excepția; u.a.s.c.g.e. = următoarele afirmatii sunt corecte, cu excepția; s.c.f.g.e. = sunt corecte următoarele, cu excepția.

- care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-3, c-4, d-2;
B. a-3, b-1, c-2, d-4;
C. a-3, b-4, c-1, d-2;
D. a-1, b-2, c-1, d-2;
E. a-1, b-3, c-1, d-2;
574. R.I. caracteristicile diverselor
tipare de febră, f.d.;
1. febra intermitentă neregulată;
2. febra continuă;
3. febra hecică;
și următoarele caracteristici:
a. oscilații foarte mari (>2.3°C,
uneori chiar până la 5°C);
b. variații mari, perioadele febrile
cu durată de una sau mai multe
zile alternează cu perioade
afebrile de durată variabilă;
c. oscilații mici (<1°C);
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
575. R.I. caracteristicile diverselor
tipare de febră, f.d.;
1. febra intermitentă
sistemată;
2. febra ondulantă;
3. febra în coccaș;
și următoarele caracteristici:
a. variații mari, perioadele febrile
cu durată constantă;
b. după ascensivitatea inițială
urmează o perioadă de
afebrilitate, apoi reapariția
febrei;
c. perioadele febrile alternează cu
perioade afebrile;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
576. R.I. condițiile patologice
asociate în mod caracteristic cu
diverse tipare de febră, f.d.;
1. febra în coccaș;
2. febra hecică;
3. febra ondulantă Pel-Ebstein;
4. febră remitentă;
și următoarele condiții patologice:
a. bronhopneumonie;
b. gripă;
c. tuberculoză cavitată;
d. boala Hodgkin;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-4, c-3, d-2;
B. a-3, b-2, c-1, d-4;
C. a-3, b-4, c-2, d-1;
D. a-4, b-1, c-2, d-3;
E. a-4, b-3, c-1, d-2;
577. R.I. condițiile patologice
asociate în mod caracteristic cu
diverse tipare de febră, f.d.;
1. febra în coccaș;
2. febra intermitentă neregulată;
3. febră ondulantă;
și următoarele condiții patologice:
a. brucelează;
b. leptospiroză;
c. angioclită;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-3, c-2;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
578. R.I. condițiile patologice
asociate în mod caracteristic cu
diverse tipare de febră, f.d.;
1. febra în coccaș;
2. febra intermitentă neregulată;
3. febră ondulantă;
și următoarele condiții patologice:
a. endocardita bacteriană;
b. vizioză;
c. cancer de diverse tipuri;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
579. R.I. condițiile patologice
asociate în mod caracteristic cu
diverse tipare de febră, f.d.;
1. febră continuă;
2. febră intermitentă neregulată;
3. febră recurentă;
și următoarele condiții patologice:
a. erizipel;
b. infecții bilare;
c. borelioze;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
580. R.I. condițiile patologice
asociate în mod caracteristic cu
diverse tipare de febră, f.d.;
1. febră continuă;
2. febră intermitentă neregulată;
3. febră remitentă, hecică sau
neregulată;
și următoarele condiții patologice:
a. pleionefrită;
b. febră tioidă;
c. stări septică/septicemii;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
581. R.I. condițiile patologice
asociate în mod caracteristic cu
diverse tipare de febră, f.d.;
1. febră continuă;
2. febră intermitentă
sistemată;
3. febră remitentă;
și următoarele condiții patologice:
a. marie;
b. tuberculoză;
c. pneumonie;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-3, c-2;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
582. R.I. condițiile patologice
asociate în mod caracteristic cu
diverse tipare de febră, f.d.;
1. febră continuă;
2. febră inversă;
3. febră remitentă;
și următoarele condiții patologice:
a. forme severe de tuberculoză
cavitată;
b. supurații;
c. litos exantematic;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-1, c-2;
583. Centul termoreglării se află
în:
A. hipotalamusul anterior;
B. hipotalamusul posterior;
C. lobul frontal;
D. lobul temporal;
E. lobul occipital;
584. Despre etiologia febrei este
falsă:
A. febra nu apare în infecție
localizată;
B. febra poate apărea în infecție
generalizată;
C. febra poate însoți neoplazii;
D. febra poate apărea în boile
neurologice care interesează
hipotalamusul;
E. febra poate însoți boile auto-
imune;
585. Despre febra „în dromader”
este falsă:
a. febra ondulantă;
b. febra remitentă;
c. febra intermitentă;
d. febra în coccaș;
e. febra ondulantă;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele; f.l. = referitor/referențiar la; U.f.d.f.d. = Următoarele fraze sunt adevărate dintr-o frază deșire.

- A. este o variantă de febră recurentă;
B. prezintă 2 episoade febrile separate de afebrilitate;
C. apare de obicei în virozele respiratorii;
D. prezintă 2 episoade febrile, primul cu valori mai mari;
E. prezintă 2 episoade febrile, al doilea cu valori mai mari;
586. Despre febra intermitentă u.a.s.c. e.g.:
A. este un tip de febră cu variații mari în care perioadele febrile sunt întrerupte de perioade afebrile;
B. este un tip de febră în care valorile minime ajung în domeniul normalului;
C. are ca variantă febra hectică;
D. este un tip de febră cu variații mari în care valorile minime rămân în domeniul febril;
E. poate fi sistematizată sau nesistematizată;
587. Despre febra Pel-Ebstein este falsă:
A. este un tip de febră ondulantă;
B. apare în boala Hodgkin;
C. prezintă perioade febrile prelungite (3-10 zile) separate prin perioade de afebrilitate (3-10 zile);
D. este un tip de febră nereglată;
E. perioadele febrile au ascensiune și scădere progresive;
588. Despre frison u.a.s.c. e.g.:
A. este perceput ca o senzație de frig intens;
B. apare în perioada de elervescență a stării febrile;
C. se manifestă sub forma contracțiilor musculare intense, continue;
D. este însoțit de vasoconstricție cutanată și paloare;
E. are ca efect creșterea temperaturii;
589. Despre hipotermie ca semn de infecție severă este falsă:
A. poate apare la nou-născuți;
B. poate apare la cei tratați cronic cu glucocorticoizi;
C. poate apare la cei cu insuficiență renală;
D. poate apare la cei cu insuficiență hepatică;
E. apare întotdeauna la pacientul imunocompetent;
590. Din punct de vedere al manifestărilor neuropsichice sindromul febril poate include, e.g.:
A. creșterea pragului convulsiv la pacienții epileptici;
B. insomnie;
C. iritabilitate;
D. delir;
E. halucinații;
591. Dintre efectele pozitive ale febrei poate face parte:
A. scăderea virulenței unor bacterii;
B. creșterea consumului de oxigen;
C. creșterea necesarului caloric;
D. accelerarea catabolismului muscular;
E. creșterea riscului convulsiv;
592. Printre efectele negative ale febrei se află u.g.:
A. creșterea consumului de oxigen și a necesităților calorice;
B. creșterea catabolismului muscular;
C. scăderea acuității psihice;
D. creșterea riscului convulsiv;
E. inhibarea proliferării unor bacterii;
593. Febra continuă definește:
A. creșterea persistentă a temperaturii cu variații zilnice > 1°C, fără a se ajunge însă la valori normale;
B. creșterea persistentă a temperaturii cu variații zilnice > 1°C, ajungându-se la valori normale;
C. creșterea persistentă a temperaturii cu variații zilnice ce nu depășesc 1°C;
D. febra cu curbă sistematizabilă;
E. febra care persistă mai mult de 2 săptămâni;
594. Febra de resorbție poate apărea în u. situații, e.g.:
A. afecțiuni tisulare necrotice;
B. infarctul miocardic;
C. infarctul pulmonar;
D. hematoame extinse;
E. fenomene de idiosincrazie;
595. Febra hectică este o variantă de febră:
A. susținută;
B. remitentă;
C. intermitentă;
D. ondulantă;
E. nereglată;
596. Febra remitentă definește:
A. febra în care variațiile zilnice sunt > 1°C, valorile minime atingând valori normale;
B. IL 1;
C. IL 6;
D. interferonul;
E. FNTG;
602. Care dintre următorii nu este un pirogen endogen:

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele; f.l. = referenționale la; U.I.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o înză despre;

- A. PG;
B. IL 1 & 6;
C. FNTG;
D. toxine ale microorganismelor;
E. interferonul;
603. Care dintre următorii nu este un pirogen exogen:
A. microorganismele;
B. toxine bacteriene;
C. anumiți medicamente;
D. anumite substanțe chimice;
E. prostaglandinele;
604. Reacții de fază acută ai inflamației care cresc în febră sunt următorii, e.g.:
A. proteina C reactivă;
B. fibrinogenul;
C. VSH-ul;
D. α₂-globulinele;
E. monocitele;
605. Temperatura corporală normală:
A. este constantă pe 24 de ore;
B. are o variație diurnă cu valori maxime dimineața (orele 03-06);
C. are o variație diurnă cu valori maxime seara (orele 18-21);
D. este de circa 37°C central;
E. este de circa 37,5°C axilar;
606. Transpirarea:
A. apare în perioada de invazie a stării febrile;
B. apare în perioada de elervescență a stării febrile;
C. reprezintă un mecanism de scădere a temperaturii;
D. reprezintă un mecanism de creștere a temperaturii;
E. nu este o manifestare a sindromului febril;

Semiologie ORL și oftalmologică – dr. J.F.B.

607. Ambliopia reprezintă:
A. pierderea în timp a acuității vizuale a globului ocular strabismic;
B. pierderea în timp a acuității vizuale a globului ocular strabismic;
C. pierderea în timp a acuității vizuale a globului ocular strabismic;
D. pierderea în timp a acuității vizuale a globului ocular strabismic;
E. pierderea în timp a acuității vizuale a globului ocular strabismic;

614. Clinic, în glaucomul cu unghi închis pot apărea, e.g.:
A. cefalee;
B. mioza internă;
C. vărsături;
D. durere intensă oculară;
E. corneă cu aspect "umurtu";
615. Clinic, în otita externa domina:
A. febra;
B. otoreea;
C. disfonie;
D. otalgia;
E. edemul pavilionului;
616. Coloboma reprezintă:
A. lipsa de substanță la nivelul irisului survenită posttraumatic;
B. lipsa de substanță la nivelul corneei survenită posttraumatic;
C. anomalie dobândită a formei corneei (aspect de con);
D. opacifierea cristalinului;
E. lipsa congenitală de substanță la nivelul irisului;
617. Despre leucoplakie este adevărat că:
A. poate apărea la bărbați cu vârstă >40 ani, consumatori de alcool;
B. apare numai la pacienți infectați HIV;
C. este o leziune benignă, de culoare alb sidă, cu localizare la nivelul limbii;
D. este un placard eritematos, cu papule ce sângerează ușor la atingere;
E. determină distonie;
618. Despre scleromalacia perforans este adevărat că:
A. reprezintă o infecție a corneei care apare la pacienți cu diabet zaharat;
B. reprezintă o infecție sclerală gravă ce apare în sclerodermie;
C. este intens dureroasă și este însoțită de fotofobie;
D. apare în poliartrita reumatoidă;
E. apare cel mai frecvent la bărbați infectați HIV;
619. Despre tonusul palatin este adevărat că:
A. apare la nivelul palatului moale, la aproximativ 20% din populație;
B. determină stăloare;
C. are risc crescut de malignizare;
D. este o excrescență lobulată a osului palatin;
E. apare la pacienții infectați HIV;
620. Despre xantelasme este adevărat că:

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele; f.l. = referenționale la; U.I.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o înză despre;

- A. reprezentă depuneri cutanate de cupru;
B. au culoare brună, nu sunt bine circumscrie;
C. se pot asocia cu dislipidemie;
D. apar cel mai frecvent la nivelul aripilor nazale;
E. apar la nivelul mucoasei bucale și sunt glande sebacee ectopice;
621. Despre xerostomie este adevărat că:
A. apare în urma hipersecreției glandelor salivare;
B. apare datorită igienei orale deficitare;
C. previne apariția candidozei orale și a cariilor dentare;
D. predispune la apariția leucoplakiei;
E. se asociază cu macroglosie;
622. Dinții Hutchinson:
A. sunt incisivi ce prezintă eroziuni determinate de refluxul de suc gastric;
B. sunt dinți ce prezintă incizuri sau abraziuni provocate de traumatisme repetate;
C. apar în sarcinidiaz;
D. apar în sfîșitul secundar;
E. apar în sfîșitul congenital;
623. Dureea la presiunea aplicată pe traqus sau la tracțiunea pavilionului apare în:
A. otita medie purulentă;
B. otita externă;
C. otita medie seroasă;
D. otoscleroză;
E. prezența toliilor gutoși;
624. Entropion-ul reprezintă:
A. imposibilitatea completă a pleoapelor;
B. întoarcerea marginii pleoapei afectate către exterior;
C. întoarcerea marginii pleoapei afectate către interior;
D. protruzia unui glob ocular;
E. pierderea de substanță la nivelul corneei;
625. Epiphora reprezintă:
A. secreția oculară purulentă;
B. leziune excesivă;
C. prezența sângelui în camera anterioară a globului ocular;
D. hemoragiile în corpii vitros;
E. inflamația sclerei;
626. Epiphora reprezintă:
A. protruzia unui glob ocular;
B. inflamația cronică a marginii unei pleoape;
C. întoarcerea marginii pleoapei către exterior, cu expunerea conjunctivei;
- D. lăcrimare excesivă ce apare în obstrucții ale canalului lacrimal;
E. plăcuță ușor elevată, galbenă, bine circumscrișă, situată la nivelul 1/3 nazale a pleoapei;
627. Escotropia reprezintă:
A. devierea temporală a unui glob ocular;
B. devierea supero-externă a unui glob ocular;
C. devierea infero-externă a unui glob ocular;
D. devierea nazală a unui glob ocular;
E. devierea supero-internă a unui glob ocular;
628. Gustul este defectat la nivelul limbii după cum urmează:
A. sărat la nivelul vârfului limbii;
C. dulce și amar la baza limbii;
D. amar și acru la baza limbii;
E. amar și sărat la baza limbii;
629. Halitoza:
A. este un miros neplăcut al respirației, determinat cel mai frecvent de o igienă precară a cavității bucale;
B. este un miros neplăcut al respirației, determinat cel mai frecvent de o afecțiune pulmonară cronică;
D. este un miros neplăcut al respirației, care apare cel mai frecvent în diabet;
E. este un miros neplăcut al respirației, care apare cel mai frecvent în uremie;
630. Hemianopsia biemporală apare în:
A. leziuni ale chiasmului optice;
B. leziuni ale nervului optic;
C. leziuni ale radiațiilor optice;
D. leziuni ale cortexului occipital;
E. glaucom;
631. Hemianopsia biemporală:
A. reprezintă pierderea acuității vizuale a globului ocular în cadranele temporale ale câmpului vizual;
B. reprezintă pierderea acuității vizuale la nivelul jumătăților temporale ale câmpului vizual, prin lezarea fibrelor temporale, bilaterale;
C. reprezintă pierderea acuității vizuale la nivelul jumătăților temporale ale câmpului vizual, prin lezarea posttraumatică a rețelei;
632. Hemianopsia biemporală poate fi semn de:
A. deslipire de rețină;
B. leziune unilaterală de tract optic;
C. leziune a chiasmului optice (de exemplu tumoră hipofizară);
D. leziuni ale radiațiilor optice;
E. leziuni ale cortexului occipital
633. Hipopion-ul reprezintă:
A. un fel de conee de culoare gri-vede ce apare în boala Wilson;
B. prezenta sângelui în camera anterioară a globului ocular;
C. prezenta unui corp străin intra-ocular;
D. prezenta purului în camera anterioară a globului ocular;
E. construcția pupilei bilaterale;
634. În boala Basedow pot apărea, de:
A. exoftalmie;
B. creșterea de volum a tiroidei;
C. tegumente reci, aspre;
D. tegumente calde, umede;
E. intoleranță la cald;
635. În hipotroidism NU apare:
A. bradicardie;
B. creștere ponderală;
C. tremor al mâinilor;
D. bradicardie;
E. constipație;
636. Inelul Kayser-Fleischer:
A. are culoare albastră și apare în boala Wilson;
B. apare la nivelul irisului, are culoare verde și semnalifică intoxicație acută cu fier;
C. se găsește la nivelul irisului, are culoare verde-gălbui și apare în hemocromatoză;
D. se găsește la periferia corneei, are culoare verde-gălbui și apare în hemocromatoză;
E. se găsește la periferia corneei, are culoare verde-gălbui și apare în boala Wilson;
637. Inelul Kayser-Fleischer:
A. apare prin depuneri de fier în membrana Descemet;

Prescurtări frecvent folosite: G.E. = cu excepție; S.U.C.E. = sunt umătoare, cu excepție; U.S.C.E. = umătoare afirmativ sunt corecte, cu excepție; S.C.E.E. = sunt corect formulate, cu excepție.

- B. apare la persoane vârstnice, la periferia corneei și are aspect argintiu;
C. semnifică prezența unei dislipidemii;
D. apare prin depuneri de cupru la nivelul corneei;
E. apare în boala Wilson, prin depuneri de cupru la nivelul irisului;
638. În cazul nodurilor tiroidiene, c.d.u. elemente ridică suspiciunea de malignitate:
A. nodul mobil la palpare, consistență dură, adenopatie bilaterală, distingie;
B. nodul mobil la palpare, consistență moale, adenopatie unilaterală, distingie;
C. nodul mobil la palpare, consistență moale, adenopatie unilaterală, aerofagie;
D. nodul mobil la palpare, consistență dură, adenopatie unilaterală, distingie;
E. nodul mobil la palpare, consistență moale, adenopatie bilaterală, distingie;
639. În otita acută externă apar:
A. canal auditiv extern edemiat, durere la presiune exercitată asupra tragusului, otoree, febră, timp de aspect normal;
B. canal auditiv extern edemiat, otoree, febră, timp de aspect normal;
C. canal auditiv extern normal, durere la presiune exercitată asupra tragusului, febră, otoree, timp de aspect normal;
D. otalgie, otoree, febră, scăderea acuității auditive prin perforația timpanului;
E. durere la presiunea exercitată pe procesul mastoid, febră, perforație marginală a timpanului, otoree;
640. La auscultarea tiroidei, se poate auzi un suflu (sincron cu sistola) în:
A. gusa endemică;
B. tiroidia Hashimoto;
C. gusa din boala Basedow;
D. prezența unui chist tiroidian simplu, cu diametrul de 3 cm;
E. prezența unui cancer tiroidian (nodul de 2,5 cm), cu adenopatie laterocervicală asociată;
641. La pacienții cu surditate de conducere unilaterală, testul Rinne va fi:
A. negativ la nivelul urechii sănătoase și pozitiv la nivelul urechii afectate;
B. negativ la nivelul urechii sănătoase și indiferent la nivelul celei afectate;
C. pozitiv la nivelul urechii sănătoase și indiferent la nivelul celei afectate;
D. indiferent la nivelul urechii sănătoase și pozitiv la nivelul celei afectate;
E. pozitiv la nivelul urechii sănătoase și negativ la nivelul celei afectate;
642. Leucoplakia:
A. este o zonă eritematoasă, nedureroasă cu papile care sângerează ușor la atingere și are un potențial ridicat de malignizare;
B. este o zonă albă, indurată, dureroasă care apare la nivelul obrajilor/ limbii/ gingivilor la pacienții cu infecție candidozică orală;
C. este o hiperplazie localizată a mucoasei orale, cu aspect de masă pseudotumorală roșie, moale, care sângerează ușor, apare în urma unui traumatism sau a unei iritații locale;
D. este o leziune nodulară ulcerată ce apare cel mai frecvent la nivelul țesuturilor laterale ale limbii;
E. este o placă albă, indurată, nedureroasă, situată la nivelul obrajilor/ limbii/ gingivilor, cu potențial de malignizare, care apare la bătrâni > 40 ani, tumori, consumatori de etanol, sau cu infecție HIV;
643. Limba geografică:
A. este roșie, granulară, cu aspect de zmeură și este o leziune preneoplazică;
B. este o limbă cu numeroase fisuri, ce apare la persoanele vârstnice;
C. este o limbă cu depozite albe pe fața dorsală, care apare la persoanele cu o igienă orală deficitară;
D. are aspect de hartă prin alternanța de zone depălate cu zone normale și are risc de transformare neoplazică;
E. are aspect de hartă prin alternanța de zone depălate cu zone normale și este benignă;
644. Limba zmeurie apare în:
A. rinita alergică;
B. boala Basedow;
C. scarlatină;
D. herpangina;
E. candidoza orală;
645. Limba zmeurie:
A. apare caracteristic în candidoza orală;
B. apare caracteristic în infecția HIV;
C. apare în scarlatină;
D. apare la vârstnici cu o igienă precară a cavității bucale;
E. apare în rujeolă;
646. Lăcrul gingival:
A. este o colorație albastră cu dispunere liniară la nivelul gingivilor ce apare în boala Addison;
B. apare în gingivita acută necrozantă, în urma consumului de metanfetamine;
C. apare posttraumatic;
D. apare în intoxicația cu fier;
E. apare în intoxicația cu plumb;
647. Localizarea cea mai frecventă a cancerului cavității bucale este la nivelul:
A. buzelor;
B. palatului moale;
C. palatului dur;
D. gingivilor;
E. limbii;
648. Măsurarea corectă a presiunii intraculare se face:
A. cu manometrul;
B. cu tonometrul Schiotz;
C. prin presarea globului ocular;
D. prin iluminarea laterală a pupilei și aprecierea grosorii a diferenșurilor camerei anterioare;
E. chirurgical;
649. Principala cauză a apariției cataractei este:
A. diabetul zaharat;
B. expunerea la radiații;
C. postmedicamentoasă (corticosteroizi);
D. expunerea îndelungată și neprotectată la soare;
E. înalțarea în vârstă;
650. Principala manifestare care apare în alergie nazale este:
A. rinoreea apoasă;
B. epistaxisul;
C. obstrucția nazală;
D. pruritul mucoasei nazale;
E. strănutul;
651. Principala manifestare în sinuzita este cea mai frecvent:
A. rinoreea apoasă;

Prescurtări frecvent folosite: U. = umătoare, c.d.u. = care dăre umătoare; I.d. = fiind date, I.d.u. = fiind date umătoare; I. = referință/referitoare la; U.I.d.f.d. = Umătoare în fragmente dintr-o frază despre;

B. tusea;

C. durerea localizată de obicei în

aria de protecție a sinusului

afectat, care se accentuează la

aplicarea capului înainte;

D. secreția nazală purulentă;

E. febra;

652. Principalele simptome din

afecțiunile oculare sunt, c.e.:

A. pierderea vederii;

B. diplopia;

C. dismetria;

D. lăcrimarea;

E. durerea oculară;

653. Sindrom Claude-Bernard-

Hornor:

A. apare prin stimularea gangli-

onului stelar și constă în triada:

mioză, ptoză palpebrală, exof-

talnie;

B. apare prin stimularea gangli-

onului stelar și constă în triada:

midriază, ptoză palpebrală, enof-

talnie;

C. apare prin paraliză gangli-

onului stelar (invazie tumorală de

exemplu) și constă în triada:

midriază, ptoză palpebrală, exof-

talnie;

D. apare prin paraliză gangli-

onului stelar (invazie tumorală de

exemplu) și constă în triada:

mioză, ptoză palpebrală, enof-

talnie;

E. apare prin paraliză gangli-

onului stelar (invazie tumorală de

exemplu) și constă în triada:

mioză, ptoză palpebrală, exof-

talnie;

654. Secreția nazală din rinia

alergică este:

A. mucopurulentă, asociată cu

prurit al mucoasei nazale;

B. sangvinolentă (în alergia la

acarien);

C. mucopurulentă, asociată cu

febra, cefalee frontală;

D. apoasă, asociată cu strănut,

prurit al mucoasei nazale;

E. apoasă în alergia la graminee,

mucopurulentă în alergia la

polenuri;

655. Semnul Pamberton pozitiv

poate sugera:

A. prezența unui nodul tiroidian

autonom;

B. tiroidita Hashimoto la debut;

C. cancer al istmului tiroidian;

D. persistența canalului tiroglos;

E. gusa interalarocica;

656. Sindromul Claude-Bernard-

Hornor se caracterizează prin:

Semiologie

cardiorespiratorie

Dispneea – Dr.D.D.,

Dr.M.M.M.

660. U.f.d.f.d. dispneea s.c.f.c.e.:

A. Respirația este controlată prin

mechanisme centrale și periferice;

B. care ajustează ventilația

adecvat nevoilor metabolice

scăzute;

C. din timpul activității fizice;

D. și scad ventilația sub nevoile;

E. metabolice în situații cum ar fi

anxietatea și frica.

661. R.I. felul în care un individ

normal își percepe respirația,

f.d.u. situații:

1. în repaus;

2. în timpul unui efort ușor până

la moderat;

3. în timpul și după un efort

epuizant;

și următoarele caracteristici:

a. șile că senzația neplăcută este

adecvată pentru nivelul efortului

și trecătoare;

b. nu resimte nici un disconfort;

c. poate deveni conștient în mod

neplăcut de respirație;

d. poate deveni conștient de

respirație;

e. nu este conștient de actul

respirației;

care sunt asocierile corecte:

A. a-1, b-2, c-2, d-3, e-3;

B. a-2, b-3, c-3, d-2, e-1;

C. a-3, b-1, c-3, d-2, e-1;

D. a-3, b-2, c-3, d-2, e-1;

E. a-3, b-3, c-2, d-1, e-2;

662. R.I. dispneea u.a.s.c.e.:

A. dispneea este un simptom

cardinal al bolilor cardiace și

respiratorii;

B. dispneea este adesea perce-

pută drept durere;

C. este necesară o anamneză

atenă pentru a stabili în ce

măsură descrierile mai obscure

reprezintă cu adevărat dispnee;

D. este foarte importantă evalu-

area simptomelor asociate

dispneei;

E. există situații în care respirația

pare laborioasă, dar nu apare

dispnee;

663. R.I. dispneea, u.a.s.c.e.:

A. dispneea este definită drept

conștientizarea anormală, într-un

mod neplăcut, a respirației;

B. spre deosebire de durere,

implică atât percepția unei

senzații, cât și reacția la acea

percepție;

C. este esențială stabilirea circum-

stanțelor în care apare dispneea;

D. hiperventilația asociată cu

acidoză metabolică este de

regulă însoțită de dispnee;

E. unui pacient cu respirație

aparent normală se pot plânga

de dispnee;

664. R.I. felul în care este

resimțită dispneea de către

pacienți f.d.u. categorii:

1. senzații neplăcute legate de

respirație pe care le pot resimți

pacienții;

2. expresii verbale folosite de

pacienți pentru a descrie

senzațiile neplăcute legate de

respirație,

și următoarele descrieri:

a. strângere;

b. sufocare;

c. „nu pot să-mi umplu pieptul cu

aer”;

d. „nu primesc destul aer”;

care sunt asocierile corecte:

A. a-1, b-1, c-2, d-2;

B. a-1, b-2, c-2, d-1;

C. a-1, b-2, c-2, d-1;

D. a-2, b-1, c-2, d-1;

E. a-2, b-2, c-1, d-1;

665. R.I. felul în care este

resimțită dispneea de către

pacienți f.d.u. categorii:

1. senzații neplăcute legate de

respirație pe care le pot resimți

pacienții;

2. expresii verbale folosite de

pacienți pentru a descrie

senzațiile neplăcute legate de

respirație,

și următoarele descrieri:

a. „nu-mi ajunge aerul”;

b. oboseală în piept;

c. apăsare;

d. „aerul nu-mi ajunge până în

plămân”;

care sunt asocierile corecte:

A. a-1, b-1, c-2, d-2;

B. a-1, b-2, c-1, d-2;

C. a-1, b-2, c-2, d-1;

D. a-2, b-1, c-1, d-2;

E. a-2, b-1, c-2, d-1;

666. R.I. dispneea, u.a.s.c.e.:

A. gradarea dispneei se bazează

pe cantitatea de efort fizic

necesar pentru a produce

senzația de dispnee;

B. unele tipare de dispnee nu sunt

legate direct de efortul fizic;

C. episoadele nocturne de

dispnee paroxistică severă sunt

caracteristice pentru TEP;

D. plătineea/ ortodeoxia este

caracteristică pentru sindromul

hepatorenal;

E. una dintre substanțele vasodi-

latatoare implicate în producerea

plătineei/ ortodeoxiei ar putea

fi serotonina;

667. U.f.d.f.d. plătineea s.c.f.c.e.:

A. plătineea/ ortodeoxia din

B. sindromul hepatopulmonar

poate fi explicată;

C. prin perfuzarea unor spații;

D. aeriene în deficit față de

ventilație;

E. echivalând cu șuntarea intra-

pulmonară a sângelui.

668. C.d.u. patologii nu poate

explica episoadele dispneice

bruste și neașteptate în repaus:

a. embolii pulmonare;

B. pneumotorace spontan;

C. hipercapnie secundară ținerii

respirației;

D. anxietate;

E. enfizem pulmonar;

669. R.I. diversele aspecte care

trebuie avute în vedere în

evaluarea/ cuantificarea severității

dispneei, f.d.u. afirmații generale:

1. este important ca medicul să

aibă o percepție clară asupra

condiției fizice generale a

pacientului, asupra istoricului

profesional și asupra obiceiurilor

recreative;

2. trebuie luată în considerare

variația interindividuală în

percepție și în tolerarea

suferei;

3. la unii pacienți cu boală

pulmonară sau cardiacă,

capacitatea de a face efort

poate să fie redusă din cauza

altor boli;

și următoarele exemple:

a. la pacienții cu forme severe de

insuficiență vasculară periferică

nu se poate constata apariția

dispneei la mers în ciuda unui

deficit grav al funcției pulmonare

sau cardiace;

b. pacienții stoice pot tolera o

dispnee severă fără să se

plângă, în timp ce persoanele

extravertite pot face mare caz

de o dispnee ușoară;

c. apariția dispneei după o

alergare de 3 km la un alergător

antrenat poate semnifica o

afecțiune mult mai gravă decât

un grad similar de dispnee la o

persoană sedentară după ce a

alergat 50 de metri;

care sunt asocierile corecte:

A. a-1, b-2, c-3;

B. a-1, b-3, c-2;

C. a-2, b-1, c-3;

D. a-2, b-3, c-1;

E. a-3, b-2, c-1;

670. R.I. diversele aspecte care

trebuie avute în vedere în

evaluarea/ cuantificarea severității

dispneei, f.d.u. afirmații generale:

1. la unii pacienți cu boală

pulmonară sau cardiacă,

capacitatea de a face efort

poate să fie redusă din cauza

altor boli;

2. trebuie luată în considerare

variația interindividuală în

percepție și în tolerarea

suferei;

3. este important ca medicul să

aibă o percepție clară asupra

condiției fizice generale a

pacientului, asupra istoricului

profesional și asupra obiceiurilor

recreative;

și următoarele exemple:

a. la pacienții cu forme severe de

coarctază sau gonartroză nu se

poate constata apariția dispneei

la mers în ciuda unui deficit grav

al funcției pulmonare sau

cardiace;

b. unii pacienți cu boală severă

se pot plânga doar de dispnee

ușoară, iar alții cu boală ușoară

pot resimți dispnee mai severă;

c. o femeie de la țară s-a

prezentat la medic pentru

dispnee după 30 de minute de

săpat în grădină, în timp ce

medicul și-a dat seama că pe el

nu l-ar fi puterile să sapa nici

10 minute.

care sunt asocierile corecte:

A. a-1, b-2, c-3;

B. a-1, b-3, c-2;

C. a-2, b-1, c-3;

D. a-3, b-1, c-2;

E. a-3, b-2, c-1;

671. R.I. dependența de poziție a

dispneei, f.d.u. categorii:

- a. poate să apară și la unii pacienți cu astm și cu obstrucție cronică a căilor respiratorii;
b. reprezintă dispneea care se accentuează în decubit lateral;
c. apare în sindromul hepatopulmonar sau în comunicarea interatrială;
d. reprezintă dispneea care se accentuează în decubit dorsal;
e. poate fi produsă de fistule arterio-venoase intrapulmonare microscopice deschise ca urmare a scăderii epurării hepatice a substanțelor vasodilatatoare;

care sunt asociatele corecte:

- A. a-1, b-1, c-2, d-2, e-3;
B. a-1, b-2, c-3, d-1, e-2;
C. a-1, b-3, c-2, d-1, e-2;
D. a-1, b-3, c-2, d-2, e-1;
E. a-2, b-1, c-2, d-1, e-3;
672. R.I. dependența de poziție a dispneei, f.d.u. categorii:

1. ortopnee;
2. platinnee/ortodoxie;
3. treponnee;
și următoarele caracteristici:
a. este o circumstanță mecanică, care apare cel mai adesea la pacienți cu boala cardiacă;

- b. considerată a fi caracteristică în principal pentru IVS;
c. poate fi explicată prin suflarea dreaptă spre stânga a sângelui; d. este un semn obișnuit în paralizila diafragmatică bilaterală (o afecțiune foarte rară);
e. reprezintă dispneea care se accentuează în poziție ridicată; care sunt asociatele corecte:

- A. a-1, b-1, c-3, d-2, e-2;
B. a-1, b-2, c-3, d-2, e-1;
C. a-2, b-2, c-3, d-1, e-1;
D. a-3, b-1, c-1, d-2, e-2;
E. a-3, b-1, c-2, d-1, e-2;

673. F.d.u. evenimente care ar putea explica mecanismul platinneei (ortodoxiei):

- a. în poziție ridicată, diafragma se deplasează în jos;
b. scade oxigenarea sângelui arterial;
c. creșterea suflării dreapta spre stânga/perfuziei în raport cu ventilația;
d. înfrângerea structurilor intratoracice;

- e. iargirea căilor de comunicare; care este lanțul cauzal corect:
A. a-3-d-1-e-3-c-b;
B. a-3-e-1-c-4-d-b;

Prescurtări frecvent folosite: f.d.u. = cu excepția; s.u.f.d.u. = sunt următoarele, cu excepția; u.a.s.c.g.e. = următoarele afirmații sunt corecte, cu excepția; s.c.f.g.e. = sunt corecte formulate, cu excepția.

- C. b-a-1-d-1-c-3-e;
D. d-1-b-3-c-3-a-1-e;
E. d-1-c-3-e-1-a-1-b;

674. R.I. mecanismele dispneei, u.a.s.c.g.e. (LMEMR = lucrul mecanic efectuat de mușchii respiratori):

- A. dispneea apare ori de câte ori efortul de respirație și deci LMEMR este excesiv;

- B. LMEMR crește atunci când ventilația este excesivă față de nivelul de activitate;
C. dispneea poate fi provocată de stimularea combinată a receptorilor localizați la mai multe niveluri;
D. creșterea sarcinii respiratorii reduce descărcarea de impulsuri din centrul respirator;

- E. dispneea este caracterizată de depunerea ciliară respiratori din trunchiul cerebral;

675. U.f.d.f.d. mecanismele dispneei s.c.f.g.e.:

- A. Dacă fiind lipsa variațiilor interindividuale;
B. există în general o corelație;
C. slăbi între severitatea;
D. dispneei și magnitudinea tulburării funcției pulmonare;

- E. sau cardiacă care o provoacă.

676. U.f.d.f.d. mecanismele dispneei s.c.f.g.e.:

- A. Mușchii respirației sunt obligați să genereze o forță;
B. creșcută pentru a produce o anumită modificare de volum;
C. dacă pereții toracici este mai complianți, dacă plămâni;

- D. sunt mai puțin complianți și; E. dacă rezistența la fluxul de aer este scăzută.

- B. dintre o respirație profundă cu o sarcină mecanică normală;
C. și o respirație de profunzime normală cu o sarcină mecanică crescută, întrucât;

D. deși LMEMR poate fi același în cele două cazuri, respirația;

- E. normală cu sarcină crescută nu generează disconfort.

679. R.I. mecanismele dispneei, u.a.s.c.g.e. (LMEMR = lucrul mecanic efectuat de mușchii respiratori):

- A. lucrul mecanic este produsul dintre forța (F) și distanța (d) pe care acționează acea forță ($L = F \times d$);

- B. o respirație profundă (d crescută) cu o sarcină mecanică normală (F normală) și o respirație de profunzime normală (d normală) cu o sarcină mecanică crescută (F crescută) sunt percepute la fel;

- C. LMEMR poate fi același în cele două cazuri (d crescută $\times$ F normală = d normală $\times$ F crescută), dar respirația profundă (d crescută) cu o sarcină normală (F normală) va genera disconfort;

- D. combinația d normală $\times$ F crescută este mai puțin aptă să genereze dispnee decât combinația d crescută $\times$ F normală;

- E. dispneea este legată mai degrabă de lucrul mecanic decât de forța excesivă pe care trebuie să o/ îl dezvolte mușchii respirației.

680. U.f.d.f.d. mecanismele dispneei s.c.f.g.e.:

- A. Ori de câte ori forța pe care mușchii o generează în timpul, B. respirației se apropie de o anumită fracțiune;
C. din capacitatea lor maximă de a genera forță;
D. (care este aceeași la toți indivizii) rezultă dispnee;

Dispneea – Dr. D. D., Dr. M. M. M.

- trunchiul cerebral este produsă de stimuli transmiși de la prin diverse structuri și căi, incluzând u.s.g.e.:

- A. receptori intratoracici pe care nervilor recurenți;

B. nervi somatici aferenți; In special de la mușchii respiratori și de la pereții toracici, dar și de la alți mușchi scheletici și articulații;

- C. chemoreceptori din creier, din glomusul aortic și din glomusul carotidian, dar și din diverse alte locuri din sistemul circulator;

- D. centri corticali mai înalți;

- E. (probabil și) fibre aferente din nervii frenici.

683. R.I. asocierea dintre descrierile calitative și mecanisme fiziopatologice ale dispneei, f.d.u. descrieri:

1. creșterea travaliului/efortului respirator sau nu poate trage aer adânc în piept, respirație nesatisfăcătoare sau sete de aer;

2. creșterea travaliului/efortului respirator, dar și din diverse alte locuri din sistemul circulator;

3. creșterea travaliului/efortului respirator sau sete de aer, nevoia (imperioasă) de a respira, dar și din diverse alte locuri din sistemul circulator;

4. creșterea travaliului/efortului respirator sau sete de aer, nevoia (imperioasă) de a respira, dar și din diverse alte locuri din sistemul circulator;

- care sunt asociatele corecte:

- A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;

685. R.I. asocierea dintre descrierile calitative și mecanisme fiziopatologice ale dispneei, f.d.u. descrieri:

1. creșterea travaliului/efortului respirator;

2. nu poate trage aer adânc în piept, respirație nesatisfăcătoare;

3. creșterea travaliului/efortului respirator sau sete de aer, nevoia (imperioasă) de a respira;

- și u. mecanisme/ patologi:

- a. obstrucția căilor respiratorii moderată sau severă;

- b. reducerea volumului curent prin boli restrictive;

- c. atelectazia pompei ventilatorii; care sunt asociatele corecte:

- A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;

- care sunt asociatele corecte:

- A. a-1, b-3, c-2;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;

688. R.I. asocierea dintre descrierile calitative și mecanisme fiziopatologice ale dispneei, f.d.u. descrieri:

1. nu poate trage aer adânc în piept, respirație nesatisfăcătoare;

2. sete de aer, nevoia (imperioasă) de a respira;

3. strângere/constricție toracică; și u. mecanisme/ patologi:

- a. edem interstițial pulmonar;

- b. embolism pulmonar;

- c. hiperinflație toracică este deja plin cu aer);

- care sunt asociatele corecte:

- A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;

mare, chiar atunci când compo-
nentele mecanice ale sistemului
sunt normale;
D. receptorii J nu sunt influențați
de edemul interstițial;
E. când sunt stimulați, metabo-
receptorii contribuie la discon-
fortul respirator;
691. U.f.d.f.d. mecanisme
dispneei s.c.f.g.e.;
A. Eferențele neuronale crescute
din cortexul motor sunt;
B. percepțiile datorită unei;
C. descărcări corolar care este;
D. trimisă cortexului motor în
aceleși timp cu semnalele;
E. trimise mușchilor membrilor;
692. R.I. mecanisme dispneei,
u.a.s.c.g.e.;
A. o anumită stare patologică
poate determina dispnee în
circumstanțe diferite prin meca-
nisme diferite;
B. afeerente implicate în produ-
cerea senzației de dispnee
constau în impulsurile senzoriale
venite de la receptorii din tot
corpul;
C. dacă afeerente și eferențe nu
se potrivește, se generează un
semnal de eroare și intensitatea
dispneei scade;
D. receptorii vasculari pulmonari
sunt activați de modificări acute
ale presiunii din artera pulmo-
nară;
E. integrarea eferențelor și a
afeerentelor intervine în produ-
cerea senzației de dispnee
atunci când există concordanță
între eferențe și reaferențe;
693. R.I. mecanisme dispneei,
u.a.s.c.g.e.;
A. o anumită stare patologică
poate determina dispnee prin-
tul sau mai multe mecanisme;
B. descărcarea corolar trimisă de
cortexul motor către cortexul
senzorial conține informații
privitoare la afeerente primite de
la receptori;
C. chemoreceptorii sunt localizați
în mușchii periferici;
D. receptorii J și receptorii
vasculari pulmonari contribuie la
selea de aer;
E. anxietatea acută poate crește
severitatea dispneei prin
alterarea interpretării datelor
senzoriale;
694. R.I. mecanisme dispneei,
u.a.s.c.g.e.;

A. afeerente furnizează informații
cu privire la acțiunea pompei
ventilatorii;
B. obstrucționarea pompei venti-
latorii induce senzația de efort
respirator crescut;
C. când survine slăbirea/
oboseala mușchilor ventilatori,
eferențele motorii participă la
producerea dispneei;
D. stimularea chemoreceptorilor
produce o senzație de greutate
în respirație;
E. la pacienți cu flux expirator
reduc, scăderea frecvenței respi-
rației ca urmare a anxietății
duce la senzație de efort
respirator crescut;
699. R.I. mecanisme dispneei,
u.a.s.c.g.e.;
A. afeerentele se proiectează și
către regiunile din creier răspun-
zătoare pentru controlul ventilației;
B. obstrucționarea pompei venti-
latorii poate fi produsă de
creșterea complianței pulmo-
nare;
C. stimularea receptorilor care
determină creșterea ventilației
produce o senzație de sete de
aer;
D. metaboreceptorii sunt localizați
în artere;
E. la pacienți cu flux expirator
reduc, creșterea frecvenței respi-
rației ca urmare a anxietății
duce la senzația de respirație
insuficientă;
700. U.f.d.f.d. mecanisme
dispneei s.c.f.g.e.;
A. Senzația de respirație;
B. nesatisfăcătoare ar putea;
C. avea originea în receptorii din;
D. bronhiile ori din peretele toracic;
E. sau ar putea fi o variantă a
senzației de sete de aer;
701. U.f.d.f.d. integrarea eferen-
țelor și a afeerentelor în producerea
senzației de dispnee s.c.f.g.e.;
A. Neconcordanța dintre mesajele
trimise la mușchii ventilatori și;
B. mesajele primite înapoi de la
receptorii care monitorizează
răspunsul pompei ventilatorii;
C. scade intensitatea dispneei,
mecanism;
D. important în special când există
un obstacol mecanic în funcțio-
narea pompei ventilatorii;
E. cum este cazul în stările
comatoase.

A. la producerea senzației de
dispnee participă eferențele
motorii, afeerentele senzoriale și
feul în care cele două sunt
integrate;
B. eferențele trimise de cortexul
motor includ o descărcare
corolar către mușchii ventilatori;
C. chemoreceptorii sunt activați
de hipoxemie;
D. când sunt stimulați prin bronho-
spasm, mecanoreceptorii din
plămâni determină o senzație de
sete de aer;
E. anxietatea acută ameliorează
dispneea prin bronhodilație
adrenergică;
695. R.I. mecanisme dispneei,
u.a.s.c.g.e.;
A. Anxietatea acută poate;
B. crește severitatea dispneei prin
generarea;
C. unor tulburări electrolitice;
D. care contracarează anomaliile
fiziolgice;
E. din sistemul respirator;
696. R.I. mecanisme dispneei,
u.a.s.c.g.e.;
A. afeerentele de la receptorii din
tot sistemul respirator se proiec-
tează direct în cortexul senzorial;
B. când pompa ventilatorie este
obstrucționată, la producerea
dispneei participă și eferențele
motorii;
C. chemoreceptorii sunt activați
de hipocapnie;
D. hiperinflația produce pacien-
tul senzația că nu poate să
respire suficient de adânc;
E. la pacienți cu flux expirator
reduc, creșterea frecvenței respi-
rației ca urmare a anxietății
ajută la diminuarea hiperinflației;
697. R.I. mecanisme dispneei,
u.a.s.c.g.e.;
A. informațiile afeerente contribuie
la experiențele senzoriale
primare calitative;
B. obstrucționarea pompei venti-
latorii scade travaliul respirator;
C. chemoreceptorii sunt activați
de alcaloză;
D. hiperinflația produce pacien-
tul senzația că respirația este
nesatisfăcătoare;
E. la pacienți cu flux expirator
reduc, creșterea frecvenței respi-
rației ca urmare a anxietății
reduc travaliul respirator;
698. R.I. mecanisme dispneei,
u.a.s.c.g.e.;

Prescurtări frecvent folosite: c.g. = cu excepție, s.u.c.g. = sunt următoarele, cu excepție; u.a.s.c.g.e. = următoarele afirmații sunt
corecte, cu excepție, s.c.f.g.e. = sunt corect formulate, cu excepție,

702. U.f.d.f.d. descărcările corolar
s.c.f.g.e.;
A. Când o comandă motorie
inițiază o descărcare electrică
spre un organ, sunt trimise;
B. simultan semnale (descărcările
corolar) către aria motorie a
cortexului, prin care sunt;
C. transmise informații importante
care servesc drept mecanisme
de retroacțiune ajutând la;
D. automonitoare, astfel încât
să poată fi produse corect
secrețiile motorii coordonate;
E. aceste descărcări corolar
ajutând la deosebita impul-
surilor autogenerate (interne) de
răspunsurile motorii externe;
703. Afeerente senzoriale implicate
în producerea dispneei includ
informațiile venite de la u. tipuri de
receptori, s.g.e.;
A. chemoreceptorii;
B. mecanoreceptorii;
C. receptorii K;
D. receptorii vasculari pulmonari;
E. metaboreceptorii;
704. În mod caracteristic, IC poate
determina u.g.e.;
A. dispnee, ortopnee, dispnee
paroxistică nocturnă;
B. oboseală, slăbiciune, astenie;
C. respirație Küssmaul;
D. simptome abdominale;
E. simptome neuropsihice;
705. R.I. dispneea din IC,
u.a.s.c.g.e.;
A. în IC, dispneea este cel mai
frecvent simptom;
B. principală diferență față de
dispneea oamenilor sănătoși
constă în asocierea cu durere
precordială;
C. nivelul de efort la care apare
dispneea este folosit în
cuantificarea IC;
D. în formele ușoare-medii de IC,
dispneea apare numai la efort;
E. IC este cuantificat drept clasa
4 dacă dispneea apare în
repaus;
706. R.I. dispneea din IC,
u.a.s.c.g.e.;
A. în IC, dispneea are un tipar
diferit de cel din astmul bronșic
necomplicat;
B. în evaluarea nivelului de efort
la care apare dispneea trebuie
făcut cont de antrenamentul
anterior al pacientului;

C. IC este considerată a fi de
clasa 1/2/3 după cum dispneea
apare la efort mare/ mediu/ mic;
D. dispneea de efort reprezintă
doar o accentuare a fenomenului
care apare, în mod fiziologic, la
orice om efectuând un efort
suficient de mare;
E. în formele severe de IC,
dispneea dispare în repaus;
707. F.d.u. evenimente implicate
în patogeniza dispneei cardiace:
a. crește travaliul mușchilor
respiratori;
b. edem pulmonar interstițial;
c. crește presiunea în capilarele
pulmonare;
d. crește presiunea în venele
pulmonare;
A. ortopnee reprezintă dispneea
care apare în poziție culcată
(dispnee de decubit);
B. ortopnee este un simptom
care apare, în evoluția IC, mai
devreme decât dispneea de
efort;
C. pacientul este obligat să
doarmă pe mai multe perne;
D. în timpul nopții, când se ridică
pe perne, pacientul se trezește
cu dispnee și/sau tuse (tusea
nocturnă a cardiocului);
E. cu timpul, pacientul tolerează
mai bine cîștatismul;
712. R.I. mecanismul dispneei de
decubit din IC, u.a.s.c.g.e.;
A. dispneea se datorază redis-
tribuirii sîngelui din teritoriile
inferioare spre torace;
B. dispneea se asociază cu creș-
terea cantității de sînge din
torace;
C. diafragma este împinsă spre
abdomen;
D. în ortostatism dispneea se
ameliorează;
E. în IC de lungă durată, simp-
tomele determinate de congestia
pulmonară tind să crească în
intensitate;
713. R.I. mecanismul dispneei de
decubit din IC, u.a.s.c.g.e.;
A. dispneea se datorază redis-
tribuirii lichidului interstițial din
torace în abdomen;
B. crește p.h. din capilarele
pulmonare;
C. în ortostatism cresc întorco-
rea venoasă și presiunea din
capilarele pulmonare;
D. mulți pacienți afirmă că
dispneea li se ameliorează dacă
stau în fața ferestrei deschise;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele, s.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, f.i. =
referitor/referitoare la; U.f.d.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază despre;

- E. pe măsură ce funcția VD se deteriorează, simptomele determinate de congestia pulmonară se agravează.
714. R.I. dispneea paroxistică nocturnă (DPN) a cardiului, u.a.s.c.g.e.
- A. DPN constă în crize severe de dispnee și tuse care survin noaptea.
- B. în formele severe, DPN poate să fie însoțită de respirație șuierătoare.
- C. DPN asociată cu respirație șuierătoare este denumită asim bronșic.
- D. nu există o deosebire fundamentală între ortopnee și DPN.
- E. hipoxemia nocturnă apare mai ales la pacienți cu edem pulmonar interstițial marcat.
715. R.I. dispneea paroxistică nocturnă (DPN) a cardiului, u.a.s.c.g.e.
- A. criza de dispnee trezește pacientul din somn.
- B. este probabil că respirația șuierătoare este provocată de bronhospasm.
- C. congestia bronhopulmonară explică dispneea, tusea și respirația șuierătoare.
- D. durata decubului nocturn până la apariția crizei de DPN poate fi folosită pentru a estima gravitatea IC.
- E. hipoxemia nocturnă apare mai ales când complicitatea pulmonară este mult scăzută.
716. R.I. dispneea paroxistică nocturnă a cardiului, u.a.s.c.g.e.
- A. criza de dispnee poate genera anxietate.
- B. respirația șuierătoare este probabil consecința îngustării lumenului bronșic prin edemul inflamator din pereții bronșici.
- C. simptomele persistă pentru un timp după ce pacientul se ridică în șezut.
- D. creșterea ventilației prin depresiunea nocturnă a centrului respirator din timpul somnului poate fi suficientă pentru a determina hipoxemie.
- E. funcția ventriculară poate să fie deprimată noaptea prin reducerea stimulării colinergice a funcției miocardice.
717. R.I. dispneea cardiacă, I.d. cele două forme caracteristice:

2. dispneea paroxistică nocturnă; și următoarele trăsături:
- a. dispneea este absentă cât timp pacientul stă în șezut (mai ales cu piciorarele atârnând la marginea patului);
- b. survine la pacientul treaz;
- c. survine în timpul nopții;
- d. se acumulează o cantitate mai mică de apă în interstițiul pulmonar;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-1, c-2, d-2;
- B. a-1, b-2, c-1, d-2;
- C. a-2, b-1, c-1, d-2;
- D. a-2, b-1, c-2, d-1;
- E. a-2, b-2, c-1, d-1;
718. R.I. dispneea cardiacă, I.d. cele două forme caracteristice:
1. ortopnee;
2. dispneea paroxistică nocturnă; și următoarele trăsături:
- a. se manifestă în timpul zilei;
- b. se acumulează o cantitate mai mare de apă în interstițiul pulmonar;
- c. criza de dispnee este prelungită;
- d. este precedată de o perioadă de abolire a conștiinței;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-1, c-2, d-2;
- B. a-1, b-2, c-1, d-2;
- C. a-1, b-2, c-2, d-1;
- D. a-2, b-1, c-1, d-2;
- E. a-2, b-1, c-2, d-1;
719. F.d.u. evenimente legate de dispneea paroxistică nocturnă:
- a. criza de dispnee durează mult timp după ridicarea în șezut;
- b. abolirea conștiinței din timpul nopții;
- c. acumularea unei cantități mari de apă în interstițiul pulmonar, care este înălțimea logică justă;
- A. a-b-c;
- B. b-a-c;
- C. b-c-a;
- D. c-a-b;
- E. c-b-a.
720. R.I. edemul pulmonar acut (EPA), u.a.s.c.g.e.
- A. EPA este o formă severă de asim cardiac;
- B. EPA se manifestă prin dispnee extremă;
- C. raturile apar întâi la vârfuri și progresează ulterior spre baze;
- D. EPA se distinge prin apariția edemului interstițial.

- E. fluidul transsudat în alveole este expectorabil ca spuță sero-hemoragică.
721. R.I. EPA, u.a.s.c.g.e.
- A. EPA este provocat de creșterea accentuată a presiunii în capilarele pulmonare;
- B. EPA se asociază cu raluri unilaterale;
- C. ralurile coboară pe măsură ce situația se agravează;
- D. edemul alveolar constă în transsudarea în alveole a unui fluid mucopurulent;
- E. EPA este letal dacă nu este tratat prompt.
722. R.I. ralurile provocate de IVS, u.a.s.c.g.e.
- A. sunt raluri umede;
- B. corespund termenului românesc (probabil cel mai adesea incorect) de „subcrepitanțe de stază”;
- C. ralurile de stază apar în forme mai severe de IVS decât ralurile alveolare;
- D. cea mai mare parte a sângelui venit la bronhi prin arterele bronșice este drenat prin venele bronșice;
- E. se aud cel mai bine în expirație;
723. R.I. ralurile provocate de IVS, u.a.s.c.g.e.
- A. de regulă, au intensitate mare;
- B. denunțarea corectă este „raluri de stază”;
- C. ralurile alveolare apar în formele ușoare de IVS;
- D. sunt generate cel mai adesea prin desîntrerea spațiului pleural;
- E. sunt frecvente când crește presiunea din venele și capilarele pulmonare;
724. R.I. ralurile provocate de IVS, u.a.s.c.g.e.
- A. au sonoritate de ronflante;
- B. originea lor este în bronhiile mari;
- C. de regulă, se auscultă la vârfurile câmpurilor pulmonare;
- D. cea mai mare parte a capilarelor bronșice drenează în AD;
- E. lipsesc în unele cazuri de IC de lungă durată datorită scăderii drenajului limfatic al lichidului alveolar.
725. R.I. ralurile provocate de IVS, u.a.s.c.g.e.
- A. sunt denumite „crackles” sau „rales” în textele anglofone;

- B. cel mai adesea, sunt generate prin barbotarea aerului prin lichidul transsudat în lumenul bronhiilor medii și mici;
- C. învechit, sunt însoțite de hiper sonoritate la percucia bazelor pulmonare;
- D. raluri similare pot să apară în multe alte afecțiuni (nu doar în IVS);
- E. denunțarea de „subcrepitanțe de stază” este cel mai adesea incorectă;
726. Referitor la ralurile provocate de IVS, fiind date următoarele cauze:
1. pereții alveolari este mult mai subțiri decât cel bronșic;
2. cea mai mare parte a sângelui venit la bronhi este drenat prin venele pulmonare;
3. crește drenajul limfatic al lichidului alveolar;
- și următoarele consecințe:
- a. ralurile din IVS pot avea originea în bronhi;
- b. este puțin probabil ca lichidul să transsudeze în bronhi înainte de a transsuda în alveole;
- c. în unele cazuri de IC de lungă durată lipsesc ralurile;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
- B. a-1, b-3, c-2;
- C. a-2, b-1, c-3;
- D. a-3, b-1, c-2;
- E. a-3, b-2, c-1;
727. U.d.f.d. ralurile provocate de IVS a.c.g.e.
- A. La producerea ralurilor din IVS, B. ar putea contribui și dilatarea căilor respiratorii mici prin:
- C. distensia venelor, capilarelor;
- D. și a interstițiului pulmonar;
- E. (compelte) pentru spațiul în cadrul cavității toracice).
728. F.d.u. evenimente care explică apariția ralurilor bronșice în IVS:
- a. creșterea presiunii din capilarele bronșice (majoritatea drenând în AS);
- b. transsudarea de lichid în lumenul bronhiilor;
- c. creșterea presiunii din AS;
- d. barbotarea aerului prin lichidul din lumenul bronșic;
- e. subcrepitanțe de stază;
- care este lanțul cauzal corect:
- A. a-e-b-d-c;
- B. b-a-e-c-d;
- C. c-a-b-d-e;

- D. d-b-c-a-e;
- E. e-c-b-d-a;
729. R.I. localizarea ralurilor de stază în IC, u.a.s.c.g.e.
- A. în general, ralurile se auscultă în zonele cele mai declive, care variază în funcție de poziția pacientului;
- B. ținând cont de poziția predominantă a pacientului cardiac, ralurile se auscultă de regulă bilateral, simetric, la vârfurile plămânilor;
- C. dacă pacientul stă cu trunchiul ridicat, ralurile se auscultă la bazele câmpurilor pulmonare;
- D. la pacientul în decubit dorsal ralurile se auscultă pe înfraga lungime a marginilor laterale ale spatelui;
- E. la pacientul în decubit lateral ralurile se aud la plămâni decub;
730. R.I. ralurile din edemul pulmonar acut, u.a.s.c.g.e.
- A. ralurile se auscultă pe o suprafață mare;
- B. supratăia pe care pot fi auscultate ralurile se extinde progresiv (de la baze către vârfuri), pe măsură ce starea pacientului se ameliorează;
- C. pe lângă ralurile umede medii-fine, se auscultă adesea și raluri umede groase;
- D. adesea se aud și raluri uscate;
- E. frecvent, inspirația devine șuierătoare;
731. R.I. manifestările clinice ale cordului pulmonar cronic (CPC) determinat de boala vasculară pulmonară (BVP), u.a.s.c.g.e.:
- A. dispneea, și tahipneea sunt caracteristice pentru HTAP determinată de BVP;
- B. dispneea și tahipneea pot să apară chiar și în repaus;
- C. durerea toracică anterioară poate fi determinată de dilatația acută a rădăcinii aortei;
- D. tusea este absentă;
- E. creșterea presiunii venoase sistolice poate determina edeme gembere;
732. R.I. manifestările clinice ale CPC determinat de boala vasculară pulmonară, u.a.s.c.g.e.:
- A. dispneea și tahipneea pot să apară la efort mic;
- B. dispneea și tahipneea nu sunt ameliorate în șezut;

- C. tusea este însoțită de expectorație abundentă;
- D. durerea toracică anterioară poate fi determinată de ischemia VD;
- E. creșterea presiunii venoase sistolice poate determina hepatomegalie;
733. R.I. diagnosticul diferențial al dispneei, u.a.s.c.g.e.:
- A. bolile parenchimatice pulmonare difuze pot avea evoluție acută sau cronică;
- B. prezența unei anomalii a pereților toracici poate fi de obicei decelată prin examen fizic;
- C. ortopneea este consecința acțiunii forțelor gravitaționale când pacientul se află în decubit;
- D. dispneea nocturnă este patognomonică pentru IVS;
- E. diagnosticul de dispnee cardiacă se bazează pe recunoașterea bolii cardiace;
- F. EcoCG transitorică este foarte utilă în stabilirea diagnosticului de boală cardiacă organică;
734. R.I. diagnosticul diferențial al dispneei, u.a.s.c.g.e.:
- A. în bolile parenchimatice pulmonare difuze istoricul, semnele fizice și anomalii radiologice furnizează adesea indicii despre diagnostic;
- B. ortopneea reprezintă dispneea agravată de ortostatism;
- C. dispneea apare mai precoce în evoluția unei valvulopatii aortice decât mitrală;
- D. dispneea nocturnă poate să apară și în boli respiratorii (precum bronșita cronică și astmul bronșic), care trebuie diferențiate de IVS;
- E. identificarea eventualei boli cardiace se bazează pe istoric și examen clinic, la care se adaugă investigațiile neinvazive;
735. R.I. cauzele obstrucției căilor respiratorii mari extratoracice, I.d.u. categorii:
1. acute;
2. cronice;
- și următoarele cauze:
- a. tumor;
- b. angioedem glosic;
- c. stenoză fibrotică după traheostomie sau intubație endotraheală prelungită;
- d. aspirație de corpi străini (alimente etc.);

Prescurtări frecvent folosite: S.G. = cu excepția; S.G.C. = sunt următoarele; cu excepția, u.a.s.c.g.e. = următoarele afirmări sunt corecte; cu excepția; S.C.C.G.E. = sunt corecte formulare, cu excepția.

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; I.d. = fiind date; I.d.u. = fiind date următoarele; I. = referitor/referitoare la; U.d.f.d. = Următoarele fraze sunt adevărate sau false.

753. R.I. obstrucția căilor respi-
ratorii, u.a.s.c.g.e.:
A. obstrucția fluxului de aer se poate produce oriunde, de la căile respiratorii extratoracice până la cele mici de la periferia plămânilor;
B. un semn caracteristic pentru obstrucția căilor respiratorii extratoracice mai este respirația șuierătoare („wheezing”);
C. refracția foselor supraclaviculare la expirație este un semn caracteristic pentru obstrucția căilor respiratorii extratoracice mari;
D. în obstrucția căilor respiratorii extratoracice mari, simptomul cardinal este tusea;
E. obstrucția acută a căilor respiratorii extratoracice mari reprezintă o urgență medicală.
754. La un pacient cu obstrucție bronșică cronică, infecție intercurrentă determină în mod caracteristic u. manifest., c.g.e.:
A. agravarea tusei;
B. reducerea expectorației;
C. transformarea purulente a expectației;
D. agravarea dispneei;
E. paroxisme nocturne de dispnee cu respirație șuierătoare agravată de tuse și de eliminarea sputei.
755. O frază r.l. bolii obstructive ale căilor respiratorii intratoracice constă din trei sintagme – f.d.u. începând de la sintagme:
1. deși o caracteristică a acestor boli o constituie;
2. senzația pe care o are pacientul constă adesea în;
3. mai degrabă decât;
și u. sfârșit din sintagme:
a. limitarea severă a fluxului expirator asociată cu hiperinflația pulmonară;
b. incapacitatea de a trage suficient aer în piept;
c. dificultatea în eliminarea aerului din piept;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1.
756. U.f.d.f.d. cauzele dispneei cardiace s.c.f.g.e.:
A. La pacienții cu boală cardiacă dispneea de efort apare cel mai:
- B. adesea drept consecință a creșterii presiunii arteriale pulmonare, cauzate:
(insuficiență de pompă);
C. de distincția VS sistolică (insuficiență de pompă);
D. de distincția VS diastolică (complananță VS redusă);
E. sau de boala aortică.
757. F.d.u. evenimentele care contribuie la producerea dispneei din VS:
a. creșterea efortului de respirație;
b. dispnee;
c. scăderea complanității plămânilor;
d. creșterea acută a p.h. din patul vascular pulmonar (vene capilare);
e. transsudarea de lichid în spațiul interstițial;
- care este lanțul cauzal corect:
A. c→a→b→d→e;
B. d→b→c→a→e;
C. d→e→a→b→c;
D. d→e→c→a→b;
E. e→a→c→d→b;
758. F.d.u. evenimentele care contribuie la producerea dispneei din VS:
a. transsudarea de lichid în spațiul interstițial;
b. stimularea receptorilor juxtacapilari din spațiul interstițial alveolar;
c. senzație de dispnee;
d. creșterea p.h. din patul vascular pulmonar;
care este lanțul cauzal corect:
A. a→c→b→d;
B. b→a→c→d;
C. c→a→b→d;
D. d→a→b→c;
E. d→b→a→c;
759. U.f.d.f.d. explicarea dispneei provocate de VS s.c.f.g.e.:
A. Creșterea acută a p.h. din patul vascular pulmonar (vene și artere în capilare) duce;
C. în timp la subțierea pereților vaselor pulmonare mici;
D. și la proliferarea celulelor și a țesutului muscular perivascular;
E. pentru ca pereții vaselor să poată rezista la presiunea crescută cronic.
760. F.d.u. evenimentele care contribuie la producerea dispneei din VS:
a. dispnee;
- b. reducerea suplimentară a complanității parenchimului pulmonar;
c. crește efortul de respirație;
d. îngroșarea pereților vaselor pulmonare mici și proliferarea celulelor și a țesutului fibros perivascular;
e. creșterea cronică a p.h. din patul vascular pulmonar;
care este lanțul cauzal corect:
A. b→c→d→e→a;
B. c→e→d→b→a;
C. d→b→e→c→a;
D. e→c→b→d→a;
E. e→d→b→c→a;
761. F.d.u. evenimentele care contribuie la producerea dispneei din VS:
a. dispnee;
b. comprimarea căilor respiratorii mici;
c. expansiunea spațiului interstițial și a celui vascular (vene și mai ales capilare) în volumul limitat al cavității toracice;
d. creșterea efortului de respirație;
e. creșterea rezistenței căilor respiratorii mici;
care este lanțul cauzal corect:
A. b→c→d→e→a;
B. c→b→e→d→a;
C. c→e→d→b→a;
D. d→c→e→b→a;
E. e→d→b→c→a;
762. F.d.u. evenimentele care contribuie la producerea dispneei din VS:
a. reducerea lumenului căilor respiratorii mici;
b. creșterea volumului de închidere pulmonar;
c. creșterea efortului de respirație;
d. distensia interstițiului (prin lichidul transsudat), a venelor și a capilarelor pulmonare în cadrul cavității toracice;
e. dispnee;
care este lanțul cauzal corect:
A. a→b→c→d→e;
B. b→d→c→a→e;
C. c→b→d→a→e;
D. c→d→a→b→e;
E. d→a→b→c→e;
763. F.d.u. evenimentele care contribuie la producerea dispneei din IC congestivă avansată:
a. crește presiunea în venele intercostale (vene sistematice)

Prescurtări frecvent folosite: c.g.e. = cu excepția, s.c.f.g.e. = sunt următoarele, cu excepția, u.a.s.c.g.e. = următoarele afirmări sunt corecte, cu excepția, s.c.f.g.e. = sunt corect formulate, cu excepția.

- care denează pleura parietală și în venele pulmonare care denează pleura viscerală;
b. crește transsudarea de lichid în spațiul pleural;
c. crește presiunea venoasă atât pulmonară, cât și sistemică;
d. comprimă extrinsecă a plămânilor;
e. hidrotorace;
f. agravarea dispneei și afectarea suplimentară a funcției pulmonare;
care este lanțul cauzal corect:
A. a→d→f→b→e→c;
B. b→c→e→a→f→d;
C. c→a→b→e→d→f;
D. e→c→a→b→f→d;
E. e→f→b→a→c→d;
764. F.d.u. evenimentele care explică agravarea în decubit a dispneei din VS (inducând ortopneea):
a. creșterea volumului de închidere pulmonar;
b. comprimarea a căilor respiratorii mici;
c. scăderea capacității vitale;
d. distensia interstițiului, venelor și capilarelor pulmonare în cadrul cavității toracice;
e. crește suplimentar presiunea venoasă și capilară pulmonară;
f. sângene din abdomen și din membrele inferioare se redistribuie către torace;
care este lanțul cauzal corect:
A. a→e→d→c→f→b;
B. b→f→e→a→c→d;
C. d→f→a→e→c→b;
D. e→d→a→f→b→c;
E. f→e→d→b→a→c;
765. R.I. dispneea paroxistică nocturnă (DPN), u.a.s.c.g.e.:
A. DPN este numită și astm cardiac;
B. crizele apar noaptea, trezind pacientul din somn;
C. volumul total de sânge din torace scade noaptea;
D. când doarme, pacientul poate tolera o congestie pulmonară relativ severă;
E. pacientul se trezește cu senzație de sufocare;
766. R.I. dispneea paroxistică nocturnă (DPN), u.a.s.c.g.e.:
A. DPN constă în crize de dispnee severe;
B. crizele sunt precipitate de stimuli care agravează congestia pulmonară preexistentă;
- C. în timpul decubitului nocturn, se resimte parțial edemul din țesuturile declive în timpul zilei;
D. pacientul se trezește doar când se acumulează secrețiile bronșice;
E. pacientul se trezește cu respirație șuierătoare;
767. F.d.u. evenimentele legate de dispneea nocturnă din bronșita cronică:
a. dispnee și respirație șuierătoare, ambele ameliorate de tuse și de eliminarea sputei;
b. hipersecreție de mucus (inclusiv noaptea);
c. obstrucția bronșică se accentuează;
d. mecanismele normale de eliminare – mișcarea cililor și tusea – sunt deprimate în cursul nopții;
e. după mai multe ore de somn, secrețiile se acumulează;
care este lanțul cauzal corect:
A. a→c→e→b→d;
B. b→d→c→a→e;
C. b→d→e→c→a;
D. c→d→e→b→a;
E. e→a→d→b→c;
768. R.I. crizele de dispnee nocturnă din astm bronșic, u.a.s.c.g.e.:
A. crizele sunt legate de variațiile circadiane ale gradului de obstrucție bronșică;
B. agravante nocturne se produc mai ales între orele 22.00-00.00;
C. accentuarea nocturnă a obstrucției bronșice este uneori suficient de severă pentru a trezi pacientul;
D. pacientul se trezește cu senzație de sufocare (dispnee extremă);
E. pacientul se trezește cu respirație șuierătoare;
F. crizele nocturne de astm nu au componentă inflamatorie;
G. în cele mai multe cazuri, inhalarea de bronhodilatatoare nu ameliorază simptomele;
769. Elemente sugestive pentru diagnosticul de dispnee cardiacă, s.u.g.e.:
A. istoric de infarct miocardic;
B. galoapuri (protodiastolic sau presistolice);
C. semne de dilatare a ventriculului stâng;
D. tuse cu expectorație muco-purulentă;
E. edem periferic;
F. semne radiologice de IC;
770. C.d.u. NU este un semn radiologic de insuficiență cardiacă:
A. edem pulmonar interstițial;
B. redistribuie a vascularizației pulmonare;
C. acumulare de lichid în septurile interalveolare;
D. acumulare de lichid în cavitățile pleurale;
E. creșterea transparenței pulmonare;
771. Elemente ecocardiografice care susțin etiologia cardiacă a dispneei s.u.g.e.:
A. dilatarea AD;
B. dilatarea VS;
C. hipertonfia VS;
D. scăderea fracției de ejecție a VS;
E. turburanțe de cinetică parietală a VS;
772. R.I. diferențierea dintre dispneea cardiacă și cea pulmonară, f.d.u. începând de la frază:
1. alai dispneea cardiacă, cât și dispneea din BPOC;
2. dispneea din BPOC;
3. dispneea cardiacă;
și următoarele sfârșit de frază:
a. se ameliorază după eliminarea secrețiilor;
b. se asociază cu producție de spută;
c. pot poate trezi pacientul noaptea din somn;
d. se ameliorază de ridicarea trunchiului la verticală;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-2, d-3;
B. a-1, b-3, c-2, d-2;
C. a-2, b-1, c-3, d-2;
D. a-2, b-2, c-1, d-3;
E. a-3, b-2, c-2, d-1;
773. R.I. deosebirea dispneei cardiace de cea respiratorie, u.a.s.c.g.e.:
A. la cei mai mulți pacienți cu dispnee există semne clinice evidente de boală cardiacă și/sau pulmonară;
B. PNU poate fi crescut și așteptunle respiratorii, mai ales în absența CPC;
C. testele funcționale pulmonare pot fi utile în a decela originea dispneei la pacienții la care etiologia dispneei nu este clară;
D. determinarea FE în repaus și în timpul efortului se poate face prin Eco sau prin TC;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele, c.d.u. = care dintre următoarele, f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, r.l. = referitor/referențiar la, U.f.d.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază despre.

asocierea hiperventilației cu tulburare în piept și modificări ECG poate produce confuzii cu boala coronariană; când dispneea psihogenă este asociată de modificări ECG, acestea constau cel mai adesea în inversarea undei T; respirația ofiată și respirația iregulară indică originea psihogenă a dispneei; prezența depresiilor și/sau a anxietății reduce severitatea dispneei resimțită de un pacient cardiac sau respirator; U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U19, U20, U21, U22, U23, U24, U25, U26, U27, U28, U29, U30, U31, U32, U33, U34, U35, U36, U37, U38, U39, U40, U41, U42, U43, U44, U45, U46, U47, U48, U49, U50, U51, U52, U53, U54, U55, U56, U57, U58, U59, U60, U61, U62, U63, U64, U65, U66, U67, U68, U69, U70, U71, U72, U73, U74, U75, U76, U77, U78, U79, U80, U81, U82, U83, U84, U85, U86, U87, U88, U89, U90, U91, U92, U93, U94, U95, U96, U97, U98, U99, U100, U101, U102, U103, U104, U105, U106, U107, U108, U109, U110, U111, U112, U113, U114, U115, U116, U117, U118, U119, U120, U121, U122, U123, U124, U125, U126, U127, U128, U129, U130, U131, U132, U133, U134, U135, U136, U137, U138, U139, U140, U141, U142, U143, U144, U145, U146, U147, U148, U149, U150, U151, U152, U153, U154, U155, U156, U157, U158, U159, U160, U161, U162, U163, U164, U165, U166, U167, U168, U169, U170, U171, U172, U173, U174, U175, U176, U177, U178, U179, U180, U181, U182, U183, U184, U185, U186, U187, U188, U189, U190, U191, U192, U193, U194, U195, U196, U197, U198, U199, U200, U201, U202, U203, U204, U205, U206, U207, U208, U209, U210, U211, U212, U213, U214, U215, U216, U217, U218, U219, U220, U221, U222, U223, U224, U225, U226, U227, U228, U229, U230, U231, U232, U233, U234, U235, U236, U237, U238, U239, U240, U241, U242, U243, U244, U245, U246, U247, U248, U249, U250, U251, U252, U253, U254, U255, U256, U257, U258, U259, U260, U261, U262, U263, U264, U265, U266, U267, U268, U269, U270, U271, U272, U273, U274, U275, U276, U277, U278, U279, U280, U281, U282, U283, U284, U285, U286, U287, U288, U289, U290, U291, U292, U293, U294, U295, U296, U297, U298, U299, U300, U301, U302, U303, U304, U305, U306, U307, U308, U309, U310, U311, U312, U313, U314, U315, U316, U317, U318, U319, U320, U321, U322, U323, U324, U325, U326, U327, U328, U329, U330, U331, U332, U333, U334, U335, U336, U337, U338, U339, U340, U341, U342, U343, U344, U345, U346, U347, U348, U349, U350, U351, U352, U353, U354, U355, U356, U357, U358, U359, U360, U361, U362, U363, U364, U365, U366, U367, U368, U369, U370, U371, U372, U373, U374, U375, U376, U377, U378, U379, U380, U381, U382, U383, U384, U385, U386, U387, U388, U389, U390, U391, U392, U393, U394, U395, U396, U397, U398, U399, U400, U401, U402, U403, U404, U405, U406, U407, U408, U409, U410, U411, U412, U413, U414, U415, U416, U417, U418, U419, U420, U421, U422, U423, U424, U425, U426, U427, U428, U429, U430, U431, U432, U433, U434, U435, U436, U437, U438, U439, U440, U441, U442, U443, U444, U445, U446, U447, U448, U449, U450, U451, U452, U453, U454, U455, U456, U457, U458, U459, U460, U461, U462, U463, U464, U465, U466, U467, U468, U469, U470, U471, U472, U473, U474, U475, U476, U477, U478, U479, U480, U481, U482, U483, U484, U485, U486, U487, U488, U489, U490, U491, U492, U493, U494, U495, U496, U497, U498, U499, U500, U501, U502, U503, U504, U505, U506, U507, U508, U509, U510, U511, U512, U513, U514, U515, U516, U517, U518, U519, U520, U521, U522, U523, U524, U525, U526, U527, U528, U529, U530, U531, U532, U533, U534, U535, U536, U537, U538, U539, U540, U541, U542, U543, U544, U545, U546, U547, U548, U549, U550, U551, U552, U553, U554, U555, U556, U557, U558, U559, U560, U561, U562, U563, U564, U565, U566, U567, U568, U569, U570, U571, U572, U573, U574, U575, U576, U577, U578, U579, U580, U581, U582, U583, U584, U585, U586, U587, U588, U589, U590, U591, U592, U593, U594, U595, U596, U597, U598, U599, U600, U601, U602, U603, U604, U605, U606, U607, U608, U609, U610, U611, U612, U613, U614, U615, U616, U617, U618, U619, U620, U621, U622, U623, U624, U625, U626, U627, U628, U629, U630, U631, U632, U633, U634, U635, U636, U637, U638, U639, U640, U641, U642, U643, U644, U645, U646, U647, U648, U649, U650, U651, U652, U653, U654, U655, U656, U657, U658, U659, U660, U661, U662, U663, U664, U665, U666, U667, U668, U669, U670, U671, U672, U673, U674, U675, U676, U677, U678, U679, U680, U681, U682, U683, U684, U685, U686, U687, U688, U689, U690, U691, U692, U693, U694, U695, U696, U697, U698, U699, U700, U701, U702, U703, U704, U705, U706, U707, U708, U709, U710, U711, U712, U713, U714, U715, U716, U717, U718, U719, U720, U721, U722, U723, U724, U725, U726, U727, U728, U729, U730, U731, U732, U733, U734, U735, U736, U737, U738, U739, U740, U741, U742, U743, U744, U745, U746, U747, U748, U749, U750, U751, U752, U753, U754, U755, U756, U757, U758, U759, U760, U761, U762, U763, U764, U765, U766, U767, U768, U769, U770, U771, U772, U773, U774, U775, U776, U777, U778, U779, U780, U781, U782, U783, U784, U785, U786, U787, U788, U789, U790, U791, U792, U793, U794, U795, U796, U797, U798, U799, U800, U801, U802, U803, U804, U805, U806, U807, U808, U809, U810,
--

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date, i.d.u. = fiind date următoarele, i.l. = referitor/referitoare la; U.i.d.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază despre:

- 793. F.d.u. evenimentele care contribuie la producerea hipoxemiei din emfizem:**
 a. scade timpul de tranziț prin capilarele alveolare (impuținate);
 b. efort;
 c. crește viteză sângelui;
 d. scade timpul disponibil pentru difuziunea prin MAC;
 e. oxigenare deficitară a sângelui; care este înălțimea temporală/cauzață corectă:
 A. a-2-d-e-c-b;
 B. b-c-a-d-e;
 C. c-d-e-a-b-a;
 D. d-c-a-b-e;
 E. e-a-c-a-b;
- 794. R.I. mecanismele care pot produce senzația că trebuie să depună prea mult efort pentru a respira (= dispnee), f.d.u. categorii:**
 1. creșterea activității/stimularea centrilor de control;
 2. creșterea discrepanței dintre rezistența care trebuie învinsă de pompa ventilatorie și performanța pompei ventilatorii; și următoarele mecanisme:
 a. stimularea receptorilor periferici (metabo- și chemorecepții) prin hipoxie tisulară periferică;
 b. stimularea receptorilor pulmonari;
 c. accentuarea hipoxemiei și/sau hipercapniei;
 d. creșterea rezistenței opuse pompei ventilatorii;
 e. scăderea performanței pompei ventilatorii;
 care sunt asocierile corecte:
 A. a-1-b-1, c-1, d-2, e-2;
 B. a-1, b-1, c-2, d-2, e-1;
 C. a-1, b-2, c-1, d-2, e-1;
 D. a-1, b-2, c-2, d-1, e-1;
 E. a-2, b-1, c-1, d-2, e-1;
- 795. R.I. accentuarea hipoxemiei și/sau hipercapniei drept mecanism al dispneei, f.d.u. stări/situații patologice:**
 1. BPOC;
 2. emfizem;
 3. pneumonie;
 a. următoarele mecanisme:
 a. hipoxemie prin alterarea schimbului de gaze;
 b. la producerea hipoxemiei contribuie și scăderea difuziunii prin MAC, dată fiind scăderea numărului de capilare alveolare;
- 796. R.I. accentuarea hipoxemiei și/sau hipercapniei drept mecanism al dispneei, f.d.u. stări/situații patologice:**
 1. astm sever;
 2. emfizem;
 3. edem pulmonar;
 a. următoarele mecanisme:
 a. hipoxemie prin alterarea schimbului de gaze;
 b. la producerea hipoxemiei contribuie oxigenarea deficitară a sângelui prin scăderea timpului de tranziț prin capilarele alveolare;
 c. hipoxemie și hipercapnie prin scăderea ventilației;
 care sunt asocierile corecte:
 A. a-1, b-2, c-3;
 B. a-2, b-1, c-3;
 C. a-2, b-3, c-1;
 D. a-2, b-3, c-1;
 E. a-3, b-2, c-1;
- 799. F.d.u. evenimentele care contribuie la producerea dispneei prin stimularea receptorilor pulmonari:**
 a. crește presiunea în interstițiul pulmonar;
 b. crește presiunea în AS;
 c. crește presiunea în capilarele alveolare;
 d. edem pulmonar interstițial cardogen;
 e. crește presiunea din venele pulmonare;
 care este lanțul cauzal corect:
 A. a-4-d-c-e-b;
 B. b-e-c-a-d;
 C. c-e-a-b-d;
 D. d-b-e-c-a;
 E. e-c-a-b-d;
- 797. R.I. accentuarea hipoxemiei și/sau hipercapniei drept mecanism al dispneei, f.d.u. stări/situații patologice:**
 1. BPOC;
 2. emfizem;
 3. aspirația conținutului digestiv, și următoarele mecanisme:
 a. la producerea hipoxemiei contribuie creșterea vitezei de tranziț a sângelui prin capilarele alveolare (impuținate);
 b. hipoxemie și hipercapnie prin discrepanța ventilație-perfuzie;
 c. hipoxemie prin alterarea schimbului de gaze;
 care sunt asocierile corecte:
 A. a-1, b-2, c-3;
 B. a-1, b-3, c-2;
 C. a-2, b-1, c-3;
 D. a-3, b-1, c-2;
 E. a-3, b-2, c-1;
- 798. R.I. accentuarea hipoxemiei și/sau hipercapniei drept mecanism al dispneei, f.d.u. stări/situații:**
 1. astm sever;
 2. emfizem;
 3. altitudine înaltă;
 și următoarele mecanisme:
 a. hipoxemie și hipercapnie prin discrepanța ventilație-perfuzie;
 b. la producerea hipoxemiei contribuie și scăderea difuziunii prin MAC, dată fiind scăderea numărului de capilare alveolare;

Prescurtări frecvent folosite: S.G. = cu excepție, s.u.S.G. = sunt următoarele, cu excepție, u.a.s.c.G.E. = următoarele afirmații sunt corecte, cu excepție, s.c.f.G.E. = sunt corect formulate, cu excepție.

- 1. dispnee prin boală cardiacă;**
 2. dispnee prin boală respiratorie;
 3. dispnee în absența unei boli cardiace sau respiratorii;
 și următoarele stări:
 a. lipsa de antrenament;
 b. valvulopatie;
 c. pneumonie interstițială;
 care sunt asocierile corecte:
 A. a-1, b-2, c-3;
 B. a-2, b-1, c-3;
 C. a-2, b-3, c-1;
 D. a-3, b-1, c-2;
 E. a-3, b-2, c-1;
- 803. R.I. diagnosticul diferențial al dispneei, f.d.u. categorii:**
 1. dispnee prin boală cardiacă;
 2. dispnee prin boală respiratorie;
 3. dispnee în absența unei boli cardiace sau respiratorii;
 a. pleurazie masivă;
 b. cardiomiopatie;
 c. obezitate;
 care sunt asocierile corecte:
 A. a-1, b-2, c-3;
 B. a-1, b-3, c-2;
 C. a-2, b-1, c-3;
 D. a-2, b-3, c-1;
 E. a-3, b-1, c-2;
- 804. U.I.f.d. perturbările gazelor sanguine din boala respiratorie s.c.f.G.E.:**
 A. în boala respiratorie, hipoxemia; B. apare mult mai rar decât hipercapnia intruși O₂ și CO₂; C. au modalități diferite de a se lega de hemoglobină;
 D. O₂ legându-se de catenele laterale aleinelui tetraprolic;
 E. iar CO₂ legându-se de atomii de azot aiinelui tetraprolic.
- 805. R.I. boala care intră în diagnosticul diferențial al dispneei, u.a.s.c.G.E.:**
 A. distoncia distolică poate produce dispnee de efort;
 B. în astm, senzația de constricție toracică și hiperventilația sunt provocate probabil de stimularea receptorilor pulmonari;
 C. toate bolile respiratorii, dacă sunt suficiente de grave, produc hipoxemie și/sau hipercapnie;
 D. șunturile intracardiacce stângă-spre-dreapta pot duce la debut cardiac crescut și la dispnee;
 E. receptorii pulmonari pot fi stimulați de bronhospasmul acut sau de reducerea presiunii în circulația pulmonară;
- 806. R.I. boala care intră în diagnosticul diferențial al dispneei, u.a.s.c.G.E.:**
 A. distoncia distolică explică dispneea cardiacă la pacienți cu funcție sistolică normală;
 B. majoritatea bolilor respiratorii se asociază cu alterarea presiunii mecanice ale pereților toracici și/sau ale plămânilor;
 C. în boala vaselor pulmonare, stimularea receptorilor pulmonari este consecința creșterii presiunii din artera pulmonară;
 D. în stadiile tardive, șunturile intracardiacce stângă-spre-dreapta pot fi complicate de instalarea HTAP;
 E. boala căilor respiratorii implică cel mai frecvent în producerea senzației de dispnee sunt bronșectaziile;
- 807. R.I. boala care intră în diagnosticul diferențial al dispneei, u.a.s.c.G.E.:**
 A. în astm, pacienții acuză senzație de constricție toracică și chiar și atunci când funcția pulmonară este în limite normale;
 B. alterarea proprietăților mecanice pulmonare sunt consecința leziunilor căilor respiratorii și/sau ale parenchimului pulmonar;
 C. în boala periferică crește presiunea intracardiacă și din vasele pulmonare;
 D. instalarea HTAP contribuie la producerea dispneei;
 E. în boala căilor respiratorii, obstrucția fluxului de aer este mai pregnantă în inspirație;
- 808. R.I. boala care intră în diagnosticul diferențial al dispneei, u.a.s.c.G.E.:**
 A. bronhospasmul acut este caracteristic pentru BPOC;
 B. perturbarea schimbului de gaze este unul dintre principalele două mecanisme prin care boala cardiovasculară produce dispnee;
 C. pericardita constictivă crește presiunea intracardiacă și din vasele pulmonare;
 D. stimularea receptorilor pulmonari produce hiperventilație și dispnee;
 E. senzația că trebuie să depună prea mult efort pentru a respira produce dispnee;
- 809. R.I. boala care intră în diagnosticul diferențial al dispneei, u.a.s.c.G.E.:**
 A. de obicei, pacienții cu bronhospasm acut hiperventilează;
 B. stimularea receptorilor pulmonari și/sau vasculari este unul dintre principalele două mecanisme prin care boala cardiovasculară produce dispnee;
 C. tamponada cardiacă scade presiunea intracardiacă și din vasele pulmonare;
 D. în obezitate, la producerea dispneei participă scăderea complicității pereților toracici și limitarea mișcării diafragmei prin grăsimi abdominale;
 E. scăderea performanței pompei ventilatorii face ca, subiectiv, pacientul să aibă senzația că efortul de a respira este prea mare;
- 810. R.I. producerea senzației de dispnee prin stimularea receptorilor pulmonari prin creșterea presiunii în circulația pulmonară și în interstițiul pulmonar, f.d.u. mecanisme:**
 1. creșterea directă a presiunii în circulația pulmonară;
 2. creșterea presiunii din circulația pulmonară ca urmare a creșterii PTDVD;
 și următoarele stări patologice:
 a. stenoză mitrală;
 b. insuficiență mitrală;
 c. insuficiență aortică;
 d. valvulopatii aortice;
 e. boala coronariană;
 care sunt asocierile corecte:
 A. a-1, b-1, c-2, d-2, e-2;
 B. a-1, b-2, c-1, d-2, e-2;
 C. a-1, b-2, c-2, d-1, e-2;
 D. a-2, b-1, c-1, d-2, e-2;
 E. a-2, b-2, c-2, d-1, e-1;
- 811. R.I. producerea senzației de dispnee prin stimularea receptorilor pulmonari, f.d.u. stări/situații patologice:**
 1. astm;
 2. edem pulmonar cardogen;
 3. lichid pleural în cantitate mare; și următoarele trăsături:
 a. ameliorarea hipoxemiei are un impact redus asupra intensității dispneei;
 b. bronhospasm acut;
 c. atelectazie prin compresie extrinsecă;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele; f.i. = referitor/referitoare la; U.I.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază dispne.

- D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;

817. R.I. producerea senzației de dispnee prin stimularea recepțiilor pulmonari prin creșterea presiunii în circulația pulmonară, f.d.u. mecanisme:

 1. creșterea PTDVS prin disfuncție sistolică;
 2. creșterea PTDVS prin disfuncție diastolică;
 3. creșterea presiunii în circulația pulmonară, dar fără edem pulmonar interstițial;

a. următoarele stări patologice:
b. afecțiunea sistemică a miocardului;

 - A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-1, c-2;

818. R.I. producerea senzației de dispnee prin stimularea recepțiilor pulmonari prin creșterea presiunii în circulația pulmonară, f.d.u. mecanisme:

 1. creșterea PTDVS prin disfuncție sistolică;
 2. creșterea PTDVS prin disfuncție diastolică;
 3. creșterea presiunii în circulația pulmonară, dar fără edem pulmonar interstițial;

a. HTAP primară;
b. insuficiența mitrală;
c. HTA;

care sunt asocierile corecte:

 - A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;

815. R.I. producerea senzației de dispnee prin stimularea recepțiilor pulmonari prin creșterea presiunii în circulația pulmonară, f.d.u. mecanisme:

 1. creșterea directă a presiunii din circulația pulmonară din cauza jetului de regurgitare;
 2. creșterea PTDVS prin disfuncție diastolică;
 3. creșterea presiunii în circulația pulmonară, dar fără edem pulmonar interstițial;

și următoarele stări patologice:

 - A. HTAP primară;
b. insuficiența mitrală;
c. HTA;

care sunt asocierile corecte:

 - A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;

816. R.I. producerea senzației de dispnee prin stimularea recepțiilor pulmonari prin creșterea presiunii în circulația pulmonară, f.d.u. mecanisme:

 1. creșterea PTDVS prin disfuncție sistolică;
 2. creșterea PTDVS prin disfuncție diastolică;
 3. creșterea presiunii în circulația pulmonară, dar fără edem pulmonar interstițial;

și următoarele stări patologice:

 - A. vasculită pulmonară;
b. stenoză aortică;
c. canalizate mare de sânge rămasă în VS la sfârșitul sistolei care sunt asocierile corecte:
 - A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;

814. R.I. producerea senzației de dispnee prin stimularea recepțiilor pulmonari prin creșterea presiunii în circulația pulmonară, f.d.u. mecanisme (PTDVS = presiunea telediastolică din VS):

 1. creșterea directă a presiunii din circulația pulmonară din cauza obstrucției valvulare;
 2. creșterea PTDVS prin disfuncție diastolică;
 3. creșterea presiunii în circulația pulmonară, dar fără edem pulmonar interstițial;

a. următoarele stări patologice:
b. afecțiunea sistemică a miocardului;

 - A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-1, c-2;

819. R.I. producerea senzației de dispnee prin stimularea recepțiilor pulmonari prin creșterea presiunii în circulația pulmonară, f.d.u. mecanisme:

 1. creșterea PTDVS prin disfuncție sistolică;
 2. creșterea presiunii în circulația pulmonară (dar fără edem pulmonar interstițial) asociată cu scăderea debitului cardiac;

3. creșterea presiunii în circulația pulmonară (dar fără edem pulmonar interstițial) prin creșterea debitului cardiac; și următoarele stări patologice:
- a. boală coronariană;
 - b. obezitate;
 - c. tamponadă cardiacă;
- care sunt asociilele corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
 - B. a-1, b-3, c-2;
 - C. a-2, b-3, c-1;
 - D. a-3, b-1, c-2;
 - E. a-3, b-2, c-1;
820. R.I. producerea senzației de dispnee prin creșterea activității centrilor de control consecutivă stimulării receptorilor periferici prin hipoxie tisulară periferică, f.d.u.
- a. boală pericardică;
 - b. insuficiență sistolică;
 - c. deconștrinderea cardiovasculară;
- și următoarele trăsături:
- A. a-1, b-3, c-2;
 - B. a-1, b-3, c-2;
 - C. a-2, b-1, c-3;
 - D. a-3, b-1, c-2;
 - E. a-3, b-2, c-1;
823. R.I. producerea senzației de dispnee prin creșterea activității centrilor de control consecutivă stimulării receptorilor periferici prin hipoxie tisulară periferică, f.d.u.
- a. boală pericardică;
 - b. insuficiență sistolică;
 - c. deconștrinderea cardiovasculară;
- și următoarele trăsături:
- A. a-1, b-3, c-2;
 - B. a-1, b-3, c-2;
 - C. a-2, b-1, c-3;
 - D. a-3, b-1, c-2;
 - E. a-3, b-2, c-1;
824. R.I. producerea senzației de dispnee prin creșterea activității centrilor de control, stimularea centrilor de control, f.d.u. mecanisme:
- a. stimularea chemoreceptorilor a metaboreceptorilor consecutivă instalării precoce a metabolismului anaerob;
 - b. anemie ușoară până la moderată;
 - c. tamponadă cardiacă;
- care sunt asociilele corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
 - B. a-1, b-3, c-2;
 - C. a-2, b-3, c-1;
 - D. a-3, b-1, c-2;
 - E. a-3, b-2, c-1;
825. R.I. producerea senzației de dispnee prin creșterea activității centrilor de control consecutivă stimulării receptorilor periferici prin hipoxie tisulară periferică, f.d.u.
- a. boală pericardică;
 - b. insuficiență sistolică;
 - c. deconștrinderea cardiovasculară;
- și următoarele trăsături:
- A. a-1, b-3, c-2;
 - B. a-1, b-3, c-2;
 - C. a-2, b-1, c-3;
 - D. a-3, b-1, c-2;
 - E. a-3, b-2, c-1;
826. F.d.u. evenimente care vizează unul dintre mecanismele care dispnee:
- a. compresie extrinsecă a plămânilor;
 - b. atelectazie parțială;
 - c. stimularea receptorilor pulmonari;
 - d. dispnee;
 - e. lichid pleural în cantitate mare;
- care este lanțul cauzal corect:
- A. a→b→e→c→d;
 - B. b→a→e→c→d;
 - C. c→a→b→e→d;
 - D. a→b→c→e→d;
 - E. e→a→b→c→d;
- Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date următoarele; f.f. = întotdeauna; U.f.d.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază despres;

827. R1. producerea senzației de dispnee prin creșterea rezistenței opuse pompei ventilatorii, f.d.u. mecanisme:
1. creșterea rezistenței la desindere a confinaților;
 2. creșterea rezistenței la umplere a plămânilor;
 3. creșterea rezistenței la flux a căilor respiratorii;
- și umfătoarea trăsăturii:
- a. scăderea complianței peretelui toracic;
- b. boala căilor respiratorii;
- c. hiperinflația din boala obstructivă pulmonară;
- d. presiune externă asupra plămânilor;
- e. boli ale parenchimului pulmonar.
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-1, c-1, d-2, e-3;
B. a-1, b-1, c-2, d-1, e-3;
C. a-1, b-2, c-1, d-3, e-1;
D. a-1, b-3, c-1, d-2, e-1;
E. a-1, b-3, c-2, d-1, e-1;

828. R1. producerea senzației de dispnee prin creșterea rezistenței la desindere a confinaților;

- f.d.u. mecanisme:
1. scăderea complianței peretelui toracic;
 2. scăderea complianței peretelui toracic și limitarea mișcării diafragmei;
 3. presiune externă asupra plămânilor;
 4. scăderea complianței plămânilor;

- și umfătoarea trăsăturii:
- a. lichid pleural în cantitate mare;
- b. cifoscolioză;
- c. boala parenchimului pulmonar;
- d. acumulare de țesut adipos toracic și abdominal;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-2, b-1, c-4, d-3;
B. a-2, b-4, c-1, d-3;
C. a-2, b-4, c-3, d-1;
D. a-3, b-1, c-4, d-2;
E. a-4, b-3, c-1, d-2;

829. R1. producerea senzației de dispnee prin creșterea rezistenței opuse pompei ventilatorii, f.d.u. mecanisme:

1. rigidizarea peretelui toracic;
 2. creșterea rezistenței la umplere a plămânilor;
 3. creșterea rezistenței la flux a căilor respiratorii;
- și umfătoarea stării patologice:
- a. hiperinflația din astm;
- b. cifoscolioză;

Prescrutări frecvent folosite: c.d.u. = cu excepția; s.u.c.d.e. = sunt umfătoare, cu excepția; u.a.s.c.d.e. = umfătoare alinații sunt corecte, cu excepția; s.c.i.c.d.e. = sunt corect formulate, cu excepția.

- a. poate fi produsă de creșterea rezistenței la flux a căilor respiratorii, de creșterea rezistenței la desindere a confinaților sau de creșterea rezistenței la umplere a plămânilor;
- b. scade capacitatea de a efectua travaliu respirator;
- c. poate fi produsă de alterarea tranziției impulsului motor sau de scăderea forței mușchilor ventilatori;

- d. crește travaliul respirator;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-2, d-1;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;

833. R1. producerea senzației de dispnee prin creșterea discrepanței dintre rezistența care trebuie învinsă de pompa ventilatorie și performanța pompei ventilatorii, f.d.u. boli:

1. boli ale parenchimului pulmonar;
 2. boli obstructive pulmonare;
 3. mastenite grave;
- și umfătoarea trăsăturii:
- a. cele mai frecvente sunt astmul și BPOC;
- b. scăderea performanței pompei ventilatorii;
- c. crește ventilația prin stimularea receptorilor pulmonari;
- d. pol. fi. provoacă de infecții, expunere profesională, boli autoimune;

- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-1, c-3, d-2;
B. a-1, b-2, c-3, d-1;
C. a-1, b-3, c-2, d-1;
D. a-2, b-3, c-1, d-1;
E. a-3, b-1, c-2, d-1;

834. R1. producerea senzației de dispnee prin creșterea discrepanței dintre rezistența care trebuie învinsă de pompa ventilatorie și performanța pompei ventilatorii, f.d.u. boli:

1. pneumopatii interstițiale;
 2. boli obstructive pulmonare;
 3. sindrom Guillain-Barré;
- și umfătoarea trăsăturii:
- a. crește travaliul respirator prin creșterea rigidității (scăderea complianței) plămânilor;
- b. scăderea performanței pompei ventilatorii;
- c. creșterea rezistenței la umplere a plămânilor prin hiperinflație;

- d. este caracteristică hiperinflația (mai ales formele ușoare și moderate de boală);
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-1, c-3, d-2;
B. a-1, b-2, c-3, d-1;
C. a-1, b-3, c-2, d-1;
D. a-2, b-3, c-1, d-1;
E. a-3, b-2, c-1, d-1;

835. R1. producerea senzației de dispnee prin creșterea discrepanței dintre rezistența care trebuie învinsă de pompa ventilatorie și performanța pompei ventilatorii, f.d.u. boli:

1. boli ale parenchimului pulmonar – PPI;
 2. boli obstructive pulmonare;
 3. miopatii;
- și umfătoarea trăsăturii:
- a. scăderea performanței pompei ventilatorii;
- b. distensia plămânilor și a peretelui toracic;
- c. în mod caracteristic, din cauza hiperinflației apare

- hipocapnie;
- d. hipoxemie prin discrepanță ventilație-perfuzie și distrugerea și/sau îngroșarea barierei alveolo-capilare;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-3, c-1, d-2;
B. a-1, b-3, c-2, d-1;
C. a-3, b-1, c-1, d-2;
D. a-3, b-1, c-2, d-1;
E. a-3, b-2, c-1, d-1;

836. F.d.u. evenimente care explică dispneea din boli obstructive pulmonare:

- a. în bolile obstructive pulmonare (forme moderate sau severe);
- b. creștea sarcina rezistivă și elastică (care reflectă rigiditatea sistemului) asupra mușchilor ventilatori;
- c. hiperinflația dinamică a plămânilor cu și a peretelui toracic;

d. pacientul are senzația că nu poate respira suficient de adânc;

- care este lanțul causal corect:
- A. a→b→c→d;
B. a→c→b→d;
C. c→a→b→d;
D. c→d→a→b;
E. d→a→c→b;

- c. hipoxemie;
- d. discrepanța ventilație-perfuzie și distrugerea și/sau îngroșarea barierei alveolo-capilare;
- care este lanțul causal corect:
- A. b→c→d→a;
B. b→d→c→a;
C. c→d→b→a;
D. d→b→c→a;
E. d→c→b→a;

838. F.d.u. evenimente care explică unul dintre mecanismele dispneei:

- a. efortul de a respira devine excesiv;
- b. dispnee;
- c. creștea discrepanța dintre performanța pompei ventilatorii și rezistența care o învingă;
- d. creștea rezistența pe care trebuie să o învingă pompa ventilatorie sau scade performanța pompei ventilatorii;

- care este lanțul causal corect:
- A. b→c→d→a;
B. b→d→c→a;
C. c→a→b→d;
D. d→b→c→a;
E. d→c→a→b;

839. F.d.u. evenimente care explică unul dintre mecanismele dispneei:

- a. hiperinflația dinamică a plămânilor și a peretelui toracic;
- b. obstrucția fluxului de aer, mai pregnant în expirație;
- c. (când boala este moderată sau severă) creștea sarcina rezistivă și elastică (care reflectă rigiditatea sistemului) asupra mușchilor ventilatori;
- d. pacientul are senzația că nu poate respira suficient de adânc;

care este lanțul causal corect:

A. a→d→b→c;
B. b→a→c→d;
C. c→d→a→b;
D. d→a→b→c;
E. d→b→c→a;

840. R1. evaluarea pacientului cu dispnee, u.a.s.c.d.e.:

- A. istoricul trebuie să includă descrierea de către pacient în propriile cuvinte a felului în care simte disconfortul respirator;
- B. fenomenul Raynaud sugerează spondilită anchilozantă, potențial responsabilă de fibroza pulmonară;

C. TC toracică este utilă pentru evaluarea suplimentară a parenchimului și a vaselor pulmonare;

D. la evaluarea toracei se urmărește simetra mișcării;

E. în evaluarea pacientului cu dispnee este importantă măsurarea frecvenței respiratorii;

841. R1. evaluarea pacientului cu dispnee, u.a.s.c.d.e.:

- A. istoricul trebuie să includă efectul poziției asupra dispneei;
- B. examenul fizic trebuie început în timpul interogării pacientului;
- C. examinarea abdomenului se face cu pacientul în decubit ventral;
- D. folosirea mușchilor ventilatori accesorii este un semn de travaliu respirator crescut;
- E. observarea cianozei poate orienta diagnosticul;

842. R1. evaluarea pacientului cu dispnee, u.a.s.c.d.e.:

- A. istoricul trebuie să includă efectul înflecțiilor asupra dispneei;
- B. după istoric și examen fizic, se va efectua o radiografie toracică;
- C. pacientul cu dispnee de efort trebuie observat în timp ce merge pentru a reproduce simptomele;
- D. poziția trepedului este un semn de presiune venoasă crescută;
- E. la inspecția toracei se urmărește simetra mișcării;

843. R1. evaluarea pacientului cu dispnee, u.a.s.c.d.e.:

- A. istoricul trebuie să includă efectul factorilor ambienali asupra dispneei;
- B. testele de bronhoprovocare sunt utile la pacienții cu simptome intermitente sugestive pentru astm confirmat de examenul fizic și de probele funcționale pulmonare;
- C. este bine ca pacienții cu dispnee de efort să fie observați în timp ce merg pentru a descoperi noi semne absente în repaus;
- D. pacientul în poziția trepedului să în șezut, propiindu-se cu mâinile de genunchi sau de marginea patului;
- E. la inspecția toracei se pot observa semne de hiperinflație;

844. R1. evaluarea pacientului cu dispnee, u.a.s.c.d.e.:

Prescrutări frecvent folosite: c.d.u. = care dintre umfătoare; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date umfătoare; r1. = referitor/referitoare la; U.d.f.d. = Umfătoare fragmente dintr-o frază dispnee.

A. istoricul trebuie să includă factori de risc pentru bolile pulmonare profesionale și pentru boala coronariană; B. până la o treime din pacienții cu diagnostic clinic de astm nu au hiperreactivitate a căilor respiratorii la testele de provocare; C. la pacienții cu dispnee de efort, saturarea în oxigen trebuie măsurată și după efort (de exemplu, după mers); D. tirajul suprasternalic este un semn de stază pulmonară; E. la inspecția toracelui se poate observa bombarea sau retracția unui hemitorax; 845. R.I. efectul poziției asupra dispneei, f.d.u. variante: 1. ortopnee; 2. platipnee; și următoarele stări patologice: a. sindromul hepatopulmonar cu fistule arterio-venoase intrapulmonare; b. obezitate, ascită masivă; c. mixom atriul stâng; d. IVS: care sunt asociilele corecte: A. a-1, b-2, c-1, d-2; B. a-1, b-2, c-2, d-1; C. a-2, b-1, c-1, d-2; D. a-2, b-1, c-2, d-1; E. a-2, b-2, c-1, d-1; 846. R.I. efectul poziției asupra dispneei, f.d.u. variante: 1. ortopnee; 2. platipnee; și următoarele stări patologice: a. fistule arterio-venoase intrapulmonare prin metabolizare deficitară a substanțelor vasodilatatoare; b. comunicarea interatrială; c. criza de astm declanșată de RGE; d. jenarea mecanică a mișcării diafragmali; care sunt asociilele corecte: A. a-1, b-2, c-1, d-2; B. a-1, b-2, c-2, d-1; C. a-2, b-1, c-1, d-2; D. a-2, b-1, c-2, d-1; E. a-2, b-2, c-1, d-1;	b. IVS: c. episoade de embolism pulmonar; care sunt asociilele corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 848. R.I. determinismul temporal al dispneei, f.d.u. variante: 1. dispnee nocturnă; 2. dispnee în episoade acute, intermitente; 3. dispnee persistentă, cronică; și următoarele stări patologice: a. astm; b. episoade de ischemie miocardică; c. PPI; care sunt asociilele corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-2, b-3, c-1; E. a-3, b-2, c-1; 849. R.I. determinismul temporal al dispneei, f.d.u. variante: 1. dispnee nocturnă; 2. dispnee în episoade acute, intermitente; 3. dispnee persistentă, cronică; și următoarele stări patologice: a. boala tromboembolică cronică; b. bronhoconstricție favorizată de vagotonie; c. episoade de bronhospasm; d. dispnee în episoade acute, intermitente; e. dispnee în episoade acute, intermitente;	E. a-3, b-2, c-1; 851. R.I. rolul examenului fizic în diagnosticul diferențial al dispneei, f.d.u. semne: 1. incapacitatea pacientului de a rosti fraze complete înainte de a se opri pentru a respira adânc; 2. semne de travaliu respirator crescut; 3. angioame stelate; și următoarele stări patologice: a. creșterea rigidității plămânilor sau a peretelui toracic; b. ciroză; c. perturbarea pompei ventilatorii cu scăderea capacității vitale; care sunt asociilele corecte: A. a-1, b-3, c-2; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 852. R.I. rolul examenului fizic în diagnosticul diferențial al dispneei, f.d.u. semne: 1. semne de travaliu respirator crescut; 2. puls paradoxal; 3. ginecomastie; și următoarele stări patologice: a. ciroză; b. BPOC; c. rezistență crescută opusă pompei ventilatorii; care sunt asociilele corecte: A. a-1, b-3, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;	853. R.I. rolul examenului fizic în diagnosticul diferențial al dispneei, f.d.u. semne: 1. semne de travaliu respirator crescut; 2. puls paradoxal; 3. paloarea semimucoaselor (conjunctivelor, buze); și următoarele stări patologice: a. criza acută de astm; b. anemie; c. creșterea rezistenței căilor respiratorii; care sunt asociilele corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 854. R.I. rolul percuției toracelui în diagnosticul diferențial al dispneei, f.d.u. semne: 1. semne de travaliu respirator crescut; 2. puls paradoxal; 3. paloarea semimucoaselor (conjunctivelor, buze); și următoarele stări patologice: a. criza acută de astm; b. anemie; c. creșterea rezistenței căilor respiratorii; care sunt asociilele corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;	855. R.I. rolul auscultății pulmonare în diagnosticul diferențial al dispneei, f.d.u. semne: 1. raluri bronșice; 2. raluri alveolare; 3. scăderea murmurului vezicular; și următoarele stări patologice: a. emfizem; b. alveolită fibrozantă; c. boli pulmonare obstructive; care sunt asociilele corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 856. R.I. rolul auscultății pulmonare în diagnosticul diferențial al dispneei, f.d.u. semne: 1. raluri bronșice; 2. raluri alveolare; 3. scăderea murmurului vezicular; și următoarele stări patologice: a. emfizem; b. alveolită fibrozantă; c. boli pulmonare obstructive; care sunt asociilele corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;	857. R.I. rolul auscultății pulmonare în diagnosticul diferențial al dispneei, f.d.u. semne: 1. raluri sforătoare; 2. raluri șuierătoare; 3. raluri alveolare; și următoarele stări patologice: a. boli pulmonare obstructive, mai ales astm bronșic; b. EPA; c. boli pulmonare obstructive, mai ales bronșită; care sunt asociilele corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;	858. R.I. rolul auscultății pulmonare în diagnosticul diferențial al dispneei, f.d.u. semne: 1. raluri alveolare (crepitante); 2. raluri uscate interstițiale; 3. scăderea murmurului vezicular; și următoarele stări patologice: a. lichid în alveole; b. PPI; c. lichid pleural; care sunt asociilele corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 859. F.d.u. elemente care explică un semn fizic abdominal asociat cu dispnee: a. anxietate și dispnee marcată; b. edem pulmonar acut; c. abdomenul bombat în expirație și se retrage în inspirație; d. pacientul are tendința de a inspira predominant costal și supraclavicular; care este înălțarea logică justă: A. b→a→d→c; B. b→d→a→c; C. b→d→c→a; D. d→b→c→a; E. d→c→b→a;	860. R.I. rolul examinării cardiace în diagnosticul diferențial al dispneei, f.d.u. semne: 1. jugulare turgescențe; 2. galop protodiastolic de VS; 3. bombareatrăția abdomenului în timpul expirației/inspirației; și următoarele stări patologice: a. creșterea presiunii în inima dreaptă; b. edem pulmonar acut; c. distuncție predominant sistolică a VS; care sunt asociilele corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 861. R.I. rolul examinării cardiace în diagnosticul diferențial al dispneei, f.d.u. semne: 1. galop de VD; 2. mișcare spre interior a abdomenului în inspirație; 3. semne de sindrom Raynaud; și următoarele stări patologice: a. creșterea presiunii în inima dreaptă; b. slăbiciune diafragmatică;	862. R.I. rolul examinării cardiace în diagnosticul diferențial al dispneei, f.d.u. semne: 1. galop de VD; 2. mișcare spre interior a abdomenului în inspirație; 3. semne de sindrom Raynaud; și următoarele stări patologice: a. creșterea presiunii în inima dreaptă; b. slăbiciune diafragmatică;
---	---	--	--	---	--	--	--	---

Prescurtări frecvent folosite: c.d.u. = care dăre următoarele; f.d. = fiind date următoarele; r.l. = referitor/referitoare la; U.f.d.u. = Următoarele fragmente din-o frază despre;

Prescurtări frecvent folosite: c.d. = cu excepția; s.u.c.d. = sunt următoarele, cu excepția; a.s.c.d. = următoarele afirmatii sunt corecte, cu excepția; a.c.f.d. = sunt corect formulate, cu excepția;

c. afectare pulmonară în cadrul sclerozei sistemice;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1.

865. R.1. rolul radiologiei în diagnosticul diferențial al dispneei, f.d.u. modificat:

1. volumele pulmonare crescute (hiperinflație);
2. spațiile aeriene diminuate;
3. revărsat lichidian pleural bilateral;
și următoarele stări patologice:
a. edem interstițial;
b. ICG;
c. boală pulmonară obstructivă;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1.

866. R.1. rolul radiologiei în diagnosticul diferențial al dispneei, f.d.u. modificat:
1. accentuarea desenului interstițial;
2. dilatarea arterelor pulmonare centrale (bombarea arcului mijlociu stâng);
3. revărsat lichidian pleural bilateral;
și următoarele stări patologice:
a. HTAP;
b. boli autoimune de țesut conjunctiv;
c. pneumonie interstițială;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1.

867. R.1. rolul radiologiei în diagnosticul diferențial al dispneei, f.d.u. modificat:
1. spații aeriene scăzute;
2. reducerea desenului interstițial;
3. revărsat lichidian pleural unilateral;
și următoarele stări patologice:
a. emfizem;
b. fibroză interstițială;
c. cancer pulmonar;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1.

868. R.1. rolul radiologiei în diagnosticul diferențial al dispneei, f.d.u. modificat:
1. volumele pulmonare scăzute;
2. modificări ale parenchimului pulmonar;
3. revărsat lichidian pleural unilateral;
și următoarele stări patologice:
a. distuncție diafragmatică;
b. pneumonie interstițială, emfizem;
c. embolism pulmonar;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1.

869. R.1. rolul radiologiei în diagnosticul diferențial al dispneei, f.d.u. modificat:
1. volumele pulmonare scăzute;
2. silueta cardiacă mărită;
3. revărsat lichidian pleural unilateral;
și următoarele stări patologice:
a. cardiomegalie dilatativă;
b. pneumonie;
c. limitare mișcării peretelui toracic;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-3, c-2;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1.

870. R.1. rolul radiologiei în diagnosticul diferențial al dispneei, f.d.u. modificat:
1. desen vascular proeminent în zonele superioare;
2. silueta cardiacă mărită;
3. revărsat lichidian pleural bilateral;
și următoarele stări patologice:
a. hipertensiune venoasă pulmonară;
b. valvulopatie;
c. insuficiență cardiacă;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1.

871. R.1. rolul investigațiilor paraclinice în diagnosticul diferențial al dispneei, f.d.u. tehnici:
1. electrocardiogramă;

2. ecocardiografie;
3. radiografia toracică;
și următoarele aspecte/afecțiuni evaluate prin aceste tehnici:
a. infarct miocardic acut sau secalar;
b. valvulopatie cardiacă;
c. silueta cardiacă mărită;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1.

872. R.1. rolul investigațiilor paraclinice în diagnosticul diferențial al dispneei, f.d.u. tehnici:
1. electrocardiogramă;
2. radiografia toracică;
3. testele de bronhoprovocare;
și următoarele aspecte/afecțiuni evaluate prin aceste tehnici:
a. parenchim pulmonar;
b. astm;
c. semne de hipertrofie ventriculară;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1.

873. R.1. rolul investigațiilor paraclinice în diagnosticul diferențial al dispneei, f.d.u. tehnici:
1. electrocardiogramă;
2. radiografia toracică;
3. tomografia computerizată;
și următoarele aspecte/afecțiuni evaluate prin aceste tehnici:
a. boală pulmonară interstițială (de elecție);
b. volumele pulmonare;
c. TEV;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1.

874. R.1. rolul investigațiilor paraclinice în diagnosticul diferențial al dispneei, f.d.u. tehnici:
1. ecocardiografie;
2. radiografia toracică;
3. tomografia computerizată;
și următoarele aspecte/afecțiuni evaluate prin aceste tehnici:
a. cancer pulmonar (de elecție);
b. distuncție sistolică și diastolică;
c. vasele pulmonare;
care sunt asocierile corecte:

A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1.

875. R.1. rolul investigațiilor paraclinice în diagnosticul diferențial al dispneei, f.d.u. tehnici:
1. ecocardiografie;
2. radiografia toracică;
3. tomografia computerizată;
și următoarele aspecte/afecțiuni evaluate prin aceste tehnici:
a. HTAP;
b. embolism pulmonar (de elecție);
c. revărsat lichidian pleural;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1.

876. R.1. tuse u.a.s.c.g.e.:
A. tusea este o expirație explozivă care începe cu o inspirație superficială;
B. tusea curăță arborele traheo-bronșic de secreții și de material străin;
C. pacienții solicite asistență medicală atunci când tusea le generează disconfort;
D. îngrijirea cu privire la cauză (în special în cazul cancerului) este un motiv pentru care pacienții cu tuse se prezintă la medic;
E. ca reflex defensiv are alături de el afecțiuni, căi și elemente;

877. R.1. tuse u.a.s.c.g.e.:
A. tusea oferă un mecanism protector normal pentru arborele traheobronșic;
B. este unul dintre cele mai frecvente simptome pentru care pacienții solicite asistență medicală;
C. pacienții solicite asistență medicală atunci când tusea le perturbă modul de viață normal;
D. tusea poate fi inițiată fie voluntar, fie reflex;
E. ramul aferent include nervii glosolaringian și nervii spinali;

878. Ramul aferent al tusei include receptori din distribuția senzorială a următoarelor nervi, c.e.:
A. trigemen;
B. glosolaringian;
C. oculomotor;
D. laringian superior;

879. F.d.u. eveniment care constituie mecanismul tusei:
a. creșterea marcată a presiunii intratoracice;
b. îngustarea traheei;
c. închiderea glotei, relaxarea diafragmei și contracția mușchilor expirațorii;
d. flux de aer rapid prin trahee și bronhi;
e. inspirație adâncă;
f. deschiderea glotei;
care este lanțul temporal corect:
A. a→d→e→c→b→f;
B. c→f→a→e→b→d;
C. d→e→b→c→a→f;
D. e→c→a→b→f→d;
E. f→c→b→e→a→d;

880. F.d.u. elemente implicate în mecanismul tusei:
a. contracția mușchilor expirațorii împotriva glotei închise;
b. diferența de presiune mare dintre căile respiratorii și atmosferă cuplată cu îngustarea traheei;
c. forțe de forfecare, care ajută la eliminarea mucusului și a materialelor străine;
d. flux de aer rapid prin trahee;
care este lanțul temporal corect:
A. a→b→d→c;
B. a→c→b→d;
C. b→a→d→c;
D. c→b→d→a;
E. d→a→c→b;

881. R.1. factorii inițiali care pot iniția tusea, f.d.u. categorii:
1. origine exogenă;
2. origine endogenă;
și următorii factori:
a. conținut gastric;
b. secreții din căile respiratorii superioare;
c. corpi străini;
d. gaze, fum, praf;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-2, d-1;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;

D. (ca în cazul refluxului gastro-esofagian);
E. factorii inițiator este de regulă evident și ușor de rezolvat;
883. U.f.d. cauzele tusei s.c.f.g.e.:

A. Exponerea îndelungată la iritanți endogeni;
B. produce o reacție inflamatorie în căile respiratorii;
C. care inhibă tusea;
D. și poate sensibiliza căile respiratorii la alți iritanți;
E. generând hipersensibilitate.

884. R.1. cauzele tusei, u.a.s.c.g.e.:
A. factorii inițiali care pot iniția tusea pot afecta receptori din căile respiratorii superioare sau din tractul respirator inferior;
B. tusea poate fi declanșată de secrețiile din căile respiratorii superioare;
C. tusea poate fi declanșată de iritație prin conținut gastric;
D. asinul este o cauză rară de tuse;

E. principalele mecanisme prin care o afecțiune poate determina tuse sunt inflamația, dilatarea, infiltrarea și compresia căilor respiratorii;
885. R.1. cauzele tusei, u.a.s.c.g.e.:
A. receptori din căile respiratorii superioare care pot declanșa tusea sunt situați în special în nas;
B. factorii inițiali care pot iniția tusea ajung în tractul respirator inferior prin inhalare sau aspirație;
C. RGE este o cauză de tuse adesea neglijată;
D. bradikinia sau substanța P sunt, ambele, catalizate de enzima de conversie a angiotensinei;
E. inflamația care produce tuse este cel mai adesea determinată de boli autoimune;

886. R.1. cauzele tusei, u.a.s.c.g.e.:
A. factorii inițiali care pot iniția tusea ajung în tractul respirator inferior pe calea arborelui traheo-bronșic;
B. tusea poate fi declanșată de secrețiile retronazale;
C. când tusea este inițiată de factori endogeni, aceștia pot trece neobservați și tusea poate persista;
D. blocații receptorilor pentru angiotensină (BRA) provoacă adesea tuse;

887. R.1. cauzele tusei, u.a.s.c.g.e.:
A. factorii inițiali care pot iniția tusea ajung în tractul respirator inferior pe calea arborelui traheo-bronșic;
B. tusea poate fi declanșată de secrețiile retronazale;
C. când tusea este inițiată de factori endogeni, aceștia pot trece neobservați și tusea poate persista;
D. blocații receptorilor pentru angiotensină (BRA) provoacă adesea tuse;

Prescurtări frecvent folosite: c.e. = cu excepția; s.u.c.g.e. = sunt următoarele, cu excepția; u.a.s.c.g.e. = următoarele afirmări sunt corecte, cu excepția; s.c.f.g.e. = sunt corect formulate, cu excepția.

E. infecțiile respiratorii care provoacă tuse merg de la bronșită virală sau bacteriană până la bronșită de hiper-sensibilitate; 887. U.I.f.d. cauzele tusei s.c.f.c.e.: A. Tusea determinată de RGE; B. se datorează exclusiv iritației receptorilor din căile respiratorii; C. supurație sau aspirației conținutului gastric, intrucât; D. poate contribui și un mecanism reflex mediat adrenergic; E. declanșat de prezența acidului în gură. 888. R.I. cauzele tusei, f.d.u. stări patologice: 1. bronșită virală; 2. tuberculoză; 3. anevrism aortic; și u. trăsături/manifestări: a. rareori cauză de tuse, prin compresia căilor respiratorii; b. infiltrarea căilor respiratorii cu granulocame poate declanșa tuse; c. inflamația căilor respiratorii persistă uneori mult timp după rezolvarea simptomelor acute tipice; care sunt asociile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-2, b-3, c-1; E. a-3, b-2, c-1;	2. formațiune tumorală extrinsecă; 3. PPI; și u. trăsături/manifestări: a. compresia căilor respiratorii; b. boala parenchimală pulmonară neinfecțioasă care poate produce tuse; c. este una dintre cauzele trecute cu vederea de tuse persistentă la adulți; care sunt asociile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 889. R.I. cauzele tusei, f.d.u. stări patologice: 1. infecția cu B. pertussis; 2. bronșectazii; 3. tratament cu IECA; și u. trăsături/manifestări: a. tusea apare la 5-20% dintre pacienți; b. de obicei, diagnosticul se pune însă pe baza tabloului clinic; c. bronhoreea purulentă; care sunt asociile corecte: A. a-1, b-3, c-2; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 892. R.I. cauzele tusei, f.d.u. stări patologice: 1. carcinom bronșic; 2. astm; 3. abces pulmonar; și u. trăsături/manifestări: a. boala parenchimală pulmonară care poate produce tuse; b. infiltrând peretele căilor respiratorii, se asociază adesea cu tuse; c. unii pacienți se prezintă cu tuse fără să aibă respirație șuierătoare sau dispnee; care sunt asociile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 893. R.I. cauzele tusei, f.d.u. stări patologice: 1. astm; 2. insuficiență cardiacă congestivă; 3. bronșectazii; și u. trăsături/manifestări: a. compresia căilor respiratorii;	a. de obicei, contextul clinic este sugestiv pentru diagnostic; b. tuse, probabil drept consecință a edemului interstițial și peribronșic; c. tuse cu expectorație purulentă în cantitate crescută; care sunt asociile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 894. R.I. cauzele tusei, f.d.u. stări patologice: 1. infecția cu B. pertussis; 2. neoplasm; 3. astm; și u. trăsături/manifestări: a. infiltrând peretele căilor respiratorii, se asociază adesea cu tuse; b. în varianta „tuseigenă”, diagnosticul este mai dificil, necesitând demonstrarea hiperreactivității bronșice; c. adesea, mai ales la adulți, șuierătura inspiratorie tipică este absentă, simptomele fiind mai esompate și mai necharacteristice; care sunt asociile corecte: A. a-1, b-3, c-2; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 895. R.I. cauzele tusei, f.d.u. stări patologice: 1. infecția cu B. pertussis; 2. astm; 3. tratament cu IECA; și u. trăsături/manifestări: a. paroxisme de tuse urmate de vomă, cianoză, rinoree persistentă; b. dispnee în acces paroxistice; c. tuse neproductivă provocată de bradikinină sau de substanța P; care sunt asociile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 896. R.I. cauzele tusei, f.d.u. stări patologice: 1. tumoră carcinoidă; 2. adenopatie mediastinală; 3. tratament cu IECA; și u. trăsături/manifestări: a. compresia căilor respiratorii;	b. tusea se instalează de obicei din prima săptămână; c. infiltrând peretele căilor respiratorii, se asociază adesea cu tuse; care sunt asociile corecte: A. a-1, b-3, c-2; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 897. R.I. cauzele tusei, f.d.u. stări patologice: 1. sarcoidoză endobronșică; 2. tumoră mediastinală; 3. tratament cu IECA; și u. trăsături/manifestări: a. compresia căilor respiratorii; b. infiltrarea căilor respiratorii cu granulocame poate declanșa tuse; c. tusea poate să apară și după mai multe luni (≤ 6 luni); care sunt asociile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 898. F.d.u. evenimente care explică tusea din bronșectazii: a. tuse cu expectorație purulentă în cantitate crescută; b. staza secrețiilor; c. dilatații bronșice; d. colonizarea cu microorganism; care este lanțul cauzal corect: A. a-b-c-d-i; B. c-a-b-i-d; C. c-b-d-a-i; D. d-b-a-c-i; E. d-c-a-b-i; 899. R.I. clasificarea tusei în funcție de expectorație, f.d.u. variante: 1. umedă (cu expectorație); 2. uscată, seacă, inițială (fără expectorație); și următoarele stări patologice: a. compresii pe căile respiratorii; b. faza inițială a unei traheobronșite, bronșite sau pneumonii acute; c. perioadele de acutizare ale unei bronșite cronice; d. iritație pleurală; e. faza secretorie a unei (traheo)bronșite acute; care sunt asociile corecte: A. a-1, b-1, c-2, d-2, e-2; B. a-2, b-1, c-2, d-1, e-2;	904. R.I. clasificarea tusei în funcție de locul de origine, f.d.u. variante de tuse laringiană: 1. lătrătoare; 2. bitonală; 3. afonă; și următoarele stări patologice: a. consecință a distrugeții corzilor vocale; b. sonoritale stridentă (tăiere cu un fierăstrău); c. de obicei manifestare a sindromului mediastinal; care sunt asociile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-2, b-3, c-1; E. a-3, b-1, c-2; 905. R.I. clasificarea tusei în funcție de locul de origine, f.d.u. variante de tuse laringiană: 1. lătrătoare; 2. bitonală; 3. surdă; și următoarele stări patologice: a. consecință a afectării corzilor vocale; b. compresie pe recurentul stâng; c. consecință a inguștării căii traheale, bronhii mari prin procese inflamatoare sau compresive; care sunt asociile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 906. R.I. clasificarea tusei în funcție de timbru, c.d.u. nu este o categorie adecvată: A. laringiană; B. răgușită; C. lătrătoare; D. bitonală; E. surdă; 907. U.I.f.d. tusea cavernosă s.c.f.c.e.: A. Are timbru metallic, găunos și; B. semnalează cavernă (de regulă TBC) pulmonară mică care; C. joacă rolul de cavitate de rezonanță dar care trebuie să; D. fie izolată de calea respiratorie; E. pentru ca aerul să poată reverbera (în această cavitate); 908. R.I. clasificarea tusei în funcție de tipar, f.d.u. variante: 1. moniformă; 2. chintoasă;	C. a-2, b-2, c-1, d-1, e-2; D. a-2, b-2, c-1, d-2, e-1; E. a-2, b-2, c-2, d-1, e-1; 909. U.I.f.d. tusea uscată, seacă s.c.f.c.e.: A. Apare în faza de stare; B. a unei traheobronșite acute; C. sau a unei bronșite acute; D. (când există doar inflamație a mucoasei, fără secreție); E. sau a unei pneumonii acute. 909. U.I.f.d. tusea iritativă s.c.f.c.e.: A. Poate fi produsă de iritația pleurală; B. fie inflamatoare, în pleurite; C. fie mecanică, în timpul unei punții pleurale când; D. acul atinge pleura viscerală; E. mai ales înainte de evacuarea lichidului. 902. R.I. clasificarea tusei în funcție de locul de origine, f.d.u. variante: 1. tuse laringiană; 2. tuse laringiană lătrătoare; 3. tuse laringiană bitonală; și următoarele stări patologice: a. consecință a paralizării corzilor vocale stângi; b. pentru fi produsă de compresia traheobronșică (manifestare a sindromului mediastinal); c. declanșată de secreții retronazale sau de faringite; care sunt asociile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 903. R.I. clasificarea tusei în funcție de locul de origine, f.d.u. variante de tuse laringiană: 1. răgușită; 2. bitonală; 3. surdă (până la afonă); și următoarele stări patologice: a. sonoritale redusă, stinsă sau chiar dispărută; b. de obicei prin procese compresive intratracheale (adenopatii, tumori, anevrisme etc.); c. produsă de inflamația laringiană; care sunt asociile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;	Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele, c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, r.i. = referitor/referitoare la, U.I.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază despre,
--	---	--	---	--	--	---

Prescurtări frecvent folosite: c.e. = cu excepție; s.u.c.e. = sunt următoarele, cu excepția; u.a.s.c.c.e. = următoarele afirmații sunt corecte, cu excepția; s.c.f.c.e. = sunt corect formulate, cu excepția;

Prescurtări frecvent folosite: u. = urmă
referitor/referen

date, t.d.u. = find date următoare, t.l. =
trecătoare.

- 946. R1. evaluarea unui pacient cu tuse, f.d.u. constatări pe radiografia toracică:**
- opacifiere localizată a parenchimului pulmonar;
 - lezuni alveolare difuze;
 - adenopatie hilară simetrică bilaterală.
- și următoarele stări patologice:**
- alveolice;
 - sarcoidoză;
 - condensare;
 - care sunt asocierile corecte:
- a-1, b-2, c-3;
 - a-1, b-3, c-2;
 - a-2, b-1, c-3;
 - a-2, b-3, c-1;
 - a-3, b-2, c-1;
- 947. R1. evaluarea unui pacient cu tuse, f.d.u. constatări pe radiografia toracică:**
- formațiune tumorală intratoracică;
 - patologie interstițială difuză (PPI);
 - imagini în „fagure de miere” sau imagini chistice (bronsecții);
 - și următoarele investigații efectuate în continuare:
- TC, bronhoscopie;
 - TC, probe funcționale;
 - examen de spută,
- bronhoscopie:**
- care sunt asocierile corecte:
- a-1, b-2, c-3;
 - a-1, b-3, c-2;
 - a-2, b-3, c-1;
 - a-3, b-1, c-2;
 - a-3, b-2, c-1;
- 948. R1. evaluarea unui pacient cu tuse, f.d.u. constatări pe radiografia toracică:**
- opacifiere localizată a parenchimului pulmonar (condensare);
 - patologie alveolară difuză (alveolice);
 - adenopatie hilară simetrică bilaterală (sarcoidoză);
 - și următoarele investigații efectuate în continuare:
- TC;
 - examen de spută, eventual TC, bronhoscopie;
 - TC, probe funcționale;
 - care sunt asocierile corecte:
- a-1, b-2, c-3;
 - a-1, b-3, c-2;
 - a-2, b-3, c-1;
 - a-3, b-1, c-2;
 - a-3, b-2, c-1;
- 949. R1. rolul investigațiilor funcționale pulmonare în evaluarea unui pacient cu tuse de >3 săptămâni, f.d.u. începători de frază:**
- obstrucția reversibilă a fluxului de aer;
 - evidențierea unui tipar restrictiv;
 - provocarea la stimul bronhocostructor;
 - și următoarele sfârșituri de frază:
- poate evidenția HRCR caracteristică pentru astm;
 - sugerează o PPI difuză;
 - este caracteristică pentru astm;
 - care sunt asocierile corecte:
- a-1, b-2, c-3;
 - a-1, b-3, c-2;
 - a-2, b-1, c-3;
 - a-2, b-3, c-1;
 - a-3, b-2, c-1;
- 950. R1. rolul investigațiilor funcționale pulmonare în evaluarea unui pacient cu tuse de >3 săptămâni, f.d.u. începători de frază:**
- constatarea HRCR;
 - măsurarea volumelor pulmonare și a capacității de difuziune;
 - măsurarea fluxurilor de aer (mai ales FEF);
 - și următoarele sfârșituri de frază:
- confirmă suspiciunea de astm;
 - poate evidenția astmul;
 - poate evidenția o PPI;
 - care sunt asocierile corecte:
- a-1, b-2, c-3;
 - a-1, b-3, c-2;
 - a-2, b-1, c-3;
 - a-2, b-3, c-1;
 - a-3, b-2, c-1;
- 951. F.d.u. constatări și decizii legate de investigațiile funcționale pulmonare în evaluarea unui pacient cu tuse de >3 săptămâni:**
- măsurarea fluxurilor de aer (mai ales FEF);
 - confirmarea diagnosticului de astm;
 - obstrucție reversibilă a fluxului de aer;
 - de pe baza prevalenței, se suspectează înălți astmul;
- 952. F.d.u. constatări și decizii legate de investigațiile funcționale pulmonare în evaluarea unui pacient cu tuse de >3 săptămâni:**
- măsurarea fluxurilor de aer (mai ales FEF);
 - test de provocare la stimul bronhocostructor (metacolină, inhalare de aer rece);
 - fluxurile sunt normale, dar se suspectează astm;
 - constatarea HRCR confirmă suspiciunea de astm;
 - e pe baza prevalenței, se suspectează înălți astmul;
 - ce secvență este recomandabilă:
- a-1, b-2, c-3;
 - a-1, b-3, c-2;
 - a-2, b-1, c-3;
 - a-2, b-3, c-1;
 - a-3, b-2, c-1;
- 953. F.d.u. constatări și decizii legate de investigațiile funcționale pulmonare în evaluarea unui pacient cu tuse de >3 săptămâni:**
- se infirmă astmul;
 - evidențierea unui tipar restrictiv sugerează o PPI difuză;
 - pe baza prevalenței, se suspectează înălți astmul;
 - se măsoară volumele pulmonare și capacitățile de difuziune;
 - măsurarea fluxurilor de aer și testul de provocare la bronhocostructor sunt negative (fluxuri normale, fără HRCR);
 - ce secvență este recomandabilă:
- a-1, b-2, c-3;
 - a-1, b-3, c-2;
 - a-2, b-1, c-3;
 - a-2, b-3, c-1;
 - a-3, b-2, c-1;
- 954. R1. evaluarea unui pacient cu tuse, f.d.u. constatări la examenul sputei:**
- sputa purulentă;
 - hemoptiză;
 - mai mult de 3% eozinofilie pe frotiul din spută la un pacient fără astm;
 - și următoarele stări patologice:
- bronșită eozinofilică;
 - bronșită cronică, bronșectazii, pneumonie, abces pulmonar, bronșită cronică, bronșecazii, pneumonie, abces pulmonar, tumoră endobronșică;
 - care sunt asocierile corecte:
- a-1, b-2, c-3;
 - a-1, b-3, c-2;
 - a-2, b-3, c-1;
 - a-3, b-1, c-2;
 - a-3, b-2, c-1;
- 955. R1. tehnici de evaluare a unui pacient cu tuse, f.d.u. începători de frază:**
- colorațiile (Gram și acid-alcoole-rezistențe) și culturile;
 - bronhoscopia flexibilă;
 - TC de înaltă rezoluție;
 - și următoarele sfârșituri de frază:
- poate evidenția un agent patogen infecțios particular;
 - poate confirma prezența pneumoniilor interstițiale și sugerează adesea un diagnostic pe baza tiparului anormal specific;
 - inspecția mucoasei căilor respiratorii poate evidenția aspectul caracteristic al sarcinului Kaposi endobronșic la pacienții cu SIDA;
 - este procedura de elecție pentru efectuarea examenului citologic și histologic;
 - care sunt asocierile corecte:
- a-1, b-2, c-3;
 - a-1, b-3, c-2;
 - a-2, b-3, c-1;
 - a-2, b-3, c-2;
 - a-3, b-1, c-2;
- 956. R1. tehnicile de evaluare a unui pacient cu tuse, f.d.u. începători de frază:**
- examenul citologic din spută;
 - inspecția mucoasei traheobronșice prin bronhoscopie flexibilă;
 - TC de înaltă rezoluție;
 - și următoarele sfârșituri de frază:
- este procedura de elecție pentru confirmarea diagnosticului de bronșectazii;
 - poate furniza diagnosticul de cancer pulmonar;
 - poate evidenția granulomă endobronșice;
 - care sunt asocierile corecte:
- a-1, b-2, c-3;
 - a-1, b-3, c-2;
 - a-2, b-3, c-1;
 - a-3, b-1, c-2;
 - a-3, b-2, c-1;
- 957. R1. tehnicile de evaluare a unui pacient cu tuse, f.d.u. începători de frază:**
- bronhoscopia flexibilă;
 - biopsia din leziunile endobronșice sau biopsia transbronșică a interstițiului pulmonar;
 - TC de înaltă rezoluție;
 - și următoarele sfârșituri de frază:
- este procedura de elecție pentru evidențierea căilor respiratorii dilatate;
 - este procedura de elecție pentru vizualizarea unei tumori endobronșice;
 - poate/pot confirma diagnosticul de sarcoidoză;
 - care sunt asocierile corecte:
- a-1, b-3, c-2;
 - a-2, b-1, c-3;
 - a-2, b-3, c-1;
 - a-3, b-1, c-2;
 - a-3, b-2, c-1;
- 958. R1. complicațiile tusei, u.a.s.c.g.e.:**
- disconfort dureros al peretelui toracic și abdominal reprezentat o complicație rară a tusei;
 - ocazional, paroxisme de tuse pot precipita o sincopă;
 - sincopa de tuse poate fi consecința scăderii marcate a presiunilor intratoracice și alveolare;
 - uterea poate provoca fracturi costale la pacienți alimnieri normali;
 - la pacienți cu fracturi costale ca urmare a tusei trebuie avute în vedere leziuni osase neoplasice (melanom multiphaz, metastaze osteolitice);
- 959. R1. complicațiile tusei, u.a.s.c.g.e.:**
- printr-o complicație obișnuită ale tusei se află incontinența urinară și starea de epuizare;
 - paroxisme de tuse pot provoca sincopă prin reacție vagală (manevră Valsalva);
 - sincopa de tuse poate fi consecința creșterii înforțării venoase și a debitului cardiac;
 - osteoporoză previne apariția de fracturi costale în urma acceselor de tuse;
 - apariția de fracturi costale ca urmare a tusei este un fenomen obișnuit;
- Expectorația – Dr.D.D., Dr.M.D.T.**
- Dr.M.D.T.**
- 960. R1. expectație, u.a.s.c.g.e.:**
- în practică, aspectul expectației are (cu anumite excepții) o utilitate redusă;
 - aspectul expectației are un grad redus de specificitate;
 - diversele tipuri de expectație caracteristice sunt rareori întâlnite în practică;
- 961. R1. clasificarea expectației în funcție de conținut, f.d.u. variante:**
- apă;
 - sângue proaspăt;
 - fibrin, leucocite, hematii degradate;
 - și u. tipuri de expectație:
- sputa ruginită/cărnămie din pneumonia lobară;
 - hemoptiză;
 - sputa seroasă;
 - care sunt asocierile corecte:
- a-1, b-2, c-3;
 - a-1, b-3, c-2;
 - a-2, b-3, c-1;
 - a-3, b-1, c-2;
 - a-3, b-2, c-1;
- 962. R1. clasificarea expectației în funcție de conținut, f.d.u. variante:**
- mucus;
 - sânge roșu aprins;
 3. puroi denificat cu aspect de monede;
 - și u. tipuri de expectație:
- spută numită;
 - spută mucoasă;
 - hemoptiză;
 - care sunt asocierile corecte:
- a-1, b-2, c-3;
 - a-1, b-3, c-2;
 - a-2, b-1, c-3;
 - a-3, b-1, c-2;
 - a-3, b-2, c-1;
- 963. R1. clasificarea expectației în funcție de conținut, f.d.u. variante:**
- puroi;
 2. apă și hematii;
 - mucus densificat în cantitate mare, cu aspect de mulețe bronșice;
 - și u. tipuri de expectație:
- spută purulentă;
 - serohemoptiză;
 - spută pseudomembranoasă;
 - care sunt asocierile corecte:
- a-1, b-2, c-3;
 - a-1, b-3, c-2;
 - a-2, b-1, c-3;
 - a-2, b-3, c-1;
 - a-3, b-1, c-2;
- 964. R1. clasificarea expectației în funcție de conținut, f.d.u. variante:**

Prescurtări frecvent folosite: u.a.s.c.g.e. = sunt următoarele, cu excepția, u.a.s.c.g.e. = sunt următoarele afirmatii sunt corecte, cu excepția, a.c.t.c.g.e. = sunt corecte formulate, cu excepția.

1. sânge;
2. mucus densificat, în cantitate mică, sub formă de dopuri;
3. fibrină, picotite, germeni fagocitari sau liberi;
și u. tipuri de expectorație:
a. spută perlată;
b. spută purulentă;
c. spută sanguinolentă;
care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-2, c-3;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-3, b-1, c-3;
E. a-3, b-2, c-1;
968 R.I. relația dintre caracterul/ conținutul sputei și cauză, f.d.u. variante:
1. fragmente de țesut pulmonar;
2. serohemoragică;
3. membrană proliferă, vezicule flice, scolecși plufind într-un lichid transparent;
și următoarele stări patologice:
a. abces pulmonar;
b. edem pulmonar acut;
c. chist hidalic delerjat într-o bronhie;
care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
969 R.I. relația dintre caracterul/ conținutul sputei și cauză, f.d.u. variante:
1. mucoasă;
2. vomită;
3. purulență;
și următoarele stări patologice:
a. bronșită cronică;
b. colecție purulentă (pulmonară, pleurală, mediastinală, subdiafragmatică) deschisă într-o bronhie;
c. infecții pulmonare;
care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-1, c-2;
970 R.I. relația dintre caracterul/ conținutul sputei și cauză, f.d.u. variante:
1. cu miros fetid;
2. perlată;
3. numulară;
și următoarele stări patologice:
a. tuberculoză cavităre;
b. stărușit unei crize de astm bronșic;
c. infecții cu germeni anaerobi;
care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
967 R.I. relația dintre caracterul/ conținutul sputei și cauză, f.d.u. variante:
1. seroasă;
2. numulară;
3. fragmente de țesut pulmonar;
și următoarele stări patologice:
a. pneumonie abcedată;
b. bronșită, bronșectazii;
c. stază cardiacă în IVS;

Prescurtări frecvent folosite: c.f. = cu excepția, s.u.c.f. = sunt următoarele, cu excepția; u.a.s.c.f. = următoarele afirmații sunt corecte, cu excepția; s.c.f. = sunt corect formulate, cu excepția;

- a. mică, pneumonie;
b. bronșită, pneumonie;
c. infarct pulmonar;
care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
975 R.I. expectorație, f.d.u. începuturi de frază:
1. poate fi prezentă în;
2. în general este absentă în;
și următoarele stări patologice:
a. patologie care nu intră în contact cu spațiile aeriene;
b. patologie bronșică și alveolară;
c. patologie care afectează spațiile aeriene;
d. patologie interstițială, pleurală, compresii extrinseci;
care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-1, d-2;
E. a-2, b-1, c-2, d-1;

Hemoptizia – Dr.D.D., Dr.M.M.M.

- 976 R.I. hemoptizie, u.a.s.c.f.;
A. hemoptizia reprezintă expectorația de sânge din tractul respirator;
B. cea mai de temut cauză este tuberculoza pulmonară;
C. la un pacient cu hemoptizie se caută sistematic o sursă de sângere de la gură/ nas până la alveole;
D. sângerea difuză în spațiul alveolar nu se prezintă întotdeauna cu hemoptizie;
E. pneumonia tuberculoasă are o tendință mai accentuată de a forma caverne;
977 R.I. hemoptizie, u.a.s.c.f.;
A. sângele poate proveni de oriunde, de la alveole până la nas;
B. gradul de urgență depinde mai ales de aspectul sângelui expectat;
C. stabilirea cauzei se bazează în primul rând pe identificarea conținutului sputei;
D. sângerea difuză în spațiul alveolar poate avea cauze inflamatoare sau nu;
E. succionarea căilor respiratorii, mai ales la pacienți intubați, poate produce hemoptizie prin traumatizarea căilor respiratorii;
978 R.I. hemoptizie, u.a.s.c.f.;
A. se poate rezuma la spută cu urme de sânge;
B. gradul de urgență depinde de severitatea bolii pulmonare subiacente;
C. numai sângerea din surse subglotice se numește hemoptizie;
D. hemoragia alveolară difuză (HAD) aparută timpuriu după un transplant medular poate fi catastrofală și amenințătoare de viață;
E. endometrioza pulmonară este cea mai frecventă cauză de hemoptizie la femei înainte de menopauză;
979 R.I. hemoptizie, u.a.s.c.f.;
A. hemoptizia poate ajunge până la eliminarea unor cantități mari de sânge curat;
B. de regulă, pacientul nu se alertează dacă expectează o cantitate mică de sânge;
C. HAD trebuie suspectată la pacienți cu dispnee și hipoxemie instalate brusc la câteva zile după o intervenție ortopedică;
D. o pneumonie produce hemoptizie doar dacă nu abcedează;
E. hemoptizia cataminală este sugestivă pentru embolia pulmonară;
980 R.I. hemoptizie, u.a.s.c.f.;
A. când sângele eliminat este în cantitate mare, poate fi amenințătoare de viață;
B. de obicei, pacientul evaluează cu fidelitate cantitatea de sânge expectat;
C. pacienții cu tratament antitrombotic sau anticoagulant au risc crescut de hemoptizie;
D. tendința la abcedare și cavitare au mai ales pneumoniile cu Streptococcus pneumoniae;
E. chiar după o evaluare amănunțită, la o proporție importantă de pacienți (<30%), nu se poate identifica o etiologie a hemoptiziei;
981 R.I. hemoptizie, u.a.s.c.f.;
A. poate consta în sânge curat (neamestecat cu secreții), de culoare brun-cărnăzie;
B. indiferent de volumul hemoptiziei, manevrele de diagnostic și tratament trebuie întreprinse urgent și expeditiv;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele, c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date următoarele, f.i. = referitor/reletoare la; U.I.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază despre;

- C. la pacienți cu tratament antitrombotic sau anticoagulant, hemoptizia poate fi decanșată de orice proces inflam alveolar;
D. tendința la abcedare și cavitare au mai ales pneumoniile cu coci gram pozitivi;
E. hemoptizia de cauză necunoscută este numită și idiopatică sau criptogenă;
982 R.I. hemoptizie, u.a.s.c.f.;
A. are ca substrat o boală gravă doar când este în cantitate mare;
B. unele etiologii pot fi sugerate de istoricul pacientului, incluzând expunerile ambientale, profesionale;
C. sângerea difuză în spațiul alveolar este numită și hemoragie alveolară difuză (HAD);
D. pneumoniile cu Haemophilus influenzae au o tendință necrozantă mai accentuată;
E. hemoptizia zisă idiopatică apare de obicei la pacienți cu valvulopatie mitrală;
983 R.I. hemoptizile cu sursă traheobronșică, f.d.u. cauze:
1. iritație/ lezarea mucoasei bronșice;
2. hipocoagulabilitate;
3. ruptura vaselor în căile respiratorii;
și următoarele consecințe:
a. sângeri bronșice mai mari;
b. hemoptizie în urma unor iritații bronșice minore;
c. sângeri bronșice mici;
care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
984 F.d.u. afirmații r.l. originea hemoptizilor:
a. cel mai adesea hemoptizile provin din bronhiile mici și medii;
b. ruptura vaselor în căile respiratorii poate fi produsă de leziuni inflamtoare, iritative etc.) mai puțin severe;
c. în bronhiile mai mici, vasele de sânge sunt situate mai aproape de spațiul aerian (din calea respiratorie);
care este înălțuirea logică justă:
A. a→b→c;
B. a→c→b;
C. b→a→c;
D. b→c→a;
E. c→b→a;

985. R.I. felul în care bronșectaziile predispun la hemoptizii, f.d.u. consecutiv:

1. arterele bronșice ajung mai aproape de suprafața mucoasei;
2. producerea hemoptizilor;
- și următoarele cauze:

a. inflamația cronică din perețele bronhiilor;
b. distrugerea/subierea/deformarea peretelui bronșic;
c. dilatarea bronhiilor;
d. situarea arterelor bronșice în proximitatea suprafeței mucoasei;
care sunt asocietile corecte:

A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-1, d-2;
E. a-2, b-1, c-2, d-1;

986. R.I. hemoptiziile cu sursă trahobronșică, u.a.s.c.g.e.:

A. orice infecție a căilor respiratorii poate provoca hemoptizii;
B. alveolele sunt cea mai frecventă sursă de hemoptizii;
C. siluarea arterei și venei bronșice în proximitatea bronhiilor facilitează producerea hemoptizilor;
D. tuberculoză bronșică poate produce bronșectazii;
E. fibroza chistică se prezintă adesea cu hemoptizii;

987. R.I. hemoptiziile cu sursă trahobronșică, u.a.s.c.g.e.:

A. hemoptizii provin mai ales din bronhiile mari;
B. cel mai adesea bronșita acută este determinată de o infecție virală;
C. la pacienții cu bronșită cronică, suprainfecția bacteriană poate produce hemoptizii;
D. hemoptizia din tuberculoză bronșică poate fi consecința bronșectazilor;
E. bronșectaziile sunt caracteristice pentru astmul bronșic;

988. R.I. hemoptiziile cu sursă trahobronșică, u.a.s.c.g.e.:

A. leziunile bronșice care produc hemoptizii pot fi de natură inflamatorie, neoplazică sau infarctivă;
B. contiguitatea dintre bronhiile și vase în cadrul pachetului bronhovascular facilitează producerea hemoptizilor;

C. sângerațiile mai mari sunt produse de obicei prin iritarea mucoasei bronșice;
D. hemoptizia din fibroza chistică este uneori amenințătoare de viață;
E. bacteriile care provoacă cel mai adesea suprainfecție în bronșita cronică sunt stafilococi și Klebsiella;

989. U.f.d.f.d. relația dintre cancerul primar bronșic și hemoptizii s.c.f.g.e.:

A. hemoptiziile însoțesc mai frecvent carcinomul cu celule scumose;
B. și carcinomul microcelular, d. intrucți acestora sunt mai adesea situate periferic;
E. și au deja dimensiuni mari când devin manifeste.

990. R.I. relația dintre cancerul primar bronșic și hemoptizii, u.a.s.c.g.e.:

A. ambele pe care, în general, o provocă hemoptizii (fie și minime) ține de gândul că ar fi produsă de o bronșită;
B. doar la ~10% din cazurile de cancer bronhopulmonar hemoptizia este o manifestare inaugurată;
C. cancerul bronșic poate provoca hemoptizii în cantitate mare prin invadarea vaselor hilare;
D. friabilitatea mucoasei predis-pune tumorile carcinomice la hemoptizii;
E. pacienții cu hemoptizii și noduli pulmonari mulți trebuie sus-pectați de metastaze pulmo-nare;

991. R.I. relația dintre cancerul primar bronșic și hemoptizii, u.a.s.c.g.e.:

A. cancerul bronhopulmonar este principala cauză de hemoptizii;
B. orice cancer pulmonar poate provoca hemoptizii;
C. cancerul bronșic poate provoca hemoptizii amenințătoare de viață prin distrugerea peretelui vaselor hilare;
D. tumorile carcinomice se pot prezenta cu hemoptizii;
E. pînă la cancerul care metastazează de obicei în plămîni se află cel renal, mamar, colonic, testicular, tiroidian;

992. R.I. relația dintre cancerul primar bronșic și hemoptizii, u.a.s.c.g.e.:

A. hemoptizia este de regulă manifestarea inaugurată a cancerului bronhopulmonar;
B. probabilitatea de a provoca hemoptizii este mult mai mare pentru cancerul situat în căile respiratorii distale;
C. tumorile carcinomice apar aproape întotdeauna cu leziuni endobronșice cu mucoasă friabilă;

D. metastazele pulmonare pot sângera;
E. melanomul este unul dintre cancerele care metastazează de obicei în plămîni;

993. F.d.u. evenimente r.l. hemoptizii de cauză cardio-vasculară:

a. presiune diastolică crescută în VS și în AS;
b. când presiunea este suficient de mare, capilarele pulmonare se rup;
c. sîngele ajunge în alveole și este eliminat prin tuse;
d. Translucența presiunii crescute din AS în venele și în capilarele pulmonare;
e. insuficiența ventriculară stîngă;

care este lanțul causal corect:

A. a-b-e-d-c-a;
B. b-c-d-e-a;
C. c-a-b-d-e;
D. d-a-c-e-b;
E. e-a-d-b-c;

994. F.d.u. evenimente r.l. hemoptizii de cauză cardio-vasculară:

a. sîngele ajunge în alveole și este eliminat prin tuse;
b. când presiunea este suficient de mare, capilarele pulmonare se rup;
c. Translucența presiunii crescute din AS în venele și în capilarele pulmonare;
d. presiune crescută în AS;
e. valvulopatii mitrale;

A. a-e-b-d-c;
B. b-d-e-a-c;
C. c-d-b-a-e;
D. d-b-c-e-a;
E. e-d-c-b-a;

995. U.f.d.f.d. hemoptizii s.c.f.g.e.:

A. Când presiunea din capilarele pulmonare este suficient de mare, acestea se rup, iar sîngele ajunge în alveole;

C. și este eliminat, de obicei, ca: D. spunîm rozalia sau ca secreții cu sînturi sanguinolente;
E. și mai ales ca spuă ruginie.

996. U.f.d.f.d. hemoptizii s.c.f.g.e.:

A. Uneori jetul de regurgitare milară este astfel direcționat, B. încît provoacă o creștere localizată a presiunii;

C. în capilarele pulmonare ale lobului superior;
D. ceea ce produce hemoptizii;
E. și un aspect nodular pe radiografie;

997. R.I. cauzele cardiovasculare ale hemoptiziei, u.a.s.c.g.e.:

A. malformațiile arterio-venoase pulmonare sunt predispu-se la sîngerare;
B. embolismul pulmonar produce hemoptizii de obicei asociată cu colaps cardiovascular;
C. hemoptizia litogenă poate fi provocată de rupura arterei pulmonare în timpul catele-ristmului;
D. manipulara unui cateter prevăzută cu balon în artera pulmonară poate provoca hemo-ptizii;

E. HTAP de altă cauză decît TEOP este o cauză frecventă de hemoptizii;

998. F.d.u. afirmații care explică raritatea hemoptiziei la pacienții cu HTAP de altă cauză decît TEOP:

a. de obicei, arteriolele pulmonare au perețele îngroșat și lumenul îngustat;
b. scade probabilitatea de a se rupe capilarele pulmonare;
c. scade tensiunea din perețele capilarelor pulmonare;
care este lanțul causal corect:

A. a-b-c-d;
B. b-a-c-d;
C. b-a-d-c;
D. c-a-b-d;
E. c-b-a-d;

999. F.d.u. afirmații care explică raritatea hemoptiziei la pacienții cu HTAP de altă cauză decît TEOP:

a. scade fluxul de sînge prin capilarele pulmonare;
b. scade probabilitatea de a se rupe capilarele pulmonare;
c. de obicei, arteriolele pulmonare au lumenul îngustat;

d. este caracteristică pentru sindromul Goodpasture;
care sunt asocietile corecte:

A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-1, d-2;
E. a-2, b-1, c-2, d-1;

1000. R.I. hemoptizii masivă, u.a.s.c.g.e.:

A. constă în expectorația a >100-600 ml. de sînge în 24 ore;
B. trebuie considerată o urgență medicală;
C. perturbă sever schimbul de gaze;

D. poate produce asfixiere;
E. frecvent produce exsangvinare;

1001. R.I. hemoptizii masivă (HM), u.a.s.c.g.e.:

A. HM poate fi imediat amenințătoare de viață;
B. sîngele poate umple căile res-piratorii și spațiile alveolare;
C. HM poate produce insuficiență respiratorie severă;
D. pacientul poate ajunge să se înecă cu sîngele aspirat;
E. HM produce adesea decompensare hemodinamică;

d. este caracteristică pentru sindromul Goodpasture;
care sunt asocietile corecte:

A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-1, d-2;
E. a-2, b-1, c-2, d-1;

1004. R.I. hemoptizii f.d.u. surse:

1. hemoragia alveolară;
2. sîngerarea bronșică;
și următoarele caracteristici:

a. provine din arterele bronșice, care pot fi din aortă, fie din arterele intercostale;
b. este caracteristică pentru capilarita pulmonară din poliangeliu microscopică;
c. provine din vase cu presiunea scăzută intrucți sunt capilare;
d. poate duce la pierderea unui volum mare de sînge dată fiind presiunea crescută din vasele de origine;

care sunt asocietile corecte:

A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-2, b-1, c-1, d-2;
D. a-2, b-1, c-2, d-1;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;

1005. R.I. cea mai frecventă cauză a hemoptiziei în țările dezvoltate, u.a.s.c.g.e.:

A. este infecția bronșică;
B. atelectază mai ales bronhiile mici;
C. este cel mai adesea virală sau bacteriană;
D. poate să fie o bronșită acută;
E. poate fi acutizarea unei bronșite cronice;

1006. R.I. cele mai frecvente cauze ale hemoptiziei în funcție de zona geografică, f.d.u. categorii:

1. cea mai frecventă cauză în țările dezvoltate;
2. probabilit a doua cauză ca frecvență în țările dezvoltate;
3. una dintre cele mai frecvente cauze în țările mai puțin dezvoltate;

și următoarele stări patologice:

a. tuberculoza (mai ales cea cavitară);
b. bronșectazii;
c. carcinomul bronșic;
d. infecția bronșică;

care sunt asocietile corecte:

A. a-2, b-3, c-3, d-1;
B. a-3, b-1, c-2, d-3;
C. a-3, b-2, c-1, d-3;

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <p>D. a-3, b-3, c-1, d-2;
E. a-3, b-3, c-2, d-1;
1007. R.I. clasificarea hemoptiziei pe baza locului de origine, f.d.u. categorii:</p> | <p>1. sursă parenchimatooasă pulmonară;
2. sursă traheobronșică (căile respiratorii);
3. sursă primar vasculară; și următoarele stări patologice:
a. lezarea arterelor pulmonare în limful cateterismului;
b. creșterea presiunii în venele și capilarele pulmonare;
c. leziune pulmonară localizată;
d. inflamație bronșică; care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3, d-3;
B. a-1, b-3, c-3, d-2;
C. a-2, b-3, c-3, d-1;
D. a-3, b-2, c-1, d-3;
E. a-3, b-3, c-1, d-2;</p> | <p>parenchimatooasă pulmonară localizată:
a. distrugerea parenchimului pulmonar;
b. infecție pulmonară;
c. erodarea vaselor de sânge; care este lanțul cauzal corect:
A. a→b→c→d;
B. b→a→c→d;
C. b→c→a→d;
D. c→a→b→d;
E. c→b→a→d;</p> | <p>C. a-2, b-1, c-1, d-2;
D. a-2, b-1, c-2, d-1;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;
1014. R.I. hemoptizia prin leziune parenchimatooasă pulmonară, f.d.u. categorii:
1. leziune localizată;
2. proces care afectează difuz parenchimul;
și următoarele stări patologice:
a. pneumonita lupică;
b. sindrom Goodpasture;
c. traumatism pulmonar prin contuzie;
d. infecție pulmonară;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-1, d-2;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;</p> |
| <p>D. a-3, b-3, c-1, d-2;
E. a-3, b-3, c-2, d-1;
1007. R.I. clasificarea hemoptiziei pe baza locului de origine, f.d.u. categorii:</p> | <p>1. sursă parenchimatooasă pulmonară;
2. sursă traheobronșică (căile respiratorii);
3. sursă primar vasculară; și următoarele stări patologice:
a. lezarea arterelor pulmonare în limful cateterismului;
b. creșterea presiunii în venele și capilarele pulmonare;
c. leziune pulmonară localizată;
d. inflamație bronșică; care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3, d-3;
B. a-1, b-3, c-3, d-2;
C. a-2, b-3, c-3, d-1;
D. a-3, b-2, c-1, d-3;
E. a-3, b-3, c-1, d-2;</p> | <p>1011. F.d.u. evenimente care explică hemoptizia prin leziune parenchimatooasă pulmonară localizată:
a. predispoziție la hemoptizie cu ocazia unor infecții ulterioare;
b. leziuni cicatriceale;
c. deformarea arhitecturii pulmonare;
d. pneumonii severe; care este lanțul cauzal corect:
A. a→c→b→d;
B. b→c→a→d;
C. c→b→a→d;
D. c→b→d→a;
E. d→b→c→a;</p> | <p>1015. R.I. hemoptizia prin leziune alveolară, f.d.u. categorii:
1. cauze inflamatoare de hemoragie alveolară – capilarele alveolare;
2. cauze neinflamatoare – cel mai adesea leziune inhalatoare;
3. hipocoagulabilitate:
și următoarele stări patologice:
a. perioadă timpurie după un transplânt medular;
b. vasculite afectând vasele mici; vasculita granulomatoasă (Wegener), poliangeita microscopică;
c. inhalarea de droguți (de exemplu, cocaină);
d. coagulopatie; care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-3;
B. a-1, b-2, c-3, d-1;
C. a-2, b-1, c-3, d-1;
D. a-3, b-1, c-1, d-2;
E. a-3, b-1, c-2, d-1;</p> |
| <p>D. a-3, b-3, c-1, d-2;
E. a-3, b-3, c-2, d-1;
1007. R.I. clasificarea hemoptiziei pe baza locului de origine, f.d.u. categorii:</p> | <p>1. sursă parenchimatooasă pulmonară;
2. sursă traheobronșică (căile respiratorii);
3. sursă primar vasculară; și următoarele stări patologice:
a. embolismul pulmonar;
b. leziune pulmonară difuză;
c. neoplasm bronșic; care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-3, c-2;</p> | <p>1013. R.I. hemoptizia prin leziune parenchimatooasă pulmonară, f.d.u. categorii:
1. leziune localizată;
2. proces care afectează difuz parenchimul;
și următoarele stări patologice:
a. abces pulmonar;
b. tuberculoză;
c. hemosideroză pulmonară idiopatică;
d. coagulopatie; care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-2, d-1;
C. a-2, b-1, c-1, d-2;
D. a-2, b-1, c-2, d-1;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;</p> | <p>1016. R.I. hemoptizia prin leziune alveolară, f.d.u. categorii:
1. cauze inflamatoare de hemoragie alveolară – capilarele alveolare;
2. cauze neinflamatoare – cel mai adesea leziune inhalatoare;
3. hipocoagulabilitate;
și următoarele stări patologice:
a. boala autoimună sistemică (de exemplu lupus eritematos sistemic);
b. pneumonie de orice tip;
c. inhalare de substanțe toxice;
d. tratament antitrombotic, care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-3;</p> |
| <p>D. a-3, b-3, c-1, d-2;
E. a-3, b-3, c-2, d-1;
1007. R.I. clasificarea hemoptiziei pe baza locului de origine, f.d.u. categorii:</p> | <p>1. sursă parenchimatooasă pulmonară;
2. sursă traheobronșică (căile respiratorii);
3. sursă primar vasculară; și următoarele stări patologice:
a. embolismul pulmonar;
b. leziune pulmonară difuză;
c. neoplasm bronșic; care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-3, c-2;</p> | <p>1013. R.I. hemoptizia prin leziune parenchimatooasă pulmonară, f.d.u. categorii:
1. leziune localizată;
2. proces care afectează difuz parenchimul;
și următoarele stări patologice:
a. abces pulmonar;
b. tuberculoză;
c. hemosideroză pulmonară idiopatică;
d. coagulopatie; care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-2, d-1;
C. a-2, b-1, c-1, d-2;
D. a-2, b-1, c-2, d-1;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;</p> | <p>1016. R.I. hemoptizia prin leziune alveolară, f.d.u. categorii:
1. cauze inflamatoare de hemoragie alveolară – capilarele alveolare;
2. cauze neinflamatoare – cel mai adesea leziune inhalatoare;
3. hipocoagulabilitate;
și următoarele stări patologice:
a. boala autoimună sistemică (de exemplu lupus eritematos sistemic);
b. pneumonie de orice tip;
c. inhalare de substanțe toxice;
d. tratament antitrombotic, care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-3;</p> |
| <p>D. a-3, b-3, c-1, d-2;
E. a-3, b-3, c-2, d-1;
1007. R.I. clasificarea hemoptiziei pe baza locului de origine, f.d.u. categorii:</p> | <p>1. sursă parenchimatooasă pulmonară;
2. sursă traheobronșică (căile respiratorii);
3. sursă primar vasculară; și următoarele stări patologice:
a. embolismul pulmonar;
b. leziune pulmonară difuză;
c. neoplasm bronșic; care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-3, c-2;</p> | <p>1013. R.I. hemoptizia prin leziune parenchimatooasă pulmonară, f.d.u. categorii:
1. leziune localizată;
2. proces care afectează difuz parenchimul;
și următoarele stări patologice:
a. abces pulmonar;
b. tuberculoză;
c. hemosideroză pulmonară idiopatică;
d. coagulopatie; care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-2, d-1;
C. a-2, b-1, c-1, d-2;
D. a-2, b-1, c-2, d-1;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;</p> | <p>1016. R.I. hemoptizia prin leziune alveolară, f.d.u. categorii:
1. cauze inflamatoare de hemoragie alveolară – capilarele alveolare;
2. cauze neinflamatoare – cel mai adesea leziune inhalatoare;
3. hipocoagulabilitate;
și următoarele stări patologice:
a. boala autoimună sistemică (de exemplu lupus eritematos sistemic);
b. pneumonie de orice tip;
c. inhalare de substanțe toxice;
d. tratament antitrombotic, care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-3;</p> |
| <p>D. a-3, b-3, c-1, d-2;
E. a-3, b-3, c-2, d-1;
1007. R.I. clasificarea hemoptiziei pe baza locului de origine, f.d.u. categorii</p> | | | |

Prescurtări frecvent folosite: C.E. = cu excepția; S.U.C.E. = sunt următoarele, cu excepția; U.A.S.C.C.E. = următoarele afirmații sunt corecte, cu excepția; S.C.F.C.E. = sunt corect formulate, cu excepția;

- C. alterarea semnelor vitale și a saturației cu oxigen indică o sângereare amenințătoare de viață.
- D. TC toracică oferă informații despre adenopatiile mediastinale, care înfrimă diagnosticul de neoplazie toracică.
- E. TC toracică vizualizează mai bine decât radiografia toracică bronsecțiile:
1028. R.I. evaluarea pacientului cu hemoptizie, u.a.s.c.g.e.:
A. evaluarea pacientului ar trebui începută prin a stabili dacă nu este vorba de o sângereare nazală sau digestivă superioară;
B. istoricul trebuie să includă factorii de risc pentru tromboembolismul venopulmonar;
C. tahicardia și hipotensiunea indică o criză de anxietate;
D. TC toracică permite diagnosticarea TEP dacă istoricul și/sau examenul fizic sugerează TEP;
E. TC toracică vizualizează mai bine decât radiografia toracică infiltratele cavitare.
1029. R.I. evaluarea pacientului cu hemoptizie, u.a.s.c.g.e.:
A. diferențierea de o sângereare nazală sau digestivă superioară este esențială, întrucât abordarea diagnostică și terapeutică este diferită;
B. în hemoptizie, sângele este roșu deschis și are pH acid;
C. examenul fizic trebuie să vizeze în primul rând aparatul digestiv și urinar;
D. istoricul de chimioterapie pentru boala neoplazică este relevant pentru explicarea unei hemoptizii;
E. TC toracică vizualizează formațiunile tumorale mai bine decât radiografia toracică.
1030. U.I.d.d. evaluarea pacientului cu hemoptizie s.c.i.g.e.:
A. La pacientul care:
B. expectorează spută, sunt necesare frota colorati;
C. aiți Gram, cât și pentru;
D. bacii acid-alcolo-rezistenți;
E. ca și cultura din secreția nazală.
1031. R.I. evaluarea pacientului cu hemoptizie, f.d.u. metode de investigație:
a. radiografie toracică și/sau evaluare ORL și/sau evaluare gastroenterologică;
b. TC și/sau bronhoscopie;
c. istoric și examen fizic;
ce secvență este recomandabilă:
A. a-b-c;
B. a-c-b;
C. b-a-c;
D. c-a-b;
E. c-b-a;
1032. R.I. evaluarea pacientului cu hemoptizie, f.d.u. constatări și concluzii clinice:
a. evaluare ORL sau gastroenterologică;
b. elemente sugestive pentru o sursă de sângereare respiratorie superioară sau digestivă;
c. istoric și examen fizic;
ce secvență este recomandabilă:
A. a-b-c;
B. b-a-c;
C. b-c-a;
D. c-a-b;
E. c-b-a;
1033. R.I. evaluarea pacientului cu hemoptizie, f.d.u. constatări și concluzii clinice:
a. radiografia toracică normală;
b. istoricul nu sugerează bronșită și nu are factori de risc pentru cancer;
c. istoric și examen fizic sugestiv pentru sursă de sângereare respiratorie inferioară;
d. TC și bronhoscopie;
ce secvență este recomandabilă:
A. a-b-c;
B. b-a-c;
C. b-c-a;
D. c-a-b;
E. d-b-a;
1034. R.I. evaluarea pacientului cu hemoptizie, f.d.u. constatări și concluzii clinice:
a. radiografia toracică normală;
b. istoric și examen fizic sugestiv pentru sursă de sângereare respiratorie inferioară;
c. istoric și examen fizic sugestiv pentru sursă de sângereare respiratorie inferioară;
ce secvență este recomandabilă:
A. a-b-c;
B. b-a-c;
C. b-c-a;
D. c-a-b;
E. d-b-a;
1035. R.I. evaluarea pacientului cu hemoptizie, f.d.u. constatări și concluzii clinice:
a. hemoptizia însoțează;
b. radiografia toracică normală;
c. istoricul sugerează bronșită și nu are factori de risc pentru cancer;
d. pacientul este înut sub observație (și eventual tratat);
e. se oprește evaluarea;
f. istoric și examen fizic sugestiv pentru sursă de sângereare respiratorie inferioară;
ce secvență este recomandabilă:
A. a-d-e-f-c-b-a;
B. b-a-f-d-e-a-c;
C. c-d-f-a-b-a-d-e;
D. d-a-a-e-b-c-a-f;
E. f-b-c-d-a-a-e;
1036. R.I. evaluarea pacientului cu hemoptizie, f.d.u. constatări și concluzii clinice:
a. TC și bronhoscopie;
b. istoric și examen fizic sugestiv pentru sursă de sângereare respiratorie inferioară;
c. factori de risc pentru cancer;
d. radiografia toracică normală;
ce secvență este recomandabilă:
A. a-b-d-c;
B. b-a-d-c-a;
C. b-d-c-a-a;
D. c-a-b-c-a;
E. d-b-a-a-c;
1037. R.I. evaluarea pacientului cu hemoptizie, f.d.u. constatări și concluzii clinice:
a. istoric și examen fizic sugestiv pentru sursă de sângereare respiratorie inferioară;
b. TC și bronhoscopie;
c. formațiune tumorală la radiografia toracică;
ce secvență este recomandabilă:
A. a-b-c;
B. b-a-c;
C. b-c-a;
D. c-a-b;
E. c-b-a;
1038. R.I. evaluarea pacientului cu hemoptizie, f.d.u. constatări și concluzii clinice:
a. evaluarea ulterioară vizează diagnosticul sugerat de TC;
b. modificări sugestive pe un anumit diagnostic la TC;
c. istoric și examen fizic sugestiv pentru sursă de sângereare respiratorie inferioară;

Prescurtări frecvent folosite: S.B. = cu excepția, s.u. G.E. = sunt umătoarele, cu excepția, u.a.s.c.g.e. = umătoarele afirmații sunt corecte, cu excepția, s.c.i.g.e. = sunt corect formulate, cu excepția.

- d. leziuni parenchimatose la radiografia toracică;
ce secvență este recomandabilă:
A. a-c-d-b;
B. b-d-c-a;
C. c-d-b-a;
D. d-b-a-c;
E. d-c-a-b;
1039. R.I. evaluarea pacientului cu hemoptizie, f.d.u. constatări și concluzii clinice:
a. bronhoscopie;
b. leziuni parenchimatose la radiografia toracică;
c. TC nu sugerează niciun diagnostic specific;
d. istoric și examen fizic sugestiv pentru sursă de sângereare respiratorie inferioară;
ce secvență este recomandabilă:
A. a-c-b-d;
B. b-d-a-a-c;
C. b-d-c-a-a;
D. c-a-b-c-a;
E. d-b-a-a-c;
1040. R.I. elemente furnizate de istoric sugestiv pentru sursă unei hemoptizii, f.d.u. categorii:
1. descreșterea hemoptiziei;
2. circumstanțele hemoptiziei;
și următoarele elemente:
a. vechimea/repetitivitatea;
b. caracterul;
c. factori cauzali/declanșatori;
d. volumul;
e. simptome sugestive asociate;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-1, d-2, e-2;
B. a-1, b-1, c-2, d-1, e-2;
C. a-2, b-1, c-1, d-1, e-2;
D. a-2, b-1, c-1, d-2, e-1;
E. a-2, b-1, c-2, d-1, e-1;
1041. R.I. felul în care caracterul hemoptiziei orientează diagnosticul etiologic, f.d.u. variante:
1. secreții (muco)purulente cu striuri sanguinolente;
2. spută rozali;
3. secreții cu mîros fetid;
4. sânge curat;
și următoarele stări patologice:
a. edem pulmonar acut;
b. bronșită, bronsecții;
c. sursă de sângereare mare;
d. abces pulmonar;
care sunt asocierile corecte:
A. a-2, b-1, c-4, d-3;
B. a-3, b-1, c-2, d-4;
C. a-3, b-2, c-4, d-1;
D. a-3, b-4, c-2, d-1;
E. a-4, b-2, c-3, d-1;
1042. R.I. felul în care vechimea/repetitivitatea hemoptiziei orientează diagnosticul etiologic, f.d.u. variante:
1. producție de spută cronică, cu o schimbare recentă în cantitate sau aspect;
2. producție de spută cronică, în cantitate mare;
3. hemoptizie lunară (catamenială) la o femeie;
și următoarele stări patologice:
a. acutizarea unei bronșite cronice;
b. endometrioziă pulmonară;
c. bronsecții;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-3, c-2;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
1043. R.I. felul în care simptome sugestive asociate orientează diagnosticul etiologic al hemoptiziei, f.d.u. variante:
1. febră, frisoane asociate cu tuse și/sau dispnee și/sau junghi toracici;
2. febră, tuse;
3. febră, frisoane, junghi toracici, eventual dispnee;
4. hemoptizie după junghi toracici și dispnee instalate brusc;
și următoarele stări patologice:
a. pneumonie;
b. bronșită acută, acutizarea unei bronșite cronice;
c. infecție respiratorie;
d. tromboembolism pulmonar;
care sunt asocierile corecte:
A. a-2, b-4, c-1, d-3;
B. a-3, b-1, c-4, d-2;
C. a-3, b-2, c-1, d-4;
D. a-3, b-2, c-4, d-1;
E. a-4, b-1, c-3, d-2;
1044. R.I. felul în care istoricul orientează diagnosticul etiologic al hemoptiziei, f.d.u. variante:
1. istoric de boli renale;
2. istoric de boli care induc tulburări de hemostază;
3. istoric de transplant renal recent;
și următoarele stări patologice:
a. hemoptizie secundară unei coagulopatii;
b. HAD ca manifestare a unui sindrom pneumo-renal;
c. HAD de cauză inflamatorie, care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-3, c-2;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
1045. R.I. felul în care istoricul orientează diagnosticul etiologic al hemoptiziei, f.d.u. variante:
1. istoric de boli vasculare;
2. istoric de boli reumatologice;
3. istoric de tratament cu medicamente care pot induce tromboticopie;
și următoarele stări patologice:
a. LES cu pneumonită lupică;
b. tromboză venoasă profundă;
c. hemoptizie secundară unei coagulopatii;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
1046. R.I. felul în care istoricul orientează diagnosticul etiologic al hemoptiziei, f.d.u. variante:
1. istoric de boli renale;
2. istoric de SIDA;
3. istoric de boli bronhopulmonare;
și următoarele stări patologice:
a. angita granulomatoasă Wegener;
b. sarcoid Kaposi endobronhic sau parenchimatous pulmonar;
c. bronșită cronică, bronsecții;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;

Prescurtări frecvent folosite: u. = umătoare, c.d.u. = care dintre umătoarele, f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date umătoarele, f.l. = referitor/referitoare la, U.I.d.d. = Umătoarele frazmente dintr-o frază despre.

1048. R.I. felul în care examenul fizic orientează diagnosticul etiologic al hemoptiziei, f.d.u. modifică:
1. hipocratism digital;
 2. semne de stază periferică;
 3. telangiectazii cutaneo-mucoase;
- și următoarele stări patologice:
- a. boala Osler-Rendu-Weber;
 - b. insuficiența cardiacă globală;
 - c. carcinom bronșic;
- care sunt asociate corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
 - B. a-1, b-3, c-2;
 - C. a-2, b-3, c-1;
 - D. a-2, b-1, c-3;
 - E. a-3, b-1, c-2;
1052. R.I. felul în care examenul fizic orientează diagnosticul etiologic al hemoptiziei, f.d.u. modifică:
1. edem unilateral la un membru inferior;
 2. hipocratism digital;
 3. raluri bronșice mai groase sau mai fine, mai degrabă umede (subcrepitante), dar și uscate (sfârșitoare), cu sau fără respirație șuierătoare;
- și următoarele stări patologice:
- a. boli pulmonare supurative sau neoplazice;
 - b. bronșectazii;
 - c. tromboză venoasă profundă;
- care sunt asociate corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
 - B. a-1, b-3, c-2;
 - C. a-2, b-3, c-1;
 - D. a-2, b-3, c-1;
 - E. a-3, b-1, c-2;
1049. R.I. felul în care examenul fizic orientează diagnosticul etiologic al hemoptiziei, f.d.u. modifică:
1. fectură pleurală;
 2. jugulare turgescențe;
 3. leziuni cutanate;
- și următoarele stări patologice:
- a. sarcom Kaposi;
 - b. embolism pulmonar;
 - c. insuficiența cardiacă globală;
- care sunt asociate corecte:
- A. a-1, b-3, c-2;
 - B. a-2, b-1, c-3;
 - C. a-2, b-3, c-1;
 - D. a-3, b-1, c-2;
 - E. a-3, b-2, c-1;
1050. R.I. felul în care examenul fizic orientează diagnosticul etiologic al hemoptiziei, f.d.u. modifică:
1. crepitanțe localizate sau difuze;
 2. hepatomegalie de stază;
 3. leziuni cutanate;
- și următoarele stări patologice:
- a. sângere aiveolară;
 - b. lupus eritematos sistemic;
 - c. insuficiența cardiacă globală;
- care sunt asociate corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
 - B. a-1, b-3, c-2;
 - C. a-2, b-3, c-1;
 - D. a-3, b-1, c-2;
 - E. a-3, b-2, c-1;
1051. R.I. felul în care examenul fizic orientează diagnosticul etiologic al hemoptiziei, f.d.u. modifică:
1. semne de obstrucție a fluxului de aer;
 2. hipocratism digital;
 3. crepitanțe localizate sau difuze;
- și următoarele stări patologice:
- a. sângere aiveolară;
 - b. insuficiența cardiacă globală;
 - c. insuficiența cardiacă globală;
- care sunt asociate corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
 - B. a-1, b-3, c-2;
 - C. a-2, b-3, c-1;
 - D. a-3, b-1, c-2;
 - E. a-3, b-2, c-1;
1054. F.d.u. variante de anemie hemolitice în urină:
- a. anemie de boală cronică;
 - b. anemie feriprivă;
 - c. anemie posthemoragică;
- și următoarele stări patologice:
- A. a-d-b-c;
 - B. b-d-c-a;
 - C. c-d-b-a;
 - D. d-a-b-c;
1055. R.I. utilitatea hemoleucogramei la un pacient cu hemoptizii, fiind dați următorii parametri:
1. Hgb;
 2. trombocite;
 3. leucocite;
- și următoarele stări patologice:
- a. pneumonie;
 - b. anemie;
 - c. tulburare de hemostază;
- care sunt asociate corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
 - B. a-1, b-3, c-2;
 - C. a-2, b-1, c-3;
 - D. a-2, b-3, c-1;
 - E. a-3, b-1, c-2;
1056. F.d.u. investigații de laborator utile în stabilirea etiologiei unei hemoptizii:
1. coagulogramă;
 2. teste vizând funcția renală cu analiza urinei;
 3. Ac anticlotoplasma neurofiliilor (ANCA);
- și următoarele stări patologice:
- a. sindrome pneumorenale;
 - b. vasculită de vase mici;
 - c. tulburare de hemostază;
- care sunt asociate corecte:
- A. a-1, b-3, c-2;
 - B. a-2, b-1, c-3;
 - C. a-2, b-3, c-1;
 - D. a-3, b-1, c-2;
 - E. a-3, b-2, c-1;
1057. F.d.u. investigații, constatări și concluzii clinice:
- a. se caută ANCA, AMBG și AAN;
 - b. teste vizând funcția renală și analiza urinei;
 - c. suspiciune de vasculită de vase mici;
 - d. insuficiență renală acută sau hematurie șisau cilindrii hematici în urină;
- ce secvență este recomandabilă:
- A. a-d-b-c;
 - B. b-d-c-a;
 - C. c-d-b-a;
 - D. d-a-b-c;

Prescurtări frecvent folosite: a.e. = cu excepția; s.c.f.g.e. = sunt următoarele, cu excepția; u.a.s.c.g.e. = următoarele afirmații sunt corecte, cu excepția; s.c.f.g.e. = sunt corect formulate, cu excepția.

- E. d-b-c-a;
1058. F.d.u. investigațiile imunologice utile în stabilirea etiologiei unei hemoptizii:
1. Ac anticlotoplasma neurofiliilor (ANCA);
 2. Ac anti-MBG (AMBG);
 3. Ac antinucleari (AAN);
- și următoarele stări patologice:
- a. boală lupică;
 - b. angeli granulomatoasă, poliangetită microscopică;
 - c. sindrom Goodpasture;
- care sunt asociate corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
 - B. a-2, b-1, c-3;
 - C. a-2, b-3, c-1;
 - D. a-3, b-1, c-2;
 - E. a-3, b-2, c-1;
1059. U.f.d.f. utilitatea bronhoscopiei la pacientul cu hemoptizii s.c.f.g.e.:
- A. Bronhoscopia trebuie efectuată la toți pacienții cu istoric de HTA care se;
 - C. prezintă cu hemoptizii nou instalată întrucât au risc;
 - D. crescut de bronșită acută;
 - E. iar TC este fidelă în vizualizarea leziunilor endobronșice.
1060. R.I. utilitatea bronhoscopiei la pacientul cu hemoptizii, f.d.u. începului de frază:
1. bronhoscopia flexibilă;
 2. bronhoscopia rigidă;
- a. este utilă pentru vizualizarea leziunilor endobronșice;
- b. este adesea preferabilă când sângerea este masivă;
- c. este utilă pentru depistarea sediului sângerării;
- d. permite un control mai bun asupra căilor respiratorii și o capacitate de aspirație mai mare.
- care sunt asociate corecte:
- A. a-1, b-1, c-2, d-2;
 - B. a-1, b-2, c-1, d-2;
 - C. a-1, b-2, c-2, d-1;
 - D. a-2, b-1, c-1, d-1;
 - E. a-2, b-1, c-2, d-1;

Cianoza – dr.D.D., dr.O.M.S.

1061. R.I. cianoza, u.a.s.c.g.e.:

- A. pacienții cu policitemia vera devin cianotici la saturații ale Hgb (S_{aO_2}) mai mari decât în cazul celor cu hematocrit normal;

- B. detectarea corectă clinică a prezenței și a gradului cianozei este dificilă, fapt dovedit de investigațiile oximetrice;
- C. sulfhemoglobinemia apare de obicei după expunerea la frig;
- D. saturația sângelui venos sistolic, către teritoriul arterial se realizează prin șunturi dreapta-spre-stânga cardiace sau pulmonare;
- E. entrocianoza este caracteristică pentru policitemia vera;
1062. R.I. cianoza, u.a.s.c.g.e.:
- A. în general, cianoza devine vizibilă când concentrația hemoglobinei reduce din sângele capilar scade sub 4 g/dL;
 - B. la unele persoane, cianoza centrală poate fi detectată cu fidelitate când S_{aO_2} scade la 85%;
 - C. sulfhemoglobina provoacă cianoza la o concentrație sanguină mai mică decât metemoglobina;
 - D. discrepanța ventilație-perfuzie determină perfuzarea spațiilor aeriene ventilate deficitar;
 - E. roșeața pleotică din policitemia vera are o tentă cianotică;
1063. R.I. cianoza, u.a.s.c.g.e.:
- A. factorul determinant pentru apariția cianozei este procentul de Hgb redus;
 - B. la unele persoane, în special la cele de culoare, cianoza centrală nu poate fi detectată decât după ce S_{aO_2} a scăzut până la 75%;
 - C. prezența în circulație a metemoglobinei în mici cantități (1.5 g/dL) produce cianoza;
 - D. prezența și severitatea cianozei prin mecanism de șunt depind de dimensiunea relativă a șuntului față de fluxul sistemic;
 - E. în diagnosticul diferențial al cianozei este importantă diferențierea de alte colorații asemănătoare ale pielii;
1064. R.I. cianoza, u.a.s.c.g.e.:
- A. gradul cianozei depinde de pigmentația naturală a pielii;
 - B. la persoanele de culoare, pentru detectarea cianozei este mai utilă examinarea pielii decât a mucoasei bucale și a conjunctivelor;
 - C. prezența în circulație a sulfhemoglobinei în cantități mici (0.5 g/dL) produce cianoza;
 - D. prezența și severitatea cianozei prin mecanism de șunt depind de

1065. R.I. cianoza, u.a.s.c.g.e.:
- A. cianoza poate fi generalizată (centrală) sau localizată (care include cianoza periferică);
 - B. policitemia secundară indusă de hipoxemia cronică poate ameliora cianoza;
 - C. formele anormale de Hgb pot fi identificate prin spectroscopie;
 - D. în ciroză, cianoza poate fi produsă de fistule artero-venoase pulmonare;
 - E. diferențierea cianozei centrale de cea periferică poate fi dificilă clinic, mai ales în situațiile când cele două pot coexista;
1066. R.I. cianoza, u.a.s.c.g.e.:
- A. gradul cianozei depinde de starea capilarilor cutanate;
 - B. la pacienții cu hipoxemie acută apare adesea policitemie secundară;
 - C. variantele nefuncționale de Hgb nu se asociază cu hipocratism digital;
 - D. în ciroză, cianoza poate fi produsă de anastomoză între vena cavă și vena pulmonară;
 - E. cianoza centrală și cea periferică pot coexista în cazul șocului cardiogen asociat cu EPA;
1067. R.I. cianoza, u.a.s.c.g.e.:
- A. cianoza este mai adesea descoperită de un membru al familiei decât de pacient, mai ales dacă este recent instalată;
 - B. cianoza periferică este cianoza localizată care vizează toate teritoriile periferice;
 - C. metemoglobinemia poate fi ereditară sau dobândită;
 - D. probabil cea mai frecventă cauză de cianoză periferică este insuficiența cardiacă;
 - E. cianoza periferică se asociază cu degete hipocratice;
1068. R.I. cianoza, u.a.s.c.g.e.:
- A. gradul cianozei depinde de grosimea pielii;
 - B. de obicei, cianoza apare după depășirea altitudinii de 4000 m;
 - C. sulfhemoglobinemia este o tulburare dobândită;
 - D. fenomenul Raynaud constă în arterioconstricție excesivă provocată de expunerea la căldură;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; f.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, f.d. = referitor/referitoare la; u.f.d.f. = Următoarele fragmente dintr-o frază despre;

- E. cianoza centrală acută nu se asociază cu degete hipocretice;
1069. R.I. cianoza, u.a.s.c.g.e.;
A. cianoza prin mecanism de supt nu este influențată de administrarea de oxigen;
B. prezența hipocratismului digital la un pacient cu BPOC trebuie să ridice suspiciunea de cancer bronhopulmonar;
C. carboxihemoglobinemia nu este o veritabilă cianoză;
D. cianoza prezintă încă de la naștere sau din copilărie timpurie este provocată de obicei de BPOC;
E. cianoza prin supt apare primar în DSA;
1070. U.f.d.d. cianoza s.c.f.g.e.;
A. Cianoza reprezintă culoarea, B. albastruire a pielii și a mucoaselor determinată;
C. de scăderea cantității de hemoglobină redusă;
D. sau de derivați ai hemoglobinei;
E. în vasele de sânge mari din aceste regiuni;
1071. U.f.d.d. cianoza la pacienții cu anemie severă s.c.f.g.e.;
A. Dacă Hgb este mult scăzută chiar dacă procentul;
B. de Hgb redusă din cantitatea totală de Hgb este foarte mare;
C. (adică saturarea în O₂ a Hgb din sângele arterial este foarte;
D. scăzută) cantitatea absolută de Hgb redusă poate fi mare;
E. iar cianoza este evidentă;
1072. U.f.d.d. cianoza la pacienții poliglobulici s.c.f.g.e.;
A. Dacă Hgb este mult crescută;
B. (cum este cazul în policitemii, mai ales în policitemia veră);
C. cantitatea de Hgb redusă poate fi suficientă pentru apariția;
D. cianozei doar dacă există o;
E. deasaturare semnificativă a sângelui arterial;
1073. U.f.d.d. mecanismele cianozei s.c.f.g.e.;
A. Creșterea cantității de Hgb redusă;
B. din vasele cutanemucoase care produce cianoză poate fi;
C. determinată fie de scăderea cantității de sânge venos;
D. ca urmare a construcției venulelor și a extremităților venoase ale capilarelor;
E. fie de scăderea Sazr din sângele capilar;
1074. C.d.u. teritori este cel mai puțin adecvat pentru observarea cianozei;
A. boze;
C. urechii;
D. abdomen;
E. proeminențe malare;
1075. R.I. cauzele cianozei, f.d.u. categorii;
1. cianoza generalizată (centrală);
2. cianoza localizată;
și următoarele stări patologice:
a. anomalii ale hemoglobinei (cianoză hemoglobinică);
b. tulburări circulatorii care vizază un membru sau o porțiune dintr-un membru;
c. scăderea saturării în oxigen (Sazr) a sângelui arterial;
d. tulburări hemoglobinică);
e. carboxihemoglobinemie;
f. funcție respiratorie deficitară;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-2, b-1, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-2, d-1;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;
1076. R.I. cauzele cianozei, f.d.u. categorii;
1. cianoza generalizată (centrală);
2. cianoza localizată;
și următoarele stări patologice:
a. debit cardiac scăzut;
b. scăderea proporției de O₂ din aerul inspirat (F_{I,O2});
c. sistemică către teritoriul arterial;
d. obstrucție venoasă (TVP);
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-1, d-2;
B. a-1, b-2, c-2, d-1;
C. a-2, b-1, c-1, d-2;
D. a-2, b-1, c-2, d-1;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;
1077. R.I. cauzele cianozei, f.d.u. categorii;
1. cianoza generalizată (centrală);
2. cianoza localizată;
și următoarele stări patologice:
a. BPOC;
b. edem pulmonar;
c. fibroză pulmonară;
d. pneumonie masivă;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-1, d-2;
E. a-2, b-1, c-2, d-1;
1080. R.I. cauzele cianozei generalizate prin funcție respiratorie deficitară, f.d.u. categorii;
1. acută;
2. cronică;
și următoarele stări patologice:
a. BPOC;
b. edem pulmonar;
c. fibroză pulmonară;
d. pneumonie masivă;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-1, d-2;
E. a-2, b-1, c-2, d-1;
1081. F.d. principalele două tipuri de cianoză;
1. cianoza generalizată (centrală);
2. cianoza localizată;
și următoarele stări patologice:
a. BPOC;
b. edem pulmonar;
c. fibroză pulmonară;
d. pneumonie masivă;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-1, d-2;
E. a-2, b-1, c-2, d-1;
1082. F.d. evenimente r.l. una dintre cauzele cianozei centrale;
a. scădere presiunea atmosferică;
b. scădere proporția de O₂ din aerul inspirat (F_{I,O2});
c. scădere Praz;
d. (dacă nu există o creștere compensatorie suficientă a ventilației alveolare) scădere P_{O2} alveolară;
e. scădere Sazr;
f. altitudine înaltă;
care este lanțul causal corect:
A. b → a → d → f → e → c;
B. c → e → f → d → a → b;
C. d → e → a → b → c → f;
D. e → a → f → c → d → b;
E. f → a → b → d → c → e;
1083. R.I. cauzele cianozei localizate, f.d.u. categorii;
1. tulburări circulatorii care vizază un membru sau o porțiune dintr-un membru;
2. tulburări circulatorii care vizază toate teritoriile periferice (cianoză periferică);
și următoarele stări patologice:
a. obstrucție arterială;
b. redistribuirea fluxului de sânge de la extremități;
c. debit cardiac scăzut;
d. obstrucție venoasă (TVP);
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-1, d-2;
E. a-2, b-1, c-2, d-1;
1084. F.d. principalele două tipuri de cianoză;
1. cianoza generalizată (centrală);
2. cianoza localizată;
și următoarele stări patologice:
a. BPOC;
b. edem pulmonar;
c. fibroză pulmonară;
d. pneumonie masivă;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-1, d-2;
E. a-2, b-1, c-2, d-1;
1085. F.d. principalele două tipuri de cianoză;
1. cianoza generalizată (centrală);
2. cianoza periferică prin scăderea debitului cardiac;
și următoarele stări patologice:
a. este provocată de oxigenarea deficitară a sângelui arterial;
b. nu depinde de lungimea circuitului vascular;
c. se observă doar la extremități (pații unghi de la degete);
d. dispare la încălzirea unui teritoriu periferic;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-1, d-2;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;
1086. F.d. principalele două tipuri de cianoză;
1. cianoza generalizată (centrală);
2. cianoza periferică prin scăderea debitului cardiac;
și următoarele stări patologice:
a. poate fi provocată de prezența unui derivat anormal de hemoglobină;
b. dispare la masarea unui teritoriu periferic (extremitatea unui deget sau lobul urechii) (semnul Lewis);
c. este caldă;
d. nu se observă în teritoriile apropiate de inimă, care sunt de cianoză;
1087. F.d. tipuri de cianoză;
1. cianoza generalizată (centrală);
2. cianoza periferică;
3. cianoza periferică prin redistribuirea fluxului de sânge de la extremități;
și următoarele stări patologice:
a. expunerea la frig (la aer sau apă rece);
b. dispare la manevre care cresc fluxul de sânge în teritoriu respectiv;
c. se asociază cu vasodilatație periferică;
d. cianoza se poate observa atât la piele, cât și la mucoase, care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-3, c-2, d-1;
B. a-2, b-1, c-1, d-3;
C. a-2, b-1, c-3, d-1;
D. a-2, b-3, c-1, d-1;
E. a-3, b-2, c-1, d-1;
1088. F.d.u. tipuri de cianoză;
1. cianoza generalizată (centrală);
2. cianoza periferică;
3. cianoza periferică prin redistribuirea fluxului de sânge de la extremități;
și următoarele stări patologice:
a. expunerea la frig (la aer sau apă rece);
b. dispare la manevre care cresc fluxul de sânge în teritoriu respectiv;
c. se asociază cu vasodilatație periferică;
d. este provocată de fluxul de sânge scăzut în teritoriu respectiv;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-3, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-3;
C. a-1, b-2, c-3, d-1;
D. a-1, b-3, c-1, d-2;
E. a-1, b-3, c-2, d-1;
1089. F.d.u. evenimente r.l. cianoza periferică;
a. vasodilatație periferică;
b. extremitățile sunt cianotice, calde și transpirate/umede;
c. hipoxemie (eventual și hipercapnie);
care este lanțul causal corect:
A. a → b → c;
B. a → c → b;
C. b → a → c;
D. c → a → b;
E. c → b → a;
1090. F.d.u. evenimente r.l. cianoza periferică;
a. vasoconstricție periferică pentru a redistribui sângele spre organele vitale;
b. scăderea debitului cardiac;

Prescurtări frecvent folosite: c.g. = cu excepție, s.g.e. = sunt următoarele, cu excepția, u.a.s.c.g.e. = următoarele afirmări sunt corecte, cu excepția, s.c.f.g.e. = sunt corect formulate, cu excepția.

1081. R.I. fisurile arteriovenozose pulmonare, u.a.s.c.g.e.;
A. pot fi congenitale sau dobândite;
B. pot fi izolate sau multiple;
C. pot fi microscopice (nici sunt multiple intrapulmonare) sau masive;
D. produc cianoză a cărei severitate depinde de dimensiunea și numărul lor;
E. sunt mai frecvente în scleroza sistemică;
1082. F.d.u. evenimente r.l. una dintre cauzele cianozei centrale;
a. scădere presiunea atmosferică;
b. scădere proporția de O₂ din aerul inspirat (F_{I,O2});
c. scădere Praz;
d. (dacă nu există o creștere compensatorie suficientă a ventilației alveolare) scădere P_{O2} alveolară;
e. scădere Sazr;
f. altitudine înaltă;
care este lanțul causal corect:
A. b → a → d → f → e → c;
B. c → e → f → d → a → b;
C. d → e → a → b → c → f;
D. e → a → f → c → d → b;
E. f → a → b → d → c → e;
1083. R.I. cauzele cianozei localizate, f.d.u. categorii;
1. tulburări circulatorii care vizază un membru sau o porțiune dintr-un membru;
2. tulburări circulatorii care vizază toate teritoriile periferice (cianoză periferică);
și următoarele stări patologice:
a. obstrucție arterială;
b. redistribuirea fluxului de sânge de la extremități;
c. debit cardiac scăzut;
d. obstrucție venoasă (TVP);
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-1, d-2;
E. a-2, b-1, c-2, d-1;
1084. F.d. principalele două tipuri de cianoză;
1. cianoza generalizată (centrală);
2. cianoza localizată;
și următoarele stări patologice:
a. BPOC;
b. edem pulmonar;
c. fibroză pulmonară;
d. pneumonie masivă;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-1, d-2;
E. a-2, b-1, c-2, d-1;
1085. F.d. principalele două tipuri de cianoză;
1. cianoza generalizată (centrală);
2. cianoza periferică prin scăderea debitului cardiac;
și următoarele stări patologice:
a. este provocată de oxigenarea deficitară a sângelui arterial;
b. nu depinde de lungimea circuitului vascular;
c. se observă doar la extremități (pații unghi de la degete);
d. dispare la încălzirea unui teritoriu periferic;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-1, d-2;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;
1086. F.d. principalele două tipuri de cianoză;
1. cianoza generalizată (centrală);
2. cianoza periferică prin scăderea debitului cardiac;
și următoarele stări patologice:
a. poate fi provocată de prezența unui derivat anormal de hemoglobină;
b. dispare la masarea unui teritoriu periferic (extremitatea unui deget sau lobul urechii) (semnul Lewis);
c. este caldă;
d. nu se observă în teritoriile apropiate de inimă, care sunt de cianoză;
1087. F.d. tipuri de cianoză;
1. cianoza generalizată (centrală);
2. cianoza periferică;
3. cianoza periferică prin redistribuirea fluxului de sânge de la extremități;
și următoarele stări patologice:
a. expunerea la frig (la aer sau apă rece);
b. dispare la manevre care cresc fluxul de sânge în teritoriu respectiv;
c. se asociază cu vasodilatație periferică;
d. cianoza se poate observa atât la piele, cât și la mucoase, care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-3, c-2, d-1;
B. a-2, b-1, c-1, d-3;
C. a-2, b-1, c-3, d-1;
D. a-2, b-3, c-1, d-1;
E. a-3, b-2, c-1, d-1;
1088. F.d.u. tipuri de cianoză;
1. cianoza generalizată (centrală);
2. cianoza periferică;
3. cianoza periferică prin redistribuirea fluxului de sânge de la extremități;
și următoarele stări patologice:
a. expunerea la frig (la aer sau apă rece);
b. dispare la manevre care cresc fluxul de sânge în teritoriu respectiv;
c. se asociază cu vasodilatație periferică;
d. este provocată de fluxul de sânge scăzut în teritoriu respectiv;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-3, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-3;
C. a-1, b-2, c-3, d-1;
D. a-1, b-3, c-1, d-2;
E. a-1, b-3, c-2, d-1;
1089. F.d.u. evenimente r.l. cianoza periferică;
a. vasodilatație periferică;
b. extremitățile sunt cianotice, calde și transpirate/umede;
c. hipoxemie (eventual și hipercapnie);
care este lanțul causal corect:
A. a → b → c;
B. a → c → b;
C. b → a → c;
D. c → a → b;
E. c → b → a;
1090. F.d.u. evenimente r.l. cianoza periferică;
a. vasoconstricție periferică pentru a redistribui sângele spre organele vitale;
b. scăderea debitului cardiac;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele, c.d.u. = care dintre următoarele, f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, r.l. = referitor/referitoare la, U.f.d.d. = următoarele fragmente dintr-o frază descriptivă.

c. extremitățile sunt reci și cianotice; care este lanțul causal corect: A. a-b-c; B. a-b-c-b; C. b-a-c; D. b-a-c-b; E. c-a-b; 1091. R.I. cianoza periferică, u.a.s.c. e.g.; A. depinde de lungimea circuitului vascular; B. este rece; C. afectează limba; D. dispare la frecarea lobului urechii; E. poate fi o consecință a ICS și anterogradă a ICD; 1092. R.I. cianoza centrală, u.a.s.c. e.g.; A. nu depinde de lungimea circuitului vascular; B. este caldă; C. afectează mucoasa bucală; D. nu dispare la frecarea lobului urechii; E. poate fi o consecință anterogradă a ICS; 1093. F.d.u. cardiopatii congenitale cianogene: 1. tetradă Fallot; 2. triadă Fallot; 3. sindrom Eisenmenger; și următoarele caracteristici: a. HTP secundară cu inversarea șuntului și apariția cianozei; b. stenoză pulmonară + DSA + HVD; c. stenoză pulmonară + DSV + aorta călare pe SIV/DSV + HVD; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 1094. C.d.u. elemente nu este definitiv pentru tetradă Fallot: B. DSV; C. hipocratism; D. aorta călare pe SIV (de fapt, pe DSV); E. HVD; 1095. F.d.u. evenimente tetradă Fallot: a. HVD cu îngroșarea pereților conului de eiecție al VD; b. îngustarea tractului de evacuare al VD; c. stenoza pulmonară;	d. accentuarea obstrucției la evacuarea VD; e. accentuarea șuntului dreapta-spre-stânga; care este lanțul causal corect: A. a-e-d-c-b; B. b-c-e-a-d; C. c-a-b-d-e; D. d-e-a-c-b; E. e-d-b-a-c; 1096. R.I. tetradă Fallot, u.a.s.c. e.g.; A. cianoza este generalizată și se instalează precoce; B. cianoza este influențată în primul rând de severitatea DSV; C. hipocratismul digital este tipic; D. dezvoltarea copilului poate fi deficitară din cauza hipoxemiei; E. în mod caracteristic, cianoza poate diminua în ortostatism; 1097. F.d.u. afirmații care explică diminuarea cianozei în poziția „pe vine” la copii cu tetradă Fallot: a. crește rezistența vasculară periferică; b. scade cantitatea de sânge ejectată în aortă; c. scade magnitudinea șuntului dreapta-spre-stânga; d. crește cantitatea de sânge ejectată în artera pulmonară; care este lanțul causal logic just: A. a-b-d-c; B. b-a-c-d; C. b-c-a-d; D. c-b-d-a; E. d-a-c-b; 1098. F.d.u. evenimente care explică creșterea rezistenței vasculare pulmonare în cardiopatii congenitale caracterizate prin debit crescut în circulația pulmonară (DSA, DSV): a. șuntul este stânga-spre-dreapta; b. în timp, apar modificări proliferative (musculatură netedă) și fibroase în microvasule (arteriole și capilare) pulmonare; c. inițial, presiunea este mai mare în cavitățile stângi; d. presiune crescută asupra peretelui vaselor mici pulmonare; e. crește rezistența vasculară pulmonară; f. supraincercarea circulației pulmonare; care este lanțul causal corect: A. c-a-b-f-d-b-a-c;	B. c-b-f-a-e-d-a; C. c-d-a-f-e-b; D. c-e-b-d-a-f; E. c-f-a-e-d-b; 1099. F.d.u. evenimente care explică apariția sindromului Eisenmenger secundar cardiopatiilor congenitale caracterizate prin debit crescut în circulația pulmonară (DSA, DSV): a. presiunile din cavitățile drepte depășesc presiunile din cavitățile stângi; b. cresc presiunile din cavitățile drepte; c. apare cianoza; d. inversarea șuntului (devine dreapta-spre-stânga); e. HTP secundară; f. rezistență vasculară pulmonară crescută; 1100. R.I. cianoza localizată determinată de obstrucția arterială, f.d.u. variante: 1. obstrucția arterială cronică; 2. obstrucția arterială acută; și următoarele trăsături: a. provocată de arteriopatia obliterantă, cel mai adesea secundară aterosclerozei; b. cianoza membrului afectat, asociată cu scăderea temperaturii cutanate; c. provocată, de regulă, de o embolie; d. inițial paloare și răcoala, ulterior se poate instala cianoza; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-1, c-2, d-2; B. a-1, b-2, c-2, d-1; C. a-2, b-1, c-1, d-2; D. a-2, b-1, c-2, d-1; E. a-2, b-2, c-1, d-1;	1101. F.d.u. evenimente r.l. cianoza localizată la un membru: cianotică; a. leguminal capătă o tentă cianotică; b. congestie pasivă locală; c. crește cantitatea totală de Hgb redusă din vasele regiunii respective; d. obstrucție venoasă; care este lanțul causal corect: A. a-d-b-c; B. b-c-d-a; C. b-d-a-c;	a. sângele este deviat de la piele spre organele vitale (sistemul nervos central și înima); b. se produce vasodilatația (nu vasoconstricție) periferică; c. cantitatea totală de Hgb fiind prea mică, cantitatea de Hgb redusă este insuficientă; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 1106. F.d.u. evenimente care explică intensificarea la efort a cianozei prin mecanism de șunt: a. extragere crescută a O₂ din sânge de către mușchii care fac efort; b. sângele venos care se întoarce la inima dreaptă este mai nesaturat decât în repaus; c. șuntarea sângelui venos nesaturat intensifică cianoza; care este lanțul causal corect: A. a-b-c; B. b-a-c; C. c-b-a; D. d-c-a; E. e-d-a-c-b; 1104. R.I. cianoza periferică, f.d.u. modificări vasculare: 1. vasoconstricție cronică; 2. vasoconstricție acută; și următoarele trăsături: a. deși sângele pleacă din inimă normal oxigenat (SaO₂ normală), este desaturat excesiv în teritoriile periferice; b. jessurile periferice extrag o cantitate anormal de mare de O₂ din sânge; c. în șocul cardiogen sau hipovolemic; d. în IC congestivă; e. apare mai degrabă paloare decât cianoza; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-1, c-1, d-2, e-2; B. a-1, b-1, c-2, d-1, e-2; C. a-1, b-1, c-2, d-2, e-1; D. a-1, b-2, c-1, d-2, e-1; E. a-2, b-2, c-1, d-1, e-1;	a. sângele este deviat de la piele spre organele vitale (sistemul nervos central și înima); b. se produce vasodilatația (nu vasoconstricție) periferică; c. cantitatea totală de Hgb fiind prea mică, cantitatea de Hgb redusă este insuficientă; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 1106. F.d.u. evenimente care explică intensificarea la efort a cianozei prin mecanism de șunt: a. extragere crescută a O₂ din sânge de către mușchii care fac efort; b. sângele venos care se întoarce la inima dreaptă este mai nesaturat decât în repaus; c. șuntarea sângelui venos nesaturat intensifică cianoza; care este lanțul causal corect: A. a-b-c; B. b-a-c; C. c-b-a; D. d-c-a; E. e-d-a-c-b; 1104. R.I. cianoza periferică, f.d.u. modificări vasculare: 1. vasoconstricție cronică; 2. vasoconstricție acută; și următoarele trăsături: a. deși sângele pleacă din inimă normal oxigenat (SaO₂ normală), este desaturat excesiv în teritoriile periferice; b. jessurile periferice extrag o cantitate anormal de mare de O₂ din sânge; c. în șocul cardiogen sau hipovolemic; d. în IC congestivă; e. apare mai degrabă paloare decât cianoza; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-1, c-1, d-2, e-2; B. a-1, b-1, c-2, d-1, e-2; C. a-1, b-1, c-2, d-2, e-1; D. a-1, b-2, c-1, d-2, e-1; E. a-2, b-2, c-1, d-1, e-1;	d. Hgb are afinitate crescută pentru oxigen; care este lanțul causal corect: A. a-b-c-d; B. a-c-d-b; C. b-c-d-a; D. c-b-d-a; E. d-b-a-c; 1109. F.d.u. evenimente care explică cianoza din suflimoglobinemie: a. expunerea la anumite medicamente; b. Hgb nu mai poate fi convertită la normal; c. Hgb nu mai poate transporta oxigen; d. sulful se leagă de hem; care este lanțul causal corect: A. a-c-d-b; B. a-d-b-c; C. b-a-c-d; D. b-c-d-a; E. c-a-b-d; 1110. R.I. cauzele fenomenului Raynaud, f.d.u. mecanisme: 1. leziune microvasculară; 2. ocluzia lumenului vaselor mici; 3. îngustarea lumenului vaselor mari; și următoarele stări patologice: a. crioglobulinemii; b. boli autoimune (scleroză sistemică, lupus eritematos sistemic); c. anomalii anatomice care determină compresia axului arterial; d. boli limfoproliferative (cu producție de aglutinine la rece); care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-3, c-2, d-2; B. a-2, b-1, c-2, d-3; C. a-2, b-1, c-3, d-2; D. a-3, b-1, c-2, d-2; E. a-3, b-2, c-1, d-2; 1111. R.I. explicația culorii pacientului cu policitemia vera, f.d.u. cauze: 1. cantitate mare de Hgb; 2. cantitate mare de Hgb redusă; 3. roșeață pleotică având o tentă cianotică; și următoarele consecințe: a. etiotocianică; b. tentă cianotică; c. cantitate mare de Hgb redusă; d. roșeață pleotică; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-1, c-3, d-2; B. a-2, b-1, c-1, d-3; C. a-2, b-1, c-3, d-1;	a. sângele este deviat de la piele spre organele vitale (sistemul nervos central și înima); b. se produce vasodilatația (nu vasoconstricție) periferică; c. cantitatea totală de Hgb fiind prea mică, cantitatea de Hgb redusă este insuficientă; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 1106. F.d.u. evenimente care explică intensificarea la efort a cianozei prin mecanism de șunt: a. extragere crescută a O₂ din sânge de către mușchii care fac efort; b. sângele venos care se întoarce la inima dreaptă este mai nesaturat decât în repaus; c. șuntarea sângelui venos nesaturat intensifică cianoza; care este lanțul causal corect: A. a-b-c; B. b-a-c; C. c-b-a; D. d-c-a; E. e-d-a-c-b; 1104. R.I. cianoza periferică, f.d.u. modificări vasculare: 1. vasoconstricție cronică; 2. vasoconstricție acută; și următoarele trăsături: a. deși sângele pleacă din inimă normal oxigenat (SaO₂ normală), este desaturat excesiv în teritoriile periferice; b. jessurile periferice extrag o cantitate anormal de mare de O₂ din sânge; c. în șocul cardiogen sau hipovolemic; d. în IC congestivă; e. apare mai degrabă paloare decât cianoza; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-1, c-1, d-2, e-2; B. a-1, b-1, c-2, d-1, e-2; C. a-1, b-1, c-2, d-2, e-1; D. a-1, b-2, c-1, d-2, e-1; E. a-2, b-2, c-1, d-1, e-1;	a. sângele este deviat de la piele spre organele vitale (sistemul nervos central și înima); b. se produce vasodilatația (nu vasoconstricție) periferică; c. cantitatea totală de Hgb fiind prea mică, cantitatea de Hgb redusă este insuficientă; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 1106. F.d.u. evenimente care explică intensificarea la efort a cianozei prin mecanism de șunt: a. extragere crescută a O₂ din sânge de către mușchii care fac efort; b. sângele venos care se întoarce la inima dreaptă este mai nesaturat decât în repaus; c. șuntarea sângelui venos nesaturat intensifică cianoza; care este lanțul causal corect: A. a-b-c; B. b-a-c; C. c-b-a; D. d-c-a; E. e-d-a-c-b; 1104. R.I. cianoza periferică, f.d.u. modificări vasculare: 1. vasoconstricție cronică; 2. vasoconstricție acută; și următoarele trăsături: a. deși sângele pleacă din inimă normal oxigenat (SaO₂ normală), este desaturat excesiv în teritoriile periferice; b. jessurile periferice extrag o cantitate anormal de mare de O₂ din sânge; c. în șocul cardiogen sau hipovolemic; d. în IC congestivă; e. apare mai degrabă paloare decât cianoza; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-1, c-1, d-2, e-2; B. a-1, b-1, c-2, d-1, e-2; C. a-1, b-1, c-2, d-2, e-1; D. a-1, b-2, c-1, d-2, e-1; E. a-2, b-2, c-1, d-1, e-1;	a. sângele este deviat de la piele spre organele vitale (sistemul nervos central și înima); b. se produce vasodilatația (nu vasoconstricție) periferică; c. cantitatea totală de Hgb fiind prea mică, cantitatea de Hgb redusă este insuficientă; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 1106. F.d.u. evenimente care explică intensificarea la efort a cianozei prin mecanism de șunt: a. extragere crescută a O₂ din sânge de către mușchii care fac efort; b. sângele venos care se întoarce la inima dreaptă este mai nesaturat decât în repaus; c. șuntarea sângelui venos nesaturat intensifică cianoza; care este lanțul causal corect: A. a-b-c; B. b-a-c; C. c-b-a; D. d-c-a; E. e-d-a-c-b; 1104. R.I. cianoza periferică, f.d.u. modificări vasculare: 1. vasoconstricție cronică; 2. vasoconstricție acută; și următoarele trăsături: a. deși sângele pleacă din inimă normal oxigenat (SaO₂ normală), este desaturat excesiv în teritoriile periferice; b. jessurile periferice extrag o cantitate anormal de mare de O₂ din sânge; c. în șocul cardiogen sau hipovolemic; d. în IC congestivă; e. apare mai degrabă paloare decât cianoza; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-1, c-1, d-2, e-2; B. a-1, b-1, c-2, d-1, e-2; C. a-1, b-1, c-2, d-2, e-1; D. a-1, b-2, c-1, d-2, e-1; E. a-2, b-2, c-1, d-1, e-1;	a. sângele este deviat de la piele spre organele vitale (sistemul nervos central și înima); b. se produce vasodilatația (nu vasoconstricție) periferică; c. cantitatea totală de Hgb fiind prea mică, cantitatea de Hgb redusă este insuficientă; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 1106. F.d.u. evenimente care explică intensificarea la efort a cianozei prin mecanism de șunt: a. extragere crescută a O₂ din sânge de către mușchii care fac efort; b. sângele venos care se întoarce la inima dreaptă este mai nesaturat decât în repaus; c. șuntarea sângelui venos nesaturat intensifică cianoza; care este lanțul causal corect: A. a-b-c; B. b-a-c; C. c-b-a; D. d-c-a; E. e-d-a-c-b; 1104. R.I. cianoza periferică, f.d.u. modificări vasculare: 1. vasoconstricție cronică; 2. vasoconstricție acută; și următoarele trăsături: a. deși sângele pleacă din inimă normal oxigenat (SaO₂ normală), este desaturat excesiv în teritoriile periferice; b. jessurile periferice extrag o cantitate anormal de mare de O₂ din sânge; c. în șocul cardiogen sau hipovolemic; d. în IC congestivă; e. apare mai degrabă paloare decât cianoza; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-1, c-1, d-2, e-2; B. a-1, b-1, c-2, d-1, e-2; C. a-1, b-1, c-2, d-2, e-1; D. a-1, b-2, c-1, d-2, e-1; E. a-2, b-2, c-1, d-1, e-1;	a. sângele este deviat de la piele spre organele vitale (sistemul nervos central și înima); b. se produce vasodilatația (nu vasoconstricție) periferică; c. cantitatea totală de Hgb fiind prea mică, cantitatea de Hgb redusă este insuficientă; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 1106. F.d.u. evenimente care explică intensificarea la efort a cianozei prin mecanism de șunt: a. extragere crescută a O₂ din sânge de către mușchii care fac efort; b. sângele venos care se întoarce la inima dreaptă este mai nesaturat decât în repaus; c. șuntarea sângelui venos nesaturat intensifică cianoza; care este lanțul causal corect: A. a-b-c; B. b-a-c; C. c-b-a; D. d-c-a; E. e-d-a-c-b; 1104. R.I. cianoza periferică, f.d.u. modificări vasculare: 1. vasoconstricție cronică; 2. vasoconstricție acută; și următoarele trăsături: a. deși sângele pleacă din inimă normal oxigenat (SaO₂ normală), este desaturat excesiv în teritoriile periferice; b. jessurile periferice extrag o cantitate anormal de mare de O₂ din sânge; c. în șocul cardiogen sau hipovolemic; d. în IC congestivă; e. apare mai degrabă paloare decât cianoza; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-1, c-1, d-2, e-2; B. a-1, b-1, c-2, d-1, e-2; C. a-1, b-1, c-2, d-2, e-1; D. a-1, b-2, c-1, d-2, e-1; E. a-2, b-2, c-1, d-1, e-1;	a. sângele este deviat de la piele spre organele vitale (sistemul nervos central și înima); b. se produce vasodilatația (nu vasoconstricție) periferică; c. cantitatea totală de Hgb fiind prea mică, cantitatea de Hgb redusă este insuficientă; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 1106. F.d.u. evenimente care explică intensificarea la efort a cianozei prin mecanism de șunt: a. extragere crescută a O₂ din sânge de către mușchii care fac efort; b. sângele venos care se întoarce la inima dreaptă este mai nesaturat decât în repaus; c. șuntarea sângelui venos nesaturat intensifică cianoza; care este lanțul causal corect: A. a-b-c; B. b-a-c; C. c-b-a; D. d-c-a; E. e-d-a-c-b; 1104. R.I. cianoza periferică, f.d.u. modificări vasculare: 1. vasoconstricție cronică; 2. vasoconstricție acută; și următoarele trăsături: a. deși sângele pleacă din inimă normal oxigenat (SaO₂ normală), este desaturat excesiv în teritoriile periferice; b. jessurile periferice extrag o cantitate anormal de mare de O₂ din sânge; c. în șocul cardiogen sau hipovolemic; d. în IC congestivă; e. apare mai degrabă paloare decât cianoza; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-1, c-1, d-2, e-2; B. a-1, b-1, c-2, d-1, e-2; C. a-1, b-1, c-2, d-2, e-1; D. a-1, b-2, c-1, d-2, e-1; E. a-2, b-2, c-1, d-1, e-1;
--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Prescurtări frecvent folosite: u. = umătorele; c.d.u. = care dăre umătorele; f.d. = fiind date; f.d.u. = fiind date umătorele; r.l. = referitor/referitoare la; U.I.f.d. = Umătorele fragmente dintr-o frază despre.

- D. a-2, b-3, c-1, d-1;
E. a-3, b-2, c-1, d-1;
1112. R.L. diagnosticul diferențial al cianozelor și al cauzelor acestora, f.d.u. trăsături:
1. cianoză prezintă încă de la naștere sau din copilăria timpurie;
 2. cianoză apare tardiv, după instalarea HTAP;
 3. eritrocianoza (roșeață pleoară având tenă cianotică);
- și următoarele stări patologice:
- a. policitemia veră;
 - b. cardiopatie congenitală cianogenă, de exemplu tetradă Fallot;
 - c. cardiopatie congenitală de tip DSA/DSV;
- care sunt asociate corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
 - B. a-1, b-3, c-2;
 - C. a-2, b-1, c-3;
 - D. a-2, b-3, c-1;
 - E. a-3, b-1, c-2;
1113. R.L. diagnosticul diferențial al cianozelor pe baza manifestărilor asociate, f.d.u. tipuri de manifestări:
1. manifestări sugestive pentru o boală respiratorie sau o cardiopatie congenitală;
 2. manifestări sugestive pentru o boală cardiacă generatoare de IC;
 3. manifestări sugestive pentru boala vasculară (arterială sau periferică);
- și următoarele variante de cianoză:
- a. mai degrabă cianoză periferică;
 - b. cianoză localizată;
 - c. mai degrabă cianoză centrală, care sunt asociate corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
 - B. a-1, b-3, c-2;
 - C. a-2, b-1, c-3;
 - D. a-2, b-3, c-1;
 - E. a-3, b-1, c-2;
1114. R.L. hipocratismului digital, u.a.s.c.g.e.:
- A. pledează pentru cianoză centrală cronică, veche;
 - B. apare uneori la pacienți cu boală pulmonară, cum ar fi emfizemul pulmonar;
 - C. constă în tumefacția globuloasă a segmentelor distale ale degetelor de la mâini și picioare;
1115. R.L. hipocratismului digital, u.a.s.c.g.e.:
- A. este frecvent la pacienți cu cardiopatie congenitală cianogenă (cu sunt dreapta-spre-sînga);
 - B. apare uneori la pacienți cu fistule arteriovenoase pulmonare;
 - C. apare prin proliferarea țesutului conjunctiv, mai ales pe suprafața dorsală a degetelor;
 - D. ar putea fi provocat de un factor circulant (prostaglandin?) care determină vasoconstricția la vârfurile degetelor;
 - E. poate fi o anomalie profesională (apare la lucrătorii cu cianoc pneumatic);
1116. R.L. cauzele hipocratismului digital, f.d.u. categorii de boli:
1. cardiace;
 2. pleuropulmonare;
 3. digestive;
- și următoarele afecțiuni:
- a. cancer pulmonar primar și metastatic;
 - b. cardiopatie congenitală cianogenă;
 - c. fibroză chistică;
 - d. boli inflamatorii intestinale;
- care sunt asociate corecte:
- A. a-1, b-3, c-2, d-2;
 - B. a-2, b-1, c-2, d-3;
 - C. a-2, b-3, c-1, d-2;
 - D. a-2, b-3, c-2, d-1;
 - E. a-3, b-1, c-2, d-2;
1117. R.L. cauzele hipocratismului digital, f.d.u. categorii de boli:
1. cardiace;
 2. pleuropulmonare;
 3. digestive;
- și următoarele afecțiuni:
- a. mezoteliom;
 - b. supurații pulmonare (bronșectazii, abces pulmonar);
 - c. ciroză hepatică;
 - d. endocardită infecțioasă;
- care sunt asociate corecte:
- A. a-2, b-2, c-1, d-3;
 - B. a-2, b-2, c-3, d-1;
 - C. a-2, b-3, c-1, d-2;
 - D. a-2, b-3, c-2, d-1;
 - E. a-3, b-1, c-2, d-2;
1118. Afecțiuni cu care se asociază osteoartropatia hipertrofică s.u.g.e.:
- A. a-1, b-2, c-3;
 - B. a-2, b-1, c-3;
 - C. a-2, b-3, c-1;

Prescurtări frecvent folosite: E.A. = cu excepția, s.u.c.g.e. = sunt următoarele, cu excepția, u.a.s.c.g.e. = următoarele afirmații sunt corecte, cu excepția, s.c.i.c.g.e. = sunt corect formulate, cu excepția.

- D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
1122. C.d.u. mecanisme de producere a cianozelor nu este caracteristic pentru CPC decompensat:
- A. sunt intrapulmonare;
 - B. cianoză centrală prin oxigenare deficitară a sângelui;
 - C. cianoză centrală prin poliglobulie;
 - D. cianoză periferică prin stază venoasă sistemică (secundară IVSD);
- E. cianoză periferică prin consum periferic excesiv (în mușchi respiratori);
1123. Caracteristicile cianozelor s.u.g.e.:
- A. este rece;
 - B. poate fi localizată;
 - C. nu este influențată de administrarea de oxigen;
 - D. poate fi generalizată;
 - E. asociată cu manifestări de afectare respiratorie;
1124. Cianoză este o colorație albastră-violacee a tegumentelor și mucoaselor determinată de:
- A. raportul dintre oxihemoglobină și hemoglobină redusă;
 - B. diferența arterio-venoasă a presiunii parțiale a oxigenului;
 - C. cantitatea de hemoglobină redusă;
 - D. cantitatea de oxihemoglobină;
 - E. gradul de saturare a hemoglobinei;
1125. Cianoză periferică localizată poate corespunde următoarelor, c.e.:
- A. arocianoze;
 - B. sindrom Raynaud;
 - C. tromboflebit;
 - D. insuficiență cardiacă;
 - E. varice;
1126. C.d.u. produce cianoză generalizată:
- A. hemoglobină anormală;
 - B. stază generalizată;
 - C. spasm arterial;
 - D. obstacol venos;
 - E. obstrucție arterială periferică;
1127. C.d.u. NU este o cauză de cianoză generalizată:
- A. suferențiozitatea;
 - B. hipovolemia alveolară;
 - C. altitudine > 5000 m;
 - D. malformații cardiace congenitale;
 - E. stază generalizată;
1128. Despre cianoză centrală u.a.s.c.g.e.:
- A. este caldă;
 - B. se întâlnește în boli cardiace congenitale;
 - C. poate să dispară la administrarea de oxigen;
 - D. se poate ameliora temporar prin activarea locală a circulației;
 - E. este generalizată;
- Dureea toracică – Dr.D.D., Dr.M.M.M.
1129. R.L. durerea toracică (DurTor), u.a.s.c.g.e.:
- A. DurTor apare în afecțiuni ale organelor din întregul torace și abdomen;
 - B. dătră afecțiunile care provoacă DurTor, potențial de evoluție gravă au mai ales cele respiratorii;
 - C. DurTor provocată de SIAO este o durere de tip anginos;
 - D. DurTor de cauză esofagiană poate fi dificil de distins de durerea miocardică;
 - E. în general, afecțiunile organelor subdiaphragmatice determină durere abdominală asociată sau nu cu disconfort toracic;
1130. R.L. durerea toracică, u.a.s.c.g.e.:
- A. DurTor are implicații prognostice care variază de la benigne până la amenințătoare de viață;
 - B. dătră afecțiunile care provoacă DurTor, potențial de evoluție gravă au mai ales SCA (ischemia acută miocardică) și mai ales (MAI) Dăo și IEP;
 - C. DurTor din SIAO are durată, caracter și localizare similare celor din angina stabilă;
 - D. în sindromul Mallory-Weiss, DurTor este provocată de dătrărea mucoasei esofagiene din cauza RGE;
 - E. DurTor produsă de afecțiunile organelor subdiaphragmatice este dependentă de efort;
1131. R.L. durerea toracică, u.a.s.c.g.e.:
- A. la pacienți cu DurTor, nerecunoașterea unor afecțiuni potențial grave poate duce la complicații severe, inclusiv la deces;
 - B. o atenție excesivă acordată unor pacienți cu risc scăzut duce la spitalizări și la investigații inutile;
1132. R.L. trăsăturile clinice tipice ale principalelor cauze de durere toracică acută, f.d.u. cauze:
1. afecțiune musculoscheletică;
 2. pneumonie sau pleurită;
 3. ulcer peptic;
- și următoarele trăsături asociate:
- a. ameliorată de alimente sau antacide;
 - b. dispnee, tuse, febră, raluri crepitante, uneori frecventă pleurăzie;
 - c. agravată de mișcare, poate fi reproducută prin apăsarea pe anumite puncte/teritorii la examenul fizic;
- care sunt asociate corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
 - B. a-1, b-3, c-2;
 - C. a-2, b-1, c-3;
 - D. a-2, b-3, c-1;
 - E. a-3, b-2, c-1;
1133. R.L. trăsăturile clinice tipice ale principalelor cauze de durere toracică acută, f.d.u. cauze:
1. disecție de aortă;
 2. stenoză aortică;
 3. angină instabilă;
- și următoarele trăsături asociate:
- a. suflu sistolic, cu maxim întârziat, cu redare pe arterele carotide;
 - b. favorizată de HTA și/sau de o boală congenitală de țesut conjunctiv, de exemplu sindrom Marfan;
 - c. dure de tip anginos, care apare însoțit de niveluri de efort mai mici sau chiar în repaus;
- care sunt asociate corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
 - B. a-2, b-1, c-3;
 - C. a-2, b-3, c-1;
 - D. a-3, b-1, c-2;
 - E. a-3, b-2, c-1;
1134. R.L. trăsăturile clinice tipice ale principalelor cauze de durere toracică acută, f.d.u. cauze:
1. disecție de aortă;
 2. pericardită;
 3. tulburări emoționale sau psihice;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele; f.l. = referențiale; u.a.s.c.g.e. = sunt următoarele afirmații corecte, cu excepția; s.c.i.c.g.e. = sunt corect formulate, cu excepția.

1137. R.I. trăsăturile clinice tipice ale principalelor cauze de durere toracică acută, f.d.u. cauze:
1. embolism pulmonar;
 2. angină stabilă;
 3. reflux gastroesofagian;
- și următoarele trăsături asociate:
- a. agravată de decubitul postprandial, ameliorată de antacide;
 - b. declanșată de efort, expunere la rece sau stres psihologic, galop presistollic sau suflu de regurgitare mitrală în timpul durerii;
 - c. dispnee, tahicardie, hipotensiune;
- care sunt asociate corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
 - B. a-1, b-3, c-2;
 - C. a-2, b-3, c-1;
 - D. a-3, b-1, c-2;
 - E. a-3, b-2, c-1;
1141. R.I. trăsăturile clinice tipice ale principalelor cauze de durere toracică acută, f.d.u. evaluări de durată:
1. instalare bruscă a unei dureri care nu cedează la nimic;
 2. ore-zile, poate fi episodică;
 3. variabilă, adesea peste 30 min;
- și următoarele cauze:
- A. a-1, b-2, c-3;
 - B. a-1, b-3, c-2;
 - C. a-2, b-3, c-1;
 - D. a-3, b-1, c-2;
 - E. a-3, b-2, c-1;
1142. R.I. trăsăturile clinice tipice ale principalelor cauze de durere toracică acută, f.d.u. evaluări de durată:
1. 10-60 min, uneori mai mult;
 2. 10-20 min;
 3. variabilă;
- și următoarele cauze:
- A. a-1, b-2, c-3;
 - B. a-1, b-3, c-2;
 - C. a-2, b-3, c-1;
 - D. a-3, b-1, c-2;
 - E. a-3, b-2, c-1;
1143. R.I. trăsăturile clinice tipice ale principalelor cauze de durere toracică acută, f.d.u. evaluări de durată:
1. 2-10 min;
 2. prelungită, legată de mese;
 3. variabilă;
- și următoarele cauze:
- A. a-1, b-2, c-3;
 - B. a-1, b-3, c-2;
 - C. a-2, b-3, c-1;
 - D. a-3, b-1, c-2;
 - E. a-3, b-2, c-1;
1144. R.I. trăsăturile clinice tipice ale principalelor cauze de durere toracică acută, f.d.u. evaluări de durată:
1. 2-30 min;
 2. instalare bruscă, durează câteva ore;
 3. variabilă;
- și următoarele cauze:
- A. a-1, b-2, c-3;
 - B. a-1, b-3, c-2;
 - C. a-2, b-3, c-1;
 - D. a-3, b-1, c-2;
 - E. a-3, b-2, c-1;
1145. R.I. trăsăturile clinice tipice ale principalelor cauze de durere toracică acută, f.d.u. evaluări de durată:
1. 10-60 min, uneori mai mult;
 2. 10-20 min;
 3. variabilă;
- și următoarele cauze:
- A. a-1, b-2, c-3;
 - B. a-1, b-3, c-2;
 - C. a-2, b-3, c-1;
 - D. a-3, b-1, c-2;
 - E. a-3, b-2, c-1;
1146. R.I. trăsăturile clinice tipice ale principalelor cauze de durere toracică acută, f.d.u. evaluări de durată:
1. 2-10 min;
 2. prelungită, legată de mese;
 3. variabilă;
- și următoarele cauze:
- A. a-1, b-2, c-3;
 - B. a-1, b-3, c-2;
 - C. a-2, b-3, c-1;
 - D. a-3, b-1, c-2;
 - E. a-3, b-2, c-1;
1147. R.I. trăsăturile clinice tipice ale principalelor cauze de durere toracică acută, f.d.u. localizări:
1. epigastru, retrosternal;
 2. retrosternal, adesea cu diverse iradieri, poate fi resimțită doar în zona de iradiere;
 3. unilaterala, adesea localizată;
- și următoarele cauze:
- A. a-1, b-2, c-3;
 - B. a-1, b-3, c-2;
 - C. a-2, b-3, c-1;
 - D. a-3, b-1, c-2;
 - E. a-3, b-2, c-1;
1148. R.I. trăsăturile clinice tipice ale principalelor cauze de durere toracică acută, f.d.u. localizări:
1. epigastru, cadrului superior drept, retrosternal;
 2. iradiere în gât, mandibulă, umeri, brațe, adesea pe stânga;
 3. variabilă;
- și următoarele cauze:
- A. a-1, b-2, c-3;
 - B. a-1, b-3, c-2;
 - C. a-2, b-3, c-1;
 - D. a-3, b-1, c-2;
 - E. a-3, b-2, c-1;
1149. R.I. trăsăturile clinice tipice ale principalelor cauze de durere toracică acută, f.d.u. localizări:
1. laterotoracic, pe partea afectată;
 2. retrosternal;
 3. variabilă, capricioasă, migratorie, uneori retrosternală;
- și următoarele cauze:
- A. a-1, b-2, c-3;
 - B. a-1, b-3, c-2;
 - C. a-2, b-3, c-1;
 - D. a-3, b-1, c-2;
 - E. a-3, b-2, c-1;
1150. R.I. trăsăturile clinice tipice ale principalelor cauze de durere toracică acută, f.d.u. caractere:
1. surdă;
 2. pleuritică;
 3. ascuțită sau arzătoare;
- și următoarele cauze:
- A. a-1, b-2, c-3;
 - B. a-1, b-3, c-2;
 - C. a-2, b-3, c-1;
 - D. a-3, b-1, c-2;
 - E. a-3, b-2, c-1;
1151. R.I. trăsăturile clinice tipice ale principalelor cauze de durere toracică acută, f.d.u. caractere:
1. de tip anginos;
 2. pleuritică;
 3. ascuțită;
- și următoarele cauze:
- A. a-1, b-2, c-3;
 - B. a-1, b-3, c-2;
 - C. a-2, b-3, c-1;
 - D. a-3, b-1, c-2;
 - E. a-3, b-2, c-1;
1152. R.I. trăsăturile clinice tipice ale principalelor cauze de durere toracică acută, f.d.u. caractere:
1. arsură, presiune;
 2. pleuritică;
 3. similar cu cea anginoasă, dar adesea mai severă;
- și următoarele cauze:
- A. a-1, b-2, c-3;
 - B. a-1, b-3, c-2;
 - C. a-2, b-3, c-1;
 - D. a-3, b-1, c-2;
 - E. a-3, b-2, c-1;
1153. R.I. trăsăturile clinice tipice ale principalelor cauze de durere toracică acută, f.d.u. caractere:
1. pleuritică;
 2. presiune, constricție, arsură;
 3. arsură;
- și următoarele cauze:
- A. a-1, b-2, c-3;
 - B. a-1, b-3, c-2;
 - C. a-2, b-3, c-1;
 - D. a-3, b-1, c-2;
 - E. a-3, b-2, c-1;
1154. R.I. trăsăturile clinice tipice ale principalelor cauze de durere toracică acută, f.d.u. caractere:
1. arsură;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care, dintre următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, f.d. = referitor/relativ la; U.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază despre;

2. presiune, constricție, strângere, greutate, asură;
3. rușel, stădere, ca un pumnal;
și următoarele cauze:
a. ulcer peptic;
b. disecție de aortă;
c. angină stabilă;
care sunt asociate corecte:

- A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;

1155. R.I. trăsăturile clinice tipice ale principalelor cauze de durere toracică acută, f.d.u. caracter:
1. similar cu cea anginoasă, dar adesea mai severă;
2. presiune;
3. veritabilă, capricioasă;
și următoarele cauze:
a. angină instabilă;
b. tulburări emoționale sau psihice;
c. hipertensiune pulmonară;
care sunt asociate corecte:

- A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-1, c-2;

Duritor de cauză cardiacă

1156. U.f.d.d. la Duritor provocată de S.D.a.s.c.g.e.:

- A. Surine în episoade recurente, mai adesea legate de efort;
B. când se atenuează discrepanța dintre fluxul coronarian;
C. scăzut (deoarece tot fluxul aortic este scăzut);
D. și necesarii de îngrijire ai unui ventricul dilatat și solicitat;
E. să nunească suplimentar.

1157. R.I. pericardită și la Duritor pe care o provoacă, u.a.s.c.g.e.:

- A. se consideră că cea mai mare parte a pericardului este insensibilă la durere;
B. de obicei, pericardita infectivă oază atelectază și suprafețele pleurale adăunare, ceea ce explică durerea;
C. atențiile senzoriale de la pleura parietală adiacentă pericardului pleacă în diverse direcții;
D. durerea este ameliorată de manevre care duc la mișcarea reciprocă a suprafețelor pleurale;
E. durerea este foarte intensă în uremie.

Prescurtări frecvent folosite: S.D. = cu excepție, s.u.c.g.e. = sunt următoarele, cu excepție, u.a.s.c.g.e. = următoarele afirmări sunt corecte, cu excepție, s.c.l.g.e. = sunt corect formulate, cu excepție.

3. determină durere în, u.a.s.c.g.e.:

- A. este probabil cauzată de inflamația pleurei parietale adiacente pericardului inflamț;
B. este intensă mai ales în TmpC;
C. este ameliorată de respirația adâncă;
D. de obicei durează câteva minute;
E. adesea, se asociază frecătură pericardică;

1159. R.I. Duritor din pericardită, u.a.s.c.g.e.:

- A. este numită durere pericardică;
B. este mai rară și mai ușoară în aștepturile care provoacă doar inflamație locală (precum IMA);
C. de obicei este absentă în aștepturile cu evoluție acută;
D. este agravată de schimbarea poziției;
E. poate fi episodică;

1160. R.I. Duritor din pericardită, u.a.s.c.g.e.:

- A. este mai frecventă și mai intensă în pericardita infectioasă;
B. este agravată de tuse;
C. este intensă mai ales în absența inflamației care provoacă doar inflamație locală;
D. poate fi resimțită în zone care se întind de la umăr și gât până la abdomen și spate;
E. mai rar, este un disconfort dureros persistent care minază IMA;

1161. R.I. disecția de aortă (D.A.O.), u.a.s.c.g.e.:

- A. D.A.O. este o așteptură cu evoluție potențial catastrofală;
B. de regulă D.A.O. evoluează torpid, asimptomatic;
C. durerea nu este ameliorată de nicio manevră fiziologică;
D. localizarea durerii se corelează de obicei cu locul și cu extindere disecției;
E. sindromul Marfan este un factor de risc pentru D.A.O.;

1162. R.I. D.A.O., u.a.s.c.g.e.:

- A. D.A.O. constă în separarea inițiale de partea exteroară a peretelui aortic printr-un hematom care se extinde progresiv;
B. durerea din D.A.O. atinge tardiv este alcătuită din patru propoziiții – f.d.u. începuturi de frază;
C. durerea este ameliorată la aplicarea în tăie;
D. durerea este ameliorată de repaus;
E. adesea, durerea este asociată cu transpirație;

1163. R.I. D.A.O., u.a.s.c.g.e.:

- A. D.A.O. constă în separarea inițiale de partea exteroară a peretelui aortic printr-un hematom care se extinde progresiv;
B. durerea din D.A.O. atinge tardiv este alcătuită din patru propoziiții – f.d.u. începuturi de frază;
C. durerea este ameliorată la aplicarea în tăie;
D. durerea este ameliorată de repaus;
E. adesea, durerea este asociată cu transpirație;

- D. în mod tipic, durerea migrează odată cu propagarea disecției;
E. în cadrul D.A.O. acute pot să apară hipotensiune, slăbiciune, sincopă;
1163. R.I. D.A.O., u.a.s.c.g.e.:

- A. hematomul poate începe cu o ruptură a inimii aortei;
B. spre deosebire de durerea din B.C.I., durerea din D.A.O. se instalează insidios;
C. caracterul durerii este sugestiv pentru procesul care se produce în peretele aortei;
D. de regulă, durerea este localizată în regiunea anterioară sau posterioară a toracelui;
E. D.A.O. acută se poate asocia cu HTA (mai degrabă drept factor cauzal);

1164. R.I. D.A.O., u.a.s.c.g.e.:

- A. hematomul poate începe cu o ruptură a vasa vasorum din media aortei;
B. adesea pacientul se prăbușește din cauza intensității durerii;
C. durerea are caracter de „sfâșiere”, „rupere”;
D. rareori, durerea este localizată intenscapilar;
E. tehnic neavizate prin care se poate pune diagnosticul de D.A.O. sunt: EcocG, T.C, RMN;

1165. R.I. D.A.O., u.a.s.c.g.e.:

- A. de cele mai multe ori D.A.O. are o evoluție cronică;
B. durerea este persistentă, nu scade în intensitate;
C. durerea poate fi resimțită „ca un pumnal”;
D. HTA este un factor de risc pentru D.A.O.;

1166. R.I. D.A.O., u.a.s.c.g.e.:

- A. D.A.O. determină Duritor (foarte severă);
B. durerea este ameliorată de repaus;
C. adesea, durerea este asociată cu transpirație;
D. migrațiile congenitale sunt un factor de risc pentru D.A.O.;

1167. O frază r.I. durerea din D.A.O. este alcătuită din patru propoziiții – f.d.u. începuturi de frază;

1. disecție care încep în, 2. și se extind spre,

3. determină durere în, u.a.s.c.g.e.:

- A. este probabil cauzată de inflamația pleurei parietale adiacente pericardului inflamț;
B. este intensă mai ales în TmpC;
C. este ameliorată de respirația adâncă;
D. de obicei durează câteva minute;
E. adesea, se asociază frecătură pericardică;

1159. R.I. Duritor din pericardită, u.a.s.c.g.e.:

- A. este numită durere pericardică;
B. este mai rară și mai ușoară în aștepturile care provoacă doar inflamație locală (precum IMA);
C. de obicei este absentă în aștepturile cu evoluție acută;
D. este agravată de schimbarea poziției;
E. poate fi episodică;

1160. R.I. Duritor din pericardită, u.a.s.c.g.e.:

- A. este mai frecventă și mai intensă în pericardita infectioasă;
B. este agravată de tuse;
C. este intensă mai ales în absența inflamației care provoacă doar inflamație locală;
D. poate fi resimțită în zone care se întind de la umăr și gât până la abdomen și spate;
E. mai rar, este un disconfort dureros persistent care minază IMA;

1161. R.I. disecția de aortă (D.A.O.), u.a.s.c.g.e.:

- A. D.A.O. este o așteptură cu evoluție potențial catastrofală;
B. de regulă D.A.O. evoluează torpid, asimptomatic;
C. durerea nu este ameliorată de nicio manevră fiziologică;
D. localizarea durerii se corelează de obicei cu locul și cu extindere disecției;
E. sindromul Marfan este un factor de risc pentru D.A.O.;

1162. R.I. D.A.O., u.a.s.c.g.e.:

- A. D.A.O. constă în separarea inițiale de partea exteroară a peretelui aortic printr-un hematom care se extinde progresiv;
B. durerea din D.A.O. atinge tardiv este alcătuită din patru propoziiții – f.d.u. începuturi de frază;
C. durerea este ameliorată la aplicarea în tăie;
D. durerea este ameliorată de repaus;
E. adesea, durerea este asociată cu transpirație;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele, c.d.u. = care dăte următoarele, f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, r.I. = referitor/referitoare la, U.f.d.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază despre.

- E. de regulă este localizată unilateral;
1180. Manifestări în pneumonie/pleurită sunt u.a.s.c.g.e.;
A. durere cu caracter anginos;
B. febră/frisoane;
C. tuse, dispnee;
D. raluri (mai frecvent, crepitante);
E. uneori, frecătură pleurală;
- DurTor de cauză esofagiană**
1181. C.d.u. este cea mai rară cauză de durere esofagiană;
A. refluxul conținutului acid din stomac;
B. ischemie;
C. spasm;
D. obstrucție;
E. leziune (inflamatoare, traumatică);
1182. F.d.u. situații în care este favorizat RGE (și care exacerbează durerea provocată de aceasta):
1. când crește presiunea intraabdominală;
2. în timpul nopții, dacă pacientul a mâncat seara târziu;
3. decubitul dorsal;
și următoarele explicații:
a. gravitația;
b. când încep mișcările propulsive ale stomacului;
c. conținutul este împins nu numai spre pilor, ci și spre cardie, dacă pacientul este în decubit dorsal;
c. presiunea crescută asupra stomacului;
care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
1183. F.d.u. situații în care este favorizat RGE (și care exacerbează durerea provocată de acesta):
1. dimineața devreme;
2. la aplecare în față;
3. când stomacul se umple excesiv;
și următoarele explicații:
a. presiunea crescută asupra stomacului și gravitația;
b. stomacul nu conține alimente care ar putea lămpona acidul gastric;
c. presiunea crescută din stomac;
care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
- E. are caracter de presiune, strângere, arsură;
1189. R.I. durerea din spasmul esofagian, u.a.s.c.g.e.;
A. este constructivă;
B. este ameliorată rapid de medicamentele antianginoase (nifedipină, nifedipină) administrate sublingual;
C. este influențată mai ales de poziție;
D. durează 2-30 minute;
E. este localizată precordial;
DurTor de cauză digestivă subdiafragmatică
1190. R.I. durerea din ulcerul peptic, u.a.s.c.g.e.;
A. în UG, este declanșată de ingestia de alimente;
B. în UD, este ameliorată de ingestia de alimente și de antacide și dispare la 60-90 min după mese;
C. este prelungită;
D. are caracter de arsură;
E. este localizată epigastric sau retrosternal;
1191. R.I. durerea din afecțiunile biliare, u.a.s.c.g.e.;
A. durerea este ameliorată de ingestia de alimente (grăsime);
B. durerea este prelungită;
C. durerea are caracter de arsură, presiune;
D. durerea este localizată în epigastriu, hipocondrul drept, retrosternal;
E. diagnosticul este facilitat de examinarea ecografică a abdomenului;
DurTor de cauză neuro-musculo-scheletică
1192. R.I. DurTor de cauză neuro-musculo-scheletică, u.a.s.c.g.e.;
A. durerea este variabilă ca durată;
B. este descrisă ca durere pur și simplu sau uneori ca senzație de contractură, tensiune;
C. localizarea este variabilă oriunde în torace, anterior, lateral sau posterior;
D. este agravată de mișcare, dar nu este influențată de apăsarea zonei respective;
E. unii dintre pacienții care au simultan astfel de afecțiuni și ischemie miocardică confundă diferențierea de durerea din RGE;
- C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
1184. R.I. durerea provocată RGE, u.a.s.c.g.e.;
A. este un disconfort localizat profund, retrosternal (subxifoidian), epigastric;
B. în general, durează cel mult 10 minute;
C. apare mai ales după ingerarea unei cantități mari de alimente;
D. este ameliorată când pacientul ingeră ceva (mâncare, salivă);
E. este favorizată de combinațiile de alimente cu timp de digestie foarte diferiți;
1185. R.I. durerea provocată RGE, u.a.s.c.g.e.;
A. urcă retrosternal;
B. este agravată mai ales de decubitul dorsal și de aplecare în față;
C. este o durere legată mai ales de poziție;
D. se agravează când pacientul înghite în sec;
E. poate fi exacerbată de alcool;
1186. R.I. durerea provocată RGE, u.a.s.c.g.e.;
A. are caracter de arsură;
B. se ameliorează dacă pacientul se întinde pe spate;
C. depinde mai ales de tipul alimentelor;
D. este ameliorată de antacide și de antisecretoare gastrice;
E. poate fi exacerbată de aspirină;
1187. R.I. durerea provocată RGE, u.a.s.c.g.e.;
A. durează zeci de minute sau chiar ore;
B. este accentuată de orice creștere a presiunii în/ asupra stomacului;
C. ceea ce irită esofagul sunt mai ales alimentele acide;
D. este favorizată de combinațiile de alimente incompatibile;
E. poate fi exacerbată de alimente infantile;
1188. R.I. durerea din spasmul esofagian, u.a.s.c.g.e.;
A. survine doar în prezența refluxului acid;
B. nu poate fi distinsă de durerea anginoasă;
C. ameliorarea la medicamente antianginoase administrate sublingual o diferențiază de durerea anginoasă;
D. dependența de poziție o diferențiază de durerea din RGE;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dăunează următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele; r.i. = referitor/referitoare la; U.I.D.U. = Următoarele fragmente dintr-o frază desprse;

- simptomele celor două sindroame;
1193. R.I. DurTor de cauză neuro-musculo-scheletică, f.d.u. stări patologice/cauze:
1. disocetă cervicală;
2. crampe ale mușchilor intercostali;
3. artroză/periartrită/bursită de umăr;
4. spondiloză cervicală sau toracică;
și următoarele trăsături:
a. este sistematic de ridicarea brațului;
b. apare la mobilizarea coloanei vertebrale;
c. este cauzată de compresia rădăcinilor nervoase;
d. are distribuție metamerică; care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-4, c-2, d-3;
B. a-2, b-3, c-1, d-4;
C. a-2, b-3, c-4, d-1;
D. a-3, b-2, c-4, d-1;
E. a-3, b-4, c-1, d-2;
1194. R.I. DurTor din herpes zoster, u.a.s.c.g.e.;
A. poate precede (cu ore-zile-săptămâni) apariția leziunilor cutanate;
B. are durată variabilă;
C. este ascuțită sau ca o arsură;
D. este bilaterală, localizată pe un dermatom;
E. se asociază cu erupție veziculară pe un fond eritematos;
1195. R.I. sindroamele costochondrale și condrosienale, u.a.s.c.g.e.;
A. sunt cea mai frecventă cauză de durere toracică anterioară de origine musculoscheletică;
B. de regulă sunt prezente semne fizice de conștientă, cum ar fi tumefacție, roșeață și căldură (sindrom Tietze);
C. durerea este de obicei trecătoare și ascuțită;
D. unii pacienți pot resimți o durere surdă, care ține mai multe ore;
E. apăsarea pe articulațiile costosternale și costochondrale poate reproduce durerea;
1196. R.I. DurTor asociată tuburilor emoționale și psihice, u.a.s.c.g.e.;
A. majoritatea pacienților care se prezintă la departamentul de urgență cu DurTor acută au
- tulburare de panică sau alte tulburări emoționale;
B. adesea, durerea durează câteva zeci de minute;
C. uneori durerea este resimțită pe o suprafață mai mare;
D. adesea, durerea sunt localizate „chiar în inimă”;
E. suprasolicitațiile financiare, relaționale, familiale, profesionale, afective, emoționale etc. pot precipita și întreține durerea;
1197. R.I. DurTor asociată tuburilor emoționale și psihice, u.a.s.c.g.e.;
A. simptomele pacienților cu tulburări psihosomatoemoționale sunt foarte variabile;
B. durerea pot fi trecătoare (durează fracțiuni de secundă sau secundă);
C. durerea poate fi resimțită în tot pieptul sau chiar în tot toracele;
D. în unele cazuri durerea sunt localizate retrosternal, mai ales dacă pacientul refuză să admită că ar avea boală coronariană;
E. un istoric atent poate culege simptome sugestive pentru diferite tulburări depresive și/sau anxioase;
1198. R.I. DurTor asociată tulburărilor emoționale și psihice, u.a.s.c.g.e.;
A. durerea are durată variabilă, este posibil;
B. practic orice tip de senzație a înut foarte mult;
C. fobii sociale;
D. tulburare de despărțire; care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-2, d-1;
C. a-2, b-1, c-1, d-2;
D. a-2, b-1, c-2, d-1;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;
1202. R.I. manifestările depresive și anxioase care se pot asocia cu DurTor, f.d.u. categorii:
1. tulburări depresive;
2. tulburări anxioase;
și următoarele tulburări:
a. claustrofobie;
b. pierderea a covai/ curva la care a înut foarte mult;
c. fobii sociale;
d. tulburare de despărțire; care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-2, d-1;
C. a-2, b-1, c-1, d-2;
D. a-2, b-1, c-2, d-1;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;

Diagnosticul diferențial al DurTor

1203. R.I. diagnosticul diferențial al DurTor, u.a.s.c.g.e.;
A. cauzele DurTor pot fi clasificate drept organice (toracice sau abdominale superioare) și psihosomatoemoționale;
B. dacă DurTor este recurent/episodic, nu se pot exclude diagnosticul cardiovascular potențial grave, dar acestea sunt mai puțin probabile;
C. afecțiuni amenințătoare de viață sunt în primul rând cele

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dăunează următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele; r.i. = referitor/referitoare la; U.I.D.U. = Următoarele fragmente dintr-o frază desprse;

cardiovasculare: IMA, DAO și pneumonie; D. chiar dacă NTG nu ameliorează durerea, diagnosticul de boală coronariană nu se poate exclude; E. diagnosticul probabil de DAO impune urgență investigativă imediată care să confirme DAO;	care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-2, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;
1204. F.d.u. afirmații vizând diagnosticul diferențial al DurTor: a. este prudent să se efectueze ECG, Rx pulmonar, determinarea INM, examinarea simetrică a pulsului TA; b. diagnosticarea potențialului amenințator de viață trebuie avută în vedere chiar și atunci când nu o probabilitate scăzută; c. recererea peste un diagnostic de IMA, DAO, TEP sau pneumotorace poate avea consecințe grave; care este înălțimea logică justă: A. a-1-b-1-c-1; B. a-1-b-1-c-1; C. b-1-b-1-c-1; D. b-1-b-1-c-1; E. c-1-b-1-a-1;	1. afecțiuni potențial grave (inclusiv amenințatoare de viață) care necesită spitalizare urgentă și intervenție terapeutică energetică; 2. afecțiuni acute care necesită un tratament specific; 3. afecțiuni cronice tratabile; și următoarele stări patologice: a. IMAs; b. disecția de aortă; c. pneumonie; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;
1205. F.d.u. categorii de patologii pe care le avem în vedere evaluarea unui pacient cu DurTor: a. afecțiuni potențial grave (inclusiv amenințatoare de viață) care necesită spitalizare urgentă și intervenție terapeutică energetică; b. afecțiuni cronice susceptibile de a genera complicații grave; c. afecțiuni acute care necesită un tratament specific; d. alte afecțiuni cronice tratabile; în ce ordine trebuie luate în considerare: A. a-1-b-1-c-1; B. a-1-b-1-c-1; C. b-1-b-1-c-1; D. c-1-b-1-a-1; E. d-1-b-1-a-1;	1207. R.I. cauzele de DurTor, f.d.u. categorii: 1. afecțiuni potențial grave (inclusiv amenințatoare de viață) care necesită spitalizare urgentă și intervenție terapeutică energetică; 2. afecțiuni acute care necesită un tratament specific; 3. afecțiuni cronice tratabile; și următoarele stări patologice: a. IMAs; b. disecția de aortă; c. pneumonie; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;
1206. R.I. cauzele de DurTor, f.d.u. categorii: 1. afecțiuni potențial grave (inclusiv amenințatoare de viață) care necesită spitalizare urgentă și intervenție terapeutică energetică; 2. afecțiuni acute care necesită un tratament specific; 3. afecțiuni cronice tratabile; și următoarele stări patologice: a. IMAs; b. disecția de aortă; c. pneumonie; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;	1208. R.I. cauzele de DurTor, f.d.u. categorii: 1. afecțiuni potențial grave (inclusiv amenințatoare de viață) care necesită spitalizare urgentă și intervenție terapeutică energetică; 2. afecțiuni acute care necesită un tratament specific; 3. afecțiuni cronice tratabile; și următoarele stări patologice: a. IMAs; b. disecția de aortă; c. pneumonie; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;
1209. R.I. cauzele de DurTor, f.d.u. categorii: 1. afecțiuni potențial grave (inclusiv amenințatoare de viață) care necesită spitalizare urgentă și intervenție terapeutică energetică; 2. afecțiuni acute care necesită un tratament specific; 3. afecțiuni cronice tratabile; și următoarele stări patologice: a. IMAs; b. disecția de aortă; c. pneumonie; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;	1210. R.I. cauzele de DurTor, f.d.u. categorii: 1. afecțiuni potențial grave (inclusiv amenințatoare de viață) care necesită spitalizare urgentă și intervenție terapeutică energetică; 2. afecțiuni acute care necesită un tratament specific; 3. afecțiuni cronice tratabile; și următoarele stări patologice: a. IMAs; b. disecția de aortă; c. pneumonie; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;
1211. R.I. cauzele de DurTor, f.d.u. categorii: 1. afecțiuni potențial grave (inclusiv amenințatoare de viață) care necesită spitalizare urgentă și intervenție terapeutică energetică; 2. afecțiuni acute care necesită un tratament specific; 3. afecțiuni cronice tratabile; și următoarele stări patologice: a. IMAs; b. disecția de aortă; c. pneumonie; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;	1212. R.I. cauzele de DurTor, f.d.u. categorii: 1. afecțiuni potențial grave (inclusiv amenințatoare de viață) care necesită spitalizare urgentă și intervenție terapeutică energetică; 2. afecțiuni acute care necesită un tratament specific; 3. afecțiuni cronice tratabile; și următoarele stări patologice: a. IMAs; b. disecția de aortă; c. pneumonie; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;

Prescurtări frecvent folosite: E.E. = cu excepție; s.u.c.g.e. = sunt următoarele, cu excepția; u.a.s.c.g.e. = următoarele afirmări sunt corecte, cu excepția; s.c.l.f.e. = sunt corect formulate, cu excepția.

A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-2, b-3, c-1; E. a-3, b-1, c-2;	2. disecție cervicală; 3. pericardită; și următoarele caracteristici: a. durere accentuată de mișcarea gâtului și/sau de presiunea pe ceafă sau umăr; b. este utilă endoscopia digestivă superioară; c. cauza poate fi sugerată de istoric, de examenul fizic și de ECG; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;
1213. R.I. cauzele de DurTor, f.d.u. categorii: 1. afecțiuni cronice, susceptibile de a genera complicații grave; 2. afecțiuni acute care necesită un tratament specific; 3. afecțiuni cronice tratabile; și următoarele stări patologice: a. pleurită; b. HTAP; c. afecțiuni musculoscheletice; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;	1214. R.I. DurTor determinată de afecțiuni cronice tratabile, f.d.u. localizări: 1. toracică; 2. abdominală superioară; și următoarele afecțiuni: a. pancreatită; b. afecțiuni musculoscheletice; c. colecistopatie; d. ulcer peptic; e. afecțiuni esofagiene; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;
1215. R.I. DurTor determinată de afecțiuni cronice tratabile, f.d.u. stări patologice: 1. reflux gastroesofagian; 2. pericardită de umăr; 3. pancreatită; și următoarele caracteristici: a. durere accentuată de ridicarea brațului și/sau de presiunea pe umăr; b. sunt utile Eco și TC; c. durere accentuată de decubit dorsal sau de apăsarea în față; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;	1216. R.I. DurTor determinată de afecțiuni cronice tratabile, f.d.u. stări patologice: 1. reflux gastroesofagian; 2. disecție cervicală; 3. pericardită; și următoarele caracteristici: a. durere accentuată de mișcarea gâtului și/sau de presiunea pe ceafă sau umăr; b. este utilă endoscopia digestivă superioară; c. cauza poate fi sugerată de istoric, de examenul fizic și de ECG; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;
1217. R.I. DurTor determinată de afecțiuni cronice tratabile, f.d.u. stări patologice: 1. afecțiuni musculoscheletice; 2. ulcer; 3. pericardită; și următoarele caracteristici: a. durere accentuată de mișcarea cuflei toracice și/sau de presiunea pe peretele toracic; b. necesită evaluarea atentă a TA; c. este utilă endoscopia digestivă superioară; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;	1218. R.I. DurTor determinată de afecțiuni cronice tratabile, f.d.u. stări patologice: 1. reflux gastroesofagian; 2. colecistopatie; 3. pericardită; și următoarele caracteristici: a. durere accentuată de decubit, mese abundente; b. este utilă endoscopia digestivă superioară Eco; c. la nevoie, se solicită Eco pentru detectarea semnelor de tamponadă pericardică iminentă; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;
1219. R.I. DurTor determinată de afecțiuni cronice tratabile, f.d.u. stări patologice: 1. reflux gastroesofagian; 2. disecție cervicală; 3. pericardită; și următoarele caracteristici: a. durere accentuată de mișcarea gâtului și/sau de presiunea pe ceafă sau umăr; b. este utilă endoscopia digestivă superioară; c. cauza poate fi sugerată de istoric, de examenul fizic și de ECG; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;	1220. R.I. evaluarea pacientului cu DurTor acută, nou apărută, în desfășurare, u.a.s.c.g.e.: A. caracteristicile durerii sunt relevante numai în context; B. evaluarea riscului de afecțiuni amenințatoare de viață se face prin istoric, examen fizic și investigații de laborator; C. riscul de complicații amenințatoare de viață este mare chiar și la pacienți cu ECG normal; D. un rezultat normal la schitografie miocardică de perfuzie crește probabilitatea de boală coronariană; E. dacă se constată asimetrice de puls TA, diagnosticul probabil este SIAO;
1221. R.I. evaluarea pacientului cu DurTor acută, nou apărută, în desfășurare, u.a.s.c.g.e.: A. dacă durerea este atipică, probabilitatea de durere coronariană este redusă chiar dacă pacientul are mulți factori de risc; B. intensificarea treptată a simptomelor într-un interval de minute sugerează pericardită acută; C. riscul de complicații amenințatoare de viață este mare chiar și la pacienți care au modificări ST-T nespecifice pe ECG; D. mulți medici administrează, ca test diagnostic, NTG sublingual sau anhidroză; E. IMA și modificări ECG de tip IMA pot să apară și în DAO;	1222. R.I. evaluarea pacientului cu DurTor acută, nou apărută, în desfășurare, u.a.s.c.g.e.: A. la un bărbat de vârstă medie obez și fumător, probabilitatea

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele, c.d.u. = care dintre următoarele, f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, f.l. = referitor/referențiar la, U.I.d.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază desprse.

- de durere coronariană este mică
dacă durerea este atipică;
B. durerea trecătoare sau care
durează ore fără a fi asociată cu
modificări ECG este foarte
probabil de origine ischemică;
C. la pacienții cu modificări ECG
absente sau nespecifice, se
poate efectua eventual test ECG
de efort;
D. este greșită ideea că răspunsul
la NTG (administrat sublingual)
sau anticidice poate servi la
stabilirea diagnosticului;
E. în DAO, pe radiografia toracică
se poate observa dilatarea
aortei; răsădina, aorta
ascendență, aorta descendență
toracică;
1223. R.I. evaluarea pacientului
cu DurTor acută, nou apărută, în
desfășurare, u.a.s.c.g.g.:
A. chiar dacă durerea este tipică,
probabilitatea de durere coro-
nariană este mare chiar dacă
sintigrafie miocardică de
perfuzie;
B. asimetria diferenței de TA între
membre superioare TE;
C. o singură determinare a INM
are o sensibilitate redusă în
diagnosticarea IMA sau în
precizarea complicațiilor;
D. reacția durerii la
sublingual sau anticidice nu
clarifică diagnosticul;
E. absența semnelor Rx nu este
suficientă pentru a exclude DAO;
1224. R.I. evaluarea pacientului
cu DurTor acută, nou apărută, în
desfășurare, u.a.s.c.g.g.:
A. la o femeie tânără,
probabilitatea de durere coro-
nariană este mare dacă durerea
este tipică;
B. dacă există o cauză traumatică
evidentă efectuarea ECG este
obligatorie;
C. pacientul poate fi trimis acasă
pe baza unei singure valori
negative a INM;
D. scăderea durerii la administrare
de anticidice se poate datoră
efectului placebo;
E. durerea din TEP poate avea
caracter pleuritic;
1225. R.I. evaluarea pacientului
cu DurTor acută, nou apărută, în
desfășurare, u.a.s.c.g.g.:
A. în primul rând trebuie avute în
vedere principalele cauze grave,
potențial amenințătoare de viață;
B. modificările ECG de ischemie
sau de IMA indică risc înalt de
frecătură pleurală, semne de
pneumotorace, embolie
pulmonară, pneumonie sau
pleurizie;
C. modul în care a început
dureza;
D. dacă durerea scade la adminis-
trare de anticidice, se poate
exclde ischemia miocardică;
E. durerea din TEP poate mima
un IMA sau o DAO;
1226. R.I. evaluarea pacientului
cu DurTor acută, nou apărută, în
desfășurare, u.a.s.c.g.g.:
A. evaluarea funcției respiratorii și
hemodinamice este utilă pentru
aprecierea riscului de afecțiuni
amenințătoare de viață;
B. absența modificărilor ECG
exclde ischemia miocardică
acută;
C. la pacientul cu durere în
desfășurare nu se poate efectua
sintigrafie miocardică de
perfuzie;
D. diagnosticul de IMA se
confirmă prin măsurarea în
plasmă a INM (troponină, NT-
ProBNP);
E. pentru confirmarea diagnosti-
cului de TEP se poate efectua la
rigorare, arteriografie pulmonară;
1227. R.I. evaluarea riscului de
afecțiuni amenințătoare de viață,
f.d.u. categorii de metode de
examinare:
1. istoric;
2. examen fizic;
3. investigații de laborator;
și u. informații/investigații:
a. TA la ambele membre
superioare și inferioare pentru
eventualitatea DAO;
b. caracterul, localizarea, durata
durerii;
c. ECG;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3 b-2, c-1;
1228. R.I. evaluarea riscului de
afecțiuni amenințătoare de viață,
f.d.u. categorii de metode de
examinare:
1. istoric;
2. examen fizic;
3. investigații de laborator;
și u. informații/investigații:
a. Rx toracic;
- b. examinarea toracelui;
scăderea murmurului vezicular,
frecătură pleurală, semne de
pneumotorace, embolie
pulmonară, pneumonie sau
pleurizie;
c. modul în care a început
dureza;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3 b-2, c-1;
1229. R.I. evaluarea riscului de
afecțiuni amenințătoare de viață,
f.d.u. categorii de metode de
examinare:
1. istoric;
2. examen fizic;
3. investigații de laborator;
și u. informații/investigații:
a. INM;
b. factorii declanșatori ai durerii;
c. examinarea cordului: suflu
sistol și diastolic, frecătură
pericardică, zgomote 3 și 4;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-1, c-2;
1230. F.d.u. constatări/ concluzii
clinice în evaluarea unui pacient
cu DurTor acută, nou apărută, în
desfășurare:
a. pentru confirmare se
efectuează ECG, INM;
b. probabilitatea de sindrom
coronarian instabil (angină
instabilă sau IMA);
c. durerea seamănă cu durerile
anterioare, dar este mai intensă,
de durată mai lungă, cedează
mai greu;
d. pacientul cunoscut cu BCI;
ce secvență este recomandabilă:
A. a→d→c→b;
B. b→a→c→d;
C. b→a→d→c;
D. c→d→b→a;
E. d→a→c→b;
1231. R.I. pacientul cu DurTor
care nu este cunoscut cu BCI sau
este cunoscut cu BCI, dar durerea
nu seamănă cu durerile ante-
riore, f.d.u. Incepțiuni de frază:
1. nu se exclde;
2. trebuie avută în vedere mai
ales;
3. trebuie avută în vedere doar
în ultimă instanță;
și următoarele sfârșituri de frază:
a. o suferință coronariană;
b. DAO, TEP, alte afecțiuni
pleuropulmonare, afecțiuni
digestive superioare (mai ales
esofagiene);
c. afecțiuni musculoskeletice;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
1232. F.d.u. constatări/ concluzii
clinice în evaluarea unui pacient
cu DurTor acută, nou apărută, în
desfășurare:
a. diagnostic de angină stabilă;
b. durerea nu este mai intensă,
nu durează mai mult, nu
cedează mai greu;
c. durerea are aceeași caracter
ca și durerile anterioare;
d. pacient cunoscut cu BCI;
ce secvență este recomandabilă:
A. a→d→b→c;
B. b→d→a→c;
C. c→d→a→b;
D. d→b→c→a;
E. d→c→b→a;
1233. F.d.u. constatări/ concluzii
clinice în evaluarea unui pacient
cu DurTor acută, nou apărută, în
desfășurare:
a. elavare de segment ST;
b. modificări ECG noi (față de
ECG anterioare);
c. probabilitate de IMA;
d. este necesară determinarea
INM pentru confirmare (sau
infirmary);
ce secvență este recomandabilă:
A. a→d→c→b;
B. b→a→c→d;
C. b→a→d→c;
D. c→d→b→a;
E. d→a→c→b;
1234. F.d.u. constatări/ concluzii
clinice în evaluarea unui pacient
cu DurTor acută, nou apărută, în
desfășurare:
a. modificări ECG noi (față de
ECG anterioare);
b. NU elavare de ST și/sau
deprimări de ST și/sau
negativare de T;
c. este necesară determinarea
INM pentru eventualitatea unui
IMA;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date; f.d.u. = fiind date următoarele; f.i. =
referitor/revenire la; U.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază despre;

- d. probabilitate de angină
instabilă;
ce secvență este recomandabilă:
A. a→b→d→c;
B. b→d→c→a;
C. c→d→b→a;
D. d→c→a→b;
E. d→c→b→a;
1235. F.d.u. constatări/ concluzii
clinice în evaluarea unui pacient
cu DurTor acută, nou apărută, în
desfășurare:
a. (mai ales dacă) durerea
persistă/recidivează;
b. de prudență se pot recolta
INM;
c. probabil NU este sindrom
coronarian instabil;
d. se efectuează ECGe și
determină de INM repetate;
e. NU există modificări ECG noi
(față de ECGe anterioare);
ce secvență este recomandabilă:
A. b→a→d→c→e;
B. c→a→d→b→e;
C. c→e→d→b→a;
D. d→c→b→a→e;
E. e→c→b→a→d;
1236. R.I. evaluarea pacientului
cu DurTor acută, nou apărută, în
desfășurare, f.d.u. constatări:
1. modificări inexistente anterior;
2. asimetrie de puls/ TA;
3. manifestări pleuro-pulmonare,
TVP, trombofle;
și următoarele stări patologice:
a. DAO;
b. IMA;
c. TEP;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
1237. R.I. evaluarea pacientului
cu DurTor acută, nou apărută, în
desfășurare, cu modificări ECG
inexistente anterior, f.d.u.
constatări:
1. probabilitate mare (75%) de
IMA;
2. probabilitate mai mică (20%)
de IMA;
și următoarele modificări ECG:
a. elavări de ST în cel puțin 2
derivații;
b. unde Q > 0,04 sec;
c. deprimări de ST de cel puțin 1
mm;
d. negativare de unde T;
care sunt asocierile corecte:
A. a→d→c→b;
- A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-2, d-1;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;
1238. U.f.d. evaluarea unui
pacient cu DurTor acută, nou
apărută, în desfășurare s.c.f.g.g.:
A. Dacă se suspectează TEP;
B. cu atenție, examinatorul va
palpa pulsul și va determina
frecvența cardiacă;
C. comparativ, la cele două
membre superioare și la;
D. membrele superioare față de
carotide pentru;
E. eventualitatea unei asimetrii.
1239. F.d.u. constatări/ concluzii
clinice în evaluarea unui pacient
cu DurTor acută, nou apărută, în
desfășurare:
a. se examinează pulsul și TA
comparativ la cele două
membre superioare și la
membrele inferioare;
b. investigații imagistice care să
confirme DAO;
c. se constată asimetrie;
d. diagnostic probabil de DAO;
ce secvență este recomandabilă:
A. a→b→d→c;
B. a→c→d→b;
C. b→a→d→c;
D. c→b→d→a;
E. d→b→c→a;
1240. F.d.u. constatări/ concluzii
clinice în evaluarea unui pacient
cu DurTor acută, nou apărută, în
desfășurare:
a. diagnostic probabil de DAO;
b. pacientul instabil hemodinamic;
c. Eco transesofagiană pentru
confirmare;
d. asimetrie de puls/ TA;
ce secvență este recomandabilă:
A. a→c→d→b;
B. b→c→a→d;
C. c→b→d→a;
D. c→d→b→a;
E. d→a→b→c;
1241. F.d.u. constatări/ concluzii
clinice în evaluarea unui pacient
cu DurTor acută, nou apărută, în
desfășurare:
a. pacientul stabil hemodinamic;
b. TC cu substanță de contrast
sau RMN pentru confirmare;
c. asimetrie de puls/ TA;
d. diagnostic probabil de DAO;
ce secvență este recomandabilă:
A. a→d→c→b;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date; f.d.u. = fiind date următoarele; f.i. =
referitor/revenire la; U.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază despre;

- B. b → c → a → d;
C. b → d → a → c;
D. c → d → a → b;
E. d → a → b → c;
1242. R.I. evaluarea unui pacient cu DurTor acută, nou apărută, în desfășurare, f.d.u. începând de frază:
1. asimetria de puls;
2. istoricul de sindrom Marfan;
3. TC cu substanță de contrast sau RMN;
și următoarele sfârșituri de frază:
a. indică un diagnostic probabil de DAO;
b. susține diagnosticul probabil de DAO;
c. confirmă DAO la pacientul stabil hemodinamic, care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
1243. R.I. evaluarea unui pacient cu DurTor acută, nou apărută, în desfășurare, f.d.u. începând de frază:
1. asimetria de TA;
2. debutul brusc și caracterul (intensă, persistentă, sfâșietoare) durerii;
3. Eco transeștorială;
și următoarele sfârșituri de frază:
a. confirmă DAO la pacientul instabil hemodinamic;
b. susține diagnosticul probabil de DAO;
c. indică un diagnostic probabil de DAO;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-2, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
1244. R.I. evaluarea unui pacient cu DurTor acută, nou apărută, în desfășurare, f.d.u. începând de frază:
1. asimetria de TA/puls;
2. istoricul de HTA;
3. ortografiat;
și următoarele sfârșituri de frază:
a. indică un diagnostic probabil de DAO;
b. se folosește mai rar la ora actuală pentru confirmarea DAO;
c. susține diagnosticul probabil de DAO;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
1245. R.I. evaluarea unui pacient cu DurTor acută, nou apărută, în desfășurare, f.d.u. sfârșituri de frază:
1. ridică suspiciunea de TEP;
2. întărește suspiciunea de TEP;
3. confirmă diagnosticul de TEP;
a. prezenta semnelor ECG de suprasolicitare dreaptă;
b. istoricul de trombofilie;
c. asocierea cu simptome respiratorii;
d. semne de HTAP la Eco;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-2, b-1, c-1, d-2;
D. a-2, b-1, c-2, d-1;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;
1246. R.I. evaluarea unui pacient cu DurTor acută, nou apărută, în desfășurare, f.d.u. sfârșituri de frază:
1. ridică suspiciunea de TEP;
2. întărește suspiciunea de TEP;
3. confirmă diagnosticul de TEP;
și următoarele începând de frază:
a. deviație axială dreaptă pe ECG;
b. TC spirală de înaltă rezoluție cu reconstrucție, echivalând cu o arteriografie prin TC;
c. caracterul pleuritic al durerii;
d. tuse asociată;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-3, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-3;
C. a-1, b-2, c-3, d-1;
D. a-2, b-1, c-3, d-1;
E. a-2, b-3, c-1, d-1;
1247. R.I. evaluarea unui pacient cu DurTor acută, nou apărută, în desfășurare, f.d.u. sfârșituri de frază:
1. ridică suspiciunea de TEP;
2. întărește suspiciunea de TEP;
3. este mai puțin demnă de încredere în confirmarea diagnosticului de TEP;
și următoarele începând de frază:
a. hemoptizia asociată;
b. undă P înaltă pe ECG;
c. sindruga pulmonară (de peritruze și de ventilație);
d. dilatarea cavității drepte la Eco;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3, d-2;
B. a-1, b-3, c-2, d-2;
C. a-2, b-1, c-3, d-2;
D. a-2, b-1, c-2, d-2;
E. a-3, b-2, c-1, d-2;
1248. R.I. evaluarea unui pacient cu DurTor acută, nou apărută, în desfășurare, f.d.u. sfârșituri de frază:
1. ridică suspiciunea de TEP;
2. întărește suspiciunea de TEP;
3. confirmă diagnosticul de TEP;
și următoarele începând de frază:
a. arteriografia pulmonară;
b. istoricul de tromboză venoasă profundă;
c. apariția BRD pe ECG;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
1249. C.d.u. NU susține diagnosticul de BCI la un pacient cu DurTor:
A. este cunoscut cu BCI;
B. are dureri tipice anginoase (prin caracter, localizare, iradiere, durată);
C. are modificări ischemice pe ECG;
D. are un suflu sistolic rugos parasternal sus;
E. are factori de risc pentru BCI;
1250. F.d.u. constatări/ concluzii clinice în evaluarea unui pacient cu DurTor recurență/ episodică:
a. agravare la efort, ameliorare în repaus;
b. pentru confirmare este utilă ECG, eventual ECG de efort sau chiar coronarografie;
c. se susține diagnosticul de durere coronariană;
d. probabilitate de durere coronariană;
e. pacientul este cunoscut cu BCI;
ce secvență este recomandabilă:
A. a → d → b → e → c;
B. a → d → e → c → b;
C. b → a → c → e → d;
D. e → b → c → a → d;
E. e → c → a → d → b;
1251. F.d.u. constatări/ concluzii clinice în evaluarea unui pacient cu DurTor recurență/ episodică:
a. pentru confirmare sunt utile ECG, eventual ECG de efort sau chiar coronarografie;
b. probabilitate de durere coronariană;
c. se susține diagnosticul de durere coronariană;
d. probabilitate de durere coronariană;
e. durerea nu sunt tipice anginoase (prin caracter, localizare, iradiere, durată);
f. durerea NU sunt tipice anginoase (prin caracter, localizare, iradiere, durată);
ce secvență este recomandabilă:
A. a → c → d → e → b;
B. b → c → d → e → a;
C. c → e → a → d → b;
D. d → b → e → c → a;
E. e → b → d → a → c;
1252. F.d.u. constatări/ concluzii clinice în evaluarea unui pacient cu DurTor recurență/ episodică:
a. agravare la efort, ameliorare în repaus;
b. modificări ischemice pe ECG;
c. este necesară ECG;
d. se susține diagnosticul de durere coronariană;
e. probabilitate de durere coronariană;
f. durerea NU sunt tipice anginoase (prin caracter, localizare, iradiere, durată);
ce secvență este recomandabilă:
A. a → e → d → b → c;
B. b → c → d → e → a;
C. c → e → a → d → b;
D. d → b → e → c → a;
E. e → b → d → a → c;
1253. F.d.u. constatări/ concluzii clinice în evaluarea unui pacient cu DurTor recurență/ episodică:
a. este necesară ECG de efort;
b. agravare la efort, ameliorare în repaus;
c. pe ECG nu apar modificări ischemice;
d. probabilitate de durere coronariană;
e. durerea nu sunt tipice anginoase (prin caracter, localizare, iradiere, durată);
ce secvență este recomandabilă:
A. a → c → e → d → b;
B. b → c → d → e → a;
C. c → e → a → d → b;
D. d → b → e → c → a;
E. e → b → d → a → c;
1254. F.d.u. constatări/ concluzii clinice în evaluarea unui pacient cu DurTor recurență/ episodică:
a. se susține diagnosticul de durere coronariană;
b. probabilitate de durere coronariană;
c. agravare la efort, ameliorare în repaus;
d. are modificări ischemice pe ECG;
ce secvență este recomandabilă:
A. a → b → c → d;
B. b → a → c → d;
C. c → b → d → a;
D. d → b → a → c;
E. e → d → a → b;
1255. F.d.u. constatări/ concluzii clinice în evaluarea unui pacient cu DurTor recurență/ episodică:
a. este necesară ECG de efort pentru a susține diagnosticul de durere coronariană;
b. agravare la efort, ameliorare în repaus;
c. probabilitate de durere coronariană;
d. nu are modificări ischemice pe ECG;
ce secvență este recomandabilă:
A. a → d → c → b;
B. b → a → d → c;
C. c → b → d → a;
D. c → a → b → d;
E. d → a → c → b;
1256. R.I. factori de risc pentru BCI care susțin diagnosticul de durere coronariană la un pacient cu DurTor recurență/ episodică, f.d.u. categorii:
1. nefluențabili;
2. influențabili;
și următorii factori de risc:
a. profil psihologic caracteristic;
b. sex (bărbați > femei);
c. vârstă (>40 ani la bărbați);
d. istoric de HTA;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-1, d-2;
E. a-2, b-1, c-2, d-1;
1257. R.I. factori de risc pentru BCI care susțin diagnosticul de durere coronariană la un pacient cu DurTor recurență/ episodică, f.d.u. categorii:
1. nefluențabili;
2. influențabili;
și următorii factori de risc:
a. vârstă (>50 ani la femei);
b. fumător;
c. dismetabolism obezitate, diabet, dislipidemie;
d. antecedente familiale;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-1, d-2;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;
1258. F.d.u. constatări/ concluzii clinice în evaluarea unui pacient cu DurTor recurență/ episodică datorată probabilității unei afecțiuni respiratorii:
a. cu toate acestea, întotdeauna se va avea în vedere și durerea coronariană;
b. se va efectua eventual și ECG de efort;
c. durerea NU are dependență de efort (agravare la efort, ameliorare în repaus);
d. se va efectua ECG;
ce secvență este recomandabilă:
A. b → d → c → a;
B. b → d → a → c;
C. c → a → b → d;
D. c → a → d → b;
E. d → c → b → a;
1259. R.I. DurTor recurență/ episodică independentă de efort, dar agravată la mișcarea toracelui, f.d.u. categorii de manifestări care indică o afecțiune respiratorie:
1. simptome respiratorii;
2. modificări de tip acut recent pe Rx pulmonară;
și următoarele manifestări:
a. condensare;
b. tuse;
c. dispnee;
d. bombarul arterei pulmonare;
e. revărsarea pleurală;
f. hemoptizie;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2, e-2, f-1;
B. a-1, b-2, c-2, d-1, e-2, f-1;
C. a-2, b-1, c-1, d-1, e-2, f-2;
D. a-2, b-1, c-1, d-2, e-2, f-1;
E. a-2, b-1, c-1, d-2, e-1, f-1;
1260. F.d.u. constatări/ concluzii clinice în evaluarea unui pacient cu DurTor recurență/ episodică față de dependență de efort:
a. agravare la mișcarea toracelui (respirație, tuse);
b. probabilitate de afecțiune respiratorie;
c. semne/simptome respiratorii și/sau modificări de tip acut recent pe Rx pulmonară;
d. probabilitate de durere pleuritică sau musculoscheletică;
ce secvență este recomandabilă:
A. a → d → c → b;
B. b → d → c → a;
C. c → d → b → a;
D. d → c → a → b;
E. d → c → b → a;
1261. F.d.u. constatări/ concluzii clinice în evaluarea unui pacient cu DurTor recurență/ episodică datorată probabilității unei afecțiuni respiratorii:
a. cu toate acestea, întotdeauna se va avea în vedere și durerea coronariană;
b. se va efectua eventual și ECG de efort;
c. durerea NU are dependență de efort (agravare la efort, ameliorare în repaus);
d. se va efectua ECG;
ce secvență este recomandabilă:
A. b → d → c → a;
B. b → d → a → c;
C. c → a → b → d;
D. c → a → d → b;
E. d → c → b → a;

Prescurtări frecvent folosite: C.d. = cu excepția, s.c.d. = sunt următoarele, cu excepția, u.a.s.c.d. = următoarele afirmări sunt corecte, cu excepția, s.c.i.d. = sunt corect formulate, cu excepția.

- c. se susține diagnosticul de durere coronariană;
d. agravare la efort, ameliorare în repaus;
e. are dureri tipice anginoase (prin caracter, localizare, iradiere, durată);
ce secvență este recomandabilă:
A. a → c → d → e → b;
B. b → c → d → e → a;
C. c → e → a → d → b;
D. d → b → e → c → a;
E. e → b → d → a → c;
1252. F.d.u. constatări/ concluzii clinice în evaluarea unui pacient cu DurTor recurență/ episodică:
a. agravare la efort, ameliorare în repaus;
b. modificări ischemice pe ECG;
c. este necesară ECG;
d. se susține diagnosticul de durere coronariană;
e. probabilitate de durere coronariană;
f. durerea NU sunt tipice anginoase (prin caracter, localizare, iradiere, durată);
ce secvență este recomandabilă:
A. a → d → c → b;
B. b → a → d → c;
C. b → c → d → a;
D. c → a → b → d;
E. d → a → c → b;
1256. R.I. factori de risc pentru BCI care susțin diagnosticul de durere coronariană la un pacient cu DurTor recurență/ episodică, f.d.u. categorii:
1. nefluențabili;
2. influențabili;
și următorii factori de risc:
a. profil psihologic caracteristic;
b. sex (bărbați > femei);
c. vârstă (>40 ani la bărbați);
d. istoric de HTA;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-1, d-2;
E. a-2, b-1, c-2, d-1;
1257. R.I. factori de risc pentru BCI care susțin diagnosticul de durere coronariană la un pacient cu DurTor recurență/ episodică, f.d.u. categorii:
1. nefluențabili;
2. influențabili;
și următorii factori de risc:
a. vârstă (>50 ani la femei);
b. fumător;
c. dismetabolism obezitate, diabet, dislipidemie;
d. antecedente familiale;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-1, d-2;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;
1258. F.d.u. constatări/ concluzii clinice în evaluarea unui pacient cu DurTor recurență/ episodică datorată probabilității unei afecțiuni respiratorii:
a. cu toate acestea, întotdeauna se va avea în vedere și durerea coronariană;
b. se va efectua eventual și ECG de efort;
c. durerea NU are dependență de efort (agravare la efort, ameliorare în repaus);
d. se va efectua ECG;
ce secvență este recomandabilă:
A. b → d → c → a;
B. b → d → a → c;
C. c → a → b → d;
D. c → a → d → b;
E. d → c → b → a;
1259. R.I. DurTor recurență/ episodică independentă de efort, dar agravată la mișcarea toracelui, f.d.u. categorii de manifestări care indică o afecțiune respiratorie:
1. simptome respiratorii;
2. modificări de tip acut recent pe Rx pulmonară;
și următoarele manifestări:
a. condensare;
b. tuse;
c. dispnee;
d. bombarul arterei pulmonare;
e. revărsarea pleurală;
f. hemoptizie;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2, e-2, f-1;
B. a-1, b-2, c-2, d-1, e-2, f-1;
C. a-2, b-1, c-1, d-1, e-2, f-2;
D. a-2, b-1, c-1, d-2, e-2, f-1;
E. a-2, b-1, c-1, d-2, e-1, f-1;
1260. F.d.u. constatări/ concluzii clinice în evaluarea unui pacient cu DurTor recurență/ episodică față de dependență de efort:
a. agravare la mișcarea toracelui (respirație, tuse);
b. probabilitate de afecțiune respiratorie;
c. semne/simptome respiratorii și/sau modificări de tip acut recent pe Rx pulmonară;
d. probabilitate de durere pleuritică sau musculoscheletică;
ce secvență este recomandabilă:
A. a → d → c → b;
B. b → d → c → a;
C. c → d → b → a;
D. d → c → a → b;
E. d → c → b → a;
1261. F.d.u. constatări/ concluzii clinice în evaluarea unui pacient cu DurTor recurență/ episodică datorată probabilității unei afecțiuni respiratorii:
a. cu toate acestea, întotdeauna se va avea în vedere și durerea coronariană;
b. se va efectua eventual și ECG de efort;
c. durerea NU are dependență de efort (agravare la efort, ameliorare în repaus);
d. se va efectua ECG;
ce secvență este recomandabilă:
A. b → d → c → a;
B. b → d → a → c;
C. c → a → b → d;
D. c → a → d → b;
E. d → c → b → a;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele, c.d.u. = care dăruie următoarele, f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, f.l. = referitor/referitoare la, U.a.s.c.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază despre.

Prescurtări frecvent folosite: C.E. = cu excepția; s.u.c.e. = sunt următoarele, cu excepția; u.a.s.c.e. = următoarele afirmații sunt corecte, cu excepția; s.c.f.e. = sunt corect formulate, cu excepția;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date; f.d.u. = fiind date următoarele, r.l. = referitor/referitoare la; U.f.d.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază despre;

ate. f.d.u. = fiind date următoarele, r.l. =
 ază despre;

E. pacienții cu tulburări psihice au o probabilitate mai mică de a declara că palpitațiile durează mai mult de 15 minute;

1282. R.1. substratul palpitațiilor, f.d.u. cauzele circumstanțe:

1. ventricul stâng mult mărit;
2. individul stă în pat, chinându-se să adoarmă;
3. creșterea nivelului de catecolamine;

și u. explicații pentru palpitații:

- a. lipsa competiției din partea altor stimuli senzoriali;
- b. mișcările ample ale peretelui ventricular;
- c. creșterea frecvenței extrasistolice;

care sunt asocierile corecte:

- A. a-1, b-2, c-3;
- B. a-1, b-3, c-2;
- C. a-2, b-1, c-3;
- D. a-2, b-3, c-1;
- E. a-3, b-2, c-1;

1283. R.1. substratul palpitațiilor, f.d.u. cauzele:

1. modificarea frecvenței cardiace;
2. creșterea nivelului de catecolamine;
3. creșterea forței contracțiilor cardiace;

și u. explicații pentru palpitații:

- a. tahicardia sinusală;
- b. bătăi cardiace prea rapide sau prea lente;
- c. bătăi cardiace puternice;
- care sunt asocierile corecte:

- A. a-1, b-2, c-3;
- B. a-1, b-3, c-2;
- C. a-2, b-1, c-3;
- D. a-2, b-3, c-1;
- E. a-3, b-2, c-1;

1284. R.1. substratul palpitațiilor, f.d.u. cauzele:

1. modificarea ritmului cardiac;
2. creșterea nivelului de catecolamine;
3. ventricul stâng mult mărit;
- și u. explicații pentru palpitații:

- a. creșterea forței contracțiilor cardiace;
- b. conștientizarea bătăilor inimii prin contactul cu peretele toracic;
- c. bătăi neregulate;

care sunt asocierile corecte:

- A. a-1, b-2, c-3;
- B. a-1, b-3, c-2;
- C. a-2, b-3, c-1;
- D. a-3, b-1, c-2;
- E. a-3, b-2, c-1;

Prescurtări frecvent folosite: C. & = cu excepția, S. u. C. & E. = sunt următoarele, cu excepția, u. a. s. C. & E. = următoarele afirmații sunt corecte, cu excepția, s. c. f. d. u. = sunt corect formulate, cu excepția.

1292. Factori care pot juca un rol în efectul aritmogen al alcoolului sunt următorii, c. & e.:

- A. posibila prezență a unei cardiomiopatii subclinice producând tulburări de conducere;
- B. excesul de polistiu și/sau magneziu;
- C. starea hiperadrenergică care însoțește severajul de alcool;

D. neuropatia vegetativă;

E. un efect direct al alcoolului asupra conducerii cardiace;

1293. R.1. palpitații, f.d.u. descrieri:

1. intermitente;
2. susținute regulate;
3. susținute neregulate;

și următoarele aritmii:

- a. tahicardii supraventriculare sau ventriculare;
- b. extrasistole atriale sau ventriculare;
- c. fibrilație atrială;

care sunt asocierile corecte:

- A. a-1, b-2, c-3;
- B. a-1, b-3, c-2;
- C. a-2, b-1, c-3;
- D. a-3, b-1, c-2;
- E. a-3, b-2, c-1;

1294. U. f. d. u. palpitații s. c. f. d. u.:

- A. în cazul palpitațiilor asociate cu aritmii, este adesea util ca;
- B. pacientul să încerce să reproducă ritmul palpitațiilor bătând în masă;
- C. (manevră care poate ajuta medicul să determine caracterul oricărei aritmii cardiace);

D. să învețe să-și ia pulsul în afara accesului de palpitații;

E. astfel încât să poată relația mai corect FC aproximativă și dacă ritmul era regulat.

1295. C. d. u. aspecte este cel mai puțin relevant în descrierea de către pacient a palpitațiilor:

1. sincopă, amețeli, dispnee;
2. angină pectorală sau dispnee;
3. durată;
4. alimentele care le influențează;

B. alimentele care le influențează;

C. durată;

D. simptomele asociate;

E. circumstanțele în care se produc;

1296. F. d. u. evenimente care explică palpitațiile induse de extrasistole:

- a. extrasistola este urmată de o pauză compensatorie;
- b. crește umplerea VS;
- c. extrasistola nu provoacă descărcarea nodului sinatrial;

d. crește volumul și contractilitatea VS;

e. prima bătăie după pauză este neobișnuit de puternică;

A. a-1, b-2, c-3;

B. a-1, b-3, c-2;

C. a-2, b-1, c-3;

D. a-3, b-1, c-2;

E. a-3, b-2, c-1;

1297. R.1. diagnosticul diferențial (orientativ) al palpitațiilor în funcție de modul în care pacientul le descrie, f.d.u. descrieri:

1. ritmul bătăilor cardiace este regulat, iar frecvența este normală;
2. ritmul bătăilor cardiace este regulat, iar frecvența este rapidă;
3. ritmul bătăilor cardiace este neregulat, pacientul percepend că o bătăie sărită, că o singură bătăie puternică sau o senzație de „furiere”;

4. ritmul bătăilor cardiace este neregulat, pacientul percepend șarje (mai lungi sau mai scurte) de bătăi rapide și neregulate;

și următoarele diagnostice:

- a. extrasistole atriale sau ventriculare;
- b. fibrilație atrială;
- c. percepție excesivă a unui RS;
- d. tahiaritmii ventriculare sau supraventriculare susținute sau nesusținute;

care sunt asocierile corecte:

- A. a-1, b-4, c-3, d-2;
- B. a-3, b-1, c-4, d-2;
- C. a-3, b-2, c-1, d-4;
- D. a-3, b-2, c-1, d-2;
- E. a-4, b-3, c-1, d-2;

1298. F. d. u. simptome care pot însoți palpitațiile semnaland o boală cardiacă organică:

1. sincopă, amețeli, dispnee;
2. angină pectorală sau dispnee;
3. durată;
4. alimentele care le influențează;

B. alimentele care le influențează;

C. durată;

D. simptomele asociate;

E. circumstanțele în care se produc;

1299. U. f. d. u. cauzele cardiace ale aritmiilor s. c. f. d. u.:

- A. la pacienții cu disfuncție ventriculară (sistolă sau diastolică), secundară unei valvopatii sau unei cardiomiopatii a inimii stângi;
- care sunt asocierile corecte:

- A. a-1, b-2, c-3;
- B. a-1, b-3, c-2;
- C. a-2, b-1, c-3;
- D. a-3, b-1, c-2;
- E. a-3, b-2, c-1;

- substrat o aritmie și dacă aceasta produce consecințe hemodinamice;
1302. C.d.u. elemente de examen fizic este cel mai puțin util în a stabili dacă o aritmie este cauza palpitațiilor și dacă aceasta produce consecințe hemodinamice;
- A. TA;
B. pulsul;
C. evaluarea presiunii venoase jugulare și a pulsului venos jugular;
D. auscultație toracică și a inimii;
E. examenul abdominalului;
1303. F.d.u. investigații utile la un pacient cu palpitații:
1. ECG de repaus;
2. ECG de efort;
3. monitorizarea ECG continuă (Holter);
4. tehnologii care permit înregistrarea ECG în momentul simptomelor;
- și următoarele indicații:
- a. dacă se știe că efortul induce aritmii palpitații;
b. pentru documentarea arimiei;
c. dacă palpitațiile sunt zilnice;
d. dacă palpitațiile nu sunt zilnice; care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3, d-4;
B. a-1, b-3, c-2, d-4;
C. a-2, b-1, c-3, d-4;
D. a-3, b-4, c-2, d-1;
E. a-4, b-3, c-1, d-2;
1304. U.I.F.D. investigarea unui pacient cu palpitații s.c.f.g.g.:
- A. în funcție de frecvența episoadelor de palpitații;
B. se poate recurge fie la monitorizarea ECG continuă (Holter);
C. fie la tehnologii care permit înregistrarea ECG în afara episoadelor simptomatice;
D. prin păstrarea înregistrării dintr-un anumit interval de timp când pacientul apăsă pe un buton sau prin transmiterea telefonică a înregistrării când se produc simptomele.
- Tulburări de ritm și de conducere - dr.J.F.B.**
1305. Bradicardia sinusală NU poate apărea:
- A. în cursul somnului;
B. la persoanele cu hipervagotonie constituțională;
- C. în intoxicația cu insecticide organofosforice;
D. la persoane fără afecțiuni vasculare;
- A. ritmul este regulat;
B. zgomotele cardiace sunt inechipotente, inechidistante;
C. tensiunea arterială sistolică este constantă la măsurători repetate;
D. suflurile cardiace sunt accentuate;
- E. nu există deficit de puls;
1312. C.d.u. criterii ECG NU este diagnostic pentru fibrilația atrială:
- A. lipsa undelor P;
B. prezența undelor "f" cu aspect de "dinți de ferăstrău", cu frecvență de 250-350/minut;
C. prezența undelor "f" cu frecvență de 400-600/minut;
D. complexe QRS ce se succed complet neregulat, adesea cu o frecvență de 120-180/minut (în lipsa tratamentului);
E. undele "f" mici, înguste, neregulate ca formă și succesiune;
1313. C.d.u. manifestări NU sunt o consecință a scăderii debitului cardiac în fibrilația atrială:
- A. lipotimii/sincope;
B. fătășibilitate;
C. precipitarea unei crize anginoase sau chiar a unui IMA;
D. tromboembolism pulmonar;
E. precipitarea unei insuficiențe renale acute sau agravarea unei insuficiențe renale cronice preexistente;
1314. În fibrilația atrială:
- A. funcția mecanică a atriilor este păstrată, dar debitul cardiac scade datorită frecvenței cardiace mari;
B. funcția mecanică a atriilor este pierdută, dar debitul cardiac se menține normal prin creșterea frecvenței cardiace;
C. funcția mecanică a atriilor este pierdută iar debitul cardiac scade cu maxim 10%;
D. funcția mecanică a atriilor este păstrată, iar debitul cardiac crește atât timp cât frecvența cardiacă nu depășește 160/minut;
E. funcția mecanică a atriilor este pierdută iar debitul cardiac scade semnificativ, chiar cu >25%, funcție și de frecvența de stimulare a ventriculului stâng.
1315. Fibrilația atrială:

- A. este o tahiaritmie supraventriculară cu ritm regulat;
B. este o aritmie normotopă;
C. este o tahiaritmie supraventriculară cu ritm complet neregulat;
D. este o bradiaritmie supraventriculară cu ritm regulat;
E. este o bradiaritmie supraventriculară cu ritm neregulat;
1316. Lipolimia reprezintă:
- A. pierderea posturii (slăbiciune musculară generalizată, cu incapacitatea de a păstra poziția ortostatică), fără pierderea stărilor de conștiență;
B. pierderea posturii (slăbiciune musculară generalizată, cu incapacitatea de a păstra poziția ortostatică) și pierderea stărilor de conștiență;
C. pierderea posturii, însoțită de convulsii tonico-clonice;
D. pierderea bruscă, tranzitorie, a stărilor de conștiență, de cauză aritmică;
E. slăbiciune musculară generalizată (cu păstrarea ortostatismului), însoțită de amețeli, greață, tulburări vizuale, confuzie;
1317. Clinic, pacienții cu TPSV NU pot prezenta:
- A. anxietate;
B. palpitații cu ritm rapid și regulat;
C. accentuarea suflurilor cardiace;
D. poliurie după accesul aritmice;
E. amețeli;
1318. În tahicardia paroxistică atrială ectopică:
- A. ritmul cardiac este regulat;
B. ritmul cardiac este influențat de poziție;
C. ritmul cardiac este influențat de respirație;
D. ritmul cardiac este influențat de efort;
E. frecvența cardiacă este 250-350/min;
1319. C.d.u. elemente ECG NU este diagnostic pentru tahicardia atrială multifocală:
- A. frecvența cardiacă >100/min;
B. prezența a cel puțin 3 tipuri diferite de unde P ectopice;
C. ritmul ventricular regulat;
D. prezența frecvenței a unor unde P blocaie;
E. existența liniei izoelectrice între undele P;
1320. Sindromul Wolff-Parkinson-White:
- A. este cel mai frecvent dintre sindroamele de preexcitație;
- B. originea ectopică idioatrială, precocitate, cuplajul fix;
- C. se asociază cu aritmii ventriculare;
- D. are drept cauză activarea ventriculărilor pe calea fibrelor James;
- E. are drept cauză activarea ventriculărilor pe calea fibrelor Mahaim;
1321. În c.d.u. tulburări de ritm supraventriculare ritmul cardiac este neregulat:
- A. tahicardia sinusală;
B. flutterul atrial cu bloc 2:1;
C. tahicardia paroxistică atrială;
D. tahicardia atrială multifocală;
E. tahicardia paroxistică joncțională reîntrântă (Bouvet);
1322. C.d.u. investigații NU este utilă în diagnosticarea tipului sau a cauzei unei aritmii:
- A. ECG de repaus;
B. ECG de efort;
C. ECG Holter;
D. ecografia cardiacă;
E. ecografia Doppler carotidiană;
1323. Dintre factorii de risc pentru apariția TVP NU face parte:
- A. sarcina;
B. obezitatea;
C. vârsta < 50 ani;
D. deficitul de proteina C;
E. cancerul pulmonar;
1324. C.d.u. afecțiuni NU determină distincție acută a nodului sinusal:
- A. infarctul miocardic acut;
B. angina Prinzmetal;
C. conversia electrică a fibrilației atriale;
D. hemocromatoza;
E. bolile infecțioase (febra tifoidă, bruceleza);
1325. C.d.u. manifestări NU sunt sugestive pentru boala de nod sinusal:
- A. bradicardia sinusală în cursul zilei, în absența factorilor precipitanți ai acesteia;
B. apariția bradicardiei sinusale la un pacient cu infarct miocardic acut inferior;
C. sindromul bradi-tahi (alternanța de bradicardie cu tahiaritmii);
D. lipsa tahicardizării la efort;
E. oprire sinusală (pauze sinusale > 3 sec.);
1326. Caracteristicile de bază ale unei extrasistole atriale sunt:
- A. originea ectopică idioatrială, precocitate, cuplajul fix;

- B. apare cel mai frecvent la pacienți cu infarct miocardic;
C. originea ectopică idioatrială, precocitate, cuplajul variabil;
D. originea ectopică idioatrială, latența de apariție, cuplajul variabil;
E. mecanismul de reintrare, precocitate, cuplajul fix;
1327. Caracteristicile ECG ale unei extrasistole atriale NU includ:
- A. undă P' cu morfologie diferită de a P sinusal, precedând QRS;
B. intervalul preextrasistolic (PP') mai scurt decât PP al RS de bază;
C. complex QRS de obicei larg;
D. durata Pp' constantă pentru extrasistolele atriale cu origine în același focar (monomorfie);
E. P' nu scade sub 0,12";
1328. În tahicardia paroxistică atrială (ectopică):
- A. undele P' au aceeași morfologie cu a ritmului sinusal de bază;
B. undele P' au cel puțin 3 morfologii diferite;
C. frecvența cardiacă este de 300-350/minut;
D. ritmul în acces este regulat, neinfluențat de respirație, poziție sau efort;
E. pentru diagnostic, accesul trebuie să aibă minim 9 extrasistolele atriale succesive;
1329. Aspectul ECG diagnostic pentru sindromul WPW este:
- A. PR > 0,12" și undă delta prezentă la începutul complexului QRS;
B. PR > 0,12", complex QRS larg, cu undă delta prezentă la începutul complexului QRS, având aspect de deflexiune ascendentă (sau descendentă);
C. PR < 0,12", complex QRS larg, cu undă delta prezentă la începutul complexului QRS, având aspect de deflexiune ascendentă (sau descendentă);
D. PR < 0,12", undă delta absentă, complex QRS normal, ca durată;
E. PR < 0,12", undă delta absentă, complex QRS larg;
1330. Apariția unei tahiaritmii supraventriculare la un pacient cu sindrom WPW:
- A. este bine tolerată datorită blocării multor impulsuri atriale la nivelul fasciculiului accesoriu;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele; r. = referitor/referență la; U.I.F.D. = Următoarele fragmente dintr-o frază despres;

Prescurtări frecvent folosite: c.f. = cu excepția; s.c.f.g. = sunt următoarele, cu excepția; u.s.c.f.g. = următoarele afirmatii sunt corecte, cu excepția; s.c.f.g. = sunt corect formulate, cu excepția;

- B. nu necesită tratament, fiind în majoritatea cazurilor auto-limitată;
C. este foarte rară, aritmia supraventriculară apărând caracteristic în sindromul LGL și nu în WPW;
D. poate determina creșterea bruscă a tensiunii arteriale;
E. este o urgență, putând apărea sincopă și chiar moarte subită cardiacă.
- 1331. Sindromul Lown-Ganong-Levine (LGL) se caracterizează pe ECG prin:**
A. PR scurt ($< 0,12''$), undă delta prezentă, QRS larg;
B. PR normal, undă delta prezentă, QRS larg;
C. PR scurt, undă delta absentă, QRS normal, prezența unor turburări de ritm supra-ventriculare;
D. PR scurt, fără alte modificări; E. undă P finală, ascuțită, PR $> 0,12''$, asociere frecventă cu tahiaritmii supraventriculare;
- 1332. Conform clasificării Lown a extrasistolelor ventriculare (ESV), progresivul cel mai grav îl au:**
A. ESV în număr de > 300 oră;
B. ESV cu "fenomen R/T";
C. bigeminismul ventricular;
D. impletile;
E. dubletele;
- 1333. Despre aritmii ventriculare NU este adevărat că:**
A. pot apărea după un IMV;
B. pot apărea în angina Prinzmetal;
C. nu apar decât pe cord patologic;
D. pot apărea după consumul de alcool;
E. pot apărea în caz de hipopotasemie;
- 1334. Pe electrocardiograma unui pacient cu tahicardie ventriculară NU vom întâlni:**
A. complexe QRS largi ($> 0,14''$);
B. frecvență cardiacă $100 - 250$ min;
C. complexe QRS de fuziune;
D. disociație arto-ventriculară;
E. ritm neregulat;
- 1335. În tahicardia ventriculară sustinută, instabilitate hemodinamică, pacientul NU va prezenta:**
A. palpitații cu ritm rapid;
C. tegumente transpirate, reci;
D. creșterea valorilor TA;
E. pierderea stărilor de conștiență;
- 1336. Despre torsada vârfurilor este adevărat că:**
A. este o tahiaritmie ventriculară cu complexe QRS înguste, al căror vârf "se răsucesc" în jurul liniei izoelectrice;
B. este o tahicardie ventriculară monomorfă, cu complexe QRS largi, al căror vârf "se răsucesc" în jurul liniei izoelectrice;
C. este o tahicardie ventriculară polymorfă, cu complexe QRS largi, al căror vârf "se răsucesc" în jurul liniei izoelectrice;
D. este o tahicardie atrială monomorfă, cu complexe QRS largi, al căror vârf "se răsucesc" în jurul liniei izoelectrice;
E. este o tahicardie atrială polymorfă, cu complexe QRS largi, al căror vârf "se răsucesc" în jurul liniei izoelectrice;
- 1337. Torsada vârfurilor:**
A. apare frecvent pe cord normal;
B. apare frecvent după consumul de etanol;
C. apare la pacienți cu QT alungit congenital sau după administrarea unor medicamente care alungesc QT;
D. nu are risc de degenerare în fibrilație ventriculară;
E. este bine suportată, frecvența ventriculară nedeșășind în general 150 min;
- 1338. În flutterul ventricular, aspectul ECG caracteristic este:**
A. complexe QRS largi, monomorfă, cu frecvența de $50-100$ min, fără undă P sau T;
B. complexe QRS largi, monomorfă, cu frecvența de $150-250$ min, fără undă P sau T;
C. P retrograd, complexe QRS largi cu frecvența de $200-250$ min, QT normal;
D. P retrograd, complexe QRS largi cu frecvența de $200-250$ min, QT normal;
E. P retrograd, complexe QRS largi cu frecvența de $200-250$ min, QT alungit;
- 1339. În fibrilația ventriculară:**
A. nu se pot distinge complexe QRS, ST, T, nu există undă P, pe ECG apar unde fibrilatorii neregulați, îngali, cu frecvență $200 - 600$ min;
B. complexe QRS sunt largi, cu frecvența de $200-600$ min, urmate de T negative; nu există undă P;
C. nu se pot distinge complexe QRS, ST, T, nu există undă P, pe ECG apar unde fibrilatorii neregulați, îngali, cu frecvență $200 - 600$ min;
D. se pot distinge complexe QRS, ST, T, nu există undă P, pe ECG apar unde fibrilatorii neregulați, îngali, cu frecvență $200 - 600$ min;
E. complexe QRS sunt largi, neprecedate de undă P și neurmate de undă T, și au frecvența regulată, de $100-200$ min;
- 1340. Clinic, un pacient cu fibrilație ventriculară NU va prezenta:**
A. pierderea stării de conștiență;
B. zgomot cardiac tahicardic, de intensitate scăzută;
C. tegumente reci, marmorate;
D. respirație stertoroasă sau stop respirator;
- 1341. În tahicardia paroxistică atrială (epiciclică), compresia sinus-ciclică determină:**
A. apariția unui bloc de ramură stângă;
B. apariția unui bloc de ramură dreaptă;
C. oprirea aritmiei;
D. blocarea nodului atrioventricular pe durata compresiei, cu apariția de unde P în serie ("urmată de complexe QRS");
E. scurtarea intervalului PR;
- 1342. Tahicardia Bouvier:**
A. este forma cea mai rară de TBSV;
B. este o aritmie înțepărită prin mecanism de reîntare, sediul circuitului de reîntare fiind atriul stâng (în jurul orificiilor de varșare ale venei cave superioare);
C. apare cel mai frecvent la persoane fără afecțiuni cardiace;
D. se caracterizează prin ritm cardiac rapid, neregulat (300 min);
E. pe ECG activitatea atrială este vizibilă sub forma unor unde cu aspect de "dint de fierăstrău";
- 1343. Despre tahicardia atrială multifocală este adevărat că:**
A. apare în principal în boli pulmonare cronice cu insuficiență respiratorie severă și cord pulmonar;
B. apare cel mai frecvent în stenoza mitrală;
C. se diagnostichează pe ECG în prezența a cel puțin 3 extrasistole atriale cu aceeași morfologie;
D. la auscultația cordului ritmul cardiac este tahicardic (> 100 min);
E. are cel mai frecvent complexe QRS largi pe ECG;
- 1344. Fibrilația atrială este o:**
A. tahiaritmie supraventriculară caracterizată prin activitate atrială desincronizată, foarte rapidă, cu o transmitere AV parțială dar care determină o activare ventriculară regulată datorită instalării unui BAV fix;
B. tahiaritmie supraventriculară caracterizată prin activitate atrială desincronizată, foarte rapidă, cu o transmitere AV parțială dar care determină o activare ventriculară regulată datorită instalării unui BAV fix;
C. tahiaritmie supraventriculară caracterizată prin activitate atrială desincronizată, foarte rapidă, cu o transmitere AV parțială și o transmitere AV rapidă, cu o transmitere AV parțială dar care determină o activare ventriculară regulată datorită instalării unui BAV fix;
D. tahiaritmie supraventriculară caracterizată prin activitate atrială desincronizată, foarte rapidă, cu o transmitere AV parțială și o transmitere AV rapidă, cu o transmitere AV parțială dar care determină o activare ventriculară regulată datorită instalării unui BAV fix;
- 1345. La examenul obiectiv al unui pacient cu fibrilație atrială NU vom găsi:**
A. ritm cardiac complet neregulat, cu bătaie cardiacă inechidistantă și înecohicentă;
B. variabilitatea TA sistolică la măsurări repetate;
C. șoc apăsător deplasat în jos și spre stânga la pacienții care au și HVS (de exemplu la hipertensivi);
D. puls filiform, dar cu toate bătaile cardiace transmise în periferie (puls măsurat la artera radială);
E. deficit al pulsului;
- 1346. La un pacient tânăr, fără afecțiuni cardiace preexistente, apariția unei fibrilații atriale are drept principală complicație:**
A. scăderea marcată a debitului cardiac, cu riscul apariției rapide a unui edem pulmonar acut;
B. apariția unui IMV;
C. formarea de trombi intraatriali și risc crescut de embolizare periferică;
D. formarea de trombi intraventriculari, cu risc major de apariție a emboliilor periferice;
E. apariția fibrilației atriale în acest caz nu se însoțește de nici o complicație;
- 1347. Flutterul atrial este o:**
A. tahiaritmie supraventriculară, caracterizată prin o activitate atrială regulată, cu frecvență de $250-350$ min, cu ritm ventricular regulat sau neregulat, funcție de gradul și variabilitatea blocului AV asociat;
B. tahiaritmie supraventriculară, caracterizată prin o activitate atrială și ventriculară perfect regulată, cu frecvența de $250-350$ min;
C. tahiaritmie supraventriculară, caracterizată prin o activitate atrială regulată, cu frecvența de $250-350$ min, și ritm ventricular regulat (aproximativ 150 min, datorită asocierii în 100% din cazuri a BAV 2:1);
D. tahiaritmie supraventriculară, caracterizată prin o activitate atrială regulată, cu frecvența de $250-350$ min, și ritm ventricular regulat (aproximativ 150 min, datorită asocierii în 100% din cazuri a BAV 2:1);
E. tahiaritmie supraventriculară, caracterizată prin o activitate atrială regulată, cu frecvența de $250-350$ min, și ritm ventricular regulat (aproximativ 150 min, datorită asocierii în 100% din cazuri a BAV 2:1);
- 1348. La compresia sinusului carotidian în flutterul atrial NU va apărea:**
A. creșterea frecvenței cardiace și ritm neregulat prin transformarea flutterului atrial în fibrilație atrială;
B. creșterea frecvenței cardiace, dar cu păstrarea ritmului regulat, prin apariția conducerei arto-ventriculare 1:1;
C. scăderea variabilă a frecvenței cardiace, ritmul cardiac devenind bradicardic și complet neregulat;
D. apariția unui IMV;
E. scăderea bruscă a frecvenței cardiace (sub 60 min) și ritm cardiac regulat, prin asistole prelungite, reversibile la întrerucerea stimulării;
- 1349. Transmiterea 1:1 în flutterul atrial:**
A. este frecventă, fiind întâlnită la majoritatea pacienților cu flutter atrial;
B. nu se însoțește de turburări hemodinamice;
C. este modalitatea de prezentare la debut a flutterului atrial, după $24-48$ ore instalându-se un BAV (de obicei 2:1);
D. nu apare nicodată;
E. poate apărea în hipertrofie;
- 1350. Cel mai frecvent întâlnit sindrom de preexcitație este:**
A. Lown-Ganong-Levine;
B. Wolff-Parkinson-White (WPW);
C. preexcitația prin fibre Mahaim;
D. sindromul "predi-kan";
E. sindromul Trousseau;
- 1351. C.d.u. afirmații NU caracterizează sindromul WPW:**
A. apare cel mai frecvent pe cord indolent;
B. preexcitația ventriculară se realizează pe calea fasciculului lent;
C. se asociază frecvent cu tahiaritmii supraventriculare, care sunt bine tolerate datorită conducerii mai lente prin fasciculul Kent;
D. poate fi diagnosticat pe o ECG de rutină;
E. în ritm sinus, ventriculii sunt activați parțial pe calea fasciculului Kent (apar unde delta) și parțial pe calea normală a funcțiunii AV;
- 1352. C.d.u. afecțiuni NU pot determina apariția unui BAV acut:**
A. IMV;
B. miocardite;
C. endocardite;
D. intervenție chirurgicală pe cord;
E. calcificările valvelor aortice;
- 1353. BAV gradul 1 se caracterizează prin:**

Prescurtări frecvent folosite: C.d.u. = cu excepția; S.U.C.d. = sunt următoarele, cu excepția; U.S.C.d. = următoarele afirmații sunt corecte, cu excepția; S.C.U.C.d. = sunt corect formulate, cu excepția.

- 1346. La un pacient tânăr, fără afecțiuni cardiace preexistente, apariția unei fibrilații atriale are drept principală complicație:**
A. scăderea marcată a debitului cardiac, cu riscul apariției rapide a unui edem pulmonar acut;
B. apariția unui IMV;
C. formarea de trombi intraatriali și risc crescut de embolizare periferică;
D. formarea de trombi intraventriculari, cu risc major de apariție a emboliilor periferice;
E. apariția fibrilației atriale în acest caz nu se însoțește de nici o complicație;
- 1347. Flutterul atrial este o:**
A. tahiaritmie supraventriculară, caracterizată prin o activitate atrială regulată, cu frecvență de $250-350$ min, cu ritm ventricular regulat sau neregulat, funcție de gradul și variabilitatea blocului AV asociat;
B. tahiaritmie supraventriculară, caracterizată prin o activitate atrială și ventriculară perfect regulată, cu frecvența de $250-350$ min;
C. tahiaritmie supraventriculară, caracterizată prin o activitate atrială regulată, cu frecvența de $250-350$ min, și ritm ventricular regulat (aproximativ 150 min, datorită asocierii în 100% din cazuri a BAV 2:1);
D. tahiaritmie supraventriculară, caracterizată prin o activitate atrială regulată, cu frecvența de $250-350$ min, și ritm ventricular regulat (aproximativ 150 min, datorită asocierii în 100% din cazuri a BAV 2:1);
E. tahiaritmie supraventriculară, caracterizată prin o activitate atrială regulată, cu frecvența de $250-350$ min, și ritm ventricular regulat (aproximativ 150 min, datorită asocierii în 100% din cazuri a BAV 2:1);
- 1348. La compresia sinusului carotidian în flutterul atrial NU va apărea:**
A. creșterea frecvenței cardiace și ritm neregulat prin transformarea flutterului atrial în fibrilație atrială;
B. creșterea frecvenței cardiace, dar cu păstrarea ritmului regulat, prin apariția conducerei arto-ventriculare 1:1;
C. scăderea variabilă a frecvenței cardiace, ritmul cardiac devenind bradicardic și complet neregulat;
D. apariția unui IMV;
E. scăderea bruscă a frecvenței cardiace (sub 60 min) și ritm cardiac regulat, prin asistole prelungite, reversibile la întrerucerea stimulării;
- 1349. Transmiterea 1:1 în flutterul atrial:**
A. este frecventă, fiind întâlnită la majoritatea pacienților cu flutter atrial;
B. nu se însoțește de turburări hemodinamice;
C. este modalitatea de prezentare la debut a flutterului atrial, după $24-48$ ore instalându-se un BAV (de obicei 2:1);
D. nu apare nicodată;
E. poate apărea în hipertrofie;
- 1350. Cel mai frecvent întâlnit sindrom de preexcitație este:**
A. Lown-Ganong-Levine;
B. Wolff-Parkinson-White (WPW);
C. preexcitația prin fibre Mahaim;
D. sindromul "predi-kan";
E. sindromul Trousseau;
- 1351. C.d.u. afirmații NU caracterizează sindromul WPW:**
A. apare cel mai frecvent pe cord indolent;
B. preexcitația ventriculară se realizează pe calea fasciculului lent;
C. se asociază frecvent cu tahiaritmii supraventriculare, care sunt bine tolerate datorită conducerii mai lente prin fasciculul Kent;
D. poate fi diagnosticat pe o ECG de rutină;
E. în ritm sinus, ventriculii sunt activați parțial pe calea fasciculului Kent (apar unde delta) și parțial pe calea normală a funcțiunii AV;
- 1352. C.d.u. afecțiuni NU pot determina apariția unui BAV acut:**
A. IMV;
B. miocardite;
C. endocardite;
D. intervenție chirurgicală pe cord;
E. calcificările valvelor aortice;
- 1353. BAV gradul 1 se caracterizează prin:**

Prescurtări frecvent folosite: C.d.u. = cu excepția; S.U.C.d. = sunt următoarele, cu excepția; U.S.C.d. = următoarele afirmații sunt corecte, cu excepția; S.C.U.C.d. = sunt corect formulate, cu excepția.

- A. interval PR lung (0,21-0,4"); dar constant (pentru aceeași frecvență), fiecare complex QRS fiind precedat de o undă P;
B. creșterea progresivă a intervalului PR, până când o undă P este blocată, după care ciclul se reia;
C. interval PR >0,21", constant; intermitent apare pe traseul ECG o undă P blocată (neumată de QRS);
D. interval PR >0,21", complexe QRS largi, undă delta prezentă; E. blocarea a 2 sau mai multe impulsuri atriale consecutive, undele P blocate fiind mai numeroase decât cele conduse;
1354. Despre BAV gradul 3 este fals că:
A. activitatea ventriculară este complet independentă de cea atrială (prin întreruperea completă a conducerii stimulului atrial la ventriculi);
B. ritmul atrilor poate fi unul din următoarele: a) ritm sinusal, fibrilație atrială, flutter atrial, tahicardie paroxistică atrială, ritm nodal;
C. ritmul ventricular este cel mai frecvent mai rapid decât cel atrial;
D. lipsește orice relație între P și QRS (interval PR foarte variabil, unde P survin înalte, peste sau după QRS);
E. QRS poate fi îngust (bloc deasupra bifurcației fasciculiului His) sau larg (bloc infranodular sau deasupra bifurcației, dar cu bloc de ramură preexistent);
1355. Clinic, în BAV gradul 3 NU vom întâlni:
A. zgomote diastolice corespunzând sistolelor atriale blocate ("galop de bloc");
B. variația intensității zgomotului I;
C. intermitent "zgomot de tun" (când se stabilește o secvență A-V optimă, PR de 0,1-0,12");
D. frecvența cardiacă de 30-35/min., caracteristică ritmului idioventricular, care crește la efort sau administrare de atropină;
E. creșterea TA sistolică;
1356. Despre blocurile intraventriculare este fals că:
A. pot apărea după o endocardită infecțioasă;
B. pot apărea în urma calcificării aparatului valvular aortic;
- C. BRD poate fi congenitală, dar la care examenele ECG repetate sunt normale, se va face pe baza:
A. testului ECG de efort;
B. ecografiei cardiace trans-toracice;
C. coronarografiei;
D. six minutes walk test;
E. monitorizării Holter;
1362. Unele aritmii pot evolua cu frecvență cardiacă în limite normale și ritm regulat, neputând fi astfel decelate doar pe baza examenului obiectiv cardiac - dintre aceste aritmii NU face însă parte una din următoarele:
A. flutterul atrial cu bloc fix 4:1 (frecvența undelor "F" pe ECG este 300/min.);
B. tahicardia joncțională neparoxistică;
C. ritmul idioventricular accelerat; (în repaus, la frecvență cardiacă de 50/minut, în lipsa oricăror simptome, examenul obiectiv cardio-vascular fiind normal), care dispare la efort sugerează:
A. o alecțiune cardiacă congenitală;
B. boală ischemică coronariană, necesitând coronarografie de urgență;
C. hipervagotonie care nu necesită nici un tratament;
D. o miocardită silențioasă clinic;
E. un defect septal atrial;
1359. La auscultația cordului unui pacient venit la camera de gardă pentru palpații medicul găsește ritm rapid și regulat, alura ventriculară 150/minut - c.d.u. tulburări de ritm NU poate avea caracteristicile de mai sus:
A. tahicardia paroxistică atrială;
B. tahicardia sinusală;
C. tahicardia atrială multifocală;
D. flutterul atrial;
E. tahicardia ventriculară;
1360. Diagnosticarea tipului aritmiei, la un pacient aflat în cursul unui episod aritmici, se va face pe baza:
A. ecografiei cardiace trans-toracice;
B. six minutes walk test;
C. testului ECG de efort;
D. ECG;
E. monitorizării Holter pe 24 de ore;
1361. Diagnosticarea tipului aritmiei la un pacient care descrie
- episoade repetate de palpații, dar la care examenele ECG repetate sunt normale, se va face pe baza:
A. testului ECG de efort;
B. ecografiei cardiace trans-toracice;
C. coronarografiei;
D. six minutes walk test;
E. monitorizării Holter;
1362. Unele aritmii pot evolua cu frecvență cardiacă în limite normale și ritm regulat, neputând fi astfel decelate doar pe baza examenului obiectiv cardiac - dintre aceste aritmii NU face însă parte una din următoarele:
A. flutterul atrial cu bloc fix 4:1 (frecvența undelor "F" pe ECG este 300/min.);
B. tahicardia joncțională neparoxistică;
C. ritmul idioventricular accelerat; (în repaus, la frecvență cardiacă de 50/minut, în lipsa oricăror simptome, examenul obiectiv cardio-vascular fiind normal), care dispare la efort sugerează:
A. o alecțiune cardiacă congenitală;
B. boală ischemică coronariană, necesitând coronarografie de urgență;
C. hipervagotonie care nu necesită nici un tratament;
D. o miocardită silențioasă clinic;
E. un defect septal atrial;
1359. La auscultația cordului unui pacient venit la camera de gardă pentru palpații medicul găsește ritm rapid și regulat, alura ventriculară 150/minut - c.d.u. tulburări de ritm NU poate avea caracteristicile de mai sus:
A. tahicardia paroxistică atrială;
B. tahicardia sinusală;
C. tahicardia atrială multifocală;
D. flutterul atrial;
E. tahicardia ventriculară;
1360. Diagnosticarea tipului aritmiei, la un pacient aflat în cursul unui episod aritmici, se va face pe baza:
A. ecografiei cardiace trans-toracice;
B. six minutes walk test;
C. testului ECG de efort;
D. ECG;
E. monitorizării Holter pe 24 de ore;
1361. Diagnosticarea tipului aritmiei la un pacient care descrie

Prescurtări frecvent folosite: S.E. = cu excepție; s.u.c.d. = sunt următoarele, cu excepție; u.s.c.d. = următoarele afirmatii sunt corecte, cu excepție; s.c.f. = sunt corect formulate, cu excepție.

- D. este caracterizată printr-o concordanță a ritmului cardiac cu fazele respirației, cu creșterea frecvenței în inspir și scăderea ei în expir;
E. apare la altitudine, în condiții de hipoxie;
1367. C.d.u. situații stări patologice NU determină apariția disecției de aortă:
A. efortul fizic;
B. administrarea de atropină;
C. sindroamele de preexcitație (de exemplu WPW);
D. afectarea în cadrul bolii de nod sinusal și a nodului atrio-ventricular (boala binodală);
E. emfiziemul pulmonic;
1368. Aritmia sinusală respiratorie:
A. apare la vârstnici;
B. apare la tineri;
C. apare la persoane cu afecțiuni cardiace organice;
D. apare după administrarea de simpatomimetice la pacienți cu astm sau BPOC;
E. apare la pacienți cu diabet zaharat;
Bolile vasculare - dr. J.F.B.
1369. Dintre factorii de risc modificabili pentru apariția aterosclerozei, NU face parte:
A. diabetul zaharat;
B. fumatul;
C. hipercolesterolemia;
D. vârsta;
E. hiperhomocisteinemia;
1370. Principala cauză a arteriopatiei obliterante este:
A. hipertensiunea arterială;
B. hipertiglicidemia;
C. diabetul zaharat;
D. fumatul;
E. ateroscleroza;
1371. Sindromul Leriche este determinat de:
A. ateroscleroza bifurcației aortei în cele două artere iliace;
B. o placă de aterom situată pe artera femurală;
C. ateroscleroza arterelor renale;
D. ateroscleroza carotidiană bilaterală;
E. ateroscleroza crossei aortice;
1372. Principali factori de risc pentru apariția trombangitei obliterante este:
A. hipertensiunea arterială;
B. hipercolesterolemia;
C. consumul de alcool;
D. expunerea la frig;
- B. apare imediat după încetarea efortului la pacienți cu arteriopatie obliterantă;
C. apare în cursul nopții, trezind bolnavul din somn, la pacienți cu angină Prinzmetal;
D. apare la efort, la pacienți cu stenoză aortică;
E. apare la efort, la pacienți cu arteriopatie obliterantă;
1380. Sindromul Leriche:
A. apare datorită afectării arteromatoase a aortei ascendente;
B. apare datorită afectării arteromatoase a crossei aortice;
C. apare datorită afectării arteromatoase a bifurcației aortice (în arterele iliace);
D. apare datorită arteromatozei arterelor cerebrale;
E. apare datorită arteromatozei arterelor carotide;
1381. C.d.u. manifestări NU apare în sindromul Leriche:
A. durere la efort în fese, coapse, moiet;
B. puls absent la arterele femurale;
C. impotență;
D. claudicație la nivelul mușchilor masei;
E. tegumente reci, pilozitate redusă sau absentă la nivelul membrelor inferioare;
1382. C.d.u. manifestări NU apare în arteriopatie obliterantă a membrelor inferioare:
A. atrofie musculară;
B. parastezii;
C. puls diminuat/absent proximal de obstrucție;
D. dureri musculare;
E. tegumente subțiale, aderente la planurile profunde;
1383. Durerea în repaus în arteriopatie obliterantă:
A. apare din stadiul 2 Fontaine;
B. se ameliorează când membrul afectat e lăsat în poziție declivă;
C. se ameliorează prin ridicarea membrului afectat la 10-15 grade;
D. semnifică obstrucție arterială ușoară;
E. se ameliorează în cursul nopții;
1384. Trombangita obliterantă:
A. apare cel mai frecvent la bărbați fumători;
B. apare cel mai frecvent la femei fumătoare;
C. apariția și evoluția bolii nu au legătură cu fumatul;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date; f.d.u. = fiind date următoarele; f.l. = felerilor/reletoare la; u.f.d. = următoarele fragmente dintr-o frază despre;

- D. apare în mod egal la ambele sexe;
E. apare la vârstnici;
1385. În trombangelia obliterantă NU sunt afectate:
A. venele superficiale;
B. venele profunde;
C. arteriole mici și medii ale membrului inferior (frecvent);
D. arterele cerebrale (rar);
E. arterele coronare (rar);
1386. Examenul obiectiv în trombangelia obliterantă NU va evidenția:
A. puls absent la artera radială;
B. puls absent la artera pedioasă;
C. puls absent la artera femurală;
D. ulcerări/ necroze la vârfurile degetelor;
E. paloare tegumentară (la nivelul mâinilor/ picioarelor);
1387. Diagnosticul de trombangia obliterantă:
A. este un diagnostic paraclinic, pus pe baza datelor furnizate de ecografia Doppler vasculară;
B. este un diagnostic paraclinic pus pe baza datelor furnizate de arterografie;
C. este pus pe baza datelor furnizate de anamneză și examenul obiectiv;
D. este mai ușor de pus la pacienții cu vârstă de peste 50 ani;
E. este pus întotdeauna prin coroborarea datelor clinice cu cele obținute prin angiografie;
1388. În trombangia obliterantă NU pot apărea:
A. puls diminuat/ absent distal de artera poplitee/ artera brahială;
B. trombozele profunde migratorii;
C. sindrom Raynaud;
D. parastezii la nivelul mâinilor/ picioarelor;
E. ulcerări la vârfurile degetelor/ interdigital, dureroase, care apar spontan sau după agresiuni termice/ chimice/ mecanice;
1389. Ischemia acută periferică este cel mai frecvent determinată de:
A. embolii cu origine în plăcile de aterom aortice;
B. disecțiile arteriale;
C. vasculite;
D. embolii cu origine cardiacă;
E. stările de hipercoagulabilitate sanguină;

Prescurtări frecvent folosite: c.d. = cu excepția, s.c.s.d. = sunt umblatoarele, cu excepția, u.a.s.c.s.d. = umblatoarele afirmative sunt corecte, cu excepția, s.c.c.d. = sunt corect formulate, cu excepție.

- C. reprezintă o tromboflebită superficială a venelor toraco-epigastice ce apare la bărbați consumatori de droguri;
D. reprezintă o tromboflebită superficială a venelor toraco-epigastice ce apare la femei, mai ales după o mastectomie unilaterală;
E. reprezintă o tromboflebită a venei cave inferioare, cu ascită refractară la tratament;
1403. Tromboflebita migratorie:
A. are o evoluție severă, cu extensie la axul venos profund;
B. are o evoluție autolimitată, vindecarea fiind completă sau cu o ușoară indurație a segmentelor venoase interesate;
C. are recidive rare;
D. apare în endocardita infecțioasă, prin embolii septic;
E. se asociază frecvent cu TEP recurent;
1404. Nu reprezintă factori de risc pentru apariția TVP:
A. neoplasmele;
B. consumul de anticoncepționale orale;
C. sarcina;
D. viziile;
E. intervențiile chirurgicale ortopedice;
1405. TVP a membrului inferior:
A. apare mai frecvent la bărbați la nivelul membrului inferior stâng;
B. reprezintă > 90% din totalul TVP;
C. cele distale au riscul cel mai mare de TEP;
D. debutează proximal și au extensie distală;
E. nu poate apărea în sindromul nefrotic;
1406. Una din u. afirmații NU caracterizează edemul din TVP:
A. este frecvent bilateral;
B. este unilateral;
C. apare distal (fața dorsală a piciorului, perimaleolar) și se extinde proximal;
D. reprezintă la ridicarea membrului afectat deasupra orizontalei;
E. este elastic;
1407. Phlegmasia alba dolens:
A. apare prin tromboza venelor supratrapezice;
B. apare în tromboza masivă a axului venos ilio-femural, când se asociază spasmi arteriali reflex;
C. apare prin tromboza venei inferioare;
D. apare în ocuzia embolică a arterei femurale;
E. apare în tromboza masivă a axului arterial ilio-femural;
1408. Despre boala Raynaud este adevărat că:
A. poate apărea în lupus;
B. apare mai frecvent la femei;
C. poate apărea în leucemie;
D. poate apărea în dermatomiozită;
E. poate apărea în poliartrita reumatoidă;

Semnologia digestivă – Dr.D.D., Dr.M.M.M.

Durerea abdominală

1409. R.I. clasificarea cauzelor de durere abdominală (DurAbd), f.d.u. categorii:
1. durere cu originea în abdomen;
2. durere de cauză metabolică/ endocrină;
3. durere de cauză neurologică;
și următoarele stări patologice:
a. diabet;
b. inflamația peritoneului parietal, c. cauză țigie;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
1410. R.I. clasificarea cauzelor de DurAbd, f.d.u. categorii:
1. durere cu originea în abdomen;
2. durere de cauză metabolică;
3. durere de cauză neurologică;
și următoarele stări patologice:
a. inflamația unui viscer;
b. radiculită de la un proces infecțios sau de la o artită interapofizară de vecinătate;
c. uremie;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;
1411. R.I. clasificarea cauzelor de DurAbd, f.d.u. categorii:
1. durere cu originea în abdomen;
2. durere de cauză metabolică;
3. durere de cauză neurologică;
și următoarele stări patologice:
a. tulburări psihice;
b. afectarea peretelui abdominal, c. febră mediteraneană familială;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele, c.d.u. = care dintre următoarele, f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, R.I. = referitor/referitoare la, U.I.d.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază despre.

- E. a-3, b-2, c-1;
1415. R.I. clasificarea cauzelor de DurAbd, f.d.u. categorii:
 1. durere iradiată de la o sursă extraabdominală;
 2. durere de cauză metabolică;
 3. durere de cauză toxică;
 și următoarele stări patologice:
 a. porfirie;
 b. saturnism;
 c. afecțiune cardiacă;
 care sunt asociate corecte:
 A. a-1, b-2, c-3;
 B. a-1, b-3, c-2;
 C. a-2, b-1, c-3;
 D. a-2, b-3, c-1;
 E. a-3, b-1, c-2;
1419. F.d.u. mecanisme ale DurAbd:
 1. inflamație;
 2. distensia;
 și următoarele structuri care pot fi afectate:
 a. unui viscer cavitărilor;
 b. obstrucție mecanică;
 c. peritoneului parietal;
 d. capsulei unui viscer plin prin inflamație, congestie, hemoragie;
 care sunt asociate corecte:
 A. a-1, b-2, c-2, d-2, e-1;
 B. a-2, b-1, c-1, d-2, e-2;
 C. a-2, b-1, c-2, d-2, e-1;
 D. a-2, b-2, c-1, d-2, e-1;
 E. a-2, b-2, c-2, d-1, e-1;
1423. F.d.u. cauze inflamatoare ale DurAbd:
 1. contaminarea bacteriană a peritoneului parietal;
 2. iritația chimică a peritoneului parietal;
 3. inflamația unui viscer;
 și următoarele stări patologice:
 a. apendice perforat sau alt viscer perforat;
 b. febra tifoidă;
 c. pancreatită;
 care sunt asociate corecte:
 A. a-1, b-2, c-3;
 B. a-1, b-3, c-2;
 C. a-2, b-3, c-1;
 D. a-2, b-1, c-2;
 E. a-3, b-2, c-1;
1424. F.d.u. cauze inflamatoare ale DurAbd:
 1. contaminarea bacteriană a peritoneului parietal;
 2. iritația chimică a peritoneului parietal;
 3. inflamația unui viscer;
 și următoarele stări patologice:
 a. durere la mijlocul ciclului;
 b. infilită;
 c. boala inflamatoare pelviană;
 care sunt asociate corecte:
 A. a-1, b-3, c-2;
 B. a-2, b-1, c-3;
 C. a-2, b-3, c-1;
 D. a-3, b-1, c-2;
 E. a-3, b-2, c-1;
1425. F.d.u. cauze inflamatoare ale DurAbd:
 1. iritația chimică a peritoneului parietal;
 2. inflamația unui viscer;
 și următoarele stări patologice:
 a. durere de ovulație;
 b. boala inflamatoare colonică;
 c. apendicită;
 d. ulcer perforat;
 care sunt asociate corecte:
 A. a-1, b-1, c-2, d-2;
 B. a-1, b-2, c-1, d-2;
 C. a-2, b-1, c-1, d-2;
 D. a-2, b-1, c-2, d-1;
 E. a-2, b-2, c-1, d-1;
1422. F.d.u. cauze ale DurAbd prin inflamația peritoneului parietal:
 1. contaminare bacteriană;
 2. iritație chimică;
 și următoarele stări patologice:
 a. insolație;
 b. afecțiune genitală;
 c. tabes dorsal;
- a. pancreatită;
 b. apendice (sau alt viscer) perforat;
 c. boala inflamatoare pelviană;
 d. ulcer perforat;
 e. durere la mijlocul ciclului de ovulație;
 care sunt asociate corecte:
 A. a-1, b-2, c-2, d-2, e-1;
 B. a-2, b-1, c-1, d-2, e-2;
 C. a-2, b-1, c-2, d-2, e-1;
 D. a-2, b-2, c-1, d-2, e-1;
 E. a-2, b-2, c-2, d-1, e-1;
1423. F.d.u. cauze inflamatoare ale DurAbd:
 1. contaminarea bacteriană a peritoneului parietal;
 2. iritația chimică a peritoneului parietal;
 3. inflamația unui viscer;
 și următoarele stări patologice:
 a. apendice perforat sau alt viscer perforat;
 b. febra tifoidă;
 c. pancreatită;
 care sunt asociate corecte:
 A. a-1, b-2, c-3;
 B. a-1, b-3, c-2;
 C. a-2, b-3, c-1;
 D. a-2, b-1, c-2;
 E. a-3, b-2, c-1;
1424. F.d.u. cauze inflamatoare ale DurAbd:
 1. contaminarea bacteriană a peritoneului parietal;
 2. iritația chimică a peritoneului parietal;
 3. inflamația unui viscer;
 și următoarele stări patologice:
 a. durere la mijlocul ciclului;
 b. infilită;
 c. boala inflamatoare pelviană;
 care sunt asociate corecte:
 A. a-1, b-3, c-2;
 B. a-2, b-1, c-3;
 C. a-2, b-3, c-1;
 D. a-3, b-1, c-2;
 E. a-3, b-2, c-1;
1425. F.d.u. cauze inflamatoare ale DurAbd:
 1. iritația chimică a peritoneului parietal;
 2. inflamația unui viscer;
 și următoarele stări patologice:
 a. durere de ovulație;
 b. boala inflamatoare colonică;
 c. apendicită;
 d. ulcer perforat;
 care sunt asociate corecte:
 A. a-1, b-1, c-2, d-2;
 B. a-1, b-2, c-1, d-2;
 C. a-2, b-1, c-1, d-2;
 D. a-2, b-1, c-2, d-1;
 E. a-2, b-2, c-1, d-1;
1422. F.d.u. cauze ale DurAbd prin inflamația peritoneului parietal:
 1. contaminare bacteriană;
 2. iritație chimică;
 și următoarele stări patologice:
 a. insolație;
 b. afecțiune genitală;
 c. tabes dorsal;
- care sunt asociate corecte:
 A. a-1, b-2, c-3;
 B. a-1, b-3, c-2;
 C. a-2, b-3, c-1;
 D. a-2, b-1, c-2;
 E. a-3, b-2, c-1;
1417. R.I. clasificarea cauzelor de DurAbd, f.d.u. categorii:
 1. durere iradiată de la o sursă extraabdominală;
 2. durere de cauză neurologică;
 3. mecanisme incerte;
 și următoarele stări patologice:
 a. sevraj de la narcotice;
 b. afecțiune esofagiană;
 c. herpes zoster;
 care sunt asociate corecte:
 A. a-1, b-2, c-3;
 B. a-2, b-1, c-3;
 C. a-2, b-3, c-1;
 D. a-3, b-1, c-2;
 E. a-3, b-2, c-1;
1417. R.I. clasificarea cauzelor de DurAbd, f.d.u. categorii:
 1. durere iradiată de la o sursă extraabdominală;
 2. durere de cauză neurologică;
 3. mecanisme incerte;
 și următoarele stări patologice:
 a. sevraj de la narcotice;
 b. afecțiune esofagiană;
 c. herpes zoster;
 care sunt asociate corecte:
 A. a-1, b-2, c-3;
 B. a-2, b-1, c-3;
 C. a-2, b-3, c-1;
 D. a-3, b-1, c-2;
 E. a-3, b-2, c-1;
1418. R.I. clasificarea cauzelor de DurAbd, f.d.u. categorii:
 1. durere iradiată de la o sursă extraabdominală;
 2. durere de cauză neurologică;
 3. mecanisme incerte;
 și următoarele stări patologice:
 a. insolație;
 b. afecțiune genitală;
 c. tabes dorsal;

Prescurtări frecvent folosite: G.B. = cu excepție; S.C.G.E. = sunt următoarele, cu excepție; u.a.s.c.g.e. = următoarele afecțiuni sunt corecte, cu excepție; S.C.G.E. = sunt corect formulate, cu excepție.

- D. a-2, b-1, c-2, d-1;
 E. a-2, b-2, c-1, d-1;
1426. R.I. DurAbd prin distensie, f.d.u. categorii:
 1. obstrucție mecanică a unui viscer cavitărilor;
 2. distensia capsulei unui viscer parenchimatous prin inflamație;
 3. distensia capsulei unui viscer parenchimatous prin congestie;
 și următoarele stări patologice:
 a. hepatită acută;
 b. obstrucția/ocluzia intestinalului subțire sau gros;
 c. tromboză acută de venă renală (în cadrul sindromului nefrotic);
 care sunt asociate corecte:
 A. a-1, b-2, c-3;
 B. a-1, b-3, c-2;
 C. a-2, b-1, c-3;
 D. a-2, b-3, c-1;
 E. a-3, b-2, c-1;
1427. R.I. DurAbd prin distensie, f.d.u. categorii:
 1. obstrucție mecanică a unui viscer cavitărilor;
 2. distensia capsulei unui viscer parenchimatous prin inflamație;
 3. distensia capsulei unui viscer parenchimatous prin hemoragie;
 și următoarele stări patologice:
 a. hemoragie intrahepatică;
 b. obstrucția arborelui biliar;
 c. glomerulonefrită acută;
 care sunt asociate corecte:
 A. a-1, b-3, c-2;
 B. a-2, b-1, c-3;
 C. a-2, b-3, c-1;
 D. a-3, b-1, c-2;
 E. a-3, b-2, c-1;
1428. R.I. DurAbd prin distensie, f.d.u. categorii:
 1. obstrucție mecanică a unui viscer cavitărilor;
 2. distensia capsulei unui viscer parenchimatous prin congestie;
 3. distensia capsulei unui viscer parenchimatous prin hemoragie;
 și următoarele stări patologice:
 a. obstrucția ureterului;
 b. stază hepatică acută;
 c. hemoragie intrarenală;
 care sunt asociate corecte:
 A. a-1, b-2, c-3;
 B. a-1, b-3, c-2;
 C. a-2, b-3, c-1;
 D. a-3, b-1, c-2;
 E. a-3, b-2, c-1;
1429. R.I. cauzele DurAbd iradiate de la o sursă extraabdominală, f.d.u. categorii:
 1. cardiacă;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele, c.d.u. = care dăte următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, r.l. = referitor/relativ la; U.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază despre;

- D. a-3, b-2, c-1;
1433. R.I. durerea determinată de inflamația peritoneului parietal, u.a.s.c.g.e.:
 A. este constantă;
 B. este transmisă prin nervii somatici care inervează peritoneul parietal;
 C. se ameliorează la schimbarea poziției;
 D. este ameliorată de palpate;
 E. se instalează progresiv atunci când este provocată de un agent iritant chimic;
 F. are o intensitate care depinde de viteza cu care materialul iritant este aplicat peritoneului;
1434. R.I. durerea determinată de inflamația peritoneului parietal, u.a.s.c.g.e.:
 A. este ascuțită și se accentuează periodic;
 B. este localizată la distanță de regiunea inflamată;
 C. este ameliorată de mișcare;
 D. se instalează lent atunci când este provocată de un agent activ enzimatic;
 E. este de la început de mare intensitate atunci când este provocată de urină;
1435. R.I. durerea determinată de inflamația peritoneului parietal, u.a.s.c.g.e.:
 A. are o intensitate care depinde de tipul și de cantitatea de material la care este expus peritoneul într-un anumit interval de timp;
 B. se ameliorează la presiune/apăsare;
 C. este ameliorată de tuse;
 D. este mai puțin intensă când este provocată de secreția pancreatică decât de bilă;
 E. este de la început de mare intensitate atunci când este provocată de sânge;
1436. R.I. durerea determinată de inflamația peritoneului parietal, u.a.s.c.g.e.:
 A. este percepută la distanță de zona boală;
 B. este accentuată de modificarea tensiunii peritoneului;
 C. este ameliorată de strânut;
 D. este mai puțin intensă (cel puțin inițial) când este produsă prin perforarea stomacului decât prin perforarea colonului;

- E. este chinătoare atunci când
urmare:
1437. U.f.d.d. tabloul clinic al
inflamației peritoneale s.c.f.g.e.;
A. Ulcerei peptic perforat;
B. poate avea tablouri clinice
complet diferite, în funcție;
C. de rapiditatea cu care;
D. sicutul gastric acid pătrunde;
E. în duoden.
1438. U.f.d.d. tabloul clinic al
inflamației peritoneale s.c.f.g.e.;
A. Eliberarea bruscă în cavitatea
peritoneală;
B. a unei cantități mici de secreție
gastrică înfășurată bacterian;
C. provoacă mai puțină durere;
D. decât aceeași cantitate de
materie fecală;
E. neutre, chiar dacă steric.
1439. R.I. mecanismele durerii
peritoneale, fiind dați următorii
agenți declanșatori:
1. secreție gastrică;
2. materii focale;
3. bila;
și următoarele caracteristici:
a. inițial, provoacă puțină durere;
b. la eliberarea bruscă în
cavitatea peritoneală, provoacă
de la început durere intensă;
c. conținutul este steric și fără
enzime putreficte;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-1, c-2;
1440. R.I. mecanismele durerii
peritoneale, fiind dați următorii
agenți declanșatori:
1. materii fecale;
2. secreția pancreatică;
3. sângele;
și următoarele caracteristici:
a. conținutul este adesea atât de
bland încât rămâne nedetectat
în cazul în care contactul cu
peritoneul nu a fost brusc și
masiv;
b. are/au activitate enzimatică
marcată;
c. conținutul este neutru, chiar
dacă puternic contaminat;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;

Presențării frecvent folosite: S.G.E. = cu excepția; S.U.A.G.E. = sunt următoarele, cu excepția; U.A.S.C.G.E. = următoarele afirmări sunt
corecte, cu excepția; S.C.F.G.E. = sunt corect formulate, cu excepția.

1441. R.I. mecanismele durerii
peritoneale, fiind dați următorii
agenți declanșatori:
1. secreția gastrică;
2. secreția pancreatică;
3. urina;
și următoarele caracteristici:
a. este adesea atât de blandă
încât rămâne nedetectată în
cazul în care contactul cu
peritoneul nu a fost brusc și
masiv;
b. este sterică, dar acută;
c. declanșează de la început
durere și inflamație intensă,
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;
1442. R.I. mecanismele durerii
peritoneale, f.d.u. variante de
evoluție:
1. declanșează de la început
inflamație și durere intense prin
ințelaj chimică;
2. este adesea atât de blandă
încât rămâne nedetectată în
cazul în care contactul cu
peritoneul nu a fost brusc și
masiv;
3. inițial provoacă puțină durere,
dar ulterior durerile crește ca
urmare a inflamației declanșate
de multiplicarea bacteriană;
și următorii agenți declanșatori:
a. urina;
b. secreția gastrică;
c. materii fecale;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-1, c-2;
1443. R.I. mecanismele durerii
peritoneale, f.d.u. variante de
evoluție:
1. declanșează de la început
inflamație și durere intense prin
mecanism biologic/biochimic;
2. este adesea atât de blandă
încât rămâne nedetectată în
cazul în care contactul cu
peritoneul nu a fost brusc și
masiv (caz în care se poate
produce și deteriorare
hemodinamică);
3. este puțin iritantă;
și următorii agenți declanșatori:
a. bila;
b. secreția pancreatică;
c. sângele;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;
1444. F.d.u. evenimente fiziopatolo-
gice r.I. etiologia peritoniei:
a. contaminare bacteriană a
peritoneului;
b. boala inflamatorie pelviană;
c. intensitatea durerii crește;
d. inițial durerea este de
intensitate redusă;
e. multiplicarea bacterilor;
f. elaborarea unor substanțe
ințelaj;
care este înălțarea temporară/
cauza corectă:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. f-1, b-2, c-3;
1445. R.I. diferența dintre durerea
din peritonită și cea din colică,
f.d.u. categorii de pacienți:
1. durerea determinată de
inflamația peritoneului;
2. durerea determinată de colica
unui organ abdominal;
și următoarele caracteristici:
a. pacienții stă liniștiți în pat,
preferă să evite mișcarea;
b. în mod caracteristic, durerea
este însoțită de contracura
musculaturii abdominale;
c. durerea este acută, de mare
intensitate, cu accentuări
periodice;
d. durerea este constantă, surdă,
de intensitate moderată;
e. pacientul se zvâcolește
nehotărât, negăsindu-și locul de
durere;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-1, e-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2, e-1;
C. a-1, b-2, c-2, d-1, e-1;
D. a-2, b-1, c-1, d-1, e-2;
E. a-2, b-1, c-1, d-2, e-1;
1446. R.I. contracura musculară
abdominală care însoțește infla-
mația peritoneală, u.a.s.c.g.e.;
A. reprezintă spasmi tonici reflex
ai musculaturii abdominale;
B. intensitatea ei nu depinde de
localizarea procesului inflamator;
C. intensitatea ei depinde de
integritatea sistemului muștar;
D. în mod caracteristic, este foarte
intensă în cazul unui ulcer
perforat în bursa omentală;
E. poate fi minimă sau absentă
atunci când intervine efectul
protector al viscerelor de
deasupra;
1447. R.I. contracura musculară
abdominală care însoțește infla-
mația peritoneală, u.a.s.c.g.e.;
A. este un semn caracteristic de
ințelaj peritoneală;
B. este localizată în partea opusă
a leziunii afectate;
C. intensitatea ei depinde de
viteza cu care se dezvoltă
procesul inflamator peritoneal;
D. în mod caracteristic, este foarte
intensă în cazul unui apendic
retrocecal perforat;
E. este adesea mult accentuată în
cazul unui proces care se
dezvoltă lent;
F. este excesivă la pacienții
obnubilați;
1448. Categori de pacienți la care
contracura musculară abdo-
minală care însoțește de obicei
inflamația peritoneală poate fi
minimă sau nedetectabilă s.u.s.g.e.;
A. grav bolnavi;
B. targați;
C. tineri;
D. obnubilați;
E. psihici;
1449. U.f.d.d. semnele infla-
mației peritoneale s.c.f.g.e.;
A. O urgență abdominală;
B. catatolă, cum ar fi o colică
biliară, poate fi însoțită de:
C. durere și/sau de spasm
muscular minime sau;
D. nedetectabile la pacienții
obnubilați, grav bolnavi;
E. targați, vărsături sau la pacienții
nevroici;
1450. R.I. durerea determinată de
obstrucția unui viscer ciliar
abdominal, u.a.s.c.g.e.;
A. este descrisă clinic ca fiind
intermitentă sau colicativă;
B. poate să nu aibă caracter de
colică crampă, ceea ce poate
induce în eroare;
C. este determinată de distensia
segmentului din aval de zona de
obstrucție;
D. poate fi constantă, cu doar rare
exacerbări;
E. este mai bine localizată decât
durerea produsă de inflamația
peritoneului parietal;
1451. R.I. durerea determinată de
ocluzia intestinului subțire,
u.a.s.c.g.e.;
A. este de obicei subombilicală;
B. este precis localizată;
C. de obicei, are caracter inflama-
tor;
D. în timp, natura ei colicativă se
accentuează;
E. se poate extinde în regiunea
lombară inferioară dacă strangu-
larea se adaugă la ocluzie (sau o
provocă);
1452. R.I. natura durerii în ocluzia
intestinului subțire, f.d.u. stări
patologice:
1. ocluzia intestinului subțire;
2. strangularea suprapusă
ocluziei de intestin subțire;
și următoarele caracteristici:
a. durerea se poate extinde la
regiunea lombară inferioară;
b. durerea este provocată de
distensia acută a unui organ
ciliar;
c. durerea este colicativă și
localizată mai ales per- sau
supraombilical;
d. la producerea durerii participă
tracțiunea exercitată asupra
rădăcinii mezenterului;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-1, d-2;
B. a-1, b-2, c-2, d-1;
C. a-2, b-1, c-1, d-2;
D. a-2, b-1, c-2, d-1;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;
1453. F.d.u. evenimente care
explică natura durerii în ocluzia
intestinală:
a. estomparea naturii colicative a
durerii;
b. dilatarea progresivă a
intestinului;
c. durere colicativă;
d. reducerea tonusului muscular
intestinal;
e. distinderea acută a
abdominal, u.a.s.c.g.e.;
f. ocluzie intestinală;
care este înălțarea temporară/
cauza corectă:
A. a-1, b-2, c-1, d-1;
B. a-1, b-2, c-2, d-1;
C. a-2, b-1, c-1, d-2;
D. a-2, b-1, c-2, d-1;
E. a-3, b-2, c-1;
1454. R.I. caracteristicile diferen-
țiale ale durerii produse de
diverse stări patologice din sfera
bilio-pancreatică, f.d.u.
bilio-pancreatică, f.d.u.
1. distensia ductului pancreatic;
2. distensia ductului biliar comun;
3. distensia bruscă a arborelui
biliar;
și următoarele trăsături ale durerii:
a. adesea localizată în epigastru
și/rădind spre porțiunea
superioară a regiunii lombare;
b. foarte frecvent, accentuată în
decubiți dorsal;
c. mai degrabă constantă decât
colicativă;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;

Presențării frecvent folosite: U. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date; f.d.u. = fiind date următoarele; r.I. =
referință/referențe la; U.f.d.d. = următoarele fragmente dintr-o frază deose.

1451. R.I. durerea determinată de
ocluzia intestinului subțire,
u.a.s.c.g.e.;
A. este de obicei subombilicală;
B. este precis localizată;
C. de obicei, are caracter inflama-
tor;
D. în timp, natura ei colicativă se
accentuează;
E. se poate extinde în regiunea
lombară inferioară dacă strangu-
larea se adaugă la ocluzie (sau o
provocă);
1452. R.I. natura durerii în ocluzia
intestinului subțire, f.d.u. stări
patologice:
1. ocluzia intestinului subțire;
2. strangularea suprapusă
ocluziei de intestin subțire;
și următoarele caracteristici:
a. durerea se poate extinde la
regiunea lombară inferioară;
b. durerea este provocată de
distensia acută a unui organ
ciliar;
c. durerea este colicativă și
localizată mai ales per- sau
supraombilical;
d. la producerea durerii participă
tracțiunea exercitată asupra
rădăcinii mezenterului;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-1, d-2;
B. a-1, b-2, c-2, d-1;
C. a-2, b-1, c-1, d-2;
D. a-2, b-1, c-2, d-1;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;
1453. F.d.u. evenimente care
explică natura durerii în ocluzia
intestinală:
a. estomparea naturii colicative a
durerii;
b. dilatarea progresivă a
intestinului;
c. durere colicativă;
d. reducerea tonusului muscular
intestinal;
e. distinderea acută a
abdominal, u.a.s.c.g.e.;
f. ocluzie intestinală;
care este înălțarea temporară/
cauza corectă:
A. a-1, b-2, c-1, d-1;
B. a-1, b-2, c-2, d-1;
C. a-2, b-1, c-1, d-2;
D. a-2, b-1, c-2, d-1;
E. a-3, b-2, c-1;
1454. R.I. caracteristicile diferen-
țiale ale durerii produse de
diverse stări patologice din sfera
bilio-pancreatică, f.d.u.
bilio-pancreatică, f.d.u.
1. distensia ductului pancreatic;
2. distensia ductului biliar comun;
3. distensia bruscă a arborelui
biliar;
și următoarele trăsături ale durerii:
a. adesea localizată în epigastru
și/rădind spre porțiunea
superioară a regiunii lombare;
b. foarte frecvent, accentuată în
decubiți dorsal;
c. mai degrabă constantă decât
colicativă;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;

3. carcinomul de cap de pancreas;
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1.
1457. R.I. caracteristicile diferențiale ale durerii produse de diverse stări patologice din sfera bilio-pancreatică, f.d.:
1. distensia acută a colecistului;
 2. distensia ductului biliar comun;
 3. distensia ductelor pancreatice;
- și următoarele trăsături ale durerii:
- a. de obicei, este resimțită în cadranul superior drept cu iradiere spre regiunea posterioară dreaptă a toracelui sau spre vârful scapulei drepte;
 - b. durere similară cu cea provocată de distensia ductului biliar comun;
 - c. este dificil (dacă nu imposibil) să o diferențiem, pe criterii clinice, de durerea produsă de distensia acută a colecistului;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-3, c-2;
 - B. a-2, b-1, c-3;
 - C. a-2, b-3, c-1;
 - D. a-3, b-1, c-2;
 - E. a-3, b-2, c-1.
1458. R.I. caracteristicile diferențiale ale durerii produse de diverse stări patologice din sfera bilio-pancreatică, f.d.:
1. distensia acută a colecistului;
 2. obstrucția tractului biliar (atât a canalului cistic, cât și a căii biliare comune);
 3. distensia treptată a arborelui biliar;
- și următoarele trăsături ale durerii:
- a. deși considerată tipică, iradierea subscapulară este adesea absentă;
 - b. absența sau redusă la un ușor disconfort în epigastru sau în cadranul superior drept;
 - c. caracter foarte variabil;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
 - B. a-1, b-3, c-2;
 - C. a-2, b-1, c-3;
 - D. a-2, b-3, c-1;
 - E. a-3, b-1, c-2.
1459. R.I. caracteristicile diferențiale ale durerii produse de diverse stări patologice din sfera bilio-pancreatică, f.d.:
1. distensia ductului biliar comun;
 2. distensia ductelor pancreatice;
- D. patologie neurologică sau psihică;
- E. durerea vezicală este simplă, mul care atrage atenția.
1463. F.d.u. evenimentele legate de obstrucția evacurii vezicii urinare la pacientul vârstnic:
- a. la pacientul vârstnic, poate duce la alterarea stării de conștiență;
 - b. febră înaltă;
 - c. infecție urinară, adesea înaltă, cu stare septică;
 - d. unica manifestare poate fi agitația;
 - e. percepția durerii este perturbată;
- care este lanțul causal corect:
- A. a→d→e→c→b;
 - B. b→a→c→e→d;
 - C. c→b→a→e→d;
 - D. d→c→a→b→e;
 - E. e→a→d→c→b;
1464. R.I. ocizia arterei mezen-terice superioare și la durerea determinată de aceasta:
- A. poate fi produsă de embolie sau de tromboză;
 - B. inițial durerea poate fi, în egală măsură, severă sau ușoară;
 - C. dacă durerea este severă, pacientul se va prezenta rapid la medic;
 - D. caracterul colicativ al durerii exclude o cauză vasculară;
 - E. după câteva zile se instalează semnele de inflamație peritoneală sau se produce colapsul vascular;
1465. R.I. ocizia arterei mezen-terice superioare și la durerea determinată de aceasta:
- A. produce inițial DurAbd difuză;
 - B. adesea durerea este ușoară, mai ales inițial, motiv pentru care pacientul nu se prezintă imediat la medic;
 - C. durerea poate fi aparent nesemnificativă, mai degrabă disconfort decât durere;
 - D. inițial, durerea este provocată de inflamația peritoneului;
 - E. adesea produce stare septică și febră, inducând o stare de hiperalertă la pacientul vârstnic;
1466. U.f.d.f.d. cauzele vasculare ale DurAbd s.c.f.c.e.:
- A. La un pacient, mai adesea;
 - B. vârstnic cu factori de risc pentru boală vasculară;
 - C. prin obnubilare fabrică ori;
3. carcinomul de cap de pancreas;
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1.
1457. R.I. caracteristicile diferențiale ale durerii produse de diverse stări patologice din sfera bilio-pancreatică, f.d.:
1. distensia acută a colecistului;
 2. distensia ductului biliar comun;
 3. distensia ductelor pancreatice;
- și următoarele trăsături ale durerii:
- a. de obicei, este resimțită în cadranul superior drept cu iradiere spre regiunea posterioară dreaptă a toracelui sau spre vârful scapulei drepte;
 - b. durere similară cu cea provocată de distensia ductului biliar comun;
 - c. este dificil (dacă nu imposibil) să o diferențiem, pe criterii clinice, de durerea produsă de distensia acută a colecistului;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-3, c-2;
 - B. a-2, b-1, c-3;
 - C. a-2, b-3, c-1;
 - D. a-3, b-1, c-2;
 - E. a-3, b-2, c-1.
1458. R.I. caracteristicile diferențiale ale durerii produse de diverse stări patologice din sfera bilio-pancreatică, f.d.:
1. distensia acută a colecistului;
 2. obstrucția tractului biliar (atât a canalului cistic, cât și a căii biliare comune);
 3. distensia treptată a arborelui biliar;
- și următoarele trăsături ale durerii:
- a. deși considerată tipică, iradierea subscapulară este adesea absentă;
 - b. absența sau redusă la un ușor disconfort în epigastru sau în cadranul superior drept;
 - c. caracter foarte variabil;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
 - B. a-1, b-3, c-2;
 - C. a-2, b-1, c-3;
 - D. a-2, b-3, c-1;
 - E. a-3, b-1, c-2.
1459. R.I. caracteristicile diferențiale ale durerii produse de diverse stări patologice din sfera bilio-pancreatică, f.d.:
1. distensia ductului biliar comun;
 2. distensia ductelor pancreatice;

Prescrutări frecvent folosite: f.d. = cu excepția, s.u.c.e. = sunt următoarele, cu excepția, u.a.s.c.e. = următoarele afirmări sunt corecte, cu excepția, s.c.f.c.e. = sunt corect formulate, cu excepția;

- C. apariția unei dureri abdominale difuze, continue;
- D. însoțite de sensibilitate sau de contractură la palparea abdomenului este foarte;
- E. caracteristică pentru ocizia arterei mezen-terice superioare.
1467. R.I. ruptura unui anevrism aortic abdominal și la durerea determinată de aceasta u.a.s.c.e.:
- A. iminența de rupătură produce DurAbd în fosa iliacă stângă;
 - B. durerea iradiază în regiunea sacrată, flanc sau organele genitale, distribuite a durerii care trebuie să sugereze acest diagnostic;
 - C. durerea poate fi severă (aducând pacientul la medic);
 - D. durerea poate fi ușoară sau moderată;
 - E. durerea poate persista timp de mai multe zile până să se producă ruptura și colapsul circulator.
1468. R.I. DurAbd parietală, u.a.s.c.e.:
- A. de obicei, este constantă și are caracter de disconfort;
 - B. mișcarea, ortostatismul prelungit și apăsarea accentuează disconfortul și spasmul muscular;
 - C. poate fi provocată de un hematom al leziilor musculare drept abdominal, cel mai adesea la ora actuală din cauza deficitului de proteină C sau S;
 - D. dacă se asociază cu apariția unei formațiuni în cadranul inferior, trebuie avut în vedere un hematom muscular;
 - E. enzimile musculare crescute pot sugera o miozită drept cauză a DurAbd;
1469. U.f.d.f.d. DurAbd parietală s.c.f.c.e.:
- A. Când este provocată de o:
 - B. miozită, poate fi diferențiată de durerea cu aceeași localizare;
 - C. provocată de o patologie;
 - D. intraabdominală prin afectarea simultană;
 - E. a organelor digestive.
1470. Afecțiunile intratoracice care mimează cel mai adesea o urgență abdominală s.u.c.e.:
- A. infarct miocardic;
 - B. infarct pulmonar;
 - C. traheobronșită;
 - D. pericardită;
 - E. boală esofagiană;

Prescrutări frecvent folosite: u. = următoarele, c.d.u. = care dintre următoarele, f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, f.d. = referențiale la, U.f.d.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază despre;

1471. U.f.d.f.d. DurAbd iradiată s.c.f.c.e.:
- A. Dacă anamneza și examenul fizic efectuate inițial nu au:
 - B. permis stabilirea originii unei dureri abdominale superioare (abdomen, torace etc.);
 - C. poate fi necesară înțelegerea pacientului sub observație timp de mai multe săptămâni;
 - D. interogându-l și examinându-l repetat și efectuând, eventual;
 - E. investigații suplimentare (indicate de noile date furnizate de examenul clinic).
1472. R.I. DurAbd iradiată, u.a.s.c.e.:
- A. o durere având originea în torace poate iradia în abdomen;
 - B. ulcerul perforat poate produce complicații intratoracice;
 - C. patologia abdominală adesea coexistă cu patologie toracică, iar cele două pot fi dificil sau imposibil de diferențiat;
 - D. spasmul mușchilor abdominali determinat de durerea de cauză abdominală diminuează la inspirație;
 - E. durerea iradiată în abdomen de la coloana vertebrală este produsă de obicei prin inflamația rădăcinilor nervoase;
1473. R.I. DurAbd iradiată, u.a.s.c.e.:
- A. o durere având originea în coloană vertebrală poate iradia în abdomen;
 - B. la orice pacient cu DurAbd trebuie avută în vedere posibilitatea unei patologii intratoracice, în special dacă durerea este în abdomenul inferior;
 - C. pacientul cu patologie biliară cunoscută adesea are durere epigastrică în timpul unui infarct miocardic;
 - D. palparea zonei din abdomen în care este resimțită iradierea unei dureri toracice accentuează durerea;
 - E. durerea iradiată în abdomen de la coloană vertebrală este intensificată la scormit;
1474. R.I. DurAbd iradiată, u.a.s.c.e.:
- A. o durere având originea în organele genitale poate iradia în abdomen;
 - B. pleurita diafragmatică dreaptă determină durere în hipocondrul drept iradiată subclavicular;
1475. R.I. DurAbd iradiată, u.a.s.c.e.:
- A. iradierea în abdomen a durerii toracice poate pune probleme dificile de diagnostic;
 - B. pneumonia supradiafragmatică dreaptă determină durere în hipocondrul drept iradiată supraclavicular;
 - C. durerea de origine toracică iradiată în abdomen este adesea însoțită de scăderea excursiilor respiratorii;
 - D. durerea iradiată în abdomen de la coloana vertebrală este produsă de obicei prin inflamația rădăcinilor nervoase;
 - E. durerea iradiată în abdomen de la testicule sau de la veziculele seminale este de obicei accentuată de apăsarea, fie și ușoară, pe aceste organe;
1476. R.I. DurAbd iradiată, u.a.s.c.e.:
- A. bolile abdominale superioare pot produce complicații intratoracice;
 - B. infarctul pulmonar supradiafragmatic drept determină durere în hipocondrul drept iradiată supraclavicular;
 - C. afecțiunile intraabdominale generatoare de durere limitează mișcările respiratorii mai puțin decât o patologie toracică;
 - D. durerea iradiată în abdomen de la coloană vertebrală este ameliorată, în mod caracteristic, de mișcări care cresc presiunea intraabdominală;
 - E. durerea iradiată în abdomen de la testicule sau de la veziculele seminale este surdă și imprecis localizată;
1477. R.I. DurAbd iradiată, u.a.s.c.e.:
- A. colecistita acută poate produce complicații intratoracice;
 - B. durerea din colica biliară poate fi resimțită în umărul stâng la un

- pacient care a avut anterior angină pectorală;
- C. distensia acută a abdomenului biliar extrahepatic provoacă durere în hipocostul drept, cu iradiere supraumbilicală;
- D. apariția spasm al mușchilor abdominali determină de durerea toracică iradiată se accentuează la inspirație;
- E. durerea iradiată în abdomen de la coloană vertebrală este interesfalică tuse;
1478. Boilele intratoracice care mimează cel mai adesea o urgență abdominală s.u.c.g.e.:
- A. infarct miocardic;
- B. infarct pulmonar;
- C. astm bronșic;
- D. pericardită;
- E. boala esofagiană.
1479. F.d.u. fragmente dintr-o frază r.l. punerea diagnosticului la un pacient cu DurAbd:
- a. în timpul căreia;
- b. înțerea sub-observare delibată și planificată pe o perioadă de câteva ore;
- c. decizia finală cu privire la originea DurAbd poate necesita;
- d. furnizarea indică care facilitează;
- e. interogarea și examinarea repetată a pacientului;
- f. punerea diagnosticului sau selecția investigațiilor adecvate;
- care este cea mai corectă reconstrucție:
- A. b-a-d-e-a-c-f;
- B. b-d-e-a-a-c-f;
- C. c-b-a-a-e-d-f;
- D. e-d-f-a-a-c-b;
- E. f-d-b-a-a-c-e;
1480. R.l. durerile abdominale asociate cu anomalii metabolice, u.a.s.c.g.e.:
- A. DurAbd de origine metabolică poate simula aproape orice alt tip de boală intrabdominală;
- B. la producerea DurAbd de cauză metabolică pot contribui mai multe mecanisme;
- C. or de câte ori cauza DurAbd este necunoscută, trebuie avută în vedere și o cauză metabolică;
- D. dacă la un pacient cu DurAbd de origine necunoscută, se descoperă o anomalie metabolică, aceasta este cauza cea mai probabilă;
- E. adesea, diferențierea DurAbd de cauză metabolică de durerea
- de cauză intrabdominală este dificilă.
1481. R.l. crizele metabolice abdominale, f.d.u. stări patologice:
1. deficitul de C1-esterază;
2. hiperfitemie;
3. uremie;
- și următoarele caracteristici:
- a. DurAbd este nespecifică, iar durerea și sensibilitatea la palpare își modifică adesea localizarea și intensitatea;
- b. se asociază cu sem angionevrotic și, adesea, cu episoade de DurAbd sever;
- c. anomalia metabolică poate determina un proces patologic intrabdominal (pancreatită acută), care poate duce la laparotomie inutilă dacă boala metabolică nu este recunoscută;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
- B. a-1, b-3, c-2;
- C. a-2, b-1, c-3;
- D. a-2, b-3, c-1;
- E. a-3, b-1, c-2;
1482. R.l. crizele metabolice abdominale, f.d.u. stări patologice:
1. febra mediteraneană familială;
2. porfirie;
3. durerea din diabet;
- și următoarele caracteristici:
- a. durerea este de obicei dificil de deosebit de cea din ocultura intestinală, deoarece hiperperistaltismul sever este o tășăsură importantă a amănuntului;
- b. durerea este nespecifică, iar durerea și sensibilitatea la palpare adesea își modifică localizarea și intensitatea;
- c. DurAbd este o manifestare caracteristică, asociată cu poliserozită;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
- B. a-1, b-3, c-2;
- C. a-2, b-3, c-1;
- D. a-3, b-1, c-2;
- E. a-3, b-2, c-1;
1483. R.l. crizele metabolice abdominale, f.d.u. stări patologice:
1. febra mediteraneană familială;
2. colica saturniană;
3. mușcăturile păianjenului văduva neagră (Latrodectus mactans);
- și următoarele caracteristici:
- a. DurAbd și sindrom inflamator bihumoral, datorată unui defect genetic care duce la hiperproducția de IL-1;
- b. durerea este de obicei dificil de deosebit de cea din ocultura intestinală, deoarece hiperperistaltismul sever este o tășăsură importantă a amănuntului;
- c. produc durere intensă și rigiditate a mușchilor abdominali, ai pieptului și ai spatelui, o regimare rarori afectată de boala intrabdominală;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
- B. a-1, b-3, c-2;
- C. a-2, b-3, c-1;
- D. a-3, b-1, c-2;
- E. a-3, b-2, c-1;
1484. R.l. DurAbd în context metabolic, f.d.u. etape ale unui lanț de situații și opțiuni diagnostice:
- a. corectarea anomaliilor metabolice;
- b. pacient cu acidoză diabetică și DurAbd;
- c. de exemplu, o apendicită acută sau o ocultura intestinală;
- d. DurAbd nu se rezolvă prompt;
- e. trebuie suspectată o patologie organică subiacentă;
- care este înălțarea temporală/logică justă:
- A. a-e-a-d-b;
- B. b-a-d-e-a-c;
- C. b-e-a-d-a-c;
- D. d-a-c-e-a-b;
- E. e-a-b-a-d-c;
1485. R.l. DurAbd cauzată de (nevrologică), u.a.s.c.g.e.:
- A. poate fi produsă de leziuni ale nervilor senzoriali;
- B. poate fi declanșată de stimulii normali;
- C. adesea este prezentă în repaus;
- D. se asociază cu inițiale peritoneale;
- E. de regulă este însoțită de distensia abdominalului;
1486. R.l. DurAbd cauzată de (nevrologică), u.a.s.c.g.e.:
- A. are caracter iritativ;
- B. poate fi declanșată de atingerea;
- C. evidențierea unor puncte dureroase cutanate neregulat spațiate poate fi singurul indicu pentru leziunea nervoasă subiacentă;
- D. nu este însoțită de contracura mușchilor abdominali;
- E. este legată de ingestia de alimente;
1487. R.l. DurAbd cauzată de (nevrologică), u.a.s.c.g.e.:
- A. de obicei este resimțită difuz în tot abdomenul;
- B. poate fi declanșată de modificarea ușoară a temperaturii;
- C. poate fi provocată de palpare, fie și blândă;
- D. limitează respirația;
- E. are drept cauză o leziune veche a nervilor motori;
1488. Durerea având originea în nervii spinali sau în rădăcinile acestora poate fi provocată de u. stări patologice, c.g.e.:
- A. herpes zoster;
- B. compresie prin osteofite (secundare unei artite);
- C. hemieria nucleului pulpos;
- D. tumor;
- E. diabet;
- F. sifilis;
1489. R.l. DurAbd având originea în nervii spinali sau în rădăcinile acestora, u.a.s.c.g.e.:
- A. se instalează brusc;
- B. nu este influențată de aportul de alimente;
- C. nu împiedică respirația;
- D. asocieră cu spasm muscular sever este caracteristică pentru crizele gastrice de tabes dorsali;
- E. nu este influențată de mișcarea coloanei vertebrale;
1490. R.l. DurAbd având originea în nervii spinali sau în rădăcinile acestora, u.a.s.c.g.e.:
- A. încealează brusc;
- B. nu este însoțită de distensie abdominală;
- C. este agravată de respirație;
- D. spasmul muscular asociat nu este accentuat de palparea abdomenului;
- E. este de obicei limitată la câteva dermatoame;
1491. R.l. DurAbd având originea în nervii spinali sau în rădăcinile acestora, u.a.s.c.g.e.:
- A. este lăncănță ascuțită;
- B. nu modifică respirația;
- C. poate fi însoțită de spasm muscular sever;
- D. spasmul muscular asociat este accentuat de palparea abdomenului;
- E. foarte frecvent este însoțită de hiperestezie cutanată;
1492. R.l. DurAbd de natură funcțională, u.a.s.c.g.e.:
- A. nu se conformează niciunui dintre tiparele uzuale de DurAbd;
- B. mecanismul este dificil de defini;
- C. cauzele Sii sau ale boilor funcționale invadate nu sunt cunoscute;
- D. diagnosticul de Sii este un diagnostic de excludere;
- E. nu este influențată de factorii psihici;
1493. R.l. sindromul de intestin iritabil (Sii), u.a.s.c.g.e.:
- A. Sii este o tulburare funcțională gastrointestinală;
- B. Sii este caracterizat de DurAbd și de tulburări de tranzit;
- C. diagnosticul de Sii se pune pe baza criteriilor clinice;
- D. diagnosticul de Sii presupune evidențierea unor anomalii organice specifice;
- E. cauza Sii nu este cunoscută;
1494. R.l. manifestările sindromului de intestin iritabil, u.a.s.c.g.e.:
- A. episoade de dureri abdominale sunt adesea provocate de ingestia de alimente grase;
- B. tipul și localizarea durerii variază mult;
- C. grețea și vărsăturile sunt frecvente;
- D. sensibilitate la palpare localizată este caracteristică;
- E. contractura musculară abdominală este prezentă în majoritatea cazurilor;
1495. F.d.u. aspecte/ evenimente r.l. pacientului cu DurAbd prin hemoragie intrabdominală exsanguinantă:
- a. faza o ECG este dificil de decis dacă hipotensiunea este consecința unei defici de pompă cardiacă sau a unei hemoragii masive;
- b. intervenția chirurgicală este începută prea târziu pentru a mai putea salva pacientul;
- c. se trece timp prelungit pentru efectuarea de ECGe;
- d. puțin chirurgi sunt dispuși să intervină înainte de a avea o ECG;
- care este succesiunea logică/temperală cea mai susceptibilă de a fi întâlnită în practică:
- A. a-d-d-b-a-c;
- B. a-d-d-c-a-b;
- C. b-c-a-a-d;
- D. c-d-d-a-b;
- E. c-d-d-b-a-c;
1496. R.l. evaluarea pacientului cu DurAbd prin hemoragie intrabdominală exsanguinantă, u.a.s.c.g.e.:
- A. o examinare expeditivă nu este suficientă pentru a stabili conduita corectă;
- B. coexistența unei patologii cardiace sau respiratorii contraindică operația;
- C. în cel mai scurt timp trebuie instituit un acces venos adecvat pentru administrarea de fluide;
- D. operația trebuie începută imediat ce s-a obținut un acces venos adecvat;
- E. nu trebuie intervenit chirurgical înainte de efectuarea unor radiografii abdominale simple și cu substanță de contrast;
1497. R.l. evaluarea pacientului cu DurAbd prin hemoragie intrabdominală exsanguinantă, u.a.s.c.g.e.:
- A. este obligatoriu un examen clinic (anamneza + examen fizic) atent și detaliat;
- B. este o situație relativ rară, din farență;
- C. este necesară intervenție chirurgicală imediată;
- D. intervenția chirurgicală înainte de efectuarea unor investigații paraclinice detaliate se poate solda cu decesul pacientului;
- E. cauza poate fi un anevrism aortic rupt;
1498. U.f.d. evaluarea pacientului cu DurAbd s.c.g.e.:
- A. Cu excepția pancreatitei acute;
- B. atelectuniile abdominale dureroase;
- C. nu necesită o intervenție chirurgicală atât de urgentă;
- D. încăl să nu permită un istoric și un examen fizic atente și sistematice, chiar dacă starea pacientului pare foarte severă;
1499. R.l. evaluarea pacientului cu DurAbd, f.d.u. afirmații generale:
1. în multe cazuri există o discrepanță între apariția severitate a manifestărilor și severitatea reală a patologiei subiacente;
2. diagnosticul de „abdomen acut” sau „abdomen chirurgical” este inacceptabil și induce în eroare;
- și următoarele exemple:

Prescurtări frecvent folosite: c.g. = cu excepție, s.u.c.g.e. = sunt următoarele, cu excepție, u.a.s.c.g.e. = următoarele afirmații sunt corecte, cu excepție, s.c.f.d. = sunt corect formulate, cu excepție.

1487. R.l. DurAbd cauzată de (nevrologică), u.a.s.c.g.e.:
- A. de obicei este resimțită difuz în tot abdomenul;
- B. poate fi declanșată de modificarea ușoară a temperaturii;
- C. poate fi provocată de palpare, fie și blândă;
- D. limitează respirația;
- E. are drept cauză o leziune veche a nervilor motori;
1488. Durerea având originea în nervii spinali sau în rădăcinile acestora poate fi provocată de u. stări patologice, c.g.e.:
- A. herpes zoster;
- B. compresie prin osteofite (secundare unei artite);
- C. hemieria nucleului pulpos;
- D. tumor;
- E. diabet;
- F. sifilis;
1489. R.l. DurAbd având originea în nervii spinali sau în rădăcinile acestora, u.a.s.c.g.e.:
- A. se instalează brusc;
- B. nu este influențată de aportul de alimente;
- C. nu împiedică respirația;
- D. asocieră cu spasm muscular sever este caracteristică pentru crizele gastrice de tabes dorsali;
- E. nu este influențată de mișcarea coloanei vertebrale;
1490. R.l. DurAbd având originea în nervii spinali sau în rădăcinile acestora, u.a.s.c.g.e.:
- A. încealează brusc;
- B. nu este însoțită de distensie abdominală;
- C. este agravată de respirație;
- D. spasmul muscular asociat nu este accentuat de palparea abdomenului;
- E. este de obicei limitată la câteva dermatoame;
1491. R.l. DurAbd având originea în nervii spinali sau în rădăcinile acestora, u.a.s.c.g.e.:
- A. este lăncănță ascuțită;
- B. nu modifică respirația;
- C. poate fi însoțită de spasm muscular sever;
- D. spasmul muscular asociat este accentuat de palparea abdomenului;
- E. foarte frecvent este însoțită de hiperestezie cutanată;
1492. R.l. DurAbd de natură funcțională, u.a.s.c.g.e.:
- A. nu se conformează niciunui dintre tiparele uzuale de DurAbd;
- B. mecanismul este dificil de defini;
- C. cauzele Sii sau ale boilor funcționale invadate nu sunt cunoscute;
- D. diagnosticul de Sii este un diagnostic de excludere;
- E. nu este influențată de factorii psihici;
1493. R.l. sindromul de intestin iritabil (Sii), u.a.s.c.g.e.:
- A. Sii este o tulburare funcțională gastrointestinală;
- B. Sii este caracterizat de DurAbd și de tulburări de tranzit;
- C. diagnosticul de Sii se pune pe baza criteriilor clinice;
- D. diagnosticul de Sii presupune evidențierea unor anomalii organice specifice;
- E. cauza Sii nu este cunoscută;
1494. R.l. manifestările sindromului de intestin iritabil, u.a.s.c.g.e.:
- A. episoade de dureri abdominale sunt adesea provocate de ingestia de alimente grase;
- B. tipul și localizarea durerii variază mult;
- C. grețea și vărsăturile sunt frecvente;
- D. sensibilitate la palpare localizată este caracteristică;
- E. contractura musculară abdominală este prezentă în majoritatea cazurilor;
1495. F.d.u. aspecte/ evenimente r.l. pacientului cu DurAbd prin hemoragie intrabdominală exsanguinantă:
- a. faza o ECG este dificil de decis dacă hipotensiunea este consecința unei defici de pompă cardiacă sau a unei hemoragii masive;
- b. intervenția chirurgicală este începută prea târziu pentru a mai putea salva pacientul;
- c. se trece timp prelungit pentru efectuarea de ECGe;
- d. puțin chirurgi sunt dispuși să intervină înainte de a avea o ECG;
- care este succesiunea logică/temperală cea mai susceptibilă de a fi întâlnită în practică:
- A. a-d-d-b-a-c;
- B. a-d-d-c-a-b;
- C. b-c-a-a-d;
- D. c-d-d-a-b;
- E. c-d-d-b-a-c;
1496. R.l. evaluarea pacientului cu DurAbd prin hemoragie intrabdominală exsanguinantă, u.a.s.c.g.e.:
- A. o examinare expeditivă nu este suficientă pentru a stabili conduita corectă;
- B. coexistența unei patologii cardiace sau respiratorii contraindică operația;
- C. în cel mai scurt timp trebuie instituit un acces venos adecvat pentru administrarea de fluide;
- D. operația trebuie începută imediat ce s-a obținut un acces venos adecvat;
- E. nu trebuie intervenit chirurgical înainte de efectuarea unor radiografii abdominale simple și cu substanță de contrast;
1497. R.l. evaluarea pacientului cu DurAbd prin hemoragie intrabdominală exsanguinantă, u.a.s.c.g.e.:
- A. este obligatoriu un examen clinic (anamneza + examen fizic) atent și detaliat;
- B. este o situație relativ rară, din farență;
- C. este necesară intervenție chirurgicală imediată;
- D. intervenția chirurgicală înainte de efectuarea unor investigații paraclinice detaliate se poate solda cu decesul pacientului;
- E. cauza poate fi un anevrism aortic rupt;
1498. U.f.d. evaluarea pacientului cu DurAbd s.c.g.e.:
- A. Cu excepția pancreatitei acute;
- B. atelectuniile abdominale dureroase;
- C. nu necesită o intervenție chirurgicală atât de urgentă;
- D. încăl să nu permită un istoric și un examen fizic atente și sistematice, chiar dacă starea pacientului pare foarte severă;
1499. R.l. evaluarea pacientului cu DurAbd, f.d.u. afirmații generale:
1. în multe cazuri există o discrepanță între apariția severitate a manifestărilor și severitatea reală a patologiei subiacente;
2. diagnosticul de „abdomen acut” sau „abdomen chirurgical” este inacceptabil și induce în eroare;
- și următoarele exemple:

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele, c.d.u. = care dintre următoarele, f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, r.l. = referitor/referitoare la, U.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază deserv;

a. cele mai catastrofale evenimente pot fi precedate de cele mai subtile manifestări;	B. interpretarea corectă a unei dureri abdominale acute este dificilă;	C. în multe cazuri există o discrepanță între aparenta severitate a manifestărilor și severitatea reală a patologiei subiacente;	D. un istoric sistematic și detaliat este mai valoros decât orice investigație de laborator sau radiologică;	E. Sili este o cauză rară de DurAbd;	F. este puțin probabil ca analgezia adecvată să mascheze diagnosticul;	1503. R.I. evaluarea pacientului cu DurAbd, u.a.s.c.e.e.:	A. regimul de urgență necesar pentru hemoragia intraabdominală exsanguinantă nu este necesar și pentru hemoragia digestivă;	B. orice pacient cu DurAbd recent instalată necesită evaluare diagnostică neîntreruptă și temeinică;	C. un istoric sistematic și detaliat necesită timp și răbdare, motiv pentru care este destul de rar practicat;	D. în multe cazuri de DurAbd cronică diagnosticul este mai dificil de stabilit;	E. narcoticele sau analgezicele trebuie evitate înainte de stabilirea unui diagnostic definitiv sau a unui plan definitiv de investigații;	1504. R.I. evaluarea pacientului cu DurAbd, u.a.s.c.e.e.:	A. în majoritatea cazurilor, un istoric sistematic și detaliat este suficient pentru punerea unui diagnostic de o acuratețe rezonabilă;	B. diagnosticul de „abdomen acut” sau „abdomen chirurgical” este inacceptabil și induce în eroare;	C. succesele cronologice a evenimentelor în istoricul pacientului este mai puțin importantă decât localizarea durerii;	D. diagnosticul de Sili trebuie întotdeauna avut în vedere;	E. localizarea durerii poate ajuta în îngustarea diagnosticului diferențial;	1505. C.d.u. condiții este cea mai puțin importantă pentru ca examinatorul să fie apt să discerne diagnosticul din
a. cele mai catastrofale evenimente pot fi precedate de cele mai subtile manifestări;	B. interpretarea corectă a unei dureri abdominale acute este dificilă;	C. în multe cazuri există o discrepanță între aparenta severitate a manifestărilor și severitatea reală a patologiei subiacente;	D. un istoric sistematic și detaliat este mai valoros decât orice investigație de laborator sau radiologică;	E. Sili este o cauză rară de DurAbd;	F. este puțin probabil ca analgezia adecvată să mascheze diagnosticul;	1503. R.I. evaluarea pacientului cu DurAbd, u.a.s.c.e.e.:	A. regimul de urgență necesar pentru hemoragia intraabdominală exsanguinantă nu este necesar și pentru hemoragia digestivă;	B. orice pacient cu DurAbd recent instalată necesită evaluare diagnostică neîntreruptă și temeinică;	C. un istoric sistematic și detaliat necesită timp și răbdare, motiv pentru care este destul de rar practicat;	D. în multe cazuri de DurAbd cronică diagnosticul este mai dificil de stabilit;	E. narcoticele sau analgezicele trebuie evitate înainte de stabilirea unui diagnostic definitiv sau a unui plan definitiv de investigații;	1504. R.I. evaluarea pacientului cu DurAbd, u.a.s.c.e.e.:	A. în majoritatea cazurilor, un istoric sistematic și detaliat este suficient pentru punerea unui diagnostic de o acuratețe rezonabilă;	B. diagnosticul de „abdomen acut” sau „abdomen chirurgical” este inacceptabil și induce în eroare;	C. succesele cronologice a evenimentelor în istoricul pacientului este mai puțin importantă decât localizarea durerii;	D. diagnosticul de Sili trebuie întotdeauna avut în vedere;	E. localizarea durerii poate ajuta în îngustarea diagnosticului diferențial;	1505. C.d.u. condiții este cea mai puțin importantă pentru ca examinatorul să fie apt să discerne diagnosticul din

Prescurtări frecvent folosite: c.e. = cu excepția; s.u.s.c.e. = sunt următoarele, cu excepția; u.a.s.c.e.e. = următoarele afirmații sunt corecte, cu excepția; s.c.f.c.e. = sunt corect formulate, cu excepția.

1509. R.I. diagnosticile diferențiale ale DurAbd în funcție de localizare, f.d.u. localizări:	c. esofagită;	3. epigastru;
1. cadranul inferior drept sau stâng;	care sunt asocierile corecte:	și următoarele etiologii:
2. cadranul superior drept;	A. a-1, b-2, c-3;	a. diabet;
3. epigastru și/sau cadranul superior stâng și/sau drept;	B. a-1, b-3, c-2;	b. patologie gastroesofagiană;
și următoarele etiologii:	C. a-2, b-1, c-3;	c. patologie subdiafragmatică;
a. pancreatită;	D. a-3, b-1, c-2;	care sunt asocierile corecte:
b. salpingită;	E. a-3, b-2, c-1;	A. a-1, b-2, c-3;
c. sindrom Budd-Chiari;	1513. R.I. diagnosticile diferențiale ale DurAbd în funcție de localizare, f.d.u. localizări:	B. a-1, b-3, c-2;
care sunt asocierile corecte:	1. cadranul inferior drept;	C. a-2, b-1, c-3;
A. a-1, b-2, c-3;	2. cadranul superior stâng;	D. a-2, b-3, c-1;
B. a-1, b-3, c-2;	3. epigastru;	E. a-3, b-1, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;	și următoarele etiologii:	1517. R.I. diagnosticile diferențiale ale DurAbd în funcție de localizare, f.d.u. localizări:
D. a-2, b-3, c-1;	care sunt asocierile corecte:	1. cadranul superior drept;
E. a-3, b-1, c-2;	A. a-1, b-3, c-2;	2. difuză nelocalizată;
1510. R.I. diagnosticile diferențiale ale DurAbd în funcție de localizare, f.d.u. localizări:	B. a-2, b-1, c-3;	3. epigastru;
1. cadranul inferior drept sau stâng;	C. a-2, b-3, c-1;	și următoarele etiologii:
2. cadranul superior stâng;	D. a-3, b-1, c-2;	a. pericardită;
3. epigastru și/sau cadranul superior stâng;	E. a-3, b-2, c-1;	b. colangită;
și următoarele etiologii:	1514. R.I. diagnosticile diferențiale ale DurAbd în funcție de localizare, f.d.u. localizări:	c. febră mediteraneană familială;
a. ulcer gastric;	1. cadranul inferior stâng;	care sunt asocierile corecte:
b. absces splenic;	2. difuză nelocalizată;	A. a-1, b-2, c-3;
c. sarcină ectopică;	3. epigastru;	B. a-2, b-1, c-3;
care sunt asocierile corecte:	și următoarele etiologii:	C. a-2, b-3, c-1;
A. a-1, b-2, c-3;	care sunt asocierile corecte:	D. a-3, b-1, c-2;
B. a-2, b-1, c-3;	A. a-1, b-3, c-2;	E. a-3, b-2, c-1;
C. a-2, b-3, c-1;	B. a-2, b-1, c-3;	1518. R.I. diagnosticile diferențiale ale DurAbd în funcție de localizare, f.d.u. localizări:
D. a-3, b-1, c-2;	C. a-2, b-3, c-1;	1. cadranul superior drept;
E. a-3, b-2, c-1;	D. a-2, b-3, c-1;	2. difuză nelocalizată;
1511. R.I. diagnosticile diferențiale ale DurAbd în funcție de localizare, f.d.u. localizări:	E. a-3, b-2, c-1;	3. epigastru;
1. cadranul inferior drept;	și următoarele etiologii:	și următoarele etiologii:
2. cadranul superior stâng;	a. boală psihică;	a. ischemie mezenterică;
3. epigastru;	b. diverticulită;	b. ulcer peptic;
și următoarele etiologii:	c. patologie cardiovasculară;	c. colecistită;
a. boală de reflux gastroesofagian;	care sunt asocierile corecte:	care sunt asocierile corecte:
b. infarct splenic;	A. a-1, b-3, c-2;	A. a-1, b-3, c-2;
c. apendicită;	B. a-2, b-1, c-3;	B. a-2, b-1, c-3;
care sunt asocierile corecte:	C. a-2, b-3, c-1;	C. a-2, b-3, c-1;
A. a-1, b-2, c-3;	D. a-3, b-1, c-2;	D. a-3, b-1, c-2;
B. a-1, b-3, c-2;	E. a-3, b-2, c-1;	E. a-3, b-2, c-1;
C. a-2, b-1, c-3;	1515. R.I. diagnosticile diferențiale ale DurAbd în funcție de localizare, f.d.u. localizări:	1519. R.I. diagnosticile diferențiale ale DurAbd în funcție de localizare, f.d.u. localizări:
D. a-3, b-1, c-2;	1. cadranul inferior drept;	1. cadranul superior drept;
E. a-3, b-2, c-1;	2. cadranul superior stâng;	2. difuză nelocalizată;
1512. R.I. diagnosticile diferențiale ale DurAbd în funcție de localizare, f.d.u. localizări:	3. epigastru;	3. perombilical sau difuză nelocalizată;
1. cadranul inferior drept;	și următoarele etiologii:	și următoarele etiologii:
2. cadranul superior stâng;	a. boală de reflux gastroesofagian;	a. gastroenterită;
3. epigastru;	b. infarct splenic;	b. empiem;
și următoarele etiologii:	c. apendicită;	c. malarie;
a. limfadenită mezenterică;	care sunt asocierile corecte:	care sunt asocierile corecte:
b. patologie splenică;	A. a-1, b-2, c-3;	A. a-1, b-2, c-3;
	B. a-1, b-3, c-2;	B. a-1, b-3, c-2;
	C. a-2, b-1, c-3;	C. a-2, b-1, c-3;
	D. a-2, b-3, c-1;	D. a-2, b-3, c-1;
	E. a-3, b-1, c-2;	E. a-3, b-1, c-2;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; f.d.u. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, f.d. = restul/reținut la; U.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază despre;

Prescurtări frecvent folosite: c.e. = cu excepția; s.u.s.c.e. = sunt următoarele, cu excepția; u.a.s.c.e.e. = următoarele afirmații sunt corecte, cu excepția; s.c.f.c.e. = sunt corect formulate, cu excepția.

1520. R1. diagnosticale diferențiale ale DurAbd în funcție de localizare, f.d.u. localizări:
1. cadranul superior drept;
 2. difuză nelocalizată;
 3. peritonită sau difuză nelocalizată;
- și următoarele etiologii:
- a. patologie de tub digestiv, mai ales intestin;
 - b. hepatită;
 - c. ocluzie intestinală;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;
1521. R1. diagnosticale diferențiale ale DurAbd în funcție de localizare, f.d.u. localizări:
1. cadranul superior drept;
 2. difuză nelocalizată;
 3. peritonită;
- și următoarele etiologii:
- a. peritonită;
 - b. apendicita în faza timpurie;
 - c. patologie biliară;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;
1522. R1. diagnosticale diferențiale ale DurAbd în funcție de localizare, f.d.u. localizări:
1. cadranul superior drept;
 2. diverse localizări, frecvent în cadranul inferior stâng, dar și difuză nelocalizată;
 3. peritonită;
- și următoarele etiologii:
- a. patologie intestinală;
 - b. patologie hepatică;
 - c. sindromul de intestin înalt;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
1523. R1. examenul fizic la un pacient cu DurAbd, c.d.u. elemente nu poate fi furnizat de inspecție:
- A. fațes;
B. poziția în pat;
C. feiul în care respiră;
D. mișcarea abdominalului cu respirația;
E. sensibilitatea la decompresie;
1524. R1. demonstrarea sensibilității la decompresie la pacientul suspionat de peritonită, f.d.u. manevre:
1. examinarea ridică brusc mâna după ce a apăsat progresiv profund pe pereții abdominali;
 2. examinarea percută blând abdomenul;
- și următoarele caracteristici:
- a. este manevra de sensibilitate la decompresie în miniatură;
 - b. poate induce spasm protector, devenind pozitivă și în durerea abdominală neînsoțită de iritație peritoneală;
 - c. este o manevră inutil de brutală (declanșând durere intensă), chiar dacă spectaculoasă și pedagogică;
 - d. poate oferi o informație mai corectă și cu o localizare mai precisă;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-1, d-2;
B. a-1, b-2, c-2, d-1;
C. a-2, b-1, c-1, d-2;
D. a-2, b-1, c-2, d-1;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;
1525. R1. demonstrarea sensibilității la decompresie la pacientul suspionat de peritonită, f.d.u. manevre:
1. examinarea ridică brusc mâna după ce a apăsă progresiv profund pe pereții abdominali;
 2. examinarea percută blând abdomenul;
 3. examinarea îi solicită pacientului să susțină și următoarele caracteristici:
- a. poate fi pozitivă și la persoane fără boală organică, dar anxioase și speriate de durerea lor abdominală;
- b. poate evidenția sensibilitatea la decompresie fără a mai fi necesară plasarea mâinii pe abdomen;
- c. furnizează informații cu atât mai nespecifice, cu cât este mai nedolose efectuată;
- d. oferă aceeași informație față de chinul pacientului;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-1, c-2, d-3;
B. a-1, b-2, c-3, d-1;
C. a-1, b-3, c-1, d-2;
D. a-2, b-1, c-3, d-1;
E. a-2, b-3, c-1, d-1;
1526. U.f.d.f.d. examenul fizic la un pacient cu DurAbd s.c.f.c.g.e.:
- A. Sensibilitatea la examinarea rectală sau pelviană în absența altor semne abdominale;
- B. poate fi provocată de patologii cu indicație chirurgicală;
- C. cum ar fi colecistita perforată;
- D. este negativă;
- E. chistul ovarian torsionat etc.
1527. U.f.d.f.d. examenul fizic la un pacient cu DurAbd s.c.f.c.g.e.:
- A. Dacă palparea abdominalului declanșează durere, pentru:
- B. diferențierea durerii gastro-intestinale de cea hepatică;
- C. i se poate solicita pacientului să efectueze o mișcare;
- D. care contracționează refluxul gastroesofagian;
- E. de exemplu, să inspire profund.
1528. U.f.d.f.d. examenul fizic la un pacient cu DurAbd s.c.f.c.g.e.:
- A. La pacientul cu mușchi abdominali contractați;
- B. palparea abdomenului va declanșa în continuare durere;
- C. dacă aceasta este de origine visceră, dar nu și dacă este de origine parietală;
- D. intrucă mușchii parietali;
- E. contracția compănimă suplimentar zona dureroasă.
1529. F.d.u. evenimente, revelatoare pentru utilitatea auscultăției la un pacient cu DurAbd:
- a. porțiunea proximală a intestinului (în amonte de obstrucție) se deslindă și se edematizează;
- b. ocluzia intestinală;
- c. auscultăția devine în mod fals sugestivă pentru peritonită;
- d. zgomotele peristaltice scad (pierzându-și caracterul de borborisme) sau dispar;
- care este lanțul causal corect:
- A. a→c→d→b;
B. b→a→d→c;
C. c→a→b→d;
D. c→b→a→d;
E. d→c→a→b;
1530. R1. utilitatea examenului fizic la un pacient cu DurAbd, u.a.s.c.g.e.:
- A. simpla inspecție a pacientului este neinformativă;
- B. o palpare brudă poate rata un colector palpabil dacă mușchii abdominali sunt prea relaxați;
- C. este importantă evaluarea stării de hidratare a pacientului;
- D. în unele cazuri de ocluzie intestinală, zgomotele peristaltice pot fi scăzute până la dispariție;
- E. distribuția timpurii poate sugera sediul obstrucției;
1531. U.f.d.f.d. utilitatea examenului fizic la un pacient cu DurAbd s.c.f.c.g.e.:
- A. într-o ocluzie intestinală;
- B. distensia și edematizarea;
- C. porțiunile de intestin situate;
- D. în aval de obstrucție poate;
- E. duce la accentuarea zgomotelor peristaltice.
1532. R1. utilitatea examenului fizic la un pacient cu DurAbd, u.a.s.c.g.e.:
- A. examinarea furnizează cu atât mai multe informații, cu cât este mai viguroasă și mai rapidă;
- B. ca și în cazul anamnezei, trebuie alocat timp suficient pentru examenul fizic;
- C. în semiologia clasică se acordă multă importanță auscultăției abdomenului;
- D. scăderea până la dispariție a zgomotelor peristaltice este considerată, clasic, semn de peritonită;
- E. malitarea produsă de ascita liberă în cavitățile peritoneale se deplasează spre zonele declive ale abdomenului, în funcție de poziția pacientului;
1533. R1. utilitatea examenului fizic la un pacient cu DurAbd, u.a.s.c.g.e.:
- A. un semn important al iritației peritoneale este sensibilitatea la decompresie;
- B. prezența unor simptome concordante poate face ca semnele abdominale, fie și minime, să devină fie foarte semnificative;
- C. în semiologia clasică se acordă multă importanță prezenței absenței zgomotelor peristaltice, caracterului și frecvenței acestora;
- D. abdomenul cu adevărat silențios este de obicei prezent doar în peritonita biliară insidios instalată;
- E. distribuția matiaji produse de ascia liberă în cavitățile peritoneale depinde de cantitatea de lichid și de poziția pacientului;
1534. R1. utilitatea examenului fizic la un pacient cu DurAbd, u.a.s.c.g.e.:
- A. sensibilitatea la decompresie chiar (natură) patologică, f.d.u. localizări:
1. epigastru și hipocondrul stâng cu extrudere la baza herniilor stâng;
 2. diverse porțiuni ale cadrului colic;
 3. pe întregul cadru colic (distensia generală a colonului);
- și următoarele stări patologice:
- a. ileus, infarct intestinal, megacolon toxic;
 - b. stomac destins;
 - c. ocluzie colonică;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
1538. R1. distribuția timpurii (la percută abdomenului) ca fenomen cvasifiziologic, f.d.u. localizări:
1. în fosa iliacă dreaptă;
 2. în epigastru;
 3. în hipocondrul drept stâng;
- și u. segmente din tubul digestiv unde se acumulează gaze:
- a. unghiul hepatic splenic al colonului;
- b. pungea cu aer a stomacului;
- c. cecul;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
1539. U.f.d.f.d. hipersonoritate la percută abdomenului s.c.f.c.g.e.:
- A. Hipersonoritatea/ timpansmul poate să apară prin excesul:
- B. de gaz dintr-un segment al tubului digestiv destins;
- C. ca urmare a peretelui muscularului intestinal (volvulus) prin contact;
- D. cu un proces neoplazic;
- E. generalizat (peritonită etc.) sau localizat (pancreatită etc.).
1540. R1. percută abdomenului, f.d.u. constată:
1. hipersonoritate/ timpansm prin excesul de gaz în cavitatea peritoneală;
 2. hipersonoritate/ timpansm prin excesul de gaz dintr-un segment al tubului digestiv destins ca urmare a unei ocluzii mecanice;
 3. matiaje fixă;
- și următoarele stări patologice:

- Prescurtări frecvent folosite: c.d.u. = cu excepția, s.d.u.g.e. = sunt următoarele, cu excepția, u.a.s.c.g.e. = următoarele afirmații sunt corecte, cu excepția; s.c.f.c.g.e. = sunt corect formulate, cu excepția;
- Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, f.l. = referitor/referitoare la; U.f.d.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază despre;
- D. în unele cazuri de ocluzie intestinală, zgomotele peristaltice pot fi scăzute până la dispariție;
- E. distribuția timpurii poate sugera sediul obstrucției;
1531. U.f.d.f.d. utilitatea examenului fizic la un pacient cu DurAbd s.c.f.c.g.e.:
- A. într-o ocluzie intestinală;
- B. distensia și edematizarea;
- C. porțiunile de intestin situate;
- D. în aval de obstrucție poate;
- E. duce la accentuarea zgomotelor peristaltice.
1532. R1. utilitatea examenului fizic la un pacient cu DurAbd, u.a.s.c.g.e.:
- A. examinarea furnizează cu atât mai multe informații, cu cât este mai viguroasă și mai rapidă;
- B. ca și în cazul anamnezei, trebuie alocat timp suficient pentru examenul fizic;
- C. în semiologia clasică se acordă multă importanță auscultăției abdomenului;
- D. scăderea până la dispariție a zgomotelor peristaltice este considerată, clasic, semn de peritonită;
- E. malitarea produsă de ascita liberă în cavitățile peritoneale se deplasează spre zonele declive ale abdomenului, în funcție de poziția pacientului;
1533. R1. utilitatea examenului fizic la un pacient cu DurAbd, u.a.s.c.g.e.:
- A. un semn important al iritației peritoneale este sensibilitatea la decompresie;
- B. prezența unor simptome concordante poate face ca semnele abdominale, fie și minime, să devină fie foarte semnificative;
- C. în semiologia clasică se acordă multă importanță prezenței absenței zgomotelor peristaltice, caracterului și frecvenței acestora;
- D. abdomenul cu adevărat silențios este de obicei prezent doar în peritonita biliară insidios instalată;
- E. distribuția matiaji produse de ascia liberă în cavitățile peritoneale depinde de cantitatea de lichid și de poziția pacientului;
1534. R1. utilitatea examenului fizic la un pacient cu DurAbd, u.a.s.c.g.e.:
- A. sensibilitatea la decompresie chiar (natură) patologică, f.d.u. localizări:
1. epigastru și hipocondrul stâng cu extrudere la baza herniilor stâng;
 2. diverse porțiuni ale cadrului colic;
 3. pe întregul cadru colic (distensia generală a colonului);
- și următoarele stări patologice:
- a. ileus, infarct intestinal, megacolon toxic;
 - b. stomac destins;
 - c. ocluzie colonică;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
1538. R1. distribuția timpurii (la percută abdomenului) ca fenomen cvasifiziologic, f.d.u. localizări:
1. în fosa iliacă dreaptă;
 2. în epigastru;
 3. în hipocondrul drept stâng;
- și u. segmente din tubul digestiv unde se acumulează gaze:
- a. unghiul hepatic splenic al colonului;
- b. pungea cu aer a stomacului;
- c. cecul;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
1539. U.f.d.f.d. hipersonoritate la percută abdomenului s.c.f.c.g.e.:
- A. Hipersonoritatea/ timpansmul poate să apară prin excesul:
- B. de gaz dintr-un segment al tubului digestiv destins;
- C. ca urmare a peretelui muscularului intestinal (volvulus) prin contact;
- D. cu un proces neoplazic;
- E. generalizat (peritonită etc.) sau localizat (pancreatită etc.).
1540. R1. percută abdomenului, f.d.u. constată:
1. hipersonoritate/ timpansm prin excesul de gaz în cavitatea peritoneală;
 2. hipersonoritate/ timpansm prin excesul de gaz dintr-un segment al tubului digestiv destins ca urmare a unei ocluzii mecanice;
 3. matiaje fixă;
- și următoarele stări patologice:

E. determinată de aerul din intestin.	D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;	1. deplasarea limitei superioare în sus; 2. dispariția limitei superioare; 3. deplasarea limitei inferioare în jos; și următoarele stări patologice: a. paralizie frenică; b. pneumoperitoneu; c. formațiune subhepatică; care sunt asociate corele: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-2, b-3, c-1; E. a-3, b-1, c-2;
1550. R.I. felul în care distribuția matității la percuția abdominală depinde de cantitatea de lichid de ascită, f.d.u. evaluări cantitative: 1. <0,5 L (cantitate foarte mică); 2. 1,5-3 L (cantitate moderată); 3. >7 L (cantitate foarte mare); și următoarele zone unde poate fi detectată matitatea: a. doar perimobilă dacă pacientul stă pe coate și genunchi; b. pe întreaga arie abdominală; c. pe ambele flancuri când pacientul stă pe spate, pe un singur flanc când pacientul stă pe partea respectivă; care sunt asociate corele: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-2, b-3, c-1; E. a-3, b-2, c-1;	1553. R.I. modificări ale matității hepatice, f.d.u. variante: 1. deplasarea limitei superioare în sus; 2. deplasarea limitei superioare în jos; 3. deplasarea limitei inferioare în jos; și următoarele stări patologice: a. plioză hepatică; b. hepatomegalie; c. enfizem; care sunt asociate corele: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-2, b-3, c-1; E. a-3, b-2, c-1;	1557. R.I. modificări ale matității hepatice, f.d.u. variante: 1. deplasarea limitei superioare în sus; 2. dispariția limitei superioare; 3. deplasarea limitei inferioare în jos; și următoarele stări patologice: a. colecție subhepatică; b. formațiune hepatică (tumoră, abces, chist); c. insinuarea temporară a colonului între ficat și perelele abdominale prin distensia gazoasă a colonului (aerocolie); care sunt asociate corele: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;
1551. R.I. felul în care distribuția matității la percuția abdominală depinde de cantitatea de lichid de ascită, f.d.u. evaluări cantitative: 1. 0,5-1,5 L (cantitate mică); 2. 3-7 L (cantitate mare); și următoarele zone unde poate fi detectată matitatea: a. pe întreaga arie abdominală; b. suprapubian dacă pacientul stă în picioare; c. pe flancuri și suprapubian (cu marginea superioară concavă în sus); care sunt asociate corele: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-2, b-3, c-1; E. a-3, b-2, c-1;	1555. R.I. modificări ale matității hepatice, f.d.u. variante: 1. deplasarea limitei superioare în sus; 2. dispariția limitei superioare; 3. deplasarea limitei inferioare în jos; și următoarele stări patologice: a. plioză hepatică; b. impingerea ficatului de către o colecție (abces) subdiaphragmatică; c. atelectazie; care sunt asociate corele: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-2, b-3, c-1; E. a-3, b-2, c-1;	1558. R.I. modificări ale matității hepatice, f.d.u. variante: 1. deplasarea limitei superioare în sus; 2. dispariția limitei superioare; 3. deplasarea limitei inferioare în jos; și următoarele stări patologice: a. insinuarea permanentă a colonului între ficat și perelele abdominale (sindromul Chilaidei); b. ascită masivă; c. plastron colectic; care sunt asociate corele: A. a-1, b-2, c-3; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;
1552. R.I. cauzele deplasării în sus a limitei superioare a matității hepatice, f.d.u. categorii: 1. patologie supradiaphragmatică; 2. patologie diafragmatică; 3. patologie subdiaphragmatică; și următoarele stări patologice: a. paralizie frenică; b. pleurălă (pahipleuriă, lichid), atelectazie; c. formațiuni hepatice (tumoră, abces, chist), ascită masivă; care sunt asociate corele: A. a-1, b-2, c-3; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1;	1559. R.I. rolul investigațiilor paraclinice în evaluarea pacientului cu DurAbd, u.a.s.c.g.:	1559. R.I. rolul investigațiilor paraclinice în evaluarea pacientului cu DurAbd, u.a.s.c.g.:
1556. R.I. modificări ale matității hepatice, f.d.u. variante: A. a-1, b-2, c-3; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1;	1556. R.I. modificări ale matității hepatice, f.d.u. variante: A. a-1, b-2, c-3; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1;	1556. R.I. modificări ale matității hepatice, f.d.u. variante: A. a-1, b-2, c-3; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele, f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, r.i. = referitor/referitoare la, U.I.d.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază despre:

1. hipersonoritate/ timpanism prin excesul de gaz dintr-un segment al tubului digestiv destins ca urmare a unei occluzii mecanice; 2. matitate fixă; 3. alternanță de zone mate și sonore; și următoarele stări/ circumstanțe: a. stenoză pilorică (malignă sau benignă); b. sarcină; c. occluzie intestinală; care sunt asociate corele: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;	1547. R.I. percuția abdominală, f.d.u. constatări: 1. hipersonoritate/ timpanism prin excesul de gaz dintr-un segment al tubului digestiv destins ca urmare a unei occluzii mecanice; 2. matitate fixă; 3. alternanță de zone mate și sonore; și următoarele stări patologice: a. TBC peritoneală; b. occluzie intestinală (de exemplu tumorală); c. leiomiobrom uterin; care sunt asociate corele: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;	1548. U.I.d.f.d. detectarea percuției a lichidului de ascită s.c.f.c.g.:	1549. U.I.d.f.d. detectarea percuției a lichidului de ascită s.c.f.c.g.:
ileus secundar contactului cu un proces inflamator localizat; 3. matitate fixă; și următoarele stări/ circumstanțe: a. acumularea de gaz în unghiul hepatic/ splenic al colonului; b. apariția de material solid sau lichid într-un organ (colon, vezică); c. pancreatită; care sunt asociate corele: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;	1544. R.I. percuția abdominală, f.d.u. constatări: 1. hipersonoritate/ timpanism prin excesul de gaz dintr-un segment al tubului digestiv destins ca fenomen cvasifiziologic; 2. matitate fixă; 3. matitate fixă cu limita superioară de obicei convexă; și următoarele stări patologice: a. organ mărit/ destins: ficat, splină, rinichi, uter, vezică, colon; b. formațiune hipogastriacă (vezică, uter, ovar mărit/ destins); c. acumularea de gaz în punga cu aer a stomacului; care sunt asociate corele: A. a-1, b-2, c-3; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;	1545. R.I. percuția abdominală, f.d.u. constatări: 1. hipersonoritate/ timpanism prin excesul de gaz dintr-un segment al tubului digestiv destins ca fenomen cvasifiziologic; 2. matitate fixă; 3. matitate deplasabilă; și următoarele stări/ circumstanțe: a. acumularea de gaz în cec; b. ascită liberă în cavitatea peritoneală; c. rinichi polichistici; care sunt asociate corele: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;	1546. R.I. percuția abdominală, f.d.u. constatări:
a. volvulus; b. pneumoperitoneu; c. glob vezical; care sunt asociate corele: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-2, b-3, c-1; E. a-3, b-2, c-1;	1542. R.I. percuția abdominală, f.d.u. constatări: 1. hipersonoritate/ timpanism prin excesul de gaz în cavitatea peritoneală; 2. hipersonoritate/ timpanism prin excesul de gaz dintr-un segment al tubului digestiv destins prin ileus secundar contactului cu un proces inflamator generalizat; 3. matitate fixă; și următoarele stări patologice: a. ulcer perforat; b. peritonită; c. formațiune solidă sau lichidă; care sunt asociate corele: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;	1543. R.I. percuția abdominală, f.d.u. constatări: 1. hipersonoritate/ timpanism prin excesul de gaz dintr-un segment al tubului digestiv destins ca fenomen cvasifiziologic; 2. hipersonoritate/ timpanism prin excesul de gaz dintr-un segment al tubului digestiv destins ca fenomen cvasifiziologic; 3. matitate fixă; și următoarele stări patologice: a. ulcer perforat; b. peritonită; c. formațiune solidă sau lichidă; care sunt asociate corele: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;	1543. R.I. percuția abdominală, f.d.u. constatări: 1. hipersonoritate/ timpanism prin excesul de gaz dintr-un segment al tubului digestiv destins ca fenomen cvasifiziologic; 2. hipersonoritate/ timpanism prin excesul de gaz dintr-un segment al tubului digestiv destins ca fenomen cvasifiziologic; 3. matitate fixă; și următoarele stări patologice: a. ulcer perforat; b. peritonită; c. formațiune solidă sau lichidă; care sunt asociate corele: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;

Prescurtări frecvent folosite: c.g. = cu excepția; s.u.c.g. = sunt următoarele, cu excepția; u.a.s.c.g. = următoarele afirmații sunt corecte, cu excepția; s.c.f.c.g. = sunt corect formulate, cu excepția;

- B. nu rareori, numărul de leucocite este normal în ciuda existenței unei perforații viscerele;
- C. amilazemia poate fi crescută în multe alte boli decât pancreatita;
- D. radiografia abdominală simplă (pe gol) poate evidenția o colecistită acută sau hernii externe strangulate;
- E. laparoscopia este în special utilă pentru diagnosticarea bolilor etiologice ale abdomenului superior;
- 1560. R.I.** rolul investigațiilor paraclinice în evaluarea pacienților cu DurAbd, u.a.s.c.g.e.:
- A. investigațiile paraclinice pot orienta diagnosticul, de exemplu, în pancreatită;
- B. prezența anemiei poate fi mai utilă decât numărul de leucocite, mai ales în combinație cu istoricul;
- C. amilazemia poate fi crescută în ulcer perforat, ocizie intestinală strangulată, colecistită acută;
- D. dacă există orice suspiciune de obstrucție colonică, administrarea orală a sulfatului de bariu este obligatorie;
- E. colonoscopia poate fi folosită pentru explorarea lumenului intestinal în căutare de tumori, displazii vasculare etc.;
- 1561. R.I.** rolul investigațiilor paraclinice în evaluarea pacienților cu DurAbd, u.a.s.c.g.e.:
- A. o leucocitoză marcată poate să apară și în pancreatită, colecistită acută, boala inflamatorie pelviană, infarct intestinal;
- B. analiza urinei poate evidenția starea de hidratare;
- C. creșterea amilazemiei nu exclude necesitatea unei operații;
- D. dacă se suspicionează obstrucție colonică (fără perforație), ingografia poate pune diagnosticul;
- E. scintigrafia (HIDA) poate ajuta la diferențierea colecistitei acute de hepatita acută;
- 1562. R.I.** rolul investigațiilor paraclinice în evaluarea pacienților cu DurAbd, u.a.s.c.g.e.:
- A. o leucocitoză marcată (>20.000/mm³) este sugestivă pentru perforația viscerală;
- B. analiza urinei poate exclude o boală renală severă, o infecție urinară ori un diabet dezechilibrat;
- C. determinarea lipazei serice poate avea acuratețe mai mare decât cea a amilazei serice;
- D. radiografia abdominală simplă (pe gol) trebuie efectuată cu pacientul așezat în ortostatism, cât și în decubit lateral;
- E. lavajul peritoneal, ca metodă de diagnostic, se mai practică la ora actuală doar în cazurile de ocizie intestinală;
- F. enteroscopia poate fi folosită pentru explorarea lumenului intestinal în căutare de tumori, displazii vasculare etc.;
- 1563. R.I.** rolul investigațiilor paraclinice în evaluarea pacienților cu DurAbd, u.a.s.c.g.e.:
- A. leucocitoza este de obicei singurul element necesar pentru a decide dacă operația este indicată sau nu;
- B. nivelurile serice ale ureei, glucozei și bilirubinei pot fi utile;
- C. radiografia abdominală simplă poate fi utilă în ocizia intestinală, ulcerul perforat etc.;
- D. în majoritatea situațiilor, lavajul peritoneal, ca metodă de diagnostic, nu poate fi înlocuit de ecografie, TC și laparoscopie;
- E. videocapsula endoscopică poate fi folosită pentru explorarea lumenului intestinal în căutare de tumori, displazii vasculare etc.;
- 1564. U.I.d.f.** evaluarea pacienților cu DurAbd s.c.f.g.e.:
- A. Rareori, este necesară investigația cu bariu;
- B. sau cu substanță de contrast hidrosolubilă;
- C. a tractului digestiv superior;
- D. pentru a evidenția o ocizie intestinală parțială;
- E. după ce acestea a fost demonstrată prin alte metode de diagnostic;
- 1565. R.I.** pacientul cu DurAbd, pentru detectarea căreia dintre următoarele ecografii nu este prima investigație imagistică recomandată:
- A. colecistă desins, litiază biliară;
- B. pancreas mărit;
- C. ovar mărit;
- D. sarcină tubară;
- E. ocizie intestinală;
- 1566. R.I.** pacientul cu DurAbd, pentru detectarea căreia dintre următoarele investigații nu este o investigație utilă:
- A. chisturi ovariene;
- B. sarcină tubară;
- C. sarcinilită acută;
- D. salpingită;
- E. apendicita acută;
- 1567. R.I.** pacientul cu DurAbd, pentru detectarea căreia dintre următoarele TC nu este o investigație utilă:
- A. un pancreas mărit;
- B. splină ruptă;
- C. îngroșarea peretelui colonic sau apendicular;
- D. ulcer peptic;
- E. infiltrarea linară a mezo-colonului sau mezoapendicului caracteristică pentru diverticula sa apendicată;
- 1568. U.I.d.f.** evaluarea pacienților cu DurAbd s.c.f.g.e.:
- A. Uneori, în ciuda tuturor eforturilor, la prima examinare nu se poate pune un diagnostic;
- B. definitiv, care să includă localizarea anatomică a leziunii;
- C. dar de obicei se poate decide totuși dacă o intervenție chirurgicală este indicată sau nu;
- D. iar dacă există dubii, pacientul trebuie externat;
- E. până când se înapucește diagnosticul și se stabilește conduita terapeutică.

Disfagia

- 1569. R.I.** disfagia și la termenii asociați, u.a.s.c.g.e.:
- A. disfagia este senzația de blocare sau obstrucție a trecerii alimentelor prin gură, faringe sau esofag;
- B. alogia este produsă de obicei de un cancer esofagian;
- C. leziunile inflamatoare dureroase care produc odinofagie pot determina și refuzul de a înghiți;
- D. la pacienții cu dificultate la înghițare înghițării, înghițarea se desfășoară normal odată inițiată;
- E. direcționarea greșită a bolului alimentar este caracteristică pentru disfagia esofagiană;
- 1570. R.I.** disfagia și la termenii asociați, u.a.s.c.g.e.:
- A. alogia reprezintă obstrucția esofagiană completă;
- B. rareori, odinofagia și disfagia se asociază;
- C. fagofobia și/sau refuzul de a înghiți pot să apară în paraliză faringiană din cauza fteilor de durere;
- D. direcționarea greșită a bolului alimentar poate determina regurgitare nazală;
- E. pacienții cu hipersensibilitate esofagiană percep coborârea bolului alimentar prin esofag;
- 1571. R.I.** disfagia și la termenii asociați, u.a.s.c.g.e.:
- A. mai general, prin disfagia se înțelege dificultatea la înghițare;
- B. alogia reprezintă o urgență medicală;
- C. dificultatea la înghițare înghițării apare în tulburări ale fazei voluntare a înghițării;
- D. direcționarea greșită a bolului alimentar poate determina aspirațiile laringiană și pulmonară în timpul înghițării;
- E. hipersensibilitatea esofagiană determină obstrucție esofagiană;
- 1572. Atecții** care pot să provoace fagofobie și/sau refuzul de a înghiți s.u.g.e.:
- A. isterie;
- B. rabie;
- C. botulism;
- D. paraliză faringiană;
- E. esofagită de reflux;
- 1573. Fînd** dați următorii termeni referenți la tulburări de deglutiție:
1. disfagia;
2. alogie;
3. glob faringian;
- și u. trăsături (definiții):
- a. senzația de blocare/obstrucție a trecerii alimentelor prin gură, faringe, sau esofag;
- b. împănarea în esofag a bolului alimentar;
- c. senzația de corp străin în gât, dar fără dificultate la înghițare;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
- B. a-1, b-3, c-2;
- C. a-2, b-1, c-3;
- D. a-2, b-3, c-1;
- E. a-3, b-2, c-1;
- 1574. Fînd** indicați următorii termeni referenți la tulburări de deglutiție:
1. disfagia;
2. odinofagie;
3. fagofobie;
- și u. trăsături (definiții):
- a. dificultate la înghițare;
- b. durere la înghițare;
- c. teama de înghițare;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
- B. a-1, b-2, c-2;
- C. a-1, b-3, c-2;
- D. a-1, b-3, c-1;
- E. a-2, b-1, c-1;
- 1575. Fînd** propuși următorii termeni referenți la tulburări de deglutiție:
1. ategie;
2. nod în gât;
3. hipersensibilitatea esofagiană;
- și u. trăsături (definiții):
- a. percepția coborârii bolului alimentar prin esofag, neînsoțită de blocarea alimentelor sau de obstrucție esofagiană completă;
- b. obstrucție esofagiană completă;
- c. senzația de corp străin în gât, dar fără dificultate la înghițare;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
- B. a-2, b-3, c-1;
- C. a-2, b-3, c-2;
- D. a-3, b-1, c-2;
- E. a-3, b-2, c-1;
- 1580. R.I.** clasificarea disfagiei pe baza sediului anatomic, f.d.u. categorii:
1. oră;
2. faringiană;
3. esofagiană;
- și u. mecanisme/ caracteristici:
- a. obstrucție la nivelul SES;
- b. dificultate la inițierea reflexului de înghițare;
- c. cancer esofagian;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
- B. a-1, b-3, c-2;
- C. a-2, b-3, c-1;
- D. a-3, b-1, c-2;
- E. a-3, b-2, c-1;
- 1581. F.d.u.** evenimente disfagice de cauză oră:
- a. mecanismele de protecție pentru căile respiratorii nu au timp să intervină;
- b. aspirație în faringe și/sau regurgitare în cavitatea nazală;
- c. bolul scapă prea repede în faringe;
- care este lanțul causal corect:
- A. a→b→c;
- B. a→c→b;
- C. b→a→c;
- D. b→c→a;
- E. c→a→b;
- 1582. F.d.u.** evenimente disfagice de cauză faringiană:
- a. propulsie linguală sau faringiană deficitară și/sau obstrucție la nivelul SES;
- b. regurgitare nazală și aspirație faringiană în timpul înghițării;
- c. staza alimentelor în faringe;
- care este lanțul causal corect:
- A. a→c→b;

B. b → a → c; C. b → c → a; D. c → a → b; E. c → b → a; 1583. R.I. clasificarea disfației pe baza mecanismului, f.d.u. categorii: 1. mecanică; 2. motorie; și următoarele mecanisme/ cauze: a. lumen prea îngust; b. slăbiciunea contracțiilor peristaltice (determinând contracții neperistaltice); c. bol prea mare; d. relaxare sfincteriană deficitară; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-1, c-2, d-2; B. a-1, b-2, c-1, d-2; C. a-2, b-1, c-1, d-2; D. a-2, b-1, c-2, d-1; E. a-2, b-2, c-1, d-1; 1584. R.I. fiziopatologia și cauzele disfației orale și faringiene (orofaringiene), u.a.s.c.g.e.; A. disfația este produsă cel mai adesea prin leziuni musculare; B. leziunile metabolice și infecțioase sunt cele mai frecvente cauze de disfație; C. disfația mecanică este provocată de îngustarea lumenului; D. disfația motorie poate fi provocată de perturbarea efortului voluntar necesar pentru pregătirea bolului alimentar; E. disfația motorie poate fi provocată de boli neuromusculare care afectează diverse etape sau aspecte ale procesului de deglutiție; 1585. Disfația motorie poate fi provocată de boli neuromusculare care afectează u. etape/ aspecte ale procesului de deglutiție, c.g.e.; A. relaxarea SEI; B. pregătirea bolului alimentar; C. inițierea reflexului de înghițire; D. trecerea la momentul potrivit a bolului alimentar prin faringe; E. împiedicarea pătrunderii alimentelor în nas sau în laringe; 1586. R.I. clasificarea cauzelor disfației orofaringiene, f.d.u. criterii: 1. în funcție de structurile afectate; 2. în funcție de natura/ originea leziunilor; și următoarele categorii: a. de ingație (vasculare);	b. musculare; c. nervoase; d. metabolice; e. degenerative; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-2, d-2, e-2; B. a-1, b-2, c-2, d-2, e-1; C. a-2, b-1, c-1, d-2, e-2; D. a-2, b-1, c-2, d-1, e-2; E. a-2, b-2, c-1, d-1, e-2; 1587. R.I. clasificarea cauzelor disfației orofaringiene, f.d.u. criterii: 1. în funcție de structurile afectate; 2. în funcție de natura/ originea leziunilor; și următoarele categorii: a. iatrogene; b. neuroase; c. infecțioase; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-1, c-2, d-2; B. a-1, b-2, c-2, d-1; C. a-2, b-1, c-1, d-2; D. a-2, b-1, c-2, d-1; E. a-2, b-2, c-1, d-1; 1588. R.I. natura/ originea leziunilor care provoacă disfația orofaringiană, f.d.u. evaluări de incidență: 1. cele mai frecvente; 2. mai rare; și următoarele tipuri de leziuni: a. metabolice; b. infecțioase; c. degenerative; d. iatrogene; e. vasculare; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-1, d-2, e-1; B. a-2, b-1, c-1, d-1, e-2; C. a-2, b-1, c-1, d-2, e-1; D. a-2, b-1, c-2, d-1, e-1; E. a-2, b-2, c-1, d-1, e-1; 1589. R.I. mecanismele disfației orofaringiene, f.d.u. categorii: 1. disfație mecanică; 2. disfație motorie; și următoarele stări patologice: a. afecțiuni/ leziuni ale cortexului cerebral și ale trunchiului cerebral și ale trunchiului cerebral; b. îngustare intrinsecă a afecțiunilor/ leziunilor neuromusculare; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-1, c-2, d-2; B. a-1, b-2, c-2, d-2; C. a-2, b-1, c-1, d-2; D. a-2, b-1, c-2, d-1; E. a-2, b-2, c-1, d-1;	D. a-2, b-1, c-1, d-2; E. a-2, b-2, c-1, d-1; 1590. R.I. mecanismele disfației orofaringiene, f.d.u. categorii: 1. disfație mecanică orofaringiană; 2. disfație motorie orofaringiană; și următoarele stări patologice: a. afecțiuni/ leziuni musculare; b. compresie extrinsecă; c. afecțiuni/ leziuni ale nervilor cranieni (V, VII, IX, X, XII); d. defecte parietale post-chirurgicale; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-1, d-2; B. a-1, b-2, c-2, d-1; C. a-2, b-1, c-1, d-2; D. a-2, b-1, c-2, d-1; E. a-2, b-2, c-1, d-1; 1591. R.I. mecanismele disfației motorii orofaringiene, f.d.u. categorii de afecțiuni/ leziuni: 1. ale cortexului cerebral și ale trunchiului cerebral; 2. ale nervilor cranieni; 3. neuromusculare; și următoarele niveluri la care este situată patologia: a. leziuni suprabulbare; b. leziuni în nucleii din trunchiul cerebral sau pe traseectoria până la mușchi; c. perturbarea neurotransmiterii la plăcile terminale motorii; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-2, b-3, c-1; E. a-3, b-1, c-2;	1592. Nervii cranieni implicați în producerea disfației motorii orofaringiene sunt următorii, c.g.e.: A. NC3; B. NC7; C. NC9; D. NC10; E. NC12; 1593. R.I. mecanismele disfației mecanice orofaringiene, f.d.u. categorii: 1. defect parietal congenital; 2. îngustare intrinsecă inflamatoare; 3. îngustare intrinsecă tumorală; și următoarele stări patologice: a. leziuni bulboase cutanecumucoase; b. tumori benigne; c. chelioschizis (buză de iepure); care sunt asocierile corecte:	1594. R.I. mecanismele disfației mecanice orofaringiene, f.d.u. categorii: 1. defect parietal congenital; 2. îngustare intrinsecă inflamatoare; 3. îngustare intrinsecă tumorală; și următoarele stări patologice: a. palatoschizis (gură de lup); b. leziune chimică, termică; c. leziune asociată corectă: care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 1595. R.I. mecanismele disfației mecanice orofaringiene, f.d.u. categorii: 1. defect parietal congenital; 2. îngustare intrinsecă printr-o membrana; 3. compresie extrinsecă; și următoarele stări patologice: a. sindrom Plummer-Vinson; b. laringoschizis; c. abces/ formațiune tumorală retrofaringiană; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-2, b-3, c-1; E. a-3, b-2, c-1;	1596. R.I. mecanismele disfației mecanice orofaringiene, f.d.u. categorii: 1. îngustare intrinsecă inflamatoare; 2. îngustare intrinsecă prin stricturi; 3. compresie extrinsecă; și următoarele stări patologice: a. infecție virală (VHS, varicela-zoster, VCM); b. micrognație congenitală; c. diverticul Zenker; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 1597. R.I. mecanismele disfației mecanice orofaringiene, f.d.u. categorii: 1. îngustare intrinsecă prin stricturi; 2. îngustare intrinsecă prin stricturi; 3. compresie extrinsecă; și următoarele stări patologice: a. demențe, inclusiv boala Alzheimer; b. neurosifilis; c. diabet; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 1600. R.I. mecanismele disfației motorii orofaringiene, f.d.u. categorii: și următoarele stări patologice: a. toxină botulinică; b. scleroză multiplă (paralizie bulbară și pseudobulbară); c. encefalită;	1. afecțiuni/ leziuni ale cortexului cerebral și ale trunchiului cerebral cu deteriorarea conștienței sau cogniției; 2. afecțiuni/ leziuni ale cortexului cerebral și ale trunchiului cerebral cu funcții cognitive normale; 3. afecțiuni/ leziuni neuromusculare; și următoarele stări patologice: a. boală Parkinson și alte leziuni extrapiramidale; b. encefalopatie metabolică; c. sindrom Eaton-Lambert; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 1601. R.I. mecanismele disfației motorii orofaringiene, f.d.u. categorii: 1. afecțiuni/ leziuni ale cortexului cerebral și ale trunchiului cerebral cu deteriorarea conștienței sau cogniției; 2. afecțiuni/ leziuni ale cortexului cerebral și ale trunchiului cerebral cu funcții cognitive normale (pot exista anumite disfuncții); 3. afecțiuni/ leziuni neuromusculare; și următoarele stări patologice: a. boală Parkinson și alte leziuni extrapiramidale; b. encefalopatie metabolică; c. sindrom Eaton-Lambert; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 1602. R.I. mecanismele disfației motorii orofaringiene, f.d.u. categorii: 1. afecțiuni/ leziuni ale cortexului cerebral și ale trunchiului cerebral cu deteriorarea conștienței sau cogniției; 2. afecțiuni/ leziuni ale cortexului cerebral și ale trunchiului cerebral cu funcții cognitive normale; 3. afecțiuni/ leziuni neuromusculare; și următoarele stări patologice: a. toxină botulinică; b. scleroză multiplă (paralizie bulbară și pseudobulbară); c. encefalită;	1. afecțiuni/ leziuni ale cortexului cerebral și ale trunchiului cerebral cu deteriorarea conștienței sau cogniției; 2. afecțiuni/ leziuni ale cortexului cerebral și ale trunchiului cerebral cu funcții cognitive normale; 3. afecțiuni/ leziuni neuromusculare; și următoarele stări patologice: a. toxină botulinică; b. scleroză multiplă (paralizie bulbară și pseudobulbară); c. encefalită;	1. afecțiuni/ leziuni ale cortexului cerebral și ale trunchiului cerebral cu deteriorarea conștienței sau cogniției; 2. afecțiuni/ leziuni ale cortexului cerebral și ale trunchiului cerebral cu funcții cognitive normale; 3. afecțiuni/ leziuni neuromusculare; și următoarele stări patologice: a. toxină botulinică; b. scleroză multiplă (paralizie bulbară și pseudobulbară); c. encefalită;	1. afecțiuni/ leziuni ale cortexului cerebral și ale trunchiului cerebral cu deteriorarea conștienței sau cogniției; 2. afecțiuni/ leziuni ale cortexului cerebral și ale trunchiului cerebral cu funcții cognitive normale; 3. afecțiuni/ leziuni neuromusculare; și următoarele stări patologice: a. toxină botulinică; b. scleroză multiplă (paralizie bulbară și pseudobulbară); c. encefalită;
---	--	---	---	--	---	--	--	--	--

Prescurtări frecvent folosite: u. = umătoare; c.d.u. = care dintre umătoare; f.d. = fiind date; f.d.u. = fiind date umătoare; r.l. = referitor/relatate la; U.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază despre;

care sunt asocierile corecte:	deteriorarea conștienței sau cogniției;
A. a-1, b-2, c-3;	2. atelecturi/lezuni ale nervilor cranieni;
B. a-1, b-3, c-2;	3. atelecturi/lezuni musculare – miozică;
C. a-2, b-1, c-3;	și umătoarele stări patologice:
D. a-3, b-1, c-2;	a. sarcoidoză;
E. a-3, b-2, c-1;	b. meningită bazilară (infamatoare cronică, neoplazică);
1603. R.1. mecanismele distragiei motorii orofaringiene, f.d.u. categorii:	c. traumatism cerebral;
1. atelecturi/lezuni ale cortexului cerebral și ale trunchiului conștienței sau cogniției;	care sunt asocierile corecte:
2. atelecturi/lezuni ale cortexului cerebral și ale trunchiului cerebral cu funcții cognitive normale;	A. a-1, b-3, c-2;
3. atelecturi/lezuni neuromusculare, și umătoarele stări patologice:	B. a-2, b-1, c-3;
a. aminoglicozide și alte medicamente;	C. a-2, b-3, c-1;
b. meningită;	D. a-3, b-1, c-2;
c. scleroză laterală amiotrofică (boală de neuron motor);	E. a-3, b-2, c-1;
care sunt asocierile corecte:	1606. R.1. mecanismele distragiei motorii orofaringiene, f.d.u. categorii:
A. a-1, b-3, c-2;	1. atelecturi/lezuni ale nervilor cranieni;
B. a-2, b-1, c-3;	2. atelecturi/lezuni musculare – miozică;
C. a-2, b-3, c-1;	3. atelecturi/lezuni musculare – miozică primare;
D. a-3, b-1, c-2;	și umătoarele stări patologice:
E. a-3, b-2, c-1;	a. lezarea trunchiului unui nerv cranian;
1604. R.1. mecanismele distragiei motorii orofaringiene, f.d.u. categorii:	b. distrofie miotonică;
1. atelecturi/lezuni ale cortexului cerebral și ale trunchiului cerebral cu deteriorarea conștienței sau cogniției;	c. miozică mitocondrială;
2. atelecturi/lezuni ale cortexului cerebral și ale trunchiului cerebral cu funcții cognitive normale;	d. sindrom Guillain-Barre;
3. atelecturi/lezuni musculare, și umătoarele stări patologice:	care sunt asocierile corecte:
a. poliomiellită și sindrom post-poliomiellitic;	A. a-1, b-1, c-2, d-3;
b. poliomiellită dermatomiozită;	B. a-1, b-2, c-1, d-3;
c. accidente cerebrovasculare multiple (mai ales în lacunismul cerebral);	C. a-1, b-2, c-3, d-1;
care sunt asocierile corecte:	D. a-1, b-3, c-2, d-1;
A. a-1, b-2, c-3;	E. a-2, b-3, c-1, d-1;
B. a-1, b-3, c-2;	1607. R.1. mecanismele distragiei motorii orofaringiene, f.d.u. categorii:
C. a-2, b-1, c-3;	1. atelecturi/lezuni ale cortexului cerebral și ale trunchiului cerebral cu funcții cognitive normale;
D. a-2, b-3, c-1;	2. atelecturi/lezuni ale nervilor cranieni – neuropatie;
E. a-3, b-2, c-1;	3. atelecturi/lezuni musculare; și umătoarele stări patologice:
1605. R.1. mecanismele distragiei motorii orofaringiene, f.d.u. categorii:	a. paralizie cerebrală;
1. atelecturi/lezuni ale cortexului cerebral și ale trunchiului cerebral cu sau fără	b. miopatie tiroidiană;
	c. disautonomie familială;
	d. rabie;
	care sunt asocierile corecte:
	A. a-1, b-1, c-2, d-3;
	B. a-1, b-2, c-1, d-3;
	C. a-1, b-3, c-2, d-1;
	D. a-2, b-3, c-1, d-1;
	E. a-3, b-2, c-1, d-1;

Prescurtări frecvent folosite: C.E. = cu excepția; S.U.C.E. = sunt umătoarele, cu excepția; U.A.S.C.E. = umătoarele afirmații sunt corecte, cu excepția; S.C.F.C.E. = sunt corect formulate, cu excepția.

A. lateralizarea distragiei; B. faringiene înseamnă fie leziune faringiană funcțională;	D. transilul baritat evidențiază un spasm cricofaringian trezor la 55% din indivizii fără distragie;
C. fie patologice neurologice care afectează selectiv;	E. manifestările distragiei orofaringiene sunt aceleași indiferent de secțiune;
D. nucleei din trunchiul cerebral;	1616. R.1. distragia orofaringiană și la cele mai frecvente cauze ale acesteia, u.a.s.c.g.e.:
E. sau nervii cranieni ipsilateral.	A. cortexul cerebral are un rol important în funcția de înghițire și în distragie;
1612. F.d.u. evenimente R.1. mecanismul diverticulului Zenker:	B. diverticulul Zenker apare într-o zonă slabă a pereții faringian (numită dehiscența Killian);
a. în timp, se dezvoltă un diverticul de pulsune;	C. distensibilitatea redusă a cricofaringianului previne formarea unui diverticul Zenker;
b. stenoza cricofaringiană;	D. chiar dacă transilul baritat evidențiază un spasm cricofaringian, trebuie excluse alte etiologii ale distragiei;
c. creșterea presiunii în faringele inferior în timpul înghițirii;	E. distragia determinată de un accident cerebrovascular se ameliorează de obicei în timp, deși adesea nu complet;
d. deschiderea lărilor a SES;	1617. R.1. distragia orofaringiană și la cele mai frecvente cauze ale acesteia, u.a.s.c.g.e.:
care este lanțul causal corect:	A. a-1, b-2, c-3;
A. a-1, b-3, c-2;	B. a-1, b-3, c-2;
B. a-1, b-3, c-2;	C. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-1, c-3;	D. a-2, b-3, c-1;
D. a-2, b-3, c-1;	E. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;	1620. R.1. manifestările distragiei orofaringiene, f.d.u. cauze:
1609. R.1. cele mai frecvente cauze distragiei orofaringiene, f.d.u. categorii:	1. leziune unilaterală a motoneuronilor;
1. lălogene;	2. paralizie mușchilor orali;
2. neuropatie;	3. patologice care afectează și mușchii laringelui sau corzile vocale;
3. organelor;	și umătoarele manifestări:
și umătoarele cauze:	a. paralizie faringiană unilaterală;
a. afectarea structurilor orofaringiene;	b. dificultate la înghițirea înghițirii și scurgerea alimentelor din gură;
b. afectarea structurilor nervoase prin leziuni vasculare sau degenerative;	c. răgușală;
c. intervențiile chirurgicale și trachea, adesea pentru cancer localizat la cap sau gât;	care sunt asocierile corecte:
care sunt asocierile corecte:	A. a-1, b-2, c-3;
A. a-1, b-3, c-2;	B. a-1, b-3, c-2;
B. a-1, b-2, c-3;	C. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;	D. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;	E. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;	1621. R.1. distragia orofaringiană și la investigarea acesteia, u.a.s.c.g.e.:
1610. R.1. cele mai frecvente cauze distragiei orofaringiene, f.d.u. categorii:	A. transilul baritat poate fi folosit pentru investigarea tractului digestiv superior;
1. neurologice;	B. tiza orofaringiană a înghițirii nu durează mai mult de o secundă;
2. organelor;	C. fiecare lătură a faringelui este înervată de nervii contralaterali;
și umătoarele stări patologice:	D. videofaringoscopia se poate efectua numai la pacienții conștienți și cooperanți;
a. spasmul fibroza cricofaringiană;	E. la examinarea video-radioscopică se observă ateri unde de contracție faringiene;
b. scleroză laterală amiotrofică;	F. manometria poate evidenția amplitudine redusă a contracțiilor
c. accidente vasculare cerebrale;	
d. boala Parkinson;	
e. boli neoplazice;	
f. diverticul Zenker;	
care sunt asocierile corecte:	
A. a-1, b-1, c-2, d-1, e-2, f-2;	
B. a-1, b-2, c-1, d-1, e-2, f-2;	
C. a-1, b-2, c-1, d-2, e-1, f-2;	
D. a-2, b-1, c-1, d-1, e-2, f-2;	
E. a-2, b-1, c-2, d-2, e-1, f-1;	

Prescurtări frecvent folosite: U. = umătoarele; C.d.u. = care dintre umătoarele; f.d. = fiind date; f.d.u. = fiind date umătoarele; R.1. = referință/referințare la; U.d.f.d. = umătoarele fragmente dintr-o frază despre.

- produce disfație decât leziunile care afectează doar o porțiune din circumferința peretelui esofagian;
- 1622. R.I.** disfația orofaringiană și la investigația acesteia, u.a.s.c.g.e.;
- A. paralizarea mușchilor suprahioidieni produce disfație ușoară;
- B. pentru detectarea și analizarea anomaliilor funcției orale și faringiene este necesară video-radioscopia cu secvențializare rapidă;
- C. investigarea videoradioscopică a deglutiției folosind bari de diverse consistențe poate evidenția dificultăți în faza orală a deglutiției;
- D. la examinarea videoradioscopică se observă atenționarea deschiderii SES la înghițire;
- E. manometria poate evidenția presunele SES reduse, care nu scade suplimentar la înghițire;
- 1623. R.I.** disfația orofaringiană, la examinarea videoradioscopică a faringelui se pot detecta următoarele anomalii, c.g.e.:
- A. staza bariului în valeculă și în sinusurile piriforme;
- B. regurgitarea bariului în nas;
- C. aspirația bariului în arborele traheobronhic;
- D. deschiderea deficitară a SES;
- E. mișcarea anormală a mandibulei și a laringelui în timpul înghițirii;
- 1624. R.I.** disfația esofagiană, u.a.s.c.g.e.;
- A. la adult, lumenul esofagian se poate destinde până la 4 cm în diametru;
- B. disfația este întotdeauna prezentă când esofagul nu se poate destinde mai mult de 1,3 cm;
- C. leziunile musculaturii stinate esofagiene afectează porțiunea abdominală a esofagului;
- D. lipsa de relaxare a SEI poate duce, în timp, la dispația peristaltismului;
- E. disfația determinată de dispația inervației inhibitoare este asociată cu BRGE;
- 1625. R.I.** disfația esofagiană, u.a.s.c.g.e.;
- A. când esofagul nu se poate dilata mai mult de 2,5 cm în diametru, poate să apară disfație pentru alimentele solide normale;
- B. leziunile circumferențiale au o probabilitate mai mică de a produce disfație decât leziunile din circumferința peretelui esofagian;
- C. leziunile musculaturii striate esofagiene afectează și mușchii orofaringieni;
- D. disfația determinată de slăbiciunea mușchilor esofagieni este adesea asociată cu simptome de BRGE;
- E. disfația determinată de dispația inervației inhibitoare poate fi asociată cu durere în piept;
- 1626. R.I.** cauzele disfației esofagiene, u.a.s.c.g.e.:
- A. carcinomul este una dintre cele mai frecvente cauze ale disfației esofagiene;
- B. slăbiciunea contracției musculare poate fi provocată de slăbiciunea musculară (ca în scleroză sistemică);
- C. spasmul esofagian difuz este produs de perturbarea inervației inhibitoare numai pentru SEI;
- D. disfația motorie esofagiană poate fi provocată de anomalii de peristaltism;
- E. manifestările clinice ale afecțiunilor esofagului cervical sunt de obicei eclipsate de cele ale disfației orofaringiene;
- 1627. R.I.** cauzele disfației esofagiene, u.a.s.c.g.e.:
- A. stricturnile benigne (peptice, caustice) sunt cauze rare ale disfației esofagiene;
- B. slăbiciunea contracției musculare poate fi provocată de perturbarea efectului colinergic;
- C. acalazia este produsă de perturbarea inervației inhibitoare atât pentru corpul esofagian, cât și pentru SEI;
- D. disfația motorie esofagiană poate fi provocată de inhibarea deglutiției determinată de boli ale musculaturii striate sau netede esofagiene;
- E. bolile segmentului esofagian cu musculatură netedă afectează porțiunea toracică a esofagului și SEI;
- F. miopatia viscerelor cavitare este o miopatie congenitală care afectează tubul digestiv și vezica urinară;
- 1628. R.I.** cauzele disfației esofagiene, u.a.s.c.g.e.:
- A. a-1, b-3, c-2;
- B. a-2, b-1, c-3;

- C. a-2, b-3, c-1;
- D. a-3, b-1, c-2;
- E. a-3, b-2, c-1;
- 1632. R.I.** cauzele disfației mecanice esofagiene, f.d.u. categorii:
1. îngustare intrinsecă prin stricturni benigne;
2. defect parietal;
3. îngustare intrinsecă prin membrane și inele;
3. îngustare intrinsecă prin stricturni benigne;
- și următoarele stări patologice:
- a. fistula traheo-esofagiană;
- b. sechela post-iradiere;
- c. boala gâtă-contragrefă;
- care sunt asociate corecte:
- A. a-1, b-3, c-2;
- B. a-2, b-1, c-3;
- C. a-2, b-3, c-1;
- D. a-3, b-1, c-2;
- E. a-3, b-2, c-1;
- 1633. R.I.** cauzele disfației mecanice esofagiene, f.d.u. categorii:
1. îngustare intrinsecă prin esofagită inflamatorie;
2. îngustare intrinsecă prin stricturni benigne;
3. compresie extrinsecă prin structuri cardiovasculare;
- și următoarele stări patologice:
- a. infecție fungică (Candida);
- b. sechela după leziuni caustice;
- c. arteră subclavie dreaptă abetanată;
- care sunt asociate corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
- B. a-1, b-3, c-2;
- C. a-2, b-3, c-1;
- D. a-2, b-3, c-1;
- E. a-3, b-1, c-2;
- 1634. R.I.** cauzele disfației mecanice esofagiene, f.d.u. categorii:
1. îngustare intrinsecă prin esofagită inflamatorie;
2. îngustare intrinsecă prin stricturni benigne;
3. compresie extrinsecă prin structuri cardiovasculare;
- și următoarele stări patologice:
- a. dextropoziția arcului aortic;
- b. efect advers medicamentos;
- c. boli bulboase cutanemucoase;
- care sunt asociate corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
- B. a-1, b-3, c-2;
- C. a-2, b-3, c-1;
- D. a-3, b-1, c-2;
- E. a-3, b-2, c-1;
- 1637. R.I.** cauzele disfației mecanice esofagiene, f.d.u. categorii:
1. îngustare intrinsecă prin esofagită inflamatorie;
2. îngustare intrinsecă prin stricturni benigne;
3. compresie extrinsecă prin structuri cardiovasculare;
- și următoarele stări patologice:
- a. dextropoziția arcului aortic;
- b. efect advers medicamentos;
- c. boli bulboase cutanemucoase;
- care sunt asociate corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
- B. a-1, b-3, c-2;
- C. a-2, b-3, c-1;
- D. a-3, b-1, c-2;
- E. a-3, b-2, c-1;
- 1638. R.I.** cauzele disfației mecanice esofagiene, f.d.u. categorii:
1. îngustare intrinsecă prin membrane și inele;
2. îngustare intrinsecă prin stricturni benigne;
3. compresie extrinsecă, și următoarele stări patologice:
- a. hematom și fibroză după vagotomie;
- b. sechela după leziune ischemică;
- c. inel de mucoasă esofagiană inferioară (inel Schatzki);
- care sunt asociate corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
- B. a-1, b-3, c-2;
- C. a-2, b-1, c-3;
- D. a-2, b-3, c-1;
- E. a-3, b-2, c-1;
- 1639. R.I.** cauzele disfației mecanice esofagiene, f.d.u. cauze de îngustare intrinsecă:
1. esofagită inflamatorie;
2. membrane și inele;
3. stricturni benigne;
- și următoarele stări patologice:
- a. afecțiuni cutanemucoase;
- b. anomalie congenitală;
- c. vroză (VHS, varicela-zoster, VCM);
- care sunt asociate corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
- B. a-1, b-3, c-2;
- C. a-2, b-1, c-3;
- D. a-2, b-3, c-1;
- E. a-3, b-2, c-1;
- 1640. R.I.** cauzele disfației mecanice esofagiene, f.d.u. cauze de îngustare intrinsecă:
1. esofagită inflamatorie;
2. stricturni benigne;
3. neoplazie;
- și următoarele stări patologice:
- a. tumori benigne sau maligne;
- b. infecție bacteriană;
- c. sechela după leziuni peptice;
- care sunt asociate corecte:
- A. a-1, b-3, c-2;
- B. a-2, b-1, c-3;
- C. a-2, b-3, c-1;
- D. a-3, b-1, c-2;
- E. a-3, b-2, c-1;
- 1641. R.I.** cauzele disfației motorii esofagiene, f.d.u. categorii:
1. boli ale musculaturii netede sau ale nervilor excitatori – contracție musculară slabă sau tonus scăzut al SEI;
2. tulburări latrogene ale musculaturii netede sau ale

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele; r.i. = referitor/la; u.i.d. = următoarele fragmente dintr-o frază desprse.

Prescurtări frecvent folosite: c.g.e. = cu excepția; s.u.c.g.e. = sunt următoarele, cu excepția; u.a.s.c.g.e. = următoarele afirmații sunt corecte, cu excepția; s.c.i.c.g.e. = sunt corect formulate, cu excepția.

nevroiz excitatori – contracție musculară slabă sau tonus scăzut al SEI;

3. boii ale muscularității netede sau ale nervilor excitatori – contracție musculară amplificată;

și următoarele stări patologice:

a. SEI hipertonic, contracții excesive ale SEI;

b. neuromiopatie metabolică; c. medicamente anticolinergice; care sunt asocierile corecte:

A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1.

1642. R.1. cauzele distrofiei motorii esofagiene, i.d.u. categorii:

1. boii ale muscularității netede sau ale nervilor excitatori – contracție musculară slabă sau tonus scăzut al SEI;

3. afectiuni ale inervației inhibitoare;

și următoarele stări patologice:

a. scleroză sistemică (și boii autoimune înrudiți);
b. neuromiopatie amiloidotică; c. spasm esofagian difuz; d. medicamente relaxante ale muscularității netede;

care sunt asocierile corecte:

A. a-1, b-1, c-3, d-2;
B. a-1, b-2, c-3, d-1;
C. a-1, b-3, c-1, d-2;
D. a-1, b-3, c-2, d-1;
E. a-3, b-1, c-1, d-2.

1643. R.1. cauzele distrofiei motorii esofagiene, i.d.u. categorii:

1. boii ale muscularității netede sau ale nervilor excitatori – contracție musculară slabă sau tonus scăzut al SEI;

2. boii ale muscularității netede sau ale nervilor excitatori – contracție musculară excesivă;

3. afectiuni ale inervației inhibitoare;

și următoarele stări patologice:

a. peristaltism hipertensiv;
b. neuromiopatie etanolică; c. miopatia viscerelor cavitare; d. acalazie;

care sunt asocierile corecte:

A. a-1, b-3, c-1, d-2;
B. a-2, b-1, c-1, d-3;
C. a-3, b-1, c-1, d-2;
D. a-3, b-1, c-2, d-1;
E. a-3, b-2, c-1, d-2.

1644. R.1. cauzele distrofiei motorii esofagiene, i.d.u. categorii:

1. boii ale muscularității netede sau ale nervilor excitatori – contracție musculară slabă sau tonus scăzut al SEI;

2. boii ale muscularității netede sau ale nervilor excitatori – contracție musculară excesivă;

3. afectiuni ale inervației inhibitoare;

și următoarele stări patologice:

a. neuromiopatie diabetică;
b. inel esofagian inferior contractil (muscular);

c. distrofie miotonică;
d. esofag spărgător de nucii; care sunt asocierile corecte:

A. a-1, b-1, c-2, d-3;
B. a-1, b-2, c-1, d-3;
C. a-1, b-2, c-3, d-1;
D. a-1, b-3, c-1, d-2;
E. a-3, b-1, c-1, d-2.

1645. R.1. rolul istoricului la un pacient cu distrofie, u.a.s.c.g.e.

A. sediul distrofiei, desicis de pacient ajută la determinarea localizării obstrucției esofagiene;
B. leziunea esofagiană este la nivelul sau deasupra localizării pericute a distrofiei;

C. germeni, oportuniști care pot provoca esofagită la pacienții cu imunodeficiență sunt streptococi și pneumococi;

D. sarcomul Kaposi este una dintre neoplazii care pot provoca distrofie în mod caracteristic la pacienții cu SIDA;

E. sughițul poate să apară (rareori) în asocierie cu leziuni esofagiene proximale;

1646. U.i.d.f.d. rolul istoricului la un pacient cu distrofie s.c.f.g.e.

A. indică diagnosticul important pe care îl furnizează;
B. de manifestări asociate;
C. de cantitatea de alimente;
D. care provoacă distrofia și de;

E. evoluția în timp a distrofiei.

1647. R.1. rolul istoricului la un pacient cu distrofie, u.a.s.c.g.e.

A. istoricul are de obicei utilitate redusă;

B. la pacienții cu imunodeficiență, trebuie avut în vedere aflarea esofagiului prin tubații funcționale;

C. printre neoplazii care pot provoca distrofie în mod caracteristic la pacienții cu SIDA se află neurozoamele;

D. scăderea în greutate severă, disproporționată față de gradul distrofiei, este un contra-argument pentru diagnosticul de carcinom;

E. în scleroza sistemică, lichidele provocă distrofie mai ales când pacientul este în poziție ridicată.

1648. Elemente anamnestice sugestive pentru cauza structurală esofagiene s.u.c.g.e.

A. intrabaile nazogastrice prelungite;

B. ingestie de substanțe de contrast radiologice;

C. ingestia unei cantități excesive de apă la administrarea medicației;

D. radioterapie anterioară;

E. boii cianomucocase asociate.

1649. R.1. felul în care istoricul poate ajuta diagnosticul etiologic al distrofiei, i.d.u. manifestări asociate:

1. regurgitarea nazală la înghițire;

2. simptome laringiene;

3. dureri în piept;

și următoarele stări patologice:

a. spasm esofagian difuz;
b. diverse afectiuni neuromusculare;

c. paralizie faringiană;

care sunt asocierile corecte:

A. a-1, b-3, c-2;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1.

1650. R.1. felul în care istoricul poate ajuta diagnosticul etiologic al distrofiei, i.d.u. manifestări asociate:

1. aspirația traheobronșică la înghițire;

2. distonie precedând distrofia;

3. dureri în piept;

și următoarele stări patologice:

a. fisulă traheo-esofagiană;

b. tulburări motorii esofagiene cu hipertonie;

c. atelectazie laringiană;

care sunt asocierile corecte:

A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1.

1651. R.1. felul în care istoricul poate ajuta diagnosticul etiologic

al distalgiei, f.d.u. manifestan asociate: 1. aspiratie traheobronșică 2. nelegăta de înghițire, 3. răsgeșea 4. răsgeșea apărută după distagie; 3. durere în piept; - și următoarele stări patologice: a. bol alimentar (prea mare blocând esofagiul; b. afectarea nervului laringian recurent prin extinderea unui carcinom esofagian; c. acalazie; - care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-2, b-3, c-1; E. a-3, b-2, c-1; 1652. R.1. felul în care istoricul poate ajuta diagnosticul etiologic al distalgiei, f.d.u. manifestări asociate: 1. aspiratie traheobronșică 2. nelegăta de înghițire; 2. răsgeșea; 3. prozoz și reflux precedând cu mult timp instalarea distalgiei; - și următoarele stări patologice: a. diverticul Zenker; b. laringia produsă de refluxul gastroesofagian; c. stricțură peptică; - care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 1653. R.1. felul în care istoricul poate ajuta diagnosticul etiologic al distalgiei, f.d.u. manifestan asociate: 1. aspiratie traheobronșică 2. nelegăta de înghițire; 2. sughiț; 3. odinofagie; - și următoarele stări patologice: a. reflux gastroesofagian; b. leziune esofagiană distală; c. esofagiită infecțioasă (candidozică, herpetică) sau medicamentosă; - care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 1654. R.1. felul în care istoricul poate ajuta diagnosticul etiologic	al distalgiei, f.d.u. manifestări asociate: 1. răsgeșea; 2. scăderea în greutate severă, disproporționată față de gradul distalgiei; 3. raluri suferitoare unilaterale; - și următoarele stări patologice: a. carcinom; b. formațiune tumorală mediastinală afectând esofagul și o bronhie mare; c. afectiuni neuromusculare; - care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 1655. R.1. utilitatea tipului de alimente care provoacă distagie în punerea diagnosticului, f.d.u. variante: 1. numai solide; 2. și lichide, nu doar solide; 3. în egală măsură solide și lichide chiar de la început; - și următoarele diagnostice: a. distagie mecanică cu tumen care nu este îngustat sever; b. obstrucție avansată; c. distagie motorie determinată de acalazie; - care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-2, b-3, c-1; E. a-3, b-1, c-2; 1656. R.1. utilitatea tipului de alimente care provoacă distagie în punerea diagnosticului, f.d.u. variante: 1. numai solide; 2. solide independent de poziția pacientului, iar lichidele doar în decubi dorsal; 3. în egală măsură solide și lichide chiar de la început; - și următoarele diagnostice: a. distagie mecanică prin îngustarea ușoară-moderată a lumenului; b. distagie motorie determinată de SED; c. scleroză sistemică; - care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;	1657. R.1. utilitatea duratei și a evoluției distalgiei în punerea diagnosticului, f.d.u. variante: 1. lent progresivă, devenind brădat mai persistentă; 2. recădere; 3. episodică pentru solide, dădând de călăa anti; - și următoarele diagnostice: a. afectiune esofagiană benignă; b. stricțură peptică, de exemplu la pacienți cu scleroză sistemică; c. proces inflamator; - care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-3, c-2; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 1658. R.1. utilitatea duratei și a evoluției distalgiei în punerea diagnosticului, f.d.u. variante: 1. lent progresivă, devenind brădat mai persistentă; 2. progresivă, dădând de călăa săptămânii sau luni; 3. episodică pentru solide, dădând de călăa anti; - și următoarele diagnostice: a. stricțură peptică, secetă a esofagiului de reflux; b. ine esofagian inferior; c. carcinom esofagian; - care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-3, c-2; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 1659. R.1. rolul examenului fizic în evaluarea unui pacient cu distagie, f.d.u. tipuri de distagie: 1. distagia orală și faringiană; 2. distagia esofagiană; - și următoarele caracteristici: a. examenul fizic este important; b. afectiunile cele mai relevante sunt limitate la esofag; c. examinarea nodurilor limfatici și a ficatului poate evidenția eventualele metastaze; d. distagia este de obicei una dintre manifestările unei afectiuni mai extinse; e. examenul fizic este mai puțin util; - care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-2, d-1, e-2; B. a-1, b-2, c-2, d-2, e-1; C. a-2, b-1, c-2, d-1, e-2; D. a-2, b-1, c-2, d-2, e-1; E. a-2, b-2, c-1, d-2, e-1;
---	---	---

1660. R.I. rolul examenului fizic în evaluarea unui pacient cu disfagie orală sau faringiană, u.a.s.c.g.e.
 A. trebuie căutate semne de paraliză facială;
 B. trebuie căutate semne de boală neuromusculară generalizată;
 C. inspecția gâtului poate evidenția mărirea tiroidei sau anomalii ale coloanei vertebrale;
 D. inspecția gurii și a faringelui poate demonstra leziuni care împiedică trecerea alimentelor;
 E. pot fi prezente complicații pulmonare cum ar fi pneumonia de aspirație acută sau cronică;
1661. Bolii sau categorii de boli care pot afecta esofagul și pe care le poate sugera s.u.c.e.
 A. scleroză sistemică;
 B. boli autoimune de țesut conjunctiv;
 C. tulburări motorii esofagiene cu hipertonie;
 D. permiogidul;
 E. epidemoliza buloasă;
1662. Semne de paraliză bulbară sau pseudobulbară s.u.c.e.
 A. dizartrie;
 B. disfonie;
 C. pluză;
 D. hipertrofia limbii;
 E. diminuarea reflexului maseterian (mandibular);
1663. U.f.d.f.d. investigarea disfagiei s.c.f.c.e.
 A. investigarea disfagiei este importantă deoarece;
 B. este principalul simptom al unor afecțiuni neoplazice;
 C. și chiar dacă nu are o cauză neoplazică;
 D. este de obicei manifestarea;
 E. unei boli pentru care nu există tratament;
1664. R.I. evaluarea unui pacient cu disfagie, u.a.s.c.g.e.
 A. în majoritatea cazurilor, disfagia este provocată de o afecțiune benignă;
 B. dacă datele de istoric sugerează disfagie esofagiană mecanică, cea mai utilă investigație este radiografia baritată;
 C. EDS permite prelevarea de biopsii de mucoasă;
 D. dacă există o suspiciune de tulburare motorie esofagiană, se efectuează manometrie esofagiană;
 A. Intrucât esofagita eozinofilică;
 1. intraperitoneale;
 B. este o cauză tot mai rară de disfagie la adulți se recomandă;
 C. ca evaluarea disfagiei inexplicabile să includă;
 D. prelevarea de rutină a biopsiilor din mucoasa esofagiană;
 E. chiar dacă nu se observă endoscopic leziuni evidente;
1669. U.f.d.f.d. evaluarea unui pacient cu disfagie s.c.f.c.e.
 A. Dacă istoricul sugerează disfagie esofagiană motorie;
 B. principala investigație este manometria esofagiană;
 C. deoarece afecțiunile neoplazice și inflamatoare;
 D. pot induce modificări de tip:
 E. accelerează sau spasm esofagian.

Greață și vărsături

1670. F.d. greață, vărsături și simptomele de care acestea trebuie diferențiate (loate, simptome reflectând inversarea direcției tranzitului oro-esogastric):
 1. greață;
 2. vărsături (emeză);
 3. regurgitare;
 4. tuminăție;
 și următoarele stări patologice:
 a. regurgitarea repetată a conținutului stomacului, care poate fi remestecat și reînghițit, fenomen în care intervine și un control voluntar, absent în cazul vărsăturilor;
 b. trecerea fără efort a conținutului gastric în gură;
 c. senzație subiectivă reflectând nevoia de a vomita;
 d. expulzarea orală a conținutului gastrointestinal ca urmare a contracțiilor musculaturii tubului digestiv și a peretelui toracoabdominal;
 care sunt asociatele corecte:
 A. a-1, b-3, c-2, d-4;
 B. a-2, b-1, c-4, d-3;
 C. a-2, b-3, c-1, d-4;
 D. a-2, b-4, c-1, d-3;
 E. a-4, b-3, c-1, d-2;
1671. C.d.u. are probabilitatea cea mai mică de a provoca greață și vărsături:
 A. afecțiuni digestive;
 B. afecțiuni extradigestive;
 C. medicamente;
 D. toxine circulante;
 E. agenți prokinetici;
1672. R.I. cauze de greață și vărsături, f.d.u. categorii:
 1. intraperitoneale;
 2. extraperitoneale;
 și următoarele stări patologice:
 a. afectarea urechii interne;
 b. iradiere abdominală;
 c. boli psihiatrice;
 d. medicație;
 e. inflamații ale organelor digestive;
 care sunt asociatele corecte:
 A. a-1, b-2, c-2, d-1, e-2;
 B. a-1, b-2, c-2, d-2, e-1;
 C. a-2, b-1, c-2, d-1, e-2;
 D. a-2, b-1, c-2, d-2, e-1;
 E. a-2, b-2, c-1, d-1, e-2;
1675. R.I. cauzele intraperitoneale de greață și vărsături, f.d.u. categorii:
 1. afecțiuni obstrucțive;
 2. afecțiuni inflamatoare;
 3. perturbarea funcției senzomotorii;
 și următoarele stări patologice:
 a. obstrucție pilorică;
 b. vărsături funcționale;
 c. pseudooobstrucție intestinală;
 d. pancreatită;
 care sunt asociatele corecte:
 A. a-1, b-3, c-2, d-3;
 B. a-2, b-3, c-1, d-3;
 C. a-2, b-3, c-1, d-4;
 D. a-2, b-3, c-1, d-4;
 E. a-4, b-3, c-1, d-2;
1676. R.I. cauzele intraperitoneale de greață și vărsături, f.d.u. categorii:
 1. afecțiuni obstrucțive;
 2. afecțiuni inflamatoare;
 3. perturbarea funcției senzomotorii;
 și următoarele stări patologice:
 a. ocluzie intestinală (înaltă, joasă);
 b. dispepsie funcțională;
 c. sindromul vărsăturilor ciclice;
 d. gastropareză;
 e. apendicită;
 care sunt asociatele corecte:
 A. a-1, b-3, c-3, d-3, e-2;
 B. a-2, b-3, c-3, d-1, e-3;
 C. a-3, b-3, c-1, d-2, e-3;
 D. a-3, b-3, c-3, d-1, e-2;
 E. a-3, b-3, c-3, d-2, e-1;
1677. R.I. cauzele intraperitoneale de greață și vărsături, f.d.u. categorii:
 1. afecțiuni obstrucțive;
 2. afecțiuni inflamatoare;
 3. perturbarea funcției senzomotorii;
 și următoarele stări patologice:
 a. hepatită;
 b. reflux gastroesofagian;
 c. sindrom de arteră mezenterică superioară;
 d. colecistită;
 e. greață cronică idiopatică;
 care sunt asociatele corecte:
 A. a-2, b-3, c-1, d-2, e-3;
 B. a-2, b-3, c-2, d-1, e-3;
 C. a-3, b-2, c-2, d-1, e-3;
 D. a-3, b-2, c-3, d-2, e-1;
 E. a-3, b-3, c-1, d-2, e-2;
1678. R.I. cauzele intraperitoneale de greață și vărsături prin perturbarea funcției senzomotorii a tubului digestiv, f.d.u. categorii:
 1. afecțiuni organice;
 2. tulburări funcționale în care greața/vărsăturile pot să apară, fără a fi caracteristice;
 3. tulburări funcționale în care greața/vărsăturile sunt principalul simptom;
 și următoarele stări patologice:
 a. greață idiopatică cronică;
 b. gastropareză;
 c. dispepsia funcțională;
 care sunt asociatele corecte:
 A. a-1, b-2, c-3;
 B. a-1, b-3, c-2;
 C. a-2, b-1, c-3;
 D. a-2, b-3, c-1;
 E. a-3, b-2, c-1;
1681. R.I. afecțiunile intraperitoneale care provoacă greață și vărsături, u.a.s.c.g.e.
 A. vărsăturile pot fi principalul simptom în afecțiunile obstrucțiv și inflamatoare ale viscerelor cavitare și solide;
 B. este o cauză tot mai rară de disfagie la adulți se recomandă;
 C. ca evaluarea disfagiei inexplicabile să includă;
 D. prelevarea de rutină a biopsiilor din mucoasa esofagiană;
 E. chiar dacă nu se observă endoscopic leziuni evidente;
1669. U.f.d.f.d. evaluarea unui pacient cu disfagie s.c.f.c.e.
 A. Dacă istoricul sugerează disfagie esofagiană motorie;
 B. principala investigație este manometria esofagiană;
 C. deoarece afecțiunile neoplazice și inflamatoare;
 D. pot induce modificări de tip:
 E. accelerează sau spasm esofagian.

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dăre următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, r.i. = referențelor folosite la; U.f.d.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază despre;

2. extraperitoneale;
 și următoarele stări patologice:
 a. vărsături postoperatorii;
 b. afecțiuni obstrucțive ale tubului digestiv;
 c. afecțiuni intracerebrale;
 d. afecțiuni endocrine/metabolice;
 e. perturbarea funcției senzomotorii digestive;
 care sunt asociatele corecte:
 A. a-1, b-3, c-2, d-3;
 B. a-1, b-2, c-3, d-3;
 C. a-2, b-3, c-1, d-3;
 D. a-2, b-3, c-3, d-1;
 E. a-3, b-3, c-1, d-2;
1676. R.I. cauzele intraperitoneale de greață și vărsături, f.d.u. categorii:
 1. afecțiuni obstrucțive;
 2. afecțiuni inflamatoare;
 3. perturbarea funcției senzomotorii;
 și următoarele stări patologice:
 a. ocluzie intestinală (înaltă, joasă);
 b. dispepsie funcțională;
 c. sindromul vărsăturilor ciclice;
 d. gastropareză;
 e. apendicită;
 care sunt asociatele corecte:
 A. a-1, b-3, c-3, d-3, e-2;
 B. a-2, b-3, c-3, d-1, e-3;
 C. a-3, b-3, c-1, d-2, e-3;
 D. a-3, b-3, c-3, d-1, e-2;
 E. a-3, b-3, c-3, d-2, e-1;
1677. R.I. cauzele intraperitoneale de greață și vărsături, f.d.u. categorii:
 1. afecțiuni obstrucțive;
 2. afecțiuni inflamatoare;
 3. perturbarea funcției senzomotorii;
 și următoarele stări patologice:
 a. hepatită;
 b. reflux gastroesofagian;
 c. sindrom de arteră mezenterică superioară;
 d. colecistită;
 e. greață cronică idiopatică;
 care sunt asociatele corecte:
 A. a-2, b-3, c-1, d-2, e-3;
 B. a-2, b-3, c-2, d-1, e-3;
 C. a-3, b-2, c-2, d-1, e-3;
 D. a-3, b-2, c-3, d-2, e-1;
 E. a-3, b-3, c-1, d-2, e-2;
1678. R.I. cauzele intraperitoneale de greață și vărsături prin perturbarea funcției senzomotorii a tubului digestiv, f.d.u. categorii:
 1. afecțiuni organice;
 2. tulburări funcționale în care greața/vărsăturile pot să apară, fără a fi caracteristice;
 3. tulburări funcționale în care greața/vărsăturile sunt principalul simptom;
 și următoarele stări patologice:
 a. greață idiopatică cronică;
 b. gastropareză;
 c. dispepsia funcțională;

1679. R.I. cauzele intraperitoneale de greață și vărsături prin perturbarea funcției senzomotorii a tubului digestiv, f.d.u. categorii:
 1. afecțiuni organice;
 2. tulburări funcționale în care greața/vărsăturile pot să apară, fără a fi caracteristice;
 3. tulburări funcționale în care greața/vărsăturile sunt principalul simptom;
 și următoarele stări patologice:
 a. sindromul de intestin iritabil;
 b. pseudooobstrucție intestinală;
 c. vărsăturile funcționale;
 care sunt asociatele corecte:
 A. a-1, b-2, c-3;
 B. a-1, b-3, c-2;
 C. a-2, b-1, c-3;
 D. a-3, b-1, c-2;
 E. a-3, b-2, c-1;

1680. F.d.u. tulburări funcționale care provoacă greață și vărsături prin perturbarea funcției senzomotorii:
 1. greață idiopatică cronică;
 2. vărsăturile funcționale;
 3. sindromul vărsăturilor ciclice;
 și următoarele trăsături:
 a. greață fără vărsături care survine de câteva ori pe săptămână;
 b. unul sau mai multe episoade de vărsături pe săptămână în absența unei tulburări de alimentație sau a unei boli psihiatrice;
 c. apariția periodică a unor episoade bine demarcate de greață și vărsături incoercibile;
 care sunt asociatele corecte:
 A. a-1, b-2, c-3;
 B. a-1, b-3, c-2;
 C. a-2, b-1, c-3;
 D. a-2, b-3, c-1;
 E. a-3, b-2, c-1;

1681. R.I. afecțiunile intraperitoneale care provoacă greață și vărsături, u.a.s.c.g.e.
 A. vărsăturile pot fi principalul simptom în afecțiunile obstrucțiv și inflamatoare ale viscerelor cavitare și solide;
 B. este o cauză tot mai rară de disfagie la adulți se recomandă;
 C. ca evaluarea disfagiei inexplicabile să includă;
 D. prelevarea de rutină a biopsiilor din mucoasa esofagiană;
 E. chiar dacă nu se observă endoscopic leziuni evidente;

1669. U.f.d.f.d. evaluarea unui pacient cu disfagie s.c.f.c.e.
 A. Dacă istoricul sugerează disfagie esofagiană motorie;
 B. principala investigație este manometria esofagiană;
 C. deoarece afecțiunile neoplazice și inflamatoare;
 D. pot induce modificări de tip:
 E. accelerează sau spasm esofagian.

1670. F.d. greață, vărsături și simptomele de care acestea trebuie diferențiate (loate, simptome reflectând inversarea direcției tranzitului oro-esogastric):
 1. greață;
 2. vărsături (emeză);
 3. regurgitare;
 4. tuminăție;
 și următoarele stări patologice:
 a. regurgitarea repetată a conținutului stomacului, care poate fi remestecat și reînghițit, fenomen în care intervine și un control voluntar, absent în cazul vărsăturilor;
 b. trecerea fără efort a conținutului gastric în gură;
 c. senzație subiectivă reflectând nevoia de a vomita;
 d. expulzarea orală a conținutului gastrointestinal ca urmare a contracțiilor musculaturii tubului digestiv și a peretelui toracoabdominal;
 care sunt asociatele corecte:
 A. a-1, b-3, c-2, d-4;
 B. a-2, b-3, c-1, d-3;
 C. a-2, b-3, c-1, d-4;
 D. a-2, b-4, c-1, d-3;
 E. a-4, b-3, c-1, d-2;

1671. C.d.u. are probabilitatea cea mai mică de a provoca greață și vărsături:
 A. afecțiuni digestive;
 B. afecțiuni extradigestive;
 C. medicamente;
 D. toxine circulante;
 E. agenți prokinetici;

1672. R.I. cauze de greață și vărsături, f.d.u. categorii:
 1. intraperitoneale;
 2. extraperitoneale;
 și următoarele stări patologice:
 a. afectarea urechii interne;
 b. iradiere abdominală;
 c. boli psihiatrice;
 d. medicație;
 e. inflamații ale organelor digestive;
 care sunt asociatele corecte:
 A. a-1, b-2, c-2, d-1, e-2;
 B. a-1, b-2, c-2, d-2, e-1;
 C. a-2, b-1, c-2, d-1, e-2;
 D. a-2, b-1, c-2, d-2, e-1;
 E. a-2, b-2, c-1, d-1, e-2;

1675. R.I. cauzele intraperitoneale de greață și vărsături, f.d.u. categorii:
 1. afecțiuni obstrucțive;
 2. afecțiuni inflamatoare;
 3. perturbarea funcției senzomotorii;
 și următoarele stări patologice:
 a. obstrucție pilorică;
 b. vărsături funcționale;
 c. pseudooobstrucție intestinală;
 d. pancreatită;
 care sunt asociatele corecte:
 A. a-1, b-3, c-2, d-3;
 B. a-2, b-3, c-1, d-3;
 C. a-2, b-3, c-1, d-4;
 D. a-2, b-3, c-1, d-4;
 E. a-4, b-3, c-1, d-2;

1676. R.I. cauzele intraperitoneale de greață și vărsături, f.d.u. categorii:
 1. afecțiuni obstrucțive;
 2. afecțiuni inflamatoare;
 3. perturbarea funcției senzomotorii;
 și următoarele stări patologice:
 a. ocluzie intestinală (înaltă, joasă);
 b. dispepsie funcțională;
 c. sindromul vărsăturilor ciclice;
 d. gastropareză;
 e. apendicită;
 care sunt asociatele corecte:
 A. a-1, b-3, c-3, d-3, e-2;
 B. a-2, b-3, c-3, d-1, e-3;
 C. a-3, b-3, c-1, d-2, e-3;
 D. a-3, b-3, c-3, d-1, e-2;
 E. a-3, b-3, c-3, d-2, e-1;

1677. R.I. cauzele intraperitoneale de greață și vărsături, f.d.u. categorii:
 1. afecțiuni obstrucțive;
 2. afecțiuni inflamatoare;
 3. perturbarea funcției senzomotorii;
 și următoarele stări patologice:
 a. hepatită;
 b. reflux gastroesofagian;
 c. sindrom de arteră mezenterică superioară;
 d. colecistită;
 e. greață cronică idiopatică;
 care sunt asociatele corecte:
 A. a-2, b-3, c-1, d-2, e-3;
 B. a-2, b-3, c-2, d-1, e-3;
 C. a-3, b-2, c-2, d-1, e-3;
 D. a-3, b-2, c-3, d-2, e-1;
 E. a-3, b-3, c-1, d-2, e-2;

1678. R.I. cauzele intraperitoneale de greață și vărsături prin perturbarea funcției senzomotorii a tubului digestiv, f.d.u. categorii:
 1. afecțiuni organice;
 2. tulburări funcționale în care greața/vărsăturile pot să apară, fără a fi caracteristice;
 3. tulburări funcționale în care greața/vărsăturile sunt principalul simptom;
 și următoarele stări patologice:
 a. greață idiopatică cronică;
 b. gastropareză;
 c. dispepsia funcțională;

1679. R.I. cauzele intraperitoneale de greață și vărsături, f.d.u. categorii:
 1. afecțiuni obstrucțive;
 2. afecțiuni inflamatoare;
 3. perturbarea funcției senzomotorii;
 și următoarele stări patologice:
 a. ocluzie intestinală (înaltă, joasă);
 b. dispepsie funcțională;
 c. sindromul vărsăturilor ciclice;
 d. gastropareză;
 e. apendicită;
 care sunt asociatele corecte:
 A. a-1, b-3, c-3, d-3, e-2;
 B. a-2, b-3, c-3, d-1, e-3;
 C. a-3, b-3, c-1, d-2, e-3;
 D. a-3, b-3, c-3, d-1, e-2;
 E. a-3, b-3, c-3, d-2, e-1;

1677. R.I. cauzele intraperitoneale de greață și vărsături, f.d.u. categorii:
 1. afecțiuni obstrucțive;
 2. afecțiuni inflamatoare;
 3. perturbarea funcției senzomotorii;
 și următoarele stări patologice:
 a. hepatită;
 b. reflux gastroesofagian;
 c. sindrom de arteră mezenterică superioară;
 d. colecistită;
 e. greață cronică idiopatică;
 care sunt asociatele corecte:
 A. a-2, b-3, c-1, d-2, e-3;
 B. a-2, b-3, c-2, d-1, e-3;
 C. a-3, b-2, c-2, d-1, e-3;
 D. a-3, b-2, c-3, d-2, e-1;
 E. a-3, b-3, c-1, d-2, e-2;

1678. R.I. cauzele intraperitoneale de greață și vărsături prin perturbarea funcției senzomotorii a tubului digestiv, f.d.u. categorii:
 1. afecțiuni organice;
 2. tulburări funcționale în care greața/vărsăturile pot să apară, fără a fi caracteristice;
 3. tulburări funcționale în care greața/vărsăturile sunt principalul simptom;
 și următoarele stări patologice:
 a. greață idiopatică cronică;
 b. gastropareză;
 c. dispepsia funcțională;

1681. R.I. afecțiunile intraperitoneale care provoacă greață și vărsături, u.a.s.c.g.e.
 A. vărsăturile pot fi principalul simptom în afecțiunile obstrucțiv și inflamatoare ale viscerelor cavitare și solide;
 B. este o cauză tot mai rară de disfagie la adulți se recomandă;
 C. ca evaluarea disfagiei inexplicabile să includă;
 D. prelevarea de rutină a biopsiilor din mucoasa esofagiană;
 E. chiar dacă nu se observă endoscopic leziuni evidente;

1669. U.f.d.f.d. evaluarea unui pacient cu disfagie s.c.f.c.e.
 A. Dacă istoricul sugerează disfagie esofagiană motorie;
 B. principala investigație este manometria esofagiană;
 C. deoarece afecțiunile neoplazice și inflamatoare;
 D. pot induce modificări de tip:
 E. accelerează sau spasm esofagian.

1670. F.d. greață, vărsături și simptomele de care acestea trebuie diferențiate (loate, simptome reflectând inversarea direcției tranzitului oro-esogastric):
 1. greață;
 2. vărsături (emeză);
 3. regurgitare;
 4. tuminăție;
 și următoarele stări patologice:
 a. regurgitarea repetată a conținutului stomacului, care poate fi remestecat și reînghițit, fenomen în care intervine și un control voluntar, absent în cazul vărsăturilor;
 b. trecerea fără efort a conținutului gastric în gură;
 c. senzație subiectivă reflectând nevoia de a vomita;
 d. expulzarea orală a conținutului gastrointestinal ca urmare a contracțiilor musculaturii tubului digestiv și a peretelui toracoabdominal;
 care sunt asociatele corecte:
 A. a-1, b-3, c-2, d-4;
 B. a-2, b-3, c-1, d-3;
 C. a-2, b-3, c-1, d-4;
 D. a-2, b-4, c-1, d-3;
 E. a-4, b-3, c-1, d-2;

1671. C.d.u. are probabilitatea cea mai mică de a provoca greață și vărsături:
 A. afecțiuni digestive;
 B. afecțiuni extradigestive;
 C. medicamente;
 D. toxine circulante;
 E. agenți prokinetici;

1672. R.I. cauze de greață și vărsături, f.d.u. categorii:
 1. intraperitoneale;
 2. extraperitoneale;
 și următoarele stări patologice:
 a. afectarea urechii interne;
 b. iradiere abdominală;
 c. boli psihiatrice;
 d. medicație;
 e. inflamații ale organelor digestive;
 care sunt asociatele corecte:
 A. a-1, b-2, c-2, d-1, e-2;
 B. a-1, b-2, c-2, d-2, e-1;
 C. a-2, b-1, c-2, d-1, e-2;
 D. a-2, b-1, c-2, d-2, e-1;
 E. a-2, b-2, c-1, d-1, e-2;

1675. R.I. cauzele intraperitoneale de greață și vărsături, f.d.u. categorii:
 1. afecțiuni obstrucțive;
 2. afecțiuni inflamatoare;
 3. perturbarea funcției senzomotorii;
 și următoarele stări patologice:
 a. obstrucție pilorică;
 b. vărsături funcționale;
 c. pseudooobstrucție intestinală;
 d. pancreatită;
 care sunt asociatele corecte:
 A. a-1, b-3, c-2, d-3;
 B. a-2, b-3, c-1, d-3;
 C. a-2, b-3, c-1, d-4;
 D. a-2, b-3, c-1, d-4;
 E. a-4, b-3, c-1, d-2;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dăre următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, r.i. = referențelor folosite la; U.f.d.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază despre;

PDF compression, OCR, web optimization using a watermark evaluation copy of CVISION PDFCompressor

- B. creșterea în greutate poate provoca sindromul de arteră mezențială superioară;
C. infecțiile intestinale sunt cauze frecvente de vărsături acute, în special la vârstnici;
D. infecțiile intestinale oportuniste provoacă vărsături la persoanele cu imunodeficiență;
E. gastroparaza idiopatică are probabili etiologii infecțioase.
1682. R.I. alecțiunile intraperitoneale care provoacă greață și vărsături, u.a.s.c.g.e.:
A. artera mezentrică superioară tece peste duoden și poate comprima duodenum;
B. perioadele îndelungate de activitate care împiedică repausul la pat poate provoca sindromul de arteră mezentrică superioară;
C. perturbarea funcției senzori-motorii intestinale este o cauză frecventă de greață și vărsături;
D. gastroparaza determină golirea întârziată a stomacului de alimente;
E. gastroparaza idiopatică poate să fie precedată de un prodrom viral.
1683. R.I. afecțiunile intraperitoneale care provoacă greață și vărsături, u.a.s.c.g.e.:
A. pseudoostrucția intestinală poate fi manifestarea para-neoplazică a unui cancer precum carcinomul pulmonar micro-celular;
B. printră germeii oportuniști care produc enterită se află *Staphylococcus aureus* și *Bacillus cereus*;
C. dintre bolile inflamatoare intestinale ostrucția tranzitului intestinal este produsă mai ales celula ulcerosă;
D. gastroparaza idiopatică apare în absența unei boli sistemice;
E. în refluxul gastroesofagian sunt caracteristice greața și vărsăturile;
1684. R.I. pseudoostrucția intestinală, u.a.s.c.g.e.:
A. este caracterizată de exacerbarea activității motorii intestinale și colonice;
B. poate fi idiopatică;
C. poate fi moștenită ca o miopatie sau neuropatie viscerala familială;
a. contracție orale;
- D. poate fi provocată de o boală sistemică;
E. poate fi o manifestare paraneoplazică a unui cancer precum carcinomul pulmonar micro-celular;
1685. C.d.u. NU este o consecință a pseudoostrucției intestinale:
A. retenție de reziduu alimentar;
B. retenție de secreții;
C. depopulare bacteriană;
D. malabsorbția principalilor nutrienți;
E. fermentație intestinală excesivă;
1686. C.d.u. NU este un simptom al pseudoostrucției intestinale:
A. greață;
B. vărsături;
C. balonare;
D. durere;
E. regurgitare;
1687. R.I. cauzele extraperitoneale de greață și vărsături, f.d.u. categorii:
1. boală cardiacă;
2. alecțiuni intracerebrale;
3. medicamente;
și următoarele stări patologice:
a. diptoxin;
b. abcese cerebrale;
c. cardiomiopatie;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-1, c-2;
1688. R.I. cauzele extraperitoneale de greață și vărsături, f.d.u. categorii:
1. boală cardiacă;
2. alecțiuni intracerebrale;
3. medicamente;
și următoarele stări patologice:
a. infarct miocardic;
b. hidrocefalie;
c. hipoglicemie;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;
1689. R.I. cauzele extraperitoneale de greață și vărsături, f.d.u. categorii:
1. boală cardiacă;
2. alecțiuni intracerebrale;
3. medicamente;
și următoarele stări patologice:
a. boala Meniere;
b. depresie;
c. cetoacidoză;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;

Prescurtări frecvent folosite: c.g. = cauzele, s.a.s.c.g.e. = sunt următoarele, cu excepția, u.a.s.c.g.e. = următoarele afirmări sunt corecte, cu excepția, s.a.s.c.g.e. = sunt corect formulate, cu excepția.

- E. a-3, b-2, c-1;
1693. R.I. cauzele extraperitoneale de greață și vărsături, f.d.u. categorii:
1. afectarea labirintului;
2. boală psihică;
3. alecțiuni endocrine/metabolice;
și următoarele stări patologice:
a. neoplasm de ureche internă;
b. anxietate;
c. alecțiuni tiretoiene;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
1694. R.I. cauzele extraperitoneale de greață și vărsături, f.d.u. categorii:
1. alecțiuni intracerebrale;
2. medicamente;
3. alecțiuni endocrine/metabolice;
și următoarele stări patologice:
a. neoplazie cerebrală primară sau secundară (metastaze);
b. alecțiuni paratiroide;
c. chimioterapie antineoplazică;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-3, c-2;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
1695. R.I. cauzele extraperitoneale de greață și vărsături, f.d.u. categorii:
1. toxine;
2. medicamente;
3. alecțiuni endocrine/metabolice;
și următoarele stări patologice:
a. etanol;
b. antibiotice;
c. insuficiență cortico-suprarenală;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;
1696. R.I. cauzele extraperitoneale de greață și vărsături, f.d.u. categorii:
1. alecțiuni intracerebrale;
2. medicamente;
3. toxine;
și următoarele stări patologice:
a. antracice cardiacă;
b. insuficiență hepatică;
c. hemoragie cerebrală;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
1697. R.I. cauzele intraperitoneale de greață și vărsături, f.d.u. mecanisme:
1. împiedicarea tranzitului prin ostrucția stomacului;
2. acțiune asupra nervilor viscerali aferenți;
3. perturbarea funcției senzomotorii a tubului digestiv prin gastroparază;
și următoarele stări patologice:
a. insuficiență vasculară mezentrică;
b. boala ulceroasă;
c. colică biliară;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-3, c-2;
B. a-1, b-2, c-3;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
1698. R.I. cauzele intraperitoneale de greață și vărsături, f.d.u. mecanisme:
1. împiedicarea tranzitului prin ostrucția stomacului;
2. iritație viscerală localizată, uneori asociată cu ileus;
3. perturbarea funcției senzomotorii a tubului digestiv prin gastroparază;
și următoarele stări patologice:
a. boli sistemice care afectează nervația sau musculatura peretelui tubului digestiv;
b. colecistită;
c. cancer gastric;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;
1699. R.I. cauzele intraperitoneale de greață și vărsături, f.d.u. mecanisme:
1. împiedicarea tranzitului prin ostrucție intestinală;
2. infecție intestinală bacteriene;
3. perturbarea funcției senzomotorii a tubului digestiv prin gastroparază produsă de o boală sistemică afectând nervația sau musculatura peretelui tubului digestiv;
și următoarele stări patologice:
a. volvulus;
b. enterită cu *Shigelloccoccus aureus*, *Bacillus cereus*;
c. anitidoză;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-3, c-2;
B. a-1, b-2, c-3;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-1, c-2;
1702. R.I. cauzele intraperitoneale de greață și vărsături, f.d.u. mecanisme:
1. împiedicarea tranzitului prin ostrucția stomacului;
2. acțiune asupra nervilor viscerali aferenți;
3. perturbarea funcției senzomotorii a tubului digestiv prin gastroparază produsă de o boală sistemică afectând nervația sau musculatura peretelui tubului digestiv;
și următoarele stări patologice:
a. scleroză sistemică;
b. apendicită;
c. tumor benigne sau maligne;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele, c.d.u. = cauzele, f.d.u. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, f.l. = referitor/venitoare la, u.a.s.c.g.e. = următoarele afirmări sunt corecte, cu excepția, s.a.s.c.g.e. = sunt corect formulate, cu excepția.

1. împiedicarea tranzitului prin ocluzie intestinală; 2. infecție intestinală virală; 3. perturbarea funcției senzomotorii a tubului digestiv prin pseudoobstrucție intestinală; și următoarele stări patologice: a. telescopare; b. miopatie viscerală familială (moștenită); c. enterite virale; care sunt asociate corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-2, b-3, c-1; E. a-3, b-2, c-1;	D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 1705. R.I. cauzele intraperitoneale de greață și vărsături, f.d.u. mecanisme: 1. perturbarea funcției senzomotorii a tubului digestiv prin gastropareză; 2. perturbarea funcției motorii intestinale și formarea de stricturi; 3. perturbarea funcției senzomotorii a tubului digestiv prin pseudoobstrucție intestinală; și următoarele stări patologice: a. vagotomie; b. iradiere abdominală; c. manifestare paraneoplazică; care sunt asociate corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;	vărsături prin staza din peretele gastric; B. vărsăturile postoperatorii apar cel mai adesea după laparotomie și după intervenții ortopedice; C. în general, afecțiunile intra- cerebrale produc greață și vărsa- turi prin spasmul piloric; D. o cauză importantă de greață și vărsături sunt afecțiunile orga- nului echilibrului și ale căilor de transmitere; E. greața din bolile psihiatrice poate fi asociată cu goliere gastrică întârziată; 1709. R.I. medicamentele care provoacă vărsături, f.d. zone asupra cărora acționează: 1. stomac; 2. aria postrema; și următoarele medicamente: a. analgezice; b. antiepileptice; c. medicamente antiparkinsoniene; d. opioizi; e. digoxin; care sunt asociate corecte: A. a-1, b-1, c-2, d-2, e-2; B. a-1, b-2, c-2, d-2, e-1; C. a-2, b-1, c-1, d-2, e-2; D. a-2, b-1, c-2, d-1, e-2; E. a-2, b-2, c-2, d-1, e-1;	1706. R.I. sindromul vărsăturilor ciclice, u.a.s.c.g.g.; A. este o tulburare rară, de etiologie necunoscută; B. se asociază puternic cu migrena; C. unele cazuri ar putea fi variate de migrenă; D. apare cel mai adesea la vârșnici; E. au fost descrise cazuri la adulți în asociere cu golierea gastrică rapidă și cu utilizarea cronică de canabis; 1707. R.I. afecțiunile extra- peritoneale care provoacă greață și vărsături, u.a.s.c.g.g.; A. infarctul miocardic produce greață și vărsături prin înfărzierea golirii gastrice; B. vărsăturile postoperatorii apar după 25% din intervențiile chirurgicale; C. vărsăturile postoperatorii apar mai frecvent la femei; D. hipertensiunea intracraniană produce vărsături marcate cu sau fără greață; E. afecțiunile urechii interne pot provoaca greață și vărsături; F. în bolile psihiatrice poate să apară greață semnificativă; 1708. R.I. afecțiunile extra- peritoneale care provoacă greață și vărsături, u.a.s.c.g.g.; A. insuficiența congestivă produce greață și	D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 1705. R.I. cauzele intraperitoneale de greață și vărsături, f.d.u. mecanisme: 1. perturbarea funcției senzomotorii a tubului digestiv prin gastropareză; 2. perturbarea funcției motorii intestinale și formarea de stricturi; 3. perturbarea funcției senzomotorii a tubului digestiv prin pseudoobstrucție intestinală; și următoarele stări patologice: a. telescopare; b. miopatie viscerală familială (moștenită); c. enterite virale; care sunt asociate corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-2, b-3, c-1; E. a-3, b-2, c-1;	1703. R.I. cauzele intraperitoneale de greață și vărsături, f.d.u. mecanisme: 1. împiedicarea tranzitului prin ocluzie intestinală; 2. infecție intestinală oportunistă; 3. perturbarea funcției senzomotorii a tubului digestiv prin pseudoobstrucție intestinală; și următoarele stări patologice: a. boli inflamatorii intestinale (mai ales boala Crohn); b. neoplasme vizcerale familiale (moștenite); c. enterite cu VCM, VHS; care sunt asociate corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-2, b-3, c-1; E. a-3, b-2, c-1;	1704. R.I. cauzele intraperitoneale de greață și vărsături, f.d.u. mecanisme: 1. perturbarea funcției senzomotorii a tubului digestiv prin gastropareză; 2. comprimarea duodenului; 3. perturbarea funcției senzomotorii a tubului digestiv prin gastropareză produsă de o boală sistemică afectând inervația sau musculatura peretelui tubului digestiv; și următoarele stări patologice: a. sindromul de arteră mezenterică superioară; b. adenocarcinom pancreatic; c. diabet; care sunt asociate corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1;	1710. Medicamente emetogene s.u.c.g.g.; A. antibiotice; B. antitumorale cardiace; C. antihipertensive orale; D. hipoglicemizante; E. antemetice; 1711. F.d.u. tipuri de greață/ vărsături provocate de chimo- terapie antineoplazică: 1. acute; 2. întârziate; 3. anticipatorii; și următoarele caracteristici: a. răspunde adesea mai bine la tratament anxiolitic decât la antivomitive; b. în primele câteva ore după administrare; c. independent de serotonină; d. mediată prin căi serotonergice 5-HT ₃ ; care sunt asociate corecte: A. a-1, b-1, c-2, d-3; B. a-1, b-1, c-3, d-2; C. a-2, b-1, c-1, d-3; D. a-3, b-1, c-1, d-2; E. a-3, b-1, c-2, d-1;	1712. F.d.u. tipuri de greață/ vărsături provocate de chimo- terapie antineoplazică: 1. acute; 2. întârziate; 3. anticipatorii; și următoarele caracteristici: a. preced administrarea; b. după una sau mai multe zile; c. determinată de medicamente puternic emetogene (cum ar fi cisplatina); care sunt asociate corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;	1713. R.I. greața din sarcină u.a.s.c.g.g.; A. cauza ar putea fi o substanță provenind din placenta (gonado- tropină corionică, estradiol etc.); B. sarcina este cea mai frecventă cauză endocrină de greață; C. greața survine la 70% din femei în primul trimestru; D. hiperemeza gravidității este o formă severă de greață de sarcină; E. hiperemeza gravidității poate produce edeme severe; 1714. Cauze metabolice de emetă s.u.c.g.g.; A. uremie; B. cetoacidoză; C. insuficiență cardiacă; D. afecțiuni paratirodience; E. afecțiuni duodenale; 1715. R.I. greața provocată de toxine, u.a.s.c.g.g.; A. toxinele circulante provoacă greață acționând asupra mucoasei gastrice; B. toxinele care provoacă greață pot fi endogene sau exogene; C. în insuficiența hepatică fulmi- nantă, greața este cauzată de toxine exogene; D. în enterocolitele bacteriene, greața este produsă de entero- toxine; E. elanul este o cauză frecventă de greață și vărsături; 1716. Elemente furnizate de istoric importante pentru stabilirea cauzei greții/vărsăturilor s.u.c.g.g.; A. caracterul temporal al simpto- melor;	B. intervalul de timp de la ingestia de alimente după care apar vărsăturile; C. aspectul conținutului lichidului de vărsătură; D. felul în care palparea influ- ențează durerea abdominală; E. simptomele asociate; 1717. R.I. modul în care caracterul temporal al simptomelor sugerează cauza greții/vărsăturilor, f.d.u. variante: 1. mai degrabă acute; 2. mai degrabă cronice; și următoarele cauze: a. toxine; b. boli preexistente; c. boli în evoluție; d. infecții gastrointestinale; e. medicamente; A. a-1, b-1, c-2, d-1, e-2; B. a-1, b-2, c-1, d-1, e-2; C. a-1, b-2, c-1, d-2, e-1; D. a-1, b-2, c-2, d-1, e-1; E. a-2, b-1, c-2, d-1, e-1;	1718. R.I. modul în care intervalul de timp de la ingestia de alimente după care apar vărsăturile sugerează cauza greții/vărsăturilor, f.d.u. variante: 1. până într-o oră; 2. mai mult de o oră; 3. multe ore sau chiar zile; și următoarele cauze: a. ocluzie intestinală; b. forme severe de gastropareză; c. obstrucție pilorică, gastropareză; care sunt asociate corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-2, b-3, c-1; E. a-3, b-2, c-1;	1719. R.I. felul în care aspectul/ conținutul lichidului de vărsătură sugerează cauza greții/vărsa- turilor, f.d.u. variante: 1. reziduuri de alimente ingerate cu multe ore sau chiar zile anterior; 2. hematemeza; 3. bilios; și următoarele cauze: a. patologii care nu determină obstrucția evacuării stomacului; b. sindrom Mallory-Weiss; c. forme severe de gastropareză; care sunt asociate corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-2, b-1, c-3;	1720. R.I. felul în care aspectul/ conținutul lichidului de vărsătură sugerează cauza greții/vărsa- turilor, f.d.u. variante: 1. hematemeza; 2. fecaloid; 3. alimente nedigerate; și următoarele cauze: a. ocluzie intestinală distală; b. diverticul Zenker; c. ulcer; care sunt asociate corecte: A. a-1, b-3, c-2; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;	1721. R.I. felul în care aspectul/ conținutul lichidului de vărsătură sugerează cauza greții/vărsa- turilor, f.d.u. variante: 1. hematemeza; 2. fecaloid; 3. alimente nedigerate; și următoarele cauze: a. ocluzie colonică; b. acalazie; c. cancer digestiv superior; care sunt asociate corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-2, b-3, c-1; E. a-3, b-2, c-1;	1722. R.I. felul în care influența vărsăturii asupra durerii abdomi- nale sugerează cauza greții/vărsa- turilor, f.d.u. variante: 1. după vărsătură, durerea abdominală se ameliorează; 2. după vărsătură, durerea abdominală nu se ameliorează; și următoarele cauze: a. ocluzie intestinală; b. obstrucție de tub digestiv; c. pancreatită; d. colecistită; care sunt asociate corecte: A. a-1, b-1, c-2, d-2; B. a-1, b-2, c-2, d-1; C. a-2, b-1, c-1, d-2; D. a-2, b-1, c-2, d-1; E. a-2, b-2, c-1, d-1;	1723. R.I. modul în care simpto- mele asociate sugerează cauza greții/vărsăturilor, f.d.u. variante: 1. scădere în greutate; 2. febră;
---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	--	---	--	---	--	--	--

Prescurtări frecvent folosite: s.c.g.g. = sunt următoarele, cu excepția; u.a.s.c.g.g. = următoarele afirmări sunt corecte, cu excepția; s.c.f.g.g. = sunt corect formulate, cu excepția;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, f.d. = referențieritate la; f.d.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază despre;

3. dureri de cap sau modificări de câmp vizual;
4. vârsături sau înghiț;
și următoarele cauze:
a. patologice a urechii interne (labirintului);
b. surdită intracraniană;
c. cancer sau obstrucție digestivă;
d. inflamație;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3, d-4;
B. a-2, b-4, c-1, d-3;
C. a-2, b-4, c-3, d-1;
D. a-3, b-1, c-4, d-2;
E. a-4, b-3, c-1, d-2.
1724. R.I. utilitatea examenului fizic la un pacient cu greață/vârsături, f.d.u. începând din frază:
1. hipotensiunea ortostatică și scăderea turgescenței cutanate indică;
2. modificările la examenul pulmonar sugerează;
3. sânge în materiile fecale sugerează drept cauză;
și următoarele stăpânuri de frază:
a. aspirația lichidului de vârsătură;
b. hipovolemia;
c. leziune a mucoasei prin ulcer, ischemie, tumoră;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1.
1725. R.I. modul în care examenul fizic sugerează cauza grețelor/vârsăturilor, f.d.u. variante:
1. zgornie intestinală de tonalitate mală;
2. clipeala la mișcarea laterală bruscă a pacientului;
3. edem papilar, reducerea câmpului vizual, anomalii neurologice focale;
și următoarele cauze:
a. gastropareză sau obstrucție pilorică;
b. ocizie intestinală;
c. afecțiuni neurologice;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-1, c-2.
1726. R.I. modul în care examenul fizic sugerează cauza grețelor/vârsăturilor, f.d.u. variante:
1. absența zgorniei intestinale (la auscultația abdominală);
2. durere la palpare sau apăsare involuntară;
3. palparea unei formațiuni abdominale sau a unei adenopatii;
și următoarele cauze:
a. inflamație;
b. neoplasm;
c. leuș;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1.
1727. R.I. investigațiile diagnostice la pacienții cu greață/vârsături, u.a.s.c.g.e.:
A. radiografia abdominală trebuie făcută în decubit dorsal și în ortostatism;
B. gastropareză se diagnostichează de obicei prin scintigrafie gastrică;
C. prin scintigrafia gastrică se evidențiază vasculizația stomacului;
D. tranzitul anormal al bănelui poate sugera pseudoostrucția intestinală;
E. pseudoostrucția intestinală poate fi sugerată de îngustarea intestinului subțire la radiografia cu substanță de contrast;
1728. U.I.d.f.d. investigațiile diagnostice la pacienții cu greață/vârsături s.c.f.g.e.:
A. Dacă investigațiile inițiale nu au pus diagnosticul sau pentru:
B. confirmarea acestuia, sunt necesare investigații biochimice;
C. pentru detectarea unor eventuale anomalii anatomice;
D. iar dacă acestea sunt absente este necesară investigația:
E. modificării gastrointestinale pentru a detecta o eventuală tulburare motrice.
1729. R.I. investigațiile diagnostice la pacienții cu greață/vârsături, f.d.u. categorii:
1. investigații inițiale;
2. investigații imagistice;
3. investigații pentru motilitatea gastrointestinale;
și următoarele investigații:
a. electrogastrografia;
- b. ecografie abdominală;
c. EDS;
d. endoscopie;
e. analiza biochimică urinară;
care sunt asocierile corecte:
A. a-2, b-1, c-2, d-3, e-3;
B. a-2, b-1, c-2, d-3, e-2;
C. a-2, b-2, c-3, d-2, e-1;
D. a-2, b-3, c-2, d-2, e-1;
E. a-3, b-2, c-2, d-2, e-1.
1730. R.I. investigațiile diagnostice la pacienții cu greață/vârsături, f.d.u. categorii:
1. investigații inițiale;
2. investigații imagistice;
3. investigații pentru motilitatea gastrointestinale;
și următoarele investigații:
a. radiografie baritată;
b. scintigrafie gastrică;
c. manometria de intestin subțire;
d. TC abdominală;
e. analize hormonale specifice;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3, d-2, e-3;
B. a-1, b-3, c-2, d-3, e-2;
C. a-2, b-3, c-3, d-2, e-1;
D. a-3, b-1, c-2, d-3, e-2;
E. a-3, b-3, c-2, d-2, e-1.
1731. R.I. investigațiile diagnostice la pacienții cu greață/vârsături, f.d.u. categorii:
1. investigații inițiale;
2. investigații imagistice;
3. investigații pentru motilitatea gastrointestinale;
și următoarele investigații:
a. teste respiratorii izotopice;
b. TC craniocerebral;
c. colonoscopie;
d. analiză serologică specifică;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-2, d-3;
B. a-2, b-1, c-2, d-3;
C. a-2, b-3, c-1, d-2;
D. a-3, b-2, c-1, d-2;
E. a-3, b-2, c-2, d-1.
1732. R.I. investigațiile diagnostice la pacienții cu greață/vârsături, f.d.u. categorii:
1. investigații inițiale;
2. investigații imagistice;
3. investigații pentru motilitatea gastrointestinale;
și următoarele investigații:
a. metode cu capsulă telemetrică;
b. TC sau RMN craniocerebral;
c. radiografia abdominală simplă;
d. inghiț;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-2, d-3;

Prescripții frecvent folosite: S.B. = cu excepția, S.U.C.E. = sunt următoarele, cu excepția, U.A.S.C.G.E. = următoarele afirmații sunt corecte, cu excepția, S.C.f.g.e. = sunt corect formulate, cu excepția.

- B. a-1, b-3, c-2, d-2;
C. a-2, b-2, c-3, d-1;
D. a-2, b-3, c-1, d-2;
E. a-3, b-2, c-1, d-2.
1733. R.I. utilitatea analizelor biochimice la un pacient cu greață/vârsături, f.d.u. variante:
1. hipokalemie;
2. anemie feriprivă;
3. creșterea enzimelor pancreatice;
și următoarele stări patologice:
a. pierdere de lichide digestive;
b. boala pancreatică;
c. sângereare cronică prin leziune a mucoasei;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1.
1734. R.I. utilitatea analizelor biochimice la un pacient cu greață/vârsături, f.d.u. variante:
1. alcaloză metabolică;
2. anemie feriprivă;
3. anomalii ale biokimiei hepatice;
și următoarele stări patologice:
a. boala hepatică;
b. pierdere de acid gastric;
c. ulcer/cancer sângărând cronic;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-3, b-2, c-1;
E. a-3, b-2, c-2.
1735. R.I. modul în care investigații inițiale sugerează cauza grețelor/vârsăturilor, f.d.u. variante:
1. anomalii la investigațiile hormonale sau serologice specifice;
2. înveliri hidro-afecție intestinale cu scăderea cantității de aer din colon pe radiografia abdominală;
3. anse intestinale dilatate difuz, pline cu aer pe radiografia abdominală;
și următoarele stări patologice:
a. ocizie intestinală;
b. leuș;
c. boii endocrine, boii autoimune sistemice, manifestări paraneoplazice;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
- C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-2, c-1;
E. a-3, b-2, c-2.
1736. R.I. felul în care se aleg investigațiile imagistice în funcție de cauza suspectată a grețelor/vârsăturilor, f.d.u. suspiciuni:
1. ulcer, cancer;
2. ocizie colonică;
3. patologice intracraniană;
și următoarele investigații:
a. colonoscopie sau irigografie;
b. endoscopie digestivă superioară;
c. TC sau RMN craniocerebral;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1.
1737. R.I. felul în care se aleg investigațiile imagistice în funcție de cauza suspectată a grețelor/vârsăturilor, f.d.u. suspiciuni:
1. ocizie (parțială) de intestin subțire;
2. procese inflamatoare intestinale;
3. ischemie mezenică;
și următoarele investigații:
a. radiografie baritată a intestinului subțire;
b. ecografie abdominală sau TC;
c. angiografie mezenică (clasică sau prin RMN);
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1.
1738. R.I. investigarea motilității gastrointestinale pentru a detecta o eventuală tulburare motrice la pacienții cu greață/vârsături, f.d.u. stări patologice:
1. gastropareză;
2. pseudoostrucția intestinală;
și următoarele investigații:
a. metode cu capsulă telemetrică;
b. teste respiratorii izotopice;
c. scintigrafie gastrică;
d. radiografia baritată a intestinului subțire;
e. electrogastrografie;
f. manometria de intestin subțire;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-1, d-1, e-2, f-2;
B. a-1, b-1, c-1, d-2, e-1, f-2;
C. a-1, b-1, c-2, d-1, e-2, f-1;
D. a-1, b-2, c-2, d-1, e-1, f-1.
1739. R.I. electrogastrografie, u.a.s.c.g.e.:
A. este un test nemnăv;
B. explorează undele rapide din activitatea electrică gastrică;
C. folosește electrozi cutanați plasati periorbitali;
D. ar putea fi o metodă alternativă de diagnosticare a dispepsiei funcționale;
E. este disponibilă doar în centre specializate;
1740. R.I. manometria de intestin subțire, u.a.s.c.g.e.:
A. poate confirma diagnosticul de pseudoostrucție intestinală;
B. caracterizează suplimentar anomalia motrice drept neuropatică sau miopatică;
C. identifică anumite tipare con-tracile caracteristice diferite după cum anomalia motrice este de cauză neuronală sau musculară;
D. oferă informații care trebuie confirmate prin biopsie intestinală deschiță;
E. nu este disponibilă pe scară largă, fiind o investigație specializată;
- Indigestia**
1741. R.I. indigestie, u.a.s.c.g.e.:
A. indigestia este un termen ne-specific care cuprinde diverse simptome abdominale superioare;
B. indigestia se referă, în general, la simptome considerate a-și avea originea în regiunea gastro-duodenală;
C. unii pacienți nu pot mânca până la capăt o masă din cauza apariției timpurii a senzației de plin;
D. indigestia este un termen ne-specific adesea considerat echivalent cu cel de dispepsie;
E. o bună parte din simptome ar putea fi explicate prin golierea precoce a stomacului;
1742. F.d. cele trei categorii de simptome incluse în termenul de indigestie:
1. disconfort epigastric;
2. simptome care exprimă inversarea tranzitului digestiv;
3. simptome care exprimă (per să expune) umplerea excesivă a stomacului;
și u. grupe de simptome:

Prescripții frecvent folosite: u. = următoarele, c.d.u. = care dintre următoarele, f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, f.l. = referitor/referitoare la, U.I.d.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază descriptivă.

a. senzație de plin postprandial, sajetate precoce, balonare, eructație, anorexie, greață; b. arsură, roader, durere; c. greață, vărsături, proz, regurgitare, eructație; care sunt asociate corecte: A. a-1, b-3, c-2; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;

1743. R.I. cauze de indigestie, f.d.u. evaluări de incidență: 1. cel mai adesea; 2. mai rar; și următoarele stări patologice: a. dispepsie funcțională; b. boli organice mai severe; c. reflux gastroesofagian; d. boala ulceroasă peptică; e. cancer digestiv superior; care sunt asociate corecte: A. a-1, b-1, c-2, d-2, e-2; B. a-1, b-2, c-1, d-2, e-2; C. a-1, b-2, c-2, d-1, e-2; D. a-1, b-2, c-2, d-2, e-1; E. a-2, b-2, c-1, d-2, e-1;

1744. R.I. factorii cauzali/ favorizanți pentru RGE u.a.s.c.g.: A. creșterea tonusului SEI în scleroza sistemică poate favoriza RGE; B. la multe persoane apar frecvente episoade de relaxare trecătoare a SEI în timpul cărora acidul gastric pătrunde în esofag; C. cei mai mulți pacienți cu RGE au hernie hiatală; D. unii pacienți au senzație de pirozis deși expunerea la acid a esofagului este normală (pirozis funcțional); E. progesteronul poate provoca/ favoriza refluxul acid prin hipertonia SEI;

1745. R.I. factorii cauzali/ favorizanți pentru RGE u.a.s.c.g.: A. în sarcină crește tonusul SEI ceea ce poate favoriza RGE; B. ingerarea unor cantități excesive de alimente poate crește presiunea în stomac suficient pentru a depăși trecător funcția de barieră a SEI; C. la majoritatea persoanelor cu hernie hiatală pirozisul este simptomul dominant; D. senzația de pirozis se poate datoră percepției exagerate a unui pH esofagian normal (hipersensibilitate viscerală);

E. etanolul poate provoca/ favoriza refluxul acid prin relaxarea SEI; 1746. R.I. factorii cauzali/ favorizanți pentru RGE u.a.s.c.g.: A. scăderea tonusului SEI se poate petrece la pacienții fără vreo afecțiune sistemică; B. scăderea motilității esofagiene și creșterea secreției salivare poate prelungi expunerea la acid; D. în etiologia bolii ulceroase peptice, care poate; E. produce simptome dispeptice; 1751. U.f.d.f. hipersensibilitatea viscerală s.c.f.g.; A. Pacienții cu SEI; B. au hipersensibilitate viscerală; C. demonștrată prin percepția deficitară; D. a unui balon umflat în rect; E. asociată cu scăderea complicațiilor rectale; 1752. R.I. boala de reflux gastroesofagian (BRGE) u.a.s.c.g.: A. în populația generală, 40% din persoanele relatează pirozis lunar, iar 7-10% zilnic; B. BRGE este frecventă; C. pirozisul este provocat în majoritatea cazurilor de reflux acid excesiv; D. 10% din pacienți au pirozis funcțional; E. pirozisul funcțional este cel care apare în urma unei expuneri excesive a esofagului la acid; 1753. C.d.u. simptome nu este inclus în DF: A. plinitudine postprandială; B. sajetate precoce; C. disconfort (durere, arsură) epigastric; D. balonare, eructații; E. diaree; 1754. U.f.d.f. dispepsia funcțională (DF) s.c.f.g.: A. DF este definită drept; B. simptome dispeptice supărate; C. cu durată de cel mult 3 luni; D. și instalate de cel puțin 6 săptămâni; E. având o cauză organică; 1755. R.I. dispepsia funcțională (DF) u.a.s.c.g.: A. simptomele dispeptice sunt frecvente în populație; B. în populația generală, aproape 25% din persoane au simptome dispeptice cel puțin de șase ori pe an;

Prescurtări frecvent folosite: u. = umblătoare; c.d.u. = care dăte umblătoare; f.d. = fınd date; f.d.u. = fınd date umblătoare, f.l. = rețineretentare la; U.f.d.f. = Umblătoare fındte dnt-o fınd despre;

C. numai 10-20% dintre persoanele cu simptome dispeptice se prezintă la medic; D. la 60% din persoanele cu simptome dispeptice cauza este DF; E. la majoritatea pacienților, DF evoluează către ulcer; F. uneori DF este consecința unei infecții gastrointestinale anterioare (ca și în cazul gastroparezii idiopatice); 1756. R.I. boală ulceroasă, u.a.s.c.g.: A. ulcere esofagiene apar la 5% dintre pacienți cu BRGE; B. vindecarea ulcerelor esofagiene poate duce la unii pacienți la formarea de stricturi; C. esofagita neerozivă poate fi diferențiată de cea erozivă sau ulceroasă pe baza simptomelor; D. dintre pacienți cu simptome dispeptice, ~15-25% au ulcere gastrice sau duodenale; E. gastrinoma este o tumoră endocrină care produce necontrolat serotonină; F. numai o mică parte din persoanele infectate cu H-py sau care iau AINS dezvoltă ulcer; 1757. R.I. etiologia ulcerelor gastrice sau duodenale, f.d.u. evaluări de incidență: 1. cel mai adesea; 2. mai rar; și următoarele stări/ circumstanțe: a. boala Crohn; b. administrarea de AINS; c. infecția cu H-py; d. sindrom Zollinger-Ellison (gastrinom); care sunt asociate corecte: A. a-1, b-2, c-1, d-2; B. a-1, b-2, c-2, d-1; C. a-2, b-1, c-1, d-2; D. a-2, b-1, c-2, d-1; E. a-2, b-2, c-1, d-1;

1758. R.I. cancer ca substrat al simptomelor dispeptice, u.a.s.c.g.: A. mulți pacienți dispeptici se tem că au cancer; B. funatul este printre cei mai importanți factori de risc pentru carcinomul scuamos esofagian; C. acalazia este un factor de risc pentru cancerul esofagian; D. esofagul Barrett reprezintă metaplazia scuamoasă a esofagului; 1762. U.f.d.f. colica biliară s.c.f.g.;

E. adenocarcinomul gastric este mai prevalent la anumite populații asiatice; 1759. R.I. cancer ca substrat al simptomelor dispeptice, u.a.s.c.g.: A. mai puțin de 2% din pacienți cu simptome dispeptice au cancer gastric sau esofagian; B. consumul de etanol previne carcinomul scuamos esofagian; C. o boală rară care predisune la carcinom esofagian este chera-tomia familială (tloză), în care apare hipercheratoză palmo-plantară; D. dintre pacienți cu BRGE, 8-20% dezvoltă metaplazie intestinală a esofagului; E. simptomele dispeptice pot avea ca substrat un adenocarcinom gastric; 1760. R.I. cancer ca substrat al simptomelor dispeptice, u.a.s.c.g.: A. carcinomul scuamos esofagian apare cel mai adesea la persoane cu istoric de fumat sau de consum de etanol; B. ingestia anterioară de substanțe caustice crește riscul de cancer esofagian; C. adenocarcinomul esofagian apare de obicei ca o complicație a spasmului esofagian; D. metaplazia intestinală a esofagului predisune la adenocarcinom esofagian; E. simptomele dispeptice pot avea ca substrat un limfom gastric; 1761. R.I. diversele forme de esofagită în diagnosticul diferențial al dispepsiei, u.a.s.c.g.: A. esofagita de reflux alcalină produce simptome similare cu cele din BRGE; B. esofagita de reflux alcalină apare la pacienți care au suferit intervenții chirurgicale pentru boală ulceroasă peptică; C. infecție esofagiene oportuniste fungice sau virale pot produce pirozis sau disconfort toracic; D. esofagita infecțioasă provoacă adesea odinofagie; E. cele mai frecvente forme de esofagită sunt cea medicamentosă și cea eozinofilică; 1762. U.f.d.f. colica biliară s.c.f.g.;

A. Majoritatea pacienților cu colică biliară veritabilă; B. relatează episoade de durere cu durată limitată; C. resimțită în hipocondrul drept sau în epigastriu; D. dar mai ales senzație de arsură continuă/ cronică; E. greață sau balonare; 1763. R.I. diversele cauze care intră în diagnosticul diferențial al dispepsiei, u.a.s.c.g.: A. deficitul de lactază se manifestă prin meteorism, flatulență, disconfort abdominal și diaree după ingestia de lactoză; B. deficitul de lactază apare la 15-25% din persoanele caucasice provenind din Europa nordică și este mai rar la afro-americani și la asiatici; C. intoleranța la fructoză sau sorbitol are manifestări similare celor din deficitul de lactază; D. proliferarea bacteriană în intestinul subțire poate produce dispepsie, adesea asociată cu disfuncție intestinală, distensie și malabsorbție; E. printre etiologiile extraperitoneale ale indigestiei se află ICCg și tuberculoza; 1764. R.I. cauzele de dispepsie sau de disconfort abdominal, f.d.u. categorii: 1. digestive – tub digestiv (boli vasculare); 2. digestive – tub digestiv (boli infiltrative); 3. digestive – glande anexe; și următoarele cauze: a. pancreatita cronică; b. gastroenterita eozinofilică; c. ischemia mezenterică; care sunt asociate corecte: A. a-1, b-3, c-2; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;

1765. R.I. cauzele de dispepsie sau de disconfort abdominal, f.d.u. categorii: 1. sistenice (boli infiltrative); 2. digestive – tub digestiv; 3. musculare; și următoarele cauze: a. sarcoidoză; b. suprasolicitare peretelui abdominal; c. boala celiacă; care sunt asociate corecte:

Prescurtări frecvent folosite: u. = umblătoare; c.d.u. = care dăte umblătoare; f.d. = fınd date; f.d.u. = fınd date umblătoare, f.l. = rețineretentare la; U.f.d.f. = Umblătoare fındte dnt-o fınd despre;

A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1.

1766. R.I. cauzele de dispepsie sau de disconfort abdominal, f.d.u. categorii:

1. digestive – tub digestiv;
2. digestive – glande anexe;
3. nedigestive – endocrine;
- și următoarele cauze:
- a. cancerul pancreatic;
- b. boala paratiroidiene;
- c. boala ulcerosă;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
- B. a-1, b-3, c-2;
- C. a-2, b-1, c-3;
- D. a-2, b-3, c-1;
- E. a-3, b-2, c-1;

1767. R.I. cauzele de dispepsie sau de disconfort abdominal, f.d.u. categorii:

1. digestive – tub digestiv;
2. digestive – glande anexe;
3. nedigestive – endocrine;
- și următoarele cauze:
- a. cancerul hepatocelular;
- b. boala Meierit;
- c. boala tiroide;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
- B. a-2, b-1, c-3;
- C. a-2, b-3, c-1;
- D. a-3, b-1, c-2;
- E. a-3, b-2, c-1;

1768. R.I. pirozis, u.a.s.c.g.e.:

- A. este o senzație de căldură retrosternală care urcă din epigastru, uneori până în gât;
B. senzația poate fi și descendentă;
C. apare/ se accentuează când stomacul este gol;
D. apare/ se accentuează când pacientul stă în picioare;
E. nu apare în somn.

1769. R.I. evaluarea pacientului cu indigestie, u.a.s.c.g.e.:

- A. durerea în piept constructiv la un pacient cu BRGE creează riscul de confuzie cu angina pectorală;
B. examenul fizic este decisiv în punerea diagnosticului de BRGE;
C. în DF apare uneori sensibilitate la palparea epigastrului;
D. este importantă diferențierea cauzelor funcționale de cele organice pe baza datelor de istoric și de examen fizic;

Prescurtări frecvent folosite: c.g. = cu excepție, s.u.c.g.e. = sunt următoarele, cu excepție, u.a.s.c.g.e. = următoarele afirmări sunt corecte, cu excepție, s.c.f.g.e. = sunt corect formulate, cu excepție.

E. distragă sugerează obstrucție esofagiană benignă sau malignă;
1770. R.I. evaluarea pacientului cu indigestie, u.a.s.c.g.e.:

- A. durerea în piept constructiv este caracteristică pentru dischinezia esofagiană cu hipermotilitate hipercontractilă;
B. examenul fizic este de obicei normal în DF;
C. uneori în DF apare distensie abdominală;
D. odinofagia sugerează esofagită de reflux;
E. la examenul fizic se pot constata leziuni dentare produse de contactul prelungit și repetat cu acidul gastric;

1771. U.f.d.d. examenul fizic în BRGE s.c.f.g.e.:

- A. modificări la examenul fizic care pot fi produse de anumiți complicații/ consecințe ale;
C. BRGE sunt entități perorale;
D. respirația sferică;
E. leziunile dentare;

1772. R.I. BRGE u.a.s.c.g.e.:

- A. simptomul cel mai caracteristic este pirozisul;
B. mai rar, poate să apară durere în piept constructiv;
C. unii dintre simptome asociate este regurgitarea acidă;
D. o asocierie caracteristică este cu astmă;
E. unii pacienți nu relatează pirozis, ci durere abdominală sau alte simptome;

1773. Complicații ale BRGE s.u.c.g.e.:

- A. la unii pacienți predomină durere sau arsură epigastrică;
C. nu generalizată sau localizată în alte regiuni, iar DF;
D. adesea coexistă alimențelor;
E. cu alte tulburări funcționale digestive, cu excepția SII;

1774. U.f.d.d. DF s.c.f.g.e.:

- A. la unii pacienți apare, de câteva ori pe săptămână, un disconfort postprandial constând în senzație de gol;
C. după ingerarea unor cantități obișnuite de alimente și;

1775. U.f.d.d. DF s.c.f.g.e.:

- A. la unii pacienți apare, de câteva ori pe săptămână, un disconfort postprandial constând în senzație de gol;
C. după ingerarea unor cantități obișnuite de alimente și;

D. sațietate precoce care determină ingestia unor cantități excesive de alimente;
E. în asocierie cu balonare, eructații sau greață;
1776. Aspecte îngrijorătoare (simptome de alarmă) la un pacient cu dispepsie s.u.c.g.e.:

- A. odinofagie;
B. vărsături repetate;
C. hemoragie digestivă macroscopică;
D. formative tumorale palpabile;
E. antecedente familiale de RGE;

1777. Aspecte îngrijorătoare (simptome de alarmă) la un pacient cu dispepsie s.u.c.g.e.:

- A. creșterea în greutate;
B. hemoragie digestivă oculară;
C. icter;
D. adenopatie palpabilă;
E. istoric de cancer, mai ales digestiv, în familie;

1778. R.I. investigațiile diagnostice la pacienții cu dispepsie, u.a.s.c.g.e.:

- A. în alegerea investigațiilor, trebuie avut în vedere că simptomele dispepsiei sunt rare;
B. se efectuează un număr limitat de investigații diagnostice;
C. la un pacient cu vârsta <55 ani și fără factori de alarmă demersul diagnostic depinde de prevalența infecției cu H-py în populația locală;
D. presiunea scăzută a SEI la manometria esofagiană ajută la selectarea pacienților care necesită intervenție chirurgicală;
E. la pacienții cu BRGE și simptome atipice diagnostici poate fi lămurit prin radiografie bariată;

1779. R.I. investigațiile diagnostice la pacienții cu dispepsie, u.a.s.c.g.e.:

- A. în alegerea investigațiilor, trebuie avut în vedere că în majoritatea cazurilor este vorba de BRGE sau de DF;
B. persoanele la care se efectuează investigațiile diagnostice sunt selectate pe baza istoricului;
C. în BRGE se efectuează manometria esofagiană când tratamentul chirurgical nu este indicat;
D. evidențierea unor tulburări ale peristaltismului esofagian la manometria esofagiană poate

influența decizia de a interveni operator;
E. testul Bernstein constă în instilare de ser fiziologic, iar apoi de apă distilată în esofag;

1780. R.I. investigațiile diagnostice la pacienții cu dispepsie, u.a.s.c.g.e.:

- A. după excluderea factorilor de alarmă, pacienții cu BRGE tipică nu necesită evaluare suplimentară;
B. la toate persoanele care au dispepsie trebuie efectuată o investigație completă;
C. presiunea crescută a SEI la manometria esofagiană poate prezice insuccesul tratamentului medicamentos;
D. evidențierea unor tulburări ale peristaltismului esofagian la manometria esofagiană poate modifica tipul de operație ales;

E. testul Bernstein poate stabili dacă disconfortul toracic, altminteru inexplicabil, este provocat de spasmul esofagian;

1781. U.f.d.d. pacienții cu dispepsie s.c.f.g.e.:

- A. După excluderea factorilor de alarmă;
B. pacienții cu BRGE tipică;
C. se tratează empiric;
D. cu medicamente antispasmodice;
E. eventual și prokinetice;

C. pentru depistarea refluxului gastroesofagian;
D. întrucât s-a demonstrat prin studii controlate că această atitudine are beneficii clinice și că este rentabilă financiar;
1785. U.f.d.d. investigarea pacienților cu dispepsie s.c.f.g.e.:

- A. La pacienții cu simptome refractare la medicamente, b. sau cu simptome atipice (precum balonare);
C. se poate recurge la monitorizarea ambulatorie a pH-ului esofagian;
D. folosind un cateter;
E. sau endoscopia digestivă superioară;

1786. F.d.u. constatări, concluzii și decizii în evaluarea unui pacient cu dispepsie inexplicabilă:

- a. pacienți cu vârsta >55 ani sau care are factori de alarmă;
b. risc crescut de cancer și ulcer;
c. se începe cu EDS;
ce secvență este recomandabilă:
A. a-b-c;
B. a-b-c-b;
C. b-a-a-c;
D. c-a-a-b;
E. c-b-a-a;

1787. F.d.u. constatări, concluzii și decizii în evaluarea unui pacient cu dispepsie inexplicabilă, vârstă <55 ani și fără factori de alarmă:

- a. nu este necesară altă intervenție;
b. simptomele se rezolvă;
c. prevalență scăzută (<10%) a H-py în populația locală;
d. tratament antisecretor de probă timp de 4 săptămâni;
e. test negativ pentru H-py;
ce secvență este recomandabilă:
A. a-b-c-d-e;
B. a-b-c-d-b;
C. c-a-a-b-a;
D. c-d-b-e-c-a;
E. d-e-a-c-b;

1788. F.d.u. constatări, concluzii și decizii în evaluarea unui pacient cu dispepsie inexplicabilă, vârstă <55 ani și fără factori de alarmă și prevalență crescută a H-py în populația locală:

- a. EDS;
b. testare pentru H-py;
c. tratament antisecretor;
d. dacă simptomele nu se rezolvă;
e. test negativ pentru H-py;
ce secvență este recomandabilă:
A. a-b-c-d-e;
B. a-b-c-d-b;
C. c-a-a-b-a;
D. c-d-b-e-c-a;
E. d-e-a-c-b;

1789. F.d.u. constatări, concluzii și decizii în evaluarea unui pacient cu dispepsie inexplicabilă, vârstă <55 ani și fără factori de alarmă și prevalență crescută a H-py în populația locală:

- a. dacă simptomele persistă în ciuda tratamentului pentru H-py;
b. dacă simptomele nu se rezolvă;
c. testare pentru H-py;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele, c.d.u. = care dintre următoarele, f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, r. = referitor/reletoare la, U.f.d.d. = următoarele fragmente dintr-o frază despre,

d. tratament anisecretor;
e. test pozitiv pentru $H_{2}P_{2}$;
f. EDS;
A. $b \rightarrow c \rightarrow e \rightarrow d \rightarrow f \rightarrow a$;
B. $c \rightarrow b \rightarrow e \rightarrow f \rightarrow d \rightarrow a$;
C. $c \rightarrow e \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow b \rightarrow f$;
D. $c \rightarrow e \rightarrow b \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow f$;
E. $f \rightarrow d \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow e \rightarrow a$.

1792. R.I. investigațiile suplimentare indicate dacă există elemente sugestive pentru o anumită patologie, f.d.u.
a. test respirator după ingestia de glucide dacă se suspectează;
b. scintigrafie de golire gastrică (pentru a depista o eventuală gastropareză);
c. teste serologice specifice;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-3, c-2;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;

Tulburările de tranzit

Diareea

1795. R.I. diaree, u.a.s.c.e.e.;
A. diareea reprezintă eliminarea de scaune lichidiene sau neformate cu frecvență crescută;
B. pentru adulți cu diaree ocazională tipică, eliminarea a mai mult de 200 g de scaun pe zi poate fi considerată diaree;
C. scăderea consistenței înseamnă că scaunul devine mai lichid;
D. diareea prin preluarea de apă apară la pacienți din centrele de îngrijire din cauza impactării materiei fecale;
E. mai mult de 90% dintre cazurile de diaree acută sunt funcționale;

1796. R.I. diaree, u.a.s.c.e.e.;
A. în fările dezvoltate cantitatea de scaun eliminat zilnic nu depășește 200 g;
B. de obicei pacientul relatează și scăderea consistenței și creșterea frecvenței scaunului;
C. frecvența normală a scaunelor variază între trei pe zi și unu pe săptămână;
D. impacarea materiilor fecale (ușor detectabilă prin tușeu rectal) poate fi urmată de diaree;
E. diareea de cauză infecțioasă este adesea însoțită de vărsături, febră și durere abdominală;
F. mai puțin de 10% dintre cazurile de diaree acută sunt și următoarele caracteristici:

provoacă de medicamente, ingestie de toxice, ischemie ș.a.;
1797. Factorii care influențează cantitatea, consistența și frecvența scaunelor sunt următorii, c.e.;
A. conținutul în proteine al dietei;
B. sexul (la bărbați cantitatea de scaun este mai mare decât la femei);
C. medicamentele ingerate;
D. efortul fizic, activitatea fizică;
E. solicitarea psihică, emoțiile, tensiunile;

1798. R.I. hiperdefecație și incontinență, u.a.s.c.e.e.;
A. au prevalență comparabilă cu sau mai mare decât cea a diareei cronice;
B. sunt două stări frecvent înălnite, de care diareea trebuie diferențiată;
C. de obicei sunt asociate cu eliminarea unei cantități de scaun totalizând mai mult de 200 g/zi;
D. trebuie întotdeauna avute în vedere la pacienții care acuză „diaree” deoarece demersurile diagnostice și terapeutice diferă;
E. în general, un istoric și un examen fizic atente permit diferențierea acestor stări de diareea veritabilă;

1799. F.d. cele două stări de care trebuie diferențiată diareea:
1. hiperdefecția (pseudodiareea);
2. incontinența de materii fecale; și următoarele caracteristici:
a. este adesea asociată cu defecație imperioasă când însoțește SII sau proctita;
b. una dintre cauzele cele mai frecvente sunt afecțiunile neuromusculare;
c. constă în eliminarea involuntară a conținutului rectal;
d. poate avea ca substrat particularități tulburări psihomotoriale;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-2, d-1;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;

1800. F.d. cele două stări de care trebuie diferențiată diareea:
1. hiperdefecția (pseudodiareea);
2. incontinența de materii fecale; și următoarele caracteristici:

d. tratament anisecretor;
e. test pozitiv pentru $H_{2}P_{2}$;
f. EDS;
A. $b \rightarrow c \rightarrow e \rightarrow d \rightarrow f \rightarrow a$;
B. $c \rightarrow b \rightarrow e \rightarrow f \rightarrow d \rightarrow a$;
C. $c \rightarrow e \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow b \rightarrow f$;
D. $c \rightarrow e \rightarrow b \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow f$;
E. $f \rightarrow d \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow e \rightarrow a$.

1792. R.I. investigațiile suplimentare indicate dacă există elemente sugestive pentru o anumită patologie, f.d.u.
a. test respirator după ingestia de glucide;
b. scintigrafie de golire gastrică (pentru a depista o eventuală gastropareză);
c. teste serologice specifice;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-3, c-2;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;

Tulburările de tranzit

Diareea

1795. R.I. diaree, u.a.s.c.e.e.;
A. diareea reprezintă eliminarea de scaune lichidiene sau neformate cu frecvență crescută;
B. pentru adulți cu diaree ocazională tipică, eliminarea a mai mult de 200 g de scaun pe zi poate fi considerată diaree;
C. scăderea consistenței înseamnă că scaunul devine mai lichid;
D. diareea prin preluarea de apă apară la pacienți din centrele de îngrijire din cauza impactării materiei fecale;
E. mai mult de 90% dintre cazurile de diaree acută sunt funcționale;

1796. R.I. diaree, u.a.s.c.e.e.;
A. în fările dezvoltate cantitatea de scaun eliminat zilnic nu depășește 200 g;
B. de obicei pacientul relatează și scăderea consistenței și creșterea frecvenței scaunului;
C. frecvența normală a scaunelor variază între trei pe zi și unu pe săptămână;
D. impacarea materiilor fecale (ușor detectabilă prin tușeu rectal) poate fi urmată de diaree;
E. diareea de cauză infecțioasă este adesea însoțită de vărsături, febră și durere abdominală;
F. mai puțin de 10% dintre cazurile de diaree acută sunt și următoarele caracteristici:

Prescurtări frecvent folosite: c.e. = cu excepție; s.u.c.e.e. = sunt următoarele, cu excepție; u.a.s.c.e.e. = următoarele afirmări sunt corecte, cu excepție; s.c.f.e.e. = sunt corect formulate, cu excepție.

a. poate să apară și în hipertiroidism;
b. poate fi agravată sau provocată de diaree și de defecație imperioasă, mai ales dacă acestea sunt severe;
c. constă în eliminarea frecventă a unor mici cantități de scaun;
d. una dintre cauzele cele mai frecvente este patologia anorectală organică;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-1, d-2;
B. a-1, b-2, c-2, d-2;
C. a-2, b-1, c-1, d-2;
D. a-2, b-1, c-2, d-1;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;

1801. R.I. clasificarea diareei în funcție de durată, f.d.u. variante:
1. acută;
2. persistentă;
3. cronică;
și următoarele evaluări de durată:
a. <4 săptămâni;
b. <2 săptămâni;
c. 2-4 săptămâni;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;

Diareea acută

1802. F.d.u. evenimente/stări patologice r.i. diareea acută infecțioasă:
a. mucoasa intestinală se apără prin mecanisme imune și neimune;
b. infectarea sau lezarea acută a mucoasei intestinale;
c. agentul patogen ingerat depășește mecanismele de apărare ale mucoasei gazdei;
d. diaree;
care este lanțul causal corect:
A. $a \rightarrow c \rightarrow b \rightarrow d$;
B. $b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow a$;
C. $c \rightarrow d \rightarrow a \rightarrow b$;
D. $d \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow c$;
E. $d \rightarrow c \rightarrow a \rightarrow b$;

1803. R.I. diareea acută infecțioasă (DAI), u.a.s.c.e.e.;
A. cel mai adesea, DAI se transmite pe cale fecal-orală;
B. de obicei, DAI apare prin ingestia de alimente sau apă contaminate cu agenți patogeni din materiile fecale umane sau animale;
C. mecanismul de producere poate genera trăsături clinice

specifice care pot fi utile în stabilirea diagnosticului;
D. bacteriile invazive care produc inflamație provoacă simptome (vărsături, sângerare etc.) de severitate invers proporțională cu gradul inflamației;
E. SII postinfecțios este recunoscut prin complicație a diareei infecțioase;

1804. R.I. microflora colonică rezidentă, u.a.s.c.e.e.;
A. include >500 specii bacteriene distincte;
B. este principala cauză de diaree la persoanele imunocompetente;
C. favorizează infecția cu germeni patogeni;
D. perturbarea ei prin antibiotice poate duce la diaree ca urmare a proliferării unor bacterii patogene;
E. diminuarea ei favorizează persistența unor reziduuri alimentare care pot produce diaree;

1805. R.I. microflora colonică rezidentă, u.a.s.c.e.e.;
A. este necesară pentru fiziologia normală a colonului;
B. poate împiedica proliferarea agenților patogeni ingerai;
C. perturbarea ei prin antibiotice poate duce la diaree prin scăderea funcției digestive;
D. participă la digestia/ descompunerea alimentelor (care ajung până în colon);
E. reducerea ei prin antibiotice inhibă proliferarea lui Clostridium difficile;

1806. Mecanismele de apărare imune și neimune ale mucoasei gazdei includ u.c.e.;
A. secreția bicarbonat;
B. enzimele digestive;
C. secreția de mucus;
D. peristaltismul;
E. capacitatea inhibitoare a florei rezidente;

1807. R.I. diareea acută infecțioasă apasă, f.d.u. variante etiologice:
1. toxină (preformată, bacterii producătoare de enterotoxină);
2. bacterii enteroadherente;

și următoarele caracteristici:
a. diaree apasă abundentă (determinată de hipersecreția intestinului subțire);
b. diaree apasă mai puțin abundentă, vărsături mai puțin importante, crampe abdominale și balonare mai intense, febră mai înaltă;
c. febră înaltă și durere abdominală cu diaree sanguinolentă (numită dizenterie);
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, r.i. = referitor/referitoare la; u.i.d.f.d. = următoarele fragmente dintr-o frază despre;

ușoară-moderată, apoiă cu
granji (ca un terci):

b. incubajie: 1-3 zile, vărsături;
uşoare-marcate, durere
abdominală, moderată-marcată,
febră: marcată-severă, diaree:
uşoară-marcată, apăsătoare

c. incubajie scurtă (1-8 ore),
vărsături: marcate-severa,
durere abdominală: ușoară-

moderată, febră: absență~

moderată, febră, absență-
ușoară, diaree, marcată-severă,
apoză:

care sunt asocierile corecte:

A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;

1824. R.I. trăsăturile clinice ale diareii infecțioase acute în funcție de agentul cauzal și de mecanismul patogen al acestuia, f.d.u. variante:

1. *Clostridium perfringens* (producător de toxină – toxină preformată);
2. *Clostridium difficile* producător de citotoxină;
3. *Salmonella*, *Campylobacter*.

Aeromonas spp, Vibrio parahaemolyticus, Yersinia (invaziv, producând inflamație variabilă);
și următoarele tablouri clinice:
a. incubanțe: 12 ore-11 zile,
văstăturii absente-marcate,

durere abdominală: moderată-severă, febră: marcată-severă, diaree: ușoară-severă, apăsă

b. incubajile lungă (8-24 ore),
sau sanguinolentă;
vărsături marcate-severe

durere abdominală: ușoară-
moderată, febră: absență-

ușoară, diaree: marcată-severă,
apăsă;

c. incubajie: 1-3 zile, vârsături:
absența-încercare dură

abdominală: marcată-severă,

lebră; pînă la mîncare, diaree;
pînă la mîncare, de obicei

apăsă, uneori sanguinolentă;
care sunt asocierile corecte.

A. a-1, b-3, c-2;

b-2, b-3, c-1;
C-a-2, b-3, c-1;
b-2, b-3, c-3;
C-a-2, b-3, c-1;

D. 3, b-1, c-2
 D. 3, b-1, c-2
 D. 3, b-1, c-2

1825. R.1. trăsăturile clinice ale

diarei infecțioase acute în funcția
de agentul cauzal și de mecanism

nd date, I.d.u. = hind date următoare, r.i. =

o-adesa despre,

mul patogen al acestuia, f.d.u.	C. listerioză;	d. arsenic;	A. diaree abundentă cu deshidratare;	D. a-3, b-1, c-2;	1. regiunile endemice din America Latină, Africa și Asia;
varianta:	D. legioneloză;	e. insecticide organofosforice;	B. durată >2 luni fără ameliorare;	E. a-3, b-2, c-1;	2. Rusia (mai ales St. Petersburg), zone sălbatice (carnapare, inot);
1. Vibrio cholerae, Escherichia coli enterotoxigenă, Klebsiella pneumoniae, Aeromonas spp (produsător de toxină - enterotoxină);	E. sindrom de șoc toxic;	care sunt asociate corecte:	C. comunitate;	1840. Printre cele cinci grupuri de persoane cu risc crescut de a dezvolta diaree acută se află u.c.e.;	3. Nepal;
2. E. coli hemoragică produsătoare de citotoxină;	1828. R.I. diareea acută de alte cauze decât infecțioase, u.a.s.c.g.e.;	A. a-1, b-1, c-1, d-2, e-2;	D. pacienți tineri;	A. călători/turști;	4. vase de croazieră;
3. Shigella spp, E. coli enteroinvazivă, Entamoeba histolytica (invaziv, producând inflamație severă);	A. efectele secundare ale medicamentelor sunt o cauză rară de diaree acută;	D. a-1, b-2, c-1, d-2, e-1;	E. pacienți cu imunodeficiență;	B. cei care consumă anumite alimente;	și următorii agenți etiologici:
și următoarele tablouri clinice:	B. numeroase medicamente pot produce diaree;	1832. R.I. cauzele neinfecțioase de diaree acută, f.d.u. categorii:	1837. R.I. diagnosticul în diareea acută s.u.c.g.e.;	C. persoane cu boli autoimune;	a. Cyclospora;
a. incubajie: 12 ore-8 zile, vârstă: absente- ușoare, durere abdominală: marcată-severă, febră: marcată-severă, diaree: ușoară-moderată, sânguinoasă;	C. diareea acută poate fi un simptom în boala grefă-contragrefă;	1. medicamente;	A. investigația esențială la pacienții suspecți de diaree infecțioasă acută severă este analiza microbiologică a scaunului;	D. persoane care solicită consultăți în centre de diagnostic private;	b. Giardia;
b. incubajie: 12-72 ore, vârstă: absente- ușoare, durere abdominală: marcată-severă, febră: ușoară-moderată, diaree: ușoară-moderată, sânguinoasă;	D. toxinele din viețări marine produc intoxicații precum ciguatera și scombroid;	2. toxine;	B. tehnicile moleculare constau în identificarea în scaun a unor secvențe de ADN unice pentru diverși agenți patogeni;	E. persoanele instituționalizate;	c. cel mai adesea Escherichia coli enterotoxigenă sau enterococagativă, dar și Campylobacter, Shigella, Aeromonas, norovirus, Coronavirus și Salmonella;
c. incubajie: 8-72 ore, vârstă: moderate-severe, durere abdominală: ușoară-moderată, febră: absență-ușoară, diaree: marcată-severă, apoasă;	E. diareile inflamatoare cronice (cum sunt BIC) pot avea un debut brusc, în loc de insidios, și diverse alte manifestări care simulează o infecție;	a. amonite antidiuretice;	C. dacă analiza scaunului nu este lămuritoare, se recurge la irigografie;	1841. R.I. grupurile cu risc crescut de a dezvolta diaree, u.a.s.c.g.e.;	d. virusul Norwalk;
care sunt asociate corecte:	1829. R.I. diareea acută de alte cauze decât infecțioase, u.a.s.c.g.e.;	care sunt asociate corecte:	D. la nevoie, se practică sigmoidoscopie flexibilă cu biopsii și EDS cu aspirate și biopsii duodenale;	A. aproape 40% dintre persoanele care vizitează regiunile endemice din America Latină, Africa și Asia dezvoltă așa-	care sunt asociate corecte:
1. sindrom Reiter (artrită, uretrită și conjunctivită);	C. diverse toxine pot provoca diaree acută, adesea asociată cu decompensare sistemică;	A. a-1, b-1, c-1, d-2, e-2;	E. un anumit context clinic și epidemiologic poate sugera un agent enteropatogen specific;	B. pe vasele de croazieră apar epidemii de gastroenterită determinată de virus E. coli; d-1;	A. a-3, b-1, c-4, d-2;
2. tiroidă, pericardită și glomerulonefrită autoimună;	D. afecțiunile care determină diaree cronică pot fi confundate inițial cu o diaree acută;	B. a-1, b-2, c-2, d-1, e-1;	1838. R.I. diagnosticul în diareea acută prin analiza microbiologică a scaunului, f.d.u. tehnici:	E. a-4, b-3, c-2, d-1;	A. a-3, b-2, c-1, d-4;
3. sindrom hemolitic-uremic (care are o mortalitate înaltă);	E. decizia de a evalua o diaree acută depinde de severitatea și durata ei și de diverși factori care în de gazdă;	C. a-2, b-1, c-1, d-2, e-1;	1. cultură;	1844. R.I. diareea care apare la cei care consumă anumite alimente, f.d.u. alimente:	D. a-3, b-4, c-1, d-2;
și următorii agenți etiologici:	1830. R.I. colita ischemică, u.a.s.c.g.e.;	D. a-2, b-3, c-1;	2. examen microscopic direct;	1. carne de pui;	E. a-4, b-3, c-2, d-1;
a. Salmonella, Campylobacter, Shigella, Yersinia;	A. poate fi ocluzivă sau neocluzivă;	E. a-3, b-2, c-1;	3. teste imunologice;	2. orez prăjit;	și următorii agenți etiologici:
b. E. coli (O157:H7) și Shigella enterohemoragică;	B. apare în mod tipic la persoane cu vârstă sub 50 ani;	1834. U.f.d.f. evaluarea pacienților cu diaree acută s.c.f.g.e.;	și următorii agenți etiologici sau produși ai acestora:	3. ouă;	a. Salmonella, Campylobacter, Shigella;
c. Yersinia;	C. se prezintă adesea cu durere abdominală inferioară acută, urmată de diaree apoasă, apoi sânguinoasă;	1835. U.f.d.f. evaluarea pacienților cu diaree acută s.c.f.g.e.;	a. anume toxine bacteriene (C. difficile), antigene virale (Rotavirus) și antigene de protozoare (Giardia, E. histolytica);	și următorii agenți etiologici:	b. Bacillus cereus;
care sunt asociate corecte:	D. determină în general modificări inflamatoare acute în sigmoid sau în colonul stâng;	1836. F.d.u. manifestări sistemice care pot însoți sau urma o diaree infecțioasă.	b. ouă și paraziți;	a. E. coli enterohemoragică (O157:H7);	c. Salmonella;
A. a-1, b-2, c-3;	E. de regulă afectează rectul;	1. sindrom Reiter (artrită, uretrită și conjunctivită);	c. bacterii și virusuri;	b. Vibrio spp. Salmonella sau virus hepatitic A;	d. Staphylococcus aureus sau Salmonella;
B. a-1, b-3, c-2;	A. apare în mod tipic la persoane cu vârstă sub 50 ani;	2. tiroidă, pericardită și glomerulonefrită autoimună;	care sunt asociate corecte:	c. Staphylococcus aureus sau Salmonella;	care sunt asociate corecte:
C. a-2, b-1, c-3;	C. se prezintă adesea cu durere abdominală inferioară acută, urmată de diaree apoasă, apoi sânguinoasă;	3. sindrom hemolitic-uremic (care are o mortalitate înaltă);	A. a-1, b-2, c-3;	1. hamburger insuficient preparat termic;	A. a-1, b-2, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;	E. durerea abdominală severă asociată la pacienți >50 ani;	și următorii agenți etiologici:	B. a-1, b-3, c-2;	2. maioneză sau cremă;	B. a-1, b-3, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;	A. bronhiodilatatoare;	a. Salmonella, Campylobacter, Shigella, Yersinia;	C. a-2, b-1, c-3;	3. viețări marine, mai ales consumate crude;	C. a-2, b-1, c-3;
1827. C.d.u. NU reprezintă o infecție sistemică în care diareea acută poate fi un simptom major:	b. AINS;	b. E. coli (O157:H7) și Shigella enterohemoragică;	D. a-2, b-3, c-1;	și următorii agenți etiologici:	D. a-2, b-3, c-1;
A. pneumonia pneumococică;	c. antibiotice, chimioterapice;	care sunt asociate corecte:	E. a-3, b-2, c-1;	a. E. coli enterohemoragică (O157:H7);	E. a-3, b-2, c-1;
B. hepatită virală.	1828. R.I. diareea care apare la călători/turști, f.d.u. destinații turistice:	1829. R.I. diareea acută de alte cauze decât infecțioase, u.a.s.c.g.e.;	după consumul anumitor alimente, diareea apare la scurt timp după un picnic, banchet, masă la restaurant;	b. Virus spp. Salmonella sau virus hepatitic A;	
		1830. R.I. colita ischemică, u.a.s.c.g.e.;	C. la persoana cu imunodeficiență agenți patogeni intestinali obișnuiți provoacă adesea o diaree mai severă și mai prelungită;	c. Staphylococcus aureus sau Salmonella;	
		1831. R.I. cauzele neinfecțioase de diaree acută, f.d.u. categorii:	D. pacienții cu hemocromatoză ar trebui să evite consumul de orez fier;		
		1. medicamente;	1842. R.I. grupurile cu risc crescut de a dezvolta diaree, u.a.s.c.g.e.;		
		2. toxine;	A. a-1, b-2, c-3;		
		și următorii agenți etiologici:	B. a-1, b-3, c-2;		
		a. bronhiodilatatoare;	C. a-2, b-1, c-3;		
		b. AINS;	D. a-2, b-3, c-1;		
		c. antibiotice, chimioterapice;	E. a-3, b-2, c-1;		

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dăruie următoarele; f.d. = fiind date; f.d.u. = fiind date următoarele, r.l. = referitor/referitoare la; U.f.d.f. = Următoarele fragmente dintr-o frază despres.

A. diaree abundentă cu deshidratare;	D. a-3, b-1, c-2;	1. regiunile endemice din America Latină, Africa și Asia;
B. durată >2 luni fără ameliorare;	E. a-3, b-2, c-1;	2. Rusia (mai ales St. Petersburg), zone sălbatice (carnapare, inot);
C. comunitate;	1840. Printre cele cinci grupuri de persoane cu risc crescut de a dezvolta diaree acută se află u.c.e.;	3. Nepal;
D. pacienți tineri;	A. călători/turști;	4. vase de croazieră;
E. pacienți cu imunodeficiență;	B. cei care consumă anumite alimente;	și următorii agenți etiologici:
1837. R.I. diagnosticul în diareea acută s.u.c.g.e.;	C. persoane cu boli autoimune;	a. Cyclospora;
A. investigația esențială la pacienții suspecți de diaree infecțioasă acută severă este analiza microbiologică a scaunului;	D. persoane care solicită consultăți în centre de diagnostic private;	b. Giardia;
B. tehnicile moleculare constau în identificarea în scaun a unor secvențe de ADN unice pentru diverși agenți patogeni;	E. persoanele instituționalizate;	c. cel mai adesea Escherichia coli enterotoxigenă sau enterococagativă, dar și Campylobacter, Shigella, Aeromonas, norovirus, Coronavirus și Salmonella;
C. dacă analiza scaunului nu este lămuritoare, se recurge la irigografie;	1841. R.I. grupurile cu risc crescut de a dezvolta diaree, u.a.s.c.g.e.;	d. virusul Norwalk;
D. la nevoie, se practică sigmoidoscopie flexibilă cu biopsii și EDS cu aspirate și biopsii duodenale;	A. aproape 40% dintre persoanele care vizitează regiunile endemice din America Latină, Africa și Asia dezvoltă așa-	care sunt asociate corecte:
E. un anumit context clinic și epidemiologic poate sugera un agent enteropatogen specific;	B. pe vasele de croazieră apar epidemii de gastroenterită determinată de virus E. coli; d-1;	A. a-3, b-1, c-4, d-2;
1838. R.I. diagnosticul în diareea acută prin analiza microbiologică a scaunului, f.d.u. tehnici:	C. a-3, b-2, c-1, d-4;	A. a-3, b-2, c-1, d-4;
1. cultură;	D. a-3, b-4, c-1, d-2;	E. a-4, b-3, c-2, d-1;
2. examen microscopic direct;	E. a-4, b-3, c-2, d-1;	și următorii agenți etiologici:
3. teste imunologice;	1844. R.I. diareea care apare la cei care consumă anumite alimente, f.d.u. alimente:	a. Salmonella, Campylobacter, Shigella;
și următorii agenți etiologici sau produși ai acestora:	1. carne de pui;	b. Bacillus cereus;
a. anume toxine bacteriene (C. difficile), antigene virale (Rotavirus) și antigene de protozoare (Giardia, E. histolytica);	2. orez prăjit;	c. Salmonella;
b. ouă și paraziți;	3. ouă;	d. Staphylococcus aureus sau Salmonella;
c. bacterii și virusuri;	și următorii agenți etiologici:	e. Shigella;
care sunt asociate corecte:	a. Salmonella, Campylobacter, Shigella;	f. Bacillus cereus;
A. a-1, b-2, c-3;	1. hamburger insuficient preparat termic;	g. Salmonella;
B. a-1, b-3, c-2;	2. maioneză sau cremă;	h. Salmonella;
C. a-2, b-1, c-3;	3. viețări marine, mai ales consumate crude;	i. Staphylococcus aureus sau Salmonella;
D. a-2, b-3, c-1;	și următorii agenți etiologici:	j. Staphylococcus aureus sau Salmonella;
E. a-3, b-2, c-1;	a. E. coli enterohemoragică (O157:H7);	k. Staphylococcus aureus sau Salmonella;
1839. R.I. diagnosticul în diareea acută prin teste imunologice din scaun, f.d.u. categorii:	b. Virus spp. Salmonella sau virus hepatitic A;	l. Staphylococcus aureus sau Salmonella;
1. anume toxine bacteriene;	c. Staphylococcus aureus sau Salmonella;	m. Staphylococcus aureus sau Salmonella;
2. antigene virale;	d. Staphylococcus aureus sau Salmonella;	n. Staphylococcus aureus sau Salmonella;
3. antigene de protozoare;	e. Staphylococcus aureus sau Salmonella;	o. Staphylococcus aureus sau Salmonella;
și următorii agenți etiologici:	f. Staphylococcus aureus sau Salmonella;	p. Staphylococcus aureus sau Salmonella;
a. Giardia, E. histolytica;	g. Staphylococcus aureus sau Salmonella;	q. Staphylococcus aureus sau Salmonella;
b. Rotavirus;	h. Staphylococcus aureus sau Salmonella;	r. Staphylococcus aureus sau Salmonella;
c. C. difficile;	i. Staphylococcus aureus sau Salmonella;	s. Staphylococcus aureus sau Salmonella;
care sunt asociate corecte:	j. Staphylococcus aureus sau Salmonella;	t. Staphylococcus aureus sau Salmonella;
A. a-1, b-2, c-3;	k. Staphylococcus aureus sau Salmonella;	u. Staphylococcus aureus sau Salmonella;
B. a-2, b-1, c-3;	l. Staphylococcus aureus sau Salmonella;	v. Staphylococcus aureus sau Salmonella;
C. a-2, b-3, c-1;	m. Staphylococcus aureus sau Salmonella;	w. Staphylococcus aureus sau Salmonella;
D. a-2, b-3, c-1;	n. Staphylococcus aureus sau Salmonella;	x. Staphylococcus aureus sau Salmonella;
E. a-3, b-2, c-1;	o. Staphylococcus aureus sau Salmonella;	y. Staphylococcus aureus sau Salmonella;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dăruie următoarele; f.d. = fiind date; f.d.u. = fiind date următoarele, r.l. = referitor/referitoare la; U.f.d.f. = Următoarele fragmente dintr-o frază despres.

1846. R.I. imunodeficiență drept factor de risc pentru diaree, f.d.u. variate:	2. persoanele care frecventează centre de îngrijire de zi și membrii familiei;	1853. U.f.d.d. cauzele diareii s.c.f.g.e.:
1. imunodeficiență primară;	3. pacienții din spitale și instituții de îngrijire pe termen lung; și următorii agenți etiologici:	A. Cauzarea unor leziuni organice prin tehnici imagistice;
2. imunodeficiență secundară; și următoarele stări patologice:	a. SIDA;	B. poate fi necesară ca abordare;
a. SIDA;	b. defici de IgA;	C. inițială la pacienții suspecți de diaree acută neinfecțioasă;
b. defici de IgA;	c. boala granulomatoasă cronică;	D. cum ar fi cea determinată de:
d. imunosupresie medicamentasă;	Treponema pallidum,	E. colita ischemică, diverticulită sau sindromul de intestin iritabil.
e. vârstă înaintată;	Chlamydia;	
f. hipogamaglobulinemie;	c. diverse microorganisme, cel mai adesea de Clostridium difficile;	
care sunt asocierile corecte:	care sunt asocierile corecte:	
A. a-1, b-1, c-2, d-2, e-2, f-1;	A. a-1, b-2, c-3;	
B. a-1, b-2, c-1, d-1, e-2, f-2;	B. a-2, b-1, c-3;	
C. a-1, b-2, c-1, d-2, e-1, f-2;	C. a-2, b-3, c-1;	
D. a-2, b-1, c-1, d-2, e-2, f-1;	D. a-3, b-1, c-2;	
E. a-2, b-2, c-1, d-1, e-2, f-1;	E. a-3, b-2, c-1;	
1847. R.I. diareea care apare la persoanele cu SIDA, f.d.u. categorii:	1. germeni oportuniști;	
2. virusuri;	3. protozoare;	
și următorii agenți etiologici:	a. VCM, adenovirus, VHS;	
b. Cryptosporidium, Isospora belli, Microsporidia, Blastocystis hominis;	c. Mycobacterium spp.;	
care sunt asocierile corecte:	A. a-1, b-2, c-3;	
A. a-1, b-2, c-3;	B. a-1, b-3, c-2;	
B. a-1, b-3, c-2;	C. a-2, b-1, c-3;	
C. a-2, b-1, c-3;	D. a-2, b-3, c-1;	
D. a-2, b-3, c-1;	E. a-3, b-1, c-2;	
E. a-3, b-1, c-2;		
1848. R.I. diareea care apare la persoanele cu imunodeficiență, f.d.u. categorii:	1. pacienți cu SIDA;	
2. pacienți cu hemocromatoză;	3. persoanele instituționalizate;	
și următorii agenți etiologici:	a. diverse microorganisme, cel mai adesea de Clostridium difficile;	
a. diverse microorganisme, cel mai adesea de Clostridium difficile;	b. Vibrio spp., Yersinia;	
b. Vibrio spp., Yersinia;	c. germeni oportuniști, anumiți virusuri, protozoare;	
c. germeni oportuniști, anumiți virusuri, protozoare;	care sunt asocierile corecte:	
care sunt asocierile corecte:	A. a-1, b-2, c-3;	
A. a-1, b-2, c-3;	B. a-1, b-3, c-2;	
B. a-1, b-3, c-2;	C. a-2, b-3, c-1;	
C. a-2, b-3, c-1;	D. a-3, b-1, c-2;	
D. a-3, b-1, c-2;	E. a-3, b-2, c-1;	
E. a-3, b-2, c-1;		
1849. R.I. diareea care apare la persoanele cu imunodeficiență, f.d.u. categorii:	1. pacienți cu SIDA (pacienți transmiși veneric pe cale rectală);	

1850. U.f.d.d. cauzele diareii s.c.f.g.e.:	A. Dacă circumstanțele indică un anumit agent patogen sau un grup de posibili agenți patogeni, B. fie poate să nu mai fie necesar tot setul de investigații de rutină;	1851. R.I. cauzele de diaree persistentă, f.d.u. categorii:
C. fie, în unele cazuri, pot fi indicate culturi speciale pentru;	D. diverse tulpini de E. coli (enterohemoragice etc.);	1. cauzele frecvențiale;
		2. trebuie avută în vedere mai ales la pacienții care au primit antibiotice;
		3. altele cauză/le care trebuie luate în seamă;
		și următorii agenți etiologici:
		a. Giardia;
		b. C. difficile;
		c. E. histolytica, Cryptosporidium, Campylobacter etc.;
		care sunt asocierile corecte:
		A. a-1, b-2, c-3;
		B. a-1, b-3, c-2;
		C. a-2, b-1, c-3;
		D. a-2, b-3, c-1;
		E. a-3, b-1, c-2;
		1852. U.f.d.d. cauzele diareii s.c.f.g.e.:
		A. Cauzarea unor leziuni organice prin tehnici;
		B. imagistice (sigmoidoscopie, colonoscopie, TC abdominală);
		C. pentru a exclude o BIC;
		D. de regulă nu este necesară;
		E. la pacienți cu diaree persistentă de cauză neclară.

1854. R.I. diareea cronică, u.a.s.c.g.e.:	A. o diaree care durează >4 săptămâni justifică evaluarea pentru a exclude o patologie subiacentă gravă;	1855. F.d.u. afirmații r.I. diareea secretorie:
B. spre deosebire de diareea acută, majoritatea cauzelor de diaree cronică sunt infecțioase;	C. clasificarea diareii cronice în funcție de mecanismul fiziopatologic facilitează abordarea rațională a tratamentului;	a. osmolaritatea scaunului este explicată de electroliții endogeni normali;
D. multe boli provoacă diaree prin mai multe mecanisme;	E. malabsorbția acizilor biliari poate induce diaree prin stimularea secreției colonice;	b. nu există un solvii malabsorbiți, c. nu există gaură osmotică fecală;
		care este înălțimea logică justă:
		A. a→b→c;
		B. a→c→b;
		C. b→a→c;
		D. b→c→a;
		E. c→a→b;
		1856. F.d.u. afirmații r.I. una dintre formele de diaree secretorie:
		a. supratrala mucoasei intestinale disponibile pentru reabsorbția lichidelor și a electroliților secretarii devine insuficientă;
		b. scade supratrala mucoasei intestinale;
		c. apare diaree de tip secretor, care este înălțimea logică justă:
		A. a→b→c;
		B. b→a→c;
		C. b→c→a;
		D. c→a→b;
		E. c→b→a;
		1857. F.d.u. afirmații r.I. una dintre formele de diaree secretorie:
		a. leonul terminal este lezată sau

Prescurtări frecvent folosite: c.g. = cu excepție; s.u.c.g. = sunt următoarele, cu excepție; u.a.s.c.g. = următoarele afirmații sunt corecte, cu excepție; s.c.f.g.e. = sunt corect formulate, cu excepție.

b. acizii biliari diluți în sân meabsoarbți;	c. leziuni ale mucoasei intestinale;	1865. R.I. diareea secretorie, u.a.s.c.g.e.:
c. acizii biliari stimulează secreția colonică;	d. diaree colonică;	A. se elimină materii fecale apase, în cantitate mare;
care este înălțimea logică justă:	A. a-b-b-c-a-d;	B. hormonii sunt cea mai frecventă cauză de diaree secretorie;
B. b-c-a-a-d;	C. a-1, b-3, c-2, d-1;	C. lezarea enterocitolilor prin consum cronic de etanol poate accentua absorbția de sodiu și apă;
D. a-2, b-3, c-1, d-1;	E. a-3, b-1, c-1, d-2;	
1862. R.I. cauzele diareii secretorii, f.d.u. categorii:	1. laxative stimulante;	D. absorbția electroliților din tubul digestiv este mediata de anumiți transportori ioni specifici;
2. ocuzia intestinală incompletă;	3. scăderea suprafeței mucoasei intestinale;	E. printru manifestările bolii Addison se află diareea apasă și hiperpigmentarea cutanată;
și următoarele cauze:	a. impacteria fecală;	1866. R.I. diareea secretorie, u.a.s.c.g.e.:
b. Cascară;	c. fistule enterocolice;	A. eliminarea scaunelor diareice este dureroasă;
d. ulei de ricin;	care sunt asocierile corecte:	B. tumorile carcinomale metastatice gastrointestinale pot produce diaree apasă, izolată sau ca parte a sindromului carcinolitic;
A. a-1, b-1, c-3, d-2;	B. a-1, b-2, c-3, d-1;	C. la diareea secundară consumului cronic de etanol contribuie încetinirea tranzitului intestinal;
C. a-1, b-3, c-1, d-2;	D. a-2, b-1, c-3, d-1;	D. razele, defectele ale anurilor transportori ioni specifici determină diaree apasă de la naștere;
E. a-3, b-2, c-1, d-1;		E. poate fi consecința unor substanțe endogene cu efect laxativ;
1863. R.I. cauzele diareii secretorii, f.d.u. categorii:	1. laxative stimulante;	1867. R.I. diareea secretorie, u.a.s.c.g.e.:
2. ocuzia intestinală incompletă;	3. scăderea suprafeței mucoasei intestinale;	A. scaunele diareice încetăzesc dacă se sistază aportul alimentar;
B. rareori, tumorile carcinomale bronșice primare pot produce diaree apasă, izolată sau ca parte a sindromului carcinolitic;	C. a-1, b-3, c-2, d-1;	D. ingestia din greșeală a anurilor toxice ambientale poate determina forme cronice de diaree mai degrabă decât acute;
1864. R.I. diareea secretorie, u.a.s.c.g.e.:	A. cauza este perturbarea transportului apei și electroliților prin mucoasa enterocolonică;	B. medicamentele și toxinele ingerate cronic sunt o cauză rară de diaree secretorie cronică;
B. în mod caracteristic, apare gaură osmotică fecală;	C. poate fi provocată de utilizarea nejustificată/ excesivă/ repetată a laxativelor stimulante;	1868. R.I. diareea secretorie, u.a.s.c.g.e.:
D. defectele congenitale de absorbție a electroliților pot provoca diaree apasă de la naștere;	E. prin efectul laxativ, acizii biliari diluți pot provoca o diaree secretorie;	A. nu există un solv malabsorbit;
1865. R.I. cauzele diareii secretorii, f.d.u. categorii:	1. laxative stimulante;	B. medicamentele și toxinele ingerate cronic sunt o cauză rară de diaree secretorie cronică;
2. ocuzia intestinală incompletă;	3. scăderea suprafeței mucoasei intestinale;	C. ingestia cronică de arsenic poate determina o formă cronică de diaree, mai degrabă decât acută;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele; R.I. = întrebare; referențiere la, U.f.d.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază descriptivă.

D. deficitul de antiport (schimbător ionic) Cl^-/HCO_3^- provoacă cloridoreea congenitală;
E. în unele cazuri, cauza diareei secretorii rămâne necunoscută (idiopatică);
1869. R.I. diareea secretorie, u.a.s.c.c.e.;
A. osmolaritatea scaunului este explicată de electroliții endogeni normali;
B. sute de medicamente au ca efect advers diareea;
C. uneori, anumiți infecții bacteriene persistente pot produce o diaree de tip secretor;
D. deficitul de antiport (schimbător ionic) Na^+/H^+ provoacă diaree asociată cu alcaloză;
E. lezarea sau rezecția jejunului proximal poate determina diareea secretorie prin scăderea suprafeței mucoasei intestinale;
1870. R.I. diareea secretorie prin scăderea suprafeței mucoasei intestinale, u.a.s.c.c.e.;
A. reabsorbția insuficientă a lichidelor și electroliților secretați poate produce diaree;
B. spre deosebire de alte forme de diaree secretorie, acest tip de diaree tinde să se amelioreze după ingestia de alimente;
C. leziunile ileale din ileita Crohn pot determina o diaree de tip secretor;
D. acizii biliari dihidroxil rămași neabsorbiți inhibă secreția colonică;
E. ocluzia intestinală incompletă poate determina, în mod paradoxal, creșterea eliminării de materii fecale din cauza hipersecreției de lichide;
1871. R.I. diareea secretorie de cauză hormonală, f.d.u. stări patologice:
1. tumoră carcinoidă;
2. gastromim;
3. carcinom medular tiroidian; a. provoacă ocluzia pancreatică;
b. diareea este provocată de eliberarea în circulație a unor substanțe puternic secretagoge produse de intestine;
c. în 25-50% din cazuri este parte a sindromului de neoplazii endocrine multiple tip 2a; care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
1874. R.I. diareea secretorie de cauză hormonală, f.d.u. stări patologice:
1. gastromim;
2. VIPom;
3. carcinom medular tiroidian; a. diareea secretorie este adesea masivă, volumul scaunului depășind 3 L/zi;
care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
1877. R.I. diareea secretorie de cauză hormonală, f.d.u. stări patologice:
1. gastromim;
2. VIPom;
3. carcinom medular tiroidian; a. rareori pot să apară leziuni cutanate pelagoidice ca urmare a supraproducerii de serotonină, care duce la depleția de niacină;
b. apare cel mai adesea sporadic, dar în 25-50% din cazuri în asociere cu alte tumori neuroendocrine;
c. sindromul diaree-apoasă-hipokalemie-aciroidie; care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-1, c-2;
1878. R.I. diareea secretorie de cauză hormonală, f.d.u. stări patologice:
1. gastromim;
2. VIPom;
3. mastocitoză sistemică; și următoarele trăsături:
a. poate fi asociată cu urticarie pigmentară;
b. secretați VIP și mulți alți hormoni peptidici;
c. se prezintă de obicei cu ulcere peptice refractare; care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-1, c-2;
1879. R.I. diareea secretorie de cauză hormonală, f.d.u. stări patologice:
1. VIPom;
2. mastocitoză sistemică; și următoarele trăsături:
a. rareori apare o diaree secretorie care pare să fie mediată de prostaglandine (poate fi inhibată de AINS); b. poate provoca diaree inflamatorie (determinată de

a. diareea este cel mai adesea provocată de maldigestia grăsimilor din cauza inactivării enzimelor pancreatice prin pH-ul scăzut din duoden;
b. rareori apare o diaree secretorie care poate provoca hipokalemie;
c. secretați polipeptida pancreatică, secretină, gastrină, polipeptida inhibitoare pentru gastrină (numită și peptida insulinotropă) dependentă de glucoră, neurotensină, calcitonină și prostaglandine; care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-3, c-2;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
1878. În legătură cu diareea secretorie de cauză hormonală, f.d.u. stări patologice:
1. carcinom medular tiroidian; 2. VIPom;
3. tumoră carcinoidă; și următoarele trăsături:
a. se poate asocia cu feocromocitom și tumori paratiroidiene cu hiperparatiroidism;
b. poate produce: deshidratare amenințătoare de viață, disfuncție neuromusculară (din cauza hipokalemiei, hipomagnezimei sau hipocalcemiei asociate), înroșire, hiperglicemie;
c. diareea este provocată de eliberarea în circulație de serotonină, histamină, prostaglandine și diverse kinine; care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
1879. R.I. diareea secretorie de cauză hormonală, f.d.u. stări patologice:
1. VIPom;
2. mastocitoză sistemică; 3. adenom vilos colorectal mare; și următoarele trăsături:
a. rareori apare o diaree secretorie care pare să fie mediată de prostaglandine (poate fi inhibată de AINS); b. poate provoca diaree inflamatorie (determinată de

infiltrare intestinală cu mastocite);
c. au fost raportate volume zilnice de până la 20 L; care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;
1880. U.f.d.f. diareea osmotică s.c.f.c.e.;
A. Determinarea osmolarității fecale este obligatorie întrucât B. doar dacă este măsurată imediat după evacuare;
C. osmolaritatea fecală poate fi greșită, deoarece:
D. glucidele sunt metabolizate de bacteriile colonice;
E. determinând scăderea osmolarității.
1881. R.I. diareea osmotică, u.a.s.c.c.e.;
A. diareea osmotică este provocată de solvii ingerați puțin absorbabili și activi osmotici;
B. în mod caracteristic, diareea osmotică se oprește când înce-tează ingestia substanței cauzatoare;
C. laxativele care conțin Mg^{2+} , PO_4^{3-} , SO_4^{2-} pot provoca diaree osmotică;
D. diareea osmotică poate să apară după ingestia de glucide slab/incomplet absorbibile;
E. deficitul de lactază afectează predominant persoanelor caucaziene;
1882. R.I. diareea osmotică, u.a.s.c.c.e.;
A. diareea osmotică este provocată de substanțe insolubile care precipită în lumenul intestinal;
B. gura osmotică este calculată drept osmolaritatea serică (de obicei 290 mosmol/kg) - [2 x (concentrația fecală a sodiului + potasiului)];
C. malabsorbția glucidelor poate fi determinată de defecte dobândite sau congenitale ale dizaharidazelor și ale altor enzime din marginea în perie;
D. fiind absorbite deficitar, sorbitolul, lactuloza și fructoza pot provoca diaree osmotică;
E. deficitul de lactază este una dintre cele mai frecvente cauze de diaree cronică la adulți;

1883. R.I. diareea osmotică, u.a.s.c.c.e.;
A. diareea osmotică este cantitativ proporțională cu cantitatea de solvii ingerată;
B. unele antiacide, laxative și suplimente nutritive pot induce diaree osmotică prin conținutul în compuși cu aluminiu;
C. malabsorbția glucidelor provoacă diaree osmotică cu pH scăzut;
D. medicamentele, guma, bom-boanele indurite cu glucoză slab absorbabile pot provoca diaree osmotică;
E. simptomele deficitului de lactază depind de cantitatea totală de lactoză ingerată;
1884. R.I. diareea osmotică, u.a.s.c.c.e.;
A. în mod caracteristic, diareea osmotică este agravată de oprirea aportului alimentar;
B. ingestia de prosoși cu calciu poate induce diaree osmotică caracterizată de un scaun cu gaură osmotică importantă (>50 mosmol/L);
C. defectele dobândite sau congenitale ale dizaharidazelor și ale altor enzime din marginea în perie duc la diaree osmotică cu un pH scăzut;
D. fiind absorbit deficitar, polietilenglicolul poate provoca diaree osmotică;
E. la majoritatea pacienților cu deficit de lactază, suplimentele enzimatică sunt inutile întrucât aceștia învață să evite laptele;
1885. R.I. steatoree, u.a.s.c.c.e.;
A. malabsorbția grăsimilor poate provoca diaree cu scaun carac-teristic;
B. efectele osmotice ale acizilor grași sunt anulate de hidroxilarea bacteriană;
C. maldigestia apare când cel puțin 30% din funcția secretorie a pancreasului este pierdută;
D. în ciroza biliară și în obstrucția biliară poate să apară o steatoree ușoară;
E. un tablou clinic și histologic similar cu boala Whipple este provocată de infecția cu *Mycobacterium avium-intracelulare* la pacienți cu SIDA;
1886. R.I. steatoree, u.a.s.c.c.e.;
A. în mod caracteristic, scaunul este gras și malodor;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date; f.d.u. = fiind date următoarele; f.i. = referitor/folositoare la; U.f.d.f. = Următoarele fragmente dintr-o frază desprse;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date; f.d.u. = fiind date următoarele; f.i. = referitor/folositoare la; U.f.d.f. = Următoarele fragmente dintr-o frază desprse;

- B. steatoarea este definită drept o cantitate excesivă de grăsime în scaun.
- C. maldigestia intraluminală este cel mai adesea provocată de sindromul de intestin iritabil.
- D. unul dintre mecanisme prin care fundoplicatura poate provoca steatoarea este înclinația golii gastrice.
- E. limfangiectazia intestinală congenitală este o boală rară care provoacă steatoarea prin obstrucția limfaticelor.
1887. R.I. steatoarea, u.a.s.c.g.e.:
A. în mod caracteristic, scaunul plutește în apa din toaletă;
B. în mod normal cantitatea de grăsime din scaun depășește 7 g/zi;
C. somatostatinomul este cea mai frecventă cauză de insuficiență exocrină pancreatică;
D. numeroase medicamente pot provoca steatoarea prin maldigestie;
E. spune tropical poate produce un tablou histopatologic și clinic similar cu boala celiacă.
1888. R.I. steatoarea, u.a.s.c.g.e.:
A. maldigestia grăsimilor provocă adesea creșterea în greutate;
B. o diaree cu tranzit rapid poate determina creșterea grăsimii fecale până la 14 g/zi;
C. pancreatita cronică este de obicei consecința abuzului de etanol;
D. colichina poate provoca steatoarea prin maldigestie;
E. spune tropical apare la persoanele care domiciliază sau călătoresc în climate tropicale.
1889. R.I. steatoarea, u.a.s.c.g.e.:
A. maldigestia grăsimilor provocă adesea carențe nutritive din cauza maldigestiei conținute a aminoacizilor și a vitaminelor;
B. în bolile intestinului subțire grăsimea fecală este în medie 15-25 g/zi;
C. pancreatita cronică este o cauză rară de insuficiență pancreatică;
D. colestiramina poate provoca steatoarea prin maldigestie;
E. debutul insiduos și lipsa de răspuns la antibiotice sugerează că spune tropical are o etiologie infecțioasă.
1890. R.I. steatoarea, u.a.s.c.g.e.:
A. creșterea cantității de materii fecale este determinată de efectele osmotice ale acizilor grași și, în-o mică măsură, de grăsimi neutre;
B. în insuficiența pancreatică exocrină grăsimea fecală depășește adesea 32 g/zi;
C. proliferarea bacteriană în intestinul subțire este mai frecventă la copii;
D. neomicina poate provoca steatoarea prin maldigestie;
E. obstrucția limfaticelor determină steatoarea, dar afectează mai ales absorbția glucidelor și a aminoacizilor.
1891. C.d.u. manifestări nu poate fi atribuită obstrucției limfaticelor:
A. maldigestia grăsimilor;
B. pierderi intestinale de proteine;
C. edem prin hipoproteinemie;
D. limfocitoze;
E. accelerarea golii gastrice.
1892. R.I. cauzele steatoarei, f.d.u. categorii:
1. pre-mucoasă (intraluminală);
2. mucoasă;
3. post-mucoasă;
și următoarele mecanisme:
a. maldigestie;
b. obstrucție limfatică;
c. maldigestia;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;
1893. R.I. cauzele steatoarei, f.d.u. mecanisme:
1. maldigestia intraluminală;
2. maldigestia;
3. obstrucția limfaticelor;
dobândită;
și următoarele stări patologice:
a. infecție;
b. numeroase medicamente, de exemplu colestiramina;
c. insuficiența exocrină pancreatică;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;
1894. R.I. cauzele steatoarei, f.d.u. mecanisme:
1. maldigestia intraluminală;
2. maldigestia;
3. obstrucția limfaticelor;
dobândită;
și următoarele stări patologice:
a. infecție, în special cu protozoare cum ar fi Giardia;
b. traumatism;
c. enteropatia prin hipersensibilizarea la gluten;
d. chirurgie bariatrică;
care sunt asocierile corecte:
A. a-2, b-2, c-1, d-3;
B. a-2, b-2, c-3, d-1;
C. a-2, b-3, c-1, d-2;
D. a-2, b-3, c-2, d-1;
E. a-3, b-1, c-2, d-2;
1897. R.I. cauzele steatoarei, f.d.u. mecanisme:
1. maldigestia intraluminală;
2. maldigestia;
3. obstrucția limfaticelor;
dobândită;
și următoarele stări patologice:
a. numeroase medicamente, de exemplu colichina;
b. tumoră;
c. spune tropical;

Prescurtări frecvent folosite: C.E. = cu excepție; S.U.C.E. = sunt următoarele, cu excepție; u.a.s.c.g.e. = următoarele afirmări sunt corecte, cu excepție; S.C.L.E. = sunt corect formulate, cu excepție.

- d. intervenții chirurgicale vizând scăderea în greutate;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-2, d-3;
B. a-1, b-2, c-1, d-3;
C. a-2, b-3, c-1, d-2;
D. a-2, b-3, c-2, d-1;
E. a-3, b-2, c-2, d-1;
1898. R.I. cauzele steatoarei, f.d.u. mecanisme:
1. maldigestia intraluminală;
2. maldigestia;
3. următoarele stări patologice:
a. boala Whipple;
b. diverse intervenții chirurgicale;
c. numeroase medicamente, de exemplu neomicina;
d. proliferarea bacteriană din intestinul subțire;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-1, d-2;
E. a-2, b-1, c-2, d-1;
1899. R.I. steatoarea prin maldigestie intraluminală, f.d.u. mecanisme:
1. insuficiență exocrină pancreatică;
2. proliferarea bacteriană din intestinul subțire;
și următoarele stări patologice:
a. ansă oarbă;
b. pancreatita cronică;
c. dismotilitate de intestin subțire;
d. obstrucția ductului pancreatic;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-1, d-2;
E. a-2, b-1, c-2, d-1;
1900. R.I. steatoarea prin maldigestie intraluminală, f.d.u. mecanisme:
1. insuficiență exocrină pancreatică;
2. proliferarea bacteriană din intestinul subțire;
și următoarele stări patologice:
a. diverticul;
b. maldigestie intraluminală;
c. proliferare bacteriană în intestinul subțire;
d. stază intestinală;
care este lanțul causal corect:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-1, d-2;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;
1901. F.d.u. evenimente care pot duce la steatoare:
a. perturbarea formării micelilor;
b. proliferarea bacteriană din intestinul subțire;
c. grăsimile nu mai pot fi digerate;
d. deconjugarea acizilor biliari;
e. grăsimile nu mai pot fi emulsionate;
care este lanțul causal corect:
A. a-1, b-2, c-3, d-4;
B. b-1, c-2, d-3;
C. c-1, d-2, e-3;
D. d-1, e-2, a-3;
E. e-1, a-2, b-3;
1902. F.d.u. evenimente care pot duce la steatoare:
a. abuzul de etanol;
b. pancreatita cronică;
c. maldigestia intraluminală;
d. insuficiență pancreatică;
care este lanțul causal corect:
A. a-1, b-2, c-3, d-4;
B. b-1, c-2, d-3;
C. c-1, d-2, e-3;
D. d-1, e-2, a-3;
E. e-1, a-2, b-3;
1903. F.d.u. evenimente care pot duce la steatoare:
a. proliferare bacteriană în intestinul subțire;
b. stază intestinală;
c. maldigestia intraluminală;
d. ansă oarbă;
care este lanțul causal corect:
A. a-1, b-2, c-3, d-4;
B. b-1, c-2, d-3;
C. c-1, d-2, e-3;
D. d-1, e-2, a-3;
E. e-1, a-2, b-3;
1904. F.d.u. evenimente care pot duce la steatoare:
a. diverticul;
b. maldigestie intraluminală;
c. proliferare bacteriană în intestinul subțire;
d. stază intestinală;
care este lanțul causal corect:
A. a-1, b-2, c-3, d-4;
B. b-1, c-2, d-3;
C. c-1, d-2, e-3;
D. d-1, e-2, a-3;
E. e-1, a-2, b-3;
1905. F.d.u. evenimente care pot duce la steatoare:
a. dismotilitate intestinală;
b. proliferare bacteriană în intestinul subțire;
c. maldigestie intraluminală;
d. stază intestinală;
care este lanțul causal corect:
A. a-1, b-2, c-3, d-4;
B. b-1, c-2, d-3;
C. c-1, d-2, e-3;
D. d-1, e-2, a-3;
E. e-1, a-2, b-3;
1906. F.d.u. evenimente care pot duce la steatoare:
a. ciroză sau obstrucție biliară;
b. scădere cantitatea de acizi biliari care ajung în lumenul intestinal;
c. maldigestie intraluminală;
care este lanțul causal corect:
A. a-1, b-2, c-3, d-4;
B. b-1, c-2, d-3;
C. c-1, d-2, e-3;
D. d-1, e-2, a-3;
E. e-1, a-2, b-3;
1907. F.d.u. evenimente care pot duce la steatoare:
a. maldigestia intraluminală;
b. colestectomie;
c. bila nu mai este depozitată în pericardul interparietal;
d. scădere cantitatea de acizi biliari disponibili pentru digestie;
care este lanțul causal corect:
A. a-1, b-2, c-3, d-4;
B. b-1, c-2, d-3;
C. c-1, d-2, e-3;
D. d-1, e-2, a-3;
E. e-1, a-2, b-3;
1908. R.I. boala celiacă, u.a.s.c.g.e.:
A. este enteropatia care provoacă cel mai adesea steatoarea;
B. este produsă de hipersensibilitatea la lactoză;
C. este caracterizată de hiperplazie viloză și atrofia criptelor din intestinul subțire proximal;
D. prevalența este mult mai mare decât s-a crezut până acum (afectează 25% din populație);
E. poate mima un SII;
1909. R.I. boala celiacă, u.a.s.c.g.e.:
A. provoacă steatoare prin maldigestie;
B. afectează toate vârstele;
C. se poate prezenta cu steatoare asociată cu multiple carențe nutritive mai mult sau mai puțin severe;
D. steatoarea nu lipsește din tabloul clinic;
E. are multe alte manifestări gastrointestinale și extraintestinale;
1910. Despre boala Whipple, u.a.s.c.g.e.:
A. este determinată de bacilul Mycobacterium avium-intracelulare;
B. în mucoasa intestinului subțire apare un infiltrat polimorfonuclear;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date; f.d.u. = fiind date următoarele; f.1 = referitor/referitoare la; U.I.d.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază despre.

C. este o cauză mai rară de steatoză, care apare de obicei la copii;

D. este adesea asociată cu artralgii, febră, adenopatie și oboșală extremă;

E. poate afecta sistemul nervos central și pericardul;

1911. R.I. abetalipoproteinemie, u.a.s.c.g.e.:

A. este o boală rară;

B. apare la copii;

C. defectul de formare a chomicronilor se asociază malabsorbția grăsimilor;

D. dislipidemia duce la apariția leucocitelor polisegmentate;

E. manifestări caracteristice sunt ataxia și retinita pigmentară;

1912. R.I. cauzele steatozei, f.d.u. stări patologice:

1. pancreatită cronică;

2. boala Whipple;

3. boala Whipple;

și următoarele manifestări:

a. atrofia viloză și hiperplazia criptelor din intestinul subțire proximal;

b. de obicei consecință a abuzului de etanol;

c. cauză mai rară de steatoză care apare de obicei la bărbai tineri sau de vârstă medie;

care sunt asociate corecte:

A. a-1, b-2, c-3;

B. a-1, b-3, c-2;

C. a-2, b-1, c-3;

D. a-2, b-3, c-1;

E. a-3, b-1, c-2;

1913. R.I. cauzele steatozei, f.d.u. stări patologice:

1. pancreatită cronică;

2. boala Whipple;

3. boala Whipple;

și următoarele manifestări:

a. se poate prezenta cu steatoză asociată cu multiple carențe nutritive mai mult sau mai puțin severe, dar adesea se prezintă fără steatoză;

b. este adesea asociată cu artralgii, febră, adenopatie și oboșală extremă;

c. cea mai frecventă cauză de insuficiență pancreatică;

care sunt asociate corecte:

A. a-1, b-2, c-3;

B. a-1, b-3, c-2;

C. a-2, b-1, c-3;

D. a-2, b-3, c-1;

E. a-3, b-1, c-2;

și următoarele manifestări:

a. scăderea cantității de acizi biliari disponibili pentru digestie, bila nemăfiind depozitată în perioada interprandială;

c. debutul abrupt și răspunsul la antibiotice sugerează o etiologie infecțioasă;

care sunt asociate corecte:

A. a-1, b-2, c-3;

B. a-2, b-1, c-3;

C. a-2, b-3, c-1;

D. a-3, b-1, c-2;

E. a-3, b-2, c-1;

1920. R.I. cauzele steatozei, f.d.u. stări patologice:

1. fundoplicatura;

2. boala Whipple;

3. obstrucția limfaticelor;

și următoarele manifestări:

a. edem prin hipoproteinemie;

1914. R.I. cauzele steatozei, f.d.u. stări patologice:

1. proliferarea bacteriană din intestinul subțire;

2. boala Whipple;

3. boala Whipple;

și următoarele manifestări:

a. poate afecta sistemul nervos central și endocardul;

b. deconjugarea acizilor biliari;

c. prevalența este mult mai mare decât s-a crezut până acum;

afectează ~1% din populație;

care sunt asociate corecte:

A. a-1, b-2, c-3;

B. a-1, b-3, c-2;

C. a-2, b-3, c-1;

D. a-3, b-1, c-2;

E. a-3, b-2, c-1;

1915. R.I. cauzele steatozei, f.d.u. stări patologice:

1. proliferarea bacteriană din intestinul subțire;

2. boala Whipple;

3. infecția cu Mycobacterium avium-intracelulare la pacienții cu SIDA;

și următoarele manifestări:

a. tablou clinic și histologic similar celui din boala Whipple;

b. perturbarea formării micelilor;

c. poate mima un SII;

care sunt asociate corecte:

A. a-1, b-2, c-3;

B. a-2, b-1, c-3;

C. a-2, b-3, c-1;

D. a-3, b-1, c-2;

E. a-3, b-2, c-1;

1916. R.I. cauzele steatozei, f.d.u. stări patologice:

1. proliferarea bacteriană în intestinul subțire;

2. boala Whipple;

3. abetalipoproteinemia;

și următoarele manifestări:

a. pierderi intestinale de proteine;

b. scăderea cantității de acizi biliari disponibili pentru digestie, bila nemăfiind depozitată în perioada interprandială;

c. debutul abrupt și răspunsul la antibiotice sugerează o etiologie infecțioasă;

care sunt asociate corecte:

A. a-1, b-2, c-3;

B. a-2, b-1, c-3;

C. a-2, b-3, c-1;

D. a-3, b-1, c-2;

E. a-3, b-2, c-1;

1917. R.I. cauzele steatozei, f.d.u. stări patologice:

1. ciroza;

2. sprue tropical;

3. abetalipoproteinemia;

Prescurtări frecvent folosite: f.d.u. = următoarele, f.d.u. = cauzele steatozei, f.d.u. = manifestările afecțiunii sunt corecte, cu excepția: s.u.c.g.e. = sunt următoarele, cu excepția; u.a.s.c.g.e. = următoarele afecțiuni sunt corecte, cu excepția: s.c.f.g.e. = sunt corect formulate, cu excepția.

b. determinată de bacilul Tropheryma whipplei;

c. unul dintre mecanisme ar putea fi golirea gastrică rapidă;

care sunt asociate corecte:

A. a-1, b-3, c-2;

B. a-2, b-1, c-3;

C. a-2, b-3, c-1;

D. a-3, b-1, c-2;

E. a-3, b-2, c-1;

1921. R.I. cauzele steatozei, f.d.u. stări patologice:

1. boala Whipple;

2. boala Whipple;

3. obstrucția limfaticelor;

și următoarele manifestări:

a. infiltrat histocitar în mucoasa intestinului subțire;

b. enteropatie prin hipersensibilitate la gluten;

c. hipersensibilitate la gluten;

care sunt asociate corecte:

A. a-1, b-3, c-2;

B. a-2, b-1, c-3;

C. a-2, b-3, c-1;

D. a-3, b-1, c-2;

E. a-3, b-2, c-1;

1922. C.d.u. NU face parte dintre mecanismele recunoscute ale diareei inflamatoare:

A. exsudarea prin mucoasa inflamată;

B. malabsorbția grăsimilor;

C. perturbarea absorbției lichidelor și electrolitilor;

D. spasmul sfincterian;

E. hipersecreția sau hipomotilitatea produse de citokine și de alți mediatori inflamatori eliberați;

1923. U.f.d.f.d. diareea inflamatoare s.c.f.g.e.:

A. Orice persoană de vârstă ce;

B. puțin medie, cu diaree cronică de tip inflamator;

C. trebuie investigată pentru:

D. a exclude un SII;

E. mai ales dacă materiile fecale nu conțin sânge.

1924. R.I. diareea inflamatoare, u.a.s.c.g.e.:

A. în general, diareele inflamatoare sunt însoțite de manifestări de inflamație;

B. mecanismul caracteristic este exsudarea prin mucoasa inflamată;

C. în funcție de localizarea leziunii, mecanismul diareei poate include hipersecreția sau hipomotilitate;

D. când inflamația este severă, pierderea de proteine prin

exsudate poate produce sindrom nefrotic;

E. rarori apare o alergie alimentară veritabilă, aptă să provoace diaree cronică;

1925. R.I. diareea inflamatoare, u.a.s.c.g.e.:

A. în general, diareele inflamatoare sunt însoțite de durere, febră și/sau sângerare;

B. în funcție de localizarea leziunii, mecanismul diareei poate include tulburări de absorbție (grăsimi, lichide, electroliti);

C. trăsătura comună la analiza scaunului este prezența hematiilor;

D. la adulți poate să apară hipersensibilitate la anumite alimente;

E. iradierea pentru cancer gastrointestinal poate provoca enterocolită;

1926. Manifestări extraintestinale asociate BIC idiopatice s.u.c.g.e.:

A. uveită;

B. poliartralgii;

C. hepatopatie colestatică (colangită sclerozană primară);

D. eritem polimorf;

E. piodermita gangrenosă;

1927. R.I. cauzele de diaree inflamatoare, f.d.u. categorii:

1. BIC idiopatice – colita microscopice;

2. tulburări de imunitate;

3. infecții;

și următoarele stări patologice:

a. boala grefă-contragrefă cronică;

b. parazitoză;

c. colita microscopice;

d. hipogamaglobulinemie;

care sunt asociate corecte:

A. a-2, b-1, c-2, d-3;

B. a-2, b-1, c-3, d-2;

C. a-2, b-2, c-3, d-1;

D. a-2, b-3, c-1, d-2;

E. a-2, b-3, c-2, d-1;

1931. C.d.u. clase de medicamente nu este recunoscut a fi asociat cu colita microscopice:

A. AINS;

B. antibiotice;

C. statine;

D. inhibitori ai pompei de protoni (IPP);

E. inhibitori selectivi ai recaptării serotoninice (ISRS);

1932. C.d.u. NU este o manifestare a gastroenteritei eozinofile:

A. diaree;

B. durere;

C. icter;

D. vărsături;

E. ascită;

1933. R.I. diareea inflamatoare, f.d.u. stări patologice:

1. BIC idiopatice;

2. colita microscopice;

3. gastroenterită eozinofilă;

și u. trăsături manifestări:

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele, c.d.u. = cauzele steatozei, f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, f.d. = rețineretelore la U.f.d.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază ușure,

a. poate coexista cu simptome care sugerează SII sau sprue celiac;
b. pacienții afectați au adesea istoric de atopie;
c. în primul rând boala Crohn și colită ulcerosă;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-3, c-2;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
1934. R.I. diareea inflamatoare, f.d.u. stân patologic:
1. BIC idiopatic;
2. colita microscopică;
3. gastroenterită eozinofilică;
și u. trăsături manifestări:
a. primele cele mai frecvente cauze organice de diaree cronică la adulți;
b. de obicei răspunde bine la medicamente anti-inflamatoare (de exemplu, bismut), la agonistii opioid loperamidă sau la budesonid;
c. pacienții afectați au adesea cristale Charcot-Leyden (provenient din eozinofile) la examenul microscopic al scaunului;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-1, c-2;
1935. R.I. diareea inflamatoare, f.d.u. stân patologic:
1. BIC idiopatic;
2. imunodeficiență (primară sau secundară);
3. gastroenterită eozinofilică;
și u. trăsături manifestări:
a. diaree infecțioasă prelungită, b. manifestările variază în severitate de la ușoare până la fulminante și amenințătoare de viață;
c. eozinofilia periferică apare la 50-75% din pacienți;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-1, c-2;
1936. R.I. diareea inflamatoare f.d.u. stân patologic:
1. colita microscopică;
2. hipogamaglobulinemie;

3. sindrom Cronkhit-Canada;
 a. în trăsătură manifestări:
 și u. în căsă colita limfocitară și
 colita colagenoză;
 b. diareea este foarte frecventă și
 adesea este consecința
 giardiei;
 c. polipi hamartomatoși în tot
 tubul digestiv (mai ales stomac
 și colon), care rarori
 progresază la cancer;
 care sunt asocierile corecte:
 A. a-1, b-2, c-3;
 B. a-1, b-3, c-2;
 C. a-2, b-3, c-1;
 D. a-3, b-1, c-2;
 E. a-3, b-2, c-1;

1937. R.1. diareea inflamtoare
 f.d.u. stări patologice:
 1. colita microscopice;
 2. gastroenterita eozinofilă;
 3. sindrom Cronkhit-Canada;
 și u. în căsă manifestări:
 a. este tot mai mult recunoscută
 drept cauză de diaree apasă
 cronică, în special la femei de
 vârstă medie și la cele care iau
 anumite medicamente;
 b. infiltrarea cu eozinofile a
 mucoasei, muscularii sau
 seroasei la orice nivel al tractului
 gastrointestinal;
 c. polipi hamartomatoși și diaree
 cronică cu pierdere de proteine;
 care sunt asocierile corecte:
 A. a-1, b-2, c-3;
 B. a-1, b-3, c-2;
 C. a-2, b-1, c-3;
 D. a-2, b-3, c-1;
 E. a-3, b-1, c-2;

1938. R.1. diareea inflamtoare
 f.d.u. stări patologice:
 1. colita microscopice;
 2. gastroenterita eozinofilă;
 3. sindrom Cronkhit-Canada;
 și u. în căsă manifestări:
 a. diaree, durere, vârsături,
 ascită;
 b. diagnosticul se pune prin
 examen histopatologic (necesită
 biopsii), întinsă, macroscopic
 colorul are aspect normal;
 c. polipi, diaree, alopecie, alofie
 unghială, pigmentare cutanată;
 care sunt asocierile corecte:
 A. a-1, b-2, c-3;
 B. a-2, b-1, c-3;
 C. a-2, b-3, c-1;
 D. a-3, b-1, c-2;
 E. a-3, b-2, c-1;

1939. R.1. diareea
 u.a.s.c.g.e. Brahm

A. este o entitate patologică din ce în ce mai frecvent diagnosticată;
B. este caracterizată prin debut progresiv și persistentă cel puțin 4 săptămâni;
C. este probabil provocată de un agent care nu pare să se transmită de la o persoană la alta;
D. se rezolvă de la sine;
E. poate fi asociată cu inflamație distală a intestinului subțire distal sau a colonului proximal;

1940. R.I. diarrea Brainerd, u.a.s.c.d.e.;
A. este apăsă, explozivă;
B. poate dura cel mult 1-3 luni;
C. cauza este necunoscută, probabil infecțioasă;
D. este probabil provocată de un agent pe care febrilele apoi pare să-l inactiveze;
E. nu răspunde la antibiotice;

1941. F.d.u. stări patologice r.l. una dintre formele de diaree prin dismotilitate;
a. proliferare bacteriană;
b. stază intestinală;
c. neuromiopatie viscerală primară;
d. diaree;
care este lanțul causal corect:

A. a→c→b→d;
B. c→b→a→d;
C. c→b→d→a;
D. d→b→b→c;
E. d→c→b→a;

1942. F.d.u. stări patologice r.l. una dintre formele de diaree prin dismotilitate;
a. stază intestinală;
b. pseudodistrucție intestinală idiopatică dobândită;
c. proliferare bacteriană;
d. diaree;
care este lanțul causal corect:

A. a→d→c→b;
B. b→a→c→d;
C. b→a→d→c;
D. c→d→b→a;
E. d→a→c→b;

1943. În c.d.u. situații cauza diareei nu este hipermotilitatea;
A. hipertiroidism;
B. sindrom carcinomic;
C. pseudodistrucție intestinală;
D. administrare de prostaglandine;
E. tratament cu prokinetice;

1944. R.I. diareea prin dismotilitate, u.a.s.c.d.e.;
A. tranzit rapid poate însoți multe forme de diaree drept un

fenomen
contribuitor;
B. trăsăturile scaun
adecese o diaree
C. rapizul rapid
pentru a nu lăsa
pentru producer
D. SII (inclusiv po
foarte frecvent
incidență 1-2% fi
E. anumele medic
glandine agenți
produce hipermet
1945. R1 diaree
liate, u.a.s.c.g.e.
A. dismotilitatea
rarori cauzată
adevărată;
B. prezența ste
căutarea altei
diaree;
C. neuropatia veg
(asociată celei
produce diaree
intestinală;
D. SII este
diminuarea reas
senzorială intest
stimuli;
E. perturbarea tr
după vagotomiz
diaree;
1946. Simptomel
frecvent din SII în
caracteristici, g.g.
A. predomină ne
B. alternează cu
stipalile;
C. sunt însoțite d
nală accentuată
D. deseei deter
greutate;
E. rareori reprezi
tabilă;
1947. R1. diare
u.a.s.c.g.e.;
A. reprezintă pâ
cazurile de diat
care sunt trimise
ticate în centrul
B. poate fi o
alimentale;
C. de obicei sun
cu istoric de l
ș/sau care
evaluă și ingrij
D. contaminarea
este sugerată d
foarte ridicată a
E. pacienții care
comportamentu
consiliere psihia

[illegible]

3. autoindusă, 4. de sindrom 5. este numită 6. profesional; 7. i autoadminis- 8. ale medica- 9. (u, diuretic); 10. zinzină cu hiper- 11. autoindusă, 12. sau își 13. nată diareea, 14. angă fraudulos 15. scaunul trimis 16. fi dificil; 17. zinzină cu hiper- 18. nu poate fi 19. alături inițiale a 20. e cronică prin 21. c și investigații 22. sindmului diareic; 23. or manifestări 24. ntru stabilirea 25. hidroelectrolit- 26. diareei; 27. ntrifoniale a 28. a pacientului 29. ascose; 30. metodele para- 31. igarea a unei 32. t consistențe și 33. ocazională tre- 34. n fizic atenție; 35. o cauză 36. și intervențiile 37. ovoca diaree; 38. gestive pentru 39. a mai probabil 40. aarea pacien-	A. Dacă ia diverse B. nu se constată C. se administrează D. și se efectuează E. este vorba de o oasă oculută. 1953. F.d.u. demen- și conduzi care inițială în evoluția cu diaree cronică: a. fără sânge în s fi fără efect; b. fără efect; c. diete de excludu sofiorii etc.); d. posibi diaree fi inclusiv SII; e. investigații limit organice; ce secvență este p A. a-c-b-d-a-c B. b-e-d-a-c C. c-e-e-b-a-a-d D. d-a-c-e-e-b E. e-b-d-a-c 1954. R.I. stralea evaluarea pacien cronică, f.d.u. con 1. Fără sânge în s năsturn de malar 2. sânge în scaun 3. diete de exclud efect; și u investigații c a. posibi diaree fi inclusiv SII; b. se încearcă diete (ficioză, sorbitol c. colonoscopie, b care sunt ascen A. a-1, b-3, c-2; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 1955. R.I. stralea evaluarea pacien cronică, f.d.u. con 1. durerea este a de scaun și amea de evacuarea scau evacuarea incu 2. fără sânge în s manifestări de m dietele de excludu 3. trăsături suges malabsorbție; și u. investigații c a. tehnici imagist transgutanmazaz absorbție.
--	---

[illegible]

b. tablou clinic sugestiv pentru diaree funcțională. Inclusiv SII; c. investigații limitate pentru boli organice; care sunt asociate corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 1956. F.d.u. demersuri, constatări și concluzii în evaluarea unui pacient cu diaree cronică: a. colonoscopie + biopsie; b. dacă se constată anemie, microcitoză, hipocromie, hipalbuminemie, exces de grăsimi în scaun; c. teste de triaj simple pentru a dirija alegerea unor investigații mai complexe; d. investigații sugestive pentru o neuropatie vegetativă; e. trăsături sugestive pentru vasculită sau o boală autoimună de țesut conjunctiv; f. următoarele stări patologice: a. dermatită herpetiformă, edem; b. anemie, edem, hipocalcemia; c. modificări la piele, mâini, articulații; d. modificări la pupile, hipotensiune ortostatică; care sunt asociate corecte: A. a-1, b-2, c-3, d-4; B. a-1, b-2, c-4, d-3; C. a-2, b-4, c-1, d-3; D. a-2, b-2, c-4, d-1; E. a-4, b-1, c-3, d-2; 1960. R.I. depistarea cauzei unei diaree cronice, f.d.u. modificări examenului fizic: 1. trăsături generale sugestive pentru melabsorbție; 2. trăsături generale sugestive pentru BIC; 3. trăsături sugestive pentru o neuropatie vegetativă; 4. trăsături sugestive pentru vasculită sau o boală autoimună de țesut conjunctiv; 5. următoarele stări patologice: a. dermatită herpetiformă, edem; b. anemie, edem, hipocalcemia; c. modificări la piele, mâini, articulații; d. modificări la pupile, hipotensiune ortostatică; care sunt asociate corecte: A. a-1, b-2, c-3, d-4; B. a-1, b-2, c-4, d-3; C. a-2, b-4, c-1, d-3; D. a-2, b-2, c-4, d-1; E. a-4, b-1, c-3, d-2; 1960. R.I. depistarea cauzei unei diaree cronice, f.d.u. categorii de modificări la examenul fizic: 1. la palparea abdomenului; 2. la examenul toracelui; 3. la examenul general; și următoarele modificări: a. formațiune tumorală, durere, hepatomegalie; b. adenopatii, formațiune tumorală tiroidiană; c. respirație șuierătoare, sufluri cardice; care sunt asociate corecte: A. a-1, b-3, c-2; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 1961. R.I. depistarea cauzei unei diaree cronice, c.d.u. modificări nu se constată prin examen local rectoanal: A. anomalii ale mucoasei rectale; B. defecte funcționale rectale; C. pancreatită cronică;	D. perturbarea funcțiilor sfincțelului anal (laxitate); E. fistule perianale; 1962. R.I. depistarea cauzei unei diaree cronice, f.d.u. manifestări cutanoneumocase de boală sistemică: 1. dermatită herpetiformă; 2. eritem nodos; 3. înroșire; 4. ulcerări orale; și următoarele stări patologice: a. colită ulcerosă; b. boala celiacă; c. carcinoid; care sunt asociate corecte: A. a-1, b-4, c-2, d-3; B. a-2, b-1, c-3, d-4; C. a-3, b-1, c-4, d-2; D. a-4, b-1, c-3, d-2; E. a-4, b-2, c-1, d-3; 1963. R.I. importanță istoricului în depistarea cauzei unei diaree cronice, f.d.u. categorii: 1. descrierea diareei; 2. circumstanțele diareei; și următoarele elemente: a. factori care agravează (în special alimentații); b. caracteristicile scaunului; c. durată; d. debut; e. tipar; f. factori care ameliorează; care sunt asociate corecte: A. a-1, b-1, c-2, d-1, e-1, f-2; B. a-1, b-1, c-2, d-1, e-2, f-1; C. a-1, b-1, c-2, d-2, e-1, f-1; D. a-2, b-1, c-1, d-1, e-1, f-2; E. a-2, b-1, c-2, d-1, e-1, f-1; 1964. R.I. rolul istoricului în depistarea cauzei unei diaree cronice, f.d.u. categorii: 1. simptome asociate; 2. manifestări extraintestinale; 3. expuneri; și următoarele elemente: a. artralgi; b. călătorie; c. incontinență fecală; care sunt asociate corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-2, b-3, c-1; E. a-3, b-2, c-1; 1965. R.I. rolul istoricului în depistarea cauzei unei diaree cronice, f.d.u. categorii: 1. simptome asociate; 2. manifestări extraintestinale;	3. expuneri; și următoarele elemente: a. medicamente; b. ulcere atroase orale; c. durere; care sunt asociate corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-2, b-3, c-1; E. a-3, b-2, c-1; 1966. R.I. rolul istoricului în depistarea cauzei unei diaree cronice, f.d.u. categorii: 1. simptome generale asociate; 2. expuneri; 3. antecedente familiale; și următoarele elemente: a. contacte cu persoane care au diaree; b. febră; c. BIC la membrii familiei; care sunt asociate corecte: A. a-1, b-3, c-2; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 1967. R.I. rolul istoricului în depistarea cauzei unei diaree cronice, f.d.u. categorii: 1. simptome generale asociate; 2. manifestări extraintestinale; 3. antecedente familiale; și următoarele elemente: a. scădere în greutate; b. scădere în funcție; c. sprue la membrii familiei; care sunt asociate corecte: A. a-1, b-3, c-2; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-3, c-1; D. a-2, b-3, c-1; E. a-3, b-1, c-2; 1968. R.I. depistarea cauzei unei diaree cronice, f.d.u. modificări bioumorale: 1. anemie; 2. leucocitoză periferică; creșterea VSH și/sau a proteinei C-reactive; 3. Ac față de transglutaminaza tisulară; și următoarele stări patologice: a. boală inflamatorie; b. boala celiacă; c. afecțiune asociată cu pierdere de sânge sau carențe nutritive; care sunt asociate corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1;	D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 1969. La un pacient cu diaree cronică, eozinofilia poate semnifica u.c.e.: A. neoplazie; B. sindrom de intestin iritabil; C. vasculite; D. alergii; E. gastroenterită eozinofilică; 1970. U.f.d.f. depistarea cauzei unei diaree cronice s.c.f.e.: A. Dacă la prima consultație, un anumit diagnostic specific pare probabil; B. Probabil este justificat un tratament de probă; C. Care poate fi foarte rentabil; D. Intrucât poate fi definitiv; E. și indică investigațiile care trebuie efectuate. 1971. R.I. depistarea cauzei unei diaree cronice printr-un tratament de probă administrat înainte de a efectua investigații, f.d.u. situații: 1. diaree apăsătoare cronică, care începează la oprirea aportului alimentar la un tânăr alimntări sănătos; 2. balonare și diaree persistente după o excursie la munte; 3. diaree postprandială persistentă după o rezeție ileală; și u. diagnostic cele mai probabile (orientând alegerea tratamentului de probă): a. deficit de lactază; b. giardiază; c. malabsorbție de acizi biliari; care sunt asociate corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-2, b-3, c-1; E. a-3, b-1, c-2; 1972. R.I. depistarea cauzei unei diaree cronice printr-un tratament de probă administrat înainte de a efectua investigații, f.d.u. situații: 1. diaree apăsătoare cronică, care începează la oprirea aportului alimentar la un tânăr alimntări sănătos; 2. balonare și diaree persistente după o excursie la munte; 3. diaree postprandială persistentă după o rezeție ileală; și u. tratamentul de probă: a. metronidazol; b. dietă fără lactoză; c. colestiramină;	care sunt asociate corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-2, b-3, c-1; E. a-3, b-1, c-2; 1973. F.d.u. constatări și concluzii în evaluarea unui pacient cu diaree cronică: a. investigații suplimentare; b. la prima consultație, un anumit diagnostic specific pare probabil; c. dacă simptomele persistă (nefînd influențate de tratamentul de probă); d. este justificat un tratament de probă; ce secvență este recomandabilă: A. a→d→c→b; B. b→d→c→a; C. c→a→b→d; D. d→a→b→c; E. d→a→c→b; 1974. U.f.d.f. depistarea cauzei unei diaree cronice s.c.f.e.: A. Chiar dacă anumite diagnostice pot fi sugerate de la prima consultație; B. de exemplu, BIC idiopatică; C. pot fi necesare evaluări suplimentare focalizate; D. pentru a confirma diagnosticul și a stabili severitatea sau extinderea bolii; E. deși acestea nu influențează alegerea tratamentului optim. 1975. F.d.u. constatări și concluzii în evaluarea unui pacient cu diaree cronică: a. evaluare inițială prin sigmoidoscopie flexibilă cu biopsii colorectale; b. pacientul va fi tratat empiric/simptomatic (cu antispasmodice, antidiarice, agenți de volum, antitortice, antidepresive); c. suspiciune de SII; d. dacă nu se evidențiază anomalii; e. pacientului i se pot da asigurări că nu are o patologie gravă; ce secvență este recomandabilă: A. b→c→d→e→a; B. c→a→d→e→b; C. c→b→d→e→a; D. c→e→d→b→a; E. e→c→a→b→d; 1976. R.I. evaluarea suplimentară a pacientului cu diaree cronică, u.a.s.c.f.e.:
---	---	---	---	---

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date; f.d.u. = fiind date următoarele; f.i. = telefon/referitoare la; U.f.d.f. = Următoarele fragmente dintr-o frază desprse;

- A. diareea cronică asociată cu hematochezie obligă la efectuarea de investigații microbiologice din scaun și colonoscopie;
- B. determinarea lactazelor pe biopsia de intestin subțire este o investigație obligatorie în evaluarea unei diaree cronice;
- C. investigațiile microbiologice trebuie să includă testul antigenic pentru Giardia;
- D. în interpretarea testelor respiratori, poate să apară confuzie atunci când există tulburări ale tranzitului intestinal;
- E. cele mai frecvente cauze ale diareei osmotice sunt intoleranța la fructoză și ingestia de (axaxile cu) magneziu;
1977. R.I. evaluarea suplimentară a pacientului cu diaree cronică, u.a.s.c.g.e.:
- A. cam în două treimi din cazuri, cauza diareei cronice rămâne neclară după consultatia inițială;
- B. investigațiile microbiologice trebuie să includă culturi bacteriene din materiile fecale;
- C. cel mai sensibil test pentru giardiază este examenul microscopic;
- D. dacă istoricul sau alte modificări o indică, trebuie efectuate teste de depistare pentru hormoni peptidici;
- E. un test direct pentru insuficiența pancreatică exocrină este testul de stimulare la somatostatina;
1978. R.I. evaluarea suplimentară a pacientului cu diaree cronică, u.a.s.c.g.e.:
- A. când cauza diareei cronice rămâne neclară după consultatia inițială, sunt necesare investigații suplimentare;
- B. investigațiile microbiologice trebuie să includă examen microscopic pentru ouă și paraziți;
- C. culturile bacteriene din materiile fecale trebuie efectuate și pe medii pentru *Aeromonas* și *Plesiomonas*;
- D. un pH fecal scăzut sugerează malabsorbția grasimilor;
- E. există o varianță a testului de stimulare la secreția colecisto-kinină care se poate efectua endoscopic;
1979. R.I. depistarea cauzei unei diaree cronice pe baza investigațiilor suplimentare, f.d.u. situații:

1. dacă evaluarea cantitativă a scaunului colectat în 24 de ore demonstrează o greutate a scaunului >200 g/zi;
2. în evaluarea suplimentară a diareei osmotice;
3. în cazurile de steatoree dovedită;
- și următoarele concluzii/attitudini:
- a. ar trebui efectuate teste pentru magnezii;
- b. trebuie efectuate analize suplimentare din scaun;
- c. trebuie efectuată endoscopia cu biopsie de intestin subțire (inclusiv aspirație pentru Giardia și culturi cantitative);
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
1980. R.I. depistarea cauzei unei diaree cronice pe baza investigațiilor suplimentare, f.d.u. situații:
1. pentru diareile secretorie (diareii apoase cu gură osmotică normală);
2. dacă nivelurile fecale ale magnezului sau laxativelor sunt crescute;
3. dacă endoscopia cu biopsie de intestin subțire nu înlămuiește cauza unei steatoree;
- și următoarele concluzii/attitudini:
- a. se va efectua o radiografie de intestin subțire;
- b. trebuie avută în vedere ingestia din greșală sau clandestină;
- c. trebuie avute în vedere posibilele efecte secundare ale medicamentelor sau utilizarea claudesimă de laxative;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
1981. R.I. depistarea cauzei unei diaree cronice pe baza investigațiilor suplimentare, f.d.u. situații:
1. în evaluarea suplimentară a diareei osmotice;
2. dacă se bănuiește utilizarea clandestină de laxative;
3. dacă se descoperă sânge sau leucocite în scaun;
- și următoarele concluzii/attitudini:

- a. ar trebui efectuate teste pentru intoleranța la lactoză;
- b. ar trebui suspectată diaree cronică de tip inflamator;
- c. trebuie solicitat ajutor psihiatric;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;
1982. U.f.d.f.d. depistarea cauzei unei diaree cronice s.c.f.g.e.:
- A. Colectarea scaunului pentru evaluarea cantitativă și analize;
- B. poate oferi date obiective importante, care pot fi stabilite un diagnostic;
- C. fie caracteriza tipul de diaree;
- D. ceea ce permite oprirea investigațiilor;
1983. F.d.u. demersuri, constatări și concluzii în evaluarea unui pacient care are diaree:
- a. se evaluează cantitativ scaunul colectat în 24 de ore;
- b. este necesară confirmarea diareei;
- c. diareea este confirmată;
- d. sunt necesare analize suplimentare din scaun;
- e. istoricul sugerează diaree;
- ce secvență este recomandabilă:
- A. a→b→c→d;
B. a→b→d→c→a;
C. c→d→e→b→a;
D. d→e→b→c→a;
E. e→b→a→c→d;
1984. Analize suplimentare din scaun care trebuie efectuate dacă diareea este confirmată s.u.g.e.:
- A. concentrația electroliților, pH;
- B. teste pentru hemoragii oculte;
- C. examen microscopic pentru leucocite sau test pentru proteinele leucocitare;
- D. determinarea cantitativă a proteinelor;
- E. test de depistare pentru lactoză;
1985. U.f.d.f.d. depistarea cauzei unei diaree cronice s.c.f.g.e.:
- A. Proliferarea bacteriană în intestinul subțire poate fi exclusă;
- B. prin aspirație intestinală urmate de cultură cantitativă sau prin;
- C. teste respiratori la lactoză;
- D. incluzând măsurarea în scaun;
- E. a azotului, melaniului sau a altor metaboliți (de exemplu, $^{14}\text{CO}_2$).

1986. R.I. utilizarea testelor pentru hormoni peptidici în depistarea cauzei unei diaree cronice, f.d.u. categorii:
1. nivelul seric pentru;
2. nivelul urinar pentru;
- și următorii hormoni:
- a. hormon tiroidian, hormonul stimulator al tiroidelor (TSH);
- b. gastrină, VIP, calcitonină;
- c. histamină;
- d. acțiunea 5-hidroxiindolacetic;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-2, d-1;
C. a-2, b-1, c-1, d-2;
D. a-2, b-1, c-2, d-1;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;
1987. U.f.d.f.d. depistarea cauzei unei diaree cronice s.c.f.g.e.:
- A. Endoscopia digestivă atât superioară, cât și inferioară;
- B. cu biopsii și radiografii;
- C. bariatul pentru stomac;
- D. sunt utile pentru a exclude o boală organică;
- E. sau inflamație oculară.
1988. U.f.d.f.d. depistarea cauzei unei diaree cronice s.c.f.g.e.:
- A. Malabsorbția lactozelor poate fi confirmată prin testul;
- B. respirația la lactoză sau prin;
- C. dietă de probă cu lactoză;
- D. urmata de observarea efectului unei provocări cu lactoză;
- E. de exemplu, un litru de lapte.
1989. F.d.u. constatări și concluzii în evaluarea unui pacient cu diaree cronică și steatoree dovedite:
- a. dacă această procedură nu este înlămuiește;
- b. trebuie efectuate endoscopia cu biopsie de intestin subțire (inclusiv aspirație pentru Giardia și culturi cantitative);
- c. dacă investigațiile pentru intestinul subțire sunt negative sau dacă se suspectează boala pancreatică;
- d. trebuie efectuate teste directe pentru insuficiența pancreatică exocrină;
- e. se va efectua o radiografie de intestin subțire;
- ce secvență este recomandabilă:
- A. a→b→e→d→c;
B. b→a→e→c→d;
C. c→e→d→a→b;
D. d→a→c→b→e;
E. e→b→c→d→a;
1990. U.f.d.f.d. depistarea cauzei unei diaree cronice s.c.f.g.e.:
- A. Testele indirecte pentru insuficiența pancreatică exocrină;
- B. cum ar fi evaluarea activității pepsinei fecale;
- C. sau testul la benitromidă;
- D. au cazuri în desubordine;
- E. deoarece au sensibilitate și specificitate crescute.
1991. Investigații care ar trebui efectuate la pacienții suspecți de diaree cronică inflamatorie s.u.g.e.:
- A. cultură din scaun;
- B. examen microscopic pentru ouă și paraziți;
- C. teste pentru toxina stafilococică;
- D. colonoscopie cu biopsii;
- E. investigarea cu substanță de contrast a intestinului subțire (dacă este indicată);
- Conspirația
1992. R.I. constipatie, u.a.s.c.g.e.:
- A. trebuie analizate cu atenție simptomele relatate de pacient pentru a stabili ce înțelege prin constipatie sau dificultate la defecație;
- B. scaunele mici, fragmentate (în scaun) sunt mai ușor de evacuat decât scaunele normale;
- C. iar scaunele moi, apoase se asociază cu tranzit rapid;
- D. nevoia de clismă sau de dezplacare digitală oferă o confirmare a percepțiilor pacientului de defecație dificilă;
- E. factorii psihosociali și culturali sunt importanți în determinarea constipației;
1993. R.I. constipatie, u.a.s.c.g.e.:
- A. se vorbește despre constipatie la persoanele care au mai puțin de trei scaune pe săptămână;
- B. frecvența scăzută a scaunului este singurul criteriu pentru diagnosticul de constipatie;
- C. forma și consistența scaunului sunt bine corelate cu timpul trecut de la defecația anterioară;
- D. o persoană ai cărei pași au acordat mare importanță defecției zilnice va deveni foarte îngrijorată dacă într-o zi are două scaune;
- E. unui adult ignoră în mod obișnuit senzația de defecație sau întârzie să îi dea curs;
1994. R.I. constipatie, u.a.s.c.g.e.:
- A. cei mai mulți oameni au cel mult trei scaune pe săptămână;
- B. scaunele foarte mari sunt mai dificil de evacuat decât scaunele normale;
- C. scaunele tari, fragmentate (în scaun) se asociază cu tranzit rapid;
- D. senzația de scaun tare sau de scormenie excesivă este mai dificil de evaluat obiectiv;
- E. unii copii rețin scaunul pentru a dobândi atenție sau din cauza fricii de durerea produsă de inițierea anală;
1995. Mulți pacienți constipați au frecvență normală a defecției, dar înțeleg prin constipatie una sau mai multe dintre u.g.e.:
- A. scorm excesiv;
- B. senzație de balonare;
- C. scaune tari;
- D. senzație de plin în abdomenul inferior;
- E. senzație de evacuare incompletă;
1996. C.d.u. tipuri de defecație nu este inclus în termenul de constipatie (înțeles în sensul cel mai cuprinzător):
- A. rețență/prelungită;
- B. dificilă;
- C. rară;
- D. aparent incompletă;
- E. imperioasă;
1997. R.I. cauzele constipației, u.a.s.c.g.e.:
- A. constipatia recent instalată poate fi un simptom de boală organică semnificativă cum ar fi o tumoră sau o strictură;
- B. constipatia cronică este provocată cel mai adesea de o tonajune care obstruează colonul;
- C. medicamentele sunt una dintre cauzele constipației recent instalate;
- D. constipatia de orice cauză poate fi accentuată de spitalizare și de boile cronice invalidante fizic sau mental;
- E. circumstanțele care determină inactivitate sau imobilitate fizică ameliorează constipatia oricare ar fi cauza acesteia;
1998. U.f.d.f.d. cauzele constipației cronice s.c.f.g.e.:
- A. în general, constipatia cronică este provocată de perturbarea tranzitului colonic sau a absorbției intestinale prin;

Prescurtări frecvent folosite: u.g.e. = cu excepție, s.u.g.e. = sunt următoarele, cu excepția; u.a.s.c.g.e. = următoarele afirmații sunt corecte, cu excepția; s.c.f.g.e. = sunt corect formulate, cu excepția.

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date; f.d.u. = fiind date următoarele; f.i. = referitor/referitoare la; U.f.d.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază despre.

C. tulburări neurogastroenterologice, prin medicamente ori, D. prin vârstă avansată sau în asociere cu un mare număr de; tractul gastrointestinal.	a. antidepresive; b. sindrom de perineu coborât; c. hipercalcemie; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;	și următoarele stări patologice: a. boala Chagas; b. tulburări de alimentație; c. scleroză sistemică progresivă; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;	2007. R.I. substratul formelor funcționale de constipație, f.d.u. categorii: 1. tulburări de tranzit – constipația idiopatică fără o cauză identificabilă; 2. tulburări de evacuare – obstrucția evacuării; și următoarele trăsături: a. de obicei, poate fi corectată prin reabilitarea prin biofeedback a defecției perturbate; b. poate determina întârzierea tranzitului colonic; c. tranzitul este prelungit (adesea în colonul proximal), în corelație cu o frecvență scăzută a contracțiilor propulsive; d. golirea colonului ascendent și transvers este întârziată; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-1, c-2, d-2; B. a-1, b-2, c-1, d-2; C. a-1, b-2, c-2, d-1; D. a-2, b-1, c-1, d-2; E. a-2, b-2, c-1, d-1;	2008. Investigații de bază în evaluarea pacientului cu constipație a.u.c.g. A. date clinice (istoric, examen fizic); B. date biomorale; C. radiografie toracică; D. radiografie abdominală; E. investigații pentru excludere unei obstrucții mecanice (de exemplu, angiografie); 2009. F.d.u. investigații, constatări și decizii în evaluarea unui pacient cu constipație: a. investigații clinice și paraclinice de bază; b. tranzit colonic normal; c. posibilă tulburare intestinală funcțională; ce secvență este recomandabilă: A. a-b-b-c; B. b-a-a-c; C. b-a-a-a; D. c-a-a-b; E. c-b-a-a;	a. antidepresive; b. sindrom de perineu coborât; c. hipercalcemie; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;	2003. R.I. cauzele constipației cronice, f.d.u. categorii: 1. tulburări ale evacuării rectale; 2. boală neurologică; 3. pseudo-obstrucție colonică; și următoarele stări patologice: a. constipație cu tranzit lent; b. traumatism al coloanei vertebrale; c. prolaps de mucoasă rectală; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-1, c-2, d-2; B. a-1, b-2, c-2, d-1; C. a-2, b-1, c-1, d-2; D. a-2, b-1, c-2, d-1; E. a-2, b-1, c-2, d-1;	2000. R.I. cauzele constipației cronice, f.d.u. categorii: 1. tulburări funcționale; 2. tulburări ale evacuării rectale; 3. afecțiuni endocrine; a. sarcină; b. SII (cu predominanța constipației-diaree); c. disfuncția planșei pelvian; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-3, c-2; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;	2001. R.I. cauzele constipației cronice, f.d.u. categorii: 1. tulburări ale evacuării rectale; 2. afecțiuni psihice; 3. boală neurologică; și următoarele stări patologice: a. boala Parkinson; b. depresie (și medicamente antidepresive); c. anism; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;	2005. R.I. cauzele constipației cronice, f.d.u. categorii: 1. pseudo-obstrucție colonică – cauză rară de megacolon; 2. afecțiuni endocrine; 3. boală neurologică; și următoarele stări patologice: a. boala Hirschsprung; b. hipotiroidie; c. scleroză multiplă; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;	2006. R.I. cauzele constipației cronice, f.d.u. categorii: 1. pseudo-obstrucție colonică – cauză rară de megacolon; 2. afecțiuni psihice; 3. boala musculară generalizată;
--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	---

Prescurtări frecvent folosite: c.d. = cu excepție; a.u.c.g. = sunt următoarele, cu excepția; a.a.s.c.g. = următoarele afirmații sunt corecte, cu excepția; s.c.f.c.g. = sunt corect formulate, cu excepția;

2010. F.d.u. investigații, constatări și decizii în evaluarea unui pacient cu constipație: a. investigații clinice și paraclinice de bază; b. afecțiune cunoscută; c. tratament; d. tranzit colonic anormal (lent); ce secvență este recomandabilă: A. a-b-b-b-c; B. a-b-b-b-c; C. b-a-a-d-c; D. c-d-a-a-b; E. d-a-a-b-c;	2011. F.d.u. investigații, constatări și decizii în evaluarea unui pacient cu constipație: a. manometrie anorectală și testul de expulzare a balonului normal; b. investigații clinice și paraclinice de bază; c. tranzit colonic anormal (lent); d. afecțiune necunoscută; ce secvență este recomandabilă: A. a-b-b-b-c; B. b-b-b-b-c; C. c-d-d-e-a-b; D. d-b-b-b-c; E. e-b-b-b-c;	2012. F.d.u. investigații, constatări și decizii în evaluarea unui pacient cu constipație: a. tratament: program de reabilitare, chirurgie etc.; b. tranzit colonic anormal (lent); c. manometrie anorectală și testul de expulzare a balonului anormal; d. afecțiune necunoscută; e. investigații clinice și paraclinice de bază; f. măsurarea unghiului rectoanal, proctografie de defecație; ce secvență este recomandabilă: A. a-e-f-a-c-b-d; B. b-f-a-a-e-c-d; C. c-a-a-e-b-f-d; D. e-b-b-d-c-f-a; E. f-b-b-e-d-a-a-c;	2013. R.I. evaluarea/ tratarea pacientului cu constipație, f.d.u. categorii: 1. leziune care poate fi identificată prin irigografie; 2. aspect esențial pe care trebuie să-l vizeze istoricul; 3. semn de alarmă; și următoarele aspecte: a. anemie;	2014. R.I. evaluarea/ tratarea pacientului cu constipație, f.d.u. categorii: 1. aspect esențial pe care trebuie să-l vizeze istoricul; 2. semn de alarmă; 3. leziune care poate fi identificată prin irigografie; și următoarele aspecte: a. aspectele psihosociale; b. scădere în greutate; c. dilatația colonică, inclusiv în cadrul megacolonului și a defecogrofiei; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-2, b-3, c-1; E. a-3, b-2, c-1;	2015. R.I. evaluarea/ tratarea pacientului cu constipație, f.d.u. categorii: 1. aspect esențial pe care trebuie să-l vizeze istoricul; 2. semn de alarmă; 3. una dintre cauzele mai relevante modificării evidențiabile prin defecografie; și următoarele aspecte: a. eventuale medicamente; b. sângerare rectală; c. modificări ale unghiului rectoanal; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-2, b-3, c-1; E. a-3, b-2, c-1;	2016. R.I. evaluarea/ tratarea pacientului cu constipație, f.d.u. categorii: 1. una dintre cauzele de constipație; 2. una dintre manevrele/ intervențiile care poate fi efectuată prin colonoscopie; 3. stare patologică remediabilă chirurgical evidențiabilă prin defecografie; și următoarele aspecte: a. telescopare severă, pe întreaga grosime cu obstrucția evacuatorii; b. polipectomie; c. hipotiroidie; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;	2017. R.I. evaluarea/ tratarea pacientului cu constipație, f.d.u. categorii: 1. una dintre cauzele de constipație; 2. una dintre manevrele/ intervențiile care poate fi efectuată prin colonoscopie; 3. una dintre cele mai relevante modificări evidențiabile prin defecografie; și următoarele aspecte: a. enterocol sau rectocol; b. biopsierea leziunilor mucoase; c. depresie; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;	2018. R.I. evaluarea/ tratarea pacientului cu constipație, f.d.u. categorii: 1. una dintre cauzele de constipație; 2. una dintre manevrele/ intervențiile care poate fi efectuată prin colonoscopie; 3. stare patologică remediabilă chirurgical evidențiabilă prin defecografie; și următoarele aspecte: a. telescopare severă, pe întreaga grosime cu obstrucția evacuatorii; b. polipectomie; c. hipotiroidie; care sunt asocierile corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;	2019. R.I. evaluarea/ tratarea pacientului cu constipație, f.d.u. categorii: 1. una dintre măsurile igienodietetice simple la care răspunde constipația;
---	---	---	---	---	--	--	--	--	---

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, f.l. = referitor/referitoare la; U.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază despre;

2. una dintre manevrele intervenție care poate fi efectuată prin colonoscopie;
3. stare patologică remediată chirurgical evidențiată prin defecografie;
- și următoarele aspecte:
 - a. hidratare abundentă;
 - b. dilatarea sfincterilor;
 - c. obstrucția completă a evacuarii din cauza obstrucției în formă de pâlnie a canalului anal prin telescopare;
- care sunt răspunsurile corecte:
 - A. a-1, b-2, c-3;
 - B. a-1, b-3, c-2;
 - C. a-2, b-1, c-3;
 - D. a-2, b-3, c-1;
 - E. a-3, b-1, c-2;

- 2020 R.I. evaluarea/ tratarea pacientului cu constipație, f.d.u. categorii:
1. una dintre măsuri igienico-dietetice simple la care răspunde constipația;
 2. leziuni care pot fi identificate prin irigografie;
 3. stare patologică remediată chirurgical evidențiată prin defecografie;
 - și următoarele aspecte:
 - a. rectocel extrem de mare: la tentativele de defecatie, barul trece preferențial în rectocel în loc să fie expulzat prin anus;
 - b. toate leziunile de mucoasă suficient de importante pentru a produce constipație;
 - c. exerciții fizice;
 - care sunt asocierile corecte:
 - A. a-1, b-2, c-3;
 - B. a-1, b-3, c-2;
 - C. a-2, b-1, c-3;
 - D. a-3, b-2, c-1;

- 2021 U.f.d.f. evaluarea/ tratarea pacientului cu constipație, s.c.f.g.e.
- A. Scăderea în greutate, sângerea rectală și anemia;
 - B. sunt semne de alarmă care obligă fie la defecografie;
 - D. fie la colonoscopie, mai ales la pacienții trecuți de 40 de ani;
 - E. pentru a exclude leziuni organice (cancer, stricturi).
- 2022 R.I. evaluarea/ abordarea/ tratarea pacientului cu constipație u.a.s.c.g.e.
- A. semnele de alarmă obligă la investigații imagistice vizând tractul digestiv inferior;
 - B. o componentă esențială a examenului fizic este tușul rectal;

Prescurtări frecvent folosite: G.E. = cu excepția; S.U.G.E. = sunt următoarele, cu excepția; U.a.s.c.G.E. = următoarele afirmații sunt corecte, cu excepția; S.c.f.g.e. = sunt corect formulate, cu excepția.

- 2030 F.d.u. etape în abordarea unui pacient cu constipație:
- a. regim de antrenare a intestinelui;
 - b. dacă pacientul nu răspunde, c. inițial doar administrare de fibre;
 - d. se recurge la tratament;
 - e. nu există semnale de alarmă și nu s-a depistat nimic la investigații;
- ce secvență este recomandabilă:
- A. b-d-c-a-e-a;
 - B. b-d-a-e-a;
 - C. c-a-e-a-d-b;
 - D. d-a-b-e-b-c;
 - E. e-d-a-c-b-a;
- 2031 R.I. tratamentul pacientului cu constipație u.a.s.c.g.e.
- A. inițial se recurge doar la administrare de fibre;
 - B. dacă pacientul nu răspunde administrare de fibre, se trece la un regim de antrenare a intestinelui;
 - C. lubrifianta este un analog prostaticlandinic care induce secreție intestinală prin blocarea canalului pentru clor;
 - D. după micul dejun, se recomandă ca pacientul să petreacă 15-20 min pe toaletă;
 - E. cât timp pacientul se află pe toaletă, nu trebuie să existe factori care să-l distragă și trebuie să se screeamă cât mai mult;
- 2032 U.f.d.f. tratamentul pacientului cu constipație s.c.f.g.e.
- A. Regimul de antrenare a intestinelui constă:
 - B. în administrarea unui:
 - C. laxativ osmotic (Cascara, Senna, crușin);
 - D. și evacuare prin dijamă;
 - E. sau cu ajutorul unui supozitor cu glicerină după caz;
- 2033 U.f.d.f. tratamentul pacientului cu constipație s.c.f.g.e.
- A. Scrimerea (efortul de defecție) excesiv poate:
 - B. provoca hemoroid, iar dacă planșul pelvian este slab;
 - C. sau nervii rușinoși sunt lezați;
 - D. poate duce, în călăvia ani, la obstrucția defecției;
 - E. prin volubus;
- 2034 R.I. pacienții cu constipație care nu răspund la metode terapeutice simple sau care necesită tratament excesiv, u.a.s.c.g.e.
- A. reprezintă o proporție mică (probabil <5%) din totalul pacienților;
 - B. tratamentul pe termen lung cu laxative potente poate produce sindromul de abuz de laxative;
 - C. se presupune că acești pacienți au constipație severă sau dificil de tratat și ar trebui investigați suplimentar;
 - D. observarea suplimentară a acestor pacienți poate uneori evidenția o cauză omisă anterior;
 - E. alegerea unui tratament rațional este ajutată de evaluarea funcției fiziologice a colonului și a planșului pelvian și a stării psihologice;
 - F. o cauză poate fi identificată la marea majoritate a celor care ajung într-un centru de referință terțiar;
 - G. d. u. NU este indicată o cauză omisă în evaluarea uzuală a unui pacient cu constipație refractară la tratament și pe care observarea ulterioară/ suplimentară a pacientului o poate uneori evidenția:
 - A. tuburare de evacuare;
 - B. abuz de laxative;
 - C. simulare;
 - D. tuburare psihologică;
 - E. tumoră anală;
- 2036 R.I. felul în care se abordează pușinele cazuri de constipație severă, u.a.s.c.g.e.
- A. în cazurile de constipație severă se poate recurge la metode de măsurare a tranzitului colonic;
 - B. senzația de evacuare incompletă a rectului infirmă diagnosticul de SII;
 - C. cea mai frecventă cauză de obstrucție a evacuarii este tonusul scăzut al mușchilor puborectali;
 - D. una dintre investigațiile dinamice este colonoscopia;
 - E. scintigrafia (în timpul expulzării unui scaun artificial) evaluează cantitatea de „scaun artificial” evacuată;
- 2037 R.I. felul în care se abordează pușinele cazuri de constipație severă, u.a.s.c.g.e.
- A. în cazurile de constipație severă se poate recurge la investigații vizând segmentul anorectal și planșul pelvian;
 - B. radioscintigrafia;
 - C. măsurarea coborârii perineale;
 - D. se solicită pacientului să se screeamă pentru a evacua

Prescurtări frecvent folosite: u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date; f.d.u. = fiind date următoarele; r.i. = referitor/referitoare la; U.f.d.f. = Următoarele fragmente dintr-o fază descriptivă.

D. generează o expunere severă la iradiere;
E. este dezavantajoasă prin costul relativ mare și nevoia de substanțe specifice preparare într-un laborator de medicină nucleară;
2045. U.f.f.d. radioscintigrafia s.c.f.g.:
A. Radioscintigrafia evaluează pe lângă tranzitul colonic;
B. și tranzitul gastric și cel al intestinului subțire;
C. ceea ce poate fi important la ~20% din pacienții cu tranzit colonic întârziat;
D. la care acesta reflectă;
E. o tulburare de mobilitate res-transă la colon.
2046. Manifestări care sugerează disfuncția de planșeu pelvian s.u.c.f.g.:
A. incapacitatea de a evacua rectul;
B. senzație persistentă de pleni-tudine suprapubică;
C. durere abdominală;
D. necesitatea de a extrage scaunul din rect cu degetul;
E. necesitatea de a aplica presiune pe peretele anterior al vaginului;
F. necesitatea de a susține perineul în timpul scormenii (efortului de defecație);
G. necesitatea de a face efort de defecație excesiv;
2047. C.d.u. tulburări decelabile la evaluarea psihologică este cea mai puțin relevantă pentru constipație:
A. tulburări de alimentație;
B. probleme legate de cine deține controlul;
C. depresie;
D. paranoia;
E. tulburări de stres post-traumatic;
2048. F.d.u. investigații vizând segmentul anorectal și planșeul pelvian la un pacient cu constipație:
1. se solicită pacientului să se scormăie pentru a evacua degetul examinătorului în timpul tușului rectal;
2. măsurarea coborârii perineale; și următoarele caracteristici:
a. evidențiază feul în care se mișcă mușchii puborectali în timpul scormenii;
b. detectează coborârea neadecvată sau balonarea perineală în timpul scormenii;
c. este relativ ușor de efectuat clinic prin plasarea pacientului în decubit lateral stâng și observarea perineului;
d. un test clinic simplu care se poate face în cabinet pentru a evidenția lipsa de relaxare a mușchilor puborectali;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-1, d-2;
E. a-2, b-1, c-2, d-1;
2049. R.I. investigarea unui pacient cu constipație, f.d.u. constată la măsurarea coborârii perineale:
1. coborâre neadecvată;
2. balonare perineală în timpul scormenii față de reperele osoase;
și următoarele caracteristici:
a. sugerează coborâre perineală excesivă;
b. <1,5 cm;
c. un semn de disfuncție a planșeului pelvian;
d. >4 cm;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-1, d-1;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;
2050. R.I. testul de expulzare a balonului la pacienții cu constipație, u.s.c.f.g.:
A. este una dintre investigațiile vizând segmentul anorectal și planșeul pelvian;
B. este un important test de depis-tare pentru distincția anorectală;
C. înaintea de introducerea în rect, balonul din vârful cateterului este umplut cu 50 mL de apă;
D. în decubit lateral, se determină greutatea necesară pentru a facilita expulzarea balonului;
E. dacă este pozitiv, este necesară evaluarea rectului, sincinelului anal și planșeului pelvian;
2051. R.I. testul de expulzare a balonului la pacienții cu constipație, u.s.c.f.g.:
A. este un test global de evacuare;

Prescurtări frecvent folosite: c.ē. = cu excepția, s.u.c.ē. = sunt următoarele, cu excepție; u.a.s.c.ē. = următoarele afirmatii sunt corecte, cu excepția, s.c.f.c.ē. = sunt corect formulate, cu excepția, corecte, cu excepția, s.c.f.c.ē. = sunt corect formulate, cu excepția.

B. presupune introducerea în rect a unui cateter urinar având la vârf un balon;	B. a-1, b-3, c-2;
C. în mod normal, pacientul poate evacua balonul șezând pe toaletă sau stând în decubit lateral stâng;	C. a-2, b-1, c-3;
D. în mod normal, expulzarea balonului are loc cu o greutate adăugată de cel puțin 200 g;	D. a-2, b-3, c-1;
E. dacă este pozitiv, impune căutarea unei cauze pentru obstrucția defecației;	E. a-3, b-1, c-2;
2052. U.f.d.f.d. investigarea constipației s.c.f.c.e.:	2061. F.d.u. moduri în care se poate prezenta HD:
A. Dacă testul de expulzare a balonului este pozitiv;	1. melenă;
B. la pacienții suspecți de obstrucție a defecației;	2. hemoragie digestivă ocultă;
C. se va efectua o evaluare anatomică a rectului;	3. simptome caracteristice pentru pierderea de sânge acută sau cronică;
D. și a sigmoidului și o evaluare;	și u. trăsături (definitorii):
E. a relaxării diafragmei.	a. scaun negru ca smoala, urât mirositor;
2053. U.f.d.f.d. manometria anorectală s.c.f.c.e.:	b. absența unor sângerări evidente, sângerarea este amestecată de sîngele din fecale;
A. Poate descoperi un tonus excesiv al sfincțerului anal;	c. amețeli, cefalee, angină, dispnee, fatigabilitate, care sunt asociate corecte;
B. în repaus (peste 80 mmHg) sau la contracție;	A. a-1, b-2, c-3;
C. sugerând anism (incontinența sfincțerului anal) și identifică și;	B. a-2, b-1, c-3;
D. sindroame rare, cum ar fi boala Hirschsprung a adultului;	C. a-2, b-3, c-1;
E. prin exacerbarea reflexului inhibitor rectoanal.	D. a-3, b-1, c-2;
2054. R.I. defecografie, u.a.s.c.e.:	E. a-3, b-2, c-1;
A. este o igrografie dinamică, incluzând vizualizări laterale efectuate în timpul expulzării fecalului;	2062. R.I. HD, u.a.s.c.e.:
B. evidențiază anomalii ușoare la mulți pacienți;	A. HD (hemoragia din tractul gastrointestinal) se poate prezenta drept HD superioară (HDS) sau inferioară (HDI);
C. la majoritatea pacienților identifică stări patologice remediable chirurgicale;	B. în formele severe de HDS se poate produce decesul, rareori însoțit prin exsangvinare;
D. necesită un radiolog implicat și cu experiență;	C. cel mai adesea, decesul este provocat de prăbușirea tensiunii arteriale;
E. evidențiază anomalii care sunt patognomonice pentru disfuncția planșeului pelvian;	D. mortalitatea la pacienții cu vârstă <60 ani în absența unei boli concomitente importante este <1%;
2055. U.f.d.f.d. investigațiile imagistice dinamice în constipația severă s.c.f.c.e.:	E. incidența spitalizărilor pentru HDI este aproximativ o cincime din cea pentru HDS;
A. Proctografia de defecație ajută la măsurarea;	2063. R.I. sursele digestive superioare de HD, f.d.u. categorii de incidență:
B. ascensiunii perineale și a unghiului rectosigmoidian;	1. cauze mai frecvente;
C. în repaus;	2. cauze mai puțin frecvente;
D. la contracția sfincțerului;	și următoarele stări patologice:
E. și la scormere (la efortul de defecație).	a. varice esofagiene;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date, i.d.u. = fiind date următoarele, r.l. = referitor/referitoare la; U.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază deose:

1. cauze mai puțin frecvente;
2. cauze mai puțin frecvente;
3. cauze mai puțin frecvente – leziuni vasculare;
- și următoarele stări patologice:
- a. sindromul Mallory-Weiss;
- b. sângerare din calea biliară (hemobilie);
- c. gastropatia asociată cu prolapsul gastric;
- d. vas aberrant din mucoasă care sângerează printr-un defect de mucoasă punctiform (leziunea Dieulafoy);
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-2, d-3;
- B. a-1, b-3, c-2, d-2;
- C. a-1, b-3, c-2, d-2;
- D. a-2, b-3, c-1, d-2;
- E. a-3, b-1, c-2, d-2;
2065. R.I. sursele digestive superioare de HD, f.d.u. categorii de incidență:
1. cauze mai frecvente;
2. cauze mai puțin frecvente;
3. cauze mai puțin frecvente – leziuni vasculare;
- și următoarele stări patologice:
- a. duodenita erozivă;
- b. gastropatia hemoragică sau erozivă;
- c. fisurile aortice; d. ecazia vasculară gastrică antrală (GAVE, „stomac perene”);
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-2, d-3;
- B. a-2, b-1, c-2, d-3;
- C. a-2, b-2, c-1, d-3;
- D. a-2, b-3, c-1, d-2;
- E. a-3, b-2, c-2, d-1;
2066. R.I. sursele digestive superioare de HD, f.d.u. categorii de incidență:
1. cauze mai frecvente;
2. cauze mai puțin frecvente;
3. cauze mai puțin frecvente – leziuni vasculare;
- și următoarele stări patologice:
- a. sângerare din ductul pancreatic (hemococcus paracelstus);
- b. esofagia erozivă;
- c. telangiectazia hemoragică ereditară (Osler-Weber-Rendu);
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
- B. a-2, b-1, c-3;
- C. a-2, b-3, c-1;
- D. a-3, b-1, c-2;
- E. a-3, b-2, c-1;
2067. F.d.u. evenimente legate de sindromul Mallory-Weiss:
- a. vărsături, reflex de vomă sau tuse;
- b. suprasolicitare mecanică a mucoasei la joncțiunea gastroesofagiană (de obicei pe versantul gastric);
- c. sfâșierea mucoasei;
- d. hematemă;
- care este lanțul cauzal corect:
- A. a-b-b-c-a-d;
- B. a-b-c-d-b;
- C. d-a-b-c-b;
- D. d-b-a-a-c;
- E. d-b-b-c-a;
2068. R.I. surse digestive superioare hemoragiei digestive, u.a.s.c.g.e.:
- A. eciziile vasculare sunt cea mai frecventă cauză de HDS (~50% din cazuri);
- B. prevalența ulcerelor determinate de Helicobacter pylori este în scădere;
- C. HTP poate determina HD prin gastropatie și enterocolopatie portal-hiperfensivă;
- D. pacienții cu hemoragie variceală au evoluție mai favorabilă decât pacienții cu alte surse de HDS;
- E. sângerarea provocată de esofagia erozivă este insuficientă pentru a produce anemie feriprivă;
2069. R.I. surse digestive superioare hemoragiei digestive, u.a.s.c.g.e.:
- A. proporția ulcerelor determinate de AINS este în creștere;
- B. proporția varicelor printr-cauzele de HDS variază mult (~5-30%) în funcție de populație;
- C. HTP poate duce la formarea de varice mai ales în stomac, dar și în esofag, intestinel subțiri și gros;
- D. esofagia erozivă produce de obicei HD masivă;
- E. prolapsul stomacului proximal în esofag la reflexul de vomă se produce în special la fumători;
2070. R.I. sindromul Mallory-Weiss, u.a.s.c.g.e.:
- A. este responsabil de ~5-15% din cazurile de HDS;
- B. apare mai ales la pacienții alcoolici;
- C. apare în urma efortului de a vărsa, icni, tuși;
- D. este provocat de suprasolicitare mecanică a mucoasei la joncțiunea gastroesofagiană, de obicei pe versantul esofagian;
- E. constă în hematemă prin sfâșierea mucoasei la joncțiunea gastroesofagiană;
2071. R.I. gastropatia hemoragică sau erozivă, u.a.s.c.g.e.:
- A. termenul se referă la hemoragi și eroziuni subepiteliale vizuale endoscopice;
- B. frecvența se folosește denumirea de gastrită;
- C. fiind leziuni ale mucoasei, sângerea este masivă;
- D. o cauză frecventă este ingestia de alcool;
- E. dintre pacienții care iau cronic AINS, jumătate au eroziuni, iar 15-30% au ulcere;
2072. R.I. gastropatia hemoragică sau erozivă, u.a.s.c.g.e.:
- A. de obicei sângerea este ușoară și doar rarori imponentă;
- B. denumirea de gastrită este mai adecvată întrucât leziunea primară este inflamatorie;
- C. o cauză frecventă este consumul de AINS;
- D. stresul este printre cauzele obișnuite;
- E. până la 20% din alcoolici cu simptome de HDS au semne de hemoragii sau eroziuni subepiteliale;
2073. Circumstanțe în care apar leziuni ale mucoasei gastrice provocate de stres, u.a.g.e.:
- A. traumatisme severe;
- B. intervenții psihoterapeutice;
- C. asursi alectând mai mult de o teime din suprafața corporală;
- D. patologie majoră intracraniană;
- E. boală medicală severă (care presupune dependență de ventilație, coagulopatie);
2074. R.I. leziunile mucoasei gastrice provocate de stres, u.a.s.c.g.e.:
- A. astfel de leziuni apar doar la pacienți extrem de bolnavi;
- B. nu se produce sângere semnificativ decât dacă apar ulcerații;
- C. mortalitatea este mare din cauza severității hemoragiei;
- D. incidența acestor forme de HD a scăzut mult în ultimii ani;
- E. scăderea incidenței se datorează cel mai probabil îngrijiri mai bune a pacienților critici;

Prescurtări frecvent folosite: S.E. = cu excepție, s.u.g.e. = sunt următoarele, cu excepție; u.a.s.c.g.e. = următoarele afirmări sunt corecte, cu excepție, s.c.i.g.e. = sunt corect formulate, cu excepție;

2075. R.I. sursele din intestinul subțire ale HD, u.a.s.c.g.e.:
- A. aceste surse sunt cele situate dincolo de teritoriul acoperit de un endoscop obișnuit;
- B. aceste surse sunt răspundătoare pentru majoritatea cazurilor de HD de cauză neclară;
- C. AINS pot provoca eroziuni și ulcere în intestinul subțire;
- D. AINS sunt probabil o cauză frecventă de HD cronică obscură;
- E. frecvența diverticulului Meckel drept cauză de sângere crește cu vârsta;
2076. R.I. sursele din intestinul subțire ale HD, u.a.s.c.g.e.:
- A. aceste surse sunt dificil de diagnosticat;
- B. sângerea din intestinul subțire este frecventă;
- C. cele mai frecvente cauze sunt tumorile, eciziile vasculare și eroziunile și ulcerile provocate de AINS;
- D. coxlii alectează intestinul subțire mai mult decât AINS tradiționale;
- E. diverticulul Meckel este cea mai frecventă cauză de HD semnificativă la copii;
2077. R.I. cauzele din intestinul subțire ale HD obscure, f.d.u. categorii de incidență:
1. cele mai frecvente;
2. mai frecvente la vârstă <40-50 ani;
3. mai puțin frecvente;
- și următoarele stări patologice:
- a. eciazi vasculare;
- b. tumori;
- c. chisturi de duplicare;
- d. infecție;
- e. varice de intestin subțire;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3, d-3, e-3;
- B. a-1, b-3, c-2, d-3, e-3;
- C. a-1, b-3, c-3, d-2, e-3;
- D. a-2, b-1, c-3, d-3, e-3;
- E. a-3, b-3, c-1, d-3, e-2;
2078. R.I. cauzele din intestinul subțire ale HD obscure, f.d.u. categorii de incidență:
1. cele mai frecvente;
2. mai frecvente la vârstă >50-60 ani;
3. mai puțin frecvente;
- și următoarele stări patologice:
- a. eciazi vasculare;
- b. telescopare;
- c. tumori;
- d. diverticule;
- e. ischemie;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-3, c-3, d-2, e-3;
- B. a-2, b-3, c-1, d-3, e-3;
- C. a-3, b-1, c-2, d-3, e-3;
- D. a-3, b-1, c-3, d-2, e-3;
- E. a-3, b-3, c-3, d-2, e-1;
2079. R.I. cauzele din intestinul subțire ale HD obscure, f.d.u. categorii de incidență:
1. cele mai frecvente;
2. mai puțin frecvente;
- și următoarele stări patologice:
- a. vasculită;
- b. eroziuni și ulcere de intestin subțire provocate de AINS;
- c. boală Crohn;
- d. eciazi vasculare;
- e. diverticul Meckel;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-1, c-2, d-2, e-2;
- B. a-2, b-1, c-2, d-1, e-2;
- C. a-2, b-1, c-2, d-2, e-1;
- D. a-2, b-2, c-1, d-1, e-2;
- E. a-2, b-2, c-1, d-2, e-1;
2080. Tumor din intestinul subțire recunoscut drept cauze ale HD obscure s.u.g.e.:
- A. sarcom;
- B. leiomiom;
- C. limfom;
- D. polipi benigni;
- E. carcinoizi;
- F. metastaze;
- G. lipom;
2081. R.I. sursele colonice ale hemoragiei digestive, u.a.s.c.g.e.:
- A. probabil cea mai frecventă cauză de HD sunt diverticulele;
- B. fisurile anale provoacă durere și sângere masivă;
- C. neoplasmele sunt în primul rând leiomiocarom;
- D. eciziile vasculare sunt situate mai ales în colonul distal;
- E. eciziile vasculare sunt sursa HD mai ales la pacienți sub 60 de ani;
2082. R.I. sângerea diverticulară, u.a.s.c.g.e.:
- A. începe insidios;
- B. de obicei este dureroasă;
- C. uneori este masivă;
- D. adesea are originea în colonul drept;
- E. de regulă este minoră sau ocultă;
2083. R.I. sângerea din eciazi vasculare ale colonului drept la vârstnici u.a.s.c.g.e.:
- A. pot fi manifeste;
- B. pot fi oculte;
- C. tind să fie cronice;
- D. de regulă sunt semnificative hemodinamic;
- E. pot provoca anemie feriprivă;
2084. R.I. sursele colonice ale hemoragiei digestive, f.d.u. categorii:
1. leziuni locale anale, care necesită razeon spitalizare;
2. printre cele mai frecvente cauze de HD la adulți;
3. cauze rare;
- și următoarele stări patologice:
- a. vasculită;
- b. hemoroidi;
- c. ulcere sau colită induse de AINS;
- d. neoplasme;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-3, c-2, d-3;
- B. a-1, b-3, c-3, d-2;
- C. a-2, b-1, c-3, d-3;
- D. a-3, b-1, c-3, d-2;
- E. a-2, b-3, c-2, d-1;
2085. R.I. sursele colonice ale hemoragiei digestive, f.d.u. categorii:
1. leziuni locale anale, care necesită razeon spitalizare;
2. printre cele mai frecvente cauze de HD la adulți;
3. cauze rare;
- și următoarele stări patologice:
- a. traumatisme;
- b. colită;
- c. fisule aortice;
- d. fisurile anale;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-3, c-3, d-2;
- B. a-3, b-1, c-2, d-3;
- C. a-3, b-1, c-3, d-2;
- D. a-3, b-2, c-3, d-1;
- E. a-3, b-3, c-2, d-1;
2086. R.I. sursele colonice ale hemoragiei digestive, f.d.u. categorii:
1. printre cele mai frecvente cauze de HD la adulți;
2. cauze rare;
3. printre cele mai frecvente cauze colonice de HD semnificativă la copii și adolescenți;
- și următoarele stări patologice:
- a. BIC;
- b. varice (cel mai adesea rectale);
- c. sângere după polipectomie;
- d. diverticule;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-2, d-3;
- B. a-1, b-2, c-3, d-2;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele, c.d.u. = care dintre următoarele; f.d.u. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele; r.I. = telefonierentore la, U.I.d.I.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază despre.

- C. a-1, b-3, c-2, d-2;
D. a-2, b-1, c-2, d-3;
E. a-3, b-2, c-2, d-1;
2087. R.I. sursele colonice ale hemoragiilor digestive, f.d.u. categorii:
1. printre cele mai frecvente cauze de HDI la adulți;
 2. cauze rare;
 3. cele mai frecvente cauze colonice de HD semnificativ la copii și adolescenți;
 4. următoarele stări patologice: a. edtații vasculare;
 - b. hiperplazie nodulară limfoidă;
 - c. polipi juvenili;
 - d. sindromul ulcerului rectal solitar;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-2, d-3;
B. a-1, b-2, c-3, d-2;
C. a-1, b-3, c-2, d-2;
D. a-2, b-3, c-1, d-2;
E. a-3, b-2, c-1, d-2;
2088. R.I. colită ca sursă a hemoragiilor digestive, f.d.u. categorii de incidență:
1. cel mai adesea;
 2. uneori;
 3. următoarele forme de colită: a. ischemică;
 - b. post-infecțioasă;
 - c. post-iradiere;
 - d. prin BIC idiopatică;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-2, b-1, c-1, d-2;
D. a-2, b-1, c-2, d-1;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;
2089. R.I. diferențierea HDS de HDI, u.a.s.c.ș.e.:
- A. hematemeza indică o sursă GI superioară de sângere (sub ligamentul Treitz);
B. hematochezia înseamnă de obicei o sursă superioară de sângere gastrointestinală;
C. leziunile sângănânde ale intestinelor subțiri se pot prezenta ca melenă sau hematochezie;
D. hipovolemia poate determina scăderea ureei plasmatică;
E. un aspect bilios exclude sângerea dintr-o leziune postpilorică;
2090. R.I. diferențierea HDS de HDI, u.a.s.c.ș.e.:
- A. melenă înseamnă că sângele a fost prezent în tractul GI pentru cel mult 14 ore;
B. o leziune GI superioară poate sângera atât de intens încât sângele să nu rămână suficient în intestin pentru a se produce melenă;
2094. R.I. evaluarea pacienților cu HD acută, u.a.s.c.ș.e.:
- A. măsurarea frecvenței cardiace și a tensiunii arteriale este cea mai bună metodă de a evalua inițial pacientul cu HD;
B. tahicardia sugerează o hemoragie importantă;
C. în cazul unei hemoragii masive, hipotensiunea poate să apară chiar și în decubit dorsal;
D. în cazul unui episod de sângere severă, hemoglobina este scăzută încă de la prezentarea inițială;
E. pe măsură ce fluidul extravascular intră în spațiul vascular pentru a restabili volumul, hemoglobina crește;
2095. R.I. evaluarea pacienților cu HD acută, u.a.s.c.ș.e.:
- A. primul gest care trebuie făcut în evaluarea pacientului cu HD este măsurarea frecvenței cardiace și a tensiunii arteriale;
B. hemoglobina scade imediat; C. hemoregia clinic semnificativă determină modificări posturale ale frecvenței cardiace și/sau ale tensiunii arteriale;
D. intrucă pacientul pierde sânge integral, inițial scad proporțional volumul plasmatic și cel eritrocitar;
E. scăderea hemoglobinei poate să dureze până la 72 de ore;
2096. F.d.u. evenimente care se petrec în urma unei HD acute:
- a. pacientul pierde sânge integral;
 - b. scad proporțional volumul plasmatic și cel eritrocitar;
 - c. hemoglobina scade;
 - d. inițial hemoglobina poate fi normală sau doar puțin scăzută;
 - e. fluidul extravascular intră în spațiul vascular pentru a restabili volumul;
- care este înălțarea temporală/cauzală corectă:
- A. a→b→d→e→c;
B. b→e→a→d→c;
C. c→b→a→d→e;
D. d→a→b→e→c;
E. e→b→c→a→d;
2097. R.I. evaluarea pacientului tipic cu HD lentă, cronică, u.a.s.c.ș.e.:
- A. hemoglobina este scăzută;
B. tensiunea arterială este scăzută;
- sângele să nu rămână suficient în intestin pentru a se produce melenă;
2092. F.d.u. evenimente care se petrec în urma unei HDS:
- a. hipovolemie;
 - b. distuncție renală acută;
 - c. hipotensiune;
 - d. crește ureea plasmatică;
 - e. scade perfuzia renală;
- care este înălțarea temporală/cauzală corectă:
- A. a→c→e→b→d;
B. b→d→e→c→a;
C. c→a→d→b→e;
D. d→a→c→e→b;
E. e→c→d→a→b;
2093. F.d.u. evenimente care se petrec în urma unei HDS:
- a. creșterea ureei plasmatică;
 - b. digestia proteinelor din sângele extravazat;
 - c. sângele ajunge în lumenul intestinal;
 - d. absorbția aminoacizilor;
 - e. metabolizarea aminoacizilor absorbiți;
- care este înălțarea temporală/cauzală corectă:
- A. a→c→b→e→d;
B. b→a→c→d→e;
C. c→b→d→e→a;
- Prescurtări frecvent folosite: c.ș.e. = cu excepție; s.u.ș.e. = sunt următoarele, cu excepția; u.a.s.c.ș.e. = următoarele afirmări sunt corecte, cu excepția; s.c.f.ș.e. = sunt corect formulate, cu excepția.

- C. frecvența cardiacă este adesea normală, dar poate fi scăzută din cauza anemiei;
D. o dată cu instalarea anemiei feriprive, VEM crește;
E. la pacientul anemic, scade lărgimea benzii de distribuție a hematiilor;
2098. R.I. evaluarea pacientului cu HDS, u.a.s.c.ș.e.:
- A. de obicei istoricul și examenul fizic nu au valoare diagnostică pentru sursa HDS;
B. EDS este investigația de elecție la pacienții cu HDS;
C. EDS ar trebui amânată la pacienții instabili hemodinamic; D. este de dori ca EDS să fie efectuată cât mai devreme și în cazurile de HDS mai ușoare;
E. EDS facilitează luarea deciziilor terapeutice;
2099. R.I. evaluarea pacientului cu HDS, c.d.u. elemente nu indică instabilitatea hemodinamică:
- A. anemie;
B. hipotensiunea;
C. tahicardia;
D. modificările posturale ale tensiunii arteriale;
E. creșterea frecvenței cardiace în ortostatism și scăderea ei în clinostatism;
2100. R.I. evaluarea pacientului cu HDI, u.a.s.c.ș.e.:
- A. în evaluarea pacientului cu HDI se începe prin a se stabili dacă pacientul este sau nu stabil hemodinamic;
B. sigmoidoscopia este investigația de elecție în cazul unei sângănări intense;
C. pregătirea pentru colonoscopie se poate realiza prin administrarea orală a unei soluții de lavaj colonic;
D. scintigrafie cu hematii marcate permite vizualizări repetate în interval de până la 24 ore;
E. în HDI activă, angiografia permite manevre terapeutice;
2101. R.I. evaluarea pacientului cu HDI, u.a.s.c.ș.e.:
- A. pacientul instabil hemodinamic are de regulă melenă;
B. în cazul unei sângănări intense, sigmoidoscopia este ideală pentru identificarea locului sângănării;
C. colonoscopia este procedura de elecție, în afară de cazul că hemoragia este prea mare sau
- sigmoidoscopia a identificat sediul sângănării;
D. scintigrafia trebuie interpretată cu prudență deoarece rezultatele (în special de la imaginile culesse timpuriu) sunt foarte variabile;
E. angiografia permite oprirea unei sângănări active prin instalarea intraarterială de AVP sau prin embolizare;
2102. R.I. evaluarea pacientului cu HDI, u.a.s.c.ș.e.:
- A. unui specialist recomanda colonoscopia pentru sângănarea rectală de orice magnitudine doar la pacienții <40 ani;
B. sigmoidoscopia este utilă mai ales la pacienții <40 ani cu sângănare masivă;
C. dacă sigmoidoscopia nu descoperă o leziune cu sângănare activă evidentă, colonoscopia poate fi amânată sau evitată;
D. în HDI activă, angiografia poate detecta sediul sângănării;
E. chiar și după oprirea sângănării, angiografia poate identifica anomalii vasculare sau tumori;
2103. R.I. evaluarea pacientului cu HDI, u.a.s.c.ș.e.:
- A. la pacienții cu presupusă HDI se poate efectua colonoscopia timpuriu pentru detectarea unor leziuni jos situate;
B. colonoscopia poate fi efectuată doar după curățarea colonului;
C. scintigrafia cu hematii marcate cu ^{99m}Tc poate identifica localizarea generală a sângănării;
D. extrazvazarea substanței de contrast în intestin în timpul angiografiei permite detectarea sediului sângănării;
E. angiografia permite identificarea ectaziilor vasculare;
2104. R.I. evaluarea unui pacient cu HDI, f.d.u. investigații:
1. EDS pentru a exclude o sursă GI superioară;
 2. colonoscopie;
 3. demersul diagnostic pentru sângănare ocultă;
- și următoarele tipuri de pacienți:
- A. instabil hemodinamic;
B. stabil hemodinamic, vârstă <40 ani, cu anemie feriprivă;
C. sângănare abundentă sau istoric familial de cancer colonic;
D. stabil hemodinamic în vârstă de >40 ani, colonoscopia nu identifică locul sângănării, iar sângănarea persistă;
2105. R.I. evaluarea unui pacient cu HDI, f.d.u. investigații:
1. angiografie;
 2. colonoscopie;
 3. sigmoidoscopia (colonoscopia după unii specialiști);
- și următoarele tipuri de pacienți:
- a. stabil hemodinamic, vârstă <40 ani, fără anemie feriprivă, sângănare abundentă sau istoric familial de cancer colonic;
b. stabil hemodinamic în vârstă de >40 ani;
c. instabil hemodinamic la care EDS nu a descoperit o sursă GI superioară și la care nu există răgaz pentru efectuarea lavajului colonic (sângănarea persistă);
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-1, c-3, d-2;
B. a-1, b-3, c-1, d-2;
C. a-1, b-3, c-2, d-1;
D. a-3, b-1, c-2, d-1;
E. a-3, b-2, c-1, d-1;
2106. F.d.u. circumstanțe, investigații și constatări în evaluarea unui pacient cu HDI, instabil hemodinamic:
- a. angiografie;
 - b. EDS pentru a exclude o sursă GI superioară;
 - c. dacă rezultatul este negativ, d. nu există răgaz pentru efectuarea lavajului colonic (sângănarea este prea mare);
- ce secvență este recomandabilă:
- A. a→d→c→b;
B. b→a→d→c;
C. b→c→d→a;
D. d→a→b→c;
E. d→b→a→c;
2107. F.d.u. circumstanțe, investigații și constatări în evaluarea unui pacient cu HDI, instabil hemodinamic:

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele, c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, f.d. = relativ/orfele/orfele la, u.f.d.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază despre,

- a. EDS pentru a exclude o sursă dinamică, în vârstă de 240 ani;
b. dacă rezultatul este negativ;
c. evaluarea imagistică a tractului GI inferior, preterabil prin colonoscopie;
d. există răgaz pentru efectuarea lavajului colonic;
e. secvență este recomandabilă:
A. a→b→d→c;
B. a→c→b→d;
C. c→a→b→d;
D. c→b→d→a;
E. d→a→c→b;
2108. F.d.u. circumstanțe, investigații și constatări în evaluarea unui pacient cu HDI, stabili hemodinamici:
a. sigmoidoscopie (colonoscopie după unit specializată);
b. vârstă <40 ani;
c. nu există anemie feriprivă, istoric familial de cancer colonic sau sângere abundentă;
ce secvență este recomandabilă:
A. a→b→c;
B. a→c→b;
C. b→a→c;
D. b→c→a;
E. c→b→a;
2109. F.d.u. circumstanțe, investigații și constatări în evaluarea unui pacient cu HDI, stabili hemodinamici:
a. vârstă <40 ani;
b. există anemie feriprivă, istoric familial de cancer colonic sau sângere abundentă;
c. colonoscopie;
ce secvență este recomandabilă:
A. a→b→c;
B. a→c→b;
C. b→a→c;
D. b→c→a;
E. c→b→a;
2110. F.d.u. circumstanțe, investigații și constatări în evaluarea unui pacient cu HDI, stabili hemodinamici, în vârstă de 240 ani:
a. colonoscopie;
b. loci sângerați este identificat;
c. sângerea persistă;
d. angiografie;
ce secvență este recomandabilă:
A. a→b→c→d;
B. b→a→d→c;
C. c→b→d→a;
D. d→b→a→c;
E. d→b→c→a;
2111. F.d.u. circumstanțe, investigații și constatări în evaluarea unui pacient cu HDI, stabili hemodinamici:
a. colonoscopie;
b. loci sângerați este identificat;
c. sângerea persistă;
d. angiografie;
ce secvență este recomandabilă:
A. a→b→c→d;
B. b→a→d→c;
C. c→b→d→a;
D. d→b→a→c;
E. d→b→c→a;
2112. R.I. căutarea sursei unei HD, f.d.u. categorii de investigații:
1. investigații de rutină;
2. tehnici imagistice mai noi, în curs de evaluare;
și următoarele tehnici:
a. enterografia prin RMN;
b. enterografia prin TC;
c. radiografia cu substanță de contrast;
d. endoscopie;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-2, b-1, c-1, d-2;
D. a-2, b-1, c-2, d-1;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;
2113. U.f.d.f.d. investigația HD de origine neclară s.c.f.c.e.:
A. Se consideră HD de origine neclară;
B. sângerea gastrointestinală;
C. severă sau complicată;
D. pentru care nu s-a identificat;
E. nicio sursă prin niciuna dintre tehnici investigaționale actuale.
2114. Referitor la investigația HD de origine neclară, fiind date următoarele tehnici:
1. angiografie;
2. capsula video endoscopică;
3. enteroscopia cu balon dublu;
și următoarele caracteristici:
A. lipsa de control împiedică manipularea pentru vizualizarea completă a intestinului;
b. poate evidenția anomalii vasculare sau vase tumorale în absența unei sângeri active;
c. permite endoscopistului să examineze și să intervină terapeutic pe aproape toată lungimea intestinului subțire, care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-1, c-2;
2117. R.I. investigația HD de origine neclară, u.a.s.c.g.e.:
A. HD de origine neclară poate fi manifestă (de exemplu melenă sau hematochezie) sau ocultă;
B. randamentul diagnostic în detectarea unei posibile cauze este de 26% pentru capsula endoscopică, față de 56% pentru enteroscopie;
C. angiografia poate evidenția anomalii vasculare sau vase tumorale chiar în absența unei sângeri active;

Prescurtări frecvent folosite: S.G. = cu excepția, s.u.c.g.e. = sunt următoarele, cu excepția, u.a.s.c.g.e. = următoarele afirmații sunt corecte, cu excepția, s.c.f.c.e. = sunt corect formulate, cu excepția.

- D. angiografia nu mai este utilă dacă sângerea a încetat;
E. scrigrafia cu ^{51m}Tc-pentlenei se efectuează pentru diagnosticarea unui apendice retrocecal, în special la pacienții tineri.
2118. U.f.d.f.d. investigația HD de origine neclară s.c.f.c.e.:
A. Enteroscopia cu balon dublu;
B. permite endoscopistului să examineze și să intervină terapeutic pe cea mai mare parte din (sau chiar pe toată) lungimea colonului;
C. terapeutic pe cea mai mare parte din (sau chiar pe toată) lungimea colonului;
D. ier imaginea sunt înregistrate în timp real, pe măsură ce;
E. substanță de contrast se deplasează prin intestin ajutată prin masarea abdominală.
2120. U.f.d.f.d. investigația HD de origine neclară s.c.f.c.e.:
A. La pacienții cu HD obscură, persistența care necesită transuzi sau spitalizări repetate;
C. sunt necesare investigații suplimentare, precum:
D. scrigrafia cu ^{51m}Tc, marcată cu ^{51m}Tc;
E. angiografia și ingrografia.
2121. R.I. enteroscopia prin împingere, u.a.s.c.g.e.:
A. este în general următorul pas dacă endoscopia și radiografia cu substanță de contrast nu identifică sursa unei HD;
B. se efectuează cu un enteroscop special conceput sau cu un colonoscop pediatric;
C. permite inspecția întregului duoden și a unei părți din jejun;
D. poate identifica sediul sângerei la majoritatea pacienților cu HD obscură;
E. este de obicei ultima investigație la care se recurge în HD de origine neclară.
2122. R.I. capsula video endoscopică, u.a.s.c.g.e.:
A. permite examinarea endoscopică doar a jejunului;
B. are un randament diagnostic mai mic decât enteroscopia prin împingere;
C. lipsa de control asupra capsulei împiedică manipularea ei și vizualizarea completă a intestinului;
D. nu permite prelevarea de eşantioane tisulare;
- E. nu permite aplicarea unor metode terapeutice;
2123. U.f.d.f.d. utilitatea enteroscopiei în investigația HD de origine neclară s.c.f.c.e.:
A. Dacă enteroscopia și endoscopia prin videocapsulă sunt negative sau nu sunt;
B. disponibile, ar trebui efectuată o investigație radiologică specializată a intestinului subțire, de exemplu enterociză în care;
C. se instalează substanța de contrast radiologică printr-un tub introdus prin nas până în ileon;
D. iar imaginile sunt înregistrate în timp real, pe măsură ce;
E. substanță de contrast se deplasează prin intestin ajutată prin masarea abdominală.
2124. R.I. HD ocultă, u.a.s.c.g.e.:
A. se manifestă printr-un test pozitiv pentru hemoragii oculte în scaun sau prin anemie posibilă;
B. în general, investigația trebuie să înceapă cu angiografie;
C. colonoscopia trebuie efectuată mai ales la pacienții sub 40 de ani;
- D. în cazul unei colonoscopii negative, mulți specialiști efectuează EDS numai dacă pacienții are anemie feriprivă sau simptome GI superioare;
E. dintre pacienții fără leziuni la colonoscopie, 25-40% au o anomalie observabilă la EDS;
F. în cazul unei colonoscopii negative, unii specialiști recomandă EDS la toți pacienții;
2125. F.d.u. demersuri constatări în evaluarea unui pacient cu HD ocultă:
a. (la pacienții cu anemie feriprivă) enteroscopia, capsula video endoscopică și/sau enterociză;
b. dacă evaluarea colonului este negativă;
c. teste pozitiv pentru hemoragii oculte în scaun;
d. EDS;
- e. dacă endoscopia standard nu este lamutitoare;
f. colonoscopie (mai ales la pacienții >40);
ce secvență este recomandabilă:
A. c→f→b→a→e→d;
B. c→f→b→d→e→a;
C. c→f→d→b→a→e;
D. d→c→b→a→f→e;
2126. U.f.d.f.d. icter s.c.f.c.e.:
A. icterul este alături de simptome, căi și semne, întrucât poate fi constatat atât de pacient, cât și de medic;
B. icterul dispare de îndată ce se normalizează bilirubina;
C. icterul semnalează de obicei o patologie care afectează direct sau indirect structurile hepatobiliare;
D. mai rar, icterul este un semn de hemoliză;
E. hiperbilirubinemia este consecința dezechilibrului dintre producția și eliminarea bilirubinei;
2128. R.I. mecanismele hiperbilirubinemiei, f.d.u. modificări:
1. hiperbilirubinemia neconjugată;
2. hiperbilirubinemia neconjugată și/sau conjugată, după caz;
3. hiperbilirubinemia conjugată;
și următoarele cauze:
a. deficit în manipularea (prelucrare, conjugarea, excreția) hepatocitară a bilirubinei;
b. sângerea înapoi în sânge a bilirubinei neconjugate sau conjugate din hepatocitele sau din ducile biliare lezate/blocate;
c. supraproducția de bilirubină, care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;
2129. R.I. mecanismele hiperbilirubinemiei, f.d.u. categorii:
1. creșterea bilirubinei neconjugate;
2. creșterea bilirubinei conjugate;
și următoarele cauze:
a. scăderea excreției în canalele biliare;
b. sângere retrogradă a bilirubinei;
c. deficit în prelucrare sau conjugarea bilirubinei;
d. supraproducție (hemoliză);
care sunt asocierile corecte:

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele; r.I. = referitor/referitoare la; U.f.d.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază corectă.

- A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-1, d-2;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;
2130. R.I. indicațiile orientative pe care examenul fizic le poate da despre nivelul hiperbilirubinemiei, u.a.s.c.g.e.:
- A. conținând multă elastină, sclerile au afinitate scăzută pentru bilirubină;
B. o hiperbilirubinemie de 3,0 mg/dl nu este decelabilă prin examen fizic;
C. icterul scleral este mai dificil de decelat într-o cameră cu iluminare fluorescentă;
D. o hiperbilirubinemie mai importantă determină colorație galbenă a pielii;
E. o hiperbilirubinemie severă și trenantă poate produce chiar o colorație verde a pielii;
2131. R.I. indicațiile orientative pe care examenul fizic le poate da despre nivelul hiperbilirubinemiei, u.a.s.c.g.e.:
- A. creșterile ușoare ale bilirubiniei sunt detectate cel mai bine prin examinarea călcâielor;
B. icterul scleral înseamnă bilirubinemie $\geq 3,0$ mg/dl;
C. dacă sclerile par icterice, prezența icterului poate fi confirmată prin examinarea zonei sublinguale;
D. colorația galbenă a pielii este mai dificil de sesizat la persoanele hiperpigmentate;
E. dacă hiperbilirubinemia persistă mult timp, se produce oxidarea bilirubinei la biliverdină;
2132. R.I. indicațiile orientative pe care examenul fizic le poate da despre nivelul hiperbilirubinemiei, f.d.u. variante:
1. icterul sesizabil doar la sclere;
2. colorație galbenă a pielii;
3. colorație verde a pielii, următoarele estimări ale severității hiperbilirubinemiei:
- a. ușoară;
b. severă și trenantă;
c. importantă;
care sunt asociile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;
- E. colorația galbenă afectează mai ales sclerile;
2136. R.I. felul în care icterul schimbă culoarea urinei și a scaunului, u.a.s.c.g.e.:
- A. urobilinogenul este puternic colorat și se decolorează prin oxidare;
B. urobilina are culoare galbenă datorită unui sistem de duble legături conjugate și imprimă unei culorii galbene caracteristice;
C. urina devine hiperconcentrată în ambele variante de hiperbilirubinemie (conjugată și neconjugată);
D. bilirubina semnalifică hemoliză;
E. în icterul colestatic bilirubina nu ajunge în intestin, ceea ce duce la creșterea cantității de urobilinogen;
2137. F.d. cele două forme de bilirubină:
1. bilirubina neconjugată;
2. bilirubina conjugată;
și următoarele caracteristici:
- a. trece prin filtrul glomerular;
b. nu poate colora urina;
c. nu este legată de proteine;
d. este lipofilă;
- care sunt asociile corecte:
- A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-2, d-1;
C. a-2, b-1, c-1, d-2;
D. a-2, b-1, c-2, d-1;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;
2138. F.d. cele două forme de bilirubină:
1. bilirubina neconjugată;
2. bilirubina conjugată;
și următoarele caracteristici:
- a. nu este lipofilă;
b. poate colora urina;
c. nu trece prin filtrul glomerular;
d. este legată de proteine;
- care sunt asociile corecte:
- A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-2, d-1;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;
2139. R.I. felul în care se schimbă culoarea urinei și a scaunului în diversele tipuri de icter, f.d.u. variante:
1. hemoliză;
2. coleastăz;
și următoarele caracteristici:
- a. stercobilină abundentă în scaun;
b. scaunul decolorat;

Prescurtări frecvent folosite: S.G. = cu excepția; s.u.p.g. = sunt următoarele, cu excepția; u.a.s.c.g.e. = următoarele afirmări sunt corecte, cu excepția; s.c.f.g.e. = sunt corect formulate, cu excepția;

- c. cantitate mare de bilirubină conjugată în urină;
d. urina hiperconcentrată;
care sunt asociile corecte:
- A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-2, d-1;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;
2140. R.I. felul în care se schimbă culoarea urinei și a scaunului în diversele tipuri de icter, f.d.u. variante:
1. hemoliză;
2. coleastăz;
și următoarele caracteristici:
- a. stercobilină lipsește din scaun;
b. scaunul intens colorat;
c. urina conține multă urobilină (provenită din urobilinogen);
d. urina hiperconcentrată;
- care sunt asociile corecte:
- A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-2, d-1;
C. a-2, b-1, c-1, d-2;
D. a-2, b-1, c-2, d-1;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;
2141. R.I. evaluarea unui pacient cu icter, u.a.s.c.g.e.:
- A. icterul poate fi constatat clinic sau paraclic;
B. evaluarea primară a unui pacient cu icter trebuie să includă istoricul, examenul fizic și anumii parametri biochimici;
C. cea mai frecventă cauză a hiperbilirubinemiei neconjugate izolate sunt medicamentele;
D. calculi de bilirubinat de calciu (la pacienții cu hemoliză cronică) pot produce colecolitiază;
E. determinarea timpului de probă Trombînă este unul dintre testele biochimice utile în evaluarea inițială a icterului;
2142. R.I. evaluarea unui pacient cu icter, u.a.s.c.g.e.:
- A. pentru identificarea cauzei, se recurge la istoric, examen fizic și investigații paraclice (biochimice și imagistice);
B. puține afecțiuni pot produce hiperbilirubinemie neconjugată izolată;
C. în cazul afecțiunilor colestatice, se începe prin a se stabili dacă sunt de cauză infecțioasă sau nu;
D. testele biochimice oferă indicii cu privire la durata și severitatea bolii;

- E. determinarea albuminiei este unul dintre testele biochimice utile în evaluarea inițială a icterului;
2143. R.I. evaluarea unui pacient cu icter, u.a.s.c.g.e.:
- A. icterul poate fi constatat clinic la examenul fizic;
B. la un pacient cu icter, istoricul trebuie să includă variațiile sezoniere;
C. în cadrul primei etape de investigare a unui icter, se stabilește dacă hiperbilirubinemia este preponderent conjugată sau neconjugată;
D. într-un caz de hiperbilirubinemie neconjugată izolată, se începe prin a stabili dacă este vorba de un deficit enzimatic hepatic;
E. determinarea nivelului plasmatic al enzimelor hepatobiliare este unul dintre testele biochimice utile în evaluarea inițială a icterului;
2144. R.I. evaluarea unui pacient cu icter, u.a.s.c.g.e.:
- A. icterul poate fi constatat paraclic prin creșterea bilirubinei pe analize biochimice efectuate pentru alt motiv sau de rutină;
B. la pacienții cu hemoliză cronică, apar frecvent calculi de colesterol;
C. enzimele folosite în mod curent pentru evaluarea inițială a icterului (enzimele hepatobiliare) sunt ALT, AST, FAIc, GGT;
D. în cadrul primei etape de investigare a unui icter, se stabilește dacă celelalte teste biochimice hepatice sunt anormale;
E. testele biochimice permit de obicei diferențierea unui proces hepatocelular de unul colestatic;
2145. R.I. evaluarea unui pacient cu icter, u.a.s.c.g.e.:
- A. examenul general trebuie să includă evaluarea stării nutriționale a pacientului;
B. bilirubinemia (totală și directă) reprezintă unul dintre testele biochimice utile în evaluarea inițială a icterului;
C. dacă nu este vorba de hiperbilirubinemie neconjugată, se stabilește dacă este o afecțiune primară hepatocelulară sau colestatică;
- D. la pacienții cu hiperbilirubinemie neconjugată prin hemoliză cronică, colecolitiază poate duce la hiperbilirubinemie conjugată;
2146. În cadrul evaluării unui pacient cu icter, clinicianul trebuie să răspundă succesiv (pe baza datelor clinice și paraclice) la anumite întrebări - f.d.u. începuți de întrebări:
1. este hiperbilirubinemia;
2. dacă este izolată, este hiperbilirubinemia;
3. dacă hiperbilirubinemia este asociată cu modificarea testelor hepatice, indică acestea o afecțiune;
4. testele hepatice indică o afecțiune colestatică, este aceasta;
și u. sfârșitul de întrebări:
- a. hepatocelulară sau colestatică?
b. intrahepatică sau extrahepatică?
c. izolată sau însoțită de modificarea testelor hepatice?
d. neconjugată sau conjugată?
care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-3, c-2, d-4;
B. a-2, b-4, c-3, d-1;
C. a-3, b-1, c-2, d-4;
D. a-3, b-4, c-1, d-2;
E. a-3, b-4, c-2, d-1;
2147. F.d.u. întrebări, constatări și concluzii în evaluarea unui pacient cu icter:
- a. este hiperbilirubinemie izolată;
b. creșterea bilirubinei este însoțită de modificarea testelor hepatice?
c. NU;
d. hiperbilirubinemia este prin creșterea bilirubinei neconjugate sau conjugate?
ce secvență este recomandabilă:
- A. a $\rightarrow$ c $\rightarrow$ b $\rightarrow$ d;
B. b $\rightarrow$ a $\rightarrow$ c $\rightarrow$ d;
C. c $\rightarrow$ a $\rightarrow$ d;
D. c $\rightarrow$ a $\rightarrow$ b;
E. d $\rightarrow$ c $\rightarrow$ b $\rightarrow$ a;
2148. F.d.u. întrebări, constatări și concluzii în evaluarea unui pacient cu icter:
- a. DA;
b. testele hepatice indică o afecțiune hepatocelulară sau colestatică?

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele, c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, r.l. = referitor/referitoare la; U.I.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază despre;

c. dacă este o afecțiune colestatică, este intrahepatică sau extrahepatică?
d. creșterea bilirubinei este însoțită de modificarea testelor hepatice?

E. a-3, b-2, c-1;
2152. F.d.u. investigații constatări și concluzii în evaluarea unui pacient cu icter:
a. creșterea izolată a bilirubinei (fără modificarea celorlalte teste hepatice);
b. examen clinic și investigații paraclinice;
c. tulburări ereditare (Dubin-Johnson,Rotor);
d. hiperbilirubinemie directă/ conjugată (bilirubine conjugată >15%);
e. icter constat clinic sau paraclic;

B. b-a-d-c-e;
C. b-c-d-a-e-d;
D. b-d-c-a-e-c;
E. d-a-c-b-e;
2155. F.d.u. investigații, constatări și concluzii în evaluarea unui pacient cu icter asociat cu modificarea testelor hepatice cu tipul hepatocelular:
a. din nou, rezultate negative;
b. teste autoimune;
c. teste virologice suplimentare;
d. rezultate negative;
e. biopsie hepatică;
ce secvență este recomandabilă:
A. b-d-c-a-e;
B. b-d-e-a-c;
C. c-d-b-a-e;
D. e-d-c-a-b;
E. e-b-a-d-c;

a. Ac antinuclear;
b. Ac anti-microzomi hepatici și renali (Ac față de citocromul P450 2D6);
c. Ac anti-fibră musculară netedă (Ac față de actină);
d. hiperagmaglobulinemia (demonstrată prin electroforeza proteinelor serice);
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3, d-4;
B. a-1, b-4, c-3, d-2;
C. a-3, b-2, c-1, d-4;
D. a-3, b-2, c-4, d-1;
E. a-4, b-2, c-3, d-1;

e. colangio-pancreatografie RMN (CPRM), biopsie hepatică;
ce secvență este recomandabilă:
A. a-d-e-c-b;
B. b-c-e-d-a;
C. c-a-d-b-e;
D. d-a-c-b-e;
E. e-c-b-d-a;

d. afecțiuni moștenite care scad/ suprimă conjugarea bilirubinei; care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-1, d-2;
E. a-2, b-1, c-2, d-1;

ce secvență este recomandabilă:
A. a-c-b-d;
B. a-d-c-b;
C. b-c-d-a;
D. c-a-b-d;
E. d-a-b-c;

2149. Care dintre următorii parametri biochimici sunt cei mai puțin relevanți în evaluarea unui pacient cu icter:
A. bilirubină cu fracțiuni;
B. aminotransferaze;
C. enzime de colestază;
D. timp de protrombină, albumină (pentru evaluarea funcției hepatice);
E. creatinină, uree (pentru evaluarea funcției renale);

2150. F.d.u. investigații, constatări și concluzii în evaluarea unui pacient cu icter:
a. creșterea izolată a bilirubinei (fără modificarea celorlalte teste hepatice);
b. hiperbilirubinemie indirectă/ neconjugată (bilirubina conjugată <15%);
c. icter constat clinic sau paraclic;
d. examen clinic și investigații paraclinice;
e. hemoliză, medicamente, tulburări ereditare;
ce secvență este recomandabilă:
A. a-d-e-b-c;
B. b-c-d-a-e;
C. c-e-a-b-d;
D. d-b-a-e-c;
E. e-b-a-d-c;

2156. R.I. evaluarea pacientului cu icter f.d.u. constatări:
1. creșterea bilirubinei neînsoțită de modificarea celorlalte teste hepatice;
2. creșterea bilirubinei asociată cu transaminaze disproporțional crescute față de enzimele de colestază;
3. creșterea bilirubinei asociată cu enzime de colestază disproporțional crescute față de transaminaze;
și u. concluzii care orientează investigațiile ulterioare:
a. tipul colestatic;
b. tipul hepatocelular;
c. hiperbilirubinemie izolată, care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;

2162. F.d.u. investigații, constatări și concluzii în evaluarea unui pacient cu icter și teste hepatice de tip colestatic:
a. biopsie hepatică;
b. la teste serologice: AAM pozitiv;
c. ducte biliare nedilate la ecografie;
d. colestază intrahepatică;
ce secvență este recomandabilă:
A. a-b-c-d-a;
B. b-c-d-a-a;
C. c-d-a-b-a;
D. d-a-b-a-c;
E. d-b-a-c-a;

2166. R.I. fiziopatologia hiperbilirubinemiei neconjugate izolate, f.d.u. mecanisme:
1. scăde prelucarea hepatică a bilirubinei;
2. crește producția de bilirubină neconjugată;
3. scade conjugarea bilirubinei; și următoarele cauze:
a. entropoeză ineficientă;
b. sindrom Gilbert;
c. riampolnă;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;

2157. R.I. evaluarea pacientului cu icter hepatocelular, f.d.u. investigații:
1. serologie virale;
2. teste toxicologice;
3. teste autoimune;
și următoarele stări patologice:
a. hepatită virală;
b. hepatită autoimună;
c. hepatopatie toxică;
d. boala Wilson;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3, d-2;
B. a-1, b-3, c-2, d-2;
C. a-2, b-1, c-3, d-2;
D. a-2, b-2, c-3, d-1;
E. a-2, b-3, c-1, d-2;

2158. R.I. evaluarea pacientului cu hepatită autoimună (HA), f.d.u. categorii de modificări:
1. caracteristici pentru HA tip 1;
2. caracteristici pentru HA tip 2;
3. prezență în fața de frecvență în HA, ca și în hepatita virală cronică;
4. frecvență în HA, fără a fi specifică pentru un tip anume, și următoarele modificări:
A. a-e-d-c-b;
B. b-d-c-a-e;
C. c-d-b-a-e;
D. d-b-a-e-c;
E. e-b-a-d-c;

2159. F.d.u. investigații, constatări și concluzii în evaluarea unui pacient cu icter și teste hepatice de tip colestatic:
a. ecografie;
b. ducte biliare dilatate mediate;
c. imegistică pentru tractul biliar extrahepatic; serologie pentru patologii hepatice sau bilare intrahepatică;
d. colestază extrahepatică intrahepatică;
ce secvență este recomandabilă:
A. a-b-d-c-a;
B. a-c-d-b-a;
C. b-a-c-d-b;
D. b-a-d-c-a;
E. c-d-b-a-a;

2160. F.d.u. investigații, constatări și concluzii în evaluarea unui pacient cu icter și teste hepatice de tip colestatic:
a. ecografie;
b. TC, colangio-pancreatografie retrogradă endoscopică (CPRE);
c. colestază extrahepatică;
d. ducte biliare dilatate;
ce secvență este recomandabilă:
A. a-b-d-c-a;
B. a-c-d-b-a;
C. b-a-c-d-b;
D. b-a-d-c-a;
E. c-d-b-a-a;

2161. F.d.u. investigații, constatări și concluzii în evaluarea unui pacient cu icter:
a. este vorba de o afecțiune hemolitică sau de entropoeză ineficientă?
b. hiperbilirubinemie neconjugată izolată;
c. este vorba de hemoliză sau nu?
d. analizele din sânge indică hemoliză;
ce secvență este recomandabilă:
A. a-d-b-e-c;
B. b-c-d-a-a;
C. c-d-b-a-a;
D. c-d-b-a-a;
E. d-a-b-a-c;

2163. U.f.d. hemoliză s.c.f.g.:
A. în hemoliză de obicei bilirubina serică nu depășește 2 mg/dl;
B. decal dacă este o hemoliză cronică (criza);
C. orpanocitară de exemplu);
D. sau se asociază o boală;
E. renală sau respiratorie;
2164. F.d.u. întrebări, constatări și concluzii în evaluarea unui pacient cu icter:
a. este vorba de o afecțiune hemolitică sau de entropoeză ineficientă?
b. hiperbilirubinemie neconjugată izolată;
c. probernec;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;

2165. R.I. fiziopatologia hiperbilirubinemiei neconjugate izolate, f.d.u. mecanisme:
1. scade prelucarea hepatică a bilirubinei;
2. crește producția de bilirubină neconjugată;
3. scade conjugarea bilirubinei; și următoarele cauze:
a. Crigler-Najjar tip 2;
b. hemoliză;
c. probernec;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;

2166. R.I. fiziopatologia hiperbilirubinemiei neconjugate izolate, f.d.u. mecanisme:
1. scade prelucarea hepatică a bilirubinei;
2. crește producția de bilirubină neconjugată;
3. este suprimată conjugarea bilirubinei; și următoarele cauze:
a. riampolnă;
b. distrugerea hematiilor (în măduvă, în splină sau în vase);
c. Crigler-Najjar tip 1;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;

2167. R.I. fiziopatologia hiperbilirubinemiei neconjugate izolate, f.d.u. mecanisme:
1. scade prelucarea hepatică a bilirubinei;
2. crește producția de bilirubină neconjugată;
3. scade conjugarea bilirubinei; și următoarele cauze:
a. Crigler-Najjar tip 2;
b. hemoliză;
c. probernec;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;

2168. R.I. fiziopatologia hiperbilirubinemiei neconjugate izolate, f.d.u. mecanisme:
1. scade prelucarea hepatică a bilirubinei;
2. crește producția de bilirubină neconjugată;
3. este suprimată conjugarea bilirubinei; și următoarele cauze:
a. riampolnă;
b. distrugerea hematiilor (în măduvă, în splină sau în vase);
c. Crigler-Najjar tip 1;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;

2169. R.I. fiziopatologia hiperbilirubinemiei neconjugate izolate, f.d.u. mecanisme:
1. scade prelucarea hepatică a bilirubinei;
2. crește producția de bilirubină neconjugată;
3. este suprimată conjugarea bilirubinei; și următoarele cauze:
a. riampolnă;
b. distrugerea hematiilor (în măduvă, în splină sau în vase);
c. Crigler-Najjar tip 1;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;

2170. R.I. fiziopatologia hiperbilirubinemiei neconjugate izolate, f.d.u. mecanisme:
1. scade prelucarea hepatică a bilirubinei;
2. crește producția de bilirubină neconjugată;
3. este suprimată conjugarea bilirubinei; și următoarele cauze:
a. riampolnă;
b. distrugerea hematiilor (în măduvă, în splină sau în vase);
c. Crigler-Najjar tip 1;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;

ce secvență este recomandabilă:
A. a-e-d-c-b;
B. b-d-c-a-e;
C. c-d-b-a-e;
D. d-b-a-e-c;
E. e-b-a-d-c;

2151. R.I. etiologia hiperbilirubinemiei izolate neconjugate, f.d.u. categorii:
1. medicamente;
2. tulburări ereditare;
3. afecțiuni hematologice;
și următoarele cauze:
a. hemoliză, hematopoeză ineficientă;
b. sindrom Gilbert, sindrom Crigler-Najjar;
c. probernec, riampolnă;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;

2154. F.d.u. investigații, constatări și concluzii în evaluarea unui pacient cu icter:
a. creșterea bilirubinei asociată cu modificarea altor teste hepatice;
b. icter constat clinic sau paraclic;
c. examen clinic și investigații paraclinice;
d. tipul hepatocelular/colestatic;
e. predominanță transaminaze/enzimele de colestază;
ce secvență este recomandabilă:
A. a-e-d-c-b;

2155. R.I. evaluarea pacientului cu hepatită autoimună (HA), f.d.u. categorii de modificări:
1. caracteristici pentru HA tip 1;
2. caracteristici pentru HA tip 2;
3. prezență în fața de frecvență în HA, ca și în hepatita virală cronică;
4. frecvență în HA, fără a fi specifică pentru un tip anume, și următoarele modificări:
A. a-e-d-c-b;

2156. R.I. fiziopatologia hiperbilirubinemiei neconjugate izolate, f.d.u. mecanisme:
1. scade prelucarea hepatică a bilirubinei;
2. crește producția de bilirubină neconjugată;
3. este suprimată conjugarea bilirubinei; și următoarele cauze:
a. riampolnă;
b. distrugerea hematiilor (în măduvă, în splină sau în vase);
c. Crigler-Najjar tip 1;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;

2157. R.I. fiziopatologia hiperbilirubinemiei neconjugate izolate, f.d.u. mecanisme:
1. scade prelucarea hepatică a bilirubinei;
2. crește producția de bilirubină neconjugată;
3. este suprimată conjugarea bilirubinei; și următoarele cauze:
a. riampolnă;
b. distrugerea hematiilor (în măduvă, în splină sau în vase);
c. Crigler-Najjar tip 1;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;

Prescurtări frecvent folosite: S.G. = cu excepția, S.U.G. = sunt următoarele, cu excepția, U.A.S.C.G. = următoarele afirmatii sunt corecte, cu excepția, S.C.G. = sunt corect formulate, cu excepția.

D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-1, c-2;

21169. R.I. cauzele icterului hemolitic, f.d.u. categorii:
1. eritropoeză deficicientă;
2. afecțiuni hemolitice moștenite;
3. afecțiuni hemolitice dobândite; și următoarele stări patologice:
a. deficit de cobalamină;
b. deficiențe enzimatice eritrocitare (de glucoză-6-fosfat-dehidrogenază sau de piruvat-kinază);
c. anemii hemolitice microangiopatice (de exemplu, SHU);
d. anemii hemolitice care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-1, c-2;

21170. R.I. cauzele icterului hemolitic, f.d.u. categorii:
1. eritropoeză deficicientă;
2. afecțiuni hemolitice moștenite;
3. afecțiuni hemolitice dobândite; și următoarele stări patologice:
a. deficit de folat;
b. anemie acantocitară;
c. drepanocitoză;
d. anemii hemolitice care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-3, c-2;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;

21171. R.I. cauzele icterului hemolitic, f.d.u. categorii:
1. eritropoeză deficicientă;
2. afecțiuni hemolitice moștenite;
3. afecțiuni hemolitice dobândite; și următoarele stări patologice:
a. talasemie;
b. talasurie;
c. hiperbilirubinurie paroxistică nocturnă;
d. anemii hemolitice care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;

21172. R.I. cauzele icterului hemolitic, f.d.u. categorii:
1. eritropoeză deficicientă;
2. afecțiuni hemolitice moștenite;
3. afecțiuni hemolitice dobândite; și următoarele stări patologice:
a. hemoliză înună;

b. deficit în preluarea/conjugarea hepatică a bilirubinei;
c. analiza din sânge infirmă hemoliză;
d. hiperbilirubinemie neconjugată izolată;
e. efect medicamentos sau boli genetice;
f. secvență este recomandabilă:
A. a→d→b→c→e;
B. b→a→c→e→d;
C. c→b→e→a→d;
D. d→a→c→b→e;
E. e→d→a→b→c;

21173. R.I. cauzele afecțiunilor hemolitice, f.d.u. categorii:
1. moștenite;
2. dobândite; și următoarele stări patologice:
a. eliptocitoză;
b. drepanocitoză;
c. anemii hemolitice microangiopatice (de exemplu, SHU);
d. anemie acantocitară;
e. deficit de glucoză-6-fosfat-dehidrogenază;
f. anemii hemolitice care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-1, c-1, d-2, e-2;
B. a-1, b-1, c-2, d-1, e-2;
C. a-1, b-1, c-2, d-2, e-1;
D. a-2, b-1, c-1, d-1, e-2;
E. a-2, b-1, c-2, d-1, e-1;

21174. R.I. cauzele de hemoliză, f.d.u. categorii:
1. moștenite;
2. dobândite; și următoarele stări patologice:
a. stercocitoză;
b. hemoliză imună;
c. talasemie;
d. deficit de piruvat-kinază;
e. hemoglobinuria paroxistică nocturnă;
f. anemii hemolitice care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-1, c-1, d-2, e-2;
B. a-1, b-1, c-2, d-2, e-1;
C. a-1, b-2, c-1, d-1, e-2;
D. a-1, b-2, c-2, d-1, e-1;
E. a-2, b-1, c-2, d-1, e-1;

21175. F.d.u. evenimentele care pot să apară la un pacient cu icter:
a. calculi de bilrubinat de calciu;
b. hiperbilirubinemie conjugată;
c. coledocolitiază;
d. hemoliză cronică;
e. anemii hemolitice care este lanțul cauzal corect:
A. a→c→d→b;
B. b→c→a→d;
C. b→d→a→c;
D. c→a→b→d;
E. d→a→c→b;

21176. F.d.u. întrebări, constatări și concluzii în evaluarea unui pacient cu icter:
a. este vorba de hemoliză sau nu?;

2179. R.1. mutațiile genetice care scad conjugarea bilirubinei prin, f.d.u. sindroame:

1. Crigler-Najjar tip 1;
2. Crigler-Najjar tip 2;
3. sindrom Gilbert;

a. hiperbilirubinemia necongjugată ușoară;

b. neputând conjuga deloc bilirubina, hepatocitele nu o pot excreta;

c. mutații în gena pentru bilirubină-UDPGT care scad activitatea enzimică;

d. icter mai frecvent vizibil la persoanele cu fond psihoemoțional mai sensibil (predispus la stres);

e. care sunt asociate corecte:

- A. a-1, b-3, c-2, d-3;
- B. a-2, b-1, c-3, d-3;
- C. a-2, b-3, c-3, d-1;
- D. a-3, b-1, c-2, d-3;
- E. a-3, b-2, c-1, d-1;

2180. R.1. mutațiile genetice care scad conjugarea bilirubinei prin, f.d.u. sindroame:

1. Crigler-Najjar tip 1;
2. Crigler-Najjar tip 2;
3. sindrom Gilbert;

a. afecțiune foarte rară, care afectează nou-născuții;

b. pacienții supraviețuiesc până la vârsta adultă;

c. mutații în regiunile care controlează transcripția genei pentru bilirubină-UDPGT care scad activitatea bilirubină-UDPGT;

d. de regulă, hiperbilirubinemia nu depășește 6 mg/dl;

e. care sunt asociate corecte:

- A. a-1, b-2, c-3, d-3;
- B. a-1, b-3, c-2, d-3;
- C. a-2, b-1, c-3, d-3;
- D. a-3, b-1, c-2, d-3;
- E. a-3, b-2, c-3, d-1;

2181. R.1. mutațiile genetice care scad conjugarea bilirubinei prin, f.d.u. sindroame:

1. Crigler-Najjar tip 1;
2. Crigler-Najjar tip 2;
3. sindrom Gilbert;

a. hiperbilirubinemia necongjugată ușoară;

b. din cauza lipoteiei, bilirubina necongjugată se depune în nucleii bazali (și în hipocamp);

c. este foarte frecvent;

d. hiperbilirubinemia crește când pacientul nu mănâncă;

e. care sunt asociate corecte:

- A. a-2, b-1, c-3, d-3;
- B. a-2, b-3, c-3, d-1;
- C. a-3, b-2, c-1, d-3;
- D. a-3, b-2, c-3, d-1;
- E. a-3, b-3, c-2, d-1;

2182. R.1. mutațiile genetice care scad conjugarea bilirubinei prin, f.d.u. sindroame:

1. Crigler-Najjar tip 1;
2. Crigler-Najjar tip 2;
3. sindrom Gilbert;

a. poate să apară icter nuclear în urma unui stres (boală intercurrentă, intervenție chirurgicală);

b. în condiții bazale, hiperbilirubinemia poate să fie insesizabilă;

c. are predominanță masculină (raport M:F = 2-7:1);

d. icter sever (bilirubină >20 mg/dl);

e. care sunt asociate corecte:

- A. a-2, b-1, c-3, d-3;
- B. a-2, b-3, c-3, d-1;
- C. a-3, b-2, c-1, d-3;
- D. a-3, b-2, c-3, d-1;
- E. a-3, b-3, c-2, d-1;

2183. R.1. mutațiile genetice care scad conjugarea bilirubinei prin, f.d.u. sindroame:

1. Crigler-Najjar tip 1;
2. Crigler-Najjar tip 2;
3. sindrom Gilbert;

a. afectează 3-7% din populație;

b. administrarea de fenobarbital crește activitatea enzimică, ceea ce scade bilirubinemia;

c. distincția etiologică secundară icterului nuclear determină adesea moartea în copilărie;

d. hiperbilirubinemia crește când pacientul trece printr-o perioadă stresantă;

e. care sunt asociate corecte:

- A. a-1, b-2, c-3, d-3;
- B. a-1, b-3, c-2, d-3;
- C. a-1, b-3, c-3, d-2;
- D. a-3, b-1, c-3, d-2;
- E. a-3, b-2, c-1, d-3;

2184. R.1. hiperbilirubinemia conjugată izolată, u.a.s.c.g.e.;

A. este provocată de două afecțiuni moștenite rare, care pot fi diferențiate (fără ca aceasta să fie necesar);

B. este provocată de două afecțiuni moștenite rare, care pot fi diferențiate (fără ca aceasta să fie necesar);

C. este provocată de două afecțiuni moștenite rare, care pot fi diferențiate (fără ca aceasta să fie necesar);

D. este provocată de două afecțiuni moștenite rare, care pot fi diferențiate (fără ca aceasta să fie necesar);

E. este provocată de două afecțiuni moștenite rare, care pot fi diferențiate (fără ca aceasta să fie necesar);

2179. R.1. mutațiile genetice care scad conjugarea bilirubinei prin, f.d.u. sindroame:

1. Crigler-Najjar tip 1;
2. Crigler-Najjar tip 2;
3. sindrom Gilbert;

a. hiperbilirubinemia necongjugată ușoară;

b. neputând conjuga deloc bilirubina, hepatocitele nu o pot excreta;

c. mutații în gena pentru bilirubină-UDPGT care scad activitatea enzimică;

d. icter mai frecvent vizibil la persoanele cu fond psihoemoțional mai sensibil (predispus la stres);

e. care sunt asociate corecte:

- A. a-1, b-3, c-2, d-3;
- B. a-2, b-1, c-3, d-3;
- C. a-2, b-3, c-3, d-1;
- D. a-3, b-1, c-2, d-3;
- E. a-3, b-2, c-1, d-1;

2180. R.1. mutațiile genetice care scad conjugarea bilirubinei prin, f.d.u. sindroame:

1. Crigler-Najjar tip 1;
2. Crigler-Najjar tip 2;
3. sindrom Gilbert;

a. afecțiune foarte rară, care afectează nou-născuții;

b. pacienții supraviețuiesc până la vârsta adultă;

c. mutații în regiunile care controlează transcripția genei pentru bilirubină-UDPGT care scad activitatea bilirubină-UDPGT;

d. de regulă, hiperbilirubinemia nu depășește 6 mg/dl;

e. care sunt asociate corecte:

- A. a-1, b-2, c-3, d-3;
- B. a-1, b-3, c-2, d-3;
- C. a-2, b-1, c-3, d-3;
- D. a-3, b-1, c-2, d-3;
- E. a-3, b-2, c-3, d-1;

2181. R.1. mutațiile genetice care scad conjugarea bilirubinei prin, f.d.u. sindroame:

1. Crigler-Najjar tip 1;
2. Crigler-Najjar tip 2;
3. sindrom Gilbert;

a. hiperbilirubinemia necongjugată ușoară;

b. din cauza lipoteiei, bilirubina necongjugată se depune în nucleii bazali (și în hipocamp);

c. este foarte frecvent;

d. hiperbilirubinemia crește când pacientul nu mănâncă;

e. care sunt asociate corecte:

- A. a-2, b-1, c-3, d-3;
- B. a-2, b-3, c-3, d-1;
- C. a-3, b-2, c-1, d-3;
- D. a-3, b-2, c-3, d-1;
- E. a-3, b-3, c-2, d-1;

2182. R.1. mutațiile genetice care scad conjugarea bilirubinei prin, f.d.u. sindroame:

1. Crigler-Najjar tip 1;
2. Crigler-Najjar tip 2;
3. sindrom Gilbert;

a. poate să apară icter nuclear în urma unui stres (boală intercurrentă, intervenție chirurgicală);

b. în condiții bazale, hiperbilirubinemia poate să fie insesizabilă;

c. are predominanță masculină (raport M:F = 2-7:1);

d. icter sever (bilirubină >20 mg/dl);

e. care sunt asociate corecte:

- A. a-2, b-1, c-3, d-3;
- B. a-2, b-3, c-3, d-1;
- C. a-3, b-2, c-1, d-3;
- D. a-3, b-2, c-3, d-1;
- E. a-3, b-3, c-2, d-1;

2183. R.1. mutațiile genetice care scad conjugarea bilirubinei prin, f.d.u. sindroame:

1. Crigler-Najjar tip 1;
2. Crigler-Najjar tip 2;
3. sindrom Gilbert;

a. afectează 3-7% din populație;

b. administrarea de fenobarbital crește activitatea enzimică, ceea ce scade bilirubinemia;

c. distincția etiologică secundară icterului nuclear determină adesea moartea în copilărie;

d. hiperbilirubinemia crește când pacientul trece printr-o perioadă stresantă;

e. care sunt asociate corecte:

- A. a-1, b-2, c-3, d-3;
- B. a-1, b-3, c-2, d-3;
- C. a-1, b-3, c-3, d-2;
- D. a-3, b-1, c-3, d-2;
- E. a-3, b-2, c-1, d-3;

2184. R.1. hiperbilirubinemia conjugată izolată, u.a.s.c.g.e.;

A. este provocată de două afecțiuni moștenite rare, care pot fi diferențiate (fără ca aceasta să fie necesar);

B. este provocată de două afecțiuni moștenite rare, care pot fi diferențiate (fără ca aceasta să fie necesar);

C. este provocată de două afecțiuni moștenite rare, care pot fi diferențiate (fără ca aceasta să fie necesar);

D. este provocată de două afecțiuni moștenite rare, care pot fi diferențiate (fără ca aceasta să fie necesar);

E. este provocată de două afecțiuni moștenite rare, care pot fi diferențiate (fără ca aceasta să fie necesar);

- B. a-3, b-1, c-2, d-3;
C. a-3, b-1, c-2, d-2;
D. a-3, b-2, c-1, d-3;
E. a-3, b-3, c-1, d-2;
2188. R.I. rolul istoricului în evaluarea afecțiunilor icterigene, f.d.u. categorii:

1. expunere la substanțe chimice sau cu rol terapeutic;
2. expuneri parenterale;
3. simptome însoțitoare;

și următoarele elemente:

- a. scădere în greutate;
b. activitate sexuală;
c. modificări ale urinei și ale scaunului;

d. steroizi anabolizanți;

care sunt asocierile corecte:

- A. a-1, b-2, c-3, d-3;
B. a-1, b-3, c-3, d-2;
C. a-2, b-3, c-1, d-3;
D. a-3, b-2, c-1, d-3;
E. a-3, b-2, c-3, d-1;

2189. R.I. rolul istoricului în evaluarea afecțiunilor icterigene, f.d.u. categorii:

1. diverse expuneri anterioare;
2. rapitalitate instalării, ritmul de progresie, durată;
3. simptome însoțitoare;

și următoarele elemente:

- a. sunt nespecifice, dar pot sugera un anumit diagnostic;
b. pot diferenția cauzele acute de cronice, benigne de maligne;
c. pot sugera cauze virale sau hepatice;

care sunt asocierile corecte:

- A. a-1, b-3, c-2;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;

2190. R.I. rolul istoricului în stabilirea etiologiei unui icter, f.d.u. cauze:

1. virusuri;
2. hepatitice;
3. următoarele elemente;

a. expunere la persoane purtătoare;

b. expunere la alimente posibile contaminare;

c. expuneri parenterale;

d. consum de alcool;

care sunt asocierile corecte:

- A. a-1, b-2, c-1, d-2;
B. a-1, b-2, c-2, d-1;
C. a-2, b-1, c-1, d-2;
D. a-2, b-1, c-2, d-1;
E. a-2, b-2, c-1, d-1;

2191. R.I. rolul istoricului în stabilirea etiologiei unui icter, f.d.u. cauze:

1. virusuri;
2. hepatitice;

3. hepatotoxine, virusuri;

și următoarele elemente:

- a. expunere profesională;
b. expunere la persoane cu icter;
c. călătorii recente;

d. expunere la substanțe chimice sau cu rol terapeutic;

care sunt asocierile corecte:

- A. a-2, b-1, c-3, d-2;
B. a-2, b-2, c-3, d-1;
C. a-2, b-3, c-1, d-2;
D. a-2, b-3, c-2, d-1;
E. a-3, b-1, c-2, d-2;

2192. R.I. rolul istoricului în evaluarea afecțiunilor icterigene, f.d.u. simptome însoțitoare:

1. artralgii și mialgii precedând icterul;

2. durere severă instalată brusc în hipocostul drept și frisoane;

3. scădere în greutate, absența durerii;

și următoarele stări patologice:

- a. afecțiune neoplazică;
b. colecolitiază și colangită ascendentă;

c. hepatită, fie virală, fie medicamentasă;

care sunt asocierile corecte:

- A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;

2193. R.I. semnele de hepatopatie cronică care pot fi decelate prin examenul fizic general la un pacient cu icter, f.d.u. categorii:

1. consecințe ale hiperpraziei vasculare secundare excesului de estrogeni;

2. consecințe ale excesului de estrogeni;

3. consecințe ale proliferării fibroblastilor și diferențierii lor în miofibroblaste, în asociere cu depunere de collagen 3;

și următoarele semne:

- a. contracturi Dupuytren;
b. ginecomastie;
c. herniajorale stiale;

2184. R.I. semnele de hepatopatie cronică care pot fi decelate prin examenul fizic general la un pacient cu icter, f.d.u. categorii:

1. consecințe ale hiperpraziei vasculare secundare excesului de estrogeni;

2. consecințe ale excesului de estrogeni;

3. semne de hipertensiune portală;

și următoarele semne:

- a. atrofia testiculară;
b. eritem palmar;
c. splenomegalie;

care sunt asocierile corecte:

- A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;

2195. R.I. semnele de hepatopatie cronică care pot fi decelate prin examenul fizic general la un pacient cu icter, f.d.u. categorii:

1. consecințe ale hiperpraziei vasculare secundare excesului de estrogeni;

2. manifestări ale consumului excesiv de alcool;

3. semne de hipertensiune portală;

și următoarele semne:

- a. circulație colaterală portocavă;
b. buze carminate;

c. hipertrofie parotidiană;

care sunt asocierile corecte:

- A. a-1, b-3, c-2;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;

2196. R.I. rolul examenului fizic general în evaluarea afecțiunilor icterigene, f.d.u. semne:

1. semne de hepatopatie cronică;

2. nodul peritoneal (nodulului soarelui Mary Joseph);

3. emaciarea mușchilor temporali și proximali;

și următoarele stări patologice:

- a. boală de lungă durată, cum ar fi cancerul pancreatic;
b. ciroza alcoolică avansată (Leenec);
c. cancer abdominal;

2197. R.I. rolul examenului fizic general în evaluarea afecțiunilor icterigene, f.d.u. semne:

1. semne de hepatopatie cronică;

2. distensia venelor jugulare;

3. emaciarea mușchilor temporali și proximali;

și următoarele stări patologice:

- a. boala de lungă durată, cum ar fi ciroza;

b. diverse tipuri de ciroza;

c. congestie hepatică secundară insuficienței cardiace drepte;

care sunt asocierile corecte:

- A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-3, c-1;
C. a-2, b-3, c-2;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;

2198. R.I. rolul examenului fizic general în evaluarea afecțiunilor icterigene, f.d.u. semne:

1. adenopatie supradiafilară (Vichow);

2. revarsat lichidian pleural drept, în absența ascitei evidente clinic;

3. distensia venelor jugulare;

și următoarele stări patologice:

- a. ciroza avansată, IC congestivă;
b. congestie hepatică secundară pericarditei constrictive;

c. cancer abdominal;

care sunt asocierile corecte:

- A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;

2199. R.I. evaluarea pacientului cu icter, aspecte nu poate fi stabilite prin examenul fizic al abdomenului:

- A. dimensiunea și consistența ficatului;

B. dacă există splenomegalie (splină palpabilă);

C. dacă există semne de IC;

2200. R.I. rolul examenului fizic al abdomenului în evaluarea afecțiunilor icterigene, f.d.u. semne:

1. ascită;

2. durere marcată la palpare în cadranul superior drept, care împiedică respirația (semnul Murphy);

3. hepatomegalie dureroasă la palpare;

4. lob stâng hepatic mărit (la palparea epigastrului);

și următoarele stări patologice:

- a. ciroză;
b. hepatită virală;
c. colangită ascendentă;

d. cancer cu metastaze peritoneale;

care sunt asocierile corecte:

- A. a-1, b-4, c-2, d-3;
B. a-3, b-4, c-1, d-2;
C. a-3, b-4, c-2, d-1;
D. a-4, b-1, c-2, d-3;
E. a-4, b-3, c-2, d-1;

2201. R.I. rolul examenului fizic al abdomenului în evaluarea afecțiunilor icterigene, f.d.u. semne:

1. ascită;

2. hepatomegalie dureroasă la palpare;

3. o formațiune tumorală abdominală palpabilă;

și următoarele stări patologice:

- a. ciroză;
b. ficat congestional acut, secundar tamponadei cardiace;

c. proces inflamator (precum amiloidoză);

d. cancer;

care sunt asocierile corecte:

- A. a-1, b-2, c-2, d-3;
B. a-1, b-2, c-3, d-2;
C. a-2, b-3, c-1, d-2;
D. a-3, b-1, c-2, d-2;
E. a-3, b-2, c-1, d-2;

2202. R.I. rolul examenului fizic al abdomenului în evaluarea afecțiunilor icterigene, f.d.u. semne:

1. durere marcată la palparea hipocostului drept, care împiedică respirația (semnul Murphy);

2. hepatomegalie dureroasă la palpare;

B. unui proces hepatocelular (cresc mai ales aminotransferazele);

C. de unui coliclastic (cresc mai ales FALP și GGT);

D. esențială pentru orientarea demersului diagnostic ulterior;

E. intrucă cele două se aseamănă prin cauze și metode de evaluare;

2204. R.I. rolul analizelor biochimice în evaluarea afecțiunilor icterigene, f.d.u. modificări:

1. albuminemia și timpul de protrombină;

2. bilirubina;

3. determinările enzimice;

și următoarele caracteristici:

- a. utilitate mai mică în diferențierea proceselor hepatocelulare de cele colestastice, intrucă poate exista o creștere marcată în ambele;

b. utilitate în evaluarea funcției hepatice;

c. utilitate în diferențierea unui proces hepatocelular de unul colestastic;

care sunt asocierile corecte:

- A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;

2205. R.I. rolul analizelor biochimice în evaluarea afecțiunilor icterigene, f.d.u. modificări:

1. creșterea timpului de protrombină;

2. creșterea disproporțională a aminotransferazelor față de FALP;

3. albumină normală;

și următoarele stări patologice:

- a. patologie instalată relativ recent, cum ar fi hepatită virală sau colecolitiază;

b. boală hepatocelulară;

c. insuficiență cardiacă dreaptă semnificativă;

care sunt asocierile corecte:

2206. R.I. rolul analizelor biochimice în evaluarea afecțiunilor icterigene, f.d.u. modificări:

1. creșterea disproporțională a FALP față de aminotransferaze;

2. albumină scăzută;

3. creșterea timpului de protrombină; și următoarele stări patologice: a. deficit de vitamină K din cauza icterului prelungit; b. disfuncție hepatocelulară de durată lungă; c. boli colestatice; care sunt asociate corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;	care este înălțimea deductivă justă: A. a-e-b-c-d; B. b-c-d-a-e; C. c-d-e-b-a; D. d-b-c-a-e; E. e-d-c-b-a;	D. hepatita autoimună apare și la bărbați; E. multe medicamente pot provoca o reacție toxică idiosincrasică (de exemplu, acetaminofen); 2213. R.I. afecțiunile hepatocelulare (icterigene), u.a.s.c.g.e.; A. hepatita toxică poate fi provocată de alcool, medicamente sau toxine ambientale; B. boala Wilson trebuie avută în vedere doar la tineri; C. hepatita autoimună apare de obicei la femei tinere sau de vârstă medie, dar și la alte vârste; D. amatoxinele conținute de ciupercile din genul Amanita sunt puternic hepatotoxice; E. aminotransferaze crescute <8 ori normalul pot avea ca substrat procese atât hepatocelulare, cât și colestatice; 2214. R.I. afecțiunile hepatocelulare icterigene provocate de toxine exogene ambientale, f.d.u. substanțe toxice: 1. alcalizii prolinizidici; 2. kavalactone; 3. amatoxine; și următoarele plante: a. Kava Kava (Piper methysticum); b. lătină, podbal; c. Amanita phalloides, A. verna; care sunt asociate corecte: A. a-1, b-3, c-2; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-1, c-3; D. a-2, b-3, c-1; E. a-3, b-1, c-2; 2211. R.I. evaluarea unui pacient cu icter suspectat de leziune hepatocelulară, f.d.u. stări patologice: 1. boala Wilson; 2. hepatită alcoolică; 3. leziune hepatocelulară acută; și următoarele investigații: a. raport AST:ALT ≥2.1, AST de obicei <300 U/L; b. aminotransferaze crescute ≥25 ori normalul; c. ceruloplasmina, care sunt asociate corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;	2210. R.I. evaluarea afecțiunilor hepatocelulare icterigene, f.d.u. cauzele afecțiunilor icterigene, f.d.u. categorii: 1. virusuri; 2. toxine exogene; 3. toxine exogene ambientale; și următoarele cauze: Amanita; b. alcool; c. VHA; care sunt asociate corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 2217. R.I. cauzele afecțiunilor hepatocelulare icterigene, f.d.u. categorii: 1. virusuri; 2. toxine exogene; 3. toxine exogene ambientale; și următoarele cauze: a. VHD; b. VHB; c. medicamente; d. plante (folosite alimentar sau terapeutic); e. VEB; care sunt asociate corecte: A. a-1, b-3, c-2; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;	2219. R.I. cauzele afecțiunilor hepatocelulare icterigene, f.d.u. categorii: 1. virusuri; 2. toxine exogene; 3. toxine exogene ambientale; și următoarele cauze: Amanita; b. alcool; c. VHA; care sunt asociate corecte: A. a-1, b-2, c-3; B. a-1, b-3, c-2; C. a-2, b-1, c-3; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1; 2220. R.I. evaluarea afecțiunilor hepatocelulare icterigene, f.d.u. a.s.c.g.e.; A. tipul hepatocelular de creștere enzimatică constă în creșterea disproporționată a aminotransferazelor față de ALT; B. determinarea Ac anti-VHC este lipsită de fidelitate dacă se suspectează hepatită C acută; C. testul de depistare inițial pentru boala Wilson este transferinemia; D. în hepatită alcoolică, raportul AST:ALT este de obicei mai mic de 2:1; E. în leziunile hepatice toxice suficiente de severe pentru a produce icter, de obicei aminotransferazele >500 U/L, iar ALT ≥AST; F. valori ale aminotransferazelor <8 ori normalul pot să apară în procese atât hepatocelulare, cât și colestatice; 2221. R.I. evaluarea afecțiunilor hepatocelulare icterigene, f.d.u. a.s.c.g.e.; A. creșterea disproporționată a aminotransferazelor față de ALT indică leziune colestatică; B. dacă se suspectează hepatită acută, trebuie determinate în primul rând Ac IgM anti-VHA, AgHBs, Ac IgM anti-HBc și Ac anti-VHC; C. Ac antinucleari, anti-microzomal și anti-actin sunt utili pentru diagnosticarea bolii Wilson; D. în hepatita virală acută suficient de severă pentru a produce icter, de obicei aminotransferazele depășesc 500 U/L, iar ALT ≥AST;	E. magnitudinea creșterii aminotransferazelor poate ajuta uneori la diferențierea proceselor hepatocelulare de cele colestatice; F. în ciroză, aminotransferazele sunt de regulă mult crescute; 2222. R.I. evaluarea afecțiunilor hepatocelulare icterigene, u.a.s.c.g.e.; A. creșterea disproporționată a aminotransferazelor față de ALT indică boli hepatocelulare care pot provoca icter; B. dacă se suspectează hepatită acută, în funcție de circumstanțe, pot fi indicate investigații pentru VHD, VHE, VEB și VCM; C. hepatita alcoolică poate fi diferențiată de hepatita virală și de hepatita toxică prin tipul aminotransferazelor; D. în hepatită alcoolică, AST depășește de obicei 300 U/L; E. valori ale aminotransferazelor ≥25 ori normalul apar mai ales în leziunile colestatice acute; 2223. R.I. evaluarea afecțiunilor colestatice, u.a.s.c.g.e.; A. tipul colestatic de creștere enzimatică este invers față de cel hepatic; B. după ecografie, se recurge, după caz, la TC, CPRM sau CPRE; C. rata de succes în canalarea coledocului pentru CPRE este de 80-95%, în funcție de experiența operatorului; D. la pacienții la care nu se reușește CPRE, este foarte probabil necesară o intervenție terapeutică; E. colangio-pancreatografia prin RMN (CPRM) este o tehnică invazivă pentru vizualizarea ductului biliar și a ductului pancreatic; 2224. R.I. evaluarea afecțiunilor colestatice, u.a.s.c.g.e.; A. creșterea enzimatică de tip colestatic constă în creșterea disproporționată a fosfatazei alcaline față de aminotransferaze; B. TC și CPMR sunt mai bune decât ecografia în evaluarea capului pancreasului; C. CPRE permite intervenții terapeutice; D. colangiografia transhepatică poate furniza aceleași informații ca și CPRE;
---	---	--	---	--	---

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date; f.d.u. = fiind date următoarele; f. = referențiale; u.a.s.c.g.e. = următoarele fragmente dintr-o frază despres;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date; f.d.u. = fiind date următoarele; f. = referențiale; u.a.s.c.g.e. = următoarele fragmente dintr-o frază despres;

E. în cazurile de colestație intrahepatică, diagnosticul se pune pe baza investigațiilor imagistice;	2228. R.I. rolul ecografiei în evaluarea afecțiunilor colestastice, u.a.s.c.g.e.;	1. colestație intrahepatică; benigă;	2. colestație extrahepatică benigă;
2229. R.I. evaluarea afecțiunilor colestastice, u.a.s.c.g.e.;	A. Eco este necostisitoare;	și următoarele stări patologice:	și următoarele stări patologice:
A. o creștere enzimatică de tip colestație diferențială colestaza intrahepatică de cea extrahepatică;	B. Eco poate detecta dilatarea căilor biliare intra- și extrahepatică cu o mare sensibilitate și specificitate;	b. strictur bilare postoperatorii;	b. strictur bilare postoperatorii;
B. TC și CPRM sunt mai bune decât ecografia pentru identificarea calculilor din colecoul distal, în special când căile biliare sunt dilatate;	C. lipsa dilatației căilor biliare sugerează colestație extrahepatică;	c. calcul infundibular sau cistic care comprimă calea biliară principală;	c. calcul infundibular sau cistic care comprimă calea biliară principală;
C. CPRM permite îndepărtarea calculilor din coledoc;	D. rezultate fals-negative apar la pacienți cu ciroză sau colelită sclerozantă primară (CSP), în care ducile intrahepatice sunt deja dilatate;	d. hepatită alcoolică;	d. hepatită alcoolică;
D. colangografia transhepatică permite intervenția terapeutică;	E. Eco poate detecta colestația extrahepatică, dar razele identifice sediul sau cauza obstrucției biliare;	e. calcul infundibular sau cistic care comprimă calea biliară principală;	e. calcul infundibular sau cistic care comprimă calea biliară principală;
E. CPRM a înlocuit CPRM ca metodă diagnostică inițială în cazurile în care necesitatea unei intervenții pare să fie mică;	2229. F.d.u. etape în efectuarea CPRM:	1. colestație intrahepatică;	1. colestație intrahepatică;
2226. R.I. evaluarea afecțiunilor colestastice, u.a.s.c.g.e.;	A. se vizualizează ampula lui Vater;	2. colestație extrahepatică malignă;	2. colestație extrahepatică malignă;
A. diferențierea colestației intrahepatice de cea extrahepatică poate fi dificilă, dar de regulă se poate face pe baza examenului clinic și a testelor biochimice;	B. se introduce un endoscop cu vedere laterală pe gură în duoden;	3. colestație extrahepatică benigă;	3. colestație extrahepatică benigă;
B. ecografia este investigația elalon pentru identificarea coledocolitazel;	C. distribuția substanței de contrast permite vizualizarea căilor biliare și a ductului pancreatic;	și următoarele stări patologice:	și următoarele stări patologice:
C. CPRM permite montarea unor stenturi;	D. se introduce un cateter prin ampulă;	a. colangiopatia SIDA;	a. colangiopatia SIDA;
D. la ora actuală, CPRM este disponibilă pe scară largă;	E. e se injectează substanță de contrast;	b. ciroză biliară primară;	b. ciroză biliară primară;
E. unele afecțiuni care produc de obicei un tip lezional hepato-colestație pot produce și un tip colestastic;	2230. R.I. afecțiunile colestastice producătoare de icter, f.d.u. categorii:	c. nutriție parenterală totală;	c. nutriție parenterală totală;
2227. R.I. rolul ecografiei în evaluarea afecțiunilor colestastice, u.a.s.c.g.e.;	1. colestație intrahepatică;	d. stenoza septică nehepatobiliară;	d. stenoza septică nehepatobiliară;
A. Eco este prima investigație care trebuie efectuată când se urmărește diferențierea colestației intrahepatice de cea extrahepatică;	2. colestație extrahepatică benignă;	e. colangiocarcinom;	e. colangiocarcinom;
B. Eco nu expune pacientul la iradiere;	3. colestație extrahepatică malignă;	care sunt asocierile corecte:	care sunt asocierile corecte:
C. prezenta dilatației căilor biliare este sugestivă pentru colestația extrahepatică;	și următoarele stări patologice:	A. a-1, b-1, c-1, d-1, e-2;	A. a-1, b-1, c-3, d-1, e-2;
D. rezultate fals-negative apar la pacienți cu obstrucție parțială a coledocului;	a. hepatită virală;	B. a-1, b-2, c-1, d-3, e-1;	B. a-1, b-2, c-3, d-1, e-3;
E. coledocul distal este ușor de vizualizat ecografic;	b. coledocolitază;	C. a-1, b-2, c-1, d-1, e-1;	C. a-1, b-2, c-1, d-1, e-3;
	c. pancreatita cronică;	D. a-2, b-3, c-1, d-1, e-1;	D. a-2, b-3, c-1, d-1, e-1;
	d. colestația recidivantă benignă;	E. a-3, b-2, c-1, d-1, e-1;	E. a-3, b-2, c-1, d-1, e-1;
	e. infecții (malaria, leptospiroză); care sunt asocierile corecte:	2231. R.I. afecțiunile colestastice producătoare de icter, f.d.u. categorii:	2231. R.I. afecțiunile colestastice producătoare de icter, f.d.u. categorii:
	A. a-1, b-2, c-1, d-2, e-1;	1. colestație intrahepatică;	1. colestație intrahepatică;
	B. a-1, b-2, c-2, d-1, e-1;	2. colestație extrahepatică benignă;	2. colestație extrahepatică benignă;
	C. a-2, b-1, c-1, d-2, e-1;	3. următoarele stări patologice:	3. următoarele stări patologice:
	D. a-2, b-1, c-2, d-1, e-1;	a. cancer pancreatic;	a. cancer pancreatic;
	E. a-3, b-2, c-1, d-1, e-1;	b. sindromul Mirizzi;	b. sindromul Mirizzi;
	2232. R.I. afecțiunile colestastice producătoare de icter, f.d.u. categorii:	c. colangită sclerozantă primară;	c. colangită sclerozantă primară;
	1. colestație intrahepatică;	d. colestația postoperatorie benignă;	d. colestația postoperatorie benignă;
	2. colestație extrahepatică malignă;	e. toxicitate medicamentasă;	e. toxicitate medicamentasă;
	3. colestație extrahepatică benignă;	care sunt asocierile corecte:	care sunt asocierile corecte:
	și următoarele stări patologice:	A. a-1, b-1, c-3, d-1, e-2;	A. a-1, b-1, c-3, d-1, e-2;
	a. colangiopatia SIDA;	B. a-1, b-2, c-3, d-1, e-3;	B. a-1, b-2, c-3, d-1, e-3;
	b. ciroză biliară primară;	C. a-1, b-2, c-1, d-1, e-1;	C. a-1, b-2, c-1, d-1, e-3;
	c. nutriție parenterală totală;	D. a-2, b-3, c-1, d-1, e-1;	D. a-2, b-3, c-1, d-1, e-1;
	d. stenoza septică nehepatobiliară;	E. a-3, b-2, c-1, d-1, e-1;	E. a-3, b-2, c-1, d-1, e-1;
	e. colangiocarcinom;	2233. R.I. afecțiunile colestastice producătoare de icter, f.d.u. categorii:	2233. R.I. afecțiunile colestastice producătoare de icter, f.d.u. categorii:
	care sunt asocierile corecte:	1. colestație intrahepatică;	1. colestație intrahepatică;
	A. a-1, b-1, c-1, d-2, e-3;	2. colestație extrahepatică malignă;	2. colestație extrahepatică malignă;
	B. a-1, b-1, c-3, d-1, e-2;	3. colestație extrahepatică benignă;	3. colestație extrahepatică benignă;
	C. a-1, b-2, c-1, d-3, e-1;	și următoarele stări patologice:	și următoarele stări patologice:
	D. a-2, b-3, c-1, d-1, e-1;	a. colangiopatia SIDA;	a. colangiopatia SIDA;
	E. a-3, b-2, c-1, d-1, e-1;	b. ciroză biliară primară;	b. ciroză biliară primară;
	2234. R.I. afecțiunile colestastice producătoare de icter, f.d.u. categorii:	c. nutriție parenterală totală;	c. nutriție parenterală totală;
	1. colestație intrahepatică;	d. stenoza septică nehepatobiliară;	d. stenoza septică nehepatobiliară;
	2. colestație extrahepatică benignă;	e. colangiocarcinom;	e. colangiocarcinom;
	3. colestație extrahepatică malignă;	care sunt asocierile corecte:	care sunt asocierile corecte:
	și următoarele stări patologice:	A. a-1, b-1, c-1, d-2, e-3;	A. a-1, b-1, c-3, d-1, e-2;
	a. cancer pancreatic;	B. a-1, b-2, c-3, d-1, e-3;	B. a-1, b-2, c-3, d-1, e-3;
	b. sindromul Mirizzi;	C. a-1, b-2, c-1, d-1, e-1;	C. a-1, b-2, c-1, d-1, e-3;
	c. colangită sclerozantă primară;	D. a-2, b-3, c-1, d-1, e-1;	D. a-2, b-3, c-1, d-1, e-1;
	d. colestația postoperatorie benignă;	E. a-3, b-2, c-1, d-1, e-1;	E. a-3, b-2, c-1, d-1, e-1;
	e. toxicitate medicamentasă;	2235. R.I. afecțiunile colestastice producătoare de icter, f.d.u. categorii:	2235. R.I. afecțiunile colestastice producătoare de icter, f.d.u. categorii:
	care sunt asocierile corecte:	1. colestație intrahepatică;	1. colestație intrahepatică;
	A. a-1, b-1, c-3, d-1, e-2;	2. colestație extrahepatică malignă;	2. colestație extrahepatică malignă;
	B. a-1, b-2, c-3, d-1, e-3;	3. colestație extrahepatică benignă;	3. colestație extrahepatică benignă;
	C. a-1, b-2, c-1, d-1, e-1;	și următoarele stări patologice:	și următoarele stări patologice:
	D. a-2, b-3, c-1, d-1, e-1;	a. colestația intrahepatică progresivă familială;	a. colestația intrahepatică progresivă familială;
	E. a-3, b-2, c-1, d-1, e-1;	b. cancer ampiclar;	b. cancer ampiclar;
	2236. R.I. colestația intrahepatică prin toxicitate medicamentasă, u.a.s.c.g.e.;	c. boala grietă-contra-gazdă;	c. boala grietă-contra-gazdă;
	A. după oprirea medicamentului, colestația este de obicei reversibilă;	d. boala venoclitivă;	d. boala venoclitivă;
	B. remiterea completă a colestației poate dura multe luni;	e. ascariroză;	e. ascariroză;
	C. medicamentele cel mai adesea asociate cu colestația sunt neuroleptice;	care sunt asocierile corecte:	care sunt asocierile corecte:
	D. colestația cronică se produce rarori;	A. a-1, b-1, c-1, d-3, e-2;	A. a-1, b-1, c-3, d-1, e-2;
	E. substrat formarea de calculi biliari;	B. a-1, b-1, c-2, d-1, e-3;	B. a-1, b-1, c-3, d-1, e-3;
	2237. R.I. colestația intrahepatică prin toxicitate medicamentasă, f.d.u. variante:	C. a-1, b-2, c-1, d-1, e-3;	C. a-1, b-2, c-1, d-1, e-3;
	1. colestație izolată;	D. a-1, b-2, c-3, d-1, e-1;	D. a-1, b-2, c-3, d-1, e-1;
	2. hepatită colestațică;	E. a-1, b-3, c-1, d-1, e-2;	E. a-1, b-3, c-1, d-1, e-2;
	3. colestație cronică;	2238. R.I. colestația intrahepatică, u.a.s.c.g.e.;	2238. R.I. colestația intrahepatică, u.a.s.c.g.e.;
	D. VCM;	A. în unele cazuri, cauza sindromului dispanției ducilor biliare rămâne necunoscută;	A. în unele cazuri, cauza sindromului dispanției ducilor biliare rămâne necunoscută;
		B. VHB și VHC pot produce hepatită fibrozantă colestațică;	B. VHB și VHC pot produce hepatită fibrozantă colestațică;
		C. sindromul Shaffer reprezintă colestația intrahepatică asociată cu cancer cu celule renale;	C. sindromul Shaffer reprezintă colestația intrahepatică asociată cu cancer cu celule renale;
		D. obstrucția arborelui biliar extrahepatic poate fi produsă de metastaze în nodulii limfatici din hilul hepatic;	D. obstrucția arborelui biliar extrahepatic poate fi produsă de metastaze în nodulii limfatici din hilul hepatic;
		E. ciroza biliară primară este o boală infecțioasă care atacează predominant bărbații în vârstă;	E. ciroza biliară primară este o boală infecțioasă care atacează predominant bărbații în vârstă;
		2239. C.d.u. NU este o cauză recunoscută a sindromului dispanției ducilor biliare:	2239. C.d.u. NU este o cauză recunoscută a sindromului dispanției ducilor biliare:
		A. respiringerea cronică a transplănt hepatic;	A. respiringerea cronică a transplănt hepatic;
		B. consumul de etanol;	B. consumul de etanol;
		C. boala grietă-contra-gazdă după transplant medular;	C. boala grietă-contra-gazdă după transplant medular;
		D. sarcoidoză (rareori);	D. sarcoidoză (rareori);
		E. medicamente (clorpromazină);	E. medicamente (clorpromazină);
		2240. R.I. colestația de sarcină, u.a.s.c.g.e.;	2240. R.I. colestația de sarcină, u.a.s.c.g.e.;
		A. apare în primul trimestru;	A. apare în primul trimestru;
		B. se agravează după naștere;	B. se agravează după naștere;
		C. are cauză necunoscută;	C. are cauză necunoscută;
		D. este probabil moștenită;	D. este probabil moștenită;
		E. poate fi ameliorată de administrarea de estrogeni;	E. poate fi ameliorată de administrarea de estrogeni;
		2241. C.d.u. virusul este cel mai puțin susceptibil să producă hepatită colestațică:	2241. C.d.u. virusul este cel mai puțin susceptibil să producă hepatită colestațică:
		A. VHB, VHC;	A. VHB, VHC;
		B. VHA;	B. VHA;
		C. VEB;	C. VEB;
		D. VCM;	D. VCM;
		2242. F.d.u. afecțiuni care produc colestație intrahepatică:	2242. F.d.u. afecțiuni care produc colestație intrahepatică:
		1. cancer de prostată;	1. cancer de prostată;
		2. sindromul dispanției ducilor biliare;	2. sindromul dispanției ducilor biliare;
		3. boala Weil (formă severă de leptospiroză);	3. boala Weil (formă severă de leptospiroză);
		și următoarele caracteristici:	și următoarele caracteristici:
		a. icter cu insuficiență renală, febră, cefalee și mialgii;	a. icter cu insuficiență renală, febră, cefalee și mialgii;
		b. tablou histologic similar cu cel din ciroză biliară primară;	b. tablou histologic similar cu cel din ciroză biliară primară;
		c. neoplazie recunoscută că poate avea icterul ca manifestare paraneoplastică;	c. neoplazie recunoscută că poate avea icterul ca manifestare paraneoplastică;
		care sunt asocierile corecte:	care sunt asocierile corecte:
		A. a-1, b-2, c-3;	A. a-1, b-2, c-3;
		B. a-1, b-3, c-2;	B. a-1, b-3, c-2;
		C. a-2, b-1, c-3;	C. a-2, b-1, c-3;
		D. a-2, b-3, c-1;	D. a-2, b-3, c-1;
		E. a-3, b-2, c-1;	E. a-3, b-2, c-1;
		2243. F.d.u. afecțiuni care produc colestație intrahepatică:	2243. F.d.u. afecțiuni care produc colestație intrahepatică:
		1. ciroză biliară primară;	1. ciroză biliară primară;
		2. sindromul dispanției ducilor biliare;	2. sindromul dispanției ducilor biliare;
		3. cancer gastroenteric;	3. cancer gastroenteric;
		și următoarele caracteristici:	și următoarele caracteristici:
		a. neoplazie recunoscută că poate avea icterul ca manifestare paraneoplastică;	a. neoplazie recunoscută că poate avea icterul ca manifestare paraneoplastică;
		b. o formă apant este duclopentia biliară a adultului, care poate fi neoplastică;	b. o formă apant este duclopentia biliară a adultului, care poate fi neoplastică;
		c. diagnosticul se bazează pe determinarea anticorpilor antimitochondriali;	c. diagnosticul se bazează pe determinarea anticorpilor antimitochondriali;
		care sunt asocierile corecte:	care sunt asocierile corecte:
		A. a-1, b-2, c-3;	A. a-1, b-2, c-3;
		B. a-1, b-3, c-2;	B. a-1, b-3, c-2;
		C. a-2, b-1, c-3;	C. a-2, b-1, c-3;
		D. a-2, b-3, c-1;	D. a-2, b-3, c-1;
		E. a-3, b-2, c-1;	E. a-3, b-2, c-1;
		2244. F.d.u. afecțiuni care produc colestație intrahepatică:	2244. F.d.u. afecțiuni care produc colestație intrahepatică:
		1. ciroză biliară primară;	1. ciroză biliară primară;
		2. colestație de sarcină;	2. colestație de sarcină;
		3. cazuri severe de malaria cu Plasmodium falciparum;	3. cazuri severe de malaria cu Plasmodium falciparum;
		și următoarele caracteristici:	și următoarele caracteristici:
		a. poate fi declanșată de administrarea de estrogeni;	a. poate fi declanșată de administrarea de estrogeni;
		b. icter asociat cu disfuncție hepatică, provocat de o combinație de hiperbilirubinemie indirectă prin hemoliză și icter colestațic și hepatocelular;	b. icter asociat cu disfuncție hepatică, provocat de o combinație de hiperbilirubinemie indirectă prin hemoliză și icter colestațic și hepatocelular;
		c. anticorpii antimitochondriali sunt prezenți la 95% din pacienți;	c. anticorpii antimitochondriali sunt prezenți la 95% din pacienți;
		care sunt asocierile corecte:	care sunt asocierile corecte:
		A. a-1, b-2, c-3;	A. a-1, b-2, c-3;

Prescurtări frecvent folosite: C.g. = cu excepție, S.u.C.g. = sunt următoarele, cu excepția, u.a.s.c.g.e. = următoarele afirmații sunt corecte, cu excepția, f.d.u. = sunt corect formulate, cu excepție.

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele, C.d.u. = care duc următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele; f.l. = referitor/referitoare la; U.I.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază desigur.

- b. neoplazie recunoscută că poate avea icterul ca manifestare paraneoplazică;
c. printre principalele cauze de colestază la pacienții din secția de terapie intensivă, care sunt asociatele corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;
2245. F.d.u. afecțiuni care produc colestază intrahepatică:
1. colangită sclerozantă primară;
2. colestază intrahepatică progresivă familială;
3. formă severă de malarie cu Plasmodium falciparum;
și următoarele caracteristici:
a. evoluție nefavorabilă când icterul este însoțit de encefalopatie și insuficiență renală;
b. afecțiune moștenită care produce colestază intrahepatică;
c. poate produce distrugerea și fibrozarea și a ductelor bilare mai mari, care sunt asociatele corecte:
A. a-1, b-3, c-2;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
2246. F.d.u. afecțiuni care produc colestază intrahepatică:
1. colangită sclerozantă primară;
2. colestază recidivantă benignă;
3. ciroză biliară primară;
și următoarele caracteristici:
a. poate afecta doar ductele intrahepatice, în care caz se prezintă drept colestază intrahepatică;
b. boală autoimună care afectează predominant femeile de vârstă medie, distragând progresiv ductele bilare interlobulare;
c. afecțiune moștenită care produce colestază intrahepatică, care sunt asociatele corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-1, c-2;
2247. F.d.u. afecțiuni care produc colestază intrahepatică:
1. colangită sclerozantă primară;
2. boală Hodgkin;
3. stare septică;
și următoarele caracteristici:
a. la 95% din pacienți sunt afectate ductele bilare atât intrahepatice, cât și extrahepatice;
b. a-1, b-2, c-3;
c. a-2, b-3, c-1;
d. a-3, b-1, c-2;
e. a-3, b-2, c-1;
2248. F.d.u. afecțiuni care produc colestază intrahepatică:
1. colangită sclerozantă primară;
2. cancer tiroidian medular;
3. ficat de șoc;
și următoarele caracteristici:
a. neoplazie recunoscută că poate avea icterul ca manifestare paraneoplazică;
b. printre principalele cauze de colestază la pacienții din secția de terapie intensivă;
c. diagnosticul se pune prin vizualizarea arborelui biliar, care sunt asociatele corecte:
A. a-1, b-3, c-2;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
2249. F.d.u. situații afecțiuni care produc colestază intrahepatică:
1. cancer cu celule renale;
2. nutriție totală parenterală;
3. colangită sclerozantă primară;
și următoarele caracteristici:
a. printre principalele cauze de colestază la pacienții din secția de terapie intensivă;
b. modificările patognomice sunt strict multiple ale ductelor bilare cu dilatații în amonte de stricturi, care sunt asociatele corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
2250. F.d.u. afecțiuni care produc colestază intrahepatică:
1. boală venoocluzivă;
2. sarcom renal;
3. colangită sclerozantă primară;
și următoarele caracteristici:
a. este provocată de obicei de infecția epiteliului biliar cu VCM sau Cryptosporidium;
b. este cea mai frecventă cauză de colestază extrahepatică;
c. a-1, b-2, c-3;
d. a-2, b-3, c-1;
e. a-3, b-1, c-2;
2251. F.d.u. afecțiuni care produc colestază intrahepatică:
1. boală grefă-contragrefă;
2. sindromul Mirizzi;
3. limfom cu celule T;
și următoarele caracteristici:
a. neoplazie recunoscută că poate avea icterul ca manifestare paraneoplazică;
b. una dintre cele mai probabile cauze de icter după transplant medular;
c. afecțiune rară, în care biopsia hepatică evidențiază scăderea numărului ductelor bilare, care sunt asociatele corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-1, c-2;
2252. U.f.d.d. curabilitatea cancerului din sfera bilio-pancreatice s.c.f.c.e.:
A. Căncelul amputat are cel mai mare procent de vindecare chirurgicală;
B. dintre toate tumorile care se prezintă cu icter dureros;
C. spre deosebire de neoplaziile pancreatice sau de căi bilare;
D. (colangiocarcinomul și cancerul de colest);
E. care sunt rezeceabile, dar au prognostic favorabil.
2253. F.d.u. afecțiuni care produc colestază extrahepatică:
1. colangiocarcinom;
2. coledocolitiază;
3. colangiopatia SIDA;
și următoarele caracteristici:
a. este provocată de obicei de infecția epiteliului biliar cu VCM sau Cryptosporidium;
b. este cea mai frecventă cauză de colestază extrahepatică;
c. a-1, b-2, c-3;
d. a-2, b-3, c-1;
e. a-3, b-1, c-2;
2254. F.d.u. afecțiuni care produc colestază extrahepatică:
1. colangiocarcinom;
2. coledocolitiază;
3. colangiopatia SIDA;
și următoarele caracteristici:
a. în forma cea mai severă, poate produce colangită ascendentă cu icter, stare septică și colaps circulator;
b. FALC este mult crescută (în medie, 800 UI/L), dar bilirubina este adesea aproape normală;
c. rezecabilitatea este rară, prognosticul este defavorabil; care sunt asociatele corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-1, c-2;
2255. F.d.u. afecțiuni care produc colestază extrahepatică:
1. colangiocarcinom;
2. coledocolitiază;
3. colangiopatia SIDA;
și următoarele caracteristici:
a. în forma cea mai severă, poate produce colangită ascendentă cu icter, stare septică și colaps circulator;
b. FALC este mult crescută (în medie, 800 UI/L), dar bilirubina este adesea aproape normală;
c. rezecabilitatea este rară, prognosticul este defavorabil; care sunt asociatele corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-1, c-2;
2256. F.d.u. afecțiuni care produc colestază extrahepatică:
1. cancerul amputat;
2. colangită sclerozantă primară;
3. sindromul Mirizzi;
și următoarele caracteristici:
a. are cel mai mare procent de vindecare chirurgicală dintre toate tumorile care se prezintă cu icter dureros;
b. este cea mai frecventă cauză de colestază extrahepatică;
c. a-1, b-2, c-3;
d. a-2, b-3, c-1;
e. a-3, b-1, c-2;
2257. F.d.u. afecțiuni care produc colestază extrahepatică:
1. cancerul de colest;
2. colangită sclerozantă primară;
3. sindromul Mirizzi;
și următoarele caracteristici:
a. în timp, poate să apară o fistulă coledocolitiază;
b. rezecabilitatea este rară, prognosticul este defavorabil;
c. uneori există o strictură dominantă a cărei rezolvare prin dilatații endoscopice repetate poate ameliora mult simptomele; care sunt asociatele corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
2258. F.d.u. afecțiuni care produc colestază extrahepatică:
1. cancerul pancreatic;
2. pancreatită cronică;
3. sindromul Mirizzi;
și următoarele caracteristici:
a. rezecabilitatea este rară, prognosticul este defavorabil;
b. provoacă rareori stricturi ale coledocului distal în porțiunea unde acesta traversează capul pancreasului;
c. icterul obstructiv poate fi și consecința fibrozei determinate de coledocolitiază;
d. în multe cazuri, nu se poate găsi o cauză precisă a distensiei abdominale;
e. stabilirea cauzei mării de volum a abdomenului începe cu investigațiile imagistice;
2259. R.I. sindromul Mirizzi, u.a.s.c.f.c.e.:
A. La un pacient care acuză mărirea abdomenului;
B. trebuie ținut cont că uneori aceasta nu este reală;
C. ci reprezintă doar senzația subiectivă de durere abdominală;
D. este cel mai adesea asociat cu colangită sclerozantă primară, care sunt asociatele corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-1, c-2;
2260. R.I. colangiopatia SIDA, u.a.s.c.f.c.e.:
A. este provocată de obicei de infecția epiteliului biliar cu VCM sau Cryptosporidium;
B. colangiografic are aspect similar cu cel din CSP;
C. FALC nu este crescută;
D. bilirubina este adesea aproape normală;
E. de obicei nu apare icter;
Mărirea abdomenului
2261. R.I. mărirea abdomenului și la cauzele acesteia, u.a.s.c.f.c.e.:
A. mărirea abdomenului este frecvent înfântă în practică;
B. în bolile sistemice, mărirea abdomenului poate fi manifestarea inițială;
C. pneumoperitoneul produce de obicei o distensie masivă a abdomenului;
D. retenția de urină este provocată de unecă de vezică neurogenă;
E. o aparentă distensie abdominală poate fi produsă uneori de rectitudinea coloanei lombare; de rectitudinea coloanei lombare; de rectitudinea coloanei lombare;
2262. R.I. mărirea abdomenului și la cauzele acesteia, u.a.s.c.f.c.e.:
A. mărirea abdomenului poate avea numeroase cauze, de la patologie locală (abdominală) până la boli sistemice;
B. de multe ori mărirea abdomenului are un substrat benign;
C. retenția de urină este provocată cel mai adesea de un obstacol supraventricular;
D. în multe cazuri, nu se poate găsi o cauză precisă a distensiei abdominale;
E. stabilirea cauzei mării de volum a abdomenului începe cu investigațiile imagistice;
2263. U.f.d.d. mărirea abdomenului s.c.f.c.e.:
A. La un pacient care acuză mărirea abdomenului;
B. trebuie ținut cont că uneori aceasta nu este reală;
C. ci reprezintă doar senzația subiectivă de durere abdominală;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, r.i. = rețineri/referențe la; U.f.d.d. = următoarele fragmente dintr-o frază desigur.

2264. R.I. gazul intestinal, f.d.u. u a.s.c.g.e.:	normal, intestinalul subțire conține aproximativ 200 ml de gaz.	2269. R.I. gazul intestinal, f.d.u. surse:	A. a-1, b-3, c-2; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;
A. în mod normal, intestinalul subțire conține aproximativ 200 ml de gaz.		1. provine din aerul atmosferic (prin înghițire);	
B. una dintre cauzele creșterii cantității de gaz din intestin este aerologia (înghițirea de aer);		2. produs în jurul intestinului prin fermentație bacteriană, și următoarele gaze:	
C. aerologia poate duce la creșterea cantității de hidrogen, dioxid de carbon și metan din intestinul subțire;		a. azotul; b. oxigenul; c. metanul; d. dioxidul de carbon; e. hidrogenul;	
D. anxietatea poate provoca aerofagia, însoțită de eructații repetate;		care sunt asocierile corecte:	
E. fermentarea lipidelor este una dintre sursele importante ale gazului intestinal;		A. a-1, b-1, c-2, d-2, e-2; B. a-1, b-2, c-2, d-2, e-1; C. a-2, b-1, c-1, d-2, e-2; D. a-2, b-1, c-2, d-1, e-2; E. a-2, b-2, c-2, d-1, e-1;	
2265. U.f.d.f.d. creșterea cantității de gaz intestinal s.c.f.g.e.:		3. creșterea conținutului intraabdominal prin material lichid, localizată/ delimitată, simetrică;	
A. Creșterea cantității de gaz intestinal poate rezulta, B. prin metabolismul de către celulele intestinale;		1. creșterea conținutului intraabdominal prin material solid, asimetrică;	
C. a substratelor fermentabile în; D. în care adesea apar și dureri abdominale, greață și vărsături;		2. creșterea conținutului intraabdominal prin material solid, asimetrică;	
E. cu producție de oxigen și azot		3. creșterea conținutului intraabdominal prin material solid, asimetrică;	
2266. C.d.u. NU reprezintă o cauză de aerofagie:		2270. U.f.d.f.d. mărirea abdomenului poate fi provocată:	
A. fermentare bacteriană excesivă;		A. a-1, b-3, c-2; B. a-2, b-1, c-3; C. a-2, b-3, c-1; D. a-3, b-1, c-2; E. a-3, b-2, c-1;	
B. înghițirea cu înlocuire a alimentelor;		2271. R.I. cauzele mării abdominale, greață și vărsături:	
C. mestecarea de gumă;		1. creșterea conținutului intestinal prin material gazos (flatul);	
D. tulburări;		2. creșterea conținutului intraabdominal prin material lichid, localizată/ delimitată, simetrică;	
E. anxietatea;		3. creșterea conținutului intraabdominal prin material solid, simetrică;	
2267. U.f.d.f.d. explicația simptomelor din S.I.I s.c.f.g.e.:		2272. R.I. cauzele mării abdominale, f.d.u. categorii:	
A. La persoanele cu S.I.I și meteorism, senzația;		1. creșterea conținutului intestinal prin material gazos (flatul);	
B. subiectivă de presiune abdominală este provocată;		2. creșterea conținutului intraabdominal prin material lichid, generalizată;	
C. în primul rând de creșterea proporției de metan din gazul intestinal;		3. creșterea conținutului intraabdominal prin material solid, asimetrică;	
D. și eventual de perturbarea tranzitului intestinal al gazului;		2273. R.I. cauzele mării abdominale, f.d.u. categorii:	
E. și nu de creșterea volumului de gaz;		1. creșterea conținutului intestinal prin material gazos (flatul);	
2268. Componente majore ale gazului intestinal s.u.c.g.e.:		2. creșterea conținutului intraabdominal prin material lichid, localizată/ delimitată, simetrică;	
A. azot;		3. creșterea conținutului intraabdominal prin material solid, asimetrică;	
B. oxigen;		2274. R.I. cauzele mării abdominale, greață și vărsături:	
C. dioxid de carbon;		1. creșterea conținutului intestinal prin material gazos (flatul);	
D. hidrogen;		2. creșterea conținutului intraabdominal prin material lichid, localizată/ delimitată, simetrică;	
E. bulan;		3. creșterea conținutului intraabdominal prin material solid, asimetrică;	

- D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
2285. R.I. cauza pacientului de mănă a abdomenului, f.d.u. începuturi de frază:
1. poate fi doar o senzație subiectivă;
2. poate fi obiectivă și asociată cu durere localizată;
3. pacientul poate sesiza o tumefacție localizată;
și următoarele sfârșituri de frază:
a. provocată de o hernie;
b. adesea asociată cu o tulburare gastrointestinală funcțională;
c. când este produsă de afectarea unui organ abdominal;
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;
2288. Aparența mănă a abdomenului care reprezintă de fapt doar o senzație subiectivă are u. trăsături, c.d.:
- A. a-1, b-3, c-2;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
2286. R.I. cauza pacientului de mănă a abdomenului, f.d.u. începuturi de frază:
1. poate fi doar o senzație subiectivă;
2. poate fi obiectivă și asociată cu durere localizată;
3. poate fi fără o veritabilă creștere în volum a cavității peritoneale;
și următoarele sfârșituri de frază:
a. când este produsă de hepatomegalie, splenomegalie, tumoră colonică;
b. neînsoțită de semne fizice obiective de creștere a circumferinței abdominale sau de tumefacție localizată;
c. când este asociată cu obezitatea și creșterea grăsimii abdominale;
D. în general nu este însoțită de disconfort abdominal;
E. este de regulă însoțită de durere când este provocată de ascită la un cirotic;
2290. R.I. situația în care mănă abdomenului este o realitate obiectivă, f.d.u. începuturi de frază:
1. asocierea cu durere abdominală sugerează;
2. durerea localizată este determinată de obicei de;
3. când apare la pacientul cirotic (rareori) cu durere la ciroticul cu provocată de obicei de;
și următoarele sfârșituri de frază:
a. infecție intraabdominală, peritonită, pancreatită;
- b. pancreatită, carcinom hepatocelular, peritonită;
c. afectarea unui organ abdominal (de exemplu, hepatomegalie, splenomegalie, tumoră colonică);
care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-3, c-2;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
2291. La pacienții la care mănă abdomenului este fără o veritabilă creștere în volum a cavității peritoneale, u.s.c.c.g.:
- A. de obicei diferențierea se poate face pe baza istoricului și a examenului fizic;
B. poate fi asociată cu creșterea grăsimii abdominale;
C. când este asociată cu obezitatea, nu este însoțită de o creștere reală a circumferinței abdominale;
D. poate fi doar aparentă în cazul lordozei lombare;
E. lordoza lombară face ca abdomenul să proemineze, fără creșterea veritabilă a circumferinței abdominale;
2292. U.f.d.f.d. mănă abdomenului s.c.f.c.g.:
- A. Adesea, o mănă importantă a abdomenului;
B. poate trece neobservată timp de săptămâni sau luni;
C. fie din cauza obezității coexistente;
D. fie a acumulării rapide a lichidului de ascită;
E. fără durere sau simptome de localizare;
2293. U.f.d.f.d. distensia abdominală s.c.f.c.g.:
- A. Distensia abdominală progresivă poate fi;
B. asociată cu o senzație;
C. de tracțiune sau întindere;
D. în epigastru și o vagă;
E. durere de spate joasă;
2294. Consecințele creșterii presiunii intraabdominale la pacienți cu ascită în tensiune sau tumor abdominală s.u.c.g.:
- A. indigestie;
B. greață și vărsături din cauza refluxului gastroesofagian;
C. hernii ale peretelui abdominal (inghinală și ombilicală) recent instalate;
- și următoarele sfârșituri de frază:
a. abdomenul fiind doar proeminent din cauza lordozei lombare;
b. situație în care trebuie avute în vedere: pancreatită, carcinom hepatocelular, peritonită;
c. pacientul fiind nevoit să-și lărgască îmbrăcămintea sau cureaua;
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;
2288. Aparența mănă a abdomenului care reprezintă de fapt doar o senzație subiectivă are u. trăsături, c.d.:
- A. a-1, b-3, c-2;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
2286. R.I. cauza pacientului de mănă a abdomenului, f.d.u. începuturi de frază:
1. poate fi doar o senzație subiectivă;
2. poate fi obiectivă și asociată cu durere localizată;
3. poate fi fără o veritabilă creștere în volum a cavității peritoneale;
și următoarele sfârșituri de frază:
a. când este produsă de hepatomegalie, splenomegalie, tumoră colonică;
b. neînsoțită de semne fizice obiective de creștere a circumferinței abdominale sau de tumefacție localizată;
c. când este asociată cu obezitatea și creșterea grăsimii abdominale;
care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-1, c-2;

Prescrutări frecvent folosite: c.d. = cu excepția; s.u.c.g. = sunt următoarele, cu excepția; u.s.c.c.g. = următoarele afirmări sunt corecte, cu excepția; s.c.f.c.g. = sunt corect formulate, cu excepția;

- D. dispnee, ortopnee și tahipnee din cauza coborârii a diafragmei;
E. hiperinflație pulmonară;
2295. R.I. importanța unui revărsat lichidian pleural coexistent ascitei, u.s.c.c.g.:
- A. poate contribui la dificultatea respiratorie;
B. este localizat mai adesea pe partea stângă;
C. este produs probabil prin transudarea lichidului din capilarele pleurale;
D. poate fi (foarte) mare, acoperind cea mai mare parte din plămân;
E. când este masiv, este numit și hidrothorax hepatic;
2296. R.I. rolul istoricului în stabilirea cauzei mănă abdomenului, f.d.u. categorii:
1. simptome sugestive pentru cancer;
2. factori de risc pentru hepatopatie cronică;
și următoarele elemente:
a. anorexie;
b. transpirații nocturne;
c. consum excesiv de alcool;
d. antecedente familiale de hepatopatie;
care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-1, c-2, d-2;
B. a-1, b-2, c-1, d-2;
C. a-1, b-2, c-2, d-1;
D. a-2, b-1, c-1, d-2;
E. a-2, b-1, c-2, d-1;
2297. R.I. rolul istoricului în stabilirea cauzei mănă abdomenului, f.d.u. categorii:
1. simptome sugestive pentru cancer;
2. factori de risc pentru hepatopatie cronică;
3. simptome de hepatopatie cronică;
și următoarele elemente:
a. hepatită virală;
b. episoade anterioare de icter;
c. pierdere în greutate;
d. steatohepatită nealcoolică;
care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-3, c-2, d-2;
B. a-2, b-2, c-1, d-3;
C. a-2, b-3, c-1, d-2;
D. a-3, b-2, c-1, d-2;
E. a-3, b-2, c-2, d-1;
2298. R.I. rolul examenului clinic în stabilirea cauzei mănă abdomenului, f.d.u. informații obținute prin istoric:

Prescrutări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; f.d.u. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, f.d. = referitor/afectare la; U.f.d.f.d. = următoarele fragmente dintr-o frază despre;

2301. R.I. rolul examenului fizic în stabilirea cauzei mănă abdomenului, u.s.c.c.g.:
- A. examenul fizic trebuie să vizeze abdomenul, dar și doscoarea unor eventuale semne de boală sistemică;
B. absența mătii la percuția abdomenului exclude ascita;
C. palparea abdomenului poate detecta zone de sensibilitate;
D. trebuie încercat să se determine dacă formațiunea tumorală detectată prin palpare se deplasează cu respirația;
E. semnul „sloului de gheață” reprezintă scăderea temperaturii cutanate abdominale când ascita este masivă;
2302. R.I. rolul examenului fizic în stabilirea cauzei mănă abdomenului, u.s.c.c.g.:
- A. întâi se efectuează inspecția pentru a detecta o distensie neuniformă sau o formațiune tumorală;
B. pentru ca ascita să poată fi detectată prin percuție (cu pacienții în decubit dorsal) este necesară o cantitate de lichid de cel puțin 500 mL;
C. palparea abdomenului poate detecta o formațiune tumorală;
D. palparea abdomenului este adesea dificilă când ascita este masivă;
E. ficatul, splina și colecistul trebuie să coboare la inspirație;
2303. R.I. rolul examenului fizic în stabilirea cauzei mănă abdomenului, u.s.c.c.g.:
- A. observând conturul abdominal, se poate diferenția mănă de volum localizată de cea generalizată;
B. când este prezentă, malitatea produsă de ascită este fixă;
C. palparea abdomenului poate detecta splenomegalie;
D. singura metodă de a palpa ficatul sau splina când ascita este masivă poate fi prin plasarea pacientului în poziția genupectorală;
E. ficatul, splina și colecistul sunt invadate de o tumoră care depășește limitele organului;
2304. R.I. rolul examenului fizic în stabilirea cauzei mănă abdomenului, u.s.c.c.g.:

- A. în ascită, lichidul se distribuie gravitațional în zonele cele mai declive, ceea ce face flancurile să bombeze;
B. lapul că matitatea este deplasabilă demonstrează că lichidul este înlocuit;
C. palparea abdomenului poate detecta hepatomegalie;
D. o ușoară splenomegalie în asocieră cu ascită poate fi singurul semn de ciroză ocultă;
E. ficatul, splina și colecistul pot să nu coboare la inspirație dacă nu sunt fixate prin aderenți sau prin invazie neoplazică;
2305. R.I. rolul examenului fizic în stabilirea cauzei mării abdominului, u.a.s.c.g.e.:
- A. un chist ovarian suficient de mare produce de obicei distensie abdominală difuză;
B. percuția poate evidenția mărirea sau micșorarea ficatului;
C. palparea abdomenului poate detecta un „ficat nodular sugerând ciroză sau tumoră”;
D. palparea blândă poate detecta un ficat pulsatil (asociat ascitei);
E. o formațiune tumorală fixată care nu coboară cu respirația este, posibil să fie retroperitoneală;
2306. R.I. rolul examenului fizic în stabilirea cauzei mării abdominului, u.a.s.c.g.e.:
- A. o tumoră localizată abdominală poate fi produsă de un uter mări;
- B. dispariția matității hepatice normale poate fi produsă de necroza hepatică masivă;
C. semnul valului necesită $\geq 1,5$ L de lichid pentru a putea fi evidențiat;
D. un ficat pulsatil (asociat ascitei) semnifică pericardită constructivă;
E. examinarea rectală și pelvică este obligatorie;
2307. R.I. rolul examenului fizic în stabilirea cauzei mării abdominului, u.a.s.c.g.e.:
- A. efectuată atenț, percuția poate diferenția mărirea abdominală generalizată de o tumoră localizată;
B. dispariția matității hepatice normale poate fi produsă de gaz liber în cavitatea peritoneală, în urma occluderii unui viscer cavitat;
- C. la pacienții obezi, cantitățile mici de lichid pot fi mai ușor de evidențiat;
D. trebuie încercat să se determine dacă formațiunea tumorală detectată prin palparea este solidă sau chistică;
E. durerea la palpare în special dacă nu este localizată, poate indica un proces inflamator cum ar fi un abces;
2308. R.I. rolul examenului fizic în stabilirea cauzei mării abdominului, u.a.s.c.g.e.:
- A. o tumoră localizată abdominală poate fi produsă de o vezică distinsă;
B. percuția poate diferenția mărirea abdomenului prin gaz intestinal (timpanism) de cea produsă de lichid sau de o formațiune solidă (matitate);
C. la pacienții obezi, cantitățile mici de lichid adesea pot fi detectate doar prin radiografie abdominală;
D. trebuie încercat să se determine dacă formațiunea tumorală detectată prin palparea este netedă sau neregulată;
E. examinarea rectală și pelvică poate descoperi formațiuni de natură tumorală sau infecțioasă;
2309. R.I. rolul inspecției generale în stabilirea cauzei mării abdominului, f.d.u. modificări:
1. adenopatie, în special supravehiculată (adenopatie Vichrow);
2. eritem palmar, angioame stelate, ginecomastie;
3. jugulare turgescențe, semnul Kussmaul (distensie jugulară la inspirație);
și următoarele stări patologice sugerate de acestea:
a. creșterea presiunii venoase centrale;
b. ciroză;
c. metastază ganglionară dintr-un cancer abdominal;
care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
2310. R.I. rolul inspecției în stabilirea cauzei mării abdominului, f.d.u. modificări:
1. abdomen distins, uneori în tensiune;
2. vene superficiale dilatate în jurul ombilicului cu direcția fluxului de sânge dinspre ombilic spre periferie;
3. abdomenul cu zone proeminente;
și următoarele stări patologice sugerate de acestea:
a. ocizie intestinală;
b. HTP;
c. ascită;
care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-3, c-2;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
2311. R.I. rolul inspecției în stabilirea cauzei mării abdomenului, f.d.u. modificări:
1. abdomen cu pielea înlinsă;
2. „capul Meduzei”;
3. zone proeminente care deformează peretele abdominal;
și următoarele stări patologice sugerate de acestea:
a. anse intestinale mult distins;
b. HTP;
c. ascită;
care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-3, c-2;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
2312. R.I. rolul inspecției în stabilirea cauzei mării abdomenului, f.d.u. modificări:
1. abdomen cu flancurile bombat;
2. colaterale venoase subombilicale cu flux dinspre partea inferioară a abdomenului spre ombilic;
3. o formațiune epigastrică, cu unde peristaltice evidente deplasându-se de la stânga la dreapta;
și următoarele stări patologice sugerate de acestea:
a. obstrucție de venă cavă inferioară;
b. obstrucție pilorică;
c. ascită;
care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;

Prescurtări frecvent folosite: s.g.e. = cu excepția, s.u.c.g.e. = sunt următoarele, cu excepția, u.a.s.c.g.e. = următoarele afirmații sunt corecte, cu excepția, s.c.f.g.e. = sunt corect formulate, cu excepția.

2313. R.I. rolul inspecției în stabilirea cauzei mării abdomenului, f.d.u. modificări:
1. ombilic distins, uneori chiar supraombilical cu flux descendent spre ombilic;
3. formațiune nodulară vizibilă în cadrului superior drept, care are contact diafragmatic (se deplasează cu respirația);
și următoarele stări patologice sugerate de acestea:
a. ascită;
b. obstrucție de venă cavă superioară;
c. ficat cu metastaze;
care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-1, c-2;
2314. R.I. rolul ausculției cardiace în stabilirea cauzei mării abdomenului, f.d.u. semne care pot indica etiologia cardiacă a ascitei:
1. pocnitură pericardică;
2. galop protodiastolic drept;
3. suflu sistolic parasternal stânga jos;
și următoarele stări patologice sugerate de acestea:
a. insuficiență tricuspidiană;
b. insuficiență ventriculară dreaptă;
c. pericardita constructivă;
care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
2315. R.I. rolul ausculției abdominale în stabilirea cauzei mării abdomenului, f.d.u. modificări:
1. zgomote intestinale de tonalitate înaltă localizate;
2. un suflu abdominal;
3. frecătură (ca cea produsă de frecarea a două bucati de piele) în dreptul unui ficat mări;
și următoarele stări patologice sugerate de acestea:
a. frecarea peretelui abdominal de un nodul de supraîntă;
b. repermabilizarea venei ombilicale în condiții de HTP;
c. faza timpurie a occluderii intestinale;
care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-3, c-2;
B. a-2, b-1, c-3;
- A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-1, c-2;
2316. R.I. rolul ausculției abdominale în stabilirea cauzei mării abdomenului, f.d.u. modificări:
1. absența zgomotelor intestinale;
2. un suflu aspru în dreptul unui ficat mări;
3. clapoții;
și următoarele stări patologice sugerate de acestea:
a. faza tardivă a occluderii intestinale;
b. cantitate crescută de lichid și gaz într-un viscer cavitat dilatat;
c. rareori, la pacienți cu carcinom hepatocelular vascularizat;
care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-1, c-2;
2317. R.I. rolul ausculției abdominale în stabilirea cauzei mării abdomenului, f.d.u. modificări:
1. absența zgomotelor intestinale;
2. un suflu aspru în dreptul unui ficat mări;
3. clapoții;
și următoarele stări patologice sugerate de acestea:
a. ileus;
b. stomacul distins din cauza unei stenozes pilorice;
c. hepatită alcoolică (rareori);
care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
2318. R.I. rolul percuției în stabilirea cauzei mării abdomenului, f.d.u. modificări:
1. tunefacție localizată abdominală;
2. matitate deplasabilă;
3. dispariția matității hepatice normale;
și următoarele stări patologice sugerate de acestea:
a. ufer mări;
b. perforația unui viscer cavitat;
c. lichid liber în cavitatea peritoneală;
care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-3, c-2;
B. a-2, b-1, c-3;
- C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
2321. R.I. rolul palpării în stabilirea cauzei mării abdomenului, f.d.u. modificări:
1. semnul valului;
2. semne de HTP și ficat cu consistență foarte tare și/sau supraîntă nouătră la palpare;
3. organula subdiafragmatică (ficatului, splina, colecistului) nu coboară la inspirație;
și următoarele stări patologice sugerate de acestea:
a. fixare prin aderenți sau prin invazie neoplazică (tumoră care depășește limitele organului de origine);
b. o cantitate de ascită $\geq 1,5$ L;
c. infiltrație tumorală a ficatului;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele, c.d.u. = care dintre următoarele, f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele, f. = referitor/referitoare la, u.f.d.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază despre.

b. obstrucție extrahepatică a fluxului portal;
c. înținderea peritoneului visceral; care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-1, c-2;

2325. R.I. rolul palpării în stabilirea cauzei mării abdomenului, f.d.u. modificări:
1. semne de HTP și ficat cu consistență tare la palparea; un ficat pulsant (asociat ascitei);
2. durere la palparea; și următoarele stări patologice sugerate de acestea:
a. ciroză drept cauza probabilită a HTP;
b. flux retrograd din VD în AD, VCI și venele suprahepatice;
c. necroză tumorală;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;

2326. F.d.u. etape în manevra de detectare a sernului „sloului de gheață”:
a. organul măr revine la suprafața lichidului;
b. organul măr izbăște mână care palpează;
c. organul măr reculează sub mână care palpează, scufundându-se în lichidul peritoneal;
d. cu un gest relativ brusc, mână palpează organul măr;
care este lanțul temporal corect:
A. a→c→b→d;
B. b→a→d→c;
C. c→d→b→a;
D. d→b→a→c;
E. d→c→a→b;

2327. R.I. rolul investigațiilor para-clinice în stabilirea cauzei mării abdomenului, u.a.s.c.g.e.:
A. se începe cu radiografie bariată a tubului digestiv;
B. ecografia este utilă pentru a detecta ascizia;
C. splenomegalia poate fi detectată prin ecografie;
D. TC nu vizualizează corect retroperitoneul, pancreasul și nodulii limfatici;

2328. R.I. rolul palpării în stabilirea cauzei mării abdomenului, f.d.u. modificări:
1. ficat cu consistență foarte tare și/sau suprafață nodulară la palparea însoțită de ascizi;
2. o formațiune tumorală fixată care nu coboară cu respirația;
3. hepatomegalie pulsantă asociată cu ascizi;
și următoarele stări patologice sugerate de acestea:
a. tumoră posibil retroperitoneală;
b. insuficiență tricuspidiană, de obicei asociată cu insuficiență cardiacă dreaptă;
c. asciziă probabil neoplazică (melastaze peritoneale);
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;

2329. R.I. rolul palpării în stabilirea cauzei mării abdomenului, f.d.u. modificări:
1. ficat nodular;
2. nodul tare perumbilical (nodulul sorei Mary Joseph);
3. durerea localizată la palparea;
și următoarele stări patologice sugerate de acestea:
a. ciroză;
b. proces inflamator (cum ar fi un abces);
c. boală melastatică de la tumoră primară pelviană sau gastrointestinală;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-1, c-2;

2330. R.I. rolul palpării în stabilirea cauzei mării abdomenului, f.d.u. modificări:
1. ficat nodular;
2. semne de HTP și ficat cu consistență renitentă (normală) la palparea;
3. durere la palparea;
și următoarele stări patologice sugerate de acestea:
a. tumoră hepatică;

E. investigațiile bioumorale trebuie să includă analizele biochimice hepatice;
2328. R.I. rolul investigațiilor para-clinice în stabilirea cauzei mării abdomenului, u.a.s.c.g.e.:
A. radiografia abdominală simplă se efectuează cu pacientul în ortostatism și în decubit dorsal;
B. ecografia poate detecta ascizi doar când există cel puțin 500 ml. lichid;
C. ecografia este adesea utilă pentru a evidenția și evalua eventuala nodularitate a ficatului;
D. TC este interioară ecografiei în vizualizarea retroperitoneului; pancreasului și nodulilor limfatici;
E. gradientul de presiune venos hepatic reprezintă diferența de presiune dintre vena portă și vena splenică;
2329. R.I. rolul investigațiilor para-clinice în stabilirea cauzei mării abdomenului, u.a.s.c.g.e.:
A. radiografia furnizează informații valoroase despre dimensiunea ficatului și a splinei;
B. ecografia este adesea utilă pentru a evidenția o formațiune tumorală;
C. ecografia este investigația de elecție pentru depistarea adenopatilor retroperitoneale;
D. TC este mai puțin fidelă decât ecografia în detectarea formațiilor tumorale;
E. în anumite cazuri, măsurarea gradientului de presiune venos hepatic se poate realiza prin canularea/ cateterizarea venei hepatice;
2330. R.I. rolul investigațiilor para-clinice în stabilirea cauzei mării abdomenului, u.a.s.c.g.e.:
A. radiografia poate evidenția un colon stenozat din cauza unei colite ulceroase altminteri nesuspectate;
B. ecografia permite măsurarea dimensiunilor ficatului și splinei;
C. ecografia este investigația etalon în evaluarea leziunilor pancreatice;
D. TC poate detecta modificări asociate cu ciroza avansată și cu HTP;
E. creșterea gradientului de presiune venos hepatic înfirmă ciroza drept cauză a ascitei;

Prăscutări frecvent folosite: c.e. = cu excepția; s.u.c.g. = sunt următoarele, cu excepția; u.a.s.c.g.e. = următoarele afirmații sunt corecte, cu excepția; s.c.i.c.g. = sunt corect formulate, cu excepția.

2331. R.I. rolul investigațiilor paraclinice în stabilirea cauzei mării abdomenului, u.a.s.c.g.;
A. a investigaarea tractului digestiv cu substanțe de contrast este de obicei necesară pentru descoperirea unei tumori digestive primare;
B. ecografia poate evidenția o hepatomegalie;
C. TC furnizează informații similare ecografiei;
D. pentru evaluarea funcției hepatice sunt utile transaminazele;
E. biopsia hepatică poate fi necesară în unele cazuri pentru a confirma ciroza.

2332. R.I. rolul radiografiei abdominale simple în stabilirea cauzei mării abdomenului, f.d.u. modificări:
1. anse intestinale dilatate, cu niveluri hidroaerice;
2. voalare abdominală difuză și ștergerea marginilor psoasului;
3. hemidiafragma dreaptă neregulată și ascensionată;
4. următoarele stări patologice sugerate de acestea:
a. ascită;
b. ocizie intestinală sau ileus;
c. abces hepatic sau carcinom hepatocelular;
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;

2333. R.I. rolul investigațiilor biochimice în stabilirea cauzei mării abdomenului, f.d.u. modificări:
1. albuminemie scăzută;
2. citopenii (trombocitopenie, leucopenie, eventual și anemie);
3. nivelul seric crescut al amilazei și al lipazei;
4. următoarele stări patologice sugerate de acestea:
a. pancreatită acută;
b. hipersplenism determinat de HTP, indicând ciroză;
c. insuficiența hepatică sugerând ciroza (drept cauză a ascitei);
care sunt asocierile corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-1, c-3;
D. a-2, b-3, c-1;
E. a-3, b-2, c-1;

Prescurtări frecvent folosite; u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date; f.d.u. = fiind date următoarele; r. = referitor/referitoare la; U.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o fază despre:

D. d → a → b → c;
E. d → c → b → a;

2337. F.d.u. evenimente patologice hipertensiunii portale; a. arteriolodilatatie splahnica;
b. creste fluxul prin vena porta;
c. factori umorali vasodilatori; care este lanțul cauzal corect:
A. a → b → c;
B. a → c → b;
C. b → a → c;
D. b → c → a;
E. C → a → b;

2338. R.l.i. patogenza ascitei în ciroza hepatică, u.a.s.c.g.:
A. în ciroză, ascita este produsă de HTP (creșterea presiunii din vena portă și de RHS renală);
B. presiunea este raportul dintre rezistență și flux;
C. presiunea din vena portă poate crește prin creșterea rezistenței hepatice sau prin creșterea fluxului prin vena portă;
D. scăderea VSCE este percepută de organism în ansamblu și de rinichi în particular drept hipovolemie;
E. retenția hidrosalină renală este consecința rețenției hidrice prin aldosteron și a rețenției saline prin AVP;

2339. U.f.d.f.d. patogenzei ascitei în ciroza hepatică s.c.f.g.e.;
A. În ciroză, ascita este adesea refractară la tratament;
B. deoarece este consecința unei combinații de factori obstrucțivi,
C. drenajului limfatic hepatic;
D. hipertensiune portală și;
E. hiperangiotubulinemia.

2340. U.f.d.f.d. patogenzei hipertensiunii portale din ciroză s.c.f.g.g.;
A. Apariția ciroze se asociază cu:
B. creșterea nivelurilor circulante sistemice ale oxidului nitric;
C. (în paralel cu creșterea intrahepatică) și cu;
D. scăderei nivelurilor factorilor de creștere vascular endotelială;
E. și ale factorului de necroză tumorală.

2341. F.d.u. evenimente r.li. patologice hipertensiunii portale din ciroză:
a. vasodilație arterială splahnică;
b. scăderea VSCE;
c. acumularea sângelui în viscerele abdominale;

a. GASA reflectă gradientul de p.O., care contrabalansează p.h. portală;

sific: u_i = următoarele; c, d, u_i = care dintre următoarele; f, d_i = fiind date, f, d, u_i = referitor/referitoare la; $\{f, d, d_i\}$ = următoarele înaintea de a avea d .

b. GASA reflectă p.h. din sinusoidale hepatice; c. GASA se corelează direct cu presiune portală; d. GASA se corelează cu gradientul de presiune venos hepatic; e. GASA scăzut; f. GASA scăzut; g. GASA scăzut; h. GASA scăzut; i. GASA scăzut; j. GASA scăzut; k. GASA scăzut; l. GASA scăzut; m. GASA scăzut; n. GASA scăzut; o. GASA scăzut; p. GASA scăzut; q. GASA scăzut; r. GASA scăzut; s. GASA scăzut; t. GASA scăzut; u. GASA scăzut; v. GASA scăzut; w. GASA scăzut; x. GASA scăzut; y. GASA scăzut; z. GASA scăzut; aa. GASA scăzut; ab. GASA scăzut; ac. GASA scăzut; ad. GASA scăzut; ae. GASA scăzut; af. GASA scăzut; ag. GASA scăzut; ah. GASA scăzut; ai. GASA scăzut; aj. GASA scăzut; ak. GASA scăzut; al. GASA scăzut; am. GASA scăzut; an. GASA scăzut; ao. GASA scăzut; ap. GASA scăzut; aq. GASA scăzut; ar. GASA scăzut; as. GASA scăzut; at. GASA scăzut; au. GASA scăzut; av. GASA scăzut; aw. GASA scăzut; ax. GASA scăzut; ay. GASA scăzut; az. GASA scăzut; ba. GASA scăzut; bb. GASA scăzut; bc. GASA scăzut; bd. GASA scăzut; be. GASA scăzut; bf. GASA scăzut; bg. GASA scăzut; bh. GASA scăzut; bi. GASA scăzut; bj. GASA scăzut; bk. GASA scăzut; bl. GASA scăzut; bm. GASA scăzut; bn. GASA scăzut; bo. GASA scăzut; bp. GASA scăzut; bq. GASA scăzut; br. GASA scăzut; bs. GASA scăzut; bt. GASA scăzut; bu. GASA scăzut; bv. GASA scăzut; bw. GASA scăzut; bx. GASA scăzut; by. GASA scăzut; bz. GASA scăzut; ca. GASA scăzut; cb. GASA scăzut; cc. GASA scăzut; cd. GASA scăzut; ce. GASA scăzut; cf. GASA scăzut; cg. GASA scăzut; ch. GASA scăzut; ci. GASA scăzut; cj. GASA scăzut; ck. GASA scăzut; cl. GASA scăzut; cm. GASA scăzut; cn. GASA scăzut; co. GASA scăzut; cp. GASA scăzut; cq. GASA scăzut; cr. GASA scăzut; cs. GASA scăzut; ct. GASA scăzut; cu. GASA scăzut; cv. GASA scăzut; cw. GASA scăzut; cx. GASA scăzut; cy. GASA scăzut; cz. GASA scăzut; da. GASA scăzut; db. GASA scăzut; dc. GASA scăzut; dd. GASA scăzut; de. GASA scăzut; df. GASA scăzut; dg. GASA scăzut; dh. GASA scăzut; di. GASA scăzut; dj. GASA scăzut; dk. GASA scăzut; dl. GASA scăzut; dm. GASA scăzut; dn. GASA scăzut; do. GASA scăzut; dp. GASA scăzut; dq. GASA scăzut; dr. GASA scăzut; ds. GASA scăzut; dt. GASA scăzut; du. GASA scăzut; dv. GASA scăzut; dw. GASA scăzut; dx. GASA scăzut; dy. GASA scăzut; dz. GASA scăzut; ea. GASA scăzut; eb. GASA scăzut; ec. GASA scăzut; ed. GASA scăzut; ee. GASA scăzut; ef. GASA scăzut; eg. GASA scăzut; eh. GASA scăzut; ei. GASA scăzut; ej. GASA scăzut; ek. GASA scăzut; el. GASA scăzut; em. GASA scăzut; en. GASA scăzut; eo. GASA scăzut; ep. GASA scăzut; eq. GASA scăzut; er. GASA scăzut; es. GASA scăzut; et. GASA scăzut; eu. GASA scăzut; ev. GASA scăzut; ew. GASA scăzut; ex. GASA scăzut; ey. GASA scăzut; ez. GASA scăzut; fa. GASA scăzut; fb. GASA scăzut; fc. GASA scăzut; fd. GASA scăzut; fe. GASA scăzut; ff. GASA scăzut; fg. GASA scăzut; fh. GASA scăzut; fi. GASA scăzut; fj. GASA scăzut; fk. GASA scăzut; fl. GASA scăzut; fm. GASA scăzut; fn. GASA scăzut; fo. GASA scăzut; fp. GASA scăzut; fq. GASA scăzut; fr. GASA scăzut; fs. GASA scăzut; ft. GASA scăzut; fu. GASA scăzut; fv. GASA scăzut; fw. GASA scăzut; fx. GASA scăzut; fy. GASA scăzut; fz. GASA scăzut; ga. GASA scăzut; gb. GASA scăzut; gc. GASA scăzut; gd. GASA scăzut; ge. GASA scăzut; gf. GASA scăzut; gg. GASA scăzut; gh. GASA scăzut; gi. GASA scăzut; gj. GASA scăzut; gk. GASA scăzut; gl. GASA scăzut; gm. GASA scăzut; gn. GASA scăzut; go. GASA scăzut; gp. GASA scăzut; gq. GASA scăzut; gr. GASA scăzut; gs. GASA scăzut; gt. GASA scăzut; gu. GASA scăzut; gv. GASA scăzut; gw. GASA scăzut; gx. GASA scăzut; gy. GASA scăzut; gz. GASA scăzut; ha. GASA scăzut; hb. GASA scăzut; hc. GASA scăzut; hd. GASA scăzut; he. GASA scăzut; hf. GASA scăzut; hg. GASA scăzut; hh. GASA scăzut; hi. GASA scăzut; hj. GASA scăzut; hk. GASA scăzut; hl. GASA scăzut; hm. GASA scăzut; hn. GASA scăzut; ho. GASA scăzut; hp. GASA scăzut; hq. GASA scăzut; hr. GASA scăzut; hs. GASA scăzut; ht. GASA scăzut; hu. GASA scăzut; hv. GASA scăzut; hw. GASA scăzut; hx. GASA scăzut; hy. GASA scăzut; hz. GASA scăzut; ia. GASA scăzut; ib. GASA scăzut; ic. GASA scăzut; id. GASA scăzut; ie. GASA scăzut; if. GASA scăzut; ig. GASA scăzut; ih. GASA scăzut; ii. GASA scăzut; ij. GASA scăzut; ik. GASA scăzut; il. GASA scăzut; im. GASA scăzut; in. GASA scăzut; io. GASA scăzut; ip. GASA scăzut; iq. GASA scăzut; ir. GASA scăzut; is. GASA scăzut; it. GASA scăzut; iu. GASA scăzut; iv. GASA scăzut; iw. GASA scăzut; ix. GASA scăzut; iy. GASA scăzut; iz. GASA scăzut; ja. GASA scăzut; jb. GASA scăzut; jc. GASA scăzut; jd. GASA scăzut; je. GASA scăzut; jf. GASA scăzut; jg. GASA scăzut; jh. GASA scăzut; ji. GASA scăzut; jj. GASA scăzut; jk. GASA scăzut; jl. GASA scăzut; jm. GASA scăzut; jn. GASA scăzut; jo. GASA scăzut; jp. GASA scăzut; jq. GASA scăzut; jr. GASA scăzut; js. GASA scăzut; jt. GASA scăzut; ju. GASA scăzut; jv. GASA scăzut; jw. GASA scăzut; jx. GASA scăzut; jy. GASA scăzut; jz. GASA scăzut; ka. GASA scăzut; kb. GASA scăzut; kc. GASA scăzut; kd. GASA scăzut; ke. GASA scăzut; kf. GASA scăzut; kg. GASA scăzut; kh. GASA scăzut; ki. GASA scăzut; kj. GASA scăzut; kk. GASA scăzut; kl. GASA scăzut; km. GASA scăzut; kn. GASA scăzut; ko. GASA scăzut; kp. GASA scăzut; kq. GASA scăzut; kr. GASA scăzut; ks. GASA scăzut; kt. GASA scăzut; ku. GASA scăzut; kv. GASA scăzut; kw. GASA scăzut; kx. GASA scăzut; ky. GASA scăzut; kz. GASA scăzut; la. GASA scăzut; lb. GASA scăzut; lc. GASA scăzut; ld. GASA scăzut; le. GASA scăzut; lf. GASA scăzut; lg. GASA scăzut; lh. GASA scăzut; li. GASA scăzut; lj. GASA scăzut; lk. GASA scăzut; ll. GASA scăzut; lm. GASA scăzut; ln. GASA scăzut; lo. GASA scăzut; lp. GASA scăzut; lq. GASA scăzut; lr. GASA scăzut; ls. GASA scăzut; lt. GASA scăzut; lu. GASA scăzut; lv. GASA scăzut; lw. GASA scăzut; lx. GASA scăzut; ly. GASA scăzut; lz. GASA scăzut; ma. GASA scăzut; mb. GASA scăzut; mc. GASA scăzut; md. GASA scăzut; me. GASA scăzut; mf. GASA scăzut; mg. GASA scăzut; mh. GASA scăzut; mi. GASA scăzut; mj. GASA scăzut; mk. GASA scăzut; ml. GASA scăzut; mm. GASA scăzut; mn. GASA scăzut; mo. GASA scăzut; mp. GASA scăzut; mq. GASA scăzut; mr. GASA scăzut; ms. GASA scăzut; mt. GASA scăzut; mu. GASA scăzut; mv. GASA scăzut; mw. GASA scăzut; mx. GASA scăzut; my. GASA scăzut; mz. GASA scăzut; na. GASA scăzut; nb. GASA scăzut; nc. GASA scăzut; nd. GASA scăzut; ne. GASA scăzut; nf. GASA scăzut; ng. GASA scăzut; nh. GASA scăzut; ni. GASA scăzut; nj. GASA scăzut; nk. GASA scăzut; nl. GASA scăzut; nm. GASA scăzut; nn. GASA scăzut; no. GASA scăzut; np. GASA scăzut; nq. GASA scăzut; nr. GASA scăzut; ns. GASA scăzut; nt. GASA scăzut; nu. GASA scăzut; nv. GASA scăzut; nw. GASA scăzut; nx. GASA scăzut; ny. GASA scăzut; nz. GASA scăzut; oa. GASA scăzut; ob. GASA scăzut; oc. GASA scăzut; od. GASA scăzut; oe. GASA scăzut; of. GASA scăzut; og. GASA scăzut; oh. GASA scăzut; oi. GASA scăzut; oj. GASA scăzut; ok. GASA scăzut; ol. GASA scăzut; om. GASA scăzut; on. GASA scăzut; oo. GASA scăzut; op. GASA scăzut; oq. GASA scăzut; or. GASA scăzut; os. GASA scăzut; ot. GASA scăzut; ou. GASA scăzut; ov. GASA scăzut; ow. GASA scăzut; ox. GASA scăzut; oy. GASA scăzut; oz. GASA scăzut; pa. GASA scăzut; pb. GASA scăzut; pc. GASA scăzut; pd. GASA scăzut; pe. GASA scăzut; pf. GASA scăzut; pg. GASA scăzut; ph. GASA scăzut; pi. GASA scăzut; pj. GASA scăzut; pk. GASA scăzut; pl. GASA scăzut; pm. GASA scăzut; pn. GASA scăzut; po. GASA scăzut; pp. GASA scăzut; pq. GASA scăzut; pr. GASA scăzut; ps. GASA scăzut; pt. GASA scăzut; pu. GASA scăzut; pv. GASA scăzut; pw. GASA scăzut; px. GASA scăzut; py. GASA scăzut; pz. GASA scăzut; qa. GASA scăzut; qb. GASA scăzut; qc. GASA scăzut; qd. GASA scăzut; qe. GASA scăzut; qf. GASA scăzut; qg. GASA scăzut; qh. GASA scăzut; qi. GASA scăzut; qj. GASA scăzut; qk. GASA scăzut; ql. GASA scăzut; qm. GASA scăzut; qn. GASA scăzut; qo. GASA scăzut; qp. GASA scăzut; qq. GASA scăzut; qr. GASA scăzut; qs. GASA scăzut; qt. GASA scăzut; qu. GASA scăzut; qv. GASA scăzut; qw. GASA scăzut; qx. GASA scăzut; qy. GASA scăzut; qz. GASA scăzut; ra. GASA scăzut; rb. GASA scăzut; rc. GASA scăzut; rd. GASA scăzut; re. GASA scăzut; rf. GASA scăzut; rg. GASA scăzut; rh. GASA scăzut; ri. GASA scăzut; rj. GASA scăzut; rk. GASA scăzut; rl. GASA scăzut; rm. GASA scăzut; rn. GASA scăzut; ro. GASA scăzut; rp. GASA scăzut; rq. GASA scăzut; rr. GASA scăzut; rs. GASA scăzut; rt. GASA scăzut; ru. GASA scăzut; rv. GASA scăzut; rw. GASA scăzut; rx. GASA scăzut; ry. GASA scăzut; rz. GASA scăzut; sa. GASA scăzut; sb. GASA scăzut; sc. GASA scăzut; sd. GASA scăzut; se. GASA scăzut; sf. GASA scăzut; sg. GASA scăzut; sh. GASA scăzut; si. GASA scăzut; sj. GASA scăzut; sk. GASA scăzut; sl. GASA scăzut; sm. GASA scăzut; sn. GASA scăzut; so. GASA scăzut; sp. GASA scăzut; sq. GASA scăzut; sr. GASA scăzut; ss. GASA scăzut; st. GASA scăzut; su. GASA scăzut; sv. GASA scăzut; sw. GASA scăzut; sx. GASA scăzut; sy. GASA scăzut; sz. GASA scăzut; ta. GASA scăzut; tb. GASA scăzut; tc. GASA scăzut; td. GASA scăzut; te. GASA scăzut; tf. GASA scăzut; tg. GASA scăzut; th. GASA scăzut; ti. GASA scăzut; tj. GASA scăzut; tk. GASA scăzut; tl. GASA scăzut; tm. GASA scăzut; tn. GASA scăzut; to. GASA scăzut; tp. GASA scăzut; tq. GASA scăzut; tr. GASA scăzut; ts. GASA scăzut; tt. GASA scăzut; tu. GASA scăzut; tv. GASA scăzut; tw. GASA scăzut; tx. GASA scăzut; ty. GASA scăzut; tz. GASA scăzut; ua. GASA scăzut; ub. GASA scăzut; uc. GASA scăzut; ud. GASA scăzut; ue. GASA scăzut; uf. GASA scăzut; ug. GASA scăzut; uh. GASA scăzut; ui. GASA scăzut; uj. GASA scăzut; uk. GASA scăzut; ul. GASA scăzut; um. GASA scăzut; un. GASA scăzut; uo. GASA scăzut; up. GASA scăzut; uq. GASA scăzut; ur. GASA scăzut; us. GASA scăzut; ut. GASA scăzut; uu. GASA scăzut; uv. GASA scăzut; uw. GASA scăzut; ux. GASA scăzut; uy. GASA scăzut; uz. GASA scăzut; va. GASA scăzut; vb. GASA scăzut; vc. GASA scăzut; vd. GASA scăzut; ve. GASA scăzut; vf. GASA scăzut; vg. GASA scăzut; vh. GASA scăzut; vi. GASA scăzut; vj. GASA scăzut; vk. GASA scăzut; vl. GASA scăzut; vm. GASA scăzut; vn. GASA scăzut; vo. GASA scăzut; vp. GASA scăzut; vq. GASA scăzut; vr. GASA scăzut; vs. GASA scăzut; vt. GASA scăzut; vu. GASA scăzut; vv. GASA scăzut; vw. GASA scăzut; vx. GASA scăzut; vy. GASA scăzut; vz. GASA scăzut; wa. GASA scăzut; wb. GASA scăzut; wc. GASA scăzut; wd. GASA scăzut; we. GASA scăzut; wf. GASA scăzut; wg. GASA scăzut; wh. GASA scăzut; wi. GASA scăzut; wj. GASA scăzut; wk. GASA scăzut; wl. GASA scăzut; wm. GASA scăzut; wn. GASA scăzut; wo. GASA scăzut; wp. GASA scăzut; wq. GASA scăzut; wr. GASA scăzut; ws. GASA scăzut; wt. GASA scăzut; wu. GASA scăzut; wv. GASA scăzut; ww. GASA scăzut; wx. GASA scăzut; wy. GASA scăzut; wz. GASA scăzut; xa. GASA scăzut; xb. GASA scăzut; xc. GASA scăzut; xd. GASA scăzut; xe. GASA scăzut; xf. GASA scăzut; xg. GASA scăzut; xh. GASA scăzut; xi. GASA scăzut; xj. GASA scăzut; xk. GASA scăzut; xl. GASA scăzut; xm. GASA scăzut; xn. GASA scăzut; xo. GASA scăzut; xp. GASA scăzut; xq. GASA scăzut; xr. GASA scăzut; xs. GASA scăzut; xt. GASA scăzut; xu. GASA scăzut; xv. GASA scăzut; xw. GASA scăzut; xx. GASA scăzut; xy. GASA scăzut; xz. GASA scăzut; ya. GASA scăzut; yb. GASA scăzut; yc. GASA scăzut; yd. GASA scăzut; ye. GASA scăzut; yf. GASA scăzut; yg. GASA scăzut; yh. GASA scăzut; yi. GASA scăzut; yj. GASA scăzut; yk. GASA scăzut; yl. GASA scăzut; ym. GASA scăzut; yn. GASA scăzut; yo. GASA scăzut; yp. GASA scăzut; yq. GASA scăzut; yr. GASA scăzut; ys. GASA scăzut; yt. GASA scăzut; yu. GASA scăzut; yv. GASA scăzut; yw. GASA scăzut; yx. GASA scăzut; yy. GASA scăzut; yz. GASA scăzut; za. GASA scăzut; zb. GASA scăzut; zc. GASA scăzut; zd. GASA scăzut; ze. GASA scăzut; zf. GASA scăzut; zg. GASA scăzut; zh. GASA scăzut; zi. GASA scăzut; zj. GASA scăzut; zk. GASA scăzut; zl. GASA scăzut; zm. GASA scăzut; zn. GASA scăzut; zo. GASA scăzut; zp. GASA scăzut; zq. GASA scăzut; zr. GASA scăzut; zs. GASA scăzut; zt. GASA scăzut; zu. GASA scăzut; zv. GASA scăzut; zw. GASA scăzut; zx. GASA scăzut; zy. GASA scăzut; zz. GASA scăzut;

sinusoidale hepatice sunt afectate (compromise, invadate, leziuni cicatriciale); E. pentru localizarea surselei lichidului pancreatic se recurge inițial la vizualizarea pancreasului prin Eco sau TC; 2380. R.I. analizele care trebuie efectuate la un pacient cu ascită, u.a.s.c.g.: A. analiza atentă a lichidului ascitic poate direcționa evaluarea etiologică; B. GASA crescut înseamnă că ascita este un exsudat; C. creșterea presiunii venoase sistemice sugerează congestie venoasă hepatică; D. peptida nativă cerebrală (BNP) este un hormon natural eliberat din pereții ventriculilor în timpul dilatației inimii; E. dacă nevăzibil nu s-a putut localiza sursa lichidului pancreatic, se vizualizează direct ductul pancreatic prin CPRE; F. investigații suplimentare sunt indicate doar în circumstanțe clinice specifice; 2381. R.I. analizele care trebuie efectuate la un pacient cu ascită, u.a.s.c.g.: A. în decelarea cauzei ascitei, este utilă clasificarea lichidului drept transsudat sau exsudat; B. GASA crescut exclude HTP drept cauză a ascitei; C. sindromul Budd-Chiari necesită vizualizarea venelor hepatice cu tehnici imagistice (ecografie Doppler, angiografie, TC, RMN); D. creșterea BNP este caracteristică pentru IC congestivă; E. dacă se suspectează peritonită secundară perforării unui viscer cavitat, se determină nivelul glucozei și al LDH din lichidul de ascită; 2382. R.I. analizele care trebuie efectuate la un pacient cu ascită, u.a.s.c.g.: A. lichidul de tip transsudat are GASA crescut și conținut redus de proteine; B. GASA crescut înseamnă că ascita este cauzată de creșterea p.h. din sinusoidale hepatice; C. sindromul Budd-Chiari constă în obstrucția venelor hepatice, cel mai adesea prin invazie tumorală; D. nivelul scăzut al proteinelor din lichidul de ascită înseamnă că

peritoneale se poate face prin biopsie peritoneală; F. în carcinomatoză peritoneală sunt necesare investigații pentru stabilirea naturii și a sediului tumorii primare; 2377. R.I. analizele care trebuie efectuate la un pacient cu ascită, u.a.s.c.g.: A. GASA reprezintă diferența dintre concentrația albuminei în ser și în lichidul de ascită; B. GASA se corelează invers cu presiunea portală; C. depistarea imagistică (TC sau ecografie) a unor modificări nodulare în ficat este sugestivă pentru HTP; D. uneori măsurarea presiunii venoase hepatice blocate poate fi utilă pentru a demonstra HTP; E. în ascita cu GASA crescut, nivelul proteinelor din lichidul de ascită poate furniza indicii suplimentari cu privire la etiologie; F. pentru diagnosticul citologic al carcinomatozei peritoneale, se extrag cel puțin 50 mL de lichid și se trimite pentru prelucrare imediată; 2378. R.I. analizele care trebuie efectuate la un pacient cu ascită, u.a.s.c.g.: A. GASA este utilă pentru a stabili dacă lichidul are caracter de transsudat sau de exsudat; B. se consideră GASA crescut când este $\geq 1,1$ g/dL; C. ca ultimă investigație, se poate recurge la biopsie hepatică, dacă aceasta este indicată clinic; D. nivelul crescut al proteinelor din lichidul de ascită înseamnă că sinusoidale hepatice sunt lezate; E. localizarea surselei lichidului pancreatic permite efectuarea unei rezecții chirurgicale; 2379. R.I. analizele care trebuie efectuate la un pacient cu ascită, u.a.s.c.g.: A. uneori, ascita apare ca o modificare aparent izolată, în absența unei boli subiacente evidente clinic; B. GASA este mult influențat de diureză; C. biopsia hepatică (preferabil ghidată prin Eco sau TC) poate confirma diagnosticul de ciroză și probabil că va sugera etiologia; D. nivelul scăzut al proteinelor din lichidul de ascită înseamnă că

D. a-2, b-1, c-2, d-2, e-1, f-1; E. a-2, b-2, c-1, d-1, e-1, f-2; 2374. R.I. analizele care trebuie efectuate la un pacient cu ascită, u.a.s.c.g.: A. dacă se suspectează infecție, se efectuează frotiu colorat Gram și cultură din lichidul de ascită; B. GASA reflectă gradientul de p.h. care însoțește contracțiunea p.h. portală; C. ciroza ascitică fără insuficiență hepatică (albumină normală) este întotdeauna asociată cu HTP; D. rareori, ascita apare în asocieri cu tumori ovariene benigne, mai ales fibroame (sindrom Meigs); E. GASA crescut indică în primul rând o patologie primară peritoneală (mai ales infecțioasă sau neoplazică) drept cauză a ascitei; 2375. R.I. analizele care trebuie efectuate la un pacient cu ascită, u.a.s.c.g.: A. randamentul diagnostic este maxim dacă inocularea lichidului ascitic în recipientele de cultură se face în condițiile sterile din laborator; B. GASA reflectă p.h. din sinusoidale hepatice; C. evaluarea ascitei include obligatoriu teste pentru funcția hepatică; D. în cadrul sindromului Meigs poate să apară și hidrotorace; E. pentru diagnosticarea metastazelor peritoneale se recurge inițial la biopsie peritoneală; 2376. R.I. analizele care trebuie efectuate la un pacient cu ascită, u.a.s.c.g.: A. se măsoară simultan nivelul albuminei serice pentru a calcula gradientul de albumină sero-ascitic; B. GASA se corelează cu gradientul de presiune venos hepatic; C. evaluarea ascitei include obligatoriu o procedură imagistică vizând ficatul (TC sau ecografie); D. sindromul Meigs reprezintă asocierile de tumori uterine benigne (mai ales fibroame) cu hidrotorace și/sau ascită; E. dacă citologia este negativă, diagnosticarea metastazelor

Prescurtări frecvent folosite: u. = urmărirea; c.d.u. = care dăre urmărirea; f.d. = fiind date, f.d.p. = fiind date urmărirea; f.l. = telefon/telefonare la; U.I.f.d. = Urmărirea fragmente dintr-o frază despr.

Prescurtări frecvent folosite: c.g. = cu excepția; u.a.s.c.g. = sunt urmărirea, cu excepția u.a.s.c.g. = urmărirea altele sunt corecte, cu excepția; s.c.f.g. = sunt corect formulate, cu excepția.

- D. GASA crescut și pro-BNP seric crescut, indică IC congestiv drept cauză a ascitei;
- E. când se suspectează ascită pancreatică, se determină nivelul amilazei din lichidul de ascită;
2383. R.I. analizele care trebuie efectuate la un pacient cu ascită, u.a.s.c.g.e.:
- A. lichidul de tip exsudat are GASA scăzut și conținut scăzut de proteine;
- B. GASA crescut este caracteristic pentru ascita cirotică necomplicată;
- C. mai ales pericardita constrictivă poate trece nedagnosticată;
- D. GASA scăzut sugerează că ascita nu este produsă de HTP cu acuratețe >97%;
- E. în ascita pancreatică, nivelul amilazei din lichidul de ascită este de obicei >1000 mg/dL;
2384. R.I. analizele care trebuie efectuate la un pacient cu ascită, u.a.s.c.g.e.:
- A. GASA este util pentru a diferenția ascita determinată de HTP de cea de alte cauze;
- B. GASA crescut diferențiază ascita produsă de HTP de ascita de altă cauză în >97% din cazuri;
- C. pentru punerea unui diagnostic definitiv de pericardită constrictivă pot fi necesare investigații imagistice cardiace și cateterism cardiac;
- D. GASA scăzut (<1,1 g/dL) înseamnă că ascita reprezintă un transsudat;
- E. examenul citologic poate fi util în diagnosticarea carcinomatozei peritoneale;
2385. U.f.d.f.d. investigarea unei ascite s.c.f.g.e.:
- A. în cazul unei ascite;
- B. pancreatice ascite se produce prin scurgerea lichidului;
- C. pancreatice conținând enzime;
- D. din sistemul ductal pancreatic;
- E. cel mai adesea din coada pancreasului;
2386. U.f.d.f.d. investigarea unei ascite s.c.f.g.e.:
- A. Dacă rămâne incertă cauza ascitei;
- B. investigația elafon rămâne;
- C. laparotomie, laparoscopia;
- D. cu lavaj peritoneal;
- E. pentru examenul histopatologic și cultură;
2387. U.f.d.f.d. investigarea unei ascite s.c.f.g.e.:
- A. Sire deosebite de peritonita bacteriană „spontană” (PBS), care poate complica ascita;
- B. ciroză, peritonita secundară este superată de;
- C. nivelul crescut al glucozei din;
- D. ascită nivelul LDH în ascită mai mic decât în ser;
- E. agent patogen unic pe cultura din lichidul ascitei;
2388. Cel mai adesea, ascita este manifestarea unei boli decompensate, care în majoritatea cazurilor este una dintre u.g.e.:
- A. ciroză;
- B. IC congestiv;
- C. sindrom nefrotic;
- D. carcinomatoză metastazată;
- E. lebră mediteraneană;
2389. La un pacient cu ciroză, decompensarea ascitei poate fi produsă de u. patologii asociate cu ciroza sau favorizate de ciroză:
- A. carcinom hepatocelular ocult;
- B. tromboză de venă renală;
- C. peritonită bacteriană spontană;
- D. hepatită alcoolică;
- E. infecție (virală, tuberculoză);
2390. U.f.d.f.d. etiologia ascitei s.c.f.g.e.:
- A. Dacă un pacient cu ciroză compensată și ascită minimă;
- B. dezvoltă ascită progresivă care este tot mai greu de controlat prin restricție de sodiu sau diuretic;
- C. există tentația de a atribui agravarea tabloului clinic hepatopatei progresive;
- D. dar aceasta poate fi produsă de o altă stare patologică;
- E. de regulă independentă de ciroză;
2391. U.f.d.f.d. etiologia ascitei s.c.f.g.e.:
- A. în majoritatea cazurilor, cauza ascitei este necunoscută;
- B. motiv pentru care, la pacienții cunoscuți cu boala ascitogenă;
- C. aceasta trebuie exclusă drept cauză a ascitei, întrucât de regulă ascita;
- D. este consecința unui alt proces patologic, eventual;
- E. legal de boala de bază;
2392. U.f.d.f.d. etiologia ascitei s.c.f.g.e.:
- A. Diferențierea diverselor cauze de ascită este necesară chiar de ascită este necesară chiar atunci când etiologia ascitei pare;
- B. evidentă, întrucât, de exemplu, la un pacient cu ICcg poate să;
- C. apără ascită ca urmare a presiunii crescute din vena cavă inferioară transmise retrograd în circulația portă;
- D. iar la un pacient cu ciroză, decompensarea ascitei poate fi;
- E. produsă de creșterea presiunii din portă;
2393. U.f.d.f.d. etiologia ascitei s.c.f.g.e.:
- A. Nesuspectarea unei alte cauze de agravare a ascitei la pacienții cu ciroză explică rata scăzută de succes în diagnosticarea;
- C. peritoniei tuberculoase;
- D. sau a cancerului gastric la;
- E. acești pacienți ciroza predispunând la ambele boli;
2394. R.I. faptul că anume trăsături ale lichidului de ascită pot sugera anumite diagnostice, f.d.u. începând de frază:
1. lichidul sanguinolent cu proteine >2,5 g/dL;
2. lichidul tulbur cu predominanța neutrofililor (>250/μL) și un frotiu Gram pozitiv;
3. lichidul mucinos;
- și următoarele stăruiri de frază:
- a. este sugestiv pentru pseudomixom peritoneal;
- b. indică peritonită bacteriană;
- c. apare rareori în ciroza necomplicată;
- A. a-1, b-2, c-3;
- B. a-1, b-3, c-2;
- C. a-2, b-1, c-3;
- D. a-2, b-3, c-1;
- E. a-3, b-2, c-1;
2395. R.I. faptul că anume trăsături ale lichidului de ascită pot sugera anumite diagnostice, f.d.u. începând de frază:
1. lichidul sanguinolent cu proteine >2,5 g/dL;
2. lichidul cu predominanța limfocitelor;
3. lichidul mucinos;
- și următoarele stăruiri de frază:
- a. ridică suspiciunea de tuberculoză;
- b. este sugestiv pentru peritonită tuberculoasă sau neoplazică;
- c. apare rareori în ciroza necomplicată;
- A. a-1, b-2, c-3;
- B. a-2, b-1, c-3;
- C. a-2, b-3, c-1;
- D. a-3, b-2, c-1;
- E. a-3, b-2, c-1;

Prescurtări frecvent folosite: c.g.e. = cu excepția, s.u.g.e. = sunt următoarele, cu excepția, u.a.s.c.g.e. = următoarele afirmații sunt corecte, cu excepția, s.c.f.g.e. = sunt corect formulate, cu excepția.

- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
- B. a-2, b-1, c-3;
- C. a-2, b-3, c-1;
- D. a-3, b-1, c-2;
- E. a-3, b-2, c-1;
2396. R.I. faptul că anume trăsături ale lichidului de ascită pot sugera anumite diagnostice, u.a.s.c.g.e.:
- A. există o mare variabilitate a lichidului în orice dintre stările patologice producătoare de ascită;
- B. lichidul sanguinolent cu proteine >2,5 g/dL este sugestiv pentru ciroza necomplicată;
- C. fluid tulbur cu predominanța neutrofililor (>250/μL) și un frotiu Gram pozitiv indică necesitatea tratamentului antibiotic;
- D. rareori, lichidul ascitic poate avea un aspect mucinos;
- E. aspectul mucinos este sugestiv pentru ascita pancreatică;
2397. R.I. investigarea pacientului cu ascită, u.a.s.c.g.e.:
- A. este foarte important ca, în fiecare caz, lichidul de ascită să fie examinat complet, deoarece uneori doar o singură analiză este anormală;
- B. dacă lichidul este un transsudat tipic, un număr de leucocite >250/μL este tipic pentru ciroză;
- C. la pacientul cu ascită cirotică, poate exista infecție peritoneală ocultă cu creșterea masivă ale numărului de leucocite din lichidul peritoneal;
- D. în multe din cazurile de ascită cirotică cu infecție peritoneală ocultă, frotiul colorat Gram din lichidul de ascită poate fi negativ;
- E. în ascita cirotică este obligatorie cultura atentă din lichidul peritoneal pentru descoperirea unei eventuale infecții peritoneale oculte;
2398. U.f.d.f.d. investigarea pacientului cu ascită s.c.f.g.e.:
- A. Este preferabil ca inocularea flaconelor de hemocultură cu;
- B. lichid de ascită să se facă la patul bolnavului;
- C. întrucât aceasta duce la o creștere impresionantă a;
- D. proporției de culturi pozitive la cazurile de peritonită tuberculoasă; 90% față de 40%;
- E. pozitivitate la culturile convenționale efectuate de laborator;
2399. U.f.d.f.d. investigarea pacientului cu ascită s.c.f.g.e.:
- A. Vizualizarea directă a peritoniei (prin laparoscopie) poate fi necesară întrucât;
- B. poate descoperi metastaze ovarene, tuberculoză;
- C. sau metastaze hepatice și;
- D. permite prelevarea de biopsii sub vizualizare directă;
- E. ceea ce poate spori acuratețea diagnostică a procedurii;
2400. R.I. aspectul macroscopic în funcție de etiologia ascitei, f.d.u. variante:
1. sero-citrin sau icteric;
2. tulbur sau purulent;
3. tulbur, hemoragic sau chilos;
- a. următoarele etiologii:
- b. ciroză;
- c. afecțiuni pancreatice;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
- B. a-1, b-3, c-2;
- C. a-2, b-1, c-3;
- D. a-3, b-1, c-2;
- E. a-3, b-2, c-1;
2401. R.I. aspectul macroscopic în funcție de etiologia ascitei, f.d.u. variante:
1. sero-citrin, hemoragic, mucinos sau chilos;
2. sero-citrin;
3. tulbur, hemoragic sau chilos;
- a. următoarele etiologii:
- b. neoplasm;
- c. insuficiență cardiacă congestivă;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-3, c-2;
- B. a-2, b-1, c-3;
- C. a-2, b-3, c-2;
- D. a-3, b-1, c-2;
- E. a-3, b-2, c-1;
2405. R.I. conținutul în proteine în funcție de etiologia ascitei, f.d.u. variante:
1. proteine >2,5 g/dL (50%), GASA <1,1 g/dL;
2. proteine <2,5 g/dL (100%), GASA <1,1 g/dL;
3. proteine în concentrație variabilă, adesea >2,5 g/dL, GASA <1,1 g/dL;
- a. următoarele etiologii:
- b. sindrom nefrotic;
- c. pseudochist pancreatic;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
- B. a-2, b-1, c-3;
- C. a-2, b-3, c-1;
- D. a-3, b-1, c-2;
2403. R.I. conținutul în proteine în funcție de etiologia ascitei, f.d.u. variante:
1. proteine <2,5 g/dL (95%), GASA >1,1 g/dL;
2. proteine >2,5 g/dL, GASA <1,1 g/dL;
3. proteine în concentrație variabilă, adesea >2,5 g/dL, GASA <1,1 g/dL;
- a. următoarele etiologii:
- b. peritonită pirogenă;
- c. afecțiune pancreatică;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-2, c-3;
- B. a-1, b-3, c-2;
- C. a-2, b-1, c-3;
- D. a-3, b-1, c-2;
- E. a-3, b-2, c-1;
2404. R.I. conținutul în proteine în funcție de etiologia ascitei, f.d.u. variante:
1. proteine >2,5 g/dL (75%), GASA <1,1 g/dL;
2. proteine în concentrație variabilă (1,5-5,3 g/dL), GASA >1,1 g/dL;
3. proteine în concentrație variabilă, adesea >2,5 g/dL, GASA <1,1 g/dL;
- a. următoarele etiologii:
- b. pancreatită;
- c. neoplasm;
- c. insuficiență cardiacă congestivă;
- care sunt asocierile corecte:
- A. a-1, b-3, c-2;
- B. a-2, b-1, c-3;
- C. a-2, b-3, c-2;
- D. a-3, b-1, c-2;
- E. a-3, b-2, c-1;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele, c.d.u. = care dintre următoarele; f.d. = fiind date, f.d.u. = fiind date următoarele; R.I. = referitor/referitoare la; U.f.d.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază despre.

- E. a-3, b-2, c-1;
2406. R.I. celularitate ascitei în funcție de etiologie, f.d.u. variante:
1. rareori (1%) hematii >10.000/ μ L, leucocite <250/ μ L (90%); predomină celulele mezoteliale;
2. rareori hematii >10.000/ μ L, leucocite, predomină neutrofile;
3. hematii în număr variabil, poate fi sanguinolent, leucocite în număr variabil;
și următoarele etiologii:
a. afecțiune pancreatică;
b. peritonită piogenă;
c. ciroză;
care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
2408. R.I. celularitate ascitei în funcție de etiologie, f.d.u. variante:
1. hematii >10.000/ μ L (70%), leucocite >1000/ μ L (70%), de obicei >70% limfocite;
2. foarte rar hematii >10.000/ μ L, leucocite <250/ μ L, celule mezoteliale, mononucleare;
3. hematii în număr variabil, poate fi sanguinolent, leucocite în număr variabil;
și următoarele etiologii:
a. pseudochist pancreatic;
b. peritonită tuberculoasă;
c. sindrom nefrotic;
care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
2407. R.I. celularitate ascitei în funcție de etiologie, f.d.u. variante:
1. hematii >10.000/ μ L (20%), leucocite >1000/ μ L (50%), diverse tipuri celulare;
2. hematii >10.000/ μ L (10%), leucocite <1000/ μ L (90%), de obicei celule mezoteliale, mononucleare;
3. hematii în număr variabil, poate fi sanguinolent, leucocite în număr variabil;
și următoarele etiologii:
a. insuficiență cardiacă congestivă;
b. neoplasm;
c. pancreatită;
care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-1, b-3, c-2;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
2. peritonită piogenă;
3. afecțiune pancreatică;
și următoarele investigații:
a. citologie (frotiu sau bloc celular), biopsie peritoneală;
b. colorație gram, cultură;
c. determinarea amilazei în lichidul ascitic și în ser;
care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-2, c-3;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;
2410. R.I. investigațiile recomandate în funcție de etiologia suspectată a ascitei, f.d.u. suspiciuni:
1. peritonită tuberculoasă;
2. sindrom nefrotic;
3. pancreatită, pseudochist pancreatic;
și următoarele investigații:
a. determinarea amilazei în lichidul ascitic și în ser;
b. biopsie peritoneală, colorație și cultură pentru bacili acid-alcoolo-rezistenți;
c. dacă lichidul are aspect chilos, se va efectua extracție în eter și frotiu cu colorație Sudan;
care sunt asociate corecte:
A. a-1, b-3, c-2;
B. a-2, b-1, c-3;
C. a-2, b-3, c-1;
D. a-3, b-1, c-2;
E. a-3, b-2, c-1;

Răspunsuri

- D. ...examinare pelviană, chiar dacă au avut histerectomie;
76. E. ...digestive pot afecta aportul de alimente timpuriu în evoluția bolii, determinând scădere în greutate înainte de apariția altor simptome;
77. B. la aproape jumătate din pacienții care afirmă scădere în greutate semnificativă nu există o modificare reală a greutății corporale când aceasta este măsurată obiectiv;
78. A. ...trebuie avut în vedere și la pacienții fără istoric de fumător;
79. D. alentă, mai degrabă decât efectuarea carbură (nedreptățită);
80. D. ...prevalența crescută...
81. E. cum ar fi mamografia și colonoscopia;
82. E. ...hainele îi sunt mai largi;
83. C. ...la pacienții vârstnici;
84. B. 85. E. 86. C. endocardită;
87. E. 88. B. 89. E. 90. A. 91. C. 92. E. 93. E. 94. A. 95. D. 96. B. 97. A. 98. C. 99. D. 100. C. 101. B.
- Starea de hidratare
102. A. ...scade pe măsură ce...
103. C. ...este mai mare decât...
104. ...adipos este mai mare;
105. A. ...de apă este mai mare;
106. E. sunt hidratați maximal.
Dehidratarea
107. B. ...nu respiră pe gură;
108. C. ...să nu depășească...
D. ...și hipernatriurie;
109. A. ...sunt mai ales consecința hipovolemiei;
C. ...cu cel mult 8 mEq/L/z;
E. ...reduce hipertonia mediulară;
110. E. 111. A. 112. E. 113. A. 114. B. 115. D. 116. E. 117. D. 118. B. 119. E. 120. C. 121. C. 122. B. 123. C. 124. E. 125. D. 126. C. 127. B. 128. B. 129. D. 130. C. 131. C. 132. C. 133. D. 134. C. 135. D. 136. E. 137. D. 138. E. 139. B. 140. D. 141. D. 142. E. 143. D. 144. C. 145. D.
- Edemul
146. C. ...la starea de hidratare;
E. nu doar a celui subcutanat.
147. D. ...contribuie excesul de hormoni feminini;
148. B. ...zile o scădere în greutate fără o reducere sensibilă a edemelor;
149. D. ...este revărsat lichidian pleural sau lichid pleural;
E. ...acumulare de fibroblaste;
150. C. ...este creșterea...
151. A. ...în mod tipic în regiunea peritibială, dar poate să apară și periorbital;
152. B. ...C și ciroza hepatică;
153. B. ...reducere importantă...
154. D. ...este mecanic;
155. A. ...în special seara, dată fiind poziția ridicată de peste zi;
156. E. ...care de obicei nu determină insuficiență renală;
157. A. ...să fie creșterea în...
C. ...va fi săracă în proteine;
D. ...drept local sau sistemic;
158. C. ...va fi un transsudat;
E. ...nu este modificată;
159. E. ...cu oligurie;
160. C. ...hidropotoneu, doar prima este folosită în...
E. ...fără hipotalinemie;
161. B. 162. D. 163. E. 164. C. 165. A. 166. B. 167. B. 168. A. 169. B. dispariția firelor de păr;
C. piele subțiată;
170. A. ...apese (cu degetul) tegumentul ferm și persistent (câteva zeci de secunde);
B. ...apăsare pe fața anteromedială a tibiei;
E. ...cel mai bine în regiunea pe fața anterioară a tibiei;
171. A. ...unui plan dur;
B. ...pe regiunea sacrată;
D. ...se face prin compararea cu o fotografie [godeul se evidențiază cu greutate];
E. ...în cadrul infero-extern;
172. D. ...regiunea posterioară, infero-intern, deasupra cotului;
173. A. ...se apasă posterior și inferior de maleola medială;
D. ...în regiunea infero-internă deasupra genunchiului;
E. ...observă inițial retromaleolar, ulterior pretibial;
174. B. se face prin pensarea pliului cutanat;

- E. amprentele lăsate de aceste pe peretele abdominal:
175. C. (...police și arătări):
176. B.
177. E. rămânând amprentate de degetele examinătorului.
178. D. mai ales la auscultajul unor focare situate mai deciv.
179. B. 180. E. 181. A.
182. C. ... lax, adică periorbital:
- D. ... dimineața la trezire;
- E. ... noaptea crește fluxul...
183. B. trece adesea nesusizată în așteptare:
- D. în alte teritorii (mai ales în cele situate deciv) decât cele;
184. E. dar care are un grad de RHS.
185. E. 186. A. 187. B. 188. B. 189. B. 190. A. 191. A.
192. E. ... cardiacă sau renală.
193. A. ... nu este folosit.
194. A. 195. C.
196. D. scăderea albuminelor...
- E. creșterea p.h. venoase;
197. C. scăderea fluxului limfatic;
- E. ... capilarelor pentru proteine;
198. C. creșterea naftemiei;
199. A. scăderea reninei;
- D. creșterea kalurei;
- E. edema, dacă este secundar;
200. E. scăderea Na la nivelu...
201. D. scăderea FSR:
202. C. creșterea angiotensinei;
- E. scăderea naftemiei;
203. A. scăderea volenței...
- C. scăderea FSR:
204. A. creșterea angiotensinei;
- B. scăderea Na la nivelu...
205. B. creșterea naftemiei;
- D. creșterea kalurei;
206. E. 207. E. 208. A.
209. D. ... mai mare în mediu...
210. D. ... deficitul presurilor...
211. C. ... excesul presurilor...
- D. ... care caracterizează compartimentul intravascular:
212. D. ... vasoconstrictoare...
213. A. ... prin aldosteron;
214. A. ... reține Na în...
- D. ... endotelului contribuie la vasoconstricția...
- E. ... favorizând natura...
215. A. 216. C. 217. E. 218. C. 219. E. 220. E. 221. D. 222. C. 223. D. 224. A. 225. D. 226. B. 227. D. 228. C. 229. A. 230. B. 231. D.
232. E. AVP provoacă retenție de apă.
233. B. ... contrar endotelului (care este vasoconstrictor):
234. E. ... pe arteriolele eferente;
235. E. ... de AT2 scade p.h.;
236. B. ... sifile edematoase apare rezistența la acțiune...
237. B. ... apă și vasoconstricția;
238. B. ... și vasodilație;
239. A. ... crește filtrarea...
240. A. ... inhibă reabsorbția...
241. A. ... inhibă eliberarea...
- D. ... de scăderea VSCE;
- E. ... prin creșterea reabsorbției...
242. A. ... inhibă eliberarea...
- D. ... de scăderea perfuziei...
243. D. ... vasoconstricție prin...
244. D. ... vasoconstricție renală;
245. D. ... hepatică se produce vasoconstricție renală reactivă la vasodilația sistemică;
246. D. ... sintetizată de ficat;
247. E. ... apare în gastropatia Menetrier prin pierderea de proteine în lumenul gastric;
248. A. ... interstițiale reprezintă un factor de siguranță împotriva formării edemului;
250. D. ... crește excreția K⁺...
251. B. ... conștient în vasodilație;
- D. ... induce secreția de AVP;
252. A. creșterea angiotensinei;
- B. scăderea concentrației...
- C. constricția arteriolelor eferente;
253. B. creșterea naftemiei;
- D. creșterea kalurei;
254. D.
255. C. ... un transsudat;
- D. ... cu edeme în anasarca, dar nu și în poliserioză;
256. D. ... edemul apare pe peretele abdominal, chiar dacă pacientul este în decubit dorsal;
- E. ... edemul apare la nivelul sânilor, chiar dacă pacienta...
257. C. ... este sarcă în prole;
- D. aspectul lichidului nu permite diferențierea de un exsudat;
258. C. 259. E.
260. A. ... observă inițial la față;
- B. ... rețormalelor și prețibai;
- C. ... cel inflamator se observă la locul procesului inflamator;
- D. cel venos se observă distal de obstrucția venoasă;
261. E. 262. E. 263. A. 264. D. 265. E. 266. A. 267. B. 268. B.
269. A. ... primar nu se produce o RHS importantă;
- D. ... prin creșterea filtrării...
270. C. ... de mineralocorticoidi potoli este auto-limitată;
- D. ... crește filtrarea glomerulară;
- E. ... potenți nu este suficientă pentru a produce edem;
271. B.
272. B. ... tunde să restabilească VSCE de obicei fără succes;
- C. ... de lichid, care însă este pierdut în interstițiu periferic sau în cavitățile peritoneale;
273. C. 274. B. 275. A. 276. A. 277. B. 278. D. 279. D. 280. E. 281. E. 282. E. 283. A.
284. C. ... se ameliorează;
- D. ... godeu, dar nu este moale;
285. E. ... o scădere a filtrării...
286. A. ... este mai evident seara;
- B. ... nu apare circulația venoasă...
- C. în fazele precoce se...
287. B. ... capilarele sistemice;
288. E. ... se dispune inițial retro-maloar, ulterior la gambe;
- E. ... și creșterea presiunii...
289. B. ... dispune pe spate;
290. B. ... ventricular favorizează o contracție mai puternică (legata Starling a inimii), restabilind debitul cardiac;
291. E. ... se observă doar seara;
292. B. ... în cazul că este acută;
293. C. ... cu camoză periferică;
294. E. ... staza hepatică sunt enzimele de colestază crescute;
295. E. ... cardiac recent este...
296. B. ... de sânge din teritoriul venos este în detrimentul VSCE;
297. E. enzimele de colestază pot fi crescute chiar fără creșterea bilurului direct;
298. D. ... o distribuție periferică;
299. A. ... IC atât sistolică, cât și...
300. A. 301. A. 302. A. 303. A. 304. A. 305. E. 306. E. 307. C. 308. B. 309. D. 310. A. 311. B. 312. D. 313. A. 314. A. 315. E. 316. C. 317. C. 318. A. 319. C. 320. C. 321. E. 322. E. 323. D. 324. E.
325. B. subțierea pielii;
326. A. retenție azotată cu uree crescută disproporțional față de creatinină;

Prescurtări frecvent folosite: C.G. = cu excepția; S.U.C.G. = sunt următoarele, cu excepția; U.A.S.C.G. = următoarele afirmări sunt corecte, cu excepția; S.C.L.G. = sunt corect formulate, cu excepția.

- C. adesea hiponatriemie (cu hipohidratare);
327. D. contractilitatea cardiacă nefiind afectată, poate să nu aară ortopnee, deși pacienții are congestie pulmonară;
328. A. ... intrucat este acut;
329. E. VSCE nu este scăzut;
330. E. 331. D. 332. E.
333. A. hipertensiune arterială;
334. B. 335. E. 336. B.
337. E. ... este normotensă;
338. D. ... acidoză metabolică;
- E. de obicei apare hipertensiune;
339. A. 340. B. 341. A. 342. B.
343. E. vena poate fi comprimată de un anevrism;
344. B. ... în poziție decivă;
- C. ... un membru inferior;
- E. ... cu arteriopatie obliterantă.
345. B. ... membrul afectat în jos;
346. A. ... durere, provocată de tensiunea tisulară crescută;
347. A. ... accentuează edemul;
- D. ... linu în poziție decivă;
- D. ... local are o tenă vineție, uneori eritematoasă;
348. B. ... membrele inferioare;
349. C. ... turgescență crescută;
- E. ... eritematoasă, provocată însă nu de inflamație, ci de acumularea de sânge;
350. C. 351. D. 352. D. 353. A.
354. C. anexele cutanate se reduc;
- E. ... adesea o tenă cianotică;
355. A. edemul fiind cronic, este carotat și lasă greu godeu;
- E. ... porțiunile distale ale...
356. D.
357. A. de obicei este discret până la moderat;
- C. ... la membrele inferioare;
- D. ... în a doua jumătate...
- E. de obicei se asociază cu hipertrofia secundară;
358. A. 359. A. 360. D. 361. C.
362. A. de obicei, EdSa apare în ultimele luni de sarcină;
- B. EdSa este moale;
363. A. ... EdSa este moderat;
- B. ... la membrele inferioare;
- D. de obicei, EdSa este alb;
364. A. apare după a 20-a săptămână;
- D. se asociază cu hipertensiune;
365. A. ... este apariția convulsilor tonico-clonice generalizate la...
- B. ... este sever [vital pentru mamă și, mai ales, pentru copil];
- D. ... este mai frecventă la nulipare;
366. A. nu apar convulsii;
- E. ... apar edeme generalizate;
367. B. ... membrele superioare;
- E. sclerite sunt congestionate;
368. A. ateciază jumătatea superioară a toracelui și membrele superioare;
- C. ... venele cave superioare;
- E. nu apucă să devină cartonat;
369. B. ... unei infecții locale;
- F. de obicei este asimetric;
370. D. ... pare îngroșată...
371. A.
372. C. gastrită hipertrofică;
373. B. ... mai mare decât...
- D. ... este dat de numărul de molecule care o exercită;
374. B. ... mai multe molecule...
- D. ... osmoze nu este influențată de masa dimensurii...
375. C. 376. A.
377. B. ... osmotică mai mare;
378. D. ... este mai accentuat la față, dată fiind poziția în decubit dorsal din timpul nopții;
379. C. ... la față diminuează;
- D. edemul cronic nu se observă de obicei la față;
380. C.
381. C. ... se scade prestina...
382. A. 383. D. 384. E. 385. A.
386. E.
387. C. ... responsabili pentru hiponatriemie apare de obicei în faze mai avansate ale bolii;
388. D. ... alcalioză respiratorie;
389. A. ... vasodilația sistemică;
- B. ... HTP precede instalarea...
390. C. ... vasoconstricție renală;
391. D. ... mai mică decât...
392. E. ... nu sunt turgescențe;
393. D. ... nu este crescută;
394. C. ... accentua retenția...
395. D. ... în anamneza de...
396. D. activarea SRAA;
397. B. scăderea perfuziei renale;
- C. activarea SN simpatic renal;
398. C. 399. E. 400. E. 401. C. 402. B. 403. A. 404. B. 405. E. 406. A. 407. B. 408. A. 409. E. 410. C. 411. B. 412. A. 413. E. 414. A. 415. A. 416. C. 417. E. 418. E. 419. C. GSFS. 420. B. 421. C. ... creșterea relativă...
422. E. ... nu determină...
423. D. ... (mai ales la copii);
- E. ... care tind să scade TA;
424. A. edemul este alb, moale, pufoș, deplasabil;
- C. ... funcția renală contribuie la formarea edemului;
425. A. ... diminuează la față, seara la membrele inferioare;
426. A. 427. E. 428. B. 429. D.
430. E. ... B1 poate produce afectare cardiacă de tip berberi;
431. E. ... debit crescut din...
432. A. 433. E. 434. D.
435. B. ... în teritoriile declive ale trunchiului și membrilor;
436. E. ... care crește direct...
437. C. mai ales colita ulceroasă;
- E. lumenul intestinal, proteinele exsudând din cauza inflamației;
438. C. diaree sanguinolentă;
439. D. ... asociat cu excesul de hormoni feminini și posibili și;
440. A. 441. A.
442. E. ... care împiedică fluxul...
443. B. ... sunt intacte, ceea ce;
- E. ... prin creșterea presiunii...
444. E. motiv pentru care fluxul limfatic nu poate să crească;
445. C. ... edemul este tare ferm;
446. B. ... provocă durere;
447. A. ... creșterii fluxului...
448. B. ... de regulă la nivelul capilarelor, intrucă acestea au peretele cel mai subțire;
449. B. ... agresivul celule ale sistemului de apărare/curățare;
- E. ... complicită crescută...
450. E. creșterea complicității;
451. C. care duc la distrugerea componentelor...
452. E. ceea ce scade...
453. B. 454. E. ca o consecință a reacțiilor de hipersensibilitate;
455. D. care determină semnele clasice de inflamație;
456. E. ceea ce reduce capacitatea gelului matriceal...
457. B. 458. B.
459. A. este roșu, B. este dur;
460. C. ... unei patologii locale;
- D. lasă greu sau deloc godeu;
- E. ... oncolică tisulară crescută;
461. B. este alb;
462. E. ... tursură este crescută;
463. A. apare roșeață locală;

Prescurtări frecvent folosite: U. = următoarele; C.G. = care dintre următoarele; I.d. = fiind date, I.d.u. = fiind date următoarele; I. = referitor/efectoare la; U.I.d.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază desprse.

464. A. este pruriginos sau ușor dureros;
B. ...dar apare mai ales la pleoapă și la buza superioară;
C. ...sunt frecvent afectate;
D. este fugace și recidivant;
E. ...edemul global (supragnotic);
465. C. ...edemul angioneurotic;
D. durează ore sau zile;
466. A. ...exclusiv la femei;
D. ...să fie agravată pe...
467. E. scăderea erecției...
468. D. ...și induce eliberarea...
469. E. stimulării estrogenice și/sau progesteronice excesive.
470. E. 471. A.
472. A. ...sunt normale;
473. D. ...plămânilor poate fi relativ normală, în ciuda...
474. D. 475. B. 476. A. 477. B. 478. B. 479. B.
480. B. ...dacă se menține sau se accentuează la inspirație;
E. ...se asociază, sau nu cu hipotalbuminemia importantă;
481. C. ...este prezentă în ICCg și absentă în ciroza hepatică;
482. C. ...dispare distensia...
E. până la nivelul AD.
483. D. 484. C. 485. D. 486. E. 487. B. 488. B. 489. A. 490. E.
491. D. ...și permite identificarea unora dintre stările patologice...
492. C. 493. C. 494. B. 495. C. 496. E. 497. A. 498. D. 499. A. 500. D. 501. E. 502. E. 503. A. 504. D. 505. E. 506. E. 507. E. 508. E. 509. A. 510. B. 511. A. 512. A. 513. A. 514. A.
515. D. ...apar îngroșate;
E. edemele sunt relativ dure;
516. D. vasodilatația periferică...
Febra și hipertermia
517. C. ...și de la temperatura sângelui care irigă regiunea;
518. E. cu dispararea de căldură prin piele și plămâni/ respirație.
519. E. t.o. maximă normală este 37,7°C la ora 16.00 (aceste valori reprezintă a 99-a percentilă pentru persoanele sănătoase);
520. A. ...este de 0,5°C;
521. A. ...mai multă căldură...
C. ...mai mică în cele două...
D. ...la nivelul crescut până la declanșarea menstruației;
522. C. ...temperatura crește...
D. ...corporală poate crește în...
523. E. 524. C. 525. A.
526. A. ...temperaturi corpului prin ridicarea nivelului de...
527. A. ...prin care căldura este conservată (vasoconstricție);
528. D. (prin aceeași mecanisme de păstrare a echilibrului termic ca și...
529. C. 530. A. 531. D. 532. D. 533. C. ...pacienții cu hemoragii în sistemul nervos central;
534. D. ...afecțiune hipotalamică se numește febră hipotalamică;
535. C. ...căldură mai rapid;
536. B. ...și nu răspunde...
537. A. ...este nemodificat [spre deosebire de febră];
538. A. ...nu sunt implicați proageni [spre deosebire de febră];
539. C. ceea ce nu este posibil într-un mediu cu umiditate...
540. C. 541. E. 542. E. 543. D. 544. A. 545. D. 546. A. 547. C. 548. D. 549. C. 550. E. 551. A. 552. C.
553. C. ...sunt crescute în...
554. B. ...de tip Toll sunt diferiți de receptorii pe care acționează citokinele, dar similari cu E. ...nu pot declanșa febră;
555. B. ...circumveniculare reduce capacitatea pirogenilor de a produce febră;
556. B. endotoxina determină eliberarea de proteine de fază...
557. C. ...care determină o activare masivă a celulelor T;
558. D. ...în circulația sistemică induc sinteza de PGE₂...
559. D. ...provocate de PGE₂ produsă de țesuturile periferice;
560. D. ...pot induce producția...
561. A. citokinele sunt proteine mici [10-20 kDa] care reglează...
562. B.
563. E. fără a fi însă principalul contributor la producerea febrei.
564. C. fără intermedierea organelor circumveniculare;
565. D. sau în ventriculii cerebri;
566. E. pacienții care iau gluco-corticoizi;
567. C. ...febră este puțin utilă, D. ...nu se corelează cu febra;
568. B. în unele boli virale poate să apară neutropenie;

Prescurtări frecvent folosite: p.g. = cu excepția; s.u.s.g. = sunt următoarele, cu excepția; u.a.s.c.g.g. = următoarele afirmații sunt corecte, cu excepția; s.c.f.g. = sunt corect formulate, cu excepția;

569. E. care sunt sugestive pentru o infecție bacteriană.
570. C. 571. D. 572. B. 573. C. 574. D. 575. B. 576. D. 577. D. 578. D. 579. A. 580. C. 581. C. 582. D. 583. A. 584. A. 585. E. 586. D. 587. D. 588. B. 589. E. 590. A. 591. A. 592. E. 593. C. 594. E. 595. C. 596. B. 597. E. 598. B. 599. C. 600. A. 601. A. 602. D. 603. E. 604. E. 605. C. 606. B.
Semiologie ORL și oftalmologică
607. A. 608. E. 609. C. 610. D. 611. B. 612. C. 613. C. 614. B. 615. D. 616. E. 617. A. 618. D. 619. D. 620. C. 621. C. 622. E. 623. B. 624. C. 625. B. 626. D. 627. D. 628. D. 629. A. 630. A. 631. C. 632. C. 633. D. 634. C. 635. C. 636. E. 637. D. 638. D. 639. B. 640. C. 641. E. 642. E. 643. E. 644. C. 645. C. 646. E. 647. E. 648. B. 649. E. 650. C. 651. C. 652. B. 653. D. 654. D. 655. E. 656. C. 657. B. 658. B. 659. A.
Semiologie cardiorespiratorie
Dispneea
660. B. ...metabolice crescute; D. și cresc ventilația peste nevoile metabolice;
661. D.
662. B. dispneea nu este dureroasă în sensul obișnuit al cuvântului;
663. B. asemenea durerii, implică atât percepția unei senzații...
D. ...este rareori însoțită...
664. A. 665. D.
666. C. ...pentru IVS;
D. ...sindromul hepatopulmonar; E. ...ar putea fi oxidul nitric;
667. D. ...în exces față de...
668. E. 669. E. 670. A. 671. C. 672. E. 673. A.
674. D. ...crește descărcarea...
E. ...de activare excesivă sau anormală a centrilor...
675. A. în ciuda variațiilor...
C. rezonabilă între severitatea;
676. C. ...mai puțin compliant...
E. ...fluxul de aer este crescut...
677. C. ...o creștere a...

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; i.d. = fiind date, i.d.u. = fiind date următoarele; r.t. = referitor/referitoare la; U.i.d.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază despre;

705. B. ...sănătoși constă în nivelul de efort la care apare;
706. E. ...apare și în repaus;
707. E. 708. D.
709. B. radiologic se evidențiază accentuarea progresivă a...
C. ...spre bazele plămânilor;
D. ...tusea neproductivă este frecventă;
E. ...sunt din ce în ce mai "albe" (mai opace) spre baze.
710. A. (...edemul interstițial);
D. ...sporește fatigabilitatea...
711. B. ...mai târziu decât...
D. ...când aluneacă de pe perne...
E. cu timpul, pacientul nu mai tolerează deloc clinostatismul și trebuie să-și petreacă noaptea în șezut;
712. C. ...împinsă în torace;
E. ...să scadă în intensitate;
713. A. ...lichidului interstițial din abdomen și din membrele inferioare spre torace;
C. ...scad întoarcerea venoasă...
E. ...de congestia pulmonară fiind să scadă în intensitate;
714. C. ...denumită astm cardiac;
715. B. ...nu este provocată...
E. hipoxemia nocturnă apare...
716. B. ...edemul hidrostatic...
D. scăderea ventilației prin...
E. ...stimulării adrenergice a...
717. A. 718. A. 719. C.
720. C. ...la baza și progresează ulterior spre vârturi;
D. ...aparitia edemului alveolar;
721. B. EPA se asociază cu raluri pe ambele câmpuri pulmonare;
C. ...relurile urcă pe măsură...
D. ...unui fluid serohemoragic;
722. C. ...mai ușoare de IVS...
D. ...prin venele pulmonare, nu prin venele bronșice;
E. ...cel mai bine în inspirație;
723. A. ...intensitate medie-mică;
C. alveolare apar doar în EPA;
D. ...prin desinderea interstițiului pulmonar edematizat;
724. A. ...de subcrepitante;
B. originea lor este în interstițiu mai degrabă decât în bronhii;
C. ...la bazele câmpurilor;
D. ...drenează în AS, nu în AD;
E. ...creșterii drenajului...
725. B. mai rar, sunt generate...
C. ...de matitate la percua...
726. C.
727. B. ...și compresia căilor...
728. C.
783. A. ...sau respirație cicălică;

Prescurtări frecvent folosite: u. = următoarele; c.d.u. = care dintre următoarele; i.d. = fiind date, i.d.u. = fiind date următoarele; r.t. = referitor/referitoare la; U.i.d.f.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază despre;

- B....de scăderea sensibilității...
D....și prelungirea timpului...
784. A.
785. B. hiperventilația acută și cronică poate să fie indusă și de emboliile pulmonare recidivante, nu doar de tulburarea anxioasă;
D....adesea ascuțită, trecătoare și cu localizare variabilă;
E....de tip repolarizare precoce pot sugera natura psihogenă...
786. A....de hiperventilația acută și cronică nu sunt utile pentru a diferenția între tulburarea anxioasă și alte afecțiuni;
C....ECG, acestea vizează cel mai adesea repolarizarea;
D....neregulată indică originea...
E....depresiei și/sau a anxietății poate face ca dispneea resimțită de un pacient cardiac sau respirator să fie mai intensă decât ar justifica-o severitatea leziunilor organice;
787. C....creșterea impulsului...
788. A. 789. E. 790. D. 791. E. 792. E. 793. B. 794. A. 795. E. 796. E. 797. C. 798. A. 799. B.
800. D influențează puțin severitatea dispneei și a...
E....dispneea nu este hipoxemia.
801. E. 802. D. 803. C.
804. B....mai frecvent decât...
D....de atomul de fier din hemoglobină, iar CO₂ legându-se de lanțurile proteice ale globinei
805. E....de creșterea presiunii...
806. E....de dispnee sunt astmul și BPOC, mai rar bronsectazile;
807. E....pregnanță în expirație;
808. A....pentru astm,
809. C....crește presiunea...
810. A. 811. E. 812. B. 813. C. 814. C. 815. D. 816. E. 817. B. 818. B. 819. B. 820. A. 821. A. 822. C. 823. B. 824. A. 825. E. 826. E. 827. E. 828. D. 829. B. 830. C. 831. A. 832. C. 833. D. 834. C. 835. E. 836. C. 837. E. 838. E. 839. B.
840. B....Răspund sugerează scleroză sistemică, potențial...
841. C....în decubit dorsal;
842. D....este un semn de travaliu respirator crescut;
843. B....pentru astm, dar cu examen fizic și probe funcționale pulmonare normale.
D....pentru sarcoidoză,
E....de aer rece poate fi...
928. A....este durată tusei;
B....fumatul, IECA și IACRS;
C....utile pentru diagnosticarea astmului și a PPI;
E....este sugestivă pentru secrețiile retronazale;
929. A....mai ales dacă tusea persistă de 3 săptămâni;
D. metacolina poate fi folosită drept stimul bronhocostrictor;
E....pentru secrețiile retronazale;
930. D. 931. A. 932. D. 933. C.
934. D. dacă pacientul fumează;
935. C....cu simptome sugestive pentru reflux gastroesofagian;
936. C....este asociată cu pirozis sau senzație de regurgitare;
E....la un IECA sau tumează;
937. B. 938. D. 939. D. 940. A. 941. A. 942. A. 943. B. 944. D. 945. D. 946. D. 947. A. 948. D. 949. E. 950. B. 951. E. 952. E. 953. C. 954. D. 955. C. 956. D. 957. D.
958. A....complicație obișnuită...
C....creșterii marcale a...
959. C....scăderii intoleranței...
D....poate favoriza apariția...
E....costile ca urmare a tusei trebuie să ridice suspiciunea de fracturi patologice;
E....pulmonar distins sau conținutul unui chist hidatic;
961. E. 962. D. 963. A. 964. C. 965. E. 966. C. 967. E. 968. A. 969. A. 970. E. 971. C. 972. A. 973. C. 974. D. 975. D.
E....după evacuarea unei anumite cantități de lichid;
902. E. 903. E. 904. E. 905. E. 906. A.
907. B....cavernă (...), pulmonară mare (p6 cm diametru);
D. fie conectată la calea respiratorie printr-o bronhie peremabibilă;
E....să poată pătrunde și reverboara (în această cavitate).
908. B. 909. D. 910. B. 911. E. 912. B. 913. E. 914. B. 915. A. 916. B. 917. E. 918. E. 919. B. 920. C. 921. E. 922. D. 923. A. 924. A. 925. B. 926. A.
927. A....examenul fizic sunt decisive în stabilirea etiologiei sau măcar în orientarea investigațiilor;
B....nu exclude aceste...
D....pentru sarcoidoză,
E....este sugestivă pentru endometrioza pulmonară;
976. B. cea mai de temut cauză este cancerul bronhopulmonar;
977. A....alveole până la glaciă;
B....mai ales de cantitatea de sânge expectorată;
C....pe identificarea sursei de sângere;
978. E. endometrioza pulmonară este o cauză rară de hemoptizie;
979. B....pacientul va fi speriat chiar dacă expectorează o...
C....și hipoxemie instalate brusc în primele 100 zile după un transplant medlar;
D....produce hemoptizie mai ales dacă evoluează cu abcedare și eventual cavitare;
E....este sugestivă pentru endometrioza pulmonară;
976. B. cea mai de temut cauză este cancerul bronhopulmonar;
977. A....alveole până la glaciă;
B....mai ales de cantitatea de sânge expectorată;
C....pe identificarea sursei de sângere;
978. E. endometrioza pulmonară este o cauză rară de hemoptizie;
979. B....pacientul va fi speriat chiar dacă expectorează o...
C....și hipoxemie instalate brusc în primele 100 zile după un transplant medlar;
D....produce hemoptizie mai ales dacă evoluează cu abcedare și eventual cavitare;
E....este sugestivă pentru endometrioza pulmonară;

Prescurtări frecvent folosite: S.G. = cu excepția, S.U.G. = sunt următoarele, cu excepția, U.A.S.C.G. = următoarele afirmații sunt corecte, cu excepția, S.C.F.G. = sunt corect formulate, cu excepția.

980. B....pacientul nu evaluează cu fidelitate cantitatea de sânge...
D....au mai ales pneumonie cu *Staphylococcus aureus*;
981. A....culcare roșu aprins;
B. volumul hemoptiziei este important în a evalua cât de urgent trebuie întreprinse măsurile de diagnostic și tratament;
D....cu bacili gram negativi;
982. A. chiar și în cantitate mică, poate semnaliza boli grave.
D....cu *Klebsiella pneumoniae*;
E. hemoptiza zisă idiopatică este provocată probabil de leziuni subtile ale căilor respiratorii sau ale parenchimului;
983. E. 984. E. 985. D.
986. B. căile respiratorii sunt...
987. A....bronhiile mici și medii;
E....pentru fibroza chistică;
988. C....produse de obicei prin ruptura unor vase de sânge;
E....în bronșia cronică sunt *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Moraxella catarrhalis*,
989. D....adesea situate central;
990. A....produsă de un cancer;
991. A....nu este principala...
992. A. cancerul bronhopulmonar nu are foarte frecvent hemoptizia printre manifestările inițiale;
B....căile respiratorii proximale;
993. E. 994. E.
995. E. rareori drept sânge roșu aprins;
996. E. și un aspect de infiltrat de lob superior pe radiografie;
997. B....cu infarct pulmonar;
E. HITAP de altă cauză decât TEP rareori provoacă hemoptizie;
998. A. 999. C.
1000. E. nicotină nu produce exsanguinare (sau doar rareori);
1001. E. HM nu produce decompensare hemodinamică (deci fără rată);
1002. D. 1003. C. 1004. C.
1005. B....ales bronhiile medii;
1006. E. 1007. E. 1008. E.
1009. D. 1010. B. 1011. E.
1012. A. 1013. C. 1014. E.
1015. A. 1016. A. 1017. B.
1018. C. 1019. D. 1020. D.
1021. D. a unei hemoragii digestive superficiale masive...
1022. B....roșu închis și pH acid;
D....electroază bronhoscopice;
1023. C....confuzie cu epistaxis;
D....cu radiografia toracică, adesea urnată de o TC;
1024. B....este fumatur;
D....electroază o TC toracică;
1025. B....factor de risc în primul rând pentru bronșita cronică și pentru cancerul bronșic;
1026. D. TC de înaltă rezoluție este procedura diagnostică...
1027. D....care pot susține diagnosticul de neoplazie toracică;
1028. C....indică o sângere amănunțioasă de viață;
1029. B....și are pH alcalin;
C....vizează în primul rând aparatul respirator și cardiac;
D....neoplazie este relevant pentru explicarea unei hemoptizii;
1030. E. ca și cultură din spută;
1031. D. 1032. E. 1033. C.
1034. B. 1035. E. 1036. C.
1037. A. 1038. C. 1039. E.
1040. B. 1041. A. 1042. A.
1043. C. 1044. E. 1045. C.
1046. A. 1047. B. 1048. E.
1049. D. 1050. B. 1051. B.
1052. C. 1053. E. 1054. C.
1055. E. 1056. C. 1057. B. 1058. D.
1059. B....de fumat care se;
D. crescut de carcinom bronșic;
E. iar TC nu este fidelă...
1060. B.
Cianoză
1061. C....după expunerea la anumite medicamente;
1062. A....din sângele capilar depășește 4 g/dL;
1063. A....este nu procentul de Hgb redusă din cantitatea totală de Hgb, ci cantitatea absolută de Hgb redusă;
1064. B....examinarea mucoaselor bucale și a conjunctivelor decât examinarea pielii;
E....determină o culcare roșu-crescă a pielii (nu cianoză);
1065. B....poate accentua...
1066. B....hipoxemie cronică...
D. \$...vena portă și vena...
1067. D....este arterioleconstricția normală provocată de expunerea la frig rece;
E....nu se asociază cu...
1068. D....la frig rece;
1069. D....provocat de obicei de o cardiopatie congenitală;
E....prin sunt apare tardiv în DSA (când se instalează HITAP producând inversarea șuntului);
1070. C....de creșterea cantității de hemoglobină redusă;
E. în vasele de sânge mici din aceste regiuni;
1071. D....poate fi mică;
E. iar cianoză nu este vizibilă;
1072. D. pentru apariția cianozelor, chiar dacă nu există o;
1073. C....creșterea cantității...
D....a dilatării venulelor...
1074. D. 1075. B. 1076. C.
1077. E. 1078. C. 1079. D.
1080. E.
1081. E....frecvente în telangiectazia hemoragică ereditară;
1082. E. 1083. C. 1084. A.
1085. A. 1086. B. 1087. D.
1088. E. 1089. D. 1090. C.
1091. E....o consecință anterogradă a ICS și retrogradă a ICD;
1092. E. poate fi provocată de bolile pulmonare;
1093. E. 1094. C. 1095. C.
1096. B. cianoză este proporțională cu gradul stenozei și cu poliglobulia secundară;
E....în poziția „pe vine”;
1097. A. 1098. A. 1099. E.
1100. A. 1101. E. 1102. C.
1103. A. 1104. B. 1105. B.
1106. A. 1107. E. 1108. B.
1109. B. 1110. C. 1111. E.
1112. E. 1113. D.
1114. B....cu boală pulmonară, cum ar fi supurațiile pulmonare;
1115....vasodilatație la...
1116. B. 1117. B.
1118. D. bronsectazii;
1119. A....în districte distale ale caselor lungi ale membrilor;
1120. B. 1121. C. 1122. A.
1123. E. 1124. C. 1125. D.
1126. A. 1127. E. 1128. D.
Ducea toracică
1129. B....cele cardiovascular; 1130....esofagiene din cauza unor vărsături violente;

Prescurtări frecvent folosite: U. = următoarele, C.U. = care dintre următoarele, I.C. = fiind date, I.C.U. = fiind date următoarele, I.L. = referitor/referitoare la, U.I.D. = următoarele fragmente dintr-o frază desprind.

- E. ...organelor subdiafragmatice nu este asociată cu efortul;
1131. E. ...din herpes zoster are o distribuție metamerică;
1132. E. 1133. B. 1134. D. 1135. E. 1136. E. 1137. E. 1138. E. 1139. A. 1140. E. 1141. C. 1142. A. 1143. A. 1144. A. 1145. B. 1146. E. 1147. A. 1148. D. 1149. B. 1150. E. 1151. D. 1152. B. 1153. D. 1154. B. 1155. B.
- DurTor de cauză cardiacă
1156. B. când se accentuează și mai mult discrepanța dintre:
D. ...de irigație al unui miocard hipertrofiat [consecință a S(Ao)];
1157. D. ...este agravată de...
E. ...este mai rară și mai ușoară (sau chiar absentă) în uremie;
1158. B. mai rară și mai ușoară (sau chiar absentă) în TimpC;
C. este agravată de respirația...
D. de obicei durează ore-zile;
1159. C. ...cu evoluție cronică;
1160. C. poate fi absentă în...
- DurTor de cauză aortică
1161. B. uneori DAO evoluează...
1162. B. ...alunge rapid...
C. durerea nu este ameliorată de modificarea poziției;
1163. B. ...DAO începe abrupt;
1164. D. frecvent, durerea...
1165. A. ...are o evoluție acută;
E. radiografia toracică poate doar sugera diagnosticul de DAO;
1166. B. ...nu este ameliorată...
D. afecțiunile congenitale de țesut conjunctiv sunt un...
1167. B.
1168. D. eventuala durere este persistentă, constantă;
DurTor de cauză pleuropulmonară
1169. A. ...se instalează brusc;
C. ...din cauza nepotririilor dintre ventilație și perfuzie;
D. scade PaCO₂ din cauza...
1170. A. ...localizată retrosternal; E. durează minute-ore;
1171. D. 1172. E. 1173. D. 1174. D. 1175. B. 1176. B. 1177. D.
1178. A. ...durere laterotoracică cu caracter pleuritic;
1179. D. ...de inspirație și de...
E. adesea este localizată...
1180. A. ...cu caracter pleuritic;
DurTor de cauză esofagiană
1181. B. 1182. E. 1183. B. 1184. B. ...mai mult de 10...
1185. D. se ameliorează când...
1186. B. apare mai ales dacă...
C. este mai puțin dependentă de tipul alimentelor;
1187. C. ceea ce întârzie esofagul este mai ales acidul gastric, mai puțin alimentele acide;
1188. A. poate surveni în prezența sau în absența refluxului acid;
C. ...sublingual accentuează durerea este atipică;
D. ...confuzia cu durerea anginoasă;
D. absența dependenței poziționale o diferențiază...
1189. C. nu este influențată de poziție;
E. este localizată retrosternal;
DurTor de cauză digestivă
1190. B. ...și reapare la 60-90 min după mese [când începe evacuarea stomacului în duoden];
1191. A. durerea se produce la o oră sau mai mult după ingestia...
DurTor de cauză neuro-musculo-scheletică
1192. D. ...de mișcare și poate fi stărnită sau accentuată prin apăsarea zonei respective;
1193. E.
1194. D. este unilaterală...
1195. B. doar ocazional sunt...
1196. A. cam 10% dintre pacienți care se prezintă la...
1197. D. ...retrosternal, mai ales dacă pacientul s-a documentat despre boala coronariană;
1198. D. ...localizare, iradiere, caracter sunt adesea relatate de pacienții care s-au documentat despre boala coronariană;
1199. D. ...când hiperventilația determină anomalii ST-T;
1200. A. durerile pot ține câteva ore, mai rar zile;
1201. A. 1202. D.
- Diagnosticul diferențial al DurTor
1203. C. IMA, DAO și TEP;
1204. E. 1205. A. 1206. B. 1207. E. 1208. D. 1209. A. 1210. B. 1211. C. 1212. E.
1274. C. ...creșterea volumului și a contractilității VS după o...
D. ...mai ales cele ventriculare;
1275. C. 1276. D.
1277. B. ...organice cardiace (de exemplu, mixom atrial);
1278. E.

Prescurtări frecvent folosite: C.E. = cu excepția; S.U.C.E. = sunt următoarele, cu excepția; U.A.S.C.E. = următoarele afirmatii sunt corecte, cu excepția; S.C.F.C.E. = sunt corect formulate, cu excepția.

- C. ...palpitații prin creșterea frecvenței extrasistolelor;
D. ...palpitații sunt extrasistolele atriale și ventriculare;
1278. E. ...generală, palpațiile au o cauză psihoemoțională;
1279. B. ...de poziție;
C. ...nu provoacă palpații;
E. ...tahicardie sinusală;
1280. D. ...mai ales cu depresia, anxietatea (inclusiv tulburarea de panică) și somatizarea;
1281. E. ...mai mare de a...
1282. C. 1283. C. 1284. C. 1285. A.
1286. C. ...hipotensiune...
1287. B. cum ar fi insuficiența aortică;
E. ...mișcărilor foarte ample ale...
1288. E. 1289. A. 1290. B. 1291. E.
1292. B. depleția de potasiu...
1293. C.
1294. D. ...în timpul accesului...
1295. B. 1296. D. 1297. D. 1298. C.
1299. E. secundară prestulii crescute din atriul stâng și din capilarele pulmonare.
1300. D. ...pacienți cu BCI sau cu factori de risc pentru BCI;
1301. D. ...palpitații nu au antonii severe sau boala cardiacă...
1302. E. 1303. C.
1304. C. ...permit înregistrarea ECG în timpul episoadelor...
- Tulburări de ritm și de conducere
1305. D. 1306. E. 1307. B. 1308. B. 1309. D. 1310. A. 1311. B. 1312. B. 1313. D. 1314. E. 1315. C. 1316. A. 1317. C. 1318. A. 1319. C. 1320. A. 1321. D. 1322. E. 1323. C. 1324. D. 1325. B. 1326. A. 1327. C. 1328. D. 1329. C. 1330. E. 1331. C. 1332. B. 1333. C. 1336. C. 1337. C. 1338. E. 1339. D. 1340. B. 1341. D. 1342. C. 1343. A. 1344. C. 1345. D. 1346. C. 1347. A. 1348. D. 1349. E. 1350. B. 1351. C. 1352. E. 1353. A. 1354. C. 1355. D. 1356. E. 1357. C. 1358. C. 1359. C. 1360. D. 1361. E. 1362. D. 1363. A.

Semnologia digestivă

- Durerea abdominală
1409. C. 1410. B. 1411. A. 1412. A. 1413. C. 1414. D. 1415. D. 1416. C. 1417. D. 1418. E. 1419. D. 1420. B. 1421. A. 1422. B. 1423. B. 1424. C. 1425. C. 1426. C. 1427. D. 1428. A. 1429. C. 1430. C. 1431. E. 1432. C. 1433.
C. ...se intensifică la...
D. este accentuată de palpate;
E. ...instalează rapid atunci...
1434. A. este surdă, persistentă, adesea de intensitate moderată;
B. este localizată în dreptul regiunii inflamate;
C. este accentuată de mișcare;
D. ...instalează rapid atunci...
E. este de mică intensitate sau absentă (cel puțin inițial) atunci când este provocată de urină;
1435. B. ...se intensifică la...
C. este accentuată de tuse;
D. este mai intensă când...
E. este de mică intensitate sau absentă (cel puțin inițial) atunci când este provocată de sânge;
1436. A. este percepută la nivelul zonei bolnave;
C. este accentuată de strănuit;
D. este mai intensă...
E. poate să treacă neobservată atunci când este produsă de...
1437. E. în cavitatea peritoneală.
1438. B. ...mici de secreție gastrică sterilă, dar acida, C. ...mult mai multă durere...
E. ...dacă puternic contaminate.
1439. C. 1440. E. 1441. E. 1442. C. 1443. D. 1444. B. 1445. A.
1446. B. ...ei depinde de...
C. ...sistemului nervos;
D. poate fi minimă sau absentă în cazul unui ulcer perforat...
1447. B. este localizată în dreptul teritoriului afectat;
D. poate fi minimă sau absentă în cazul unui apendicite...
E. ...mult atenuată în cazul...
F. poate fi minimă sau nedeterminabilă la pacienții...
1448. C. vârstnici;
1449. B. ...ar fi un ulcer perforat, poate fi însoțită de...
E. ...sau la pacienții psihici.
1450. C. ...din amonte de zona...
E. nu este la fel de bine localizată ca și durerea...
1451. A. ...obicei perionbilicală sau supraombligă;
B. este imprecis localizată;
C. ...are caracter colicativ;
D. ...poate să diminueze;
1452. C. 1453. E.
1454. A. ...mai mică decât...
D. este adesea localizată în regiunea subombligă;
1455. C. 1456. C. 1457. A. 1458. B. 1459. E. 1460. A. 1461. C. ...la bărbați vârstnici cu adenom de prostată;
E. ...și febra, cu alterarea stării de conștiință la pacientul...
1462. E. singura manifestare poate fi agitația.
1463. C.
1464. D. durerea poate fi continuă sau discontinuă (cu caracter de crampe);
1465. D. ...de hiperperistaltism, nu de inflamația peritoneului;
1466. D. neînsoțite de...
1467. A. ...DurAbd difuză;
1468. C. ...cel mai adesea la ora actuală ca efect advers al tratamentului anticoagulant;
1469. E. a mușchilor din alte părți.
1470. C. pneumonie;
1471. C. ...mai multe ore;
1472. D. ...abdominală este persistent pe întreaga durată a ambelor faze respiratorii;
1473. B. ...abdomenul superior;
D. ...toracice nu accentuează sau chiar ameliorează durerea;

Prescurtări frecvent folosite: U = următoarele; C.D.U. = care dintre următoarele; I.d. = fiind date, I.D.U. = fiind date următoarele; I.L. = referitor/efectoare la; U.I.d.I.d. = următoarele fragmente dintr-o fază despr;

1474. B. ...duree în hipocondrul drept, iradiază supraclavicular; D. ...cu originea în abdomen adesea accentuează durerea; E. ...cu hiperestezie în ...
1475. D. ...prin compresia sau iritația rădăcinilor nervoase;
1476. D. ...este intensificată ...
1477. C. ...duree în hipocondrul drept, cu iradiază subscapulară; D. ...diminuează la inspirație;
1478. A. infarct miocardic; C. pneumonie;
1479. C.
1480. D. anomalii metabolice pot fi declanșate de o patologie intraabdominală generatoare de durere;
1481. E. 1482. C. 1483. A.
1484. B.
1485. D. nu se asociază cu ...
1486. E. nu are nicio legătură cu ingestia de alimente;
1487. A. de obicei este limitată la distribuția unui anumit nerv periferic;
1488. D. nu împiedică respirația;
1489. E. ...veche a nervilor senzoriali;
1489. B. (...unei artroze);
1489. E. este agravată de ...
1490. G. este influențată de ...
1491. D. ...muscular asociat poate fi ameliorat de palparea ...
1492. E. are un evident determinant psihosomatoformal;
1493. D. ...de SII presupune excluderea unor anomalii organice demonstrabile;
1494. A. ...de suprasolicitare psihosomatoformală;
1494. C. greața și vărsăturile sunt rare; D. ...la palpare localizată este inconstanță sau absentă;
1495. B.
1496. A. o examinare de doar câteva minute este suficientă la pentru a stabili gravitatea situației și necesitatea unei intervenții urgente;
1497. B. în această situație nu există contraindicații pentru operație;
1498. A. ...doar în peritonita chimică severă cu debut brusc; poate avea consecințe fatale;
1499. A.
1500. B. hemoragia digestivă poate fi adesea tratată prin metode nechirurgicale;
1501. E. folosirea cateterului pentru stabilirea diagnosticului nu oferă avantajă față de simpla evaluare clinică;
1502. E. SII este una dintre cele mai frecvente cauze de Durabd;
1503. E. ...nu trebuie evitate ...
1504. C. istoricul pacientului este adesea mai importantă ...
1505. C. 1506. A. 1507. A. 1508. A. 1509. E. 1510. E. 1511. E. 1512. A. 1513. B. 1514. C. 1515. A. 1516. D. 1517. D. 1518. C. 1519. E. 1520. C. 1521. D. 1522. D. 1523. E. 1524. C. 1525. C. 1526. C. cum ar fi apendicita perforată;
1527. B. diferențierea durerii parietale de cea viscerală; D. care presupune contracția mușchilor abdominali;
1528. C. dacă aceasta este de origine parietală, dar nu și dacă este de origine viscerală;
1529. B.
1530. A. ...inspecție a pacientului poate furniza indicii valoroși;
1531. D. în amonte de ...
1532. A. ...cu cât este mai blândă, riguroasă și rădătoare;
1533. D. ...doar în peritonita chimică severă cu debut brusc;
1534. A. ...la decompresie este sugestivă pentru perforanță;
1535. A. ...este puțin revelatoare la ...
1536. E. ...este mai declivă a peretelui ...
1537. D. 1538. E.
1539. C. ...intestinel (ileus) ...
1540. C. 1541. C. 1542. A. 1543. B. 1544. C. 1545. B. 1546. A. 1547. D.
1548. B. ...și suprapubian; C. ...conștient în sus și adesea ...
1549. B. ...peste 7 L);
1550. B. 1551. E. 1552. B. 1553. B. 1554. B. 1555. C. 1556. A. 1557. D. 1558. B. 1559. E. ...bolilor pelvine;
1560. D. ...burtă trebuie evitată;
1561. E. ...de pancreatita acută;
1562. E. ...de traumatism;
1563. A. leucocitoza nu trebuie să fie niciodată singurul factor pe baza căruia să se decidă dacă operația este indicată;
1564. E. care poate fi omisă prin alte metode de diagnostic;
1565. E. 1566. C. 1567. D. 1568. D. ...trebuie supravegheat și reexaminat periodic;
1569. B. ...produsă de obicei de impactarea bolului alimentar;
1570. B. deoseol, odinofagia ...
1571. E. ...esofagiană nu determină obstrucție esofagiană;
1572. C. tetanos;
1573. D. ...doar în peritonita chimică severă cu debut brusc;
1574. B. nu este însoțit de anomalii ...
1575. B. dimensiunea lumenului;

Prescurtări frecvent folosite: S.E. = cu excepția; s.e. = sunt următoarele; cu excepția; u.s.c. = sunt următoarele afirmatii sunt corecte; cu excepția; s.c. = sunt corect formulate, cu excepția.

1578. A. 1579. E. 1580. B.
1581. E. 1582. A. 1583. B.
1584. A. ...mai adesea prin leziuni nervoase sau orofaringiene, mai rar prin leziuni musculare;
1585. A. 1586. C. 1587. D. 1588. E. 1589. D. 1590. D.
1591. A. 1592. A. NC5;
1593. C. 1594. D. 1595. C. 1596. A. 1597. C. 1598. E. 1599. A. 1600. C. 1601. C. 1602. E. 1603. D. 1604. D. 1605. E. 1606. D. 1607. C. 1608. D. 1609. E. 1610. D. 1611. B. ...faringiană organică;
1612. C. 1613. E.
1614. C. ...cartilajului cricoid;
1615. B. ...imediat deasupra ...
1616. C. ...distensibilitate redusă a ...
1617. D. spasmi cricofaringiani se poate produce la persoane normale în timpul manevrei Valsalva;
1618. C. ...spasm cricofaringian trece în mod normal în disfație;
1619. E. 1620. A.
1621. C. ...nervi ipsilaterali;
1622. A. ...suprahoidien produce disfație severă întrucât SES nu se deschide la înghițire;
1623. E. ...a osului hioid și ...
1624. C. ...porțiunea cervicală ...
1625. B. ...mai mare de a ...
1626. C. ...inervației inhibitoare numai pentru corpul esofagian;
1627. A. ...sunt printre cele mai frecvente cauze ale disfației;
1628. B. ...contracții neperistaltice și lipsa de relaxare a SEI;
1629. C. ...distensia acestora;
1630. C. 1631. A. 1632. A. 1633. A. 1634. E. 1635. E. 1636. D. 1637. E. 1638. E. 1639. D. 1640. D. 1641. D. 1642. A. 1643. B. 1644. D.
1645. B. ...este la nivelul sau sub localizarea percepută a disfației;
1646. C. ...sunt Candida, VHS, VCM.
1647. E. ...leziuni esofagiene distale;
1648. C. de tipul de alimente;
1649. A. istoricul poate furniza un diagnostic prezumtiv la >80% din pacienți;
1650. A. ...oportunitate sau tumor;
1651. C. ...se află limfonemle;
1652. A. ...gratul disfației, este foarte sugestivă pentru cancer;
1653. A. ...scleroza sistemică, lichidele nu provoacă disfație când pacientul este în poziție ridicată întrucât pot aluneca în jos ajutate de gravitație;
1654. B. ...substane caustice;
1655. A. 1656. B. 1657. D. 1658. A. 1659. A.
1660. A. ...de paralizare bulbară sau pseudobulbară;
1661. C. boli cutaneo-mucoase;
1662. D. atrofia limbii;
1663. E. unei boli identificabile și tratabile;
1664. B. ...investigație este EDS;
1665. D. ...poate furniza ...
1666. A. ...este investigarea videoendoscopică a deglutiției;
1667. C. ...prelevarea de rutină a biopsiilor din mucoasa esofagiană chiar dacă nu se observă endoscopic leziuni;
1668. B. ...mai ușor investigație diferentă dacă disfația este mecanică sau motorie;
1669. B. ...tot mai frecvent de ...
1670. E. 1671. E. 1672. D. 1673. D. 1674. D. 1675. B. 1676. A. 1677. A. 1678. B. 1679. C. 1680. A.
1681. B. scăderea în greutate ...
1682. E. în special la copii;
1683. B. ...se află VCM și VHS;
1684. A. ...scade tonusul ...
1685. A. ...scade tonusul ...
1686. E. 1687. E. 1688. A. 1689. D. 1690. A. 1691. D.
1692. A. 1693. A. 1694. A. 1695. A. 1696. C. 1697. D. 1698. E. 1699. B. 1700. E. 1701. A. 1702. B. 1703. B. 1704. B. 1705. A.
1706. D. ...mai adesea la copii;
1707. A. ...prin mecanism reflex;
1708. C. ...și vărsături prin hipertensiunea intracraniană;
1709. A.
1710. E. contraceptive;
1711. E. 1712. E.
1713. E. ...poate produce pierderi semnificative de lichide și tulburări electrolitice;
1714. E. afectuni tiroidiene;
1715. A. ...provoacă greață acționând asupra ariei postrema;
1716. D. felul în care vărsătură influențează durerea abdominală;
1717. D. 1718. D. 1719. E. 1720. C. 1721. D. 1722. A. 1723. E. 1724. B. 1725. C. 1726. C.
1727. C. ...se măsoară timpul de evacuare din stomac a unor alimente marcate radioactiv;
1728. B. ...investigații imagistice;
1729. E. 1730. C. 1731. E. 1732. E. 1733. B. 1734. D. 1735. C. 1736. C. 1737. A. 1738. B.
1739. B. ...undele lente din ...
1740. D. poate elimina necesitatea unei biopsii intestinale deschise vizând musculatura netedă sau degenerarea neuroană din peretele intestinelui subțire;
1741. E. ...putea fi explicate prin umplerea excesivă a stomacului;
1742. D. 1743. B.
1744. A. scăderea tonusului ...
1745. A. ...scade tonusul ...
1746. B. ...scăderea secreției ...
1747. B. aerofagia poate crește presiunea în stomac suficient pentru a depăși trecător funcția de barieră a SEI;

Prescurtări frecvent folosite: U. = următoarele; C.d.U. = care dintre următoarele; I.d. = fiind date; I.d.U. = fiind date următoarele; I.U. = fiind date următoarele; I.U.I.d. = Următoarele fragmente dintr-o frază despre;

1748. D. factorii psihologici au probabil rolul cel mai important;
1749. B. ...postprandială defici-
tară a formului gastric;
1750. B. are un rol minor sau nul
în DF dar;
1751. C. ...percepția exagerată;
E. fără să existe modificări ale
complanței rectale.
1752. E. ...este cel care apare în
ciuda unui nivel normal de
exponere a esofagului la acid;
1753. E.
1754. C. ...de cel puțin 3 luni;
D. și instalate de cel puțin 6 luni;
E. fără să aibă o cauză organică.
1755. E. la majoritatea pacienților,
DF are o evoluție benignă;
1756. C. esofagita neerozivă nu
poate fi deosebită de cea...
E. ...necontrolat gastrină.
1757. C.
1758. D. ...reprezintă metaplazia
intestinală a esofagului;
1759. B. ...de elan este printre
cel mai importanți factori de
risc pentru carcinomul
scamos...
1760. C. ...ca o complicație a
refluxului acid de lungă durată;
1761. E. forme mai rare de...
1762. D. și nu senzație de...
1763. B. ...mai frecvent la...
1764. E. 1765. B. 1766. D.
1767. B.
1768. C. ...când stomacul este
plin ori comprimat;
D. ...când pacientul se lasă pe
spate sau se apleacă în față;
E. poate trezi pacientul din
somn;
1769. B. examenul fizic este de
obicei normal în BRGE;
1770. D. odinoglia sugerează o
infecție esofagiană;
1771. C. ...eritemul faringian;
1772. D. ...cu slăbirea (creșterea
reflexă a secreției salivare);
1773. A. faringită;
1774. E. ...tulburări funcționale
digestive, printre care SII.
1775. B. ...senzație de plin;
D. ...precoce care împiedică
ingestia completă a unei canti-
tăți obișnuite de alimente;
1776. E. antecedente familiale de
cancer gastrointestinal;
1777. A. scădere inexplicabilă în
greutate;
1778. A. ...vedere că simptomele
dispeptice sunt foarte frecvente;
B. ...dirijate de istoric;
E. ...prin manometrie esofagi-
ană și teste de provocare;
1779. C. ...când se are în vedere
tratamentul chirurgical;
E. ...de acid în esofag;
1780. B. nu se poate efectua o
investigație completă la toate
persoanele care acuză dis-
pepsie;
C. presiunea scăzută a SEI...
E. ...provocat de refluxul acid;
1781. D. cu medicamente anti-
secretore gastrice;
1782. B.
1783. C. ...cu simptome atipice;
D. ...simptome refractare la...
E. și/sau cu factori de alarmă.
1784. A. ...pirozis de >5 ani;
B. ...în vârstă peste 50 ani;
C. pentru depistarea metaplaziei
Barrett;
D. deși nu s-a demonstrat...
1785. B. ...[precum durere în
piept inexplicabilă];
E. sau o capsulă esofagiană im-
plantată.
1786. A. 1787. D. 1788. A.
1789. A. 1790. B. 1791. C.
1792. C. 1793. C. 1794. C.
Tulburările de tranzit
Diarrea
1795. E. ...sunt infecțioase;
1796. C. ...3 pe zi și trei pe...
1797. A. ...în fibre al dietei;
1798. C. ...mai puțin de 200 g/zi;
1799. C. 1800. A. 1801. D.
Diarrea acută
1802. A.
1803. D. ...direct proporțională...
1804. B. rareori provoacă diaree
la persoanele imunocompetente;
C. reprezintă un important
factor de protecție față de
infecția cu germeni patogeni;
1805. E. ...ei prin antibiote
favorizează proliferarea lui...
1806. A. acidul gastric;
1807. C. 1808. C. 1809. A.
1810. E. 1811. A. 1812. D.
1813. D. 1814. B. 1815. B.
1816. C. 1817. C. 1818. E.
1819. A. 1820. E. 1821. E.
1822. B. 1823. C. 1824. D.
1825. E. 1826. B. 1827. A.
1828. A. ...sunt probabil cea mai
frecventă cauză neinfecțioasă
de diaree acută;
1829. B. diverticula colonică
poate provoca diaree acută;
1830. B. ...vârsta peste 50 ani;
E. de obicei nu afectează rectul;
1831. A. 1832. C.
1833. D. și nu este necesar...
1834. E. efectuând-se investi-
gații etiologice doar în cazul
unui eșec terapeutic.
1835. A. scaune macroscopice
sanguinolente;
C. administrare recentă de anti-
biotice;
1836. B. durată >48 ore fără...
D. pacienți vârstnici [≥70 ani];
1837. C. ...la endoscopie;
1838. E. 1839. E.
1840. C. ...cu imunodeficiență;
D. persoanele care frecventează
centre de îngrijire de zi și
noapte
1841. B. ...de virusul Norwalk;
D. ...pot produce proctocolită;
E. ...consumul de pește crud;
1842. A. norovirus este cea...
D. ...letale cu Vibrio spp. și la...
1843. B. 1844. A. 1845. B.
1846. D. 1847. D. 1848. E.
1849. B.
1850. E. ...de Vibrio, Yersinia,
1851. A.
1852. D. poate fi necesară;
1853. E. ...diverticula sau ob-
strucția intestinală parțială.
Diarrea cronică
1854. B. ...sunt neinfecțioase;
1855. C. 1856. B. 1857. A.
1858. C. 1859. D. 1860. B.
1861. B. 1862. D. 1863. B.
1864. B. ...nu există gaură...
E. ...hiperpigmentație cutanată;
1865. B. hormonii sunt o cauză
rară de diaree secretorie;
C. ...poate perturba absorbția...
1866. A. ...este nedureroasă;
C. ...accelerarea tranzitului...
1867. A. ...diaree persistă chiar
dacă se sistează aportul;
D. ...asociată cu alcaloză;
1868. B. ...cronic sunt cea mai
frecventă cauză de diaree...
1869. D. ...asociată cu acidoză;
E. ...resecția ileonului terminal...
1870. B. ...se agravează după...
D. ...stimulează secreția colonică
[diareea colorectală];
1871. A. 1872. B. 1873. B.
1874. B. 1875. E. 1876. B.
1877. A. 1878. A. 1879. E.
1880. A. ...osmolarități fecale nu
mai este recomandată intrucă;
B. chiar dacă este măsurată...
E. ...creșterea osmolarității.
1881. E. deficitul de lactază afec-
tează trei sferturi din perso-
nele necaucaziene la nivel
mondial și 5-30% din persoane
în Statele Unite;
1882. A. ...esle provocată de
solvi care atrag suficient lichid
în lumenul intestinal încât să fie
depășită capacitatea de reab-
sorție a colonului;
1883. B. ...compuși cu magnezii;
1884. A. ...caracteristic, diareea
osmoică se oprește când este
sistat aportul alimentar;
B. ...cu magnezii poate...
1885. B. ...sunt accentuate de...
C. ...cel puțin 90% din funcția...
1886. C. ...de insuficiența pan-
creatică exocrină;
D. ...accelerarea golirii gastrice;
1887. B. ...grăsime din scaun nu
trebuie să depășească 7 g/zi;
C. ...este o cauză rară de...
1888. A. ...adesea scădere în...
1889. C. ...este cea mai fre-
ventă cauză de insuficiență...
E. debutul abrupt și răspunsul la
antibiotice sugerează că...
1890. C. ...frecvență la vârstnici;
E. ...steatoree, dar nu afectează
absorbția glucidelor și a...
1891. E. 1892. B. 1893. E.
1894. E. 1895. A. 1896. D.
1897. D. 1898. E. 1899. E.
1900. C. 1901. B. 1902. B.
1903. E. 1904. A. 1905. B.
1906. A. 1907. B.
1908. B. ...la gluten;
C. ...de atrofie viloză și hiper-
plazia criptelor din...
D. (afectează ~1% din populație);
1909. D. adesea se prezintă fără
steatoree;
1910. A. este determinată de
bacilul *Tropheryma whipplei*;
B. ...apare un infilit histiocitar;
C. ...apare de obicei la bărbai
tineri sau de vârstă medie;
E. ...central și endocardial;
1911. D. ...duce la apariția eritro-
citelor acantocitare;
1912. C. 1913. D. 1914. D.
1915. D. 1916. E. 1917. A.
1918. E. 1919. D. 1920. E.
1921. B. 1922. D.
1923. D. a exclude o tumoră
colorectală;
E. ...fecale conțin sânge.
1924. D. ...prin exsudare poate
produce edem, mergând până la
edem generalizat (anasarcă);
1925. C. ...analiza scaunului este
prezența leucocitelor sau a
proteinelor provenite din leuco-
cite cum ar fi calprotectina;
1926. D. eritem nodos;
1927. A. 1928. C. 1929. E.
1930. D. 1931. B. 1932. C.
1933. C. 1934. A. 1935. C.
1936. A. 1937. A. 1938. B.
1939. B. ...debut brusc și...
sau chiar ani de zile);
1941. B. 1942. B. 1943. C.
1944. B. ...diaree secretorie;
1945. B. din cauza maldigestiei,
apare steatoree ușoară de până
la 14 g de grăsime pe zi;
D. ...de exacerbară reacțiilor...
1946. A. încetează noaptea;
C. ...ameliorată de defecație;
D. rareori determină scădere...
1947. D. ...foarte scăzută a...
1948. D. frecvent se prezintă cu
hipotensiune arterială;
E. ...foarte crescută a scaunului;
1949. D. ...cu hipokalemie;
1950. D.
1951. E. ...indică mai probabil
patologie de intestin subțire;
1952. C. se administrează opioide;
D. și se urmărește pacientul,
considerându-se că;
E. ...diaree cronică persistentă
1953. A. 1954. D. 1955. D.
1956. E. 1957. C. 1958. D.
1959. B. 1960. A. 1961. C.
1962. B. 1963. D. 1964. D.
1965. E. 1966. B. 1967. A.
1968. C.
1969. B. parazitoză;
1970. E. și tranșează diagnosti-
cul fără alte investigații.
1971. A. 1972. C. 1973. B.
1974.
E. care sunt esențiale pentru
alegera tratamentului optim.
1975. B.
Prescurtări frecvent folosite: u. = umătoarele, c.d.u. = care dăre umătoarele; f.d. = find date, f.d.u. = find date umătoarele, f.f. =
referitor/referitoare la; U.I.d. = Umătoarele fragmente dintr-o frază despr;

Prescurtări frecvent folosite: c.p. = cu excepția; s.u.c.g. = sunt umătoarele, cu excepția; u.a.s.c.g. = umătoarele afirmati sunt
corecte, cu excepția; s.c.f. = sunt coned formulate, cu excepția.

- E...depistat nimic la investigații, se recurge la tratament.
2026. B...consistență crescută a scaunelor [scaun tare, în schimb].
2027. C...la pacienți >40 ani;
E...scăderea în greutate, sângerea rectală, anemie.
2028. E...și dilatația colonului...
2029. B...cronice de laxative și...
2030. E...
2031. C...secreție intestinală prin activarea canalului pentru clor;
E...factori care să-l distragă și nu trebuie să se screeamă.
2032. C...osmotic (lactuloză, sorbitol, polietilenglicol);
2033. E...prin sindromul de perineu coborât.
2034. F...la doar aproximativ două treimi dintre cei care...
2035. E...
2036. B...evacuare incompletă a rectului este frecventă în SII;
C...este lipsa de relaxare a mușchilor puborectali;
D...imagistic dinamice este proctografia de decoafte;
2037. C...puborectal nu poate fi identificată prin defecografie;
E...lipsa de înțepere a unghiului rectoanal cu cel puțin 15°...
2038. C...intervenții cognitive sau de altă;
2039. B...sforț posterior în...
C...necesară o investigație dinamică precum proctografia;
2040. A...
2041. E...defecografie
2042. A...ușor de efectuat;
D...necostisitoare;
F...ușor aplicabile în...
2043. C...eliminarea din colon a cel puțin 80% din substanță;
2044. D...exponere redusă la...
2045. E...o tulburare de motilitate gastrointestinală mai generalizată;
2046. B...plenitudine rectală;
C...durere rectală;
E...peretele posterior al...
2047. D...2048. C...2049. D...
2050. C...după introducerea în...
2051. D...de cel mult 200 g;
2052. D...și a sfîrșitului anal;
E...relaxări planșei pelvian.
2053. C...sugerând anism (spasmul sfîrșitului anal) și...
E...prin absența reflexului...
2054. C...la puțini pacienți (denifiți stări patologice...
E...nu sunt patologice...
2055. B...coborâri perineale și a unghiului rectoanal;
2056. C...traumă pelvian (de exemplu, obstetrical);
D...nervului rușinos prin...
2057. B...
2058. E...pentru a se încerca antrenare prin biofeedback.
Hemoragia digestivă
2059. C...hematochezie;
2060. C...2061. A...
2062. C...de decompensarea unei boli coexistente;
2063. A...2064. A...2065. B...2066. B...2067. A...
2068. A...ulcerare sunt cea...
D...mai favorabilă decât...
E...esofagita erozivă poate duce în timp la anemie feriprivă;
2069. C...mai ales în esofag, dar și în stomac, intestinul...
D...esofagita erozivă produce rareori HD importantă;
E...în special la alcoolici;
2070. D...versanți gastric; nu provoacă sângerare importantă;
2071. C...ale mucoasei;
2072. B...denunțarea de gastrită nu este corectă, intrucât leziunea primară nu este inflamatorie;
2073. B...intervenții chirurgicale majore;
2074. C...este mare din cauza bolilor severe subiacente;
2075. E...scade cu vârsta;
2076. B...subțire este rară;
D...coabi produc mai puține leziuni de intestin subțire decât AINS tradiționale;
2077. A...2078. B...2079. B...
2080. A...adenocarcinom;
2081. A...sunt hemorizi;
B...durere și sângerare minoră;
C...rând adenocarcinome;
D...ecăzile vasculare sunt situate mai ales în colonul proximal;
E...pacienții peste 70 de ani;
2082. A...începe brusc;
B...de obicei este nedureroasă;
E...de obicei nu este minoră...
2083. D...doar uneori sunt semnificative hemodinamice;
2084. D...2085. D...2086. E...2087. B...2088. D...
2089. A...de sângerare (deasupra ligamentului Treitz);
B...surse inferioare de...
D...determină creșterea ureei;
E...chiar și un aspect (aparent) bilios nu exclude sângerarea dintr-o leziune postpilorică;
2090. A...cel puțin 14 ore;
C...intestinale hiperactive sunt sugestive pentru HDS;
2091. A...mai proximal...
B...al unei HDS, este asociată cu instabilitate hemodinamică și cu scăderea hemoglobinei;
C...al ureei indică HDS;
D...dintr-o surse duodenală;
E...este inutilă testarea...
2092. A...2093. C...
2094. D...hemoglobina poate fi normală sau numai puțin scăzută la prezentarea inițială;
E...volentia, hemoglobina scade;
2095. B...nu scade imediat;
2096. A...
2097. B...tensiunea arterială nu este influențată;
C...poate fi crescută din...
D...feriprivă, VEM scade;
E...anemic, crește lărgimea...
2098. C...EDS ar trebui efectuată urgent la pacienți instabili...
2099. A...
2100. B...este dificilă în cazul...
2101. A...regulă hematochezie;
B...sigmoidoscopia nu reușește identificarea locului sângerării;
D...colese mai târziu...
2102. A...magnitudine și la...
B...cu sângerare minoră;
C...sigmoidoscopia descoperă o leziune cu sângerare activă...
2103. A...se poate efectua sigmoidoscopia timpuriu...
2104. A...2105. E...2106. C...
2107. A...2108. D...2109. A...
2110. A...2111. E...2112. E...
2113. C...persistență sau recidivă;
E...prin investigații de rutină.
2114. C...2115. B...2116. B...
2117. B...în detectarea unei posibile cauze este de 56% pentru capsula endoscopică, față de 26% pentru endoscopie;
D...angiografia este utilă chiar dacă sângerarea a încetat;
E...unui diverticul Meckel, în...
2118. E...lungimea intestinului subțire.

Prescurtări frecvent folosite: C.E. = cu excepția, S.L.C.E. = sunt umătoare, cu excepția, U.A.S.C.E. = umătoare afirmative sunt corecte, cu excepția, S.C.F.C.E. = sunt corect formulate, cu excepția.

2119. B...endoscopia intraop-
ratorie la;
2120. D...cu hematii marcate...
E...angiografia și endoscopia in-
trooperatorie.
2121. D...sedul sângerării la 20-
40% din pacienți cu HD obscură;
E...obicei prima investigație...
2122. A...endoscopică a între-
gului intestin subțire;
B...mai mare decât...
2123. C...nas până în duoden;
E...ajută, prin administrarea
de metil-celuloză.
2124. A...anemie feriprivă;
B...înceapă cu colonoscopia;
C...la pacienți peste 40 de ani;
2125. B...
Icterusul
2126. E...în condiții de hiper-
bilirubinemie.
2127. B...uneori icterul se poate
menține un timp după norma-
lizarea bilirubinei;
2128. D...2129. E...
2130. A...sclerole au afinitate
crescută pentru bilirubină;
2131. A...examinarea sclerelor;
2132. B...
2133. C...a pielii și a sclerelor...
E...icter pe baza istoricului;
2134. B...
2135. B...de diferențiat de icter
pe baza distribuției pigmentului;
E...nu se aștează sclerole;
2136. A...urobilinogenul este
incolor, dar generează prin
oxidare urobilină [numită pe
viemuri urobilin];
D...semnifică colestază (inclusiv
hepatopatie colestatică);
E...nu ajunge în intestin, deci nu
se mai produce urobilinogen;
2137. D...2138. E...2139. C...
2140. C...
2141. C...neconjugate izolate
este hemoliză;
2142. C...prin a se stabili dacă
este vorba de colestază intra-
hepatică sau extrahepatică;
2143. B...trebuie să includă
exponerea la medicamente;
D...vorba de hemoliză sau nu;
2144. B...cronică, apar frecvent
calculi de bilirubină de calcul;
2145. E...evaluează, de obicei,
prin măsurarea timpului de pro-
trombină și a albuminiei;
2146. D...2147. C...2148. E...
2149. E...2150. C...2151. E...
2152. E...2153. E...2154. C...
2155. A...2156. B...2157. B...
2158. A...2159. A...2160. B...
2161. C...2162. C...
2163. A...5 mg/dL;
B...decât dacă este o criză
hemolitică acută (criza);
E...sau hepatocelulară.
2164. B...2165. B...2166. C...
2167. E...2168. A...2169. A...
2170. A...2171. A...2172. E...
2173. C...2174. C...2175. E...
2176. D...2177. B...2178. B...
2179. D...2180. A...2181. A...
2182. B...2183. E...
2184. B...perturbarea excreției
bilirubinei în ductele biliare
determină sindromul...
D...cu icter asimptomatic, de
obicei în a doua parte a vieții;
2185. C...2186. C...2187. A...
2188. E...2189. E...2190. A...
2191. A...2192. E...2193. E...
2194. C...2195. D...2196. D...
2197. D...2198. C...2199. C...
2200. E...2201. A...2202. C...
2203. E...două diferă prin...
2204. B...2205. E...2206. E...
2207. E...2208. A...2209. A...
2210. B...2211. C...
2212. C...[boala Wilson];
E...[de exemplu, izoniazid];
2213. B...în vedere nu doar la
tineri, ci și la toți adulții la care
nu se găsește cauza icterului;
2214. B...2215. E...2216. E...
2217. A...2218. D...2219. B...
2220. C...este ceruloplasmina;
D...de obicei mai mare de 2:1;
2221. A...față de FALC indică
leziune hepatocelulară;
B...și ARN de VHC;
C...utili pentru diagnosticarea
hepatitei autoimune;
F...aminotransferazele pot fi
normale sau doar ușor
crescute;
2222. D...în hepatită alcoolică,
AST rareori depășește 300 U/L;
E...apar mai ales în leziunile
hepatocelulare acute;
2223. E...neinvazivă...
2224. E...diagnosticul se pune
adesea pe baza investigațiilor
serologice asociate cu biopsia
hepatică;
2225. A...după constatarea unei
creșteri enzimice de tip
colestatic, trebuie diferențiat
colestaza intrahepatică de cea
extrahepatică;
B...bilare nu sunt dilatate;
2226. A...poate fi dificilă,
intrucât istoricul, examenul fizic
și testele biochimice adesea nu
sunt utile;
B...CPRE este investigația...
2227. E...coledocul distal este
foarte dificil de vizualizat prin
ecografie [din cauza gazului in-
testinal intersus];
2228. C...intrahepatică;
D...primară (CSP), în care cica-
trizarea impletică dilatarea
ductelor intrahepatic;
2229. B...2230. B...2231. C...
2232. D...2233. D...2234. B...
2235. C...
2236. C...colestază sunt steroizi
[anabolizante, contraceptive];
E...substrat fibroză hepatică pro-
gresivă în ciuda opririi timpurii
a medicamentului;
2237. A...
2238. E...cicla biliară primară
este o boală autoimună care
afectează predominant femeile
de vârstă medie;
2239. B...
2240. A...în trimestrele 2 și 3;
B...se rezolvă după naștere;
E...fi declarată de...
2241. E...2242. E...2243. E...
2244. C...2245. E...2246. B...
2247. A...2248. C...2249. C...
2250. B...2251. E...
2252. B...icter nedureros;
E...care sunt rareori rezecabile și
au prognostic defavorabil;
2253. E...2254. D...2255. D...
2256. A...2257. D...2258. A...
2259. A...complicație rară...
2260. C...FALC este mult crescută
[în medie, 800 U/L];
Măritarea abdomenului
2261. C...pneumoperitoneul nu
produce de obicei o acumulare
de gaz suficient de importantă
încât să ducă la distensia
abdomenului;
E...poate fi produsă uneori de
creșterea lordozelor lombare;
2262. C...obstacol subvezical;
E...volumul abdomenului începe
cu istoricul și examenul fizic;
2263. C...senzația subiectivă de
presiune abdominală.

Prescurtări frecvent folosite: U. = umătoare, C.E. = care dăre umătoare, I.d. = fiind date, I.d.U. = fiind date umătoare, I.L. =
referențiale, U.A.S.C.E. = Umătoare fragmente dintr-o frază descriptivă.

- D. ...intestinel al gazului;
E. și nu de creșterea verticabilă a volumului de gaz din intestin.
2264. C. ...cantități de oxigen și azot din intestinul subțire;
E. fermentarea glucidelor este...
2265. B. ...de către bacterii;
D. exos, cum ar fi lactoză și alte oligozaharide;
E. cu producție de hidrogen, dioxid de carbon, metan.
2266. A.
2267. C. ...rând de exagerarea percepțiilor viscerale;
2268. E. metan;
2269. A.
2270. E. iar diagnosticul se pune prin investigații imagistice.
2271. B. ...la 12-14 săptămâni...
E. ...și a relaxării mușchilor...
2272. E. 2273. D. 2274. E.
2275. B. 2276. C. 2277. D.
2278. A.
2279. B. ...cel mai adesea de dezechilibrul dintre aportul de calorii și cheltuielile de energie;
D. ...ar fi sindromul Cushing;
2280. A. ...prin creșterea;
D. și relaxarea peretelui abdominal anterior;
2281. E. 2282. C. 2283. E.
2284. E. 2285. D. 2286. C.
2287. E.
2288. B. ...de obicei trecătoare;
D. nu este însoțită de semne...
2289. D. adesea este însoțită de disconfort abdominal [mai rar durere];
E. ...este însoțită de...
2290. A.
2291. C. ...este însoțită de...
2292. D. fie a acumulării însoțite de ascită;
2293. D. în flancuri sau în regiunile inghinale și o vagă;
2294. B. pirozis din cauza...
D. ...cauza împingerii în sus a...
E. expansiunea incompletă a plămânilor;
2295. B. ...pe partea dreaptă;
C. ...probabil prin scurgerea lichidului ascitic prin canalele limitate transdiafragmatice;
2296. A. 2297. C. 2298. E.
2299. B. 2300. C.
2301. B. ...matității la percuția abdominalului nu exclude ascita;
E. ...reprezintă balotarea la palpare a ficatului sau a splinei în lichidul ascitic când ascita...
2302. B. ...cel puțin 1500 mL;
2303. B. ...este deplasabilă;
D. ...însoțită poate fi prin balotare în lichidul ascitic;
E. ...colecistul pot să nu coboare la inspirație dacă sunt...
2304. B. ...că lichidul este liber în cavitatea peritoneală;
E. ...dacă sunt fixate...
2305. A. ...de obicei tumefacție abdominală localizată;
2306. D. ...semnifică insuficiență tricuspidiană, de obicei asociată cu IC dreaptă;
2307. B. ...peritoneală, în urma perforației unui viscer cavitărilor; C. ...pot fi dificil de...
E. ...dacă este localizată...
2308. C. ...prin ecografie...
2309. E. 2310. E. 2311. E.
2312. C. 2313. A. 2314. E.
2315. E. 2316. B. 2317. B.
2318. A. 2319. E. 2320. B.
2321. D. 2322. D. 2323. B.
2324. A. 2325. A. 2326. E.
2327. A. se începe cu radiografie abdominală simplă (pe gol);
D. TC este adesea necesară pentru a vizualiza retroperitoneul, pancreasul...
2328. B. ecografia poate detecta chiar și numai 100 mL de ascită;
D. ...este superioară ecografiei...
E. ...reprezintă diferența de presiune transhepatică dintre vena portă și venele hepatice;
2329. C. ecografia este deseori inadecvată pentru a detecta adenopatiile retroperitoneale din cauza gazului intestinal de deasupra;
D. ...este mai fidel decât...
2330. A. ...colon destins din...
C. ecografia este deseori inadecvată pentru a detecta leziunile pancreatice din cauza gazului intestinal de deasupra;
E. ...venos hepatic confirmă că ciroza este cauza ascitei;
2331. D. ...sunt utile albuminemia și timpul de protrombină;
2332. C. 2333. E. 2334. D.
- Ascita
2335. C. 2336. D. 2337. E.
2338. B. ...este produsul dintre...
2339. B. ...este produsul dintre...
2340. B. ...este produsul dintre...
2341. B. ...este produsul dintre...
2342. B. ...este produsul dintre...
2343. A. ...este produsul dintre...
2344. B. ...este produsul dintre...
2345. E. ...poliserozilei tipice;
2346. C. 2347. B. 2348. D.
2349. A. 2350. A.
2351. E. complicațiile sunt rare;
2352. A. ...este suficiență extragerea a 50-100 mL de lichid;
E. ...prea mare de lichid;
2353. E. o coagulare intravasculară diseminată.
2354. A. ...situat mai profund;
C. ...mai gros și mai muscular;
E. ...este mai subțire;
2355. C. hipotensiune;
2356. E. examenul citologic frotiu și bloc celular [poate descoperi un carcinom alimentat nebulu];
2357. C. ...frotiul colorat Sudan evidențiază globule de grăsime;
D. ...cu lichidul tubure din cauza leucocitelor sau a celulelor tumorale [pseudocholosi];
E. ...sunt crescute și în...
2358. B. ...diagnosticului este suficiență o concentrație de trigliceride de >200 mg/dL;
E. ...chiloasă este inadecvată în cadrul sindromului nefrotic;
2359. E.
2360. D. ...infestații (tuberculoză, filarioză);
2361. E. 2362. B.
2363. A. nivelului albuminei;
2364. A. 2365. C. 2366. C.
2367. A. 2368. E. 2369. B.
2370. A. ...se realizează cu dificultate prin paracenteză;
2371. D. ...și biopsiile pentru TBC pot necesita 6 săptămâni pentru a furniza un rezultat;
2372. B. 2373. D.
2374. E. GASA scăzut indică...
2375. A. ...recipientele de cultură se face la patul pacientului;
E. ...inițial la examenul citologic al lichidului peritoneal;
2376. D. ...tumori ovariene...
2377. B. ...corelează direct cu...
2378. D. ...sunt normale;

Prescurtări frecvent folosite: G.A. = cu excepția; S.U.C.G. = sunt urmărirea; cu excepția; u.a.s.c.G. = urmărirea afirmativ sunt corecte, cu excepția; S.C.G. = sunt corect formulate, cu excepția.

2379. B. GASA nu depinde de...
2380. B. ...este un transsudat;
2381. B. ...crescut indică HTP...
2382. C. ...cel mai adesea prin tromboză, dar și prin invazie tumorală sau obliterare;
2383. A. ...conținut crescut de...
2384. D. ...reprezintă un exsudat;
2385. E. cel mai adesea dintr-un pseudochist.
2386. D. ...de diverse stări asociate cu ciroza sau favorizate de ciroză;
D. ...mai mare decât în ser;
E. agenți patogeni multipli pe...
2388. E.
2389. B. tromboză de venă portă;
tuberculoasă sau neoplazică;
- E. ...sugestiv pentru mixelomul peritoneal;
2397. B. ...este atipic pentru ciroză și impune căutarea unei tumori sau a unei infecții;
C. ...cu creșteri doar minore ale numărului de leucocite din...
2398. D. la cazurile cu infecție bacteriană;
2399. B. ...descoperi metastaze peritoneale, tuberculoză;
2400. B. 2401. E. 2402. D.
2403. A. 2404. D. 2405. C.
2406. E. 2407. C. 2408. D.
2409. A. 2410. D.

Bibliografie

- Longo DL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Jameson JL, Loscalzo J – *Harrison's Principles of Internal Medicine* 18th Ed. The McGraw-Hill Companies, 2011
Fauci AS, Kasper DL, Longo DL, Braunwald E, Hauser SL, Jameson JL, Loscalzo J – *Harrison's Principles of Internal Medicine* 17th Ed. The McGraw-Hill Companies, 2008
Braunwald E, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL – *Harrison's Principles of Internal Medicine* 15th Ed. The McGraw-Hill Companies, 2001
Mihail A, Ion IC, Popescu P, Alexandru I, Georgescu DE – *Curs de Semnologie medicală*, vol. I și II, Institutul de medicină și farmacie, Facultatea de medicină generală, Catedra de semnologie, București, 1986

Prescurtări frecvent folosite: u. = urmărirea; c.d.u. = care dintre urmărirea; i.d. = fiind date, i.d.u. = fiind date urmărirea, r.i. = referențiar însoțitor la; U.I.d.I. = Urmărirea fragmente dintr-o fază despre;

Director: Conf. Dr. Ing. Victor Lorin Purcărea
Secretar Științific: Conf. Dr. Bogdan Voiculescu
Tehnoredactare: Dr. Dorin Dragoș, Graziella Grozavu
Copertă: Graziella Grozavu

Format: A4

Bun de lipă: Septembrie 2014

© Copyright 2014

Toate drepturile aparțin Editurii Universitare „Carol Davila”

Editura Universitară „Carol Davila”
B-dul Eroii Sanitari nr. 8, sector 5, București
Tel: 021.318.08.62 int. 199